

La Gran Biblia para preparar EUNACOM



Creado por Cristóbal Eggers

Con aportes de Nicoletta Campodónico, Josefina Izurieta, Sofía Larrondo y Konstanze Bergholz

Primera y única edición, (este año de mierda) 2020

Nota al lector:

A lo largo de estas múltiples páginas de resumen de los videos de Guevara de todos los temas de EUNACOM podrán ir notando como la cuarentena fue consumiendo poco a poco mis ganas de vivir, lo cual, podremos ver representado en la notoria disminución de memes presentes en estos resúmenes, los cuales tan solo buscan alegrar la vida de los lectores. (No están ordenados en orden cronológico de elaboración).

El índice tiene hipervínculos a los capítulos, porque sí, así de tecnológico soy.

Les deseo el mayor de los éxitos en el estudio de nuestros bellos, apolíneos y sensacionales resúmenes.



*Bendiciones,
C. Eggers et al.*

Índice

Medicina Interna

<u>Cardiología (10 preguntas).....</u>	5
<u>Diabetes y nutrición (Nicoletta, 5 preguntas fáciles).....</u>	37
<u>Endocrinología (5 preguntas).....</u>	48
<u>Gastroenterología (10 preguntas, fáciles)</u>	68
<u>Infectología (4 preguntas)</u>	89
<u>Nefrología (5 preguntas).....</u>	122
<u>Respiratorio(10 preguntas).....</u>	140
<u>Reumatología (4 preguntas).....</u>	161
<u>Hematología (5 preguntas).....</u>	175
<u>Cirugía y anestesia(10 preguntas, fáciles).....</u>	189
<u>Obstetricia (Sofía Larrondo ,14-15 preguntas)</u>	230
<u>Ginecología (Josefina Izurieta, 14-15 preguntas)</u>	259
<u>Pediatría (29 preguntas).....</u>	279
<u>Psiquiatría (14 preguntas, muy costo-efectivo de estudiar)</u>	334
<u>Otorrinolaringología (4 preguntas fáciles).....</u>	361
<u>Dermatología (4 preguntas fáciles)</u>	385
<u>Oftalmología(4 preguntas fáciles).....</u>	405
<u>Geriatría(4 preguntas fáciles).....</u>	421
<u>Neurología (5 preguntas).....</u>	424
<u>Traumatología (5 preguntas fáciles)</u>	442
<u>Urología (5 preguntas).....</u>	468
<u>Salud Pública (Koni Bergholz, 5 preguntas)</u>	487

Composición de preguntas del EUNACOM-ST

Área clínica	Preguntas	
	%	Número
Cardiología	5.5	10
Enfermedades respiratorias	5.5	10
Gastroenterología	5.5	10
Endocrinología	2.5	5
Diabetes y nutrición	3	5
Neurología	3	5
Nefrología	3	5
Hemato-oncología	3	5
Enfermedades Infecciosas	2	4
Reumatología	2	4
Geriatría	2	4
Total Medicina Interna	37	67
Cirugía general y anestesia	6	10
Traumatología	3	5
Urología	3	5
Total Cirugía	12	20
Total Pediatría	16	29
Total Obstetricia y ginecología	16	29
Total Psiquiatría	8	14
Total Salud Pública	5	9
Dermatología	2	4
Oftalmología	2	4
Otorrinolaringología	2	4
Total Especialidades	6	12
TOTAL EXAMEN	100	180

Resumen Guevara by creggers

Cardiología

De las 10 preguntas de cardiología, 6-7 tratan sobre semiología cardiaca



1. Cardiopatía Congénita y soplo cardiaco

Cardiopatía se pregunta en pediatría también

Se dividen en 2, cianóticas (shunt de derecha a izquierda) y acianóticas (shunt de izquierda a derecha, las mas frecuentes)

Acianóticas

Presentan hiperflujo pulmonar que genera congestión pulmonar, mal incremento ponderal, intolerancia al ejercicio (se cansan con la succión) e infecciones respiratorias a repetición. Pueden hacer cianosis y mejoran con el uso de Oxígeno.

Tipos

- **CIV (las más frecuente)**→ Soplo holosistólico, dilatación de cavidades izquierdas
- **CIA**→ La 2ª más frecuente. Tiene un soplo sistólico eyectivo (mesosistólico) más un desdoblamiento del segundo sonido. Dilata las cavidades derechas
- **Ductus arterioso persistente (DAP)**→ Soplo continuo sistodiastólico. Dilata el lado izquierdo.
- **Coartación aórtica**→ Cardiopatía obstructiva izquierda que tiene soplo eyectivo (mesostiolico) con disminución de los pulsos de las EEII
- **Canal auriculoventricular** (se ha preguntado 1 vez)→ CIA + CIV, característico del Sd de down

Cianóticas

Se presentan con cianosis que no mejora con oxígeno (así mismo lo preguntan)

- **Tetralogía de fallot**→ **Es las más frecuente de las cianóticas.** Viene con una obstrucción derecha, por eso tiene este shunt de derecha a izquierda.
- **Ventrículo único**
- **Trasposición de grandes vasos**→ La aorta y la arteria pulmonar están cambiadas (aorta sale del lado derecho y pulmonar del izquierdo). No tiene soplos y no hay mezcla de las sangres. Hay un circuito de sangre que nunca se oxigena y otro sistema que nunca pasa a nivel sistémico. Si se cierra el ductus el paciente se muere al toque.
- **Tronco arterioso**→ Al aorta y la arteria pulmonar salen como una única arteria, se mezclan las sangres.

Todas tienen la misma clínica→ cianosis que no mejora con oxígeno, esto es lo importante

Diagnostico de ambas → Se hace con ecocardiograma

Tratamiento

TODAS se operan. El DAP puede intentar cerrarse antes con AINEs (indometacina o ibuprofeno)

Cianótica → Como pueden ser ductus dependiente, se debe mantener el Ductus abierto con prostaglandinas (antes de hacer el diagnostico con eco, ante cianosis que no mejora a oxígeno)

Soplo Cardiaco → Lo importante es diferenciar si es un soplo funcional o patológico. La clínica da la diferencia en general

Soplo funcional → SIEMPRE es sistólico eyectivo sin frémito, tienen tonalidad musical con intensidad III/VI

Soplo patológico → Puede ser sistólico o diastólico, puede tener frémito (intensidad IV/VI) y tiene síntomas de insuficiencia cardiaca

Los soplos funcionales se observan, los patológicos deben ser estudiados con ecocardiograma.

2. TVP, TEP, várices y Anticoagulación

Entran en varias especialidades (cirugía, respiratorio y cardio). Se preguntan siempre

TVP

Edema unilateral con fovea (+) y eritema de la piel. Se presenta con dolor y suele tener signos de insuficiencia venosa (telangectasias, trayectos venosos tortuosos).

Signo de Homans → Dolor en gastrocnemios al dorsiflectar el pie.

Empastamiento → Se palpan duros los gastrocnemios

Antecedentes que orientan a TVP

- Triada de Virchow (Hipercoagulabilidad, ectasia venosa y daño endotelial)
- Trombofilia
- Postquirúrgico
- Puerperio
- Cáncer
- Síndrome nefrótico
- SAF (o patologías asociadas a este como el LES)

Se estudian con eco-doppler de EEII y se manejan con **anticoagulación por 3 meses habitualmente**. Si no tengo eco, anticoagulo a ciegas porque el riesgo de TEP es grande.

TEP

Clínica → Dolor torácico + disnea de inicio súbito que aumenta con la inspiración (pleurítico). Se asocia a taquipnea, taquicardia (lo más común), hemoptisis, pueden hacer fiebre, desaturaciones y lo mas importantes es que puede venir precedido por TVP o factores de riesgo para TVP/TEP.

MANEJO

El examen de elección es el angioTAC. Se debe **anticoagular por mínimo 6 meses**.

Como examen alternativo está el Dímero D. Esto se pide en paciente con baja sospecha de TEP.

Si sale negativo descarta el TEP (Alto VPN) si sale positivo debo ir a descartar con AngioTAC.

TEP masivo

Misma clínica de TEP + hemodinamia inestable (hipotenso + ingurgitación yugular).

El manejo es distinto.

El examen que se toma es el ecocardiograma. Este muestra hipertensión pulmonar

Tratamiento→ trombolisis Ev

Anticoagulación

Heparina

- Fraccionada (HBPM)→ No requiere control
- No fraccionada→ Se controla con TTPA. LA idea es llevarlo a 1,5 veces el basal. Debe ser controlado cada 4 horas. Se administra hospitalizado por BIC

TACO (cumarínicos)

Warfarina y acenocumarol→ Se controla con INR, dejándolo ente 2-3

Várices

Al diagnostico es clínico (Aumento de volumen de venas, edema de extremidades, úlceras varicosas y signos de insuficiencia venosa)

Manejo→ Vendaje compresivo y ejercicio. En casos graves se puede operar con safenectomia.

No hay fármacos muy útiles para su manejo. Si sangran (generalmente por trauma) el manejo es con compresión y por ultimo suturar (se preguntó 1 vez).

3. Patología arterial De EEII

Claudicación Intermitente

Causa→ ateromatosis arterial

Clínica→ Dolor en EEII (especialmente en pantorrillas) que aparece con el ejercicio y cede con el reposo.

Diagnostico→ Clínico

Tratamiento→ Médico, manejo de los FRCV + programa de ejercicios y suspender tabaquismo.

Isquemia crítica EEII

Causa→ Ateromatosis arterial con los mismo FRCV

Clínica→ Igual a una claudicación intermitente +

- dolor de reposo
- úlcera arterial (maléolo externo, dolorosa, irregular y de fondo pálido)
- Índice tobillo brazo (ITB) menor a 0,5. (presión arterial tomada en el tobillo /PA brazo). Su VN es >1.

Esto debe estudiarse y tratarse de forma distinta.

Se estudia con PVR y después angiografía para determinar el sitio de obstrucción.

El tratamiento es quirúrgico haciendo un bypass.

Manejo ulcera arterial → Se hacen curaciones, posición de fowler (extremidades colgando) y ATB si se infecta.

Isquemia aguda de EEII

Causa → Embolia arterial (antecedente de FA o arritmia cardiaca). Suele venir con historia de un adulto mayor que estuvo mucho rato en cuclillas y al pararse inició con dolor

Clínica → 6P

- | | | |
|-----------|--------------|----------------------------|
| - Pain | - Paresia | - Pulso ausente/disminuido |
| - Palidez | - Parestesia | - Poiquilotermy (frialdad) |

Manejo

1. Anticoagular con heparina
2. Angiografía
3. Embolectomía

Resumen

Patología	Clínica	Examen	Tto
Claud. Interm.	Dolor ejercicio	Solo clínica	Médico Ejercicios
Isquemia Crítica	Dolor reposo	PVR	Bypass
Isquemia Aguda	6P	Angio-grafía	Heparina Embolec.
TVP	Dolor Edema	Eco doppler	Heparina

4. Dolor torácico, SCA

Estudio de dolor torácico inespecífico → Rx Tx y ECG

Tipos de dolor torácico

Pericarditis → Dolor que disminuye al inclinarse hacia delante, aumenta con la inspiración, tope inspiratorio y ECG con elevación difusa de ST con concavidad superior

Costocondritis→ Aumentan con la inspiración, pero especialmente al apretar la articulación costochondral afectada

Dissección aórtica→ (se pregunta con mucha frecuencia) Dolor asociado a asimetría de pulsos superior e inferiores. Puede generar un soplo diastólico (si afecta la válvula aórtica), disfonía (si afecta al N. Laríngeo recurrente) y suele darse en contexto de crisis hipertensivas

Neumotórax→ asociado a disminución del murmullo pulmonar, hipersonoridad a la percusión, dolor aumenta con la inspiración. Se da generalmente en pacientes jóvenes y delgados (longilineos)

Espasmo esofágico—Suele ser postprandial y en paciente con antecedente de RGE. **Mejora inmediatamente con la nitroglicerina**

Angina estable→ Dolor opresivo con factores de riesgo cardiovascular que se da durante el ejercicio y mejora con reposo. Si se da en cara inferior puede presentarse como dolor crónico epigástrico

TEP→ Dolor súbito que aumenta con la inspiración asociado a disnea, fiebre, hemoptisis, viene con antecedente que nos orientan a trombosis (Cáncer, cirugía, ACO, SAF, o clínica de TVP) y en el ECG puede tener un S1Q3T3, pero lo más clásico es la taquicardia.

Neumonía→ Fiebre, tos, disnea, expectoración, crepitaciones en el foco de condensación, broncofonía, matidez a la percusión en zona afectada y aumenta el dolor con la inspiración (causas pulmonares y pericarditis aumenta con la inspiración)

SINDROME CORONARIO AGUDO

Causado por isquemia cardiaca.

Dolor torácico súbito opresivo de gran intensidad en región precordial con irradiación a hombro izquierdo, mandíbula y sensación de muerte inminente. Suelen tener muchos factores de riesgo cardiovascular presentes.

Presentaciones atípicas

- IAM de cara inferior→ Dolor epigástrico
- IAM ventrículo derecho→ Hipotensión arterial, ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema de EEII.
- Diabéticos→ Sin dolor, pueden venir con malestar, palpitaciones, sudoración y frialdad, por lo cual, **puede ser confundido con hipoglicemia.**
- Adulto Mayor→ Sin dolor, 1er síntoma puede ser la **desorientación**

Manejo del SCA

El ECG es fundamental para determinar el tipo de SCA (con o sin SDST (o con nuevo BRI))

Manejo general de los SCA

- Oxígeno
- Morfina (no en hipotensión)
- Nitroglicerina (no en hipotensión)
- Aspirina/ Clopidogrel

Con SDST→Angioplastia y en caso de que no esté disponible se hace trombolisis
Sin SDST→ Se evalúa si se debe hacer angioplastia o tratamiento conservador

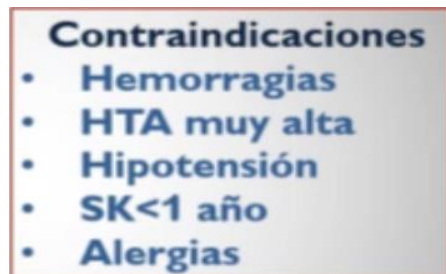
SCA CON SDST

Lo importante es la revascularización inmediata, ya sea con angioplastia o con trombolisis.

La angioplastia se debe hacer siempre que este disponible en mi centro o en algún centro de derivación, siempre y cuando no se demore más de 90 minutos hasta que le hagan angioplastia allá. **En caso de falla de la trombolisis debe hacer angioplastia igual.**

Trombolisis→ rTPA (mas caro y mejor) o estreptoquinasa (en todos lados). El rTPA se dan 10UI en bolo, la estreptoquinasa se da 1.5 millones de UI en 250cc SF a pasar en 30 minutos. En los mayores de 75 años se dan 750.000UI.

Contraindicaciones de trombolisis (debo derivar a angioplastia aunque esté a más de 90 minutos)



(alergia a estreptoquinasa)

Evaluación del éxito de la trombolisis

Se hace ante de los 90 minutos

- Disminución del dolor
- Depresión del ST
- Aumento de enzimas

SCA SIN SDST

Hay que dividirlo en alto y bajo riesgo

Alto riesgo

- Shock o EPA
- Eco-cardio que muestra FEVI bajo 50%
- TIMI score igual o mayor a 4
 - Mas de 65 años
 - FR cardiovascular
 - Usuario de aspirina
 - Antecedente de enfermedad coronaria

Mnemotecnia **AMERICA**

- A** →Aspirina en los últimos 7 días
- M** →Marcadores cardiacos positivos
- E** →ECG con ST 0,5-1mm
- R** → Risk Factors (>3)
- I** → Isquemia (Angina en las ultimas 24 horas)
- C** →Cardiopatía conocida
- A** →Age > 65

- Antecedente de angina en las ultimas 24 horas
- Infradesnivel de la ST
- Enzimas positivas

Alto riesgo → Angioplastia

Bajo riesgo → Manejo conservador (MONA)

NUNCA SE DA TROMBOLISIS EN UN SCA SIN SDST

Indicaciones al alta

- Estatinas
- Control de todos sus Factores de riesgo cardiovascular
- Aspirina + Clopidogrel
- Manejo de ICC
- Ecocardio para determinar su fracción de eyección (esto me da pronóstico)

Marcadores de isquemia miocárdica

Troponina I → De elección, las más específica. Su peak es a las 4-6 horas

Ck-MB → Muy buena, pero baja su sensibilidad da mediad que pasa el tiempo

Ck total → Muy inespecífica

Mioglobina → Muy inespecífica, pero su peak es precoz (2 horas)

Utilidad

1. Para hacer el diagnostico ante una clínica inespecífica

2. Determinar éxito de la trombolisis

3. Criterios del TIMI

ECG en SCA

Onda T → Invertida, aplanada o bifásica. Habla de isquemia aguda reversible

Segmento ST → Supradesnivel habla de lesión aguda transmural (necrosis). El Infradesnivel ST habla de una lesión subendocárdica

Onda Q o QS → para que sea patológica debe ser mayor al 25% de la R. Habla de infarto antiguo o agudo irreversible.

Pared septal → V1 y V2

Pared apical → V3 y V4

Pared anterior → V1-V4

Pared lateral → V5, V6, AVL y D1

Pared inferior → D2, D3 y AVF

Ventrículo derecho → V4R (derivada derecha)

COMPLICACIONES DEL IAM

- Mecánicas → Ocurren del 2º al 7º día tras el IAM. TODAS se estudian con Ecocardio y se tratan con cirugía.
 - Rotura del músculo papilar → Produce una insuficiencia mitral aguda (soplo holsistólico + ICC)

- Rotura de tabique IV → CIV aguda que da la misma clínica que la anterior (soplo holístico + ICC). Inicialmente son iguales a la rotura del músculo papilar.
 - Rotura de pared libre → Taponamiento agudo
 - Pseudoaneurisma → Hacen trombos que se sueltan y dan émbolos a distintas partes del cuerpo. Puede generar un supradesnivel ST persistente.
- Eléctricas
- Paro → RCP avanzado
 - Extrasístoles ventriculares → Tienen el riesgo de pasar a taquicardia ventricular y Fibrilación ventricular, llevando a la muerte. Se maneja con antiarrítmicos, amiodarona o lidocaína
 - Bradicardia → Puede ser por reacción vagal (se maneja con atropina) o por infarto del nódulo sinusal o auriculoventricular (se pone marcapaso externo)
 - Arritmias de reperfusión → Cualquier arritmia que aparece durante los primeros 30 minutos tras la reperfusión. Se observan, no tiene riesgo, salvo la taquicardia ventricular de más de 30 segundos.

IAM ventrículo derecho

Clínica → Hipotensión arterial, ingurgitación yugular, asociado a infarto de pared inferior generalmente (que tenga IAM de pared inferior no significa que tenga de ventrículo derecho, simplemente se asocian)

Diagnóstico → ECG con precordiales derechas, se observa Supradesnivel en V4R. A todo IAM de pared inferior se le deben pedir derivadas derechas

Tratamiento → Suero fisiológico a lo maldito (no hay riesgo de EPA) + angioplastia. No podemos dar nada que hipotense (nitroglicerina, morfina, trombolisis, betabloqueo ni enalapril)



5. Disección aórtica/Aneurisma aórtico abdominal

Se pregunta bastante

Disección aórtica

Causa → Degeneración de las arterias (**HTA principalmente**, Ehler-danlos, Marfán, etc.) y causas traumáticas

Clínica → Dolor torácico súbito, intenso, irradiado al dorso, de característica transfixiante.

Suele asociarse a crisis HTA, asimetría de pulsos, disfonía por compresión del laríngeo recurrente y soplo diastólico aórtico.

Diagnostico → Angio TAC de tórax o Ecocardio TE. ECG suele estar normal. Rx de tórax muestra ensanchamiento del mediastino.

Se clasifica en tipo A o B. A es sobre la subclavia o B bajo la subclavia. La tipo A se opera, mientras que, la disección tipo B se maneja médicamente para control de la crisis HTA (Labetalol y nitroprusiato generalmente)

**NUNCA JAMAS DAR:
ASPIRINA
HEPARINA
TROMBOLISIS**

ANEURISMA AÓRTICO ABDOMINAL

Causa → Enfermedad ateromatosa, es decir, es una situación de máximo riesgo coronario (es un equivalente coronario).

Clínica

No complicado → Asintomático, a lo más se palpa masa pulsátil en abdomen

Complicado → Roto, viene con una triada compuesta por **shock hipovolémico, dolor y masa pulsátil**.

Si un adulto mayor viene con sospecha de cólico renal, este es un aneurisma aórtico abdominal hasta que se demuestre lo contrario (Se preguntó una vez).

Diagnóstico → Eco abdominal (Aorta >3cm)

Tratamiento → Depende del diámetro

<5cm → Conservador. Se sigue con eco abdominal y se manejan los factores de riesgo cardiovascular

>5cm → Cirugía electiva (Stent endovascular o prótesis)

>8cm → Cirugía en el corto plazo

Roto → Cirugía de urgencia + manejo del shock (suelen morir)



Aneurisma micótico → Aneurisma de causa bacteriana (no hongos), generalmente secundario a embolia séptica de una endocarditis.

6. Angina cardiaca

Se pregunta con cierta frecuencia

Angina estable → Dolor torácico precordial durante el esfuerzo que cede con el reposo. El diagnóstico es clínico

Estudio → test de esfuerzo y luego coronariografía. Con esta yo decido si hago **un bypass o angioplastia**.

Si la persona tiene BCRI, amputación de EEII o intolerancia al esfuerzo, NO SE PUEDE hacer el test de esfuerzo. En estos casos debemos realizar test equivalentes al de esfuerzo.

Equivalentes al test de esfuerzo → Ecocardio con dobutamina y Cintigrafía con talio-dipiridamol.

Angina estable asociada a soplo o síncope (se suele preguntar) → Sospechar estenosis aortica (viejos generalmente) o miocardiopatía hipertrófica (jóvenes generalmente). **Estos casos se estudian con eco-cardio**

Test de esfuerzo alterado → Debemos dar aspirina, nitroglicerina y manejo de factores de riesgo cardiovascular, además de hacer una coronariografía para decidir si ponemos un stent o hacemos bypass. La angioplastia se elige cuando hay afección de 1 o 2 vasos.

El bypass se elige en casos de:

- Afección de 3 vasos
- Compromiso de 2 vasos con compromiso de la descendente anterior
- Cuando la obstrucción es muy larga.

Angina inestable

- Dolor en reposo
- Angina que cambia de características (en relación a anginas previas)
- Primer episodio de angina

Se estudia con ECG porque es un SCA. El manejo es el del SCA.

7. Endocarditis Bacteriana y enfermedad reumática

Endocarditis

Clínica de sepsis + soplo cardíaco + criterios de Duke

Estudio → Ecocardiograma y hemocultivos son la clave.

Ecocardio → Buscamos vegetaciones valvulares, insuficiencia valvular y abscesos perivalvulares

Los agentes más comunes son el **S. aureus (el más común)**, *S. viridians* (el más frecuente de endocarditis subagudas), Enterococo y bacterias del grupo HACEK.

El diagnóstico se hace con los criterios de Duke (no esperemos encontrarlos todos, hay que sospecharlo con algunos)

Mayores

- Hemocultivo positivo para una de las bacterias clásicas de endocarditis
- Ecocardiograma (+) para endocarditis
- Soplo de nueva aparición

Menores

- Fiebre
- Antecedentes de enfermedades cardíacas (cardiopatía, Valvulopatías)
- Uso de drogas EV
- Hemorragias subconjuntivales

- Lesiones de Osler y Janeway
- Enfermedad inmunológica (glomerulonefritis asociado a Endocarditis es lo mas común)

Tratamiento

ATB→ **Cloxacilina** (S aureus) + **gentamicina** (para potenciar la cloxa y cubrir HACEK) + **ampicilina** (Para Strepto y Enterococo). Este tratamiento puede ser modificado una vez teniendo el resultado de hemocultivo.

Profilaxis ATB→ Se administra en caso de EBSA previa o cardiopatía no corregida ante procedimientos dentales, GU o GI.

Enfermedad reumática (fiebre reumática)

Nunca se ha preguntado enfermedad reumática, hay que conocer sus clínica para sospecharla



Diagnóstico es clínico

- Antecedente de infección estreptocócica
- Eritema marginado (marca eritematosa en forma de anillo)
- Nódulos reumáticos (en codos generalmente)
- Corea de Sydenham
- Artritis migratoria
- Frotos pericárdicos (afecta las 3 capas del corazón, asique puede dar clínica de cualquier afección de ellas)

Tratamiento→ Penicilina G + AAS

8. Insuficiencia Cardíaca Congestiva

Suelen haber 1 a 2 preguntas de este tema

Definición→ Incapacidad del corazón de bombear sangre a volúmenes adecuados o con una presión de fin de diástole elevada. Es decir, **Gasto cardíaco disminuido o PFD elevada.**

Causas

- Cardiopatía hipertensiva (la mas frecuente)
- Cardiopatía coronaria (2ª en frecuencia)
- Valvulopatías, miocardiopatías, otras

Cardiopatía hipertensiva→ A este diagnóstico nos orienta el antecedente de hipertensión de larga data, ECG con signos de hipertrofia del VI y Ecocardio con hipertrofia concéntrica del VI.

Cardiopatía coronaria→ A este diagnóstico nos orienta el antecedente de Factores de riesgo cardiovascular con ECG con onda Q y en la Ecocardio se ve una zona hipoquinética que nos habla de infarto previo.

ICC izq.→ Síntomas respiratorios por congestión pulmonar (disnea de esfuerzo, ortopnea, DPN) y EPA finalmente

ICC derecha → Síntomas generales como astenia y adinamia y de congestión venosa (ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema de EEII principalmente.)

ICC global → IC der + izq.

Disfunción sistólica → Cardiomegalia, choque de punta desplazado y R3

Disfunción diastólica → Hipertrofia concéntrica y R4

Clasificación de la disnea (capacidad funcional)

I → Sin disnea

II → Disnea de grandes esfuerzos

III → Disnea de pequeños esfuerzos

IV → Disnea de reposo

Clasificación de IC

A → Solo Factores de riesgo

B → Cambios estructurales, sin síntomas

C → Síntomas de ICC

D → Síntomas refractaria

Estudio de ICC

Ecocardio → ME permite determinar la causa y el pronóstico (dado por la función ventricular).
Si la FE es mayor a 55% tiene un buen pronóstico

ECG → Signos de hipertrofia VI, ondas Q, los cuales no pueden orientar a la etiología. Es buena, pero LEJOS de reemplazar al Ecocardio que es el gold standard.

Tratamiento

Que aumenta sobrevida → Son siempre de elección

- **IECA (ARA II en caso de RAM)**
- **Betabloqueo (carvedilol de elección)**
- **Espironolactona**
- **Hidralazina + isosoribide**

Sintomático → Son los primeros en quitarse

- **Diuréticos (de asa principalmente, como la furosemida)**
- **Digitálicos**

A → Solo tratar FR

B → IECA + Betabloqueo

C → + Espironolactona (+ furo/Digoxina)

D → + Trasplante cardiaco o marcapaso de resincronización

COR pulmonar → ICC derecha 2ª a HTP. Generalmente 2º a EPOC o fibrosis pulmonar. Su manejo es el tratamiento de la patología de base

Jamás habló del diagnóstico de insuficiencia cardiaca

Tabla 9. Criterios de Framingham para diagnóstico de IC*

Criterios Mayores	Criterios Menores
Disnea paroxística nocturna u ortopnea	Tos nocturna
Distensión venosa yugular	Disnea de esfuerzo
Crepitaciones pulmonares (> 10 cm desde la base pulmonar)	Taquicardia > 120 lpm
Galope por R3	Edema maleolar bilateral
Cardiomegalia clínica o en Rx de Tórax	Derrame pleural
Edema pulmonar agudo clínico o en Rx de tórax	Hepatomegalia
Reflujo hepato-yugular	Disminución de capacidad vital a 1/3 de la máxima registrada
Disminución de peso > 4.5 kg en respuesta a tratamiento de IC	

*Para el diagnóstico de IC se requieren 2 criterios mayores o 1 criterio mayor y 2 menores



Es clínico con criterios de Framingham
(2 mayores o
1 mayor y 2) menores)

Dato extra de creggers:

Tabla 12. Condiciones que pueden modificar los niveles de péptidos natriuréticos

Aumentan el nivel de péptidos natriuréticos	Reducen el nivel de péptidos natriuréticos
Edad	Inhibidores de enzima de conversión
Insuficiencia renal	Antagonistas receptores de angiotensina II
Género femenino	Diuréticos de asa
Enfermedades pulmonares: EPOC, Neumonía, TEP	Betabloqueadores (uso crónico)
Betabloqueadores (uso agudo)	Espironolactona
HTA	Hidralazina
Cirrosis hepática con ascitis	Isosorbide
Fibrilación auricular	Obesidad

9. Paro cardíaco

No se pregunta tanto

La mortalidad es alta

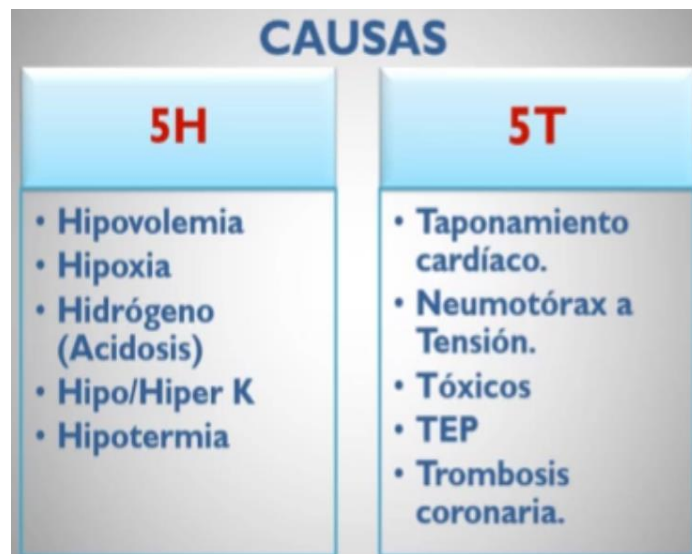
Paciente que no se mueve, no respira y no tiene pulso

Manejo→ RCP básico (30 compresiones y 2 ventilaciones) Se reevalúa cada 5 ciclos (2 min)

Se aplica el CAB, porque acá **lo más importante son las compresiones**

Causas

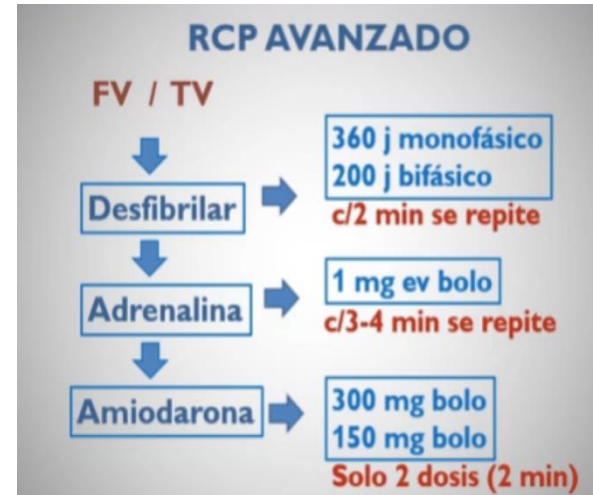
- 5H y 5T



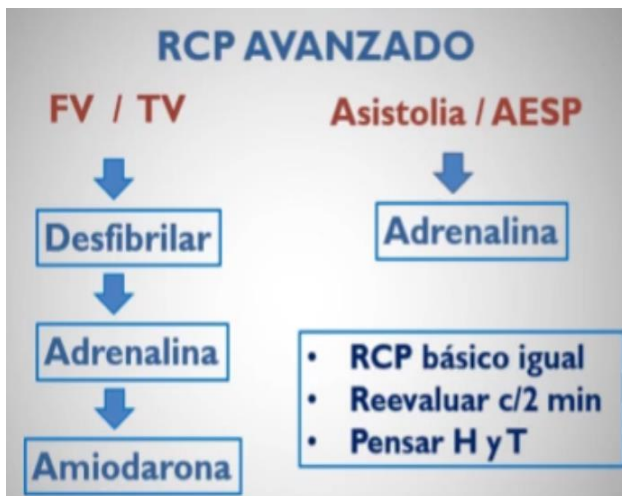
RCP avanzado→ Es el que se realiza en el contexto hospitalario

1ª pregunta → ¿El ritmo es desfibrilable? → TV sin pulso y FV

Ritmos no desfibrilables → Asistolia y actividad eléctrica sin pulso (cualquier trazado sin pulso, salvo TV y FV)



Manejo general



¿Cuando suspendo RCP? → Cuando sale de paro (tiene pulso) o cuando se declara la muerte (tras 20-30 minutos de RCP)

En caso de que el paro se presencie en el hospital, se debe iniciar con la desfibrilación

10. Shock

Se pregunta bastante y con cierta dificultad

Shock → Falla circulatoria con hipoperfusión e hipoxia de los tejidos en general. Viene con hipotensión, diaforesis, palidez, livedo reticularis, FC alta o baja y compromiso de conciencia

Hay de 3 tipos

- Hipovolémico → Por deshidratación o pérdidas de sangre
- Cardiogénico → Por insuficiencia cardíaca o taponamiento cardíaco
- Vasodilatador (el mas preguntado) → Incluye al shock séptico, anafiláctico y medular

Manejo

Hipovolémico → Suero fisiológico Ev. Si no responde se administran coloides

Cardiogénico → Manejo de la causa (angioplastia, cardioversión eléctrica, drogas vasoactivas etc.). **NO SE PUEDE DAR SUERO FISIOLÓGICO POR RIESGO DE EPA.**

Vasodilatador → Suero fisiológico + drogas vasoactivas. No responde solamente a SF, se requieren DVA.

SHOCK			
	PVC	PCP	RVP
Hipovolémico	↓	↓	↑
Cardiogénico	↑	↑	↑
Vasodilatador	↓	↓	↓

PVC: Presión venosa central PCP: Presión capilar pulmonar RVP: resistencia vascular periférica

Manejo general

- Hospitalizar UCI
- Régimen O
- Procalcitonina (elevado en shock séptico), lactato más mil pruebas más
- **Cristaloides (Para PVC sobre 8) , oxígeno (sobre 93%) y DVA (para PAM sobre 65)**

11. Valvulopatías, miocardiopatías y enfermedades del Pericardio

VALVULOPATÍAS

- Estenosis → Obstrucción de una válvula
- Insuficiencia → Cuando la válvula no es capaz de cumplir su función y se devuelve sangre
- Enfermedad → Estenosis + insuficiencia

Generalidades

Izquierda → Mitral y aórtica. Producen clínica de insuficiencia izquierda. Disnea, Ortopnea y DPN

Derecho → Tricuspídea y pulmonar. Producen clínica de insuficiencia derecha. Hepatomegalia, edema y yugulares ingurgitadas.



Estenosis mitral → Soplo diastólico, R1 aumentado, chasquido de apertura, dilata la aurícula izquierda y por tanto puede ser la causa de FA.

Insuficiencia mitral → Soplo holsistólico, R1 disminuido, dilata aurícula y ventrículo izquierdo, es una causa de gran cardiomegalia

Estenosis	MITRAL	Insuficiencia
- Soplo diastólico - Refuerzo presist. - R1↑ - Chasquido apertura - Chapas mitrálicas - Hemoptisis - Dilatación de AI - FA		- Soplo holsistólico - R1↓ - Dilatación VI y AI - HT excéntrica - Cardiomegalia - Desplazamiento choque punta

Estenosis aortica → Soplo sistólico eyectivo (mesosistólico), R2 disminuido, Click de apertura, asociado a **Síncope de esfuerzo, angina cardiaca y riesgo de muerte súbita**, produce hipertrofia de aurícula y ventrículo izquierdo y pulso parvus et tardus (pequeño y lento)

Insuficiencia aórtica → Soplo diastólico, R2 disminuido, dilatación del ventrículo izquierdo, cardiomegalia muy grande y un pulso muy amplio. Genera danza arterial del cuello (por el pulso amplio)

Estenosis	AÓRTICA	Insuficiencia
- Soplo mesosistól. - R2 ↓ - Click de apertura - Síncope esfuerzo - Angina - Muerte súbita - HT AI y VI concen. - Pulso parvus-tardus		- Soplo diastólico - Soplo Austin Flint - R2 ↓ - Dilatación VI - Cardiomegalia!! - Pulso amplio o celler - Danza arterial en cuello

Estenosis tricuspídea → Soplo diastólico, R1 aumentado, chasquido de apertura, dilata aurícula derecha por lo cual, se asocia a Flutter auricular

Insuficiencia tricuspídea → Soplo holsistólico con R1 disminuido, dilación de aurícula y ventrículo derecho

Estenosis	TRICÚSPIDE	Insuficiencia
- Soplo diastólico - Refuerzo presistólico - R1 ↑ - Chasquido - Dilatación AD - Flutter auricular - Pulso venoso onda "a" gigante		- Soplo holosistólico - R1 ↓ - Dilatación VD y AD - Pulso venoso onda "v" gigante

Estenosis pulmonar → Soplo eyectivo (mesosistólico), R2 disminuido, dilatación de aurícula derecha

Insuficiencia pulmonar → Soplo diastólico, disminución de R2 con dilatación del Ventrículo derecho.

Estenosis	PULMONAR	Insuficiencia
- Soplo mesosistólico - R2 ↓ - Click de apertura - Dilatación de AD - Hipertrofia concéntrica de VD		- Soplo diastólico - R2 ↓ - Dilatación VD

Manejo de Valvulopatías (no se pregunta tanto, se pregunta la semiología de Valvulopatías)

Diagnostico → Ecocardiograma

Tratamiento

- Médico → Si es leve y/o asintomática
- Quirúrgico → Si es severa y/o sintomática → Se puede realizar una plastia valvular (si están los velos en buen estado) o prótesis valvular. Las prótesis pueden ser **mecánicas** (es buena, dura para siempre (**para pacientes jóvenes**) pero se necesita anticoagulación de por vida) o **biológicas** (**En mayores de 70 años**, No requiere TACO pero dura solo 10 años)

MIOCARDIOPATÍAS

Hay 3 tipos

- Hipertrófica→ Genética autosómica dominante (en pacientes jóvenes con antecedentes familiares)
- Dilatada→ Idiopática, se cree que hay relación con miocarditis virales. Puede ser secundaria a Chagas o uso de alcohol/drogas
- Restictiva→ Por enfermedades de deposito (amiloidosis, hemocromatosis), de muy mal pronóstico. Se pregunta poco



Hipertrófica→ ICC izquierda. Fácilmente **se confunde con la estenosis aortica** pues son parecidas.

Presenta angina, síncope, soplo sistólico eyectivo y muerte súbita (el síntoma más frecuente).

La diferencia con la estenosis aórtica es que se da en paciente jóvenes, presenta pulso celler (amplio) y el soplo aumenta en valsava y disminuye en cuclillas.

Eco: HT concéntrica y de tabique

Tratamiento: Betabloqueo y verapamilo. Qx podría ser necesaria por obstrucción mecánica del tabique. Si tiene **alto riesgo de muerte súbita (dado por síncope, arritmias o antecedentes familiares de muerte súbita)**, se debe poner un DAI (desfibrilador externo implantable)

Dilatada→ICC izquierda. Presenta cardiomegalia y soplos holsistólico por insuficiencia mitral
Eco: HT concéntrica con paredes delgadas y baja contractibilidad. No tiene cardiomegalia (esto la diferencia de la hipertrófica)

Tratamiento: Si es que hay una causa tratable (Chagas u OH) esta debe ser tratada. Si no hay causas tratables se da el tratamiento de la insuficiencia cardiaca. Son buenos candidatos a trasplante.

Restictiva→ ICC global de instalación rápida y rápido deterioro. Tiene un muy mal pronóstico (6 meses)

Eco: Aumento de la refringencia del miocardio

Tratamiento→ Besito en la frente y pa la casa



Estudio→ Todas con ecocardiograma

ENFERMEDADES DEL PERICARDIO

Hay que conocer 3. Se pregunta con cierta frecuencia

- Pericarditis
- Derrame
- Pericarditis constrictiva

Pericarditis

Causa: Suelen ser idiopática, uno asume que son virales (Coxsackie, ecovirus). Pueden ser por enfermedades autoinmunes, TBC, por IAM o por uremia (pericarditis urémica)

Clínica→ Dolor torácico en adulto joven generalmente. Aumenta con la inspiración y disminuye al inclinarse hacia adelante. Puede presentar frotos pericárdicos. El estudio es con ECG (SDST con concavidad superior difusos, en todas las precordiales o descenso del PR).

Se pide el Ecocardio igual para descartar un derrame y CK para descartar miocarditis

Tratamiento→ AINEs a altas dosis

Derrame pericárdico

Causado por pericarditis (lo más frecuente), insuficiencia cardíaca, cáncer o hemopericardio por heridas penetrantes.

Clínica→ Es una clínica pobre. Ruidos cardíacos apagados, signo de Kussmaul (ingurgitación de yugulares al inspirar profundo) y alternancia eléctrica del ECG (el QRS cambia de amplitud) Finalmente puede llegar a un taponamiento cardíaco (Ingurgitación yugular, hipotensión arterial y ruidos apagados)

Tratamiento→ De la causa. En caso de taponamiento cardíaco se debe hacer una pericardiocentesis de urgencia.

Pericarditis constrictiva

De causa idiopática generalmente. Secundarias a pericarditis agudas previas.

Clínica→ IC derecha, signo de Kussmaul y pulso venoso con Y prominente y frotos pericárdicos. El estudio es con Ecocardio.

Tratamiento→ Pericardiectomía

12. Manejo de arritmias en Urgencias

Tenemos 3 opciones:

Pueden llegar muertos, HDN inestables o HDN estables

Muertos → RCP avanzado

HDN inestable → Hay que diferenciar si es taqui o bradiarritmia. Taquiarritmia se debe cardiovertir eléctricamente de inmediato y la bradiarritmia se pone marcapaso externo transitorio.

HDN estable → Se hace un ECG y manejo según la arritmia.

Desfibrilación → Para el paro, se manda la descarga eléctrica de una (no sincronizada). Se utiliza una gran energía (200 joules)

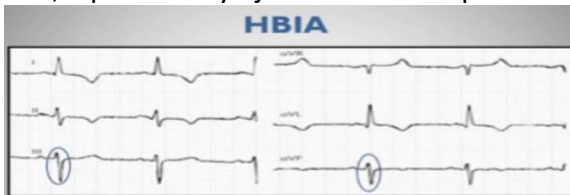
Cardioversión → La descarga eléctrica se hace sincronizada y es de menor intensidad (50 Joules)

13. Bradiarritmias

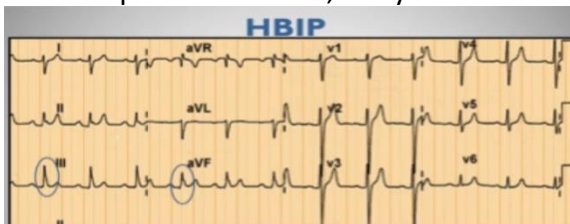
Son enfermedades degenerativas por daño del sistema eléctrico

- Bloqueo de rama → **Todos se observan, salvo el BCRI** agudo en contexto de SCA pues esto equivale a Supradesnivel de ST.

- BCRD → Se ve un QRS ancho con patrón rSR' (se ven 2 erres, **Orejas de conejo**) en V1 y V2
- BCRI → También tiene un QRS ancho con S profunda en V1 y V2 y una onda R alta en V5 y V6.
- BIRD y BIRI → Son iguales a los bloqueos completos pero con un QRS angosto
- Hemibloqueo izquierdo anterior (HBIA) → QRS angosto con patrón rS en DII, DIII y aVF, S profunda y eje desviado a izquierda.



- Hemibloqueo izquierdo posterior (HBIP) → QRS angosto, pero es al revés porque tiene un patrón Rs en DII, DIII y aVF con un eje desviado a derecha



Estos ultimo dos nunca se han preguntado (grax por decirlo después de que me di la paja de entenderlos, escribirlos y hasta pegar esta imagen qia, tartamudo de mierda)

- **Bloqueos auriculoventriculares (BAV) (estos si se preguntan más)**

Existen de 1er, 2º y 3er grado.

1er grado → segmento PR largo (> 200mseg) pero todas las P conducen

2º grado → Algunas P conducen y otras no

Mobitz 1 → El PR se va alargando hasta que una P no conduce

Mobitz 2 → PR normal hasta que espontáneamente una P no conduce

3er grado → Ninguna P conduce, hay disociación auriculoventricular. La FC suele ser de 30lpm

Bloqueo trifascicular → BAV de primer grado + BCRD + HBIA o HBIP. En cualquier minuto esto hace un bloqueo de tercer grado.

Manejo

1er grado → Se observa

2º Grado → Se observa

Mobitz 1 → Se observa

Mobitz 2 → **Marcapaso**

3er grado → **Marcapaso**

Trifascicular → **Marcapaso**

- **Enfermedad del nodo sinusal**

Su manejo va a depender de si es sintomática (sincopes) o no.

Si no es sintomática solo se observa. En caso de ser sintomática se pone marcapaso

Son bradicardias irregulares que pueden alternarse con FA (síndrome de taquicardia-bradicardia)

14. Taquiarritmias

TPSV

- QRS angosto
- Ritmo regular
- Con o sin onda P

Causas

- Fenómenos de reentrada
 - o Reentrada nodal
 - o Haz paraespecífico (WPW)

Tratamiento

Sigue un orden que debemos respetar

HDN estable

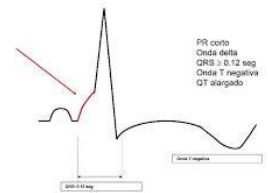
1. Maniobras vagales
 - Masaje carotideo
 - Valsalva
2. Adenosina en bolo (6/12/12)
3. Verapamilo
4. Amiodarona

Tratamiento definitivo → Ablación con radiofrecuencia del haz paraespecífico o de la reentrada nodal. Esto se debe determinar con un estudio electrofisiológico

HDN inestable → Cardioversión cardiaca

Síndrome de Wolf Parkinson White

Acortamiento del PR, ensanchamiento del QRS y aparición de onda delta (explica los 2 fenómenos anteriores)



TPSV con aberrancia → TPSV con bloqueo de rama (QRS ancho), se maneja igual a una TPSV

TPSV retrógrada → QRS ancho, es igual a una TV → Se maneja con amiodarona (como una TV)

FA + WPW → QRS ancho variable → Se trata igual a una TV

Taquicardia Ventricular

QRS ancho con ritmo regular o irregular

TV monomorfa → Reentrada ventricular por una cicatriz (generalmente por IAM)

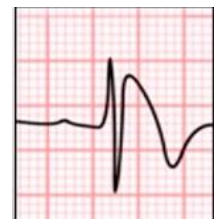
Tratamiento → Lidocaína o amiodarona en caso de estar HDN estable. Si está HDN inestable se debe hacer CVE (como todas las TV HDN inestables, lo cual, es frecuente)

Síndrome de Brugada

Canalopatía genética. Es un BCRI + SDST V1-V2 que cae.

Tiene riesgo de muerte súbita

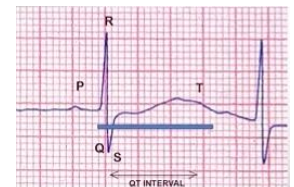
Manejo → DAI



Síndrome de QT largo

Canalopatía genética. QT mayor a 440ms (10 cuadraditos). Se complica con torsión de puntas.

Manejo → DAI y evitar todo lo que me alargue el QT. (HipoMg, K y Ca)



Torsión de puntas

Taquicardia con QRS ancho irregular con patrón sinusoidal.

Causa→ Cualquier cosa que me alargue el QT.

Tratamiento→ Sulfato de magnesio + marcapaso externo transitorio

Si está HDN inestable (casi siempre), se debe realizar CVE.

15. Fibrilación auricular

En el ECG se ve como un ritmo irregular con ausencia de onda P y QRS angosto. Su FC va a depender del grado de bloqueo del nodo AV.

Causas→ Cualquier cosa que me dilata la aurícula izquierda o estados hiperdinámicos

1. Dilatación de las aurículas
 - a. HTA
 - b. Valvulopatías (estenosis mitral principalmente)
 - c. Cardiopatía congénita
 - d. Miocardiopatía
2. Estado hiperdinámico (todo lo que me acelere el ritmo cardiaco)
 - a. Sepsis
 - b. Hipertiroidismo
 - c. SCA

El pronóstico está determinado por la causa.

Se clasifica en aguda y crónica

Aguda

HDN inestable→ CVE

HDN estable→ Se trata con fármacos. En primer lugar (1) debemos controlar la frecuencia cardiaca. Segundo (2) debemos volver a ritmo sinusal (cardioversión farmacológica si HDN estable y lleva menos de 48 horas) y en tercer lugar (3) debemos anticoagular en caso de que lleve más de 48 hrs para cardiovertir tras 4-6 semanas. Finalmente debo tratar la causa

1. Control de frecuencia→ Propanolol (BB Ev), verapamilo o lanatósido C (digitálico Ev).
 - a. Propanolol→ Contraindicado en ASMA y EPOC
 - b. Lanatósido C→ Contraindicado en ERC (por riesgo de intoxicación)
 - c. Verapamilo→ Contraindicado en shock, (esto se preguntó). Ojo que si esta en shock la indicación es la cardioversión eléctrica porque no está HDN estable.
2. Control de ritmo→ Amiodarona, propafenona o procainamida
 - a. Amiodarona→ Contraindicado en Hipertiroidismo (viene con mucho yodo) y fibrosis pulmonar (esto se preguntó)
 - b. Propafenona→ Contraindicado en cardiopatías, en corazón sano es de elección
 - c. Procainamida→ Contraindicado en cardiopatías, en corazón sano es de elección

3. Anticoagulación→ Se inicia con heparinas y luego se mantiene con cumarínicos (TACO). La decisión de anticoagulación se toma con el Eco TE para ver si hay o no hay trombos. De no haber, se cardiovierte farmacológicamente, pero en caso de haber trombos hay que dar anticoagulación y control de frecuencia y tras 4-6 semanas hago la cardioversión.
4. En caso de que la eco TE no esté disponible (la mayoría de los casos) la decisión va a depender del tiempo, pues, si lleva mas de 48 horas se decide anticoagular, y cardiovertir tras 4-6 semanas, pero si lleva menos de 48 horas se decide cardiovertir

FA Crónica

Paroxística→ Pasa de FA a ritmo sinusal de forma espontanea

Persistente→ Pasa a ritmo sinusal solo con fármacos

Permanente→ Nunca pasa a ritmo sinusal

La 1ª pregunta importante en el manejo de la FA es determinar si doy control de ritmo o de frecuencia.

La FA paroxística queda con control de ritmo , mientras que, las otras 2 quedan con control de frecuencia, aunque esto no es estricto, puede dejarse indistintamente un tratamiento u el otro.

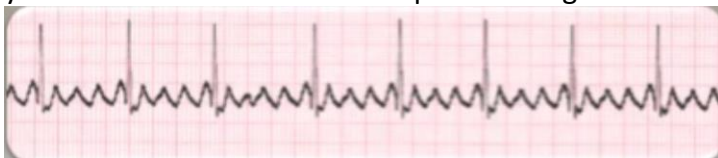
La 2ª pregunta es si dejo anticoagulación o antiagregación

Control de ritmo v/s control de frecuencia→ Control de ritmo se hace con amiodarona de forma crónica idealmente o se puede dejar propafenona o flecainamida que son de uso SOS.

La amiodarona se deja en pacientes con corazón enfermo, mientras que las propafenona y flecainamida en pacientes con corazón sano.

Control de frecuencia es con Propanolol, Digoxina o verapamilo.

Flutter Auricular→ Ritmo regular con ondas P de serrucho en DII, DIII y aVF. Tiene QRS estrecho y su frecuencia cardiaca va a depender del grado del bloqueo del nodo AV (igual que en FA)



Causas

- Dilatación de la aurícula **derecha** (se produce fenómeno de reentrada)

Manejo→ Igual a la FA. Se debe hacer un estudio electrofisiológico para realizar una ablación del istmo cavotricuspideo que va a solucionar definitivamente esta patología

16. Hipertensión Arterial primaria y secundaria

Se pregunta siempre y con bastante especificidad, por lo cual, hay que manejarlo en detalle

Diagnostico

1. 3 tomas de P/A mayor a 140
2. Una sola toma de presión sobre 180/110
3. Holter de presión arterial con promedio sobre 140/90

El Holter de presión se reserva para aquello paciente con sospecha de hipertensión del delantal blanco. Se prefiere toma seriada de presión para el resto de los pacientes

Clasificación

Se puede clasificar en base a la causa o en base a la severidad

Causa

Esencial o 1ª → 90%

2ª → 10%

1. Renovascular es la principal (**5% de las HTA**)
2. Glomerulopatías médica (Causas de Insuficiencia renal crónica, **4% de las HTA**)
3. Hiperaldosteronismo primario
4. Feocromocitoma

En pediatría estos números se invierten, pues suele ser 2ª.

Severidad→ Esta clasificación tiene importancia para la elección del tratamiento a seguir. La etapa II se inicia inmediatamente con fármacos

Etapa I→ Sobre 140/90

Etapa II→ Sobre 160/100

Objetivos de PA→ Bajo 140/90

ERC (y DM2 con daño renal (proteinuria o aumento crea))→ 130/80

Daño órgano Blanco

Cardiopatía hipertensiva→ La 1ª causa de ICC (principalmente ICC izq.). Screening con ECG 1 vez al año buscando hipertrofia ventricular (Índice de Sokolow > 35mm). Si está alertado se pide una Ecocardio. El tratamiento se hace tratando la HTA y la ICC.

Índice de Sokolow→ La S en V1 o V2 + la R en V5 o V6 > 35mm

Retinopatía hipertensiva→ Suele ser totalmente asintomática. Solo en casos graves puede haber vasos de neoformacion y hemorragia vítrea. El Dg es con fondo de ojo (anual).

Esta patología refleja el estado general de resto de los órganos. Es un reflejo del daño generalizado de la HTA.

Nefropatía hipertensiva → Se caracteriza por ser una ERC (elevación de la crea) , es la 2ª causa de ERC tras la diabetes.

ACV → Lo mas habitual es que hayan de tipo lacunar o hemorrágico por daño de las arterias perforantes (forman aneurismas que se pueden trombosar o romper)

HTA SECUNDARIA

¿Que nos hace sospechar HTA 2ª ?

1. Edad de comienzo (antes de los 30 o después de los 55)
2. P/A sobre 160/100 (etapa II)
3. HTA resistente → No logra metas de HTA con uso de 3 antihipertensivo, siendo uno de estos un diurético en dosis máximas.
4. HTA maligna → Rápido daño a órgano blanco (rápida falla renal usualmente), el cual, se ve generalmente en el fondo de ojo.
5. Rápido daño a órgano blanco
6. Hipokalemia (renovascular e hiperaldosteronismo 1º) o hiperkalemia (ERC)
7. Elevación de la creatinina

HTA Renovascular

La vamos a sospechar en 3 casos

1. Soplo abdominal (por estenosis renal)
2. Hipokalemia
3. Elevación de la crea la iniciar IECA/ARA II

Se estudian con doppler renal

Tratamiento → IECA/ARA II o stent en caso de falla renal

Nefropatías médicas

Sospechar ante elevación de la creatinina, hiperkalemia y edema

Se diagnostica con la función renal (**Crea** + Proteinuria + BUN + ELP) y Eco renal (muestra riñones chicos, atróficos, hiperrefrigentes)

Tratamiento → Manejo de la volemia (restricción de agua y sal) es lo mas importante.

Además debe tratarse la causa

Hiperaldosteronismo 1º

Sospechar ante hipokalemia, debilidad, cefalea y calambres

El diagnostico se hace con el índice aldosterona/renina (sobre 50)

Se pide TAC de suprarrenales porque puede ser por tumor o hiperplasia

El tratamiento generalmente es con Espironolactona (diurético inhibidor del receptor de aldosterona), pero en caso de ser por un tumor se debe operar.

Feocromocitoma

Tumor productor de catecolaminas.

Se presenta como palpitaciones, cefalea, sudoración y crisis hipertensiva generalmente.

Estudio→ Metanefrinas en orina de 24 horas (Gold estándar) y TAC de suprarrenal para buscar tumor

Tratamiento→ Alfabloqueantes como 1ª cosa, luego betabloqueo y finalmente se opera. (DEBE ser en ese orden)

Tratamiento de la HTA

Manejo no farmacológico

1. Dieta hiposódica (7g de sal al día)
2. Baja de peso (10%) en caso de Sobrepeso u obesidad
3. Evitar consumo de cafeína, tabaco y drogas
4. Ejercicio aeróbico (el anaeróbico aumenta las cifras de PA)
5. Manejo de factores de riesgo cardiovascular (DLP, DM2, tabaquismo, etc.)

Se controlan cada 3 meses.

En etapa I se inicia tratamiento no farmacológico y se reevalúa a los 3 meses

En caso de estar en etapa II se parte con manejo farmacológico y no farmacológico inmediatamente.

Manejo farmacológico

Cuando iniciar?

1. Etapa II
2. Etapa I que no responde medidas generales en 3 meses

Familias de fármacos

1. IECA (A)
2. ARA II (A)
3. Betabloqueo (B)
4. Bloqueadores de canales de calcio (C)
 - a. Dihidropiridínicos→ Amlodipino
 - b. NO dihidropiridínicos→ Diltiazem
5. Diuréticos (D)

Cual debemos usar? → Depende de 3 cosas

1. Edad
2. Comorbilidades
3. Contraindicaciones

IECA

El mas usado es le enalapril (5-10mg cada 12 horas).

Se da en pacientes menores de 55, DM2 y en caso de ICC (mejora sobrevida)

Contraindicaciones → **Hiperkalemia** sobre 5, Insuficiencia renal aguda, ERC en etapa 4

ARA II

No son de elección, son el reemplazante del IECA

Losartán es el típico (12,5 a 100mg al día)

Indicado cuando se desea reemplazar al IECA por Tos o angioedema (solo en estos dos casos)

Betabloqueo

Atenolol es el más usado (50-100mg al día)

Se da en pacientes menores de 55 años, jaqueca (profilaxis de jaqueca), FA y/o ICC

Contraindicaciones → **Asma y EPOC** (broncoconstricción), DM2 (podría ocultar síntomas de hipoglicemia) y Bradiarritmias.

Bloqueadores de canales de calcio

El clásico es el Amlodipino (5-10mg dl día)

En mayores de 55 años. Sirve también para la acalasia esofágica

Contraindicaciones → RGE, edema y Bradiarritmias

Diuréticos

Hidroclorotiazida es más usada (50-100mg dl día). Clortalidona hay que conocerla también

Indicaciones: Edad sobre 55 años, que tenga edema e hiperkalemia

Contraindicaciones: Gota (aumenta uricemia), dislipidemia, DM2 (aumenta la glicemia) e **hipokalemia**.

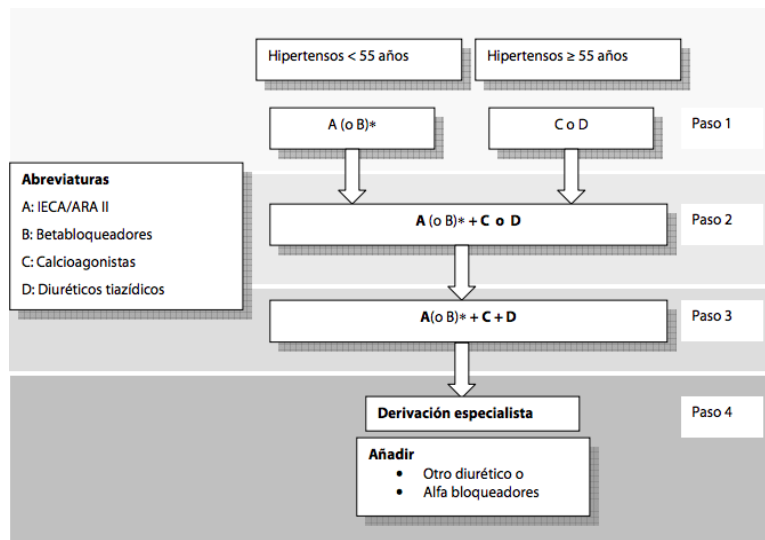
Si el paciente NO SIGUE LA DIETA HIPOSÓDICA y usa tiazidas, va a generar hipokalemia

Resumen de tto

<55 años → Iniciamos IECA o betabloqueo (A o B)

>55 años → Iniciamos Tiazidas o Amlodipino (D o C)





¿Que pasa si no logra la meta con 1 fármaco?

1. Reemplazar el fármaco
2. Aumentar la dosis
3. Agregar otro fármaco

Según MINSAL, si no logra metas, en etapa I debemos reemplazar el fármaco y en etapa II debemos aumentar dosis o agregar otro fármaco. En la realidad (y debemos responder esto en EUNACOM), **se debe evaluar el cambio según las comorbilidades del paciente y el valor del potasio**

Si debemos añadir un segundo fármaco, utilizaremos uno con el cual no iniciamos. Es decir, Si estaba con A o B, le agrego C o D y al revés (C o D le agrego A o B)

Crisis hipertensiva

Urgencias → P/A diastólica sobre 110. NO HAY DAÑO DE ÓRGANO BLANCO. Se trata con Captopril 25mg SL.

Emergencia → Viene con riesgo vital o daño de órgano blanco (Encefalopatía, IAM, EPA, disección aortica o ACV.

Se maneja con fármacos endovenosos (Labetalol, nitroprusiato o nitroglicerina)

17. Dislipidemia

Se pregunta con cierta frecuencia

Tipos

1. Hipertrigliceridemia
2. Hipocolesterolemia HDL
3. Hipercolesterolemia LDL

Hipertrigliceridemia → Sobre 150mg/dl. Además del riesgo CV, tiene alto riesgo de pancreatitis cuando están sobre 500. (¿?1000 según lo que yo se)

Hipocolesterolemia HDL → En hombres mantenerlo en más de 40 y mujeres más de 50. Si está sobre 60 es un factor protector

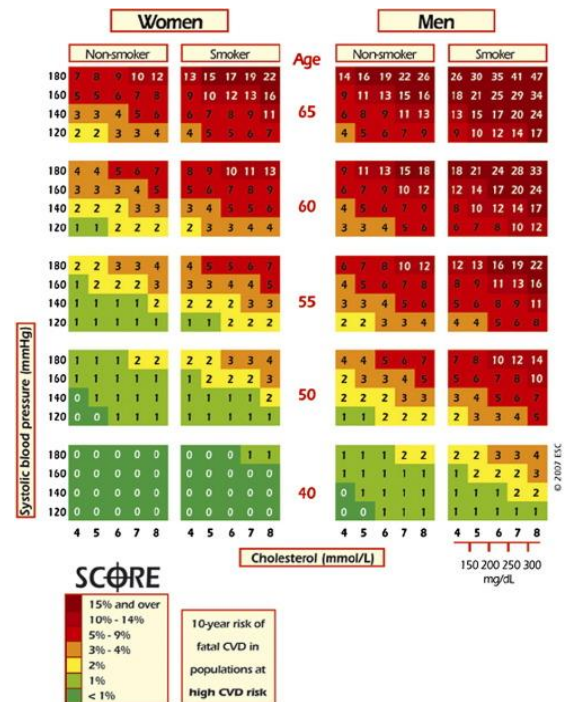
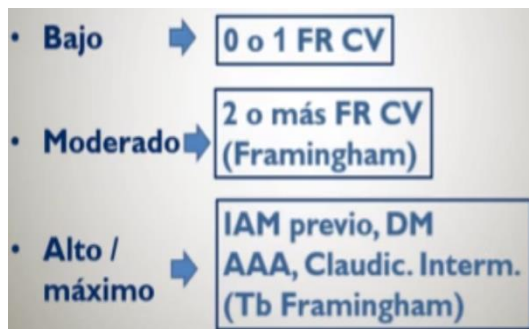
Hipercolesterolemia LDL → Sus niveles óptimos van a depender según el riesgo cardiovascular basal del paciente (Framingham).

RCV bajo → Bajo 130

RCV medio → Bajo 100

RCV alto → Bajo 70

RCV se calcula según el Score de Framingham.



Causa

Genética poligénica (muchos genes). Suele estar asociado a resistencia a al insulina

Manejo

Cambios de estilo de vida + dieta.

Inicio de tratamiento farmacológico:

- Si tras 3 meses no logra controlarlo
- LDL alto con FRCV moderado-alto
- Antecedentes de dislipidemia familiar

Dislipidemias mixtas → Viene con más de una alteración de los lípidos. En estos casos el tratamiento sigue un orden. Hay prioridades

1. Hipercolesterolemia LDL es lo primero a tratar

2. Hipertrigliceridemia es lo segundo
3. Hipocolesterolemia HDL es lo ultimo

En casos de que los TG estén sobre 500, esto va a ser lo primero que debemos tratar.

Los fármacos le pegan a todas las dislipidemias, pero mejor a una que otras.

Tratamiento

TG alto → Dieta baja en azúcares (como diabéticos pues se asocia a IR) y fibratos (gemfibrozilo)

HDL bajo → Dieta baja en azucares y acido nicotínico

LDL alto → Dieta baja en grasas saturadas y el tratamiento farmacológico a elección son las estatinas (Atorvastatina)

RAM → Hepatitis y rabdomiolisis, por lo tanto, se deben controlar con pruebas hepáticas y CK.

La CK se deben pedir en caso de:

1. Dolor muscular
2. IRC
3. Si toma dosis muy altas
4. En caso de usar estatinas y fibratos en conjunto (Estatinas + fibratos elevan muchísimo el riesgo de rabdomiolisis, por lo tanto, SON SOLO MANEJO DE ESPECIALISTA, nunca contestar esto en EUNACOM).

DIABETES (5 preguntas)

1. Generalidades

TIPOS DE DIABETES

1. DM1: autoinmune, en niños
2. DM2: + frecuente, causada por resistencia a la insulina (adultos)
3. DMG: embarazo, aumento de las hormonas de contrarregulación de insulina (lactógeno placentario)
4. DMPG: tb en embarazo, pero estaba diagnosticada antes de la semana 20
5. LADA: autoinmune de aparición tardía
6. MODY: causa genética, RI afecta a niños. Autosómica dominante, importante carga genética familiar.
7. Fármacos: corticoides
8. Quirúrgicas: pancreatectomía, pancreatitis crónica

CRITERIOS DIGNÓSTICOS

1. 2 glicemias de ayuno ≥ 126
2. 1 TTGO ≥ 200 a las 2 horas
3. 1 glicemia de ayuno ≥ 200 + síntomas (puede ser de ayuno o no). Síntomas 4 P (polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso)
4. DMG: - 2 glicemias ayuno ≥ 100
 - 1 TTGO ≥ 140 (2 horas) (no hay IGO en el embarazo)
 - 1 glicemia de ayuno
 - 1 glicemia de ayuno ≥ 200 + síntomas
5. DMPG: - Dx. Previo de DM
 - a. 2 glicemias de ayuno ≥ 126
 - b. 1 glicemia de ayuno ≥ 200 + síntomas AL INICIO DEL EMBARAZO
 - Hb1Ac: controversial, no está estandarizada en Chile. >6.5 . No es criterio
 - HOMA >2.6 : RI. (Glicemia x insulina) / 405
 - GAA: 100-125.
 - IGO: TTGO 140-199

SCREENING DE DIABETES

Glicemia de ayuno

- <100 : normal
- 100-125: TTGO
- ≥ 126 : repetir

TTGO

- <140 : normal
- 140-199: IGO
- ≥ 200 : DM

SCREENING EN EMBRAZO

Glicemia de ayuno

- <100: normal
- >100: repetir

TTGO (screening), 24-28 semanas

- 2h <140 y basal <100: normal
- 2h $\geq$ 140 y basal >100: DMG

TRATAMIENTO DM2

1. **No farmacológico:** bajar de peso, dieta baja en azúcares de absorción rápida, baja en grasas, ejercicio, no fumar, MANEJO FRCV
2. **Farmacológico**

Hipoglicemiantes orales:

- **Biguanidas:** metformina (buena, bonita, barata)
Disminuyen resistencia a la insulina. RAM: diarrea. No genera hipoglicemia
- **Sulfonilureas:** glibenclamida
Secretagogos, aumentan secreción de insulina. Producen mucha hipoglicemia. Glimepicida y glimepiride hacen menos hipoglicemia
- **Inhibidores DPP4:** gliptina
Secretagogos, aumentan secreción insulina. Hacen muy poca hipoglicemia. Son muy caros
- **Tiazolinedionas:** Glitazonas
Aumentan riesgo CV, no recomendada
- **Inh. Alfaglucosidasa:** acarbosa
Poco eficaz. NO LO MARQUE EN EL EXMEN
- **Agonistas GLP1:** Secretagogos, caros, Poco usados

Insulina:

- NPH: + usada
- IC

OBJETIVOS DIABETES

- HbA1c $\leq$ 7%: hay situaciones donde se es más permisivo ($\leq$ 8%): niños, adultos mayores >75 años y gente que hace muchas hipoglicemias (por riesgo de hipoglicemia)
- Disminuir el 10% del peso
- PA >140/90
- Perfil lipídico TG< 150, HDL >40 hombre >50 mujer, LDL< 70
- Glicemia preprandial <100, glicemia post prandial <130.

TRATAMIENTO CLÁSICO

1. Dieta, ejercicio y metformina
2. (+) dosis metformina: 500 mg/día o 850 a 1 g c/ 8 hrs
3. Agregar Glibenclamida
4. (+) dosis glibenclamida: 2.5 mg/día, 10 mg c/ 12 hrs
5. Agregar NPH nocturna.

Indicaciones

- Si HGO a dosis Máxima con HbA1c >7%
 - HbA1c $\geq$ 9%
 - Mantener metformina mejor que suspenderlo
 - Glibenclamida según MINSAL puede ser suspendida
6. Elevar dosis NPH nocturna (si glicemia ayuno está muy alta)
 7. Agregar NPH matinal (si glicemia preprandial y preCENA alta)
 8. Agregar IC (si glicemia postprandial alta)

TRATAMIENTO ACTUAL

1. Metformina Sigue siendo de elección
2. Glibenclamida: mucho riesgo de hipoglicemias → se prefieren inh. DPP4 (sitagliptina) para segunda línea. En Chile no hay recursos así que se usa glibenclamida igual
3. Cuando cambiar metformina por inh. DPP4:
 - RAM metformina
 - Si viene con hipoglicemias muy marcadas o falla renal es obligatorio

2. DM1 – LADA – CRITERIOS INSULINA

DM1

Tratamiento: INSULINA ESQUEMA INTENSIFICADO

1. 1 dosis insulina Glargina (Lantus MR) → 1 dosis en 24 hrs
(+) Insulina ultrarrápida precomidas
2. 2 dosis NPH c/12 hrs (2/3 am y 1/3 pm)
(+) Insulina rápida (cristalina) 3 dosis precomidas

* Glargina mantiene glicemias basales estables. La ultrarrápida actúa en un periodo corto de tiempo

Control: HbA1c + valor de glicemias

- Precomidas: dependen de la Llantus o NPH que se puso antes
- Postprandiales: Dependen de la insulina rápida previa
- También dependen de la cantidad de comida y dependen de la glicemia preprandial

*Dr. Hace ejercicios con distintos que hay que ver en los videos

Pregunta Eunacom: Qué pasa si el paciente está haciendo hipoglicemias antes del desayuno con su esquema?

R: Bajar insulina NPH de la noche

Qué pasa si ... Ídem ídem durante la tarde?

R: bajar NPH de la mañana o bajar derechamente la Lantus

LADA

Late autoimmune diabetes of adults

- **Clínica:** agresiva como la DM1.
- **Antecedentes:** enfermedad autoinmune como vitíligo, hipotiroidismo, etc
- **Sospecha:** pedir marcadores: Ac. antiisletos, Ac. Antiinsulina, péptido C disminuido

Esta diabetes no responde a hipoglicemiantes orales → se trata igual que la DM1 con esquema INTENSIFICADO de insulina

CRITERIOS DE INSULINOTERAPIA EN GRAL

Paciente DM2

- Si HGO a dosis máxima con HbA1c >7%
- HbA1c $\geq$ 9%
- Paciente hospitalizado → IC c/ 6 hrs
- Cetoacidosis diabética
- SHH
- ICC, DHC, IRC (crea $\geq$ 1.5) CONTRAINDICAN HGO
- Corticoides (lo han preguntado en Eunacom)
- DM1 Y LADA → insulina esquema intensificado
- Diabetes descompensada o sintomática (4P)

3. COMPLICACIONES AGUDAS DE LA DIABETES

HIPOGLICEMIAS

Clínica:

- **Síntomas simpáticos:** taquicardia, temblor, inquietud, sudoración
- **Síntomas neuroglucopénicos:** Convulsiones, desorientación, agitación, compromiso de conciencia

Diagnóstico: Glicemia <60 mg/dl.

Causas:

- a) Provocadas: Insulina (antecedente que recibe insulina) → Vienen con péptido C bajo (lo preguntaron en Eunacom hipoglicemia facticia).

HGO → Antecedente de uso de HGO. Vienen con péptido C alto, glibenclamida aumenta la secreción pancreática de insulina y péptido C (se liberan juntos)

b) Espontáneas:

- Reactiva (resistencia a la insulina): hipoglicemia aparece a las pocas horas de comer. Le sobre insulina y hace hipoglicemia. La forma de objetivarlo y estudiarlo es con TTGO prolongado hasta por 4 hrs
- Glicemias de ayuno: ayuno de más de 4 hrs.

Si péptido C está alto → insulinoma.

Si péptido C está bajo → sarcoma o Ca grande, DHC o IRC

Tratamiento hipoglicemias

a) **Leve:** Síntomas simpáticos → líquido azucarado vía oral

b) **Severa:** Síntomas neuroglucopéicos → Glucosa EV. 20 cc SG 30% en bolo EV → paciente revive rápido. Mantención: suero glucosado al 5% goteo ev

Después:

- **Ajustar dosis insulina hipoglicemiante oral** (si es por HGO queda hospitalizado por la vida media larga de los HGO)
- **Si es por Reactiva: RI → tratar causa (dieta ejercicio y metformina)**

CETOACIDOSIS DIABETICA VS SHH

Síntomas:

CAD	SHH
- Dolor abdominal	- Mayor deshidratación
- Náuseas/ vómitos	- Hipotensión
- Deshidratación	- Taquicardia
- Aliento cetónico	- Confusión
- Respiración Kussmaul (profunda o polipnea)	- Coma
- Compromiso de conciencia	

Criterios

CAD	SHH
Ceto: Cetonas +++ en orina o sangre Ácido OH butírico Ácido acetoacético	Hiperglicemia: >600 mg/dl
Ácido: pH <7.3 + HCO ₃ <15 + AG >12 Acidosis metabólica con anión GAP aumentado	Hiperosm: >320 mOsm (Na x 2) + (BUN/ 2.8) + (Glicemia/18)
Diabética: Glicemia >250 (>200 en niños)	En Eunacom no hay tiempo para calcular hiperosmolaridad, así que 99% una glicemia>600 es SHH

Tratamiento CAD/SHH

1. **SF:** 1 lt ev o 20 cc/kg ev (niños)
2. **IC:** 0.1 UI/kg ev o 10 UI bolo ev
3. **K:** KCl en goteo ev (NO DAR EN BOLO PQ VA A HACER ASISTOLÍA).
 *Pedir antes el K+ porque:
 $K \leq 3.2 \rightarrow$ No dar IC, primero corregir K+ (K+ baja con la insulina, le puede dar torsión de puntas y paro). 3 g goteo KCl (39mEq)
 $K 3.2- 5 \rightarrow$ 1 g goteo KCl (13 mEq)
 $K > 5 \rightarrow$ No dar K
4. **HCO3:** Si pH < 6.9 $\rightarrow$ 250 cc 2/3 Molar

Si no tengo exámenes, lo único que puedo dar es suero. Para lo demás hay que esperar.
 FINALMENTE... TRATAR LA CAUSA (infección, debut, IAM, cualquier cosa me puede descompensar una diabetes)

4. COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES

1. RETINOPATÍA DIABÉTICA

Dx: Fondo de ojo. (1 vez al año diabéticos, si está alterado más seguido)

- a) RD no proliferativa (RDNP):
 1. Muerte de pericitos
 2. Exudados céreos
 3. Microaneurismas
 4. Microinfartos (exudados algodinosos) (manchas blancas)
- b) RD proliferativa (RDP):
 1. Neovasos
 2. Hemorragia vítrea (el neovaso se rompe y el paciente se queda ciego)

Un paciente diabético que hace amaurosis (ciego de un ojo), puede ser:

- a) RDNP $\rightarrow$ por edema macular: exudados céreos en mácula (o polo posterior)
- b) RDP $\rightarrow$ por hemorragia vítrea: clínica con rojo pupilar alterado o pérdida completa de este, percepción de sombra en zona de CV y **oculomotilidad conservada**

Manejo:

- a) **RDNP:** Control metabólico
- b) **RDP:** fotocoagulación (quemar esos vasitos para que no haya hemorragia). Si ya hay hemorragia existe una cirugía pero lo más probable es que pierda la vista igual

2. NEFROPATÍA DIABÉTICA

- a) NFPD inicial: Diagnóstico
 - Microalbuminuria >30 mg/día (orina 24 hrs)

- RAC >0.03 mg/dl (más fácil pq es solo una muestra de orina)
- RAC >30 mg/dl

b) NFPD estable: disminución del ClCr

La inicial VA A EVOLUCIONAR a estable yes o yes (va a tener una caída de la TFG)

Tratamiento

a) NFPD inicial: Si es persistente → Riesgo de IRC.

IECA → Objetivo: desaparición de la proteinuria.

b) NFPD establecida:

- Control metabólico
- Tratamiento IRC
- Tto HTA (IECA) (lo que más incide)

Objetivo de PA: DM → <140/90

Objetivo de PA con NFPD (cualquiera de las 2) <130/85

3. NEUROPATÍA DIABÉTICA

TIPOS DE NEUROPATÍA (dx. Clínico)

a) **Sensitiva:**

- Afectación en guante/calzetín
- Simétrica, distal
- Sensibilidad vibratoria y termalgésica

Manejo:

- Control metabólico + cuidado de los pies

b) **Dolorosa:**

- Dolor urente, profundo
- Alodinia (estímulo no doloroso duele)
- Hiperalgnesia (estímulo doloroso duele DEMASIADO)
- Empeora en las noches

Manejo:

- IC + ADTC (modulador del dolor Imipramina, gabapentina, etc)

c) **Amiotrófica:** Atrofia muscular. Manejo: IC (IC es anabólico, recupera masa muscular)

d) **Atrapamiento:** ej. túnel carpiano. Manejo: hacer EMG y eventual cirugía

e) **Craneal:** Ej: parálisis del III PC

4. VASCULOPATÍAS

Afectación Micro y macrovascular, aumentan el riesgo CV:

- IAM
- Claudicación

- Intermitente
- Estenosis carotídea
- AAA

5. PIE DIABÉTICO

Herida en pie de un paciente con DM

Multifactorial:

- 200
- Vasculopatía
- Inmunodepresión

Tratamiento

- a) Infección: ATB amplio espectro (clinda + cipro vo / ceft + cloxa + (metro/clinda) ev)
- b) Cirugía revascularización → cuando hay insuficiencia arterial
- c) Herida (según extensión en profundidad)
 1. Piel/TSCS: curaciones
 2. Fascias/tendones: qx. Debridación
 3. Hueso/Osteomielitis: amputación (sólo amputar con hueso comprometido, tratar de salvar la articulación) Osteomielitis se ve en Rx. Como lesión lítica (2 semanas en aparecer), por lo que es preferible con RMN

5. DIABETES MELITUS GESTACIONAL

CRITERIOS

DMG:

- 2 glicemias de ayuno ≥ 100
- 1 TTGO (75 mg) ≥ 100 basal y/o ≥ 140 postcarga

DMPG:

- DM diagnosticada de antes
- 2 glicemias de ayuno ≥ 126
- 1 glicemia ≥ 200 + síntomas

COMPLICACIONES FETALES

DMG:

- Macrosomía fetal
- Hipoglicemia neonatal
- Hipocalcemia neonatal
- Distocia de hombros

- Poliglibulia neonatal
- PHA

DMPG (más grave)

- Todo lo anterior
- Malformaciones (defectos TN)
- Insuficiencia placentaria (OHA, RCIU)

MANEJO

DMG: Dieta y ejercicio. Si no, pasar a esquema insulina intensificado

DMPG: Dieta + ejercicio. Si no, pasar a esquema insulina intensificado. Los HGO son seguros en embarazo, pero MINSAL DICE QUE NO.

Adicional: ácido fólico 4 mg/día → DMG, DMPG, DTN previa. En paciente sana (0.4 mg/día)

OBJETIVO: control cada 2 semanas.

Glicemias precomidas → 70-90

Glicemias precomidas → 90-120

En el embarazo no sirve como control HbA1c porque cambia en mucho tiempo, pero si puede hablar de hábito previo.

INTRAPARTO

- Parto vaginal sin problema
- Cesárea por macrosomía (DMG ≥ 4200 g, paciente normal ≥ 4500 g)
- Interrupción
- DMG: 40 semanas
- Si usa insulina: 38 semanas
- Si mal control metabólico: 36 semanas

6. NUTRICIÓN

DESNUTRICIÓN CALÓRICA

Dx: IMC (eutrofia entre 18.5 y 24.9)

a) Moderada <18.5

b) Severa <17

Niños: IPT ≤ -1 : bajo peso, IPT ≤ -2 desnutrición

Niños menores a 1 año: IPE

Niños >6 años: IMC con desviación estándar

Tratamiento

Buscar causas y tratarlas + dieta hipercalórica

DESNUTRICIÓN PROTEICA

Estado hipercatabólico por:

- Infección
- Quemaduras
- Traumatismos
- Pancreatitis
- Otros: malabsorción, pobreza, etc

Dx: Clínica de desnutrición con edema → Sd. Kwashiorkor. Y con exámenes:

- Prealbúmina (baja muy rápido) MÁS IMPORTANTE
- Colesterol bajo (lipoproteínas bajan)
- GB bajos en hemograma

Tto: Tratar la causa + dieta hiperproteica. Importante el balance nitrogenado (+) Nitrógeno que entra (comidas) vs. Nitrógeno saliente (NUT, NUU)

Sd. De realimentación

Paciente desnutrido crónico y al realimentarlo muy rápido → caída brusca de distintos oligoelementos.

- Baja K⁺ → Torsade de pointes
- Baja Mg⁺⁺ → Torsade de pointes
- Baja Ca⁺⁺ → Torsade de pointes
- Baja P⁻ → Hemólisis, rhabdomiólisis y compromiso de conciencia
- Baja Vit B1 → encefalopatía de wernicke: COCA (confusión, ataxia, oftalmoplejia, coma)

Prevención: Realimentación lenta 10 kcal/kg/día + aporte de oligoelementos

Tratamiento: Soporte y aporte de oligoelementos.

DÉFICIT DE VITAMINAS

- **Vit A (retinol)** → Ceguera nocturna, caída del cabello, piel seca, uñas quebradizas
- **Vit C (ácido ascórbico)** → Escorbuto. Dolores óseos, petequias, equimosis. Sirve para hacer colágeno y elastina. Grupos típicos: OH y lactantes
- **Vit D (calciferol)** → niños raquitismo y huesos blandos no calcificados. En adulto se produce osteomalacia
- **Vit K** → hemorragias (clásico en RN, por eso se da profilaxis)
- **Vit B1 (Tiamina)** →
 - Wernicke: COCA. Encefalopatía aguda
 - Korsakoff: Alteración de la memoria a corto y largo plazo, confabulación. Encefalopatía crónica
 - Beri Beri: ICC de alto flujo
- **Vit B3 (Niacina)** → Pelagra: alopecia, uñas quebradizas, diarrea, úlceras periorificiales y acrales (manos)

- **Vit B9 (folatos) → similar a B12**
- **Vit B12 (cianocobalamina) → Causas:** Anemia perniciosa (AI), cirugías gástricas con resección íleon distal
 - Anemia megaloblástica
 - Demencia
 - Degeneración Medular
 - Neuropatías

OBESIDAD

Dx: IMC

- ≥ 25 sobrepeso
- ≥ 30 obesidad
- ≥ 40 obesidad mórbida

Niños: IPT <6 años, luego IMC > 6 años

- $\geq +1$ sobrepeso (percentil 85)
- $\geq +2$ obesidad (p95)

Tratamiento: cambio en estilo de vida – cirugía bariátrica

Indicaciones cx. Bariátrica

- $IMC \geq 40$
 - $IMC \geq 35$ + comorbilidades
- Ojo luego de cirugía: aportar B12 IM y evitar dumping

Endocrinología

Son 5 preguntas, 1 o 2 de patología de tiroides, 1 de patología suprarrenal y las otras 2 de cualquiera de los otros temas



1. Generalidades

Eje hipotálamo-hipófisis

El hipotálamo secreta las hormonas liberadoras, las **RH**. Estas viajan a través del sistema porta hipotálamo-hipofisario y estimulan la secreción de las hormonas estimulantes en la hipófisis, las **SH** (trofinas o tropinas). Esta a su vez viajan hasta la glándula endocrina para que produzca la hormona final (**H**). Esta hormona final hace un feedback negativo sobre hipotálamo e hipófisis.

La parte anterior es la adenohipofisis y la región posterior es la neurohipofisis, donde se liberan 2 hormonas, la ADH y la Oxitocina. Estas son producidas en el hipotálamo pero liberadas en la hipófisis. En la adenohipófisis se producen la CRH, TSH, GnRH, GRH y dopamina. ADH genera reabsorción de agua libre en el túbulo colector y la oxitocina estimula la eyección de leche y las contracciones uterinas.

Cuando hay alguna alteración en este eje, se alteran los niveles de las hormonas. Los niveles plasmáticos de las distintas hormonas producidas en los distintos niveles del eje van a depender de a que nivel está el daño o la hiperproducción (glándula, hipófisis o hipotálamo) como se ve en la siguiente tabla

	DAÑO			HIPERPROD	
	Gland	Hipof	Hipot	↑ Gland	↑ Hipof
RH	↑	↑	↓	↓	↓
SH	↑	↓	↓	↓	↑
H	↓	↓	↓	↑	↑

Hormonas hipofisiarias

- CRH (Hipófisis) → ACTH (hipotálamo) → Cortisol (Glándulas suprarrenales)
- TRH (Hipófisis) → TSH (Hipotálamo) → T4 (tiroides) → T3
- GRH (hipófisis) → GH → Hipotálamo → IGF1 (Somatomedina)
- GnRH (hipófisis) → FSH/LH (hipotálamo) → Testosterona/estrógeno

- Dopamina → Inhibe a → Prolactina (Producción de leche)

2. Hipopituitarismo

Clínica → Afectación de todas las hormonas que se producen acá, es decir:

- Insuficiencia suprarrenal
- Hipotiroidismo
- Alteración del crecimiento
- Hipogonadismo
- Agalactia
- Diabetes insípida

Pueden ser muchos síntomas, pero **suele presentarse como astenia**. Van a estar bajos los niveles de la hormona y de la hormona estimulantes también.

Causas:

- Tumores hipofisarios
- **Síndrome de Sheehan** → Esta es una hemorragia puerperal post-parto que genera hipovolemia que va a generar un infarto hipofisario. Se presenta como **astenia, amenorrea y agalactia (esto se pregunta)**
- Autoinmune
- TEC

Estudio → Neuroimagen (TAC o RNM de silla turca)

Tratamiento → **Sigue un orden**

- 1- Cortisol (Para tratar la insuficiencia suprarrenal)
- 2- Desmopresina (en caso de que haya diabetes insípida, porque tiende a hipernatremias por falta de ADH)
- 3- Levotiroxina
- 4- Terapia de reemplazo hormonal (Estrógeno o testosterona según corresponda)
- 5- GH → Solo en niños

Síndrome de compresión del tallo hipofisario

Si se comprime el tallo hipofisario se va a cortar la comunicación entre hipotálamo e hipófisis, por lo general, se genera un panhipopituitarismo, a excepción de la prolactina que va a aumentar.

Panhipopituitarismo con PRL alta → Compresión del tallo o Tumor productor de PRL

Tumores de hipófisis

Clínica→ Suelen ser asintomáticas y ser hallazgos imagenológicos. En este caso, el manejo es la observación.

En caso de que haya síntomas, **estos pueden ser de 2 tipos**

1. Compresivos

- a. Cefalea
- b. Hemianopsia bitemporal por compresión del quiasma
- c. Afectación de pares craneales que pasan cerca (III, IV o VI)

2. Por hiperproducción

- a. Hiperprolactinemia por prolactinoma
- b. Enfermedad de Cushing (hiperproducción de ACTH)
- c. Acromegalia (hiperproducción de GH)

Estudio→ Neuroimagen y estudio hormonal

Tratamiento→ Si hay síntomas de hiperproducción o compresión, se tratan con cirugía. **La excepción es el prolactinoma, porque responde bien al tratamiento farmacológico con agonistas dopaminérgicos**

Apoplejía Hipofisaria

Infarto hemorrágico de un tumor de hipófisis. El diagnóstico es clínico

Síntomas **SÚBITOS** :

- Hipertensión endocraneana (Cefalea intensa, náuseas, vómitos y compromiso de conciencia)
- Síntomas de compresión (el quiasma es lo más frecuente)

ESTUDIO: TAC

TRATAMIENTO: Corticoides Ev y derivación para Cirugía

Acromegalia

Tumor productor de GH en la hipófisis.

En los niños produce gigantismo, en los adultos acromegalia

Clínica→ aumento de tamaño de manos y pies, mandíbula, labios, nariz y/o orejas. Aumenta la resistencia a la insulina, por lo tanto aumenta la DM y el riesgo cardiovascular

El diagnóstico es con la IGF-1 (somatomedina), no con GH y una RNM.

El tratamiento es quirúrgico.

3. Síndrome de Cushing

Clínica

- Astenia
- Adinamia
- Obesidad Centrípeta

- Estrías violáceas
- **Atrofia Muscular (signo más frecuente)**

Complicaciones

- HTA
- Diabetes
- Hirsutismo
- **Infecciones**
- **Osteoporosis**

Causas

- **Uso de corticoides exógenos (la más frecuente)**
- Enfermedad de Cushing (Tumor hipofisario productor de ACTH, es la 2ª causa en frecuencia)
- Tumor suprarrenal
- Hiperplasia suprarrenal
- Síndrome de ACTH ectópico (generalmente un tumor de pulmón de células pequeñas)

Estudio

- Cortisol libre urinario de 24 horas (gold standard) (Cortisol plasmático no sirve porque los niveles son muy erráticos)
 - Cortisol en saliva o test de Nugent (test de supresión corta) son las otras opciones

En caso de que este test salga alterado, se va a pedir:

- Test de Liddle (test de supresión larga) → Se da dexametasona en mayores dosis y por más tiempo.
- Niveles plasmáticos de ACTH

En caso de que sea un problema hipofisario → La ACTH va a estar alta **y va a suprimir** a la administración de dexametasona.

En caso de que sea un problema suprarrenal → LA ACTH va a estar baja y el cortisol se mantiene alto, es decir, **no se suprime la producción de cortisol**.

Por lo tanto, el test de supresión larga, sirve para distinguir un trastorno central de uno periférico. Si es hipofisario se debe estudiar con RNM o TAC de hipófisis, mientras que si es de la suprarrenal el problema se debe estudiar con un TAC de suprarrenales

Causas suprarrenales → Tumores e hiperplasia suprarrenal.

Síndrome de ACTH ectópico → Clínica de cáncer de pulmón orienta a este diagnóstico. En este caso la ACTH no suprime al test de supresión.

Se estudia con imagen de los pulmones (Rx Tx o TAC de tórax)

Tratamiento

Exógeno → Bajar dosis de corticoides si es posible

Tumor hipofisario → **Cirugía**
Tumor suprarrenal → **Cirugía**
Hiperplasia suprarrenal → **Cirugía**
ACTH ectópica → **Cirugía**

4. Insuficiencia Suprarrenal

Se pregunta con alguna frecuencia y muchas veces la gente que da EUNACOM ni se da cuenta porque la clínica es inespecífica (y obviamente tienen mala la pregunta, pónganse vivos)

Clínica (inespecífica)

- Astenia/adinamia
- Nauseas/vómitos
- Dolor abdominal
- Trastornos hidroelectrolíticos (Hay que ir a buscarlos)
 - o Hiperkalemia (por disminución de la producción de aldosterona)
 - o Hiponatremia (por disminución de la producción de aldosterona)
 - o Hipoglicemia (cortisol es una hormona de contrarregulación)
- Hiperpigmentación de mucosas, cara y manos (SOLO EN LA ENFERMEDAD DE ADDISON (insuf SSRR 1ª). Al bajar la producción de cortisol se aumenta la producción de ACTH la cual, se libera junto a la MSH (hormona estimulante de melanocitos).

Es importante preguntar por antecedente de TBC (adrenalitis por M. tuberculosis) y enfermedades autoinmunes (**la principal causa de Addison es la adrenalitis autoinmune**)

Diagnostico: Test de estimulación con ACTH (se mide cortisol basal y luego de estimularlo con ACTH)

Tratamiento → Cortisol en 2 dosis al día, la cual, debe ser aumentada ante infecciones, stress, accidentes por riesgo de crisis suprarrenal.

En caso de que sea un Addison se debe agregar aldosterona como Fludrocortisona

Crisis o insuficiencia suprarrenal

Cuadro de hipotensión que no responde a volumen que viene con los trastornos hidroelectrolíticos típicos de insuf SSRR.

De los antecedentes es importante saber uso de corticoides orales, clínica de Addison hiperplasia suprarrenal congénita, VIH (Adrenalitis por CMV) o meningococcemia por riesgo de síndrome de waterhousefriedrichsen,

El tratamiento es con corticoides

Ante un paciente que viene con antecedente de astenia hace 1 mes, nauseas, vómitos y ahora viene shockeado uno piensa que esta shockeado por la perdida de volumen actual, pero si viene con la hiperkalemia y la hiponatremia se debe pensar en insuf SSRR.

5. Hipotiroidismo

Pregunta Segura en el EUNCOM

Generalidades

Hipotálamo (TRH) → Hipófisis (TSH) → Tiroides (T4) → Conversión periférica a T3

El Feedback negativo lo hace la T4 a nivel central (T3 tiene la acción biológica) , por lo tanto, una persona que se intoxica con Levotiroxina va a tener TRH y TSH normales.

Valores normales (hay que saberlos):

TSH: 0,4 a 4,0 UI/L

T4 libre: 0,7 -1,8ng/dl

Niveles de hormonas tiroideas en distintos trastornos:

	TSH	T4 libre
HipoT4 primario	↑	↓
HiperT4 primario	↓	↑
HipoT4 subclínico	↑	N
HiperT4 subclínico	↓	N
HipoT4 secundario	↓	↓
HiperT4 secundario	↑	↑
Aumento TBG	N	T4↑
Disminución TBG	N	T4↓

TBG → (Globulina fijadora de tiroxina) Proteína transportadora de hormonas tiroideas. Se altera en embarazo, uso de anticonceptivos y anabólicos.

Hipotiroidismo

Clínica

- Astenia/adinamia
- Intolerancia al frío
- Constipación
- Caída de cola de las cejas
- Piel seca
- Bradipsiquia

Exámenes alterados:

-
- - Anemia (VCM alto)
- - Hiponatremia
- - Ictericia Indirecta
- - Dislipidemia

Causas

- Primario → TSH alta y T4 baja (Tiroiditis de Hashimoto principal causa)
- Secundario → TSH y T4 bajas, se debe pedir una RNM de silla turca

Screening Hipotiroidismo → TSH

Diagnostico → TSH – T4 libre

En caso de que se sospeche que sea secundario (TSH y T4L bajas), se debe pedir una RNM de silla turca.

Tratamiento (independiente de la causa)

Levotiroxina: 1,6ug/kg ajustando dosis hasta llegar a TSH 0,4 a 4.

En un inicio se controla cada 6 semanas y luego al mantenerse estable cada 3 meses

En caso de que sea secundario se diagnostica y se controla con T4 libre

Excepciones

- **Adulto Mayor** → Partir con dosis más baja (25ug) por riesgo de arritmia (FA)
- **Cardiopatía** → Partir con dosis más baja (25ug) por riesgo de arritmia (FA)
- **Embarazo** → Se exige TSH entre 0,4 y 2,5. Al momento de embarazarse se debe aumentar la dosis de la paciente en un 30%
- Hipotiroidismo subclínico → Tiene la TSH elevada **y la T4 libre NORMAL**. NO se trata, a menos de que tengas las D:
 - Depresión
 - Demencia
 - Dislipidemia
 - Demasiado embarazada
 - Diez (TSH sobre 10)
 - **DIABETES NO ES INDICACIÓN DE TTO DE HIPOT4 SUBCLÍNICO**

6. Hipertiroidismo

Clínica

- Astenia/adinamia
- Intolerancia al calor
- Polidefecación
- Piel fina y húmeda
- Temblor, nerviosismo
- Palpitaciones
 - Basedow-Graves
 - Bocio Difuso
 - Soplo tiroideo
 - Exoftalmo
 - Mixedema pretibial

Tormenta tiroidea → Es el símil al coma mixedematoso. Viene con compromiso de conciencia, hipertermia, taquiarritmias

Causas

- Enfermedad de Basedow-Graves
- Bocio multinodular toxico
- Adenoma toxico

El screening y diagnostico se hace igual que en el hipotiroidismo con TSH y TSH + T4 libre respectivamente.

LA TSH estará baja y la T4L alta si es primario. En caso de que sea secundario estarán ambas altas. Acá se deberá estudiar también con RNM de silla turca.

Estudio de Hipertiroidismo

1. Enfermedad de Graves → Dg clínico, pero podemos apoyarnos con los anticuerpos TRAB.
2. En las demás causa, se debe pedir la cintigrafía de yodo radioactivo para poder diferenciar las distintas causas

Tratamiento

Betabloqueo con propanolol: este es el primer fármaco que se da para disminuir palpitaciones y temblor.

Drogas antiroides → PTU (propiltiouracilo) y metimazol → Disminuyen la síntesis y acción de T3 y T4

Yodo radioactivo → Es el tratamiento de elección, no se da de entrada porque va a destruir la glándula y al destruirla generará una tormenta tiroidea. Se debe dar después de controlarlo con los otros fármacos.

Cirugía → Es la última línea a menos que este embarazada.

Control del HiperT4 es igual que en el hipoT4, con TSH y T4 libre

7. Bocio y Tiroiditis

Bocio → Aumento de volumen de la Glándula Tiroides

Puede ser difuso (sin nódulos) o nodular (con nódulos, los cuales pueden ser uni o multinodular)

Causas de bocio difuso

- **Hashimoto** → **Bocio Difuso con T4 baja**
- Graves → Bocio Difuso con T4 alta
- Tiroiditis quervain → Bocio difuso doloroso

Se estudian con TSH y anticuerpo anti TPO (causa mas frecuente es Hashimoto)

Causa de bocio nodular

- Quistes coloides
- Adenoma toxico → Quiste único con T4 alta

- Cáncer
- Bocio multinodular toxico → Bocio multinodular con T4 alta

Se estudia con Eco y TSH. Lo importante es determinar si es cáncer o no

Tiroiditis

Inflamación de la tiroides. Puede ser aguda, subaguda o crónica

Aguda

Suele ser un proceso infeccioso por gram (+), S. aureus el más típico.

Clínica → Similar a un absceso del cuello. El diagnóstico es clínico (dolor, eritema, fiebre, aumento de volumen).

El tratamiento es con cloxacilina o cefazolina y drenaje del absceso o tiroidectomía si está muy grave.

Subaguda

Es lo que más se pregunta. La más típica es la de quervain. Suele ser autoinmune o postinfecciosa (antecedente de resfriado hace 2 semanas. Suele ser transitoria).

Su clínica es un bocio doloroso irradiado a oídos a veces y con clínica de hipertiroidismo por destrucción de los coloides.

El diagnóstico es clínico, pero hay que saberse los exámenes (TSH baja, T4 libre alta, tiroglobulina muy alta y la captación de yodo muy reducida)

El tratamiento (Se pregunta) son los AINEs y propranolol si viene con clínica de hiperT4

Tiroiditis postparto → Igual a la tiroiditis de quervain pero es postparto, se maneja igual.

Crónica

La más típica es la de Hashimoto con Anticuerpos anti TPO y la otra es la tiroiditis de Riedel

Hashimoto → Bocio difuso con anticuerpos anti TPO y T4 libre baja. ES LA CAUSA MAS FRECUENTE

Tiroiditis de Riedel → Bocio difuso leñoso (fibrosis de la tiroides).

Tratamiento de ambas → Levotiroxina en caso de haber hipotiroidismo (no siempre hay, pero generalmente si)

8. Nódulo tiroideo, Ca de tiroides y masa cervical

Nódulo tiroideo

Causas

- Benignas
 - o Quiste Coloideo
 - o Adenoma

- Malignas
 - o Cáncer

Clínica→ Presencia de nódulo tiroideo, el cual, debe ser estudiado con Eco y TSH. En caso de ser mayor a 1 cm se debe hacer PAAF (Punción aspiración con aguja fina)

Si la TSH esta baja (hipertiroidismo), se debe pedir una cintigrafía de yodo radioactivo para determinar si este nódulo es la causa del hipertiroidismo. Podemos tener dos resultados:

- Nódulo caliente (hipercaptante)→ Se hace el diagnostico de adenoma toxico y se trata como tal (drogas antitiroideas y Yodo)
- Nódulo Frio→ Se hace la PAAF porque queda la duda de lo que puede ser

Cáncer de tiroides

El diagnostico se hace con la PAAF, es una biopsia **citológica**.

Puede ser un cáncer papilar (el mas común, 85%), folicular (10%), medular o anaplásico.

Cánceres papilar y folicular

Se tratan con tiroidectomía total y yodo radioactivo. El seguimiento es con tiroglobulina.

Tienen buen pronóstico, porque responden a Yodo radioactivo

Cáncer medular→ Antes de empezar a tratarlo hay que descartar un Feocromocitoma. Se trata con tiroidectomía + linfadenectomía seguido por quimio y radioterapia.

El seguimiento es con calcitonina

Cáncer anaplásico→ De muy mal pronóstico, el tratamiento es solo paliativo

Adenoma folicular→ Es benigno, pero totalmente indistinguible del cáncer en la PAAF, por lo tanto, también se va de tiroidectomía total.

Masa cervical

Lo importantes es el manejo

El examen inicial siempre es la eco de cuello

Causas que se preguntan

- Quiste del conducto tirogloso→ alteración congénita, se ve en los niños. Es una masa en la línea media. Si bien está desde el nacimiento, no siempre es evidente en esta etapa y puede hacerse el diagnostico en la adolescencia. Pero si es una masa que se moviliza con la deglución uno está seguro que es esto. Se operan
- Quistes Branquiales→ También de los niños, pero por la cara lateral, en relación al Esternocleidomastoideo
- Linfoma→ Masa, adenopatías + síntomas B. El estudio es con ex generales, Rx tórax y biopsia excisional
- Metástasis de cáncer de cabeza y cuello→ Primero se debe buscar el primario y si no lo encontramos se hace la PAAF.

9. Calcio y Paratohormona (PTH)

VN Ca: 8.5-10,5 mg/dl

Antes de determinar si hay hipo o hipercalcemia, este se debe corregir por la albúmina.

Ca corregido = $Ca + 0,8 \times (4 - \text{albumina})$

Si la albúmina es 4, el calcio dado es igual al calcio corregido

En vez de corregirlo podemos pedir el calcio iónico (este es el que tiene la acción biológica)

Ca ⁺⁺	PTH	P ⁻	Dg
↑	↑	↓	HPP
↑	↓	↑	HiperCa ⁺⁺ maligna
↓	↑	↑	HP 2 ^{rio} (IRC)
↓	↓	↑	Hipo PTH

Hiperparatiroidismo primario → Ca⁺ y PTH altas con fósforo bajo. Causado por tumor o hiperplasia de paratiroides.

Hipercalcemia por Cáncer → Ca⁺ y Fosforo elevado y PTH baja.

Hiperparatiroidismo secundario (2º a ERC) → Ca⁺ bajo, por lo cual, sube la PTH para compensar. Por la ERC hay retención de fósforo, por lo cual, este estará alto.

Hipoparatiroidismo → Ca⁺ y PTH baja con fosforo alto. Causado por extirpación quirúrgica de paratiroides

Hipercalcemia

Clínica

- Astenia/debilidad
- Deshidratación/poliuria (por hipercalciuria)
- Constipación
- Compromiso de conciencia

Antes que anda hay que corregirla por albúmina. Después se estudia con PTH

- Si está alta → Hiperparatiroidismo primario. Se trata con cirugía
- Si está baja probablemente es cáncer y el tratamiento depende del tipo de cáncer.

Tratamiento en caso de ser grave →

- 1- Hidratar
- 2- Bifosfonatos Ev (Ac zolendróico o zolendronato)
- 3- Corticoides Ev en caso de que sea secundario a un cáncer hematológico

Hipocalcemia

Causas

- Enfermedad celiaca (por afectación del duodeno donde se absorbe el Ca)

- Furosemina
- AKI/ERC → La causa más común por falta de excreción de fosfato que es un quelante del calcio.

Clínica

- Parestesias peribucales
- Debilidad
- Tetania
 - Contracturas musculares
 - Hiperreflexia
 - Fasciculaciones
 - Alargamiento del QT (suelen morir por arritmias ventriculares por esto)

Tratamiento →

- Leve: Calcio vía oral
- Grave: Presentan tetania o alteraciones al ECG. Se debe dar 1g de gluconato de calcio Ev.

10. Osteoporosis, osteopenia

Causas

- **Primaria (la mas frecuente) → Postmenopausia**
- Secundaria
 - Hiperparatiroidismo 1º y 2º (ERC)
 - Síndrome de Cushing
 - Hipertiroidismo
 - Hipogonadismo
 - Anorexia
 - **Uso de corticoides**

Clínica → Es asintomático hasta que se fractura de forma patológica (**vertebras, cadera, muñeca y humero proximal son las más frecuentes**)

Screening y diagnóstico → Densitometría ósea. Nos proporciona 2 valores, el T y el Z score, los cuales, si son mayores a -1 están normales.

T Score → Entre -1 y -2,5 es diagnóstico de osteopenia y si su valor es menor a -2,5 es osteoporosis. **El que se ocupa para el diagnostico es el T score.**

Z score → se ocupa para determinar si es una causa primaria o secundaria. Si es menor a -2 es secundario y se debe estudiar, pero sobre -2 no se debe estudiar.

T - score	Z - score	
-2,0	-1,0	Osteopenia 1ria
-2,8	-1,8	Osteoporosis 1ria
-2,4	-2,2	Osteopenia 2ria

Tratamiento

- Osteopenia → Su riesgo es la evolución a osteoporosis. **Lo mejor y mas eficaz es hacer ejercicio.** Ayuda a no caerse y en caso de caídas los huesos estarán más fuertes. El calcio y vitamina D ayudan también y son parte del tratamiento.
- Osteoporosis → Su riesgo son las fracturas. El tratamiento es igual (ejercicio, calcio y Vit. D) y se agregan los bifosfonatos.

Bifosfonatos

- Ácido alendronico o alendronato (diario o una vez a la semana)
- Ácido ibandronico (1 vez al mes)
- Ácido Zolendrónico (1 vez al año)

Se deben tomar en ayunas y con mucha agua

11. Diabetes insípida, Polidipsia primaria (psicógena), SIADH e hiponatremia

Diabetes insípida → Síndrome polidipsico poliúrico con glicemia normal. Hace orina diluida y su sodio plasmático será normal.

En caso de privación de agua se va a generar hipernatremia con orina diluida

Polidipsia primaria → Síndrome polidipsico poliúrico con glicemia normal. La orina va a estar diluida y el Na plasmático también estará normal, pero en caso de privación de agua todos los parámetros se normalizan.

Causas

- Trastorno psiquiátrico (ej. TOC)
- Central (daño hipofisiario)
- Nefrogénica → La ADH no actúa correctamente. Puede ser por Litio o hipercalcemia

Exámenes

- **Test de la sed** → Para diferenciar diabetes insípida de polidipsia primaria. Este test mide el sodio Urinario y plasmático basal y post privación de agua.
- **Test de desmopresina** → Para diferenciar causa central y nefrogénica de diabetes insípida. La desmopresina es un análogo de la ADH, por lo tanto, si el trastorno hidroelectrolítico se mejora al darla concluimos que es un trastorno central. En caso de que no mejore con Desmopresina, es un trastorno periférico porque no falta ADH, simplemente no actúa correctamente en el túbulo.

Tratamiento

Central → Desmopresina

Nefrogénica → Agua + Hidroclorotiazida

SIADH

Es lo contrario a la diabetes insípida, me sobra ADH por un aumento en su excreción y se produce hiponatremia. **(una de las principales causa de hipoNa)**

Causas

- **Pulmonares**

- TBC
- NAC
- Ca
- TEP

- **Alteraciones del SNC**

- ACV
- Tu
- Meningitis
- TEC

- **Tumores** (cualquiera, los más comunes son pulmón y cerebro)

Diagnostico → Hiponatremia + orinas concentradas (Osmolaridad urinaria aumentada). Se deben descartar otros tipos de HipoNa, es un Dg de descarte

Tratamiento → Restricción de agua

Hiponatremia → Na menor a 135.

Clínica

- Leve → Asintomática
- Severa → Edema cerebral (compromiso de conciencia, Hipertensión intracraneana)

Causas

VEC normal → Alteraciones endocrinas como SIADH, hipotiroidismo o Addison

VEC aumentado → Por edema (ICC, IRC, DHC)

VEC disminuido → Diuréticos y diarreas hiperosmolares

Tratamiento:

Leve → restricción de agua (800cc al día)

Severa (Na menor a 120 o con clínica de edema cerebral) → Suero hipertónico al 3% a pasar lento por riesgo de mielinolisis pontina.

Las natremias dependen de la entrada y salida de agua

Las volemias dependen de la entrada y salida de sodio

12. Temas Varios (pediátricos)

Pubertad Precoz

Pubertad → Aparición de caracteres sexuales secundarios.

Primer signo de desarrollo puberal → Aumento de volumen de testículos (orquidarquia) o aparición del botón mamario (telarquia), esto es Tanner 2

Pubertad normal → 9-14 años en niños y 8-13 años en niñas.

Si empieza antes se habla de pubertad precoz. Si parte después se llama retraso puberal. Ambas se estudian con gran cantidad de exámenes (LH, FSH, testosterona, estrógeno, progesterona, 17-hidroxiprogesterona y edad ósea)

Riesgo de PP → Se quedan chicos, talla baja.

Causas

- Central (la más frecuente). Es por una activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Hay aumento de LH y FSH, por lo cual, las gónadas aumentan de tamaño
- Periférica → Hay varias causas, la FSH y LH están bajas, por lo cual, **las gónadas son pequeñas**
 - o Tumor productor de andrógenos

No confundirlo con adrenarquia precoz, que es la activación precoz de las glándulas suprarrenales que producen hormonas sexuales (tendrán olor axilar y pubarquia). **Se observa, no se piden exámenes a menos que haya desarrollo sexual**

Hipotiroidismo congénito

Es una causa congénita por disgenesia tiroidea.

A todo RN se le pide TSH al nacer por esto mismo.

Clínica

- Ictericia tardía de predominio indirecto
- Hipotermia
- Hipotonía
- Retrase en caída del cordón (7-14 es lo normal)

Al nacer son normales, pero a largo plazo puede presentar retraso mental.

El tratamiento es con Levotiroxina 1,6ug/kilo y bien tratado va a ser un niño totalmente normal.

Hiperplasia suprarrenal congénita (HSRC)

Es de causa congénita por déficit enzimático, por lo cual, no se produce cortisol. Esto genera hiperproducción de ACTH que aumenta el tamaño de las suprarrenales.

Diagnostico → Por aumento de la 17- hidroxiprogesterona. Clínicamente se presenta como una insuficiencia suprarrenal, incluso con hiperpigmentación por aumento de la ACTH.

Aumenta la DHEA que puede producir hiperandrogenismo

Clínica → Hiperandrogenismo, insuficiencia suprarrenal e hiperpigmentación

El tratamiento es con cortisol. Se agrega fludrocortisona si es perdedor de sal.

13. Amenorrea

Se pregunta siempre

Amenorrea 2ª

Amenorrea (>90 días o 3 ciclos regulares) después de la menarquia

Causas

- Fisiológicas
 - Embarazo
 - Lactancia
 - Menopausia
- Patológicas
 - Hormonales
 - Anatómicas
 - Otras

Enfrentamiento clásico de amenorreas

0→ Test de embarazo

1→ TSH y prolactina, es una causa frecuente de amenorrea, ya sea por hipotiroidismo o Hiperprolactinemia

2→ Prueba de progesterona→ Dar progestágeno (Acetato de medroxiprogesterona) y luego se suspende. Si la mujer menstrua nos dice que le faltaba la progesterona y el diagnóstico es anovulación (SOP). Si está negativa se sigue con el estudio

3→ Prueba de estrógeno + progesterona. Si menstrua nos habla de Hipogonadismo por falta de estrógenos. El estudio de Hipogonadismo es con LH y FSH. Si no menstrua es de causa uterina, como el síndrome de Asherman. En este caso se debe pedir una Eco TV

a→ LH y FSH bajas→ Hipogonadismo hipogonadotrofo. En este caso son causas hipotalámicas o hipofisarias. Se debe pedir una RNM de silla turca para ver que problema hay en la hipófisis e hipotálamo

b → LH y FSH altas → Hipogonadismo hipergonadotrofo, es de causa ovárica. Menopausia precoz en caso de ser menor de 40 años

Estradiol	Estradiol	N	CASO 2 40 años, antec. Legrado post-aborto ↓ Sd. Asherman (sinequias uterinas)
Progesterona	Progesterona	N	
FSH	FSH	N	
LH	LH	N	
PRL	PRL	N	
TSH	TSH	N	
HCG	HCG	(-)	
Anti-Mülleriana	Anti-Mülleriana	N	

Estradiol	↓	CASO 3 30 años, ant. hemorragia puerperal y luego agalactia ↓ Sd. Sheehan
Progesterona	↓	
FSH	↓	
LH	↓	
PRL	↓	
TSH	↓	
HCG	(-)	
Anti-Mülleriana	N	

Estradiol	↑	CASO 4 22 años, acné ↓ Anovulación SOP
Progesterona	↓	
FSH	N	
LH	↑	
PRL	N	
TSH	N	
HCG	(-)	
Anti-Mülleriana	↑	

Amenorrea primaria

Ausencia de menarquia a los 15 años con desarrollo puberal o a los 13 años sin desarrollo puberal (retraso de pubertad).

Causas

- Anovulación → Viene con desarrollo puberal. Se pide prueba de progesterona
- Genéticas / hormonales → Sin desarrollo puberal. Se piden todos los exámenes y cariograma para descartar un síndrome de Turner
- Malformaciones → Generalmente uterinas. Se pide con ecografía transrectal

14. Oligomenorrea y SOP

Oligomenorrea → Ciclos largos, más de 35 días

Causas → Las mismas de Amenorrea, la más clásica es SOP.

SOP

El diagnóstico se hace con 2 de 3 criterios

- Amenorrea u Oligomenorrea
- Hiperandrogenismo
 - o Clínico
 - Acné
 - Hirsutismo
 - o Laboratorio
 - IAL >4,5 (testosterona/ SHBG), no se mide la testosterona libre
- Eco TV → Mas de 12 folículos o mas de 10ml de volumen por ovario

Tratamiento

- Tratar la causa, suele ser por Resistencia a la insulina + componente genético.
 - o Dieta + ejercicio + metformina
- Tratamiento del hiperandrogenismo
 - o ACO antiandrogénicos (Dienogest, drospirinona, ciproterona)
- Infertilidad → Inductores de la ovulación (citrato de clomifeno, HCG o análogos GnRH)

Otras causas de hirsutismo e hiperandrogenismo

- Aumento de DHEAs
 - o Enfermedad de Cushing
 - o Hiperplasia suprarrenal congénita
 - o Tumor virilizante adrenal

15. Climaterio, menopausia y TRH

Se pregunta bastante

Menopausia → última regla de la vida. Diagnóstico retrospectivo tras 12 meses. Ocurre entre los 45 y 55 años, en promedio a los 50. Es normal desde los 40 en adelante, pero es precoz si ocurre antes de los 40 y conlleva riesgo de osteoporosis y atrofia genital

Climaterio → Periodo de la vida de una mujer caracterizado por caída de los estrógenos. Esto conlleva muchos síntomas físicos y mentales. Inicia antes de la menopausia y sigue después de ella

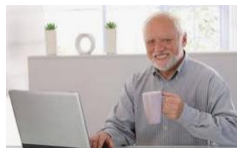
Ventajas

- Se acaba
 - Embarazo
 - Dismenorrea
 - Endometriosis
 - Miomas
 - Adenomiosis
 - Mastalgia
 - Síndrome premenstrual



Desventajas

- Síntomas vasomotores
- Riesgo aumentado de
 - Osteoporosis
 - Prolapso genital
 - Incontinencia urinaria
 - atrofia genital
 - Depresión
 - Aumenta riesgo CV



TRH

La administración, contraindicaciones y efectos adversos son los mismos de los ACO

Indicación → Para disminuir los síntomas vasomotores. Además es útil para la osteoporosis, pero no es tratamiento para esto (Vit D, Calcio y ejercicio)

Se dejan estrógenos + progestágenos conjugados de baja potencia

En casos de que la paciente no tenga útero solo se deja el estrógeno, dado que, los progestágenos se dejan para evitar el cáncer de endometrio que se genera cuando hay demasiado estrógeno sin contraposición de progestágenos

Si solo hay síntomas genitales se dejan lubricantes genitales. En caso de atrofia muy marcada se pueden dejar estrógenos tópicos

16. Métodos anticonceptivos

Se pregunta poco

Clasificación

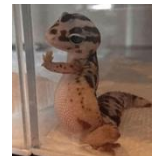
- Naturales → La ventaja es que son aceptados por el cristianismo, pero tiene un gran riesgo de embarazo. Se debe conocer muy bien el ciclo menstrual. Ventana fértil → 5 días antes de la ovulación
 - Coitus interruptus. Valle callampa
 - Ducha vaginal → Aumenta riesgo de PIP y vale callampa



- Método de la Temperatura → Surprise, vale callampa
- Billings → Un poco mas completo, índice de Pearl de 2%, similar al condón. La mujer debe "conectarse con su vulva"



- Barrera → Son los únicos que protegen contra las ETS, pero igual tienen riesgo de embarazo. Índice de Pearl de 2%. Contraindicado ante alergia al látex
 - Preservativo masculino → De elección ante el sexo casual y promiscuidad, evita las ETS.
 - Condón femenino → Una mierda
 - Diafragma → Otra mierda más y no protege de ETS
- DIU → Dura de 5-10 años. Puede aumentar la dismenorrea, hipermenorrea y tiene riesgo de PIP al ponerlo y sacarlo (el DIU, maldito malpensad@). Contraindicado ante la promiscuidad sexual, dismenorrea, hipermenorrea y nulíparas (relativo). En caso de embarazo se dispara el riesgo de embarazo ectópico y aborto porque se debe retirar el DIU y se asocia a complicaciones infecciosas. Si al ponerlo le da un PIP, se debe sacar solo si no responde al tratamiento ATB.
 - DIU levonorgestrel → Dura 5 años, efectividad casi 100%, es lo mejor que hay. Disminuye la hipermenorrea y dismenorrea. Solo contraindicado ante promiscuidad sexual por riesgo de PIP, lo queremos mucho.



- Hormonales → Los que se preguntan más. Son efectivos, pero vienen con varios RAM (nauseas, aumento de RCV, aumentan riesgo de CA de mama pero disminuye el de endometrio y ovario). Contraindicado ante hepatopatías (agudas, DHC), jaqueca (solo si es producida o agravada por ACO), Lupus, alto riesgo CV, fumadora mayor de 35 años (alto riesgo CV) y ante antecedente personal de Ca de mama, endometrio, metrorragia desconocida (Ca endometrio) y melanoma.

Vía de administración

Vía oral es lo mas común, pero por su primer paso hepático genera aumento de las dislipidemias (CI en estos casos) y un leve aumento CV. Vienen con un estrógeno (etinilestradiol) + progestágeno. Durante la lactancia solo se ocupan los ACO de progestágenos solos.

Vía transdérmica y Anillo vaginal → Se pone 1 vez al mes. Vienen sin paso hepático. Es de elección ante riesgo CV mas alto y dislipidemias.

Inyectables y subcutáneos → Solo levonorgestrel, muy prácticos y efectivos. Se asocian a spotting y pueden generar aumento de peso,

- Quirúrgicos → Son permanentes, por lo tanto, contraindicados ante posibilidad de arrepentimiento.
 - Ligadura tubáica → Suele hacerse junto a una cesárea, pero puede hacerse de forma electiva. Si hay embarazo, este será ectópico seguro. (se pregunta)
 - Vasectomía → Menor riesgo quirúrgico

Resumen Guevara by creggers

Gastroenterología



Son aproximadamente 10 preguntas, las cuales no son difíciles.

1. Trastornos digestivos funcionales

Son la 1ª causa de consulta gastroenterológica, diarrea crónica, constipación crónica y dolor abdominal crónico. El diagnóstico es clínico y lo importante es buscar signos de alarma. Ante estos síntomas de alarma se debe pedir EDA o colonoscopia según corresponda.

El tratamiento es en base a la educación, disminuir el stress y dar algunos fármacos que ayuden al dolor.

Signos de alarma de las gastroenterología en general: ABC

- A: Anemia o uso DE AINEs
- B: Baja de Peso (cáncer)
- C: Cambio en los síntomas
- D: Disfagia (Ca de esófago)
- E: Edad sobre 50 años
- F: Familiar con cáncer
- G: Antecedentes de Úlcera Gastroduodenal
- H: Antecedente de Hemorragia digestiva
- N: Síntomas Nocturnos (que la diarrea te despierte en la noche)

Fiebre (Infección y EII), lentería (malabsorción) y pujo/tenesmo (Colitis ulcerosa, infección) son otros síntomas de alarma

SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE

Dolor abdominal crónico + (Alguno de estos)

- Diarrea/constipación
- Cambios en la frecuencia
- Dolor disminuye con la defecación

NO debe haber síntomas de alarma y la COLONOSCOPIA debe ser normal

Tratamiento

- Educación + disminuir stress
- Fármacos
 - o Antidepresivos tricíclicos → En caso de diarrea
 - o Trimebutino → En caso de constipación

2. Ictericia

VN de la bilirrubina es < 1,1, pero genera ictericia sobre 2-2,5mg/dl

Diagnóstico diferencial → Carotenosis (Coloración amarillo-naranja de cara, palmas y plantas.
Por consumo de carotenos(zapallo, zanahoria)

Causas

- Hiperbilirrubinemia indirecta
 - Síndrome de Gilbert (con pruebas hepáticas normales, es genético y se observa)
 - Hemolisis → Anemia con esquiztosis y LDH elevada. El Tto es según el tipo de anemia.
- Hiperbilirrubinemia directa (Cuando más del 30% de la bili es conjugada)
 - Hepatitis → Elevación de las transaminasa
 - Colestasia → Elevación de FA y GGT
 - Cirrosis biliar primaria
 - Coledocolitiasis/colangitis (Colestasias dolorosa)
 - Cáncer (colestasia sin dolor)

Ictérica por cáncer

Es una ictericia indolora o dolor leve (sordo) con baja de peso.

Sus causas son cánceres de páncreas o de vía biliar. Las pruebas hepáticas nos van a mostrar un patrón colestásico. **Se pide Eco (Siempre como 1ª aproximación diagnóstica)** y después RNM en caso de ver la masa. La excepción es el cáncer de páncreas, donde se pide TAC y no RNM.

3. Hepatitis

Hepatitis → Elevación de transaminasas AST (GOT) y ALT (GPT)

Lo importante frente a una hepatitis es buscar la causa para tratarla

Causas

- Agudas
 - Virus
 - **VHA, VHB, VHE** y virus herpes (CMV, VEB y VHS)
 - OH y tóxicos
 - Fármacos
- Crónicas
 - NASH (esteatohepatitis no alcohólica)
 - Virus
 - **VHB y VHC**
 - Autoinmune

El riesgo de las hepatitis agudas es hacer una hepatitis fulminante. Se define como Ictericia + encefalopatía. Es un cuadro muy grave en el cual el paciente generalmente fallece

Examen → TP nos marca el riesgo de progresión a hepatitis fulminante

En cambio el riesgo de la hepatitis crónica es pasar a DHC, por lo tanto, en este caso el examen a pedir es la biopsia hepática (nos muestra el daño y el futuro del cuadro).

Riesgo de Hepatitis fulminante ---- Examen a pedir es el TP ---- Manejo con trasplante

Riesgo de DHC---- Examen a pedir es la Bx hepática ---- Manejo es con besito en la frente

HEPATITIS AGUDA

- Virus Hepatitis A

Es la 1ª causa de hepatitis

Transmisión→ Vía fecal-oral o vía sexual (que sigue la misma lógica, Moraleja: No chupen ano si no están vacunados)

Clínica

- Fiebre
- Malestar general
- Dolor abdominal HD
- - Ictericia
- Coluria
- Acolia

Puede presentarse también de forma silente o asintomática (frecuente en niños), Recurrente (hace una nueva hepatitis 1 mes tras el cuadro, es una respuesta inmune y finalmente la forma colestásica (aumento de FA, Bili y GGT)

Diagnostico→ IgM VHA (IgG (+)→ ya lo tuvo o está vacunado)

Tratamiento→ Soporte e higiene para no contagiar al resto

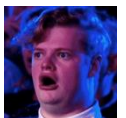
Se debe pedir el TP para evaluar el riesgo de progresión a hepatitis fulminante que es 0,1% (1 en 1000)

Manejo de contactos→ Vacunar (contactos extradomiciliarios) o dar IgG (contactos intradomiciliarios)

- Virus hepatitis B

Transmisión→ La vía de contagio mas importante es la sexual y en 2º lugar la parenteral. Generalmente da un cuadro de hepatitis aguda, pero un 10% cronifica.

Clínica→ Igual a VHA en la etapa aguda e igual a hepatitis crónica en la presentación crónica



Diagnóstico→ Antígeno de superficie VHB (**Ag-VHBs**) y Anticuerpo anticore (**IgM VHBc**).

IgG – VHBs→ Nos muestra que esta vacunado o tuvo la infección previamente.

IgG VHBc→ Nos muestra que tuvo la infección previamente o que tiene una hepatitis crónica. En caso de estar **vacunado NO VA A TENER ESTE MARCADOR POSITIVO, solo la IgG-VHBs.**

Diagnóstico	Ag Superficie	IgM Core
Aguda	+	+
Crónica	+	-
Aguda P.Ventana	-	+

Tratamiento

Agudo→ Soporte y antivirales. Tiene más riesgo de hepatitis fulminante, riesgo es de un 1% (1/100)

Virus Hepatitis C

Solo genera hepatitis crónica , pero un 10% no cronifica

Clínica→Hepatitis crónica – DHC

Diagnóstico→ Anticuerpos totales anti VHC y se confirma con PCR

Como es casi siempre una Hepatitis crónica se debe realizar biopsia. Se maneja con antivirales y manejo del DHC

- Hepatitis por OH

Suele venir con antecedente de consumo de alcohol

Diagnostico→ Lo da la relación entre las transaminasas, en el cual, la GOT es el doble de GPT

Marcadores de consumo de alcohol→ Aumento de GGT y VCM

Tratamiento→ Soporte

-Hepatitis por fármacos

Casi cualquier fármaco puede producirlo. (Paracetamol y anti TBC lo más típicos)

SE DEBE SUSPENDER EL FARMACO INMEDIATAMENTE. En caso de paracetamol se da n-acetilcisteína y si es por anti TBC se debe suspender y derivar a especialista.

HEPATITIS CRÓNICAS

- NASH→ Esteatohepatitis no alcohólica (Hígado graso)

Causa→ RI (suele tener antecedente de DM2 u obesidad porque se relacionan con RI)

Diagnostico→ Ecografía que muestra un hígado hiperrefringente. SE DEBE DESCARTAR OTRAS CAUSAS (VHB, VHC, AI)

Tratamiento→ Dieta, baja de peso y metformina (tratamiento de la resistencia a insulina)

- Hepatitis autoinmune (AI)

Hepatitis crónica con aumento de **ANA, ASMA y anti LKM1. Se debe confirmar con biopsia como buena hepatitis crónica.**

Suele estar asociado a otras enfermedades autoinmunes

Tratamiento→ Corticoides + inmunomoduladores

- Cirrosis Biliar Primaria

No es hepatitis, es una colestasia (elevación de FA, Bili y GGT)

Clínica→ Da astenia principalmente, ictericia y prurito

Diagnostico→ AMA (Anti mitocondriales). Se confirma con biopsia

Tratamiento-> Acido ursodeoxicólico

4. Patología Biliar

COLELITIASIS

Presencia de cálculos en la vesícula.

Formas de presentación

1. Asintomático → Por hallazgo en ecografía, se debe operar laparoscópicamente de forma electiva.
2. Cólico Biliar → Dolor en epigastrio e HD de tipo sordo o cólico que dura **20-30 minutos** asociado a vómitos. El diagnóstico es clínico, pero se debe pedir Eco para descartar Colecistitis. Se maneja de forma sintomática con AINEs y antiespasmódicos. Tras la resolución del cuadro se debe planificar una colecistectomía laparoscópica.

COLECISTITIS AGUDA

Es similar, pero:

- Dolor dura más de 30 minutos
- Presencia de fiebre
- Elevación de PCR y leucocitos
- Signo de Murphy positivo

La ecografía muestra **barro biliar, pared vesical engrosada (>4mm) y vesícula distendida (>10cm).**

Manejo → Cirugía de urgencia.

COLEDOCOLITIASIS

Se presenta como dolor + ictericia

Pruebas hepáticas muestran colestasia

Ecografía → 1er examen a pedir, muestra vía biliar dilatada (>7mm). En algunos casos sirve para ver los cálculos

Colangio RNM → De elección porque muestra los cálculos

ERCP → Diagnóstica y terapéutica (después de hacer la RNM). Tras este procedimiento se debe realizar una colelapanoscopia de forma electiva.

COLANGITIS

Intenso dolor + ictericia marcada + fiebre (triada de Charcot). Si se agrega compromiso de conciencia + hipotensión se conforma la llamada Pentada de Reynolds

El diagnóstico es clínico

Manejo → SF + ERCP + ATB amplio espectro (ceftriaxona + metronidazol)

¿A quién hacer ERCP?

- Clínica de colangitis
- Observación de cálculos en colédoco en la eco
- Cuando laolangio RNM muestra cálculos

COLECISTITIS CRÓNICA

Suelen ser asintomáticas y se diagnostican por la Eco abdominal. Hay 2 tipos

1. Vesícula en porcelana
2. Vesícula escleroatrófica

Ambas tienen riesgo de progresar a CA de vesícula, por lo cual, el manejo es con Cirugía electiva

5. Cánceres digestivos

Clínica→ Todos pueden producir baja de peso, hemorragia digestiva, anemia y síntomas de alarma del ABCDE...

El diagnóstico es con EDA o EDB + biopsia según sea la sospecha. Se etapifican con TAC TAP

Pronóstico→ **Depende de la invasión transmural**

EL tratamiento curativo es la cirugía + QT y/o RT según corresponda

- **Cáncer de esófago**

Clínica→ Disfagia lórica

Antecedentes de importancia→ RGE y tabaquismo

Etapificación--> Acá nos sirve la endosonografía también.

- **Cáncer gástrico**

Clínica

- Sd pilórico (vómitos postprandiales que van en aumento)
- Masa epigástrica
- Dolor urente
- Adenopatías supraclaviculares

Suele dar síntomas tardíos, cuando ya da síntomas suele ser muy tarde.

Es la 1ª causa por muerte de cáncer en hombres y la 2ª en mujeres.

Fuertemente asociado a la presencia de E. pylori.

- **Cáncer de colon**

Síntomas mas frecuentes→ Constipación y se suele complicar con obstrucción intestinal (1ª causa de obstrucción intestinal en colon).

En caso de que tenga muchísimos pólipos en la colonoscopia, el tratamiento es colectomía total, dado que, probablemente se trate de polipomatosis adenomatosa familiar (PAF) y esta evoluciona en un 100% de los casos a cáncer.

Marcador de CA de colon→ CEA. **Sirve para el seguimiento de la enfermedad**

QT→ Suele tener muy buenos resultados y por eso mismo es un cáncer de mejor pronóstico.

Se opera SIEMPRE (hemicolectomía), incluso aunque este muy avanzado, para evitar que se obstruya

Pólipos en la colonoscopia

Si hacemos colonoscopia y nos encontramos con una pólipo **debemos sacarlo si o si para bx.**

En caso de que sea de tipo hiperplásico (el mas frecuente) simplemente se observa. Pero si es adenoamitoso, tiene riesgo de evolucionar a cáncer, entonces se debe hacer seguimiento colonoscópico seriado.

- **Cáncer de recto**

Se asocia a infección por VIH, VPH y colitis ulcerosa

Clínica→ Afecta la defecación, produciendo dolor o cambiando su forma.

Da harta metástasis a pulmón, por lo cual, el TAC de tórax va si o si. Además se debe pedir RNM de pelvis y endosonografía. Es decir, se deben pedir muchas imágenes para etapificar este cáncer.

6. Abdomen Agudo

Lo más importante es conocer la clínica

Abdomen agudo: Dolor abdominal potencialmente grave (muchas causas)

El diagnóstico es clínico

Las imágenes son útiles, pero no reemplazan a la clínica

No todos son quirúrgicos, no todos reciben ATB y no todos tienen signos peritoneales

- Apendicitis aguda

Dolor epigástrico/periumbilical que migra para ubicarse en la fosa iliaca derecha.

El diagnóstico es clínico.

En una mujer joven con esta clínica se le debe hacer un test de embarazo y evaluación ginecológica.

- Plastrón apendicular

Clínica de apendicitis que lleva varios días. Tiene una masa en la FID. Suele venir con antecedente de automedicación con ATB.

El diagnóstico no es solo clínico, se necesita un TAC.

Manejo → ATB Ev (Ceftriaxona + Metronidazol). En 2ª instancia podría relajarse una laparoscopia (a los 6 meses), esto es discutible.

- Diverticulitis aguda

Afecta a adultos sobre los 50 años generalmente. Su clínica es similar a una apendicitis, pero en FII

El diagnóstico es clínico, pero se pide un TAC para determinar el pronóstico y manejo.

CONTRAINDICADA LA COLONOSCOPIA

Se clasifica según la escala de Hinchey para saber el manejo

Hinchey I → Absceso pericólico menor a 5 cm. **Se trata con ATB (Cipro + MTZ o cfx + mtz) mas régimen líquido.**

Hinchey II → Absceso de mas de 5 cm o que esté distante (no pericólico). Se trata con drenaje con punción guiada por eco o TAC + ATB Ev (CFT + MTZ)

Hinchey III → Peritonitis difusa → Cirugía de Hartmann

Hinchey IV → Peritonitis esterocorácea → Cirugía de Hartmann

En caso de tener 2 o más casos de diverticulitis grado I o II se debe hacer una colectomía electiva.

- Enfermedad Diverticular

Se clasifica en complicado o no complicado

- No complicado → Tto → Dieta rica en fibra
 - Asintomática
 - Clínica inespecífica (SII)

- Complicada
 - Diverticulitis → Se trata con cirugía electiva
 - Perforación
 - Obstrucción
 - Fistulas
 - Hemorragia digestiva baja → Colonoscopia

7. Abdomen agudo de origen vascular

Se preguntan con cierta frecuencia. Lo importante es saber la clínica

- Embolia Mesentérica

Antecedente de FA generalmente

Clínica

- Dolor súbito muy intenso sin signos peritoneales (Aparecen al final cuando se necrosa)
- Puede haber vómitos y diarrea
- Hematoquezia
- RHA aumentados en un inicio, pero se van apagando a medida que se necrosa el intestino

Manejo

- AngioTAC
- Anticoagulación con heparina + Embolectomía o Trombolisis
- Suero fisiológico + ATB
- Cirugía en caso de necrosis/perforación

- Trombosis venosa mesentérica

Clínica

- Clínica similar, pero mas larvada
- Sí presenta signos peritoneales

Manejo

- Estudio con TAC c/c
- Anticoagular con heparina.
- Suero fisiológico + ATB
- Cirugía en caso de necrosis/perforación

- Colitis Isquémica

Clínica

- Dolor en HI (ángulo izq. del colon tiene irrigación terminal)
- Pueden tener hematoquezia
- Puede tener Signos peritoneales

Manejo

- TAC que mostrará inflamación en el ángulo izquierdo
- Suero fisiológico + ATB
- Cirugía en caso de necrosis/perforación

8. Pancreatitis

Pregunta segura

Pancreatitis aguda

Causas

- **Litiasis**
- **OH**
- **Hipertrigliceridemia (sobre 500)**
- Viral
- Traumática
- Autoinmune
- Otras

Clínica

- Dolor epigástrico irradiado en faja hacia los flancos
- Vómitos profusos
- Signos de Cullen (hemorragia periumbilical), Grey Turner (hemorragia zona lumbar) y Mayo-Robson (dolor en la unión costovertebral)
- CEG, fiebre, distress

Diagnostico

Clínica + amilasa y Lipasa sobre 3 veces su máximo. La Lipasa es más específica, pero la amilasa también sirve,
El pronósticos se ve con el TAC a través de la clasificación de Baltazar.
Los criterios de APACHE y Ranson (obsoletos) sirven para pronóstico también.

Criterios de Ranson			
↳ Obsoletos, pero útiles.			
L	LDH	V	Volumen (edema)
L	Leucocitosis	A	Anemia
E	Edad >55 años	N	BUN ↑
G	Glicemia ↑	C	Calcio ↓
O	GOT ↑	H	H+ (Acidosis)
		O	Oxígeno ↓

Tratamiento

- Régimen O
- Hidratación EV
- Alimentación con sonda nasoyeyunal o Nutrición parenteral.
- AINEs
- ATB solo ante
 - Infección
 - Abscesos y necrosis infectados

Cirugía → Pancreatitis infectada o pseudoquiste 666 (mas de 6cm, ms de 6 semana y 6tomas(síntomas))

PANCREATITIS CRONICA

La causa es alcohol

Dolor postprandial o post consumo de alcohol.

Se suele complicar con diabetes insulino dependiente y síndrome de malabsorción

Diagnóstico → TAC

Tratamiento

- Suspender consumo de OH
- AINEs para tratar el dolor
- Insulina si se complica con DM
- Enzimas Vo si se complica con sd de malabsorción
- Cirugía → Solo cuando no responde a AINEs

Angina mesentérica

Dolor abdominal post-prandial, baja de pesos y diarrea. Si tiene antecedentes de factores de riesgo cardiovascular nos orienta a este diagnóstico. Se trata con manejo de los factores de riesgo cardiovascular y stent mesentérico.

9. Hemorragia digestiva

Preguntas seguras

Masiva → Compromiso hemodinámico. Primero se produce taquicardia, luego ortostatismo y finalmente caída de P/A.

Ambas se tratan igual, Fluidos Ev + EDA o colonoscopia

La gravedad va a estar determinada por la HEMODINAMIA Y NO POR EL HEMTOCRITO, dado que, este se altera después.

- HDA

Sobre el ángulo de Treitz

Viene con melena y/o hematemesis

Causas

- Várices esofágicas → Suelen ser masivas, con hematemesis. Viene con antecedente de DHC generalmente (sospecharlo si tiene protrombina baja).
- Úlcera gastroduodenal → Suele venir con antecedente de síndrome ulceroso (dolor urente epigástrico que aumenta en ayuno). Más que hematemesis presentan MELENA.
- Síndrome de Mallory-Weiss → Vómitos alimentarios profusos que son seguidos por hematemesis. Suele resolver espontáneamente.

Manejo → Siempre se da SF y se debe hacer una EDA.

Varices → SF + EDA + Terlipresina + ATB (profilaxis PBE) + Vit B1 en caso de ser alcohólico (profilaxis Encefalopatía de Wernicke)

Úlcera → SF + EDA + Omeprazol Ev

Mallory-Weiss→ Podría ahorrarme la EDA si el paciente esta en BEG y la clínica es evidente.

- HDB

Bajo el ángulo Treitz

Viene con hematoquezia y/o rectorragia

Causas:

- Enfermedad Diverticular→ Hemorragia Diverticular. Suele ser un sangrado grave
- Angiodisplasia
- Cáncer de colon
- Divertículo de Meckel en niños

Manejo

Suero fisiológico

Enfermedad divertículo→ Colonoscopia en 24 horas tras preparación de colon en caso de no ser masiva. Si es masiva no esperamos y se hace urgente tras meterle volumen.

Es probable que no vea nada por la presencia de deposiciones. Si no veo nada tengo que hacer EDA, porque un 10% de las HDB pueden ser de origen alto.

Como tercera línea tenemos la Angiografía mesentérica y como último recurso la hemicolectomía (derecha generalmente)

En caso de no ser masiva no encontrarse el origen mediante la colonoscopia, se puede hacer una enteroclisia por TAC para buscar el origen en intestino delgado.

10. Enfermedad inflamatoria intestinal

Causa→ Enfermedades autoinmunes

Afectan a personas jóvenes.

Caracterizadas por dolor abdominal +diarrea crónica. Suelen tener baja de peso, fiebre y DISENTERÍA.

Pueden venir con manifestaciones extraintestinales como artritis (lo más frecuente), uveítis, eritema nodoso y Pioderma gangrenoso. Ambas se diagnostican con colonoscopia

COLONOSCOPIA

CU

Siempre afecta recto
Inflamación Continua
Nunca afecta Intestino Delgado

EC

No siempre afecta recto
Inflamación en parches
Puede afectar Intestino Delgado

Diferencias de CU y EC

EC → Suele afectar intestino delgado, generalmente el íleon distal.
Viene generalmente con síndrome de malabsorción, la CU no.

CLÍNICA

CU

Pujo
Tenesmo
Diarrea
Disentería

EC

+
Úlceras orales
Masa abdominal
Absceso perianal

HISTOLOGÍA ANTICUERPOS

CU

Afecta Mucosa
ANCA

EC

Afectación Transmural
ASCA

TRATAMIENTO

ATB + AINES + CORT + Inmunomod.

Si Falla o Complicaciones → Qx

CU

Colectomía subtotal
Si Cá de Colon → Total +
Ileostomía.

EC

Resecar el segmento afectado.

Suele hacerse una colectomía subtotal para permitir la defecación, pero en caso de que se asocie a Cáncer, la colectomía será total con ileostomía

En caso del Crohn solo se resecta la porción afectada porque puede afectar a todo el tracto GI

Principales causas

- Cáncer de esófago
- Acalasia

Disfagia → dificultad para tragar

Lógica → Progresiva de sólido y líquidos. Cáncer suele ser la causa

Ilógica → Fluctuante, afecta desde un principio a los líquidos. De cuenta de un trastorno motor (esclerodermia y Acalasia)

CÁNCER DE SÓFAGO

Factores de riesgo

- Cigarrillo
- RGE

Clínica → Disfagia lógica + baja de peso

Diagnóstico → EDA+ biopsia

Etapificación → TAC TAP

Tratamiento → Cirugía es lo único curativo QT y RT.

Cáncer de cardias → Igual al cáncer de esófago, pero no se pregunta

ACALASIA

Disfagia ilógica baja fluctuante.

Se asocia a NAC aspirativas y RGE no ácido, pues viene del esófago, no del estómago.

Diagnóstico → Manometría (disminución de la peristalsis mas aumento de tono el esfínter esofágico inferior. En este tipo de trastornos suele iniciarse estudio con EDA, pero si se sospecha fuertemente de acalasia, se hace la manometría como primer examen y así tenemos el diagnóstico

Tratamiento → Cirugía → Esfinterotomía.

La inyección de bótox es otro tratamiento, pero la cirugía es la de elección

Esclerodermia

Disfagia de tipo ilógica + pirosis + CREST

Divertículo esofágico

También son causa de disfagia que no debemos confundir con acalasia

El más típico es el divertículo de Zencker. Es una disfagia alta de tipo fluctuante, dado que, a veces el divertículo se llena de comida. Viene con halitosis por la acumulación de comida en el divertículo. Hacen NAC aspirativas también.

Se estudia con Rx con bario

El tratamiento es quirúrgico

Divertículo del cuerpo esofágico → Se observan

Divertículo del esfínter esofágico inferior → Igual al divertículo de Zencker, solo que la disfagia es baja. Se maneja igual que Zencker (Rx con bario y Cx)

12. Diarrea

Diarrea → Baja en la consistencia de las deposiciones con aumento en la frecuencia (mas de 3 veces al día)

Aguda → Menos de 2 semanas

Prolongada → 2-4 semanas

Crónica → Más de 4 semanas

- Diarrea Aguda

Suelen ser de causa infecciosa, siendo los virus mas frecuentes que las bacterias.

Diagnostico → Clínico

Tratamiento pediátrico → Hidratación.

Si es leve (baja de peso <5% o sin signos de DH) → Se maneja con plan A, hidratación por vía oral. 100-200cc después de cada deposición líquida.

Si es moderada (5-10% del peso sequedad de las mucosas, ojos hundidos, sed), se utiliza el plan B, 50-100cc por kilo de peso en 4-6 horas.

Si es severa se pasa a plan C, hidratación Ev.

En 1er lugar se trata la volemia y después los trastornos hidroelectrolíticos, a menos que venga con hipernatremia (en este caso no se da SF, se dan soluciones glucosalina o solución hipotónica)

Si no encontramos vena, en niños se hace osteoclisis y en adultos se debe llamar a cirujano.

Antidiarreicos → NUNCA en diarrea aguda

Antiespasmódicos → En caso de dolor

ATB → Ciprofloxacino o cefalosporinas de 3ª generación en caso de

- Disentería o demostración de que es por Shigella
- Fiebre por 2 días o mas en adultos
- Diarrea del viajero

En niños se deja ante un niño con mal estado general con disentería, fiebre alta, dolor intenso y/o presencia confirmada de Shigella o ECEI

- **Diarrea prolongada** → Se debe buscar el agente infeccioso, es raro que bacterias o virus duren mas que esto. Se toma coprocultivo y EPSD

- Diarrea Crónica

Si tiene clínica funcional (dolor que disminuye con la evacuación, distensión abdominal y mucosidad en sangre) se maneja como una diarrea funcional, es decir, manejar el stress, educar y antidepresivos tricíclicos

Si hay signos de alarma (ABCDE) la conducta es ir a descartar cáncer o EII con colonoscopia
Si hay clínica de síndrome de malabsorción (lentería o esteatorrea) se debe estudiar con Sudan III y estudio de enfermedad celiaca (Anticuerpos anti transglutaminasa, anti endomisio y EDA)

Si tiene clínica de EII (Disentería, fiebre, hematoquezia) se debe estudiar con colonoscopia

Si estuvo con ATB de forma previa se debe ir a buscar el clostridium

Diarrea post ATB → Paciente con diarrea con antecedente de uso de ATB hace menos de 1 mes.

La causa importante a descartar es la diarrea por C. Difficile (se ha preguntado en el último tiempo).

El diagnostico es con la PCR, aunque también sirven las toxinas A y B de clostridium.

Tratamiento → Metronidazol Vo. Si falla se repite y si falla de nuevo se da Vancomicina

Como se si responde a tratamiento? → Mejoría de la clínica en 1 semana.

Ej: Parto metronidazol y pasa una semana de tto pero sigue con diarrea → Repito metronidazol → Vuelve a pasar una semana y sigue con diarrea → Doy vancomicina

Constipación → Aumento en la consistencia de las deposiciones con una disminución en su frecuencia (menos de 3 veces a la semana)

Manejo → Si es funcional se maneja con educación, manejo de stress y Trimebutino (NUNCA dejar antidepresivos tricíclicos porque se la empeoraríamos)

Si hay síntomas de alarma (ABCDE) se va de colonoscopia

13. RGE, UGD, dispepsia, H. pylori

Se preguntan con mucha frecuencia y tienden a confundirse

- RGE

Causa → Relajación transitoria del esfínter esofágico inferior

Clínica

- Pirosis
- Regurgitación ácida
- Tos, asma, disfonía y lesiones dentales como presentación mas atípica

Diagnóstico

De 3 formas distintas

1. Clínica típica (Pirosis + regurgitación ácida) → diagnóstico hecho

2. Clínica atípica se pide pHmetría de 24 horas (Gold Standard)
3. Endoscopia digestiva alta (por hallazgo, no se pide de entrada a menos que tenga síntomas de alarma)

Tratamiento

1. Medidas generales
 - a. Comer de forma fraccionada
 - b. Levantar respaldo de la cama
 - c. Evitar OH y BDZ, sobretodo antes de dormir
2. Fármacos → En ayunas, 30 min antes de comer
 - a. Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol
 - b. Ranitidina o famotidina (pencas)
3. Cirugía → En ciertos casos
 - a. Esófago de Barret
 - b. Paciente joven muy sintomático que no responde a tratamiento (se preguntó una vez como joven que en la EDA de control seguía con senda esofagitis)

Esófago de Barret

Es una Metaplasia intestinal

Clínica → Es asintomática, viene con la sintomatología del RGE como mucho.

El riesgo del Barret es producir un Ca de esófago

A todo paciente con RGE cada cierto tiempo se debe pedir una EDA para hacer el diagnóstico (con biopsia)

Tratamiento → Tratamiento del RGE. LA cirugía se hace solo cuando la biopsia nos muestra displasia. Si no hay displasia se debe manejar como RGE con EDA periódicas.

- Úlcera gastroduodenal

Causas

- H. pylori (70/90% gástrica/duodenal)
- AINEs
- Tabaquismo

Clínica → Epigastralgia urente que aumenta con ayuno y disminuye con ingesta de alimentos

Diagnóstico → EDA

Tratamiento → Se debe tratar la causa (erradicar H. pylori, suspender AINEs). Se deja omeprazol por 6 semanas. Esta bacteria se erradica en caso de tener una úlcera gástrica y test de ureasa (+) o en caso de úlcera duodenal SIN IMPORTAR EL RESULTADO DEL TEST DE UREASA, se asume que hay H. pylori)

Complicaciones

- Hemorragia digestiva alta → Se trata con SF + Omeprazol EV + EDA de urgencia

- Perforación → Da una peritonitis difusa. Es un dolor epigástrico que se generaliza rápidamente. Se estudia con Rx de abdomen de pie que nos muestra neumoperitoneo. Se debe hacer una Cx de urgencia. Está CONTRAINDICADA la EDA.

Dispepsia funcional

Clínica → Dolor epigástrico urente + EDA normal. Es un diagnóstico de descarte
Es distinto del intestino irritable, pues este si necesita de criterios diagnósticos

Tratamiento

- Educar
 - o Manejo de stress
- Moduladores del dolor
- Erradicar H. pylori
- Omeprazol

H. Pylori

75% de la población es portadora

El diagnostico es con la EDA – biopsia o test de ureasa

Riesgos asociados a la portación

- Úlcera GD
- Cáncer
- Linfoma MALT

Erradicación

ATB + IBP

1ª línea → Amoxicilina 1g/12 + Claritromicina 500mg/12hrs + omeprazol 20mg/24hrs x 14 días

En caso de falla a tratamiento:

2ª línea → Tetraciclina + metronidazol + bismuto + omeprazol

Evolución del éxito

En caso de ulcera gástrica se debe realizar una EDA, para asegurar que bajo la úlcera no hay cáncer

En caso de ulcera duodenal me basta el antígeno en deposiciones para helicobacter

¿A quienes erradico?

- Úlcera gastroduodenal
- Linfoma MALT
- Dispepsia funcional
- Usuario de AINEs
- Metaplasia/displasia
- Antecedente familiar de Ca gástrico
- Gastritis atrófica

14. Malabsorción y enfermedad celiaca

Ambas se pregunta con frecuencia

- Síndrome de malabsorción

Clínica

- Diarrea
- Baja de peso
- Esteatorrea
- Lientería
- Signos carenciales (anemia ferropénica, piel seca, quelitis angular, caída de pelo, etc.)

El diagnóstico es relativamente clínico, pero se necesitan exámenes para ir a confirmarlo
Test de Sudan → Utiliza una muestra de deposiciones para determinar la presencia de grasa en ellas. Es un test para confirmar la esteatorrea y con esto la malabsorción

Test de D-xilosa → La D-xilosa es un monosacárido que se absorbe pero no se digiere, por lo cual, se orina. Si la cantidad de d-xilosa orinada es menor a la cantidad ingerida, no habla de un problema parietal, un problema de absorción intestinal (enf celiaca, Crohn, intestino corto, etc.). Si esta normal asumimos que es un problema enzimático como la fibrosis quística, pancreatitis crónica.

Se pide un EPSD para descartar una giardiasis

Estudio de enfermedad celiaca es otras causa

Respuesta inmune al gluten (antígeno en cereales) que genera inflamación y atrofia de la pared intestinal.

Clínica

- Síndrome de malabsorción
- Dolor abdominal
- Disminución del apetito
- Gases

Suele venir con anemia ferropénica e hipocalcemia, dado que, estos 2 electrolitos se absorben en el duodeno (la parte mas afectada por la enfermedad celiaca)

Se puede confundir con un trastorno funcional fácilmente.

Diagnostico:

- Anticuerpos
 - Antitransglutaminasa
 - Anti endomisio
- EDA
- Biopsia de duodeno
 - Disminución de la altura de las vellosidades
 - Alargamiento de las criptas

- Infiltrado linfoplasmocitario en la lamina propia

Se pide también IgA total, dado que, suele estar baja y como los anticuerpos anti endomisio y anti TG también son IgA, entonces si esta muy bajo podría ser un falso negativo.

Tratamiento→ Dieta sin gluten ni avena

Control→ Clínica + niveles de anticuerpos (deberían ir bajando hasta llegar a ser negativos al año si ha seguido bien la dieta)

La falta de respuesta a tratamiento es por falta de apego a la dieta. En caso de que los anticuerpos si estén negativos (es decir, si hay apego a la dieta), se debe sospechar en un linfoma de MALT, el cual, se trata con antibióticos

Intolerancia a la lactosa

Hay una disminución de la producción de lactasa

- diarrea
- Dolor abdominal
- Distensión abdominal

Puede simular un sd de malabsorción.

Dg→ Prueba de tolerancia a la lactosa (Se toma lactosa y se miden los niveles de lactosa en sangre, los cuales, van a ser 0 porque no la absorbe)

Tratamiento→ No tomar lactosa

Galactosemia

Enfermedad genética recesiva rara.

Faltan enzimas que degradan la galactosa

La clínica es inespecífica

Da ictericia, IRC, daño del SNC y cataratas

Tratamiento→ Dieta sin lactancia materna ni ningún otro tipo de leche animal, se debe dar “leches” de origen vegetal

15. Daño hepático crónico

Se pregunta siempre

Causa

1,2 y 3→ Alcohol

4. Esteatohepatitis alcohólica

5. VHC, VHB

6. Hepatitis autoinmune

7. HBP

Clínica

- Ictericia
- Ginecomastia
- Disminución del vello
- Telangectasias faciales
- Atrofia de eminencias tenar e hipotenar (palma hepática)
- **Síntomas de hipertensión portal**
 - Hemorroides
 - Cabeza de medusa
 - Esplenomegalia
 - Hipocratismo digital

Complicaciones y su manejo

1. Derivadas de la HTP
 - a. Ascitis
 - b. Varices esofágicas
2. Por la insuficiencia hepática
 - a. Encefalopatía hepática
 - b. Coagulopatía hepática
3. Síndrome hepato renal → Es tanto por la HTP como la insuficiencia hepática, pero mas asociado a la ascitis

Manejo

- Varices esofágicas
 - Asintomáticas (en EDA de control) → Los pacientes con DHC deben hacerse una EDA al año. El manejo de estas varices asintomáticas es la profilaxis de la hemorragia variceal, esto es con propranolol. Su ligadura no esta indicada como profilaxis primaria, solo en caso de contraindicación a betabloqueo. En caso de haber tenido HDA previa ahí se aplica profilaxis secundaria que implica ligadura + Betabloqueo. Si esto falla se debe hacer TIPS
 - Sintomáticas (Hemorragia digestiva) → 2 vías venosas gruesas y se debe dar SF + EDA de urgencia para escleroterapia o ligadura. Mientras tanto se da Terlipresina y de forma profiláctica se da tiamina (para la encefalopatía de Wernicke) y ATB (para la PBE).
- Ascitis → Es de diagnostico clínico con matidez desplazable, aumento del diámetro abdominal y el signo de la ola. Ante la duda se pide una ecografía. El tratamiento depende del contexto
 - Ascitis común → Diuréticos + restricción hidrosalina (furo + espiro)
 - Ascitis a tensión → Paracentesis evacuadora con reposición de albúmina (8g/l sacado después de los 5 litros). Antes de drenar una ascitis a tensión se debe descartar la PBE, es decir, antes de evacuarla se debe hacer una punción diagnóstica para descartar PBE.

- Ascitis refractaria → Ascitis que no responde a diuréticos. Se trata con ascitis periódicas. El tratamiento ideal es con Tx hepático o TIPS como 2ª opción. TIPS está contraindicado en caso de encefalopatía
- PBE → Se pregunta con frecuencia. El diagnóstico es con la Paracentesis diagnóstica. El diagnóstico se hace cuando hay más de 250 PMN por mm³. Todo cirrótico descompensado con ascitis se debe pinchar SI O SI, porque es PBE hasta que se demuestre lo contrario. Tratamiento → Cefotaxima Ev + albumina 1,5g/Kg y 1g/kg por 3 días para profilaxis de síndrome hepato-renal. Además debe quedar con profilaxis de PBE. Esta profilaxis también se da en caso de HDA o ascitis o albumina muy baja. Esta profilaxis es con ciprofloxacino a permanencia mientras tenga ascitis
- Síndrome hepato renal → Complicación con un pronóstico muy malo. Es una IRA pre-renal asociado a DHC. Se deben descartar otras causas de IRA. Para mantenerlo vivo se debe dar Terlipresina, albumina y paracentesis evacuadoras, pero el tratamiento real es el trasplante
- Síndrome hepato-pulmonar → Hacen ortodeoxia, lo contrario a la Ortopenia.
- Encefalopatía → Aumento de toxinas intestinales que no son filtradas por el hígado. El diagnóstico es clínico (desorientación, compromiso de conciencia y asterixis). El tratamiento es buscar el descompensante que suelen ser las infecciones. Además se da lactulosa para aumentar el tránsito intestinal (aumenta la excreción de toxinas causantes) se dan 15cc/8 horas de lactulosa para tener 2-3 deposiciones blandas al día.
- Coagulopatía hepática → EL hígado produce los factores de la coagulación. Caída en los factores de la coagulación, se alarga el TP o INR. Suele haber esplenomegalia, la cual, va a producir plaquetopenia. Estas 2 cosas me aumentan el riesgo de sangrado. Tratamiento → Transfusión de plaquetas (si menores a 50.000) + plasma fresco congelado o crioprecipitado. También debemos tratar el fenómeno descompensante que suelen ser infecciones.

Hay que conocer el manejo de las distintas ascitis, en eso es donde uno se confunde

Infectología

1. Sepsis

Infección + SIRS

Diagnóstico

- Leucos > 11.000
- PCR > 1 mg/dl o 10 mg/L
- VHS > 20
- Procalcitonina > 10 (más específica)

Tratamiento

- Suero fisiológico
- Antibióticos → Según foco y bacterias

Shock séptico → Hipotensión que no responde a volumen. Se deben agregar drogas vasoactivas y evaluar desfocar el foco.

Definitivamente el video más de mierda de nuestro querido Dr espasmofémico

2. Manejo de contactos

Contacto intradomiciliario → Personas que viven bajo el mismo techo

Contacto extradomiciliarios → Personas que pasan mucho tiempo juntos (compañeros de colegio, trabajo, avión)

TBC

A un contacto de un bacilífera se debe ver si tiene clínica, Rx de tórax y Baciloscopía. A los menores de 15 años se les pide el PPD

Se debe dejar **RIPE** (tratamiento TBC) en caso de:

- BK (+)
- Menor de 15 años con Rx alterada.

Se deja **profilaxis** (Isoniacida por 6 meses)

- PPD > 10mm (> 5mm en caso de ser VIH)
 - o Por 6 meses en caso de ser positivo
 - o Por 3 meses en caso de ser negativo y control con PPD tras completado el tto.
- < 15 años
- PPD positivo tras 6 meses
- RN de madre bacilífera (vacuna BCG se le da posterior a completada la profilaxis a los 6 meses)

Hepatitis A

Extradomiciliarios → Vacunar

Intradomiciliarios → IgG anti VHA

Hepatitis B

Vacuna (Ante contacto más alejado) o IgG anti VHB (Ante exposición muy reciente)

Meningitis

Hib → Rifampicina por 4 días (20 mg/ kilo por 4 días)

Meningococo

- Rifampicina por 2 días
- Ciprofloxacino 500mg Vo dosis única
- Ceftriaxona 500 mg Ev dosis única

Coqueluche

Azitromicina por 5 días para:

- Contactos sintomáticos (Con tos y/o cuadro catarral)
- Contactos de riesgo
 - o Menores de 1 año
 - o Entre 1 y 2 años con menos de 3 dosis de vacuna (2,4 ,6 y 18 meses son las vacunas)
 - o Mayores de 65 años
 - o Hospitalizados
 - o Embarazadas en 3er trimestre
 - o Enfermedad descompensada (pulmonar, cardiaca o epilepsia)

Accidentes corto punzantes

Puede haber riesgo de VIH. Al paciente se le pide un VIH y en caso de ser positivo se debe dar triterapia por 3 meses. Si es de un paciente desconocido, se ofrece triterapia y ante serología negativa se observa

Además se debe hacer un ELISA el día del accidente, a las 6 semanas y 3 meses al que sufrió el accidente cortopunzante.

Otra clase de mierda



3. Síndrome mononucleósico, síndrome retroviral agudo y TORCH

Se pregunta con cierta frecuencia

Síndrome mononucleósico

Tiene una triada clásica compuesta por odinofagia, fiebre y adenopatías cervicales

Muy inespecífico porque muchos virus, algunas bacterias y parásitos pueden producirlo en su infección aguda

Además de esta triada se agregan otros síntomas

- Esplenomegalia
- Hepatomegalia
- Ictericia
- Hepatitis
- Rash morbiliforme → Presente en un 30% de los casos que aumenta a 90% en caso de usar aminopenicilinas (Amoxi-clav)

Hemograma → muestra linfocitosis (como en cualquier infección viral), pero estos linfocitos son extraños al frotis, es una linfocitosis atípica.

Anticuerpos heterófilos → Hace pensar harto en Mononucleosis, pero se piden poco, están obsoletos

Diagnóstico → IgM VCA o VEB

El virus Epstein Bar es por lejos el virus mas frecuente en producir Mononucleosis.

Su tratamiento es totalmente sintomático.

Si la IgM es negativa se debe pensar en otras causas de Mononucleosis como CMV, VIH, etc.

Síndrome retroviral Agudo

Síndrome asociado a la primo infección por VIH. Esta suele ser asintomática, pero de no serlo puede dar un sd monucleósico + un Rash rosado.

Para sospecharlos se debe tener un antecedente de riesgo (promiscuidad sexual, contacto sexual de riesgo o accidente cortopunzante)

Promiscuidad sexual → más de 2 parejas sexuales al año



El diagnostico es con PCR VIH o Antígeno p24. El ELISA no sirve a estas altura porque mide anticuerpos y estos demoran días en producirse.

Tratamiento → TARV

TORCH

T oxoplasma

O otros (sífilis, Chagas , varicela y Zika)

R ubéola

C itomegaloviurs

H erpes simplex

Se produce cuando hay una primo infección al inicio del embarazo, salvo en infecciones crónicas como sífilis o Chagas.

Riesgo
 Malformaciones (cerebrales, cardiacas, GI)
 Microcefalia con retraso mental

CMV→ Es la causa más frecuente, da una RCIU, microcefalia, hepatoesplenomegalia y Calcificaciones cerebrales.

Toxoplasmosis→ Es igual a CMV + Hidrocefalia (CMV igual, pero menos)

Rubéola→ Cataratas congénitas, microcefalia, cardiopatía congénita

Se hace un screening IgG de toxoplasma y CMV antes del embarazo. Como son IgG, si están positivas no habla de que no tiene riesgo de TORCH por estos bichos

La IgM no se pide

4. Meningitis

Tema muy preguntado



Clínica

- cefalea
- Nauseas
- Vómitos
- Fiebre
- Signos meníngeos (rigidez de nuca, Kernig y Brudzinski)

Se debe pedir TAC de cerebro para descartar HTEC y una vez descartada esta se hace una PL
 La PL me hace el diagnostico y diferencia entre las distintas etiologías

Ante la duda, se trata como si fuera bacteriana (en caso de que no haya TAC, si existe HTEC o tenemos una PL con líquido intermedio)

	Bacteriana	Viral	TBC	Normal
Glucosa	↓	N	↓	>40mg/dl
Tipo de células	PMN	MN	MN	-
No células	>1000	>10	>100	<10/mm³
Proteína	>100	>40	>100	<40mg/dl

Tratamiento MBA

- Antibióticos → empíricos, van a depender de la edad de paciente
 - o RN
 - Cefotaxima + ampicilina
 - o Niños
 - Ceftriaxona + Vancomicina (para neumococo resistente)
 - o Adultos
 - Ceftriaxona + Vancomicina (opcional)
 - o Adulto mayor y embarazada
 - Ceftriaxona + ampicilina (para cubrir listeria)
- Corticoides → Útiles en infecciones pediátricas producidas por neumococo y Hib, pero se da para todos

La ceftriaxona cubre: Neumococo (el más frecuente), Meningococo (2º mas frecuente), Hib y E. coli

Neumococo → Diplococo gram (+) en cadena corta. Responde a ceftriaxona

Meningococo → Diplococo gram (-). Responde a ceftriaxona o penicilina

Hib → Cocobacilo gram (-). Responde a ceftriaxona

E. coli → Bacilo gram (-), se trata con ceftriaxona

Listeria → Bacilo gram (+), se trata con ampicilina

ESTO SE PREGUNTA



Manejo de contactos

Hib → Rifampicina por 4 días (20mg/kg/día)

Meningococo → Rifampicina (20mg/kg/día), ciprofloxacino o ceftriaxona o 500mg dosis única

Encefalitis viral

Clínica muy similar a la MBA

Causado por enterovirus generalmente

Tratamiento → Paracetamol



En caso de ser por VHS 1 o 2 se puede producir una encefalitis herpética.

Se trata con aciclovir Iv, ante la mera sospecha se debe iniciar tratamiento

Se confirma con PCR de LCR

Que me hace sospechar encefalitis por VHS?

- Clínica grave (desorientación, convulsión, compromiso de conciencia)
- Afecta más adultos jóvenes y adolescentes

- Lesiones temporales en el TAC
- LCR con sangre (xantocromía o GR cromados)

5. IAAS y aislamientos

Es un problema frecuente, grave y caro

Suelen ser por bacterias multiresistentes, por lo cual, son difíciles y caras de tratar

Enterococo resistente a ampicilina y SAMR (*S. aureus* meticilino resistente) → Se trata con vancomicina como 1ª línea.

Bacterias BLEE (+) → No sirven las cefalosporinas para estas. Si es resistente a varias de las cefalosporinas es BLEE. Se tratan con carbapenémicos

C. difficile → Se trata con metro, si falla se repite esquema con metronidazol y finalmente como 3er tratamiento si ha fallado 2 veces el metro se da vancomicina

Pseudomonas y *acinetobacter baumannii* → Se tratan con quinolonas o aminoglicósidos. Cefoperazona, ceftazidima y cefepime tienen acción antipseudomónica

Prevención de IAAS → Dar de alta



Precauciones Standard → Lavado de manos y uso de guantes ante contacto con fluidos

Aislamiento de contacto → Guantes, pechera y utensilios exclusivos para el paciente aislado

Aislamientos de gotitas → Lo mismo que contacto + mascarilla si estaré a menos de 1,5 metros del paciente. Camas separadas por mínimo 1 metro entre ellas. Para todos los virus respiratorios y meningitis

Aislamiento respiratorio → Mascarilla siempre, paciente totalmente aislado, solo en su pieza. Varicela, sarampión y TBC requieren de este aislamiento

Aislamiento de cohortes → A todos los paciente enfermos con el mismo bicho los junto a todos en una misma pieza. Se hace cuando hay un brote de una enfermedad



6. Rabia y tétanos

No se pregunta la clínica, pero si su profilaxis

Rabia

Pasa de los murciélagos, de estos a las mascotas y de las mascotas a nosotros. Produce una encefalitis muy grave

Cuando indicar la vacuna antirrábica? → No tiene ninguna contraindicación, dado que, la mortalidad de la rabia es de 100%, asique nada puede ser peor que eso

- Contacto con murciélago
- Mordedura de animal no observable
- Mordedura por animal sintomático o que muere a los pocos días
- Mordedura de una animal salvaje raro

55.000 personas mueren al año por esto, pero en Chile no hay casos reportados
Solo falta que los chinos qls empiecen una pandemia de rabia por comer murciélagos esta vez, ahí si que la cagan los bastardos, grax amigos

TÉTANOS

Herida infectada con *Clostridium tetani*.

Quemaduras, mordeduras y cualquier herida que se pueda infectar por esta bacteria.

Quedémonos con la idea de vacunar contra tétanos ante cualquier herida

Si se vacunó hace menos de 10 años, no es necesario vacunar. Si han pasado mas de 10 años se da una dosis de refuerzo.

Si tiene esquema incompleto se debe completar y fin.

Si nunca se ha vacunado se deben dar mínimo 3 dosis, separadas por 1 mes.

Si además de no haberse vacunado nunca, la herida está sucia, se debe dar IgG antitetánica junto a las 3 vacunas.

La enfermedad se trata con ATB para anaerobios (penicilina o metro) e IgG

7. Fiebre sin foco y FOD

Se pregunta poco

Fiebre→ No hay consenso respecto al numero. En pediatría es sobre 38, en los seres humanos normales sobre 37 o 37,5.

Fiebre con Foco→ Hay un foco evidente a la anamnesis y/o examen físico que nos explica esa fiebre

FSF→ La clínica y examen físico en general no me señala un foco claro

FOD→ Fiebre sin foco mayor o igual a 38 grados que haya durado mas de 2 semanas (**1 semana según nuestra Dra izquierdo?**) y que tenga un estudio negativo

Causas

- Infecciosas→ Son las mas frecuentes, principalmente las virales. De las bacterias la bartonella y brucella. Parásitos como la malaria
- Autoinmune→ Lupus, arteritis de la temporal, AR juvenil, enfermedad de still
- Cáncer→ Las H`s. Canceres **H**ematológicos, **H**ipernefroma, **H**epatocarcinoma y **H**otros
- Fármacos→ Misoprostol el mas típico.

Estudio

0→ Anamnesis y examen físico completo junto a exámenes generales

1→ Autoinmune e infecciosa. ANA, FR, ANCA E IgM de todos los bichos

2→ Imágenes. Ecocardiograma para descartar EBSA y TAC TAP buscando abscesos o adenopatías

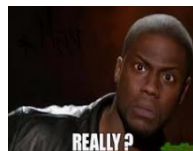
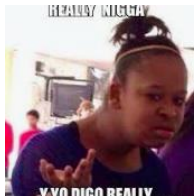
3→ Biopsia de médula ósea→ Para buscar dirigidamente al cáncer hematológico

4→ Ponerse creativo, pensar en infecciones raras y enfermedades aun más raras.

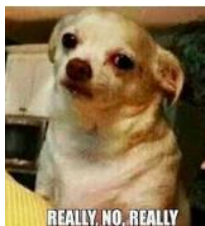
Tulariasis es el único nombre que retuve (también conocida como fiebre del conejo, es transmitido por moscas)



Es probable que se le pase la fiebre y nunca descubrimos la etiología. En este caso probablemente es un virus cualquiera que nunca descubrimos.



8. Adenitis infecciosa, adenitis submandibular y flegmón del piso de la boca



Puros temas de mierda, que aparentemente algo se preguntan



Adenopatía→ Ganglio aumentado de volumen, tiene muchas causas. Generalmente son de causa infecciosa o autoinmune

Adenitis infecciosa→ Un puro ganglio infectado, se ve como adenopatía con signos inflamatorios, dolorosa y que se puede complicar con absceso o fistula. Puede ubicarse en cualquier parte del cuerpo, pero suelen ser submandibulares o cuello (se ha preguntado)

Agentes→ Bacterias Gram (+), S. aureus y S. Pyogenes

Se trata con ATB, Amoxi/clavulánico, clindamicina o cefalosporinas de 1ª generación

Si no responde a ATB, se debe pinchar, porque puede ser un absceso.

Si asociada a la adenopatía tiene enfermedad dental o periodontal, se deben cubrir bacterias anaerobias. Se deja Amoxi/clav o clindamicina

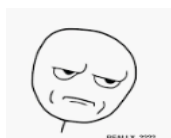
Si es subaguda debemos pensar en TBC o enfermedad de arañazo de gato (se trata con azitromicina)

En caso de ser bilateral, suele ser por virus respiratorios y se trata sintomáticamente.

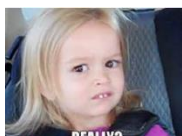
Flegmón → Edema + inflamación de causa infecciosa. No se forma un absceso, solo este edema infeccioso. El diagnóstico es con clínica + TAC para descartar el absceso.

Puede localizarse en cualquier lugar, pero suele ser submandibular, piso de la boca o en el cuello.

Se trata con ATB Ev de amplio espectro. No se puede drenar porque no hay absceso.



9. Ántrax o carbunclo



Otro tema apasionante

Causado por bacillus anthracis.

Viene con el antecedente de exposición a animales (ovejas o vacas).

La medida preventiva más importante es la vacunación de estos animales.

Tiene 3 formas clínicas

1. Respiratorio → La más grave, es como una neumonía. En la Rx se ve un mediastino ancho por adenopatías mediastínicas y derrame
2. Cutánea → Vesículas o pústulas que progresan a una úlcera indolora. Esta forma es la más preguntable
3. Gastrointestinal → Dolor abdominal, diarrea, no se pregunta nicagando

El diagnóstico se hace con el gram, es de los pocos bacilos gram (+) o con PCR

Tratamiento → Penicilina Ev, Cipro + clinda en caso de ser respiratorio.

Puede ser grave, lo más importante es la prevención con vacunación del ganado.

10. Amigdalitis, difteria y anginas infecciosas

Amigdalitis

Pueden ser virales (90%) o bacteriana (10%)

Bacteriana → Producida por Strepto Pyogenes (streptococo betahemolítico grupo A)

Clínica (bacteriana)

- Odinofagia intensa de inicio agudo
- Adenopatías cervicales
- Fiebre alta
- Exudado grisáceo en surcos amigdalinos
- Eritema faríngeo, petequias en paladar blando
- **Sin síntomas catarrales (tos, disfonía, conjuntivitis ni rinorrea)**

Exudado en surcos amigdalinos



Diagnóstico → Cultivo faríngeo es el Gold estándar. Las pruebas rápidas de detección Strepto son útiles. Lo que manda es la clínica.

Si tiene la clínica, se dejan los antibióticos.

En caso de que quede con la duda de si es bacteriano o viral (con síntomas catarrales y menos intenso) ahí debemos pedir el cultivo o test pack

En caso de que tenga clínica viral se trata de forma sintomática

Tratamiento→ Penicilina Benzatina 1.2 millonesUI IM x una vez o se puede dar amoxicilina VO por 10 días. A los alérgicos se les da azitromicina o clindamicina por 5 días. Cefadroxilo es otra buena opción.

Complicaciones

- Glomerulonefritis aguda post estreptocócica (GNAPE)
- Fiebre reumática→ EL tratamiento ATB la ha hecho desaparecer
- Abscesos→ Se debe tomar un TAC, dar ATB de amplio espectro y drenaje quirúrgico.
 - o Absceso periamigdalino→ Trismus + pilar abombado. Es el más frecuente
 - o Absceso parafaríngeo→ Duele a la movilización lateral del cuello
 - o Absceso retrofaríngeo→ Dolor a la movilización anteroposterior del cuello. Este es el más grave.

Hay que saber diferenciarlos porque se preguntan

Si avanzan pueden llegar a producir una Mediastinitis aguda y ahí se nos va a la B el cable.

Amigdalitis virales

- Odinofagia
- Síntomas catarrales
 - o Tos
 - o Rinorrea
 - o Disfonía
 - o Conjuntivitis (pensar en adenovirus)
 - o Si hay exudado es blanco, grande y adherente (VEB)
- NO ES
 - o Súbito
 - o Petequias en paladar

Clásica amigdalitis por VEB



El tratamiento es sintomático

El hemograma mostrará una leucocitosis de predominio linfocitario

Si tiene un exantema escarlatiniforme se piensa que es bacteriano

Si tiene un exantema morbiliforme se piensa en Mononucleosis

Difteria

Enfermedad erradicada gracias a la vacunación. Muy grave

Clínica

- Amigdalitis + faringitis
- Pseudomembranas en faringe y amígdalas
- Odinofagia
- Edema cervical (cuello de toro)



Complicaciones

- Miocarditis
- NTA

Diagnostico es clínico con las Pseudomembranas y el gram

Tratamiento→ Penicilina o Macrólidos

Anginas infecciosas

La única que hay que saber es la angina de Vincent.

Infección faríngea por anaerobios

Clínica

- Amigdalitis
- Gingivitis severa
- Halitosis
- Úlceras y necrosis de paladar blando y/o amígdalas

El diagnostico es clínico. Se pide gram y cultivo para descartar difteria. El tratamiento es con enjuagues de agua oxigenada + ATB para anaerobios (metronidazol o clindamicina)

11. Chagas, malaria, dengue, Zika, fiebre amarilla, Chikungunya y Hanta

Dengue y malaria están en el temario del EUNACOM, las otras no

CHAGAS

Transmitido por la vinchuca, el agente es el tripanosoma cruzi.

La vinchuca la encontramos en la zona centro-norte

Diagnóstico→ Serología

Screening de Chagas→ Embarazadas y donantes de sangre

Tratamiento→ benznidazol y nifurtimox

MALARIA

Transmitido por el mosquito anopheles, enfermedad producida por el plasmodium.

No hay en Chile. Hay en Brasil, y principalmente en Asia y África

Clínica

- Antecedente de viaje a zona endémica de la enfermedad
- Fiebre
- Mialgias
- Cefalea
- Hepatitis y encefalitis
- Anemia→ Característico de esta enfermedad

Diagnóstico→ Frotis de gota gruesa o serología.

Tratamiento es con antimaláricos (cloroquina, Hidroxicloroquina y mefloquina)

ZIKA

Transmitido por mosquito Aedes

Clínica

- Antecedente de viaje a zona endémica de la enfermedad
- Fiebre
- Artralgias
- Enantema pruriginosos (de los pocos exantemas pruriginosos)

Es una enfermedad leve, pero tiene el riesgo de producir TORCH

DENGUE

Transmitido por mosquito Aedes. En Chile solo hay en isla de Pascua, solo se ha reportado dengue en esta isla

Clínica

- Antecedente de viaje a zona endémica de la enfermedad
- Fiebre alta
- Mialgias intensa (se conoce como fiebre quiebra hueso)
- Petequias (sobre todo después de inflar el manguito de presión, aparecen bajo este. Se ha preguntado)
- Exantema en Mar rojo con isla blancas (al revés que los exantemas habituales)
- Hemorragias en casos graves
 - o Intracerebrales
 - o Digestivas
- **SIN ANEMIA (para diferenciarlo de malaria)**

CHIKUNGUNYA

Transmitido por mosquito Aedes.

Clínica

- Antecedente de viaje a zona endémica de la enfermedad
- Artritis aguda

FIEBRE AMARILLA

Transmitido por mosquito Aedes.

Clínica

- Antecedente de viaje a zona endémica de la enfermedad
- Fiebre
- Mialgias
- Ictericia (por esto se llama fiebre amarilla)

- “vómito negro” → Cuadro clínico característico, mas grave en el cual hay hematemesis

HANTA

El reservorio es el ratón de cola larga (no es vector), enfermedad producida por el virus hanta. Se encuentra en casi todo Chile, principalmente en la zona sur y precordillerana de zona centro y norte.

Se contagia por la inhalación de heces y orina de los ratones de cola larga.

Es difícil de encontrar en una ciudad grande

Clínica

- Antecedente de viaje a zona endémica de la enfermedad
- Distress respiratorio con EPA. Esto es lo mas característico
- Diarrea
- **Trombopenia, clásico de HANTA (resto del hemograma clásico de infección viral)**

Diagnóstico → IgM virus Hanta

Tratamiento → Ventilación mecánica, tiene alta letalidad

FIEBRE DE ORIGEN TROPICAL

Es malaria hasta que se demuestre lo contrario

Prevención

Mosquitos → Repelentes, mosquiteros, no tener agua estancada

Ratones → Prevención de roedores (pasto corto, casa limpia, alimento bien guardado, ventilar casa)

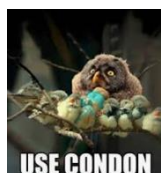
Vinchuca → Mantener casa limpia

Malaria → mefloquina semanal de forma profiláctica

Fiebre amarilla → Existe vacuna. Es un virus atenuado, por lo cual, está contraindicado en embarazadas e inmunosuprimidos

12. Enfermedades de Transmisión sexual

Lo fundamental es la prevención, la educación sexual y evitar promiscuidad son la clave. Solo existe vacuna contra VPH y hepatitis B



El condón es el único anticonceptivo que protege contra ETS

Tener una enfermedad de transmisión sexual es el máximo riesgo para tener más ETS, por lo tanto, ante una ETS debemos ir a descartar las otras

Uretritis

El diagnóstico es clínico. Se caracteriza por disuria, secreción uretral y puede venir con adenopatías inguinales.

Cuando hay uretritis se debe diferenciar la etiología.

Esto va a variar si es en un hombre o mujer

Hombre → Por lo general se utiliza el gram

Mujeres → Hay que hacer una PCR o cultivo de Thayer Martin

Si es gonococo (coco gram -) se debe tratar con ceftriaxona 250mg IM x 1 vez.

Como se dijo anteriormente, si se tiene una ETS el riesgo de tener otra es alto, por lo cual, además de gonococo debo ir a cubrir chlamydia, lo cual, se hace con azitromicina **2g x 1 vez**.

Si no es gonocócica puede ser por mycoplasma, ureaplasma y chlamydia. En este caso se deja cobertura con doxiciclina 100mg/12 horas por 10 días. La alternativa es azitromicina **1g x 1 vez**.

Cuando es gonocócica se deja cobertura para gonococo y chlamydia y si es no gonocócica se deja cobertura solo para no gonocócica.

En las mujeres suele ser asintomático. Se puede complicar con PIP, embarazo ectópico y cervicitis.

Herpes Genital

Producido generalmente por VHS 2, aunque puede ser producido por el 1 también (este suele ser oral)

Diagnostico es clínico, pero se puede apoyar en la PCR

Se observan vesículas múltiples que se rompen y forman úlceras, fiebre, adenopatías y Disuria

Tratamiento → Aciclovir o valaciclovir

Aciclovir 400mg cada 6 horas por 7 días

Valaciclovir 500mg cada 8 horas por 7 días

El herpes **activo** durante el parto, contraindica el parto vaginal.

Condiloma acuminado

Producido por VPH serotipos 6 y 11

Genera lesiones polipoideas solewantadas indoloras

En los hombres generalmente en el surco balanoprepucial o perianal en caso de sexo anal

En las mujeres generalmente en labios mayores, menores o perianal en caso de sexo anal

El diagnóstico es clínico, pero si encontramos VPH debemos DESCARTAR OTRAS ETS, como en toda ETS

Tratamiento → Crioterapia, resección, acido tricloroacético, imiquimod, etc.

Condiloma sí tiene opción de parto vaginal a menos que sea gigante. En caso de Ca cervical sí lo contraindica.

Chancroide

Causado por Haemophilus ducrei

Es una úlcera igual que el chancro, pero duele

Usualmente viene con una adenopatía dolorosa que puede absedarse y fistularse

Diagnostico → Clínico

Tratamiento → Ceftriaxona o azitromicina

Sífilis

Es lo que más se pregunta tanto en clínica como exámenes

Producido por *treponema palidum*

Tiene clínicas muy variables

Sífilis primaria

- Chancro
 - Úlcera única indolora
 - Aspecto limpio (no como cancroide)
 - Indolora

Sífilis secundaria

- Fiebre
- Exantema
 - Placas eritematosas generalizadas que **afecta palmas y plantas** (basta 1 sola lesión en palma o planta)

Sífilis terciaria

- Gomas sífilíticas → Aumentos de volumen
- Tabes dorsal → Alteración neurológica donde se pierde la sensibilidad de extremidades inferiores
- Aneurisma aórtico
- Neurosífilis

Sífilis latente

- Totalmente asintomática, se diagnostica solo por exámenes

Diagnóstico se hace mediante pruebas no treponémicas y se confirma con pruebas treponémicas

No treponémicas → RPR y VDRL. Negativizan con tratamiento

Treponémicas → Fta ABS y MHA-TP. Permanecen positivas tras tratamiento

La excepción es la sífilis 1ª (chancro), porque el diagnóstico es clínico.

Puede apoyarse en microscopia de campo oscuro que observa el *treponema*.

VDRL	FTA-ABS	Dg
+	-	Falso +
-	+	Tuvo y mejoró
+	+	Sífilis

Tratamiento

Penicilina benzatina 2,4 millones UI IM 1 a 2 dosis para la 1ª y 2ª, pero para sífilis 3ª se requiere de 3 dosis. Cada una separada por 1 semana

Neurosífilis se trata con penicilina G Ev

Ante alérgicos se trata con macrólidos, doxiciclina o ceftriaxona

Cuando se trata?

- VDRL y FTA ABS positivo
- Sífilis primaria

- VDRL (+) más:
 - o Embarazo (Pido FTA ABS, pero no espero el FTA ABS, trato de una a pesar de que pueda ser falso +)
 - o Clínica de sífilis 2ª (igual pido el FTA ABS, pero no espero su resultado)
 - o Si ya tuvo sífilis antes, porque el FTA ABS va a estar + de seguro

Ladillas

Phthirus pubis. Lo importante de encontrarlo es ir a descartar otras ETS. Se trata con permetrina al 1% en esquema 1-6-1

13. Exantemas

Lo importante de ellos es saber la clínica, porque su diagnóstico es clínico. Suelen ser 2 preguntas de este tema

Para su diagnóstico es vital conocer

- Edad
- Ubicación
- Síntomas acompañantes

SARAMPIÓN

Causado por virus del sarampión

Enfermedad de notificación inmediata

Edad→En Chile está erradicado. Sería por tanto un extranjero o un niño menor de 1 año con contacto con extranjero

Ubicación→Inicia en la cabeza y luego se desplaza hacia caudal

Síntomas→ Exantema rojo intenso (morbiliforme), fiebre alta precedido por conjuntivitis o tos. Viene con un enantema, las llamadas manchas de Koplick en la mucosa oral, son patognomónicas. Suelen aparecer un par de días antes del exantema.

Diagnóstico→ Clínico, pero requiere confirmación con IgM

Tratamiento→ Sintomático

Riesgo→ Neumonía y encefalitis

RUBEOLA

Causado por Virus Rubeola

Enfermedad de notificación obligatoria.

Edad→ Extranjeros o menores de 1 año contactos de extranjeros

Ubicación→Exantema rosado

Síntomas→ Fiebre baja, adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores además de artralgias y/o artritis

Diagnostico→ Clínico pero requiere confirmación con IgM

Riesgo→ TORCH

ERITEMA INFECCIOSO o QUINTA ENFERMEDAD

Producido por Parvovirus B19

Es el que más se pregunta

Edad→ Escolares y preescolares

Ubicación→ Eritema malar (signo de la cachetada) y luego aparece exantema en encaje (reticular) que afecta tronco y extremidades

Clínica→ Fiebre baja, artralgias

Diagnostico→ Clínico, no requiere confirmación

Tratamiento→ Sintomático

Riesgo→ Aborto

EXANTEMA SÚBITO, ROSEOLA O SEXTA ENFERMEDAD

Se pregunta con frecuencia

Producido por virus herpes 6 y 7

Edad→ Lactantes entre 6 meses y 1.5 años

Clínica→ Fiebre alta (causa de convulsiones febriles) que cede y tras esto aparece el exantema maculopapular eritematoso inespecífico

Diagnostico→ Clínico

Tratamiento→ Sintomático

SÍNDROME PIE MANO BOCA

Producido por Coxsackie A-16

Edad→ Escolares y preescolares

Ubicación→ Exantema papulo-**vesicular** que afecta manos, pies y enantema en paladar. Afecta manos, palmas y dorso. También puede estar en resto del cuerpo

Síntomas→ Fiebre baja

Diagnostico→ Clínico

Tratamiento→ Sintomático

Si es adulto→ Pienso en sífilis

Si es lactante → Pienso en sarna

ESCARLATINA

Se ha preguntado un par de veces

Producida por estreptococo grupo A

Edad → Escolares principalmente. Puede afectar a preescolares también, pero >3 años.

Clínica → Amigdalitis pultácea con exantema en piel de gallina

(papular) que respeta el triángulo de fialton (entre los surcos

nasogenianos) y viene con enantema, lengua aframbuesada

Líneas de pastia → Petequias de distribución línea en fosas cubitales



Líneas de Pastia

Diagnóstico → Clínico

Tratamiento → Penicilina benzatina o amoxicilina

Meningococemia

Se ha preguntado un par de veces

Causado por meningococo

Edad → A todos

Clínica → Púrpura petequeal que luego se vuelve equimótico + Fiebre. Antes puede venir con exantema rosado.

Además puede venir con meningitis y hacer síndrome de Waterhouse-Friedrichsen (insuficiencia suprarrenal grave). Además puede hacer CID y shock séptico

Es el exantema más grave, se debe sospechar desde un inicio

Diagnóstico es clínico, pero se objetiva con hemocultivos y PL, las cuales, no deben retrasar el inicio de ATB.



Tratamiento → Penicilina G en dosis altas o ceftriaxona

Púrpuras febriles → Siempre urgencia, porque es meningococemia o CID o Leucemia aguda

Exantemas con fiebre alta:

- Sarampión
- Exantema súbito
- Meningococemia

CASO

Niño 5 años, fiebre, 38.5°C hace 2 días, más eritema en mejillas, desaparece la fiebre y aparece exantema en tronco y extremidades.

Caso real del EUNACOM, es un eritema infeccioso a pesar de que podríamos pensar en exantema súbito. Tiene fiebre baja y la edad en la cual se produce la 5ª enfermedad (exantema súbito es de lactantes)

14. Brucelosis, leptospirosis, bartonelosis, fiebre tifoidea y fiebre paratifoidea

Todos estas son distintas causas de fiebre

Brucelosis

Es una zoonosis (contacto con cabras, ovejas, o consumo de estos quesos)

Clínica inespecífica (Fiebre, adenopatías, hepatoesplenomegalia)

Diagnostico→ Serología como parte del estudio del FOD o hemocultivo (muy baja sensibilidad)

Nadie las anda buscando, suelen aparecer como hallazgo

Tratamiento→ Doxiciclina o Rifampicina

Leptospirosis

Antecedente de baño en aguas estancadas o antecedente de contacto con animales o consumo de queso de cabra.

Clínica infrecuente, pero clásica

- Hepatitis
- Meningitis aséptica
- Insuficiencia renal aguda
- Conjuntivitis hemorrágica

Diagnostico→ Serología

Tratamiento→ Penicilina , doxiciclina o ceftriaxona, bicho fácil de matar

Bartonelosis

Conocida como la enfermedad de arañazo de gato. Producida por Bartonella henselae

Clínica inespecífica, pero destacan las adenopatías persistentes y abscesos en bazo. Causa frecuente de FOD en pediatría

Fiebre Tifoidea

Causada por Salmonella typhi, contagio vía fecal-oral

Enfermedad de notificación obligatoria

Clínica

- Fiebre alta
- Cefalea intensa
- Bradicardia relativa
- Rash en abdomen
- Hepatoesplenomegalia
- Diarrea que puede evoluciona con hemorragia, perforación intestinal o sepsis grave

Exámenes

Hemograma tífico→ Leucopenia + desviación izquierda +Eosinofia

Diagnostico→ Hemocultivo, con alta sensibilidad (>90%)

Tratamiento → Ciprofloxacino

Fiebre paratifoidea

Provocado por *S. paratyphi* A, B y C

Es iguala a la fiebre tifoidea, pero mas leve

Salmonellas no typhi

Se contagia mediante consumo de alimentos derivados de animales contaminados

Se trata con hidratación, el ciprofloxacino podría darse.

Diagnostico → Las diarreas agudas por lo general no se estudian, pero en caso de estudiarse es con un coprocultivo

15. Intoxicación alimentaria, diarrea , Cólera

Intoxicación alimentaria

Ingesta de alimentos contaminados, suele ser intradomiciliario, pero cuando son masivas (Restaurant, casino) son un problema de salud pública y por lo tanto, de notificación inmediata

Diagnóstico → Clínico

Tratamiento → Hidratación – manejo sintomático. ATB solo en caso de salmonella

AGENTE	TIEMPO	COMIDA	CLÍNICA
S. aureus	Pocas horas	Cualquiera (Refrigerado) Ej. jugo, torta, mayonesa	Vómitos intensos, luego dolor abd. y/o diarrea

AGENTE	TIEMPO	COMIDA	CLÍNICA
Salmonella no Typhi	1-2 días	Origen Animal carnes, huevos, leche (Ej. Asado)	Diarrea Febril

Tipos de intoxicaciones (se pregunta)

AGENTE	TIEMPO	COMIDA	CLÍNICA
Vibrio parahemolítico	1-2 días	Mariscos	Diarrea acuosa, abundante, vómitos, dolor cólico

Agente	Tiempo	Comida	Clínica
Anisakis	Minutos a horas	Pescado crudo	Vómitos Intensos
Marea roja (Dinoflagelados)	Minutos	Mariscos	Parálisis (Otras)
Tetrodotoxina	Minutos	Pez Globo	Parálisis

CASO: Todos los niños de un cumpleaños se ponen a vomitar.

→Aureus

CASO: Hicimos un asado y al otro día todos teníamos diarrea.

→Salmonella

CASO: Nos juntamos a comer sushi y todos empezamos a vomitar.

→Anisakis

CASO: Comimos ostras y al otro día, todos con vómitos y diarrea

→Vibrio parahemolítico

CASO: Completada bailable: todos con dolor de guata y vómitos (hoy vs mañana)

→Aureus (si los vómitos son hoy) o salmonella (si lo vómitos son mañana)

Diarrea y sus MO

Las diarreas acuosas suelen ser por virus o por E. coli ECET o ECEA (enterotoxigenica o enteroadhesiva). Se tratan con hidratación y tratamiento sintomático

Diarreas febriles→ Rotavirus. E. coli enteropatógena, Salmonella, Yersinia o Campylobacter, pero en la práctica no se estudian a menos que sean prolongadas (>14 días)

Disentería→ E. coli enterohemorrágica (asociado a SHU) , enteroinvasiva y Shigella

Diarrea del viajero→ Suele ser por E. coli. Se dejan ATB (ciprofloxacino)

Diarrea post ATB→ Clásicamente por C. difficile.

Cólera

Causado por Vibrio cholerae

En los 90 se erradicó (junto con fiebre tifoidea y disminuyó VHA)

Clínica→ Diarrea acuosa muy intensa, es pura agua, por lo cual, se asocia a deshidratación
Enfermedad de notificación inmediata en centros centinela

Diagnóstico→ Observación directa en microscopio de las deposiciones o cultivo

Tratamiento→ HIDRATAR + ATB (azitromicina, ciprofloxacino o doxiciclina)

16. Varicela y Herpes Zóster

Varicela

Causado por Varicela zoster

- Pródromo de Fiebre, malestar general y cefalea
- Exantema polimorfo **pruriginoso** (pápulas que se convierten en vesículas, luego pústulas, úlcera y finalmente costra)

La varicela contagia, hasta que todas las heridas son costras.

SIEMPRE afecta la cabeza. Tiene una distribución céfalo-caudal ,

Diagnóstico→ Clínico

Tratamiento→ Sintomático (no dar AINEs ni AAS, por riesgo de sd de reye (encefalitis + hepatitis muy grave, causa de muerte)

La administración de antivirales tiene ciertas indicaciones

- > 13 años
- 2º caso familiar (por riesgo de varicela mas grave)
- Varicela grave

Dosis (doble de la dosis que VHS)

Aciclovir→ 800mg/4 horas (10mg/kg/día) x 7 días

Valaciclovir→ 1g /8 horas x 7 días (10mg/kg/día)

Complicaciones

- Sobreinfección bacteriana→ clásica de los niños. Suele infectarse con gram+, se trata con cefalosporinas de 1ª generación o cloxacilina
- Neumonía→ Aciclovir Ev
- Encefalitis→ Aciclovir Ev
- Hepatitis→ Aciclovir Ev

HERPES ZÓSTER

Recurrencia del VVZ

Clásico del adulto mayor, inmunodeprimido y gatillado por stress

En quien hace 2 herpes zóster se debe sospechar inmunosupresión

Síntomas→ Eritema y luego vesículas en un dermatomo, asociado a dolor neuropático

Diagnostico→ Clínico

Tratamiento→ Aciclovir o valaciclovir (800mg 5 veces al día o 1g cada 8 horas por 7 días)

Este tratamiento es para disminuir el riesgo de neuritis post herpética, dolor que puede persistir incluso por años

Embarazo→ Tiene riesgos

- **Neumonía o neumonitis**→ Tienen mayor riesgo, por lo tanto, toda embarazada con varicela deben recibir aciclovir si o si, pero de forma Ev

- **TORCH**→ Cuando hay **primoinfección** antes de las 24 semanas. Si nunca ha tenido varicela, se le pide IgG para certificar que nunca la ha tenido y en caso de ser negativa la IgG, se da IgG anti VVZ. En caso de haber tenido varicela antes (IgG+) o antecedente) no se hace nada.
- **Varicela neonatal**→ Es una varicela grave en el RN. Se da aciclovir Ev + IgG. Es un cuadro grave. Vamos a dar aciclovir si la mamá presenta varicela 5 días preparto hasta 2 días postparto, aunque el niño no tenga síntomas

17. VIH

Son 2 preguntas de VIH

Vías de contagio

- Sexual→ La mas frecuente
- Parenteral→ Poco frecuente
- Vertical→ Se deben tomar medidas para evitarla

Diagnostico: ELISA→ ELISA (se repite) → Western Blot (más específico)

Excepciones

- Periodo de ventana (ambos miden anticuerpos). Este periodo es de 6 semanas hasta 3 meses
- Hijo de madre VIH, porque la madre le traspasa los antígenos, es un falso (+)

En estos casos se debe pedir PCR o antígeno p24

Etapas

Se clasifica en base a los CD-4. Nos ayuda para determinar inicio de profilaxis para ciertas enfermedades.

- Etapa I→ Tiene mas de 500 cd-4
- Etapa II→ Entre 200 y 500 CD-4
- Etapa III→ Menos de 200 CD-4. Acá empezamos a dejar profilaxis para infecciones oportunistas

Se clasifica también en base a base presencia de enfermedades oportunistas

- A→ asintomático
- B
 - o Candidiasis mucocutáneas (algorra, balanitis, vulvovaginitis)
 - o Bacterianas→ Infecciones no recurrentes ni invasivas (otitis, sinusitis) por Neumococo o Haemophilus.
 - o Displasias→ Lesiones precancerosas (displasia de cuello uterino)
- C→ Enfermedades definitorias de SIDA
 - o Pneumocystis (la mas frecuente)
 - o Toxoplasma
 - o Criptococo
 - o Candidiasis invasivas (traqueal, esofágica)

- Cáncer
- Neumonías recurrentes
- MAC
- CMV
- TBC
- LMFP (leucomalasia multifocal progresiva)
- Otras

Tratamiento

- TARV
- Profilaxis
- Tratamiento de enfermedades oportunistas

TARV→ Según la OMS debería darse TARV a todos los VIH (+). La OMS desea lograr el 90-90-90 (90% diagnosticado, tratado y en remisión). El MINSAL (desactualizado) propone iniciar TARV en etapa B o menos de 350 CD-4, pero recomiendan seguir la guía de la OMS. Por lo tanto, en EUNACOM hay que dar TARV a todos.

Profilaxis→ Hay 2 tipos

Profilaxis 1ª (solo según nivel de CD-4) y 2ª (según nivel de CD-4 y tras haber sufrido una infección por el MO contra el cual se desea hacer profilaxis).

Se deja profilaxis hasta que los CD-4 aumenten

- Pneumocystis→ Profilaxis 1ª, se deja al tener CD-4 bajo 200. Profilaxis con cotrimoxazol
- Criptococo→ Al tener CD-4 bajo 100, profilaxis 2ª, se deja Fluconazol (1 vez a la semana)
- Toxoplasma→ Al tener CD-4 bajo 100, profilaxis 1ª, se deja cotrimoxazol
- CMV→ CD-4 bajo 50, profilaxis 2ª, se deja ganciclovir
- MAC→ CD-4 bajo 50, profilaxis 1ª, se deja azitromicina
- TBC→ NO depende de los Cd-4, depende del PPD mayor a 5mm (>10mm en no VIH), se usa Isoniacida

AGENTE	CD4	1ria- 2ria	Fármaco
Pneumocystis	<200	1ria	Cotrimoxazol
Toxoplasma	<100	1ria	Cotrimoxazol
Criptococo	<100	2ria	Fluconazol
CMV	<50	2ria	Ganciclovir
MAC	<50	1ria	Azitromicina
TBC	PPD≥5	1ria	Isoniazida 9m

VIH y embarazo

Se hace screening a todas las embarazadas al inicio del embarazo para poder prevenir la infección vertical.

- TARV desde las semana 20 (desde la semana 16 si tiene mas de 100.000 copias)
- Si tenia TARV desde antes, se debe mantener (contraindicado efavirenz)

- Interrupción del embarazo por cesárea a menos que haya carga viral indetectable (CV<1000)
- Zidovudina durante el parto/cesárea
- LME contraindicada
- PCR durante las primeras semanas
- Triterapia al RN por 6 semanas

INFECCIONES OPORTUNISTAS

Todas (Salvo candidiasis oral) son definitorias de SIDA

Candidiasis

Oral → Algorra, etapa B

Genital → Balanitis en hombres y leucorrea grumosa + prurito en mujer

Candidiasis esofágica → Viene con disfagia y odinofagia. El diagnóstico es con EDA (placas blancas en esófago). El diagnóstico es clínico, yo inicio tratamiento, pero si no responde a los 3 días debo hacer a EDA

Oral o genital → Fluconazol 150mg x 1 vez

Esofágica → Fluconazol 150mg por 21 días

Pneumocystis Jiroveci

Es un hongo

Clínica → Neumonía larvada.

Tiene compromiso bilateral y suele ser similar a NAC atípica (crépitos en bases, sibilancias y afectación bilateral)

Se caracteriza por LDH muy alta

Rx Tx → Infiltrado alveolointersticial bilateral difuso mayor en bases

Diagnóstico → PCR

Tratamiento → Cotrimoxazol + corticoides si está desaturando. Dapsone + pirimetamina es la opción ante alergia a las sulfas

Toxoplasma Gondii

Clínica de absceso cerebral, viene con signos focales y convulsiones (1ª causa de convulsiones en paciente VIH)

Diagnóstico → TAC (lesión con contraste en anillo)

Tratamiento → Sulfadiazina + pirimetamina

Criptococo

Hongo

Clínica → Meningoencefalitis. Toxoplasma viene sin signos meníngeos, este viene con signos meníngeos por ser meningitis

Diagnóstico→ PL con tinción de tinta china. Es de predominio mononuclear y glucosa baja
Tratamiento→ Anfotericina liposomal

Citomegalovirus

En su clínica clásica genera una corioretinitis que se manifiesta como disminución de la agudeza visual
Sin embargo puede producir casi cualquier –itis (colitis, esofagitis, adrenalitis, encefalitis, neumonitis)

Diagnostico→ Fondo de ojo
Tratamiento→ Ganciclovir, Valganciclovir o foscarnet

Mycobacterium avium Complex (MAC)

Clínica→ Sepsis subaguda sin foco claro. Fiebre, baja de peso, astenia. Puede durar meses
Diagnostico→ PCR
Tratamiento→ Claritromicina + Etambutol + rifabutina

Cryptosporidium, Isospora y microsporiidum

Se han preguntado como agentes de diarrea
Producen una diarrea acuosa crónica.

Diagnostico→ EPSD con tinciones especiales
Tratamiento

- Cryptosporidium→ TARV
- Isospora→ Cotrimoxazol
- Microsporiidum→ Albendazol

Sarcoma de Kaposi

Producido por virus herpes 8

Clínica→ Nódulos eritematovioláceos palpables
Diagnostico→ Biopsia
Tratamiento→ TARV + CX/QT/RT según corresponda

Leucomalasia multifocal progresiva

Causada por el virus JC

Clínica→ Signos focales, demencia y compromiso de conciencia
Esta es de las principales causas de demencia en VIH (VIH en si mismo también produce demencia)

Diagnostico→ TAC que muestra lesiones en múltiples focos en la sustancia blanca.
Tratamiento→ TAR

Otras complicaciones

Disfagia

- Candidiasis
- VHS
- CMV

Diarrea

- Cryptosporidium
- Isospora
- Microsporidium
- CMV
- MAC
- VIH

Compromiso de conciencia

- Toxoplasma
- LEMP
- Criptococo
- Demencia por VIH
- Linfoma del SNC
- Meningitis bacteriana aguda

Neumonía

- Neumococo (el más frecuente)
- Pneumocystis
- Criptococo
- TBC
- MAC
- Virus

En EUNACOM no dicen que es VIH +, pero cuentan antecedentes de infecciones o practicas sexuales de riesgo

18. Parasitosis

Triquinosis

Triquina spiralis

Enfermedad de notificación inmediata

Contagio → Carne de cerdo

Clínica → Mialgias (retrocuales principalmente) + Fiebre

Se caracteriza por una gran eosinofilia y elevación de la CK

Diagnostico → IgM, el gold standard es la biopsia de musculo

Tratamiento → Mebendazol o Albendazol + Corticoides + AINEs

En caso de que no tenga mialgias, solo se observa

Ascariasis

Ascaris lumbricoides

Contagio → Comer alimentos contaminados con deposiciones humanas

Clínica→ Asintomáticos generalmente. Suelen consultar por encontrar gusanos en deposiciones. Puede tener dolor abdominal, anemia u obstrucción cuando son muchos
En un inicio puede presentarse con el triada de Löffler (Tos, fiebre y eosinofilia), dado que, en el ciclo del gusano, pasa por lo pulmones

Diagnostico→ EPSD

Tratamiento→ Albendazol, Mebendazol

Es frecuente en Chile, somos buenos pa la caca en resumen

Oxuriasis

Enterobius vermiculares

Contagio→ Alimentos contaminados por deposiciones

Clínica→ Prurito anal (puede ser asintomático)

Diagnostico→ Test de Graham

Tratamiento→ Albendazol o Mebendazol

Se deben manejar a los contactos porque es muy contagiosa, lavar ropa, limpiar la casa

Teniasis

Tenia saginata (Carne de vaca), solium (carne de cerdo) y difilobotrium latum (peces)

Contagio→ Comer carne de cerdo, vaca o pescado mal cocida contaminada con cisticercos.

Clínica→ Asintomática o abdominal inespecífica. Déficit de B12 es sugerente

Diagnostico→ EPSD

Tratamiento→ Prazicuantel

Neurocisticercosis

Por tenia solium

Contagio→ Comer alimentos contaminados con deposiciones humanas

Clínica→ Suele ser asintomático, pero puede dar clínica de tumor cerebral (epilepsia focal, cefalea y signos focales)

Diagnostico→ Neuroimagen (TAC o RNM)

Tratamiento

Activos: Prazicuantel + albendazol + corticoides.

Síntomas: Convulsiones o cefalea se tratan los síntomas (AINEs o anticonvulsivantes)

Asintomático: Se observa

Hidatidosis

Equinococcus granulosus

La vía de contagio es por comer alimentos infectados con deposiciones de perros

Clínica→ Asintomática generalmente

Hepático→ Abscesos hepáticos (dolor abdominal + fiebre)

Pulmonar→ Vómica (tos + agua clara con las membranas del quiste hidatídico (en hollejo de uva))

Diagnóstico

Hepático→ Eco abdominal (imagen en rueda de carreta)

Pulmonar→ Rx de tórax que muestra imagen redondeada homogénea o con nivel hidroaéreo)

Tratamiento→ Quirúrgico, con albendazol las 6 semanas previas

La prevención es lo más importante, la cual, va a estar dada por la desparasitación de perros y evitar alimentarlos con vísceras rudas de animales

Distomatosis

Producido por Fasciola hepática

Contagio→ Comer plantas acuáticas contaminadas (berros)

Clínica→ Dolor abdominal + ictericia. Hemograma con eosinofilia

Diagnostico→ EPSD o con Eco abdominal

Tratamiento→ Triclabendazol

Prevención→ Comer berros hidropónicos

Amebiasis

Producido por Entamoeba histolytica (Entamoeba coli es normal en deposiciones)

Contagio→ Comer alimentos contaminados con deposiciones

Clínica→ Disentería aguda o crónica. Simula un EII

Diagnostico→ EPSD

Tratamiento→ Metronidazol por 7 días

Giardiasis

Producido por Giardia Lamblia

Contagio→ Comer alimentos contaminados con deposiciones

Clínica→ Diarrea crónica, síndrome de malabsorción y meteorismo. Se parece a enfermedad celiaca.

Diagnostico→ EPSD

Tratamiento→ Tinidazol o metronidazol

Parásitos que producen eosinofilia importante

- Triquinosis
- Distomatosis
- Ascariasis

19. TBC

1 o 2 preguntas (Respiratorio o infecto)

producida por *Mycobacterium tuberculosis*

Clínica → Tos + expectoración que puede ser hemoptoica. Además fiebre, baja de peso por 2 semanas por lo menos

Diagnostico → Rx de tórax, baciloscopias (de elección, 80% sensibilidad) y cultivo de Koch

Rx Tx → Retracción apical, paquipleuritis y complejo primario (lesión con zona de fibrosis mas adenopatía en mediastino)

A quien pedir BK? → Se requieren 50 neutrófilos por campo. Si hay menos se debe repetir

- Rx sugerente
- Clínica sugerente (tos más de 2 semanas)
- Contacto de paciente TBC

Tratamiento

1ª fase → 50 dosis (2 meses), RIPE

Diaria

- Rifampicina
- Isoniacida
- Pirazinamida
- Etambutol

2ª fase → 48 dosis (4 meses)

Trisemanal

- Rifampicina
- Isoniacida

Si hay RAM (hepatitis, vómitos, diarrea, etc.), se deben suspender los fármacos y derivar a especialista.

Resistencia → Tratamiento secundario con moxifloxacino, kanamicina, streptomycin. Manejo de especialista.

Control

BK mensual y cultivo en caso de estar positiva la BK

Casos especiales

Fracaso → Cultivo positivo tras 4 meses de tratamiento

Fracaso probable → BK que no Negativizan o que se positivizan 2 seguidas hasta el 4º mes. En este caso mantengo tratamiento hasta recibir el cultivo, pues podría ser eliminación de bacilos muertos.

El fracaso es por resistencia TAB, en este caso se debe derivar a especialista

Recaída→ Paciente que se da de alta, pero vuelve con síntomas y BK (+). Es un caso nuevo, por lo tanto, se debe notificar nuevamente y tratar como tal. Se deben estudiar a los contactos porque alguno lo contagió

Abandono→ Suspender tratamiento por 4 semana o más. Lo importante no es el tiempo de tratamiento, sino que el número de dosis

En caso de haber suspendido hace menos de 1 mes, se debe retomar hasta donde había llegado.

Si ha pasado más de un mes se debe iniciar todo el tratamiento desde cero.

Si lleva mas de 1 mes sin tratamiento, pero las BK están negativas se da de alta.

Manejo de contacto

A todo contacto de bacilífero se debe evaluar si tiene **clínica, pedir Rx y BK**.

Si es menor de 15 años se debe pedir PPD

Si la Bk es positiva se debe iniciar tratamiento anti TBC. Si es menor de 15 años y tiene BK negativa, pero Rx sugerente, se debe iniciar tratamiento igual

Profilaxis→ Para otros contactos. Es con Isoniacida por 6 meses (en VIH por 9 meses)

LA profilaxis se deja a:

PPD>10mm (PPD es para <15años, VIH y enfermedades crónicas)

PPD>5mm en paciente VIH

Menor de 15 años (3 meses en caso de PPD negativo)

RN hijo de madre bacilífera→ Se le deja profilaxis, pero no se contraindica la LME

20. Infección de piel y partes blandas

Entra en pediatría, TMT, dermatología e infecto, asique es pregunta segura, pero fácil

Son producidas por bacterias gram + (Staphylo aureus y Strepto grupo A)

S. aureus (SA)
S. Pyogenes (SP)

	Leve VO	Grave EV	Alérgico	Resistente
SP	Amoxi Ampi	Peni G Ampi	Macrólidos Clinda	No hay resistencia
SA	Cloxa Flucloxa Cefadroxilo	Cloxa Cefazolina	Clinda	Vanco

TODOS los ATB que cubren al *S. aureus* también van a cubrir al *Strepto pyogenes*

Se trata con ATB por 10 días generalmente, que varía dependiendo de si es leve o grave y del MO obviamente

Erisipela

Producida por *S. Pyogenes*, es grave, por lo cual, se trata EV

Placa eritematosa con BORDES NÍTIDOS, fiebre y compromiso linfático

Si me queda la duda entre si es erisipela o fascitis, debo confirmarlo con imágenes (Eco o RNM)

Celulitis

Producida por *S. aureus* o *S. pyogenes*

Se presenta como una placa eritematosa de bordes difusos, dolor y fiebre

Tratamiento → Es EV con Coxa o cefazolina

Fascitis necrotizante

Producida por *Strepto pyogenes*

Es una placa dolorosa, violáceo/negra con bulas hemorrágicas y mucho DOLOR

Tratamiento → Penicilina EV + Clindamicina + DEBRIDACIÓN QUIRÚRGICA

SCHOCK TÓXICO

Por *S. aureus* o *S. pyogenes*

Ambos productores de exotoxina que activa el sistema inmune

Clínica → Hipotensión, taquicardia, mala perfusión. Es un shock vasodilatador.

Tiene una letalidad alta

Tratamiento → Cloxacilina o Penicilina EV + clindamicina EV + SF + Drogas vasoactivas

Síndrome de piel escaldada

Producido por *S. aureus* productor de epidermotoxina

Inicia como eritema periocular, luego vesículas y pápulas sobre las zonas eritematosas, que rompen y se cae la epidermis.



Viene con signo de nikolski (Se desprende la epidermis al presionarla con el dedo)

Tratamiento: Cuadro grave, se trata con cloxacilina + clindamicina EV

Impétigo

Producido por ambas bacterias

Produce costras mielicerica generalmente alrededor de la boca o nariz.

Es una infección leve, se trata con flucloxacilina o cefadroxilo o mupirocina tópica por 10 días

Impétigo bulloso

Por S aureus productor de toxina exfoliativa, como en piel escaldada, pero en este caso la infección está solo en la zona del impétigo

Clínica→ Impétigo + bulas flácidas

Tratamiento→ El mismo del impétigo

Foliculitis

Producido por S. Aureus

Clínica→ Pústulas en relación al folículo pilosos, frecuentemente después de afeitarse o depilarse

Tratamiento→ Coxa, flucloxa o cefadroxilo o bien no se hace nada porque es un cuadro de mierda que pasa solo

Si se ha bañado en sauna o aguas estancadas se sospecha de infección por pseudomonas y se trata con ciprofloxacino

Furúnculo

Producido por S aureus

Iguala una Foliculitis, pero mas grande que podría absedarse

Tratamiento→ Nada o ATB orales o drenaje si es muy grande

Ántrax

Producido por S aureus

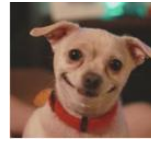
Masa inflamatorio donde varios furúnculos se unen en una sola masa

Tratamiento→ Cloxacilina o cefazolina Ev + drenaje quirúrgico

Resumen Guevara by Creggers

Nefrología

5 preguntas, son difíciles porque se confunden conceptos



1. Insuficiencia renal aguda

Se define como la caída en la filtración glomerular. El Gold standard es la medición de creatinina en orina recolectada de 24 horas.

Complicaciones

- Hiperkalemia
- Hiponatremia
- Acidosis
- Hipervolemia
- Osteodistrofia renal → Por aumento de la PTH
- Anemia
- Síndrome urémico

La diferencia entre AKI y ERC es el tiempo, siendo la AKI menor a 3 meses. La ERC dura mas de 3 meses y es irrecuperable, solo puedo evitar que siga progresando, la AKI es recuperable. La ecografía me puede hacer la diferencia al ver el tamaño de los riñones, pues ante riñones atróficos, probablemente se trata de ERC, aunque existen casos de ERC con riñones grandes (DM, amiloidosis, mieloma múltiple, VIH, VHB y riñones poliquísticos).

Insuficiencia Renal aguda

Se clasifican en 3 grupos

- Prerenal → Dada por hipovolemia por deshidratación, diarrea, diuréticos, hemorragias, ICC. Se maneja con reposición de volemia, salvo en ICC
- Renal → Causada por NTA, glomerulonefritis, PNA, SHU, nefritis intersticial. Su manejo es según la causa
- Postrenal → Por litiasis, malformaciones urinarias y uropatía obstructiva baja (próstata). Se estudia con ecografía y se trata según la causa.

Diferencias entre pre-renal y renal

Lo más importante para diferenciarlos es el FeNa (fracción excretada de sodio). En segundo lugar, es importante mirar el sodio urinario, el cual, va a estar bajo en la prerenal y alto (sobre 20) en la renal. FeNa y NaU son los más importantes y que hay que saber. (BUN/Crea es bueno saberlo igual, porque es fácil de calcular)

Tratamiento:

1. Tratar la causa
 - a. Suero fisiológico en caso de AKI pre-renal

	Prerenal	Renal
FeNa	< 1 %	> 1 %
Na U	< 10 mEq/L	> 20 mEq/L
Osm U	↑	↓
Úrea U	↑	↓
BUN/Crea	> 20	< 20

- b. Tratar la causa en caso de AKI renal
 - c. En caso de ser post-renal lo primero es poner sonda Foley y en 2ª instancia manejar la obstrucción (cirugía probablemente)
2. Tratar las complicaciones
- a. Hiperkalemia
 - i. Leve → Dieta baja en potasio
 - ii. Grave → Calcio (estabiliza membrana miocárdica), salbutamol y suero glucosado + insulina.
 - b. Acidosis → Bicarbonato Vo (leve) o Ev (graves)
 - c. Hipervolemia → Diuréticos y restricción de agua y sal
 - d. Hipocalcemia → Ca vía oral o Ev
 - e. Hiponatremia → Restricción de agua libre y suero hipertónico en caso de ser muy grave

Indicaciones de diálisis de urgencia:

Mnemotecnia AEIOU (auspiciada por creggers)

A → Acidosis grave que no responde a tratamiento

E → Electrolitos (hiperkalemia grave que no responde a tratamiento)

I → Intoxicación que no responde a tratamiento

O → Overload (sobrecarga de volumen grave que no responde a tratamiento)

U → Uremia. Encefalopatía o pericarditis urémica

Necrosis tubular aguda (NTA)

Insuficiencia renal aguda de tipo renal

Causas:

- IRA prerenal grave que lleva a vasoconstricción renal y necrosis.
- Fármacos como aminoglicosidos y antivirales

Exámenes a pedir

- Clearance de creatinina → Nos muestra que hay una IRA
- FeNa, NaU, BUN/Crea, etc.
- Sedimento urinario que presentará Cilindros granulosos y Cilindros céreos en caso de ser NTA

La NTA presenta 2 fases. La primera fase es la fase oligúrica y luego viene una fase poliúrica cuando se empiezan a reepitelizar los túbulos renales y no pueden reabsorber bien agua y ELP.

Tratamiento → Tratar la causa y reponer las pérdidas de agua y electrolitos

Cilindros

- Hialinos → Normales
- Céreos y granulosos → de NTA, contienen células epiteliales muertas
- Hemáticos → De Glomerulonefritis aguda
- Piocitarios → De PNA

2. Insuficiencia renal crónica y trasplante renal

Caída del clearance de creatinina por más de 3 meses (irreversible)

Existen 5 etapas:

I	≥	90
II	<	90
III	<	60
IV	<	30
V	<	15

En la etapa IV empiezan las complicaciones graves (HiperK, acidosis)

La etapa V es indicación diálisis y trasplante

Causas→ La más frecuente es la DM y en segundo lugar la HTA.

El diagnóstico se hace con la caída del clearance de creatinina y con una eco renal congruente (atrofia renal generalmente) y nos permite ver las causas obstructivas que podrían ser tratables.

Tratamiento

1. Tratar Factores de riesgo (HTA, DM, etc.), evitar nefrotóxicos y ajustar las dosis de los fármacos.
2. Disminuir la proteinuria→ La proteinuria hace progresar la ERC. Este se trata con IECA, ARAII o diltiazem. En clearance bajo 30 están contraindicados, a menos que esté en diálisis.
3. Tratar las complicaciones (osteodistrofia, HiperK, HipoNa, hipervolemia, etc.)
4. Como última opción tenemos la diálisis y trasplante en la etapa V.

Complicaciones

Osteodistrofia renal

Ante la ERC se genera hiperfosfemia. El fosforo quela al calcio, generando una hipocalcemia y esto genera aumento de la PTH.

El exceso de PTH produce daño renal y osteoporosis.

Lo primero en elevarse es la PTH que en un inicio tendrá Calcio y fosforo normal.

El diagnóstico se hace con Ca, P y PTH además de una densitometría ósea para objetivar osteoporosis.

↑ P ⁻	↓ Ca ⁺⁺	↑ PTH
------------------	--------------------	-------

Tratamiento→ Dieta baja en fósforo y calcio en forma de carbonato de calcio (quelantes de fósforo y aumenta el calcio, es un 2x1).

Hiperkalemia

Se diagnostica con potasio sobre 5.

Tratamiento

Leve→ Dieta baja en potasio, kayexalate (resina intercambiadora)

Grave→ Sobre 6,5 o con alteraciones al ECG. En este caso lo primero que se debe hacer es dar calcio para estabilizar membrana miocárdica y en segundo lugar salbutamol y suero glucosado con insulina.

Acidosis

En caso de ser leve se da bicarbonato Vo y si es grave se da Ev. Si no responde a tratamiento médico requerirá de diálisis de urgencia

Hiponatremia

Se trata con restricción de agua y si es grave se da suero hipertónico al 3% a pasar lento.

Anemia

Se pregunta con frecuencia

Tiene varios objetivos

Fe: Si está bajo se trata con **hierro endovenoso**. Buscamos tener una ferritina sobre 100 con saturación de transferrina sobre 20%. Si la ferritina está sobre 400 no nos importa la saturación de transferrina y consideramos logrado el objetivo del hierro. Es siempre lo primero que debemos ir a corregir.

Hematocrito → Se maneja con EPO subcutánea. Se da solo cuando el hierro ya está controlado, pero el hematocrito o Hb no me sube. Se exige un hematocrito sobre 30 o Hb sobre 10.

IRC + Anemia
Hb = 9 g/dl → **Fe ev**
Ferritina: 150
Sat. transferrina: 15 %

Si en este caso logro mejorar el Fe (sobre 100 y 20%), pero la Hb se mantiene bajo 10, debo dar EPO. Si al dar Fe Ev se mejora el perfil del hierro y me sube la Hb a 10, no hago nada más.

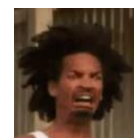
Nefropatía diabética

Inicial → Microalbuminuria mayor a 30mg/día (RAC > 0,03) por más de 3 meses y sin alteración del clearance (>90). Se maneja la diabetes y se dejan IECA para evitar la proteinuria y progresión de la insuficiencia renal.

Establecida → Caída del clearance (etapa II-V), se debe manejar la diabetes y manejo general de la ERC con sus complicaciones

Trasplante renal

Busca mejorar la calidad de vida, porque la alternativa es la diálisis, que es un culo. Además, mejora muy levemente la sobrevida.



Indicaciones → Las mismas de diálisis

Rechazo → Se da por incompatibilidad inmunológica.

- Hiperagudo → Instalación rápida (horas- días post trasplante) de fiebre, necrosis del implante y SIRS.
- Agudo → Antes de los 3 meses
- Crónico → Aparece después de los 3 meses y evoluciona lentamente como una ERC

3. Glomerulonefritis, síndrome nefrítico, GNR y nefritis intersticial

Conceptos

Glomerulonefritis → Inflamación del glomérulo, hematuria dismórfica (con acantocitos). Es un diagnóstico de exámenes.

Síndrome nefrítico→ Es un diagnóstico clínico. Se ve como una triada clásica compuesta por hematuria dismórfica, HTA y edema

GNRP→ Es una GN más una AKI severa y rápida. Viene con una caída en el clearance de por lo menos un 50%.

Síndrome riñón-pulmón→ Glomerulonefritis con afectación de los pulmones (hemoptisis o alveolitis). Tiene varias causas.

Insuficiencia renal aguda→ Caída en el clearance de creatinina de menos de 3 meses de evolución

Nefritis intersticial→ Inflamación del intersticio renal, el glomérulo está bien, es una enfermedad distinta a las anteriores.

Estudio

1. Función renal→ Crea, BUN, ELP y RAC
2. Estudio inmunológico
 - a. ANA (lupus)
 - b. ANCA (vasculitis como la PAM, Wegener, Churg Strauss, hay que recordar que Schönlein-Henoch es ANCA -)
 - c. Antecuerpos anti-membrana basal (síndrome de goodpasture)
 - d. ASO e hipocomplementemia (GNAPE)
 - e. Otras GN que me bajan el complemento (para no confundirla con el post estreptocócica)
 - i. LES
 - ii. Crioglobulinemia
 - iii. Mesangiocapilar
 - iv. EBSA
 - v. Sepsis
 - vi. Shunt
3. Biopsia renal→ Se pide casi siempre, a menos que todo indique que es una post estreptocócica. La biopsia puede mostrar varios patrones a la inmunofluorescencia.
 - a. Lineal→ Nos habla de Goodpasture, anticuerpos que atacan a la lamina basal
 - b. Moteado→ Por deposito de complejos inmunes (LES, GNAPE, asociado a EBSA, enfermedad de Berger)
 - c. Pauciinmune→ No brilla, nos habla de vasculitis (wegener, Churg Strauss y PAM)

Tratamiento

1. Manejo de la IRA y sus complicaciones (HiperK, acidosis y EPA)
2. Tratamiento de la causa (Ej. LES→ Corticoides)
3. Si edema→ diuréticos + restricción de agua
4. Si HTA→ Anti HTA (IECA y alfametil dopa en niños)
5. Si GNRP→ Corticoides Ev + inmunosupresores

Enfermedad de Berge

- **Niño 13 años con tos y rinorrea, consulta por hematuria de 1 día.**
Sedimento: hematuria + dismorfia
Crea: 0,8 mg/dl
Ex. físico normal

Enfermedad de Wegener (granulomatosis con poliangitis)

- **Hombre 27 años, sinusitis crónica, presenta artralgias y malestar, con hematuria y luego oliguria.**
Sedimento: hematuria dismórfica
Crea: 5,5 mg/dl
Ex. Físico: HTA y Edema

LES

- **Mujer 20 años con artralgias y febrícula. Presenta hematuria.**
Crea: 2,1 mg/dl
Sedimento: hematuria dismórfica
C3 ↓ y cilindros eritrocitarios

GNAPE

- **Niño 7 años, amigdalitis hace 2 semanas, presenta edema, P.A. : 150/100 y hematuria.**
Sedimento: hematuria dismórfica
Crea: 1,3 mg/dl
C3 ↓

GNRP (Probablemente PAM)

- **Mujer 65 años, tos, artralgias y edema, más hematuria.**
P.A. : 220/120
Sedimento: hematuria + dismorfia
Crea: 6,0 mg/dl

GN mesangiocapilar (se preguntó 1 vez)



- **Hombre 20 años, hematuria y orinas espumosas.**
P.A. : 150/98, Edema EEII
Crea: 1,9 mg/dl
C3 ↓
Refiere estar resfriado y que hace 1 año le pasó lo mismo

Nefritis intersticial

Suelen venir con antecedente de uso prolongado de AINEs o síndrome de Sjögren

Clínica

- Fiebre
- Exantema
- Artralgias
- IRA

Exámenes

- Hemograma con EOSINOFILIA
- Orina completa con eosinofilia

Diagnostico→ Biopsia renal

Tratamiento→ Corticoides + tratamiento de la causa

4. Edema, proteinuria y síndrome nefrótico

Edema

Puede ser blando o duro

Blando (Con signo de la fóvea)→ ICC, AKI, insuficiencia venosa, Sd nefrótico/nefritico

Duro (sin signos de la fóvea)→ Mixedema (hipotiroidismo) y linfedema (Ca o postqx)

Proteinuria

Normal→ <300mg en 24hrs o índice proteinuria/creatininuria <0,3 (muestra de orina única)

Proteinuria→ >300 mg en 24 horas o IPC >0,3

Proteinuria nefrótica→ Sobre 3g al día o IPC >3

Albuminuria→ Se mide en la DM para ver si hay nefropatía diabética. Es normal cuando es menor a 30mg/dl (RAC< 0,03). Puede ser micro (bajo 300mg/dl o RAC 0,3) o macroalbuminuria (sobre estos valores)

Síndrome nefrótico

Se produce por distintas causas que son glomerulopatías

1. GN por cambios mínimos (nefrosis lipoidea)→ Clásica de los niños, es la principal causa de síndrome nefrótico en edad pediátrica. La biopsia se ve normal, las alteraciones se ven solo en la microscopía electrónica.
2. Glomerulopatía membranosa o extramembranosa→ Es producida por la Diabetes generalmente, siendo esta patología la principal causa de síndrome nefrótico en el adulto. También puede ser causada por LES, mieloma y fármacos.
3. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS)→ Clásica de los pacientes VIH y adolescentes.

Existen algunas glomerulonefritis que pueden hacer un síndrome nefrótico, como la GN de Berger y GNMC (glomerulonefritis mesangiocapilar)

Clínica

- Edema
- Orinas espumosas
- Lipiduria
- Complicaciones
 - o Edema pulmonar agudo
 - o TVP-TEP

- Infecciones (NAC o MBA generalmente)

Diagnóstico

- Proteinuria en rango nefrótico (>3g al día) o RAC>3 o >40mg/m²/h (niños)
- Hipoalbuminemia <3,5
- Edema
- Dislipidemia

Exámenes a pedir

- Función renal (se complica con IRA)
- Exámenes para confirmar diagnóstico
- Biopsia renal si es impuro o cuando no parece ser de cambios mínimos

Puro→ Clínica clásica de síndrome nefrótico

Impuro→ Se agregan elementos de síndrome nefrítico (HTA, hematuria, elevación de crea y/o alteraciones inmunológicas)

Tratamiento

- 1- Dieta NORMOPROTEICA
- 2- IECA (disminuye proteinuria)
- 3- Vacunar contra neumococo, haemophilus, meningococo e influenza (encapsulados)
- 4- ATB y/o anticoagular en caso de infecciones y/o TVP/TEP
- 5- Tratar la causa (Corticoides en caso de GN cambios mínimos)

5. Infección del tracto urinario

Se pregunta siempre

Causas→ E. coli (70-80%) + otras enterobacterias.

Pseudomonas y acinetobacter son importantes agentes en ITU por sondas e IAAS.

Diagnostico→ Clínica + UC

UC positivo

- >100.000 UFC si es por 2º chorro
- >10.000 UFC si es por sondeo
- >1 UFC si es por punción vesical

ITU baja

Clínica

- Disuria
- Polaquiritia
- Pujo y tenesmo
- Nicturia

- Orinas turbias
- Mal olor

Tratamiento → Ciprofloxacino o cefalosporina de 1ª generación por 3 días en mujeres sanas y por 7 en hombres.

Nitrofurantoina se da por 7 días

Pielonefritis aguda

Clínica

- ITU baja +
- Fiebre
- Puño percusión

Hospitalización

- Grave
- Embarazo

Tratamiento

Ciprofloxacino o cefalosporinas de 1ª o 2ª generación por 7-10 días Vo

Cefalosporinas de 1ª o 3ª generación por vía Ev.

Aminoglicósidos son la opción (amikacina) por 10-12 días.

Bacteriuria asintomática

Solo UC positivo, sin clínica

Si tenemos la clínica y el sedimento (+), pero UC negativo, hay que ir a descartar TBC (junto a Lupus y Kawasaki son causas de piuria aséptica)

NO se tratan, a menos que la paciente esté embarazada.

Caso: Mujer 80 años, Alzheimer.

Usa sonda Foley.
Cuidadores notan orinas turbias por lo que se pide UCT, que muestra **E. Coli > 100.000 UFC**, sensible solo a **Imipenen, Tobramicina y Nitrofurantoína.**

No se trata por ser bacteriuria asintomática. (se preguntó)



ITU y Sonda

Tener una sonda aumenta el riesgo de ITU (y por bichos mas malos como pseudomonas o acinetobacter)

Se previene mediante la instalación de sonda Foley mediante técnica estéril

No se debe cambiar de forma periódica, no se dan ATB profilácticos ni irrigaciones con suero fisiológico a través de la sonda

Tratamiento→ Cambio de sonda + ATB

ITU en pediatría

Lo importante es que LAS ITU EN PEDIATRÍA SE ESTUDIAN.

Exámenes para estudio de ITU

- Eco renal→ Se pide **siempre**
- Uretrocistografía→ En caso de eco alterada o que sea PNA en menor de 1 año. Es el Gold standard para estudio de reflujo vesicoureteral.
- Cintigrafía DMSA→ Se pide en caso de eco alterada o que sea PNA en menor de 1 año.

Tratamiento

ITU baja→ Nitrofurantoina o cefadroxilo. No se ocupan quinolonas

ITU alta→ Cefadroxilo o ATB Ev en caso de ser menor de 3 meses.

Profilaxis ATB→ Cefadroxilo o nitrofurantoina 1 vez al día a la mitad de la dosis.

Indicaciones de profilaxis ATB en pediatría

- Estudio pendiente
- Resolución de causa pendiente
- ITU recurrente (3 o más al año)

ITU en embarazo

En este caso se tratan las bacteriurias asintomáticas como una ITU baja por 7 días.

Se pide UC al inicio del embarazo y a las 28 semanas

Las PNA se hospitalizan y se tratan con cefalosporinas de 1ª o 3ª generación Ev.

Contraindicado el ciprofloxacino y se recomienda evitar la nitrofurantoina.

Profilaxis→ Si tiene 2 o más bacteriurias asintomáticas o ITU's (síntomática o asintomáticas) durante el embarazo.

6. Diuréticos y sueroterapia

Diuréticos

De asa→ Inhiben el canal NKCC2, Furosemida y torasemida. Producen hiponatremia, hipokalemia e hipocalcemia. Se usan ante ICC, EPA o ascitis

Tiazidas→ Bloquean canal cotransportador Na/Cl en el TC distal, impidiendo así su reabsorción. Hidroclorotiazida y clortalidona.

Producen hiponatremia, hipokalemia e hipercalcemia. Se usan para tratamiento de la HTA y litiasis renal cuando se asocia a hipercalciuria

Bloqueadores del ENAC→ Amiloride y triamterene, son ahorradores de potasio. Generan hiponatremia e hiperkalemia.

Se usan en HTA

Bloqueadores de la aldosterona → Espironolactona. Genera hiponatremia e hiperkalemia también. Se usa en la ICC (aumenta la sobrevida) y en la ascitis.

Contraindicaciones

- Gota (absoluto)
- Resistencia a la insulina (relativo)
- Dislipidemias (relativo)

Todos pueden producir hipotensión, por lo cual, ante hipotensión se suspenden.

Si alguien está tomando una tiazida y presenta alto consumo de sal, se puede agravar la hipokalemia (se ha preguntado)

Sueroterapias

Cristaloides

Vienen con NaCl y algunos con glucosa (glucosalino, glucosado los más típicos son el suero fisiológico y Ringer lactato).

Suero fisiológico → Es el de elección.

Ringer lactato → Es igual al SF (un poco más caro), se debe elegir cuando el paciente viene con acidosis.

Suero hipotónico (0,45%) → se ocupa ante hipernatremias severas

Suero hipertónico (3%) → Se ocupa ante hiponatremias severas

Suero glucosalino → Viene con glucosa al 2,5% y NaCl 0,45%. Se ocupa de mantención en pacientes hospitalizados y ante CAD o SHH que han logrado glicemias bajo 200.

Suero glucosado → Viene con glucosa al 5%.

Coloides (albúmina, dextranos y GES) → Son tratamiento de 2ª línea ante hipovolemia cuando no responde a cristaloides y el shock no es de tipo vasodilatador (en ese caso se ocupan DVA).

7. Alteraciones hidroelectrolíticas

Primero se trata la volemia y luego se arreglan las alteraciones hidroelectrolíticas

Alteraciones del sodio

Dependen de la entrada y salida de agua (entrada y salida de sodio determinan la volemia)

Hipernatremia → Por deprivación de agua

Su corrección agresiva tiene riesgo de hemorragias cerebrales

Tratamiento

- Leve → Agua VO

- Severa → Suero glucosalino o hipotónico Ev

Hiponatremia

Se caracteriza por edema cerebral.

Su corrección agresiva puede generar mielinolisis pontina

Alteraciones del potasio

Hiperkalemia

Puede ser producida por muchos fármacos (IECA, ARA II, espironolactona, B-bloqueo y AINEs) y por IRA o ERC

Clínica

- Debilidad
- Afectación del ECG (QRS ancho, QT corto y ondas T picudas)
- Arritmias (desde TV a Bradiarritmias)

Tratamiento

Leve → Dieta baja en potasio y tratar la causa y

Grave → (>6,5 o alteraciones al ECG). Se debe dar gluconato de calcio como 1ª medida y luego suero glucosado + insulina y nebulizaciones con SBT. En ultima instancia dejar resinas de intercambio como el kayexalate.

Hipokalemia

Suele ser causado por diuréticos o por aumento de la aldosterona (hiperaldosteronismo, HTA-RV)

Clínica

- Debilidad
- Alargamiento del QT → Torsión de puntas

Se trata con K Ev **en goteo** si es grave

Alteraciones del magnesio

Hipomagneemia

Se asocia a hipokalemia y su clínica es idéntica, por lo cual, ante una hipokalemia refractaria, se debe sospechar hipomagneemia

Hipermagneemia

Causada por intoxicación por sulfato de magnesio (usado en obstetricia).

Clínica

- Arreflexia
- Bradipnea
- Arritmias

En toda mujer con sulfato de magnesio se debe vigilar la frecuencia respiratoria, ROT y diuresis.

Tratamiento → Gluconato de calcio EV y suspender el Mg

Alteraciones del fósforo

Hipofosfemia

Suele ser causado por síndrome de realimentación.

Clínica

- Psicosis, compromiso de conciencia
- Destrucción celular (hemólisis y rabdomiolisis)

Hiperfosfatemia

Causado por ERC (con calcio bajo y PTH alta) y Cáncer (Con calcio alto PTH baja)

8. Litiasis urológica

Las preguntas suelen ser fáciles

Cólico Renal

Clínica

- Dolor lumbar tipo cólico
- Irradiación hacia genitales
- Náuseas/vómitos
- Agitación psicomotora

El diagnóstico es clínico

Tratamiento

Sintomático con antieméticos, AINEs y de segunda línea opioides.

Hay que recordar que clínicamente un Aneurisma abdominal roto se puede presentar igual, pero presentará hipotensión

Una vez que se maneja el cuadro agudo, debo ver que hago con el cálculo. El calculo voy a ir a verlo con un PielotAC para determinar sus dimensiones y ubicación

<1cm → Se observa, se debería eliminar solo

>1cm → LEC de elección, a menos que esté en la pelvis. En este caso se hace una ureteroscopía.

Cálculos coraliformes → Nefrolitotomía extracorpórea

Prevención de recidivas

Es una enfermedad crónica recidivante.

La medida más importante es tomar mucha agua.

Además, se hace un análisis químico del cálculo para saber de que está hecho, pues podría beneficiarse de ciertos tratamientos.

Hiper calciuria (lo más común) → Se trata con hidroclorotiazida

Hiper oxaliuria (la 2ª más común) → Dieta baja en carne y frutos secos

Asociado a ITU (estruvita) → Se dejan ATB para tratar la ITU

9. Uropatía obstructiva baja, retención urinaria y sondas urinarias

Uropatía obstructiva Baja

Causas

- Hiperplasia protática benigna
- Cáncer de próstata
- Estenosis uretral, solo en caso de que tenga los siguientes antecedentes:
 - Uretritis
 - Trauma perineal
 - RTU

Clínica

- Síntomas obstructivos
 - Disuria de esfuerzo
 - Latencia
 - Intermitencia
 - Disminución del calibre miccional
 - Goteo terminal
- Síntomas irritativos
 - Nicturia
 - Polaquiria
 - Incontinencia de urgencia o por rebalse

Diagnostico→ Clínico

Pero de todas formas se debe estudiar la causa, por lo cual, se pide:

- APE (screening de Ca próstata)
- Eco vesico-prostática (Para ver la obstrucción y el tamaño de la próstata)
- Uretrocistografía (en caso de sospechar estenosis uretral)

Complicaciones

- Hematuria recurrente
- ITU recurrente
- ERC post-renal
- Hidroureteronefrosis
- Urolitiasis
- Retención urinaria aguda

Tratamiento

- Médico (1ª línea)
 - Tamsulosina (antagonista Alfa 1)
- Quirúrgico→ Cuando no responde a tratamiento médico o que tenga complicaciones
 - RTU (<60cc)
 - Prostatectomía (>60cc)

Estenosis uretral→ Se estudia con UCG y se trata con RTU

Retención urinaria aguda

Complicación de la UOB

Clínica

- Dolor abdominal bajo
- Retención urinaria
- Globo vesical

Manejo

Instalar sonda Foley hasta que se haya operado el paciente

Si la sonda no pasa o hay sospecha de sección uretral se debe hacer una cistotomía

Sondas Urinarias

Sonda Nelaton → Se usa de forma intermitente con técnica limpia (no estéril). Es de elección en vejiga neurogénica

Sonda Foley → Útil para el sondeo permanente, se debe instalar con técnica estéril, por lo cual, es de elección en la retención urinaria aguda y pacientes que quedan sondeados a permanencia.

CASO

Paciente 75 años, antecedente de diabetes mal controlada, presenta incontinencia urinaria e ITU recidivantes.

Ecografía: Vejiga dilatada de paredes muy finas

Manometría: Sin contracciones del detrusor

Vejiga neurogénica → Autocateterismo limpio con sonda Nelaton

10. Calcio y PTH

VN Ca: 8.5-10,5 mg/dl

Antes de determinar si hay hipo o hipercalcemia, este se debe corregir por la albúmina.

Ca corregido = $Ca + 0,8 \times (4 - \text{albumina})$

Si la albúmina es 4, el calcio dado es igual al calcio corregido

En vez de corregirlo o podemos pedir el calcio iónico (este es el que tiene la acción biológica)

Ca ⁺⁺	PTH	P ⁻	Dg
↑	↑	↓	HPP
↑	↓	↑	HiperCa ⁺⁺ maligna
↓	↑	↑	HP 2 ^{rio} (IRC)
↓	↓	↑	Hipo PTH

Hiperparatiroidismo primario → Ca⁺ y PTH altas con fósforo bajo. Causado por tumor o hiperplasia de paratiroides.

Hipercalcemia por Cáncer (hipercalcemia maligna) → Ca⁺ y Fosforo elevado y PTH baja.

Hiperparatiroidismo secundario (2º a ERC) → Ca⁺ bajo, por lo cual, sube la PTH para compensar, Por la ERC hay retención de fósforo, por lo cual, este estará alto.

Hipoparatiroidismo → Ca⁺ y PTH baja con fosforo alto. Causado por extirpación quirúrgica de paratiroides

Hipercalcemia

Clínica

- Astenia/debilidad
- Deshidratación/poliuria (por hipercalciuria)
- Constipación
- Compromiso de conciencia

Antes que nada hay que corregirla por albúmina. Después se estudia con PTH

- Si está alta → Hiperparatiroidismo primario. Se trata con cirugía
- Si está baja probablemente es cáncer y el tratamiento depende del tipo de cáncer.

Tratamiento en caso de ser grave

1. Hidratar
2. Bifosfonatos Ev (Ac zolendróico o zolendronato)
3. Corticoides Ev en caso de que sea secundario a un cáncer hematológico

Hipocalcemia

Causas

- Enfermedad celiaca (por afectación del duodeno donde se absorbe el Ca)
- Furosemda
- ERA/ERC → La causa más común por falta de excreción de fosfato que es un quelante del calcio.

Clínica

- Parestesias peribucales
- Debilidad

- Tetania
 - o Contracturas musculares
 - o Hiperreflexia
 - o Fasciculaciones
 - o Alargamiento del QT (suelen morir por arritmias ventriculares por esto)

Tratamiento

- Leve: Calcio vía oral
- Grave: Presentan tetania o alteraciones al ECG. Se debe dar 1g de gluconato de calcio Ev.

11. Diabetes insípida, polidipsia primaria, SIADH e hiponatremia

Diabetes insípida → Síndrome polidipsico poliúrico con glicemia normal. Hace orina diluida y su sodio plasmático será normal.

En caso de privación de agua se va a generar hipernatremia con orina diluida

Polidipsia primaria → Síndrome polidipsico poliúrico con glicemia normal. La orina va a estar diluida y el Na plasmático también estará normal, pero en caso de privación de agua todos los parámetros se normalizan.

Causas

- Trastorno psiquiátrico (ej. TOC)
- Central (daño hipofisiario)
- Nefrogénica → La ADH no actúa correctamente. Puede ser por litio o hipercalcemia

Exámenes

- **Test de la sed** → Para diferenciar diabetes insípida de polidipsia primaria. Este test mide el sodio Urinario y plasmático basal y post privación de agua.
- **Test de desmopresina** → Para diferenciar causa central y nefrogénica de diabetes insípida. La desmopresina es un análogo de la ADH, por lo tanto, si el trastorno hidroelectrolítico se mejora al darla concluimos que es un trastorno central. En caso de que no mejore con Desmopresina, es un trastorno periférico porque no falta ADH, simplemente no actúa correctamente en el túbulo.

Tratamiento

Central → Desmopresina

Nefrogénica → Agua + Hidroclorotiazida

SIADH

Es lo contrario a la diabetes insípida, me sobra ADH por un aumento en su excreción y se produce hiponatremia. (**una de las principales causas de hipoNa**)

Causas

- **Pulmonares**

- TBC
- NAC
- CA
- TEP

- **Alteraciones del SNC**

- ACV
- Tu
- Meningitis
- TEC

- **Tumores** (cualquiera, los más comunes son pulmón y cerebro)

Diagnostico→ Hiponatremia + orinas concentradas (Osmolaridad urinaria aumentada).

Se deben descartar otros tipos de HipoNa, es un Dg de descarte

Tratamiento→ Restricción de agua

Hiponatremia→ Na menor a 135.

Clínica

- Leve→ Asintomática
- Severa→ Edema cerebral (compromiso de conciencia, Hipertensión intracraneana)

Causas

VEC normal→ Alteraciones endocrinas como SIADH, hipotiroidismo o Addison

VEC aumentado→ Por edema (ICC, IRC, DHC)

VEC disminuido→ Diuréticos y diarreas hiperosmolares

Tratamiento:

Leve→ restricción de agua (800cc al día)

Severa (Na menor a 120 o con clínica de edema cerebral)→ Suero hipertónico al 3% a pasar lento por riesgo de mielinolisis pontina.

Las natremias dependen de la entrada y salida de agua

Las volemias dependen de la entrada y salida de sodio

Respiratorio

Son 10 preguntas, habitualmente no son muy fáciles, porque el nivel de profundidad es alto, pero son pocos temas

1. Neumonía

2 o 3 preguntas de este tema

NAC

Clínica

- Fiebre
- Tos
- Expectoración generalmente mucopurulenta
- Malestar general
- Dolor tipo pleurítico (aumenta con inspiración)
- MP ausente o disminuido
- Vibraciones vocales aumentadas
- Broncofonía
- Crépitos en foco de condensación
- Matidez a la percusión

Toda neumonía debe estudiarse con una Rx, el diagnóstico es clínico-radiológico.
El inicio ATB es empírico. Se debe cubrir Neumococo

Clasificación ATS

ATS I → <65 años sin comorbilidades y sin criterios de gravedad. Manejo ambulatorio (Amoxicilina)

ATS II → > 65 o con comorbilidad, sin criterios de gravedad Manejo ambulatorio con amoxi/clavulánico, se debe cubrir Neumococo y Haemophilus. Azitro o claritro en caso de alergia a Betalactámicos.

ATS III → Paciente grave, se debe hospitalizar en sala y manejar con Ceftriaxona o cefotaxima. Levo o moxifloxacino en caso de alergia.

ATS IV → Muy grave, hospitalización en UCI (Necesidad de VMI y/o drogas vasoactivas). Se maneja con ceftriaxona + levofloxacino.

En Chile se utiliza el CURB 65, pero es inútil para el EUNACOM según nuestro Drcito

Si tras 48-72 hrs de iniciado el tratamiento ATB no responde se debe pedir una Rx de tórax para descartar derrame pleural.

- **C: Conciencia**
- **U: Uremia (Insf. Renal)**
- **R: Resp. >30**
- **B: Blood pressure <90/60**
- **65: > 65á**

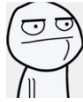
Casos Especiales (Se preguntan)

- Neumonía Atípica → Producida por MO atípicos (Mycoplasma, chlamydia, Legionella). Suelen ser cuadros mas larvados (1-3 semanas de síntomas de resfrio que no cede). Suelen tener cínica obstructiva. La Rx también es diferente. Tienen un patrón alveolo intersticial bilateral, en bases generalmente. El tratamiento es con Macrólidos (azitromicina) o quinolona (levofloxacino)
- Neumonía intrahospitalaria → Neumonía que se inicia 2 días después de haberse hospitalizado o en los primeros 7 días después de haber sido dado de alta. Hay que tenerles miedo a Pseudomonas, acinetobacter y MO BLEE +. Se debe pedir un cultivo para determinar el tipo de bicho. Hasta antes de tener el resultados se debe dejar tratamiento de amplio espectro como cefepime (para Pseudomonas) o imipenem (para los BLEE).
- NAC en inmunodeprimidos → Tiene riesgo de infecciones oportunistas como por ejemplo N. Jiroveci (hongo). Se debe pedir cultivo también y de forma dirigida PCR par Pneumocystis. Se deja con tratamiento de amplio espectro cubriendo Pneumocystis (cotrimoxazol). Ej: Paciente VIH se trataría con Ceftriaxona + levo + cotri
- Neumonía espirativa → Se sospecha ante paciente con ACV, trastorno de la deglución o alcoholismo. Suele ser por anaerobios, por lo cual, se debe agregar metronidazol o clindamicina (Además de la ceftriaxona)
- NAC post-influenza → Antecedente de influenza 1-2 semanas antes. Suelen hacer una NAC cavitada grave bilateral, generalmente por S. aureus que puede ser muy grave. Se suele agregar cloxacilina o cefazolina.
- Neumonitis virales → Producidas por virus. En caso de influenza se deja oseltamivir. Si es varicela se trata con aciclovir

Absceso pulmonar (anaerobios) → Tos con expectoración pútrida, fétida. Suelen no tener fiebre. El diagnóstico es con Rx donde se ve una cavidad con nivel hidroaéreo. El tratamiento es con Clindamicina + drenaje (mediante KNT). Si la KNT no es suficiente se drena por broncoscopía (en caso de ser de ubicación central) o punción percutánea (en caso de ser periférico y que el broncoscopio no llegue)

2. Infección respiratoria alta, influenza

Una que otra pregunta de esto



Clínica

- Tos
- Rinorrea
- Odinofagia
- Congestión Nasal
- Expectorcación mucosa



Al examen físico suele haber eritema en faringe con EXAMEN PULMONAR NORMAL

Hay muchas causas, son todas casi iguales

Suelen ser así todas virales (VRS, influenza, parainfluenza,, metapneumovirus, etc.), por lo cual, el tratamiento es sintomático

Diagnostico → Clínico. Solo en situaciones excepcionales se pide panel viral
Tratamiento → Sintomático

- Fiebre Faringoconjuntival → Infección por adenovirus. Se presenta como fiebre, faringitis y conjuntivitis (quien lo hubiese dicho sorprendente).
- Bronquiolitis → Causado por VRS. Lactante menor de 1 año que sufre su primer cuadro obstructivo. Es una infección baja, no alta
- Laringitis Obstructiva → Causada por Virus Parainfluenza. Estridor inspiratorio + cuadro obstructivo. La obstrucción es alta, tiene estridor y no sibilancias

INFLUENZA (1 pregunta)

- **Fiebre alta**
- **Tos**
- **Mialgias**
- Cefalea
- CEG

Examen pulmonar generalmente normal.

Diagnostico es clínico.

Tratamiento → Paracetamol. Evitar AINEs y totalmente contraindicado la aspirina por posible síndrome de Reye (edema cerebral + hepatitis)

Casos graves puede producir neumonía por influenza. Además de la triada de fiebre, mialgias y tos se agrega dificultad respiratoria, desaturación y Rx con patrón intersticial.

Se trata con oseltamivir Ev. Es un antiviral que tiene poca utilidad realmente, pero se deja igual en adultos >65 o con factores de riesgo (MINSAL)

Es un cuadro poco frecuente

Oseltamivir también se puede utilizar como profilaxis en esta misma población.

Vacuna (para la población de riesgo)

- <5 o >65 años
- Embarazadas
- Patologías crónicas
- Inmunodeprimidos
- Trabajadores de la salud y educación

Como diferenciamos una patología viral de una bacteriana?

Sinusitis → La clínica es similar, la diferencia nos la entrega la evolución del cuadro (más de 14 días o si después del día 7 empeora eso es bacteriano. El color de los mocos no nos dice nada)

Laringitis viral (Parainfluenza) v/s epiglottitis bacteriana (Hib) → La laringitis viene con fiebre, disfonía, odinofagia, estridor, mientras que la epiglottitis hay estridor fiebre alta, aspecto tóxico, el niño tiene dificultad respiratoria (posición de trípode)

Tratamiento → Laringitis viral → Adrenalina racémica (0,05mg/kg) + Corticoides sistémicos. La epiglottitis se trata igual pero + ceftriaxona.

Amigdalitis viral/bacteriana → Viral viene con tos rinorrea, disfonía conjuntivitis. Bacteriana viene con dolor intenso de inicio súbito, adenopatía, exudado, lengua saburral. **Viene SIN tos ni rinorrea.**

Viral → Tratamiento sintomático

Bacteriana → Amoxicilina o PNC (S. Pyogenes)

Si queda la duda → Test pack o cultivo

Mononucleosis → Odinofagia, fiebre y adenopatías además de hepatoesplenomegalia, ictericia y Rash morbiliforme. Diagnóstico es con IgM VCA VEB.

3. Espirometría y Gases arteriales

Espirometría se pregunta, gases arteriales hace varios años que no (ojalá mantengamos esa racha)

ESPIROMETRIA

Mide volúmenes pulmonares. Se miden basalmente y post BD. Se comparan con los volúmenes teóricos que debería manejar una persona de ese sexo, edad, talla y raza.

CVF (capacidad vital forzada)

VEF1 (volumen espiratorio del 1er segundo)



Lo primero a ver es la relación VEF1/CVF → Lo normal es mayor o igual a 70%. Menor a esto es un **patrón obstructivo**. Se debe ver si revierte o no post BD (Asma vs EPOC).

Reversión post BD: Aumento en un 15% cualquiera de los valores (VEF1, CVF o VEF1/CVF)

SEVERIDAD	
>80%	Leve
>50%	Mod
>30%	Severo
<30%	Muy Sev

La severidad del EPOC la evaluaremos es base al porcentaje del VEF1 teórico.

Después evaluaremos el CFV. Si es menor a 80% estaremos frente a un **patrón restrictivo** clásico de fibrosis, NAC, cáncer, atelectasias y neumotórax

Obstructivo → ASMA v/s EPOC

Restrictivo → Fibrosis, cáncer, NAC, neumotórax, atelectasia

Gasometría arterial

Nos permite ver la función respiratoria y equilibrio acido/base.

Función respiratoria

PaO2 → >75mmHg. Una Sat de 90% equivale a 60mmHg

PaCO2 → lo normal es entre 35 y 45. Si está baja el paciente está hiperventilando y si está alta está hipoventilando. Sobre 50 se habla de insuficiencia respiratoria.

Insuficiencia respiratoria → Es un diagnóstico gasométrico. Puede ser parcial (PaO2 bajo 60) o global (PaO2 bajo 60 y PaCO2 sobre 50)

Lo tercero que se debe evaluar es la diferencia alveolo arterial

Si tengo una hipoxia con diferencia A-a normal le problema no es pulmonar

Cuando tengo problemas pulmonares se va a afectar la diferencia A-a

VEF1/CVF		VEF1		CVF		Dg.
Basal	PostBD	B	PBD	B	PBD	
62%	79%	66%	100%	92%	94%	ASMA
60%	62%	63%	66%	100%	102%	EPOC Mod.
80%	80%	50%	49%	53%	53%	Fibrosis
75%	78%	95%	99%	89%	94%	Normal
42%	44%	48%	49%	78%	80%	EPOC Sev.

Equilibrio ácido-base

pH → 7.36-7.44

pCO₂ → 35-45

HCO₃ → 22-26

BE → -2 a +2

Acidosis

pH bajo 7.36. Puede ser metabólico o respiratoria

Metabólica → Diarrea, AKI, CAD

Respiratoria → Hipoventilación (BDZ, enf neuromuscular)

ACIDOSIS			
	CO ₂	HCO ₃	BE
Metabólica	↓	↓↓	↓
Respiratoria	↑↑	↑	N

Acidosis respiratoria

Si la acidosis metabólica tiene anion Gap aumentado (>12), es por algún ácido orgánico, no por pérdida de base. Esto se ve en la acidosis láctica y CAD

¿Viene con un trastorno respiratorio asociado?

En el caso de que sea por un componente metabólico puro (sin componente respiratorio), el pH debería ser 7, CO₂. Esto significa que el valor del pH va a ser similar al nivel de CO₂ (después del 7,).

Si el CO₂ es mucho mayor al nivel del pH, se asume que también tiene un componente respiratorio. En casos de que sea mucho menor el número, se asume que se tiene una alcalosis respiratoria



ALCALOSIS

pH sobre 7.44

Metabólica → Vómitos, Hiperaldosteronismo

Respiratoria → Hiperventilación (crisis de pánico, taquipnea)

ALCALOSIS			
	CO ₂	HCO ₃	BE
Metabólica	↑	↑↑	↑
Respiratoria	↓↓	↓	N

pH	HCO ₃	CO ₂		Dg.
7,33	17	33	→	Ac. Metabólica
7,27	27	60	→	Ac. Respiratoria
7,62	19	19	→	Alc. Respiratoria
7,04	10	38	→	Acidosis Mixta
7,40	12	20	→	Acid. Metabólica Alc. Respiratoria

No se he preguntado en los últimos 2 años. Si, efectivamente el muy CSM lo dice al final del video después de rompernos el cerebro y dejarnos con ganas de llorar. Hay esperanza señores



4. Tabaquismo

Se pregunta con bastante detalle

Riesgos del consumo de cigarrillos

- Cardiovascular
 - o ACV, IAM, Claudicación, AAA, etc.
- Cáncer
 - o Pulmón, boca, vejiga, etc.
- EPOC
- Bronquitis crónica



IPA: Cigarrillos al día/20 x años de tabaquismo

Criterios de tabaquismo

- Fumar mas de 25 cigarros al día
- Fumar más durante la mañana
- Fumar en lugares prohibidos+
- Fumar a pesar de estar resfriado/EPOC

Tratamiento

- Psicoterapia cognitivo/conductual es la base del tratamiento
- Apoyo nicotínico (parches o chicles nicotínicos) para síndrome de abstinencia
- Fármacos (disminuyen el deseo de fumar)
 - o Bupropion
 - o Vareniclina (Champix)

Cigarrillo electrónico → Se recomienda no usarlo, pues mantiene el hábito, aunque es un mal menor.

Medidas para dejar el tabaquismo

Decirle DEJE DE FUMAR → 5%

Tener un ACV → 75%



Contaminación ambiental → Tiene riesgos similares al tabaquismo, pero en menor intensidad

Aumenta las infecciones respiratorias de tipo viral

Aumenta riesgo de NAC

Aumenta riesgo de Ca de pulmón

Aumenta riesgo cardiovascular

Medidas de protección primarias para esto → Restricción vehicular y calefacción a leña

5. Tuberculosis

1 o 2 preguntas (Respiratorio o infecto)

Producida por *Mycobacterium tuberculosis*

Clínica → Tos + expectoración que puede ser hemoptoica. Además fiebre, baja de peso por 2 semanas por lo menos

Diagnostico → Rx de tórax, baciloscopias (de elección, 80% sensibilidad) y cultivo de Koch

Rx Tx → Retracción apical, paquipleuritis y complejo primario (lesión con zona de fibrosis mas adenopatía en mediastino)

A quien pedir BK? → Se requieren 50 neutrófilos por campo. Si hay menos se debe repetir

- Rx sugerente
- Clínica sugerente (tos más de 2 semanas)
- Contacto de paciente TBC

Tratamiento

1ª fase → 50 dosis (2 meses), RIPE

Diaria

- Rifampicina
- Isoniacida
- Pirazinamida
- Etambutol

2ª fase → 48 dosis (4 meses)

Trisemanal

- Rifampicina
- Isoniacida

Si hay RAM (hepatitis, vómitos, diarrea, etc.), se deben suspender los fármacos y derivar a especialista.

Resistencia → Tratamiento secundario con moxifloxacino, kanamicina, streptomina. Manejo de especialista.



Control

BK mensual y cultivo en caso de estar positiva la BK

Casos especiales

Fracaso → Cultivo positivo tras 4 meses de tratamiento

Fracaso probable → BK que no Negativizan o que se positivizan 2 seguidas hasta el 4º mes. En este caso mantengo tratamiento hasta recibir el cultivo, pues podría ser eliminación de bacilos muertos.

El fracaso es por resistencia ATB, en este caso se debe derivar a especialista

Recaída → Paciente que se da de alta, pero vuelve con síntomas y BK (+). Es un caso nuevo, por lo tanto, se debe notificar nuevamente y tratar como tal. Se deben estudiar a los contactos, porque alguno lo contagió

Abandono → Suspender tratamiento por 4 semana o más. Lo importante no es el tiempo de tratamiento, sino que el número de dosis

En caso de haber suspendido hace menos de 1 mes, se debe retomar hasta donde había llegado.

Si ha pasado más de un mes se debe iniciar todo el tratamiento desde cero.

Si lleva mas de 1 mes sin tratamiento, pero las BK están negativas se da de alta.

Manejo de contacto

A todo contacto de bacilífero se debe evaluar si tiene **clínica, pedir Rx y BK**.

Si es menor de 15 años se debe pedir PPD

Si la Bk es positiva se debe iniciar tratamiento anti TBC. Si es menor de 15 años y tiene BK negativa, pero Rx sugerente, se debe iniciar tratamiento igual

Profilaxis → Para contactos. Es con Isoniacida por 6 meses (en VIH por 9 meses)

La profilaxis se deja a:

PPD > 10mm (PPD es para < 15 años, VIH y enfermedades crónicas)

PPD > 5mm en paciente VIH

Menor de 15 años (3 meses en caso de PPD negativo)

RN hijo de madre bacilífera → Se le deja profilaxis, pero no se contraindica la LME

6. Enfermedades intersticiales

Enfermedades intersticiales pulmonares difusas

Son varias.

La mas importante es la Fibrosis pulmonar idiopática (FPI o UIP). Es la mas frecuente y la más mala, pues no tiene tratamiento específico

Otras causas son: Enfermedades autoinmunes, fármacos (nitro, Metotrexato, amiodarona o quimioterapia), inhalantes (asbesto), histiocitosis X y más.



Clínica

- Disnea
- Tos, generalmente sin expectoración
- Crépitos gruesos
- Hipocratismo
- Disminución del tamaño pulmonar

Diagnostico → Anamnesis completa + radiografía. Patrón intersticial mayor en bases y zonas periféricas. Finalmente se debe tomar una biopsia.

NEUMOCONIOSIS

Debido a exposición a inhalantes de forma crónica. Esto genera una Enfermedad intersticial difusa. La clínica y Rx es igual a UIP. Puede ser por asbesto, carbón, vidrio o loza.

MESOTELIOMA

Mal pronóstico, el tratamiento es solo paliativo



HIPERTENSIÓN PULMONAR

Presión de arterial pulmonar mayor a 30 en la sistólica y 25 la media.

Puede ser 1ª o 2ª.

1ª (esta se ha preguntado) → Disnea de esfuerzo, astenia con Rx y Espirometría normal. El problema es el árbol vascular, no el parénquima. Es de mal pronóstico. Se trata con vasodilatadores pulmonares (Oxígeno, NO y prostacilina)

2ª → Las mas frecuentes. Suele ser por ICC o EPOC. Acá lo importante es tratar la causa

COR pulmonar

ICC derecha secundaria a patología pulmonar que genera HTP.

Conducta → Tratar la causa.

7. Apneas del sueño, cuerpo extraño, intoxicación por CO y asfixia por inmersión

SAHOS

Clínica

Roncopatía + somnolencia diurna (pueden estar desconcentrado y tener accidentes de tránsito por quedarse dormidos) + complicaciones (HTA o poliglobulia)

Diagnostico → Polisomnografía (clínica inespecífica). Requiere mas de 5 apneas o hipopneas por hora para el diagnóstico.

Tratamiento → Baja de peso, evitar OH y BDZ antes de dormir.

Cirugía solo en caso de que tenga alteraciones anatómicas muy groseras

CPAP se indica en caso de ser severa o no responder a tratamiento

CUERPO EXTRAÑO RESIRATORIO

Nasal → Rinorrea purulenta fétida unilateral. Se debe derivar a otorrino



Laríngeo → Es una urgencia por imposibilidad de respirar. Realizar maniobra de Heimlich. En menores de 1 año se realizan 5 golpes interescapulares seguidos de 5 compresiones torácicas. En caso de no ser obstructivo se debe derivar a servicio de urgencia para Rx y extracción.

Bronquial → Tos súbita, intensa y persistente. Puede generar atelectasias, hiperinsuflación o sibilancias localizadas en la zona de obstrucción. El lugar mas frecuente es el LID. Se toma Rx y se extrae por broncoscopía

Intoxicación por monóxido de carbono

La fuente de CO más frecuente es un brasero, calefón en baño, estufa a leña en la pieza o automóvil viejo

Clínica

- Hipoxia

- Compromiso de conciencia
- **SIN CIANOSIS**

Diagnóstico→ Carboxihemoglobina. PaO₂ y SatO₂ estarán normales.

Tratamiento→ Oxígeno al 100%. Cámara hiperbárica es el ideal

ASFIXIA POR INMERSIÓN

Su prevención es lo más importante. Rejas altas y barrotes no escalables en piscinas

Tratamiento

RCP + soporte ventilatorio y medidas de neuroprotección

8. Neumotórax, Trauma de tórax, Hemotórax y mediastinitis

NEUMOTÓRAX

Aire en la cavidad pleural

Espontáneo→ Por rotura de bulas apicales generalmente

- Dolor pleurítico
- Disnea

Disminución del MP e hipersonoridad a la percusión.

El diagnóstico es con Rx en espiración máxima.

Tratamiento→Depende del tamaño

<15%--> AINEs + RX de control a las 4-6 horas. (tubo en caso de avance)

>15%--> Tubo pleural

NEUMOTÓRAX A TENSIÓN

Se debe puncionar inmediatamente en el 2º EIC en línea media clavicular (según Dr Mordojovich (Cx tórax)se pincha en 5º EIC LAA o LAM)

Diagnóstico clínico

- Hipotensión
- Yugulares ingurgitadas
- Asimetría torácica
- Tráquea desviada

Tras la punción se debe realizar manejo usual de neumotórax.

SOLO PUNCIONAR LOS NEUMOTÓRAX A TENSIÓN, NO CUALQUIERA

Abierto→ Se debe tratar inmediatamente con parche en 3 puntas, luego cirugía

Secundario→ Por patologías pulmonares, como EPOC.

1er episodio suele no operarse, pero del 2º episodio en adelante se operan aunque sea pequeño, se hace pleurodesis.

TRAUMA DE TORAX

Se pregunta poco

Ante un trauma se debe pedir Rx y actuar según los hallazgos.

Tórax volante → Fx de 3 o más costillas continuas en 2 o más zonas de cada una de estas. Se maneja con analgesia + VMI. No es el tórax volante en si el que genera daño, es la contusión pulmonar.

Fx costal → Manejo con analgesia

HEMOTÓRAX

Trauma de tórax + derrame

Manejo → Tubo

Masivo → Mas de 1.500cc o mas de 200cc por hora. Requiere cirugía

MEDIASTINITIS AGUDA

Causas

- Perforación esofágica (iatrogénica por EDA)
- Comida (hueso de pollo)
- Síndrome de boerhaave
- Infecciones del cuello (absceso periamigdalino, para o retrofaringeo)

Clínica → Dolor torácico + sepsis

Diagnostico → TAC de tórax

Tratamiento → ATB de amplio espectro + cirugía

9. Nódulo pulmonar, cáncer pulmonar, bronquitis crónica, bronquiectasias y hemoptisis

Se preguntan con cierta regularidad

NÓDULO PULMONAR SOLOITARIO

Tiene muchas causas. Lo importante es ver si es benigno o maligno

<1 cm suelen ser benignos y sobre 3 cm suelen ser malignos (90%)

Aspecto benigno → Calcificado, <1cm, estable por 2 años en relación a Rx previas

TAC es el examen de elección para estudiar una masa sospechosa

Benigno → Pequeño, estable, calcificado. Se siguen con Rx o TAC

Sospechoso → Por ejemplo uno de 2 cm pero de aspecto benigno. TAC cada 3-6 meses o PET-CT

Aspecto maligno → Denso, espiculado, vidrio esmerilado o mayor a 3cm → Biopsia transbronquial si es central, Punción percutánea en caso de ser periférico.

Cáncer de pulmón

El antecedente clásico es el tabaquismo

Se puede presentar de muchas formas, el examen pulmonar suele ser normal

- Tos
- Baja de peso
- Expectoración mucosa/hemoptoica/hemoptisis
- Hipocratismo digital
- NAC recidivante en un mismo lóbulo (por esto mismo toda NAC se debe controlar con Rx Tx tras 1 mes, para asegurarnos que no haya Ca bajo esta)

Se estudia igual que un nódulo pulmonar

Tipos

- Ca de células pequeñas → Pronóstico malo, suele producir síndromes paraneoplásicos (Secreción ectópica de ACTH, hipercalcemia o síndrome de carcinoide). Se trata con Quimioterapia
- No células pequeñas (Adenocarcinoma, espinocelular y de células grandes) → Mejor pronóstico, se trata con cirugía (lobectomía)

Contraindicaciones de cirugía → EPOC severo o adenopatías mediastínicas metastásicas confirmados con mediastinoscopía.

BRONQUITIS CRÓNICA

Complicación del tabaquismo

CLINICA

Fumador con tos y broncorrea de predominio matinal x 3 meses

El diagnóstico es clínico. Se toma Rx para descartar cáncer y Espirometría para descartar EPOC.

Si bien suele venir asociado a EPOC, la clínica de expectoración es de bronquitis, no de EPOC.

Tratamiento → Dejar de fumar

BRONQUIECTASIAS

Dilatación bronquial permanente e irreversible.

Clínica → Tos + broncorrea crónica. Suele venir con hemoptisis

Suelen ser de gente joven (no confundirlo con cáncer)

Suele ser postinfecciosa (TBC, cuerpo extraño, NAC por adenovirus). **Se ha preguntado como paciente que tras TBC persiste con tos y expectoración, pero con BK negativas.**

Fibrosis quística y enfermedad de cilio inmóvil son causa de bronquiectasias genéticas

Estudio → Radiografía (suele ser normal) → TAC es el examen de elección

Tratamiento → Es irreversible. Se hace KNT y ATB SOS.

En caso de que estén localizadas en un solo lugar se pueden operar.

HEMOPTISIS

Hemoptisis leve → Suele ser a causa de bronquitis, estenosis mitral (se pregunta), TEP, cáncer, TBC, bronquiectasias.

Se hace broncoscopía y se trata la causa

Masiva → Suele ser por causas similares TBC, bronquiectasias y Ca.

Se trata con intubación selectiva y broncoscopía de urgencia para detener el sangramiento.

10. Derrame pleural, EPA

Derrame se pregunta con bastante frecuencia y EPA suele preguntarse manejo

DERRAME PLEURAL

Disnea + dolor pleurítico.

Al examen hay abolición del MP y matidez

La Rx es el examen de elección. Muestra un borramiento del receso costofrénico y curva de Damoiseau.

Se deben puncionar para determinar que tipo de derrame es.

Criterios de Light me sirven para determinar diferencia entre transudado y exudado

Basta con tener 1 criterios para que se catalogue como exudado.

Criterios de Light

- LDH > 0,6 Plasma
- Prot. > 0,5 plasma
- LDH > 2/3 máximo (180 UI/L)

Causas

Transudado → Se debe tratar la causa

- ICC
- Sd nefrótico
- DHC

Exudado → Son mas complejo

Predominio polimorfonuclear

- Derrame paraneumónico simple (pH >7,2, lactato <5, con gram y cultivo -). Cualquiera de estos parámetros alterados lo hace un derrame paraneumónico complicado.
- Empiema (pH <7,2, lactato > 5 y gram o cultivo +)

Predominio mononuclear

- TBC (ADA mayor a 50)
- Cáncer (ADA menor a 30)

ADA nos ayuda a diferenciarlo, pero el diagnostico se hace con biopsia pleural porque el ADA no es tan E ni S

Las enfermedades reumatoides y el empiema también tienen ADA alto

Tratamiento → Depende del tipo de exudado

Transudado → Tratar la causa

Derrame simple → ATB (con el drenaje de la punción es suficiente)

Derrame paraneumónico complicado → ATB mas tubo pleural

TBC → RIPE

Cáncer → Cirugía, Quimio, radio

Mesiotelioma → Paliativo

EDEMA PULMONAR AGUDO

- Disnea
- Cianosis
- Taquipnea
- Uso de musculatura accesoria
- Desaturación
- Crébitos en bases

Es un diagnostico clínico-radiológico.

Se clasifica en EPA cardiogénico y no cardiogénico.

Cardiogénico → Se da por ICC izquierda donde la PCP (presión hidrostática capilar) es mayor a 18. Se trata con bomba de TNT o furosemida de no tener esto. Si está hipotenso solo puedo dar terapia de soporte (y besito en la frente porque ese cabro está pedido)

No cardiogénico → PCP menor a 18. Es un aumento de la permeabilidad capilar (sepsis, quemaduras, TEP). Se trata con soporte y VM a presión positiva además de tratamiento de la causa.

11. ASMA y EPOC

Los errores en estas preguntas están dados por confundir asma con EPOC y Asma/EPOC estable con el descompensado

ASMA

Es una hiperreactividad bronquial reversible.

Se produce broncoconstricción e hipersecreción

El diagnóstico es clínico

- Tos
- Disnea
- Obstrucción

Suele aumentar en la noche, con el ejercicio e infecciones virales

Al examen físico observaremos aumento del diámetro AP, sibilancias, hipersonoridad y disminución del MP

Los diafragmas se aplanan y las costillas se horizontalizan.

Espirometría → Patrón obstructivo que revierte con BD. En el paciente asintomático se utiliza el test de metacolina

Manejo

Sigue un orden

1. Medidas generales
 - a. Evitar alérgenos
 - b. Educar sobre uso de aerocámara
2. Corticoides inhalados/12h + SBT SOS (Solo SBT SOS en caso de que lleve mucho tiempo muy bien). En caso de ser cardiópata se debe reemplazar por ipratropio
3. De no ser suficiente lo anterior: Broncodilatadores de larga acción cada 12 horas (salmeterol y formoterol)-Tiotropio en caso de ser cardiópata.
4. Antileucotrienos (Montelukast)
5. Aumentar dosis de corticoides inhalados
6. Corticoides VO como última línea

Crisis asmática

1. Oxígeno para saturar sobre 94%
2. NBZ con SBT
3. Corticoides sistémicos

Hospitalización → Paciente grave con insuficiencia respiratoria, agotamiento muscular,

EPOC

Se produce a causa del cigarrillo (IPA de 20 por lo menos). Hay enfisema (destrucción de tabiques pulmonares)

Clínica

- Disnea de esfuerzo
- Tos
- Expectoración
- Aumento de diámetro torácico

Diagnostico → Clínica + Espirometría con patrón obstructivo que no revierte con BD.

La severidad la da el VEF1

Severidad: VEF ₁ (%teórico):	
• Leve	≥80% → Asintomático
• Mod	≥50% → disnea esfuer.
• Severo	≥30% → ↓ Calidad vida
• Muy severo	< 30%

Manejo

- Aumenta sobrevida
 - Suspende Cigarro
 - Oxígeno domiciliario por 18 horas al día
 - PaO₂ menor a 55mmHg
 - PaO₂ menor a 60 mmHg asociado a
 - HTP
 - Poliglobulia
 - Cor pulmonar
- Mejoran sintomatología
 - 1. Broncodilatadores de acción corta
 - Salbutamol
 - Bromuro de ipratropio
 - 2. Broncodilatadores de larga acción
 - Salmeterol
 - Formoterol
 - Tiotropio
 - 3. Corticoides inhalados

Manejo de EPOC descompensado

Oxígeno 24% por mascarilla

NBZ con Salbutamol

Corticoides sistémicos

Antibióticos, CFTX (Los EPOC suelen descompensarse por neumonía)

Mnemotecnica auspiciada por creggers: **ABC- O**

A: Antibióticos - B: Broncodilatadores - C: Corticoides - O: Oxígeno

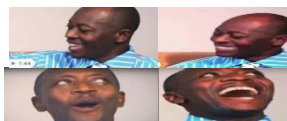


Tabla comparativa de manejos

ASMA ESTABLE • Cort inh. antes. • Todo $\uparrow$ SV.	EPOC ESTABLE • BD larga acción antes. • Solo eliminar cig. y O_2 dom $\uparrow$ SV
CRISIS DE ASMA • O_2 Sin miedo • ATB solo si NAC • Hosp??	EPOC DESCOMPENSADO • O_2 con miedo • ATB siempre • VM??

12. TVP, TEP, Anticoagulación y várices

TVP

- Edema de una extremidad inferior
- Eritema
- Dolor
- Signos de insuficiencia venosa
 - o Trayectos venosos
 - o Lipodermatoesclerosis (piel hiperpigmentada)
- Úlcera venosa (maléolo medial, bordes bien definidos, poco dolorosa y pulsos conservados)
- Empastamiento, signo de fóvea y Hommans

Suele venir con antecedente de:

- Triada de Virchow
 - o Ectasia
 - o Hipercoagulabilidad
 - o Daño endotelial
- Trombofilia
- Post Cx
- Puerperio
- Síndrome nefrótico
- Cáncer
- SAF (LES)

Se estudian con Eco-doppler de EEII

Manejo → Anticoagulación por mínimo 3 y máximo 6 meses. Si no tengo eco anticoagulo a ciegas

TEP

- dolor torácico pleurítico súbito
- Disnea súbita

Suele venir con taquipnea y taquicardia. Puede tener hemoptisis, fiebre, desaturación y crépitos. Si viene con antecedente o FR de TVP previa es muy sugerente. Si llega a dar un derrame, este será hemorrágico (se preguntó una vez, peluda la wea)

Examen → Angio TAC de tórax

Tratamiento → Anticoagulación → mínimo 6 meses

Dímero D → Examen de soporte cuando hay baja sospecha de TEP. Dímero D negativo descarta TEP, pero si esta positivo no lo confirma, por lo cual, debo ir a pedir Angio TAC

ECG → Taquicardia sinusal y S1Q3T3

TEP masivo → Misma clínica del TEP + hemodinamia inestable (hipotenso + ingurgitación yugular).

Examen → Ecocardiograma

Tratamiento → Trombolisis Ev

ANTICOAGULACIÓN

Heparina no fraccionada → Se controla con TTPA, hay que llevarlo a 1,5 veces el basal. Control cada 4 horas. Se da por BIC

Heparina fraccionada → No requiere control, se da dosis fija y shao

TACO → Lo que más se deja, es barato, ambulatorio y se controla con INR (2-3)

RAM → Hemorragias.

HNF da trombopenia, HBPM da AKI y TACO puede interactuar con otros medicamentos

VÁRICES

Diagnóstico es clínico

- Aumento de tamaño de venas
- Edema EEII
- Ulceras venosas

Manejo→ Vendas elásticas + ejercicio. En casos graves se pueden operar con safenectomia.
Si sangran por trauma se deben comprimir y si esto no funciona se deben suturar (Se preguntó 1 vez)



1. Artrosis y Monoartritis

Artrosis

Enfermedad degenerativa que destruye el cartílago articular

Causa

Primaria

- Genética/Degenerativa (1ª causa)

Secundaria

- Luxación crónica
- Fx intraarticular
- Artritis séptica/reumatoide

Clínica → DOLOR (puede evolucionar a anquilosis). Si hay una Rx alterada, pero no hay dolor, no se diagnostica artrosis

Características radiológicas

- Disminución del espacio articular
- Osteofitos
- Esclerosis subcondral
- Geodas (quistes) subcondrales

Tratamiento

1. Paracetamol (1g/8hrs)+ ejercicios de fortalecimiento
2. AINEs si lo anterior no sirve (**no se usan si tiene ERC o ulcera gastroduodenal**)
3. Tramadol si el dolor persiste
4. Corticoides intraarticulares si aun persiste con dolor
5. Prótesis como ultima opción

MONOARTRITIS AGUDA

Dolor, aumento de volumen, eritema y derrame en 1 articulación

Conducta → Punción para determinar la causa

Líquido no inflamatorio → Artrosis

- Menos de 1.000 células
- Filante, transparente

Líquido Inflamatorio → Artritis por cristales o Artritis séptica

- Más de 1.000 células
- Turbio
- Filancia disminuida

Artritis por Cristales

- Birrefringencia (Elongación) positiva → Condrocalcinosis (cristales de pirofosfato de calcio)
- Birrefringencia (Elongación) negativa → Gota

Séptica

Gram (+) → *S. aureus*. Se trata con cloxacilina o cefazolina Ev + drenaje Qx

Gram (-) → *Gonococo*, se trata con ceftriaxona Ev + drenaje Qx

GOTA

Monoartritis aguda recidivante, clásicamente la 1ª metatarsofalángica (podagra)

CONDROCALCINOSIS

Monoartritis aguda que afecta generalmente la rodilla

Tratamiento

AINEs Ev (colchicina como 2ª opción)

No se debe cambiar la dosis ni iniciar alopurinol durante la crisis de gota.

Prevención

Condrocalcinosis → Nada que hacer

Gota → Dieta (bajo consumo de OH y comer poco marisco y carnes) + baja de peso. Como tratamiento farmacológico se puede dar Alopurinol (solo si tiene 2 o más crisis al año, sino no sirve). Se debe mantener el Ac úrico bajo 6 en mujeres y bajo 7 en hombres

2. Poliartritis Artritis y artritis reumatoidea

AR se pregunta con cierta frecuencia

POLIARTRITIS

> 4 articulaciones inflamadas (1: mono, 2-4 oligoartritis)

Poliartritis aguda → Probablemente de origen viral (Parvovirus B19)

Poliartritis crónica → Artritis reumatoidea es lo mas importante a descartar. Lupus, vasculitis, Sjögren son otras causas. La causa va a estar determinada por la clínica.

Es súper importante diferenciar entre artrosis y artritis

ARTROSIS	AR
• Rigidez matutina breve • Sin inflamación • IFD, IFP	• Rigidez matutina >30 min • Artritis • MCP, IFP, muñecas
ARTROSIS	AR
• ↓ Simétrica del espacio art. • Nódulos de Bouchard, y Heberden	• ↓ Asimétrica del espacio art. • Ráfaga cubital • Dedos sastre • Dedos en cuello de cisne.

En cuanto a la Rx es importante saber que la artrosis tiene una disminución simétrica del espacio articular. La artritis tiene una disminución asimétrica del espacio interarticular, va produciendo lesiones en sacabocado.

ARTRTIS REUMATOIDE

El diagnóstico es principalmente clínico

Poliartritis crónica que afecta principalmente a las manos con notoria rigidez matinal. (puede afectar cualquier articulación, salvo la columna a excepción de la articulación atlantoaxoidea))

Manifestaciones extraarticulares

- Nódulos reumatoideos
- Escleritis/epiescleritis
- Cualquiera de las 3 capas del corazón (endo, mio o pericarditis)
- Derrame pleural
- Fibrosis pulmonar
- Vasculitis de pequeños vasos
 - Fiebre
 - Exantema
 - Mononeuritis múltiple

Marcadores

- Factor Reumatoide
- Anti CCP (más específico)

En la Rx se ven con lesiones en sacabocado

Tratamiento

- Drogas modificadoras de enfermedad
 - o **Metotrexato**→ **Una vez a la semana, el más importante**
 - o Azatiopina
 - o Hidroxicloroquina
 - o Leflunomida
- **Infliximab**→ Anticuerpos monoclonales, se ocupan cuando no funcionan los anteriores **o para mujeres embarazadas con AR**
- Corticoides→ Solo como manejo sintomático junto a paracetamol

Los marcadores NO HACEN EL DIAGNÓSTICO, ayudan, pero si no se acompañan de la clínica clásica valen callampa

LA CLINICA ES LO QUE MANDA.

3. Enfermedades del tejido conectivo

Los característico o de estas enfermedades es que son ANA (+). Si pedimos el ENA podemos determinar cuales ANA están positivos.

Lupus→ Anti DNA y anti Sm

Sjögren→ Anti Ro y La

Esclerodermia→ Anti Scl-70 con patrón anticentrómero o antinucleolo en la inmunofluoresencia

Dermatomiositis→ Anti Jo-1

Enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC)→ Anti RNP (ribonucleoproteína)

HAY QUE SABERSE LOS MARCADORES.

Recuerden que lo que manda es la CLINICA, no los marcadores.



Conocer la clínica y los marcadores es lo importante en estos temas

LES

Suele presentarse en mujeres jóvenes(< 30 años)

Clínica

- Rush malar
- Lupus discoide
- Fotosensibilidad
- Ulceras orales (indoloras)
- Artritis
- Xerostitis (pericarditis, derrame pleural)
- Alteraciones del SNC
 - o ACV
 - o Psicosis
 - o Meningitis aséptica
 - o Mielitis transversa

Alteraciones de laboratorio

Renal

- Hematuria
- Aumento de la crea
- Proteinuria

Hematológico

- Plaquetas <100.000
- Leucocitos <4.000
- Linfocitos <1.500
- Anemia hemolítica (Coombs directo +)

Inmunológico

- ANA
- Anti DNA
- Anti Sm
- Hipocomplementemia

Con 4 criterios hacemos el diagnóstico

Si la pregunta el EUNACOM parece Lupus a pesar de no cumplir 4 criterios, es lupus

Tratamiento

Corticoides + inmunomoduladores (azatioprina, Hidroxicloroquina)

Si es muy grave se dan corticoides EV (Se preguntó una vez)



Sjögren

Clínica (síndrome de SICCA)

- Xerostomía (boca seca)
- Xeroftalmia (ojos secos)
- Sequedad vaginal

Manifestaciones extraglandulares

- Artritis
- Fibrosis pulmonar
- Nefritis intersticial
- Mielitis transversa

Tratamiento

Sintomático (agua, lubricantes oftalmológicos y lubricante vaginales)

Esclerodermia

Hay 2 tipos

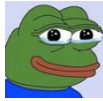
Limitada → CREST (Calcinosis, Raynaud, Esófago (disfagia ilógica), Esclerodactilia y Telangectasias faciales (cara de pájaro). Suelen morir de HTP

Marcadores → Anticentrómeros



Sistémica → Hacen un CREST+ fibrosis en cualquier parte del cuerpo (pulmonar, hepática, etc.)
Suelen morir de fibrosis pulmonar
Anticentrómeros y anti SCL-70

Tratamiento → NO existe



El Raynaud es idiopático en un 80% de los casos, sin ningún tipo de riesgo. Mujer de 30 que solo tiene Raynaud, le pido ANA y me quedo tranquilo

- **Polimiositis/dermatomiositis**

Mialgias + debilidad proximal y compromiso cutáneo en caso de la dermatomiositis

Compromiso cutáneo

- Rash Heliotropo
- Rash/pápulas de gottron
- Rash en manto

Pápulas de Gottron



Rash en manto



Marcadores

CK elevadas (marcador mas importante)

ANA

Anti Jo-1 (se asocia a fibrosis pulmonar, no empeora el pronóstico)

Tratamiento

Corticoides

Es Fundamental ir a descartar un cáncer primario, porque suele presentarse como un síndrome paraneoplásico (ESTO SE PREGUNTA)



- **EMTC (Enfermedad mixta del tejido conectivo)**

Tiene una clínica muy inespecífica

Se presenta como artritis + astenia. No afecta riñones ni SNC

Tiene ANA y anti- RNP

Tratamiento → Corticoides

4. Vasculitis

No es lo más importante, pero se pregunta

Tipos de Vasculitis

- Primarias → Raras, hay que conocer su clínica, suelen ser ANCA (+)
 - o De vaso pequeño
 - Wegener (poliangeitis con granulomatosis)
 - Poliangeitis microscópica (PAM)
 - Vasculitis de Churg Strauss
 - Púrpura de Schönlein-Henoch
 - o De vaso medio
 - Enfermedad de Kawasaki
 - Panarteritis nodosa (PAN)
 - o De Grandes Vasos
 - Arteritis de Takayasu
 - Arteritis de la temporal o de células gigantes
- Secundarias (asociadas a otras enfermedades autoinmunes como AR o LES)

ANCA puede ser p (perinuclear) o c (citoplasmático).

ANCA-C → Granulomatosis de Wegener

ANCA p → PAM, PAN, Churg-Strauss y Takayasu

Kawasaki, arteritis de la temporal y Schönlein Henoch suelen ser ANCA (-)

- Wegener (poliangeitis con granulomatosis)

Clínica (sinusitis + riñón-pulmon y basuras reumatológicas)

- Síndrome riñón pulmón
 - o Alveolitis hemorrágica
 - o Afectación renal grave (GNRP)
- Mononeuritis múltiple (afectación del nervio periférico por afección de la vasa nervorum)
- Fiebre, exantema y artritis
- **Se da en pacientes jóvenes (20-30)**
- **ANCA-C**
- **Suele afectar la parte nasosinusal, dan sinusitis. 30% son diagnosticados por ORL**

Diagnostico → Biopsia de nervio periférico (Sural)

Tratamiento

Corticoides + inmunosupresores (ciclofosfamida). Sin tratamiento producen una muerte rápida
Si se limita a la región sinusal se trata solo con corticoides.

- Poliangeitis microscópica

Clínica

- Síndrome riñón pulmón
 - o Alveolitis hemorrágica

- Afectación renal grave (GNRP)
- Mononeuritis múltiple (afectación del nervio periférico por afección de la vasa nervorum)
- Fiebre, exantema y artritis
- **Afecta adultos mayores, muy agresiva**
- **ANCA-P**

Diagnostico→ Biopsia de nervio periférico (Sural)

Tratamiento

Corticoides + inmunosupresores (ciclofosfamida). Sin tratamiento producen una muerte rápida

- Churg Strauss

Clínica

- **Síndrome riñón- pulmón**
 - **Asma (Que no responde a tratamiento con inhaladores)**
 - **GNRP**
- **Eosinofilia**
- **Anca-P**

-Púrpura de Schönlein-Henoch

Se pregunta con harta frecuencia

Vasculitis de los niños con buen pronóstico

Clínica

- Artralgias
 - Glomerulonefritis (hematuria)
 - **Compromiso Gastrointestinal (dolor, vómitos, hematoquezia)**
 - **Purpura palpable en EEI y glúteos, lo más clásico**
- Purpura→ Lesiones palpables que no blanquean con a compresión

Diagnostico es eminentemente clínico

Tiene un hemograma normal y ANCA -.

El pronóstico está dado por la función renal.

Tratamiento

- Corticoides en caso de púrpura, osino solo observación

Seguimiento es con OC, porque el daño renal me da el pronóstico

- Vasculitis de Kawasaki

Afecta a los niños, diagnóstico clínico

Clínica

- Fiebre por más de 5 días
- Ojo rojo
- Boca Roja (Labios partidos, lengua aframbuesada)
- Adenopatías cervicales
- Exantema de cualquier tipo
- Edema y eritema en manos y pies
- Artritis
- Piuria aséptica (viene con fiebre, ojo con no confundirlo con PNA)
- Anemia y trombocitosis

Se puede confundir con la escarlatina (**viene con amigdalitis pultácea y sin ojo rojo**)

Pronóstico → Se hace con el ecocardiograma para ver la formación de aneurismas coronarios que es su riesgo a largo plazo

Tratamiento → Inmunoglobulina G + AAS. Si no lo trato, tengo riesgo de infarto (esto se preguntó)

Riñón-pulmon → Wegener, PAM y Churg-strauss

- Panarteritis nodosa (PAN)

Asociado a infección por VHB

No afecta riñón ni pulmón porque es de vaso mediano

Clínica

- Afecta vasos mesentéricos
 - Angina mesentérica
 - Hematoquezia
- HTA maligna
- Mialgias y artralgias
- Exantema
- Neuropatía

Diagnóstico

Angiografía de arterias mesentéricas (angioTAC/RNM) o Biopsia muscular
ANCA-P

Tratamiento

Corticoides + ciclofosfamida

- Vasculitis de Takayasu

Afecta a mujeres jóvenes, es una vasculitis de grandes vasos

Clínica

Fiebre, cuadro inespecífico que se asocia a

- ACV
- **Claudicación de EESS**
- HTA renovascular
- **Disminución de pulsos radiales (esto se pregunta)**
- Puede ser ANCA –P positivo, pero lo que manda es la angiografía

Afecta EESS



Diagnóstico

Angiografía /Angio TAC/RNM)

Tratamiento

Corticoides + Cirugía (endarterectomía aórtica)

- Arteritis de la temporal (arteritis de células gigantes)

Arteritis más frecuente, **es la que más se ha preguntado**

Es una vasculitis del adulto mayor



Clínica

- Fiebre (FOD)
- Baja de peso, sudoración nocturna
- Amaurosis fugax
- Dolor de cuello cabelludo (por inflamación de las a. temporales)
- ACV
- Claudicación mandibular
- Polimialgia reumática (dolores, mialgias, fiebre, debilidad proximal)

Presenta VHS muy alta (100) y podría tener anemia

Tratamiento→ Corticoides a dosis altas

Polimialgia reumática→ NO es vasculitis pero puede ser criterio de la arteritis de la temporal pero puede venir sola.

Adulto mayor con mialgia, debilidad muscular, un poco de fiebre. Tienen CK y VHS elevados.

ANA no están elevados (en ese caso sería Polimiositis)

Tratamiento→ Corticoides

5. Pelviespondilopatías

LA clínica es la clave

Clínica común

- Todas afectan la columna, presentan lumbago de tipo inflamatorio
- Oligoartritis periférica ASIMÉTRICA de pequeñas y grandes articulaciones
- Seronegativas, es decir, tienen todos los marcadores negativo (FR, ANA y ANCA)

- **Espondilitis anquilosante (EAA)**

La más importante

Clínica

- Lumbago inflamatorio
- Oligoartritis periférica
- Evoluciona con anquilosis (rigidez) de columna y tórax
- Entesitis, del talón de Aquiles generalmente (se pregunta como dolor arriba de los talones)
- Manifestaciones extraarticulares
 - o **Uveítis anterior**
 - o Eritema nodoso
 - o Pioderma Gangrenoso
 - o Aortitis
 - o Fibrosis pulmonar (como todas las enfermedades reumatológicas)

Diagnóstico

Rx sacroiliacas → Sacroileitis en caña de bambú (por anquilosis de las vertebrae)

RNM → Gold standard. Permite ver EAA iniciales

HLA-B27 → Marcador de apoyo diagnóstico. Es una molécula de histocompatibilidad, no es anticuerpo. Ayuda al diagnóstico

Tratamiento → AINEs + ejercicios para evitar la anquilosis (elongación)

Asociada a EII

Se asocia a Crohn y CU

Muy parecido a EAA, aunque suele afectar mas a las articulaciones distales que la columna

Tratamiento → Tratar la EII

Artritis psoriática

Paciente con psoriasis (placas en codos y rodillas o compromiso ungueal)

Clínica → Oligoartritis de pequeñas y grandes articulaciones periféricas + **Dactilitis (dedo en salchicha)**

Tratamiento → **Corticoides + inmunomoduladores**

Artritis reactiva

Artritis post infecciosa, generalmente post diarrea por Campylobacter

Clínica → Oligoartritis migratoria + Síndrome de Reiter (Artritis + uretritis + Ojo rojo)

Tratamiento

Corticoides + AINEs

Suelen ser autolimitadas y responder a esto

- **Enfermedad de Behcet**

No es pelviespondilopatía

Artritis + úlceras orales dolorosas + úlceras genitales

Puede afectar SNC y SNP

Puede presentar fenómeno de Patergia → Desarrollo de pústula al inyectar Suero fisiológico en el Subcutáneo

Tratamiento → Corticoides + inmunomoduladores

6. Temas Varios

Lumbago

Causas

- Mecánico es lo más frecuente. Se debe a una debilidad de la musculatura lumbar. Dg es clínico y se trata con AINEs, calor local y Kine para fortalecer CORE.

Signos de alarma → Si están presentes se debe solicitar una RNM. De no estar presentes se sigue el tto anteriormente mencionado

- **Fractura**

- Osteoporosis
- Corticoides
- Adulto Mayor
- Caída o trauma

- **Cáncer**

- Antecedente de cáncer
- Síntomas B

- **Clínica de enfermedad reumatológica**

- Aumenta con reposo y disminuye con ejercicio
- Entesitis
- Uveítis
- Rigidez matinal

- **Infección**

- Fiebre

- **Afectación neurológica**

- Disminución de fuerza
- Disminución de sensibilidad
- Alteración de los ROT (**irradiación del dolor no es Red Flag**)
- Duración mayor a 6 semanas

Lumbociática

Dolor lumbar irradiado EEII

El manejo es igual al lumbago mecánico (Analgesia, calor y Kine)

Se indica RNM en caso de compromiso neurológico o si no responde a tratamiento

Dorsalgia, Cervicalgia y cervicobraquialgia se manejan igual que un lumbago.

Hombro doloroso

Síndrome de manguito rotador es la causa clásica

- Dolor aumenta con movimiento repetitivos
- Aumenta en la noche
- Aumenta ante la abducción y extensión contra resistencia

Diagnóstico es clínico, pero se pide Ecografía para determinar la causa

Manejo

Reposo, AINEs y Kine motora

Solo se opera si el tendón está muy malo y no responde a tratamiento médico

Hombro congelado

Dolor impide la movilización tanto activa como pasiva, lo cual, lleva a la anquilosis (en esta etapa sin dolor)

Diagnóstico es clínico

Tratamiento→ Corticoides + KNT y en ultima instancia podría llegar a Cirugía

Codo Doloroso

Epicondilitis o Epicondilitis lateral o codo del tenista→ Duele la zona de inserción de los extensores del codo.

Tratamiento→ Reposo, AINEs y Kine + Epicondilera

Epitrocleitis o Epicondilitis medial codo del golfista → Duele la zona de inserción de los flexores del codo

Tratamiento→ Reposo, AINEs y Kine + Epicondilera

Tendinitis tricipital→ Duele inserción del tríceps

Tendinitis→ Dolor a la elongación y palpación de un tendón debido a movimientos repetitivos.

T. Pata de ganso → Cara medial
T. Rotuliana → Cara anterior
T. Fascia lata o Sd de la banda iliotibial o tendinitis del trotador → Cara lateral
T. de Quervain → Cara lateral de muñeca
T tricipital → Dolor sobre olecranon

Tratamiento → Reposo relativo, AINEs+ KNT. Si se llega a pedir imagen se pide una Eco



Bursitis → Inflamación de una bursa. Se presentan como dolor, **eritema y aumento de volumen** de la bursa.

La clásica es la bursitis olecraneana, pertrocantérica y rotuliana.

Tratamiento → AINEs + Calor/frío local



Fibromialgia

Diagnostico es clínico

Dolor a la compresión de puntos gatillo (masas musculares), astenia
Suele estar asociado a otros trastornos somatomorfos como SII.

Tratamiento → Ejercicio + moduladores del dolor (pregabalina, gabapentina o Tricíclicos)

Si VHS aumentada pensamos en Polimialgia reumática

Si CK elevada pensamos en Polimiositis o Polimialgia reumática

Resumen Guevara by creggers

Hematología

Son 5 preguntas, de las cuales, 2 son de anemias, 2 de cánceres hematológicos y otra de cualquier tema.

Este es mi último resumen de Guevara de la vida y de un tema de mierda, no hay ánimo para incluir memes, váyanse a la mierda



1. Anemias

Se pregunta siempre

Síndrome anémico

- Astenia
- Adinamia
- Palidez
- taquicardia

Causas

- Ferropenia
- Enfermedades crónicas
- Déficit de B12
- Anemias hemolíticas

Diagnóstico

Se hace con el hemograma teniendo una Hb bajo 13 en hombres, bajo 12 en mujeres, bajo 11 en el embarazo y bajo el p10 en niños (VN en RN es de 15, a los 3 meses es de 9 y al año es de 12)

Para determinar la etiología hay que ver el resto del hemograma (VCM, líneas celulares y reticulocitos)

VCM

- Marocítica (>100) → Déficit de B12, B9, anemia asociada a OH, a hipotiroidismo y mielodisplasia
- Normocítica (80-100) → Enfermedades crónicas es la más típica
- Microcítica (<80) → Ferropénica, talasemia y siderobástica

Otras líneas celulares

- Gb elevados → Leucemia
- Gb y plaquetas disminuidas → Pancitopenia

Índice reticulocitario

Es similar al porcentaje de reticulocitos (formas inmaduras)

Regenerativa ($IR > 2$) → Hemolítica o por hemorragias agudas

Arregenerativas ($IR < 2$) → Todas las demás

ANEMIA FERROPÉNICA

Anemia con VCM bajo además de hipocromía y anisocitosis. Puede haber elevación de las plaquetas (trombocitosis reactiva)

Persona joven con este hemograma → Se trata como si fuera ferropénica

Adulto mayor con este hemograma → Se debe pedir perfil de hierro, realizar EDA y colonoscopia antes para descartar Ca.

Si es refractaria a tratamiento → Se debe sospechar enfermedad celiaca

Tratamiento → Hierro hasta normalizar la ferritina (no el hemograma), lo cual, suele lograrse tras 3-6 meses de tratamiento. Se puede dar como sulfato ferroso (200mg/8horas). Se debe tomar con algo ácido en ayunas para mejorar la absorción. Puede generar constipación y oscurecimiento de las deposiciones.

ANEMIA POR ENFERMEDADES CRÓNICAS

Su hemograma muestra anemia con VCM normal y perfil de hierro con ferritina alta y transferrina baja. La VHS puede estar elevada por la inflamación.

Su manejo es buscar y tratar la enfermedad

	Ferropenia	E.C
Ferritina	↓↓	↑
Transferrina (o TIBC)	↑	↓
Sat. TIBC	↑↑↓	↑↓
Fe	↓	↑↓

TALASEMIAS

Su hemograma puede tener elevado el número de glóbulos rojos (pero con Hb baja). La ferritina suele estar alta, VCM baja y hay ISOCITOSIS, es decir, son todos los GR igualmente chicos.

Existe la alfa talasemia (Desde el nacimiento) y la beta talasemia (de los 3 meses en adelante)

El diagnóstico es con la electroforesis de proteínas

Tratamiento → NO DAR FIERRO, de hecho, en ocasiones se dan quelantes de hierro. En general se observan y si está muy grave se puede transfundir.

ANEMIA	FROTIS DE SANGRE
FERROPÉNICA	Microcítica/hipocrómica Anisocitosis
TALASEMIA	Microcítica/hipocrómica Isocitosis Dianocitos

ANEMIA POR DÉFICIT DE B12

Causas

- Anemia perniciosa (autoinmune)
- Cirugía gástrica
- Resección íleon distal
- Vegetarianos/Veganos

Hemograma→ Puede haber caída de GB y plaquetas (pancitopenia), hipersegmentación del núcleo de neutrófilos, VCM sobre 108. Puede venir con LDH y bilirrubina elevadas. (Dg diferencial de mielodisplasias y hemólisis)

Diagnostico→ Niveles de B12 y folatos

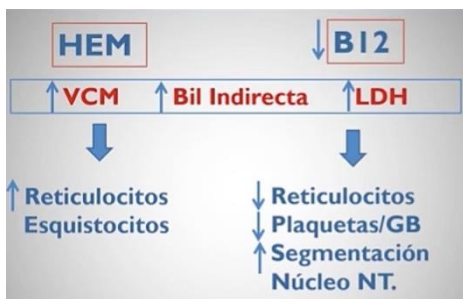
Tratamiento→ Suele ser por problemas de absorción, por lo cual, se trata con VitB12 intramuscular.

La profilaxis es con B12 Vo en vegetarianos

HEMÓLISIS

Viene con reticulocitosis, VCM, LDH y Bilirrubina indirecta elevada. En el frotis se observan esquistocitos.

En caso de ser autoinmune viene con Coombs directo +



2. Alteraciones de la hemostasia/púrpura

Hemostasia 1ª→ Plaquetas

Hemostasia 2ª→ Cascada de la coagulación

Clínica

Hemostasia 1ª→ Petequias, hemorragia de mucosas.

Me altera el tiempo de sangría y en ocasiones el hemograma. En caso de estar bien el hemograma (sin trombocitopenia) se debe a disfunción plaquetaria (enfermedad de von Willebrand y disfunción plaquetaria por AINEs).

En caso de presentar trombocitopenia, las clásicas causas son el PTT, PTI, leucemia y fármacos (hidroclorotiazida, heparinas)

Hemostasia 2ª→ Se presenta como hematomas profundos y hemartrosis.

Se alargan los tiempos de coagulación (TTPK y TP).

>TTPK→Se debe a hemofilias, uso de heparinas

>TP→Se debe a DHC o TACO

Púrpura Trombocitopénico Idiopático (PTI)

Produce clínica de alteración de la hemostasia primaria. En los niños suelen venir con el antecedente de infección viral reciente y en adultos suele estar asociado a enfermedad autoinmune.

NO DEBE TENER Esplenomegalia, fiebre ni adenopatías, en esos casos se debe sospechar de una leucemia.

El diagnóstico del PTI es con hemograma (Trombocitopenia aislada)

Si queda la duda, se puede hacer biopsia de médula ósea, que sería normal.

Tratamiento

Agudo (niños)→Reposo (evitar golpes). Corticoides en caso de plaquetas bajo 20.000

Crónico (adultos)→Corticoides y si no responde se debe realizar esplenectomía.

En caso de estar con hemorragias agudas y severas se debe dar IgG Ev. La transfusión de plaquetas es la última opción.

Púrpura trombocitopénico trombótico (PTT)

Se presenta como insuficiencia renal, alteraciones neurológicas (compromiso de conciencia, convulsiones y parestesias), fiebre, anemia hemolítica y plaquetas bajas.

Si ANA (+) sería un LES

Si ANCA (+) sería vasculitis

Si está embarazada podría ser un HELLP.

El tratamiento es la plasmaféresis de urgencia.

Enfermedad de Von Willebrand

Se pregunta bastante

Clínica→ Alteración de la hemostasia primaria. Puede afectar tanto a hombres como mujeres (no como hemofilia que solo de hombres)

Hemograma normal, pero tiempo de sangría estará alterado (TP y TTPK normal)

Diagnóstico→Pruebas de agregación plaquetarias

Hemofilia

Clínica→ Alteración de la hemostasia 2ª desde la infancia (hematomas profundos y hemartrosis). Solo afecta a hombres. El hemograma es normal, pero viene con TTPK alterado (primer examen a pedir)

Tratamiento→ Dar Ev el factor que falta XIII o IX si es A o B)

Coagulación intravascular diseminada

Es una complicación muy grave de enfermedades muy graves (sepsis, HELLP, pancreatitis, etc.).

Se producen trombosis en distintas partes del cuerpo, lo cual, consume los factores de coagulación, que van a llevar a hemorragias, es decir, tengo los dos extremos.

Diagnostico→ Fibrinógeno disminuido (bajo 100) y Dímero D aumentado.

Tratamiento→ Tratar la causa. En caso de trombosis se puede dar heparina o en caso de hemorragia se puede dar PFC, pero siempre con susto.

Púrpura

Lesiones que no blanquean a la vitropresión. Suelen ser petequias y/o equimosis.

Se estudia con hemograma (para ver si es o no trombocitopénico)

Trombopénico→ Pienso en PTI o leucemia

No trombocitopénico→ Púrpura de Schönlein- Henoch

Purpura con fiebre→ Es una urgencia por tratarse de Leucemia o meningococemia (Agudo)

3. Generalidades de cánceres hematológicos y leucemias

Suelen ser 2 preguntas de hematología (hemato y pediatría)

Leucemia

Existen varios tipos y hay que saber diferenciarlas.

1. Leucemia mieloide crónica

Clínica→ Instalación más lenta, semanas/meses

- Síntomas B (fiebre, baja de peso y sudoración nocturna)
- Esplenomegalia
- Hemograma característico
 - o Aumento significativo de GB, con desviación izquierda (aumento de formas inmaduras con >10% baciliformes), pero sin hiato leucémico, con elevación de lo mieloide (basófilos, eosinófilos, monocitos). Blastos están bajo 5% (lo diferencia de la LMA)
 - o Elevación de plaquetas
 - o Sin anemia

Diagnostico→ Se confirma con biopsia de MO. Tiene presencia de cromosoma filadelfia

Tratamiento→ Anticuerpos monoclonales contra el cromosoma filadelfia (imatinib)

2. Leucemia mieloide aguda

Clínica→ Su instalación es aguda, días/semanas. Clásica de los adultos

- Síntomas B
- Esplenomegalia
- Dolores óseos
- Insuficiencia medular
 - o Sd anémico→ Por baja de GR
 - o Alteración de hemostasia primaria→ Por baja de plaquetas
 - o Infecciones→ Por baja de GB
- Hemograma

- Aumento de GB con formas inmaduras (>5% blastos) con hiato leucémico
- Pancitopenia
- Anemia
- Podría venir con baja de GB (leucemia aleucémica)

Diagnóstico→ Biopsia de MO, si hay >20% de blastos en sangre es dg también.

Tratamiento→ QT de inducción

		Hiato Leucémico				
		SEG	BACIL	MIELO	PRO MIELO	BLASTOS
LMC						
Sin Anemia ↑ Plaquetas Sin Hiato leucémico Crónica		++++	+++	++	+	+/-
LMA						
Anemia ↓ Plaquetas Hiato leucémico Aguda		++	-	-	+++	+++
		+	-	-	-	+++

3. Leucemia linfática aguda

Clínica→ LMA + adenopatías. Es clásica de los niños.

Tiene 90% de curación con QT.

Su hemograma es igual que la LMA, pero en vez de neutrófilos tiene linfocitos.

Dg→ biopsia MO.

Tratamiento→ QT de inducción + QT de mantención.

4. Leucemia linfática crónica

Clínica→ Clásica del adulto mayor. Suele ser un hallazgo o con síntomas piola de insuficiencia medular. Puede venir con adenopatías

Hemograma→ Elevación de GB (linfocitos principalmente) con caída de GR y plaquetas.
NO hay blastos

Dg→ Biopsia de MO

Tratamiento→ Observar, tiene una sobrevida de 10 años y puede darse QT paliativa.

Hemogramas en infecciones

Ante infecciones bacterianas o virales hay un aumento de GB (10.000-20.000) y podría haber una trombocitosis reactiva. Los GR se mantienen.

Virales→ Se elevan los linfocitos

Bacterianas→ Se elevan los neutrófilos junto a las formas inmaduras (desv. izquierda)

Reacción Leucemoide

Secundario a una infección en que los GB se elevan sobre 50.000, por lo cual, es confundible con una leucemia. El ejemplo clásico es el coqueluche.

¿Como lo diferencio de una leucemia? → Si hay baja de otras líneas celulares, probablemente es leucemia, pero si las otras líneas celulares se mantienen sin alteraciones y hay una infección, probablemente es una reacción leucemoide.

En caso de haber elevación de lo mieloide (basófilos, eosinófilos y plaquetas), debo pensar en una LMC

4. Linfomas

Clínica

- Síntomas B
- **Adenopatías**
- Hemograma NORMAL

Rx Tx→ podría haber ensanchamiento de mediastino

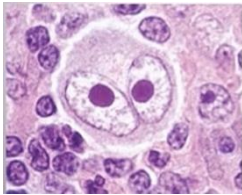
Diagnostico→ biopsia ganglionar (biopsia excisional). Nos confirma el diagnostico y el tipo de linfoma.

Las adenopatías que se biopsian son aquellas persistentes (>2 semanas) y que persisten pese a AINEs y ATB (Amoxi/clav).

Tras el diagnostico se pide un TAC TAP para etapificar

Clasificación

- Hodgkin→ Es clásico de los adolescentes y gente joven (1ª causa de muerte por cáncer en adolescentes). Se caracteriza por células de Reed Stanberg (células grandes, binucleadas) en las biopsia. **Viene con síntomas B** (característico de esta enfermedad, aunque pueden estar presentes en todos los Ca hematológicos), dolor con consumo de OH y tiene mejor pronóstico que el linfoma no hodgkin.

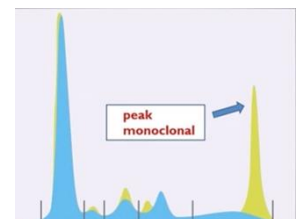


Células de Reed Stteemberg

- NO Hodgkin→ Se clasifican en linfomas de alto (agresivos) y bajo grado (indolentes).
 - o Bajo grado→ No producen síntomas hasta muy avanzada la enfermedad y tienen una sobrevida larga, pero no tienen opción curativa, no se tratan con QT, solo se observan.
 - o Alto grado→ Da síntomas rápidamente, pero la QT es curativa. En caso de que no responda a QT, es mortal.

5. Gamapatías monoclonales

Son 3, mieloma múltiple, MGUS y macroglobulinemia de Waldeström. Tienen en común las elevación de proteínas y que, al hacer una electroforesis, se ve un peak monoclonal.



Mieloma múltiple

- Dolores óseos (síntoma mas frecuente)
- Adulto mayor
- Síntomas B

- Síntomas de insuficiencia medular

Hemograma → VHS muy alta (puede estar sobre 100), anemia y pancitopenia en ocasiones. En el frotis se observa Roleaux +.

Laboratorio

Hipercalcemia, ERC, peak monoclonal y lesiones óseas líticas (en sacabocado).

Se pide Rx de cráneo, pues al ser huesos mas delgados, las lesiones líticas se observan antes acá.

Diagnostico → Biopsia de MO que muestra gran cantidad de células plasmáticas

Tratamiento → QT

Gamapatía monoclonal de significado incierto (MGUS)

Es asintomática y tiene exámenes de laboratorio normales. Su única alteración es la disproteinemia (elevación de inmunoglobulinas que se ve en la electroforesis (peak monoclonal). Es un hallazgo

Diagnostico → Biopsia de MO

Tratamiento → Nara, 2-3% se transforma en mieloma múltiple

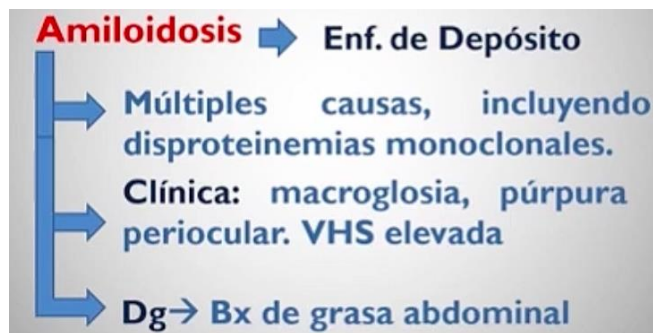
Macroglobulinemia de Waldeström

Similar a mieloma, pero de tipo IgM.

Clínica → Suele ser asintomático, pero puede presentar Trombofilia (TVP, TEP)

Tratamiento → Observar. Anticoagulación en caso de fenómenos trombóticos.

Amiloidosis (me dio paja escribirlo, probablemente no se pregunte)



6. Síndromes mieloproliferativos y mielodisplásicos

Síndromes mieloproliferativos

Son 4, pueden mezclarse entre ellos y evolucionar de uno a otro. Se caracterizan por tener esplenomegalia.

- **Policitemia vera**

Clínica

- o Esplenomegalia

- Riesgo de trombosis (por aumento de GR que genera hiperviscosidad)
- Gen JAK-2 (+)

Tiene un hematocrito y Hb muy elevadas (>55 y 18 respectivamente) y elevación de plaquetas.

Es un diagnostico de descarte (descartar que viva en altura, EPOC y otras causas de hipoxia)

Tratamiento→ Sangrías

- **Trombocitosis esencial**

Clínica

- Plaquetas sobre 600.000 (GB y GR normales)
- Esplenomegalia
- Trombosis o hemorragias (porque las plaquetas pueden ser no funcionantes)

Recordar→ La principal causa de trombocitosis es la trombocitosis reactiva (a infección, inflamación, quemaduras, politmt, etc.)

- Leucemia mieloide crónica→ Explicado en la pagina 179 ☺

- **Mielofibrosis→**

Clínica

- Esplenomegalia gigante
- Síntomas de insuficiencia medular (pancitopenia)

Tiene un hemograma con pancitopenia (al inicio pueden aumentar todos, ojo). E el frotis pueden haber dacriocitos.

Diagnóstico→ Bx de MO

Tratamiento→ Soporte transfusional

Mielodisplasias

También llamadas leucemias In situ. Es un cáncer, pero que no es grave en la medula ósea, pero con riesgo de avanzar a una leucemia aguda.

Clínica

- Insuficiencia medular
- Esplenomegalia (no tan marcada)
- Anemia refractaria en el **ADULTO MAYOR**

Hemograma→ Pancitopenia con VCM alto (100-108).

Diagnóstico→ Biopsia de MO

Tratamiento→ Soporte transfusional

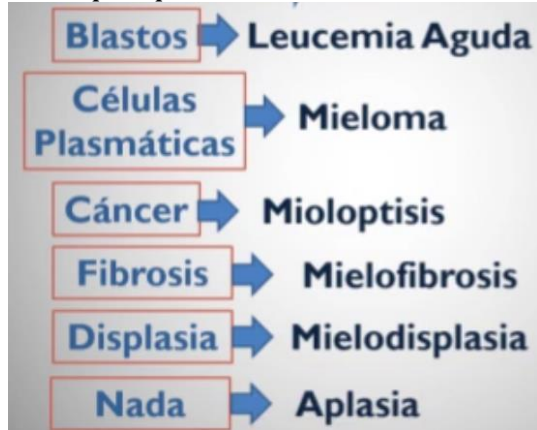
Se pregunta como adulto mayor con anemia y en el hemograma viene con VCM alto (100-108) y pancitopenia

Pancitopenia

Caída de las 3 líneas celulares

Toda pancitopenia se estudia con Bx de MO (a menos que sea muy sugerente de déficit de B12).

La biopsia puede mostrar muchas cosas:



Aplasia medular → Suele ser una enfermedad autoinmune, por lo cual, se trata con corticoides y/o inmunomoduladores, pero también puede ser 2ª a fármacos como QT o cloranfenicol.

Síndrome leucoeritoblástico

Salida de precursores medulares (leucoblastos, eritroblastos) a la sangre.

Conducta → Pedir Bx de MO

Resumen Ca hematológicos

Síntomas B → característico de Linfoma de Hodgkin, aunque pueden estar presentes en todos los Ca hematológicos

Adenopatías → Presentes en todas las alteraciones linfáticas (LLA, LLC y linfomas)

Insuficiencia medular → Se ven en leucemias agudas, LLC y en las pancitopenias (Mieloma múltiple, mielofibrosis, aplasia medular, etc.)

Esplenomegalia → Clásico de las leucemias, de los mieloproliferativos y mielodisplasias.

Dolor óseo → Característico del mieloma, pero también se ve en Leucemias agudas

Trasplante de médula ósea → Es siempre la última opción cuando las QT ya no funcionaron.

7. Urgencias oncológicas

Se preguntan EUNACOM por medio

Síndrome de vena cava superior

Es por compresión de la vena cava, clásico de Ca de células pequeñas. Se puede dar también por un linfoma del mediastino

Clínica

- Edema de cara y EESS

- Tos
- Cianosis
- Dilatación de las venas (cuello y EESS)
- Edema cerebral en casos graves

Diagnostico→ clínico

Tratamiento→ Corticoides Ev y Radioterapia de urgencia

Síndrome de compresión medular

Se da por metástasis ósea, su diagnostico es clínico (peor se complementa con RNM para ver las metástasis)

Clínica

- Paraparesia progresiva
- Hipoesteisa en EEII
- Incontinencia o retención urinaria/fecal

Tratamiento→ Corticoides Ev. Luego Cx o Rt de urgencia.

Síndrome de lisis tumoral

Suele ocurrir post QT, Clásico de Ca hematológicos.

Clínica (inespecífica)

- Rápido deterioro
- Alteraciones hidroelectrolíticas (híper K, Híper P, Hipo Ca y aumento de ácido úrico)

Tratamiento→ Soporte.

Se debe dar profilaxis ante la QT con hidratación, bicarbonato y alopurinol.

Hipercalcemia maligna

Se eleva el Calcio con PTH baja. Es clásico de cánceres epinocelulares (pulmón, esófago y piel) y hematológicos.

Clínica

- Compromiso de conciencia
- Deshidratación
- Debilidad
- Constipación
- Arritmias

Tratamiento

1. SF Ev
2. Bifosfonatos Ev (Ac zolendróico o zolendronato)
3. Calcitonina

Trombopenia maligna

Es una complicación de los Ca hematológicos y de la QT.

El riesgo es que haga una hemorragia grave.

Tratamiento→ Transfusión de plaquetas bajo 10.000 PLQ (20.00 en caso de fiebre o leucemia). En caso de que esté con hemorragias graves se transfunde bajo 100.000

Tratamientos paliativos

Tto. Paliativo No ↑vida, sí ↑calidad de vida

- **Dolor:** PCT, AINES, opiáceos (Ej. Morfina SC).
- **Obstrucción intestinal:** Haldol.
- **Disnea:** morfina.
- **Convulsión:** Midazolam, Diazepam.

8. TVP, TEP, anticoagulación y várices

Entran en varias especialidades (cirugía, respiratorio y cardio). Se preguntan siempre

TVP

Edema unilateral blando con fóvea (+) y eritema de la piel. Se presenta con dolor que aumenta al palpar las masas musculares y suele tener signos de insuficiencia venosa (telangectasias, trayectos venosos tortuosos y úlceras venosas).

Úlcera Venosa

- Ubicada en maleolo interno
- Bordes definidos
- Poco dolorosa/indolora
- Pulsos conservados
- Color violáceo

Úlcera arterial es todo lo contrario

Signo de Homans→ Dolor en gastrocnemios al dorsiflectar el pie.

Empastamiento→ Se palpan duros los gastrocnemios

Antecedentes que orientan a TVP

- Triada de Virchow (Hipercoagulabilidad, ectasia venosa y daño endotelial)
 - o Trombofilia
 - o Postquirúrgico
 - o Puerperio
 - o Cáncer
 - o Síndrome nefrótico
 - o SAF (o patologías asociadas a este como el LES)

Se estudian con eco-doppler de EEII y se manejan con **anticoagulación por 3 meses habitualmente**. Si no tengo eco, anticoagulo a ciegas porque el riesgo de TEP es grande.

TEP

Clínica

- Dolor torácico y disnea de inicio súbito que aumenta con la inspiración (pleurítico).
- Taquipnea
- Taquicardia (lo más común)
- Hemoptisis
- Pueden hacer fiebre, desaturaciones y lo mas importantes es que puede venir precedido por TVP o factores de riesgo para TVP/TEP.

MANEJO

El examen de elección es el angioTAC. Se debe **anticoagular por mínimo 6 meses**.

Como examen alternativo está el Dímero D. Esto se pide en paciente con baja sospecha de TEP. Si sale negativo descarta el TEP (Alto VPN) si sale positivo debo ir a descartar con angio TAC.

EKG→ Suele mostrar taquicardia sinusal y puede mostrar el patrón característico S1Q3T3.

Rx Torax→ Suele ser normal

TEP masivo

Misma clínica de TEP + hemodinamia inestable (hipotenso + ingurgitación yugular).

El manejo es distinto.

El examen que se toma es el ecocardiograma. Este muestra hipertensión pulmonar

Tratamiento→ Trombolisis Ev

Por lo tanto, ante una pregunta de TEP, SIEMPRE FIJARSE EN LA PRESIÓN ARTERIAL

Anticoagulación

Heparina

- Fraccionada (HBPM)→ No requiere control con ningún examen, es de elección en pacientes ambulatorios que no pueden ocupar cumarínicos.
- No fraccionada→ Se controla con TTPA. LA idea es llevarlo a 1,5 veces el basal. Debe ser controlado cada 4 horas. Se administra hospitalizado por BIC con control c/4hrs.
- TACO (cumarínicos)→ Warfarina y acenocumarol, se controla con INR, dejándolo entre 2-3. Es de manejo ambulatorio

RAM de todas→ Hemorragias

No fraccionada→ trombopenia, osteoporis

HBPM→ daño renal

TACO-→ Interacción medicamentosa

Várices

Al diagnóstico es clínico (Aumento de volumen de venas, edema de extremidades, úlceras varicosas y signos de insuficiencia venosa)

Manejo→ Vendaje compresivo y ejercicio. En casos graves se puede operar con safenectomía.

No hay fármacos muy útiles para su manejo. Si sangran (generalmente por trauma) el manejo es con compresión y por ultimo suturar (se preguntó 1 vez).

Resumen Guevara by Creggers y Nicoletta

Cirugía

Son 10 preguntas fáciles, 5 suelen ser de cirugía digestiva y vascular y 5 de cirugía general (hernias, flegmones, absceso, etc)

1. Fiebre post quirúrgica

Causas (5W)

- **Wind:** Atelectasias (la más común dentro de las primeras 24 horas), neumonía, TEP: **RxTx**
- **Water:** ITU: **OC y UC**
- **Wound:** Infección herida operatoria (la más frecuente después de las 48 horas), dehiscencia anastomosis: **revisar herida**
- **Wonderful Drugs:** RAM como el Steven Johnson, Sd. De Sweet, hipertermia maligna (La más frecuente como fiebre inmediata)
- **VVeins:** TVP/ TEP, tromboflebitis

Complicaciones cirugía

- **Seromas**

Clínica: Edema, Equimosis/dolor, salida de líquido por herida

Dg: clínico

Tto: curaciones y drenaje aspirativo, buen pronóstico

- **Hematoma**

Clínica: Aumento de volumen, dolor, acumulación de sangre

Dg: clínico (ecografía)

Tto: Drenaje quirúrgico (riesgo de infección)

- **Eventración**

Vísceras protruyen por pared abdominal. Hay saco peritoneal (hernia incisional)

Dg: Clínico

Tto: Quirúrgico

- **Evisceración**

Vísceras protruyen por herida quirúrgica, no hay saco peritoneal.

Dg: clínico

Tto: Quirúrgico

- **Dehiscencia de anastomosis**

Clínica: Filtra la anastomosis del tubo digestivo: dolor, vómitos, Blumberg (+), signos peritoneales marcados

Dg: Clínico

Tto: Cirugía urgencia

2. Clasificación herida quirúrgica

- A) Limpia: no abre mucosas: no ATB
- B) Limpia contaminada: abre mucosas (GU, GI, respiratoria): Profilaxis ATB
- C) Contaminada: por cortar tejido inflamado, o por pérdida de asepsia: Profilaxis ATB
- D) Sucia o infectada: En contacto con heces/pus, celulitis clínica o erisipela: tto ATB

Profilaxis: antes o durante cirugía

Tto ATB: 7 a 10 días

- Apendicectomía: limpia contaminada: ceftriaxona+metro
- Mastectomía: Limpia
- Endarterectomía: Limpia
- Cesárea: Limpia contaminada: cefazolina
- Drenaje absceso: sucia
- Colecistectomía: Limpia contaminada
- Prostatectomía: Limpia contaminada
- Hernioplastia: Limpia

Infección herida operatoria

- ATB profiláctico (LC y C)
- Técnica aséptica quirúrgica
- Dar de alta lo antes posible (IAAS)

Dg: clínico

Tto: ATB, depende si abre mucosa o no:

- Mucosa abierta: GI: ceftriaxona-metro, Resp: ceftriaxona, Gine: Cefazolina
- Mucosa cerrada: cubrir aureus y pyogenes (G+): cefazolina/cloxacilina

3. HERIDAS – ESCARAS – QUELOIDES

MANEJO HERIDAS

- Aseo: SF para remover suciedad
- VAT: todas las heridas según esquema
- ATB: solo si sucia, masiva o infectada (exposición músculo)
- Sutura: Grande, profunda, deformante (herida abrasiva o sucia no suturar)
- Analgesia: AINES
- Curaciones: con SF, clorhexidina aún se usa

Profilaxis antitetánica:

- hace menos 10 años: nada
- Mas de 10 años: booster
- Incompleto (mínimo 3 dosis): completar 3 dosis (separadas por 1 mes c/u).
- Nunca se ha vacunado y sucia: completar + IgG antitetánica

Suturas

- No absorbible: retirar puntos a los 7 días, nylon, ethylon
- Absorbible: No se retiran, catgut. Se usa en puntos a nivel de músculo y TCSC e intradérmicas (cara)

Hemostasia: comprimir, sutura es secundario. Sangramiento arterial: ligadura

Escaras

Úlcera por presión o decúbito

Clínica: paciente inmóvil, postrado, inconsciente, herida en zona de apoyo y/o presión

Clasificación:

- I: eritema (no blanquea)
- II: Hasta dermis
- III: Tejido celular o esfacelado
- IV: tendón, músculo, hueso

Tto: Cambios de posición, prevención MÁS importante. **Debridación química con hidrogel.** Nutrición paciente, soporte, etc.

Indicación de cirugía: Infección (halo eritematoso grande, pus) grado III y IV que no curen.

ATB amplio espectro para infección y cirugía

Cicatriz patológica

- a) Queloide: Genética, sobrepasa bordes de herida, tto: remoción + parche silicona + corticoide y/o radioterapia. Riesgo de recidiva
- b) Cicatriz hipertrófica: exceso de tensión, respeta bordes de herida. Tto: remoción, afrontamiento sin tensión. Sin riesgo de recidiva

4. PIEL

Furúnculo

Asociado a foliculitis. Pústula en relación a un pelo, puede absedarse.

Complicación + grande: ántrax

Dg: clínico

Tto: Observar, si muy grande ATB (cloxa), drenaje quirúrgico. Ántrax: cirugía

Abscesos

Aumento de volumen fluctuante. Signos inflamatorios, eritema + dolor. Contenido: pus

Dg: clínico (superficial) + imagen (eco o TAC retroperitoneal)

Tto: drenaje quirúrgico (box o pabellón)

Flegmones

Clínica: Aumento de volumen: edema, signos inflamatorios, fiebre, no forma tercer espacio (sin colección de pus)

Dg: clínica + imagen (eco o TAC) diferencia con absceso

Tto: ATB (no se opera)

Panadizos

Clínica: Aumento de volumen de los dedos (falange distal) al lado de uña + común (paraungueal o paroniquia)

Dg: clínico

Tto: por aureus o s. pyogenes (cloxa/cefadroxilo)

Onicocriptosis (uña encaranda)

Clínica: dolor + paroniquia. Tiene riesgo de hacer celulitis u osteomielitis (GRAVE)

Dg: clínico. Prevención: corte recto de uñas.

Tto: depende de grado de compromiso o infección sistémica (operar). **Cx de elección: matricectomía química con fenol. Onicectomía NO ES DE ELECCIÓN**

5. Hernias

Inguinal (diferenciado por vasos epigástricos inferiores)

- a) Indirecta: anillo inguinal. LA MAS FRECUENTE en **hombres** y mujeres
- b) Directa: atraviesa triángulo Hesselbach. + freq en hombres
- c) Femoral: atraviesa triángulo femoral. + freq mujeres

Umbilical

Lumbar: petit

Spiegel: lateral al recto abdominal (cara anterior)

Complicaciones

- Atascada/ encarcerada: irreductible, dolorosa
- Estrangulada: + compromiso vascular (examen físico aspecto violáceo)
- Obstrucción intestinal: dolor cólico + vómitos alimentarios o fecaloideos + distensión abdominal

Tto:

- No complicada. Cirugía electiva
- Complicada: cirugía de urgencia: hernioplastía
- Excepción: hernia umbilical no complicada en niños menor 4 años (a esa edad no se opera, puede desaparecer de manera espontánea hasta los 4 años)

Obstrucción intestinal

Triada: Dolor abdominal tipo cólico + vómitos alimentarios y luego fecaloideos + distensión abdominal. Imposibilidad de eliminar gases, RHA + (bazuqueo intestinal) y luego silencio abdominal, abdomen en tabla, etc. (cuando evoluciona a peritonitis)

Dg: clínico (+ **rx abdomen simple** que ve asas dilatadas y niveles hidroaéreos) TAC abd: orienta a causa.

Tto: cirugía (+SF y ATB)

Causas:

- Adherencias y bridas: atc de cirugías previas

- Hernias
- Vólvulo de sigmoides: rx imagen en grano de café
- Ca de colon: anemia, constipación, baja de peso previa
- Ileo Biliar: triada distensión asas + pneumobilia + cálculo

6. Mordeduras – quemaduras

Mordeduras

Perro – gato (usual en lactantes) – humano

1. Lavado con jabón (1ª medida, en casa)
 2. Aseo SF
 3. VAT
 4. VAR: no se deja siempre. No tiene CI pues la enfermedad es gravísima
- Indicaciones: contacto con murciélago, animal no observable, animal sintomático o que se muere, animal salvaje raro
5. ATB: amoxi-clav Cubre S.aureus, Pasteurella y otros en boca/hocico.
- Se deja ante: Mordedura por gato (70% se infecta), humano, herida masiva, en reacción a hueso/articulación (riesgo osteomielitis o artritis séptica) y ante una mordedura infectada. Profilaxis 5 días, tto 10 días
6. Manejo heridas: no se suturan, a menos que sea muy grande y antes se debe limpiar

Quemaduras (se pregunta EUNACOM por medio)

Contacto con fuego – líquidos calientes – etc

1. ABC
2. Hidratar con cristaloides, SF (medida más importante)
3. Analgesia agresiva: AINEs, opiáceos, etc
4. VAT
5. ATB? **NO**
6. Qx: grado B (o AB con mala evolución) y tipo circular en extremidades (cara, manos, pies tb)
7. Manejo heridas: curaciones + cobertura (excepto cara y periné). Flictenas se remueven, las leves se dejan.

Clasificación

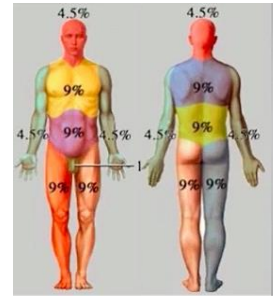
- a) A epidermis:** rojo y duele mucho. Quemadura solar + flictenas. Curación en 7 días espontánea.
- b) AB dermis:** rojo pálido no tan intenso, dolor piola. Sensibilidad, llene capilar, estado de folículos pilosos (diferencia si es Aba o ABb). Curación espontánea en 14 días vs Qx.
- c) B completo:** Blanco o negro, indolora. Sin flictenas y sin dolor. Escarectomía de tipo precoz.

Superficie

Regla de los 9% o Palma de la mano 1%. En niños es distinto

Manejo especial

- **Cara:** intubar por riesgo quemadura vía aérea. No cubrir con apósitos
- **Periné:** no cubrir
- **Manos:** Separar bien dedos y luego cubrir.
- **Eléctricas:** empeoran con el tiempo, interna. Hospitalizar siempre. Pedir Ck + ECG. Si hay rabdiomiolisis: dar SF + NaHCO₃.



7. Lesiones hepáticas

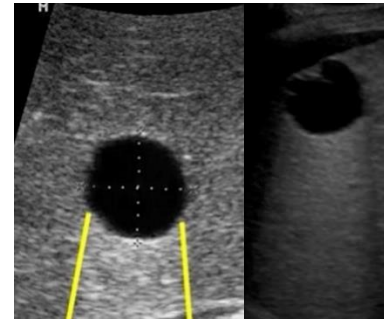
Se preguntan siempre

Quiste hepático

Clínica: asintomático, hallazgo

Dg: Ecografía. Anecogénico (negro) con refuerzo posterior. Sin bordes y sin tabiques

Tto: Observar



Quiste hidatídico

Clínica: asintomático, hallazgo eco

Dg: Ecografía. Anecogénico. Refuerzo posterior. CON BORDES Y/O TABIQUES

Tto: Albendazol x 6 semanas. Cirugía o inyectoterapia (Suero hipertónico). Si quiste se rompe en cirugía puede haber riesgo de siempre y/o shock anafiláctico.



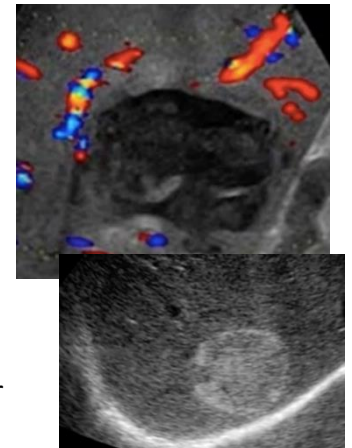
Absceso hepático

Clínica: fiebre + dolor + ictericia (todos leves)

Dg: ecografía. Quístico hipoecogénico, sin flujo en el Doppler (diferencia con hepatocarcinoma).

Tto:

- Amebiano: Metronidazol ev (raro drenar)
- Bacteriano: ceftriaxona + metronidazol + drenar (quirúrgico o punción)



Hemangioma

Clínica: Asintomático. Hallazgo

Dg: ecografía. Hiperecogénico, homogéneo.

Tto: Observar (hamartoma vascular, no se complica). >10 cm → operar por riesgo de sangrado



Adenoma hepático (benigno)

Clínica: hallazgo, asintomático. Puede tener antecedente de uso de ACO, DHC, VHC/VHB.

Dg: Ecografía: hipoecogénico, único, homogéneo.

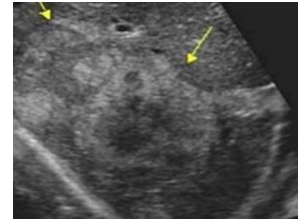
Tto: Qx: resecar (riesgo de malignizar)

Hepatocarcinoma

Clínica: hallazgo o descompensación de DHC (principal FR para Ca de hígado es el DHC). Antecedentes: uso ACO, DHC, VHB, VHC.

Dg: Ecografía → TAC/RMN: TU grande, heterogéneo

Tto: Qx: único curativo, trasplante en caso de que su DHC esté muy avanzado.

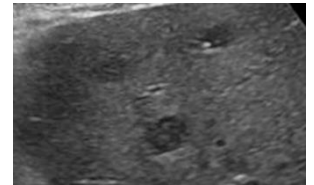


Metástasis hepáticas

Clínica: De Ca primario. Baja de peso, CEG, anemia, debilidad, etc. DHC.

Dg: Ecografía: Hipoeecogénico (algunas son hipereecogénicas). Múltiples.

Tto: depende del primario.



Pólipos biliares (se han preguntado)

Colesterolínicos	Neoplásicos
Benignos	Riesgo Cancer
Sin cálculos ni colecistitis crónica	Cálculos, vesícula en porcelana o escleroatrófica.
<1 cm, homogéneos, no crecen	>1 cm, heterogéneos, crecen
Manejo: seguimiento eco	Manejo: BxCx: colecistectomía laparoscópica.
	Sospecha Ca vesícula: cole abierta

8. Trauma abdominal y torácico

Se pregunta siempre

Trauma abdominal cerrado

Manejo: Evaluar clínica + eco fast

- Observación: clínica ok, eco fast sin alteraciones → contusión
- Exploración quirúrgica: HDN inestable, Signos peritoneales, eco: líquido libre (lavado peritoneal diagnóstico NO SE HACE)
- Rotura víscera hueca/sólida: hueca va a ser clínica con signos peritoneales + aire y líquido libre. Sólida: clínica shock hipovolémico.

Trauma abdominal por arma blanca

Manejo: Evaluar clínica + exploración digital (Con anestesia local, se explora)

- Sutura: Todo ok, no llega al peritoneo (superficial grasa/músculo)
- Exploración Qx: HDN inestable, signos peritoneales (+), llega al peritoneo o aponeurosis de músculo (se sospecha rotura de víscera hueca)

Trauma abdominal con arma de fuego

CIRUGÍA ALWAYS

Trauma de tórax cerrado

Manejo: clínica + RxTx.

Soporte: O2 + ventilación

Manejo complicaciones:

- a) Neumoórax a tensión → punción 2° EIC
- b) Taponamiento pericárdico → pericardiocentesis
- c) Hemotórax → Tubo pleural
- d) Neumotórax → Tubo pleural
- e) Contusión → Soporte

Trauma torácico arma blanda

Manejo: clínica + RxTx.

Igual que trauma cerrado

Trauma torácico arma de fuego

CIRUGÍA YES O YES

9. Patología perianal

Se pregunta siempre, 2 o 3 preguntas del EUNACOM

Fisura anal aguda (+ preguntada)

Clínica: atc de constipación (bolo fecal muy grande, rompe el ano). Dolor anal que inicia con la defecación + rectorragia postdefecación. Síntomas de repiten al defecar. Esfínter interno es la causa del dolor

Dg: Examen anal

Tto: baños de asiento (calor húmedo) → para relajar esfínter interno. Tratar la constipación (dieta rica en fibra + agua + laxantes opcional)

Fisura anal crónica

Clínica: Lo mismo pero >6 semanas o que recurre

Dg: examen anal

Tto: Baños de asiento + laxantes si o si (PEG o lactulosa) se opera si no responde a tto médico. Esfinterotomía del EA interno (no externo pq quedaría con incontinencia fecal).

Hemorroide externo trombosado

Los externos se trombosan, los internos sangran.

Clínica: Dolor anal intenso no relacionado a la defecación, de inicio agudo. Aumenta el dolor al defecar y al sentarse

Examen físico: Aumento de volumen de color violáceo perianal (AFUERA del ano)

Dg: examen anal

Tto: discutible. Baños de asiento si o si. A veces trombectomía si lleva menos de <48-72 hrs. Un hemorroide trombosado crónico puede dejar un plicoma.



Hemorroide interno

Clínica: Hematoquezia. No duele

Dg: Rectoscopia o colonoscopia (objetivar HDB, buscar CA)

Tto: cirugía electiva → ligadura. + tratamiento constipación (se relacionaría con formación hemorroides)

Complicaciones: Prolapso y fluxión hemorroidal. Prolapsos tienen grados, de 1 al 4.

1: No salen

2: Reducción espontánea

3: Reducción manual

4: Irreducible



Fluxión hemorroidal

Clínica: Dolor anal de inicio agudo. Patología anal más dolorosa. Aumento de volumen que protruye por el ano. El hemorroide externo trombosado estaba afuera, en cambio este es un hemorroide interno que atraviesa el ano y se trombosa afuera.

Dg: inspección anal

Tto: Controvertido → Qx de urgencia vs. Tto conservador (baños de asiento). Actualmente la mayoría se inclina a operarlos siempre pero no inmediatamente, mejor dejar que pase la inflamación.



Absceso perianal

Clínica: dolor anal que va en aumento. Sin inicio súbito. También aumenta al defecar y sentarse. Aumento de volumen eritematoso y de aspecto fluctuante (contenido es pus que fuctúa)

Dg: Examen anal

Complicaciones: Fístula y absceso pelvirectal

Tto: QUIRÚRGICO. No en box, drenaje en pabellón. ATB no sirven en este caso, lo importante es el drenaje

Fístula perianal

Clínica: Absceso perianal que se abre a la piel y empieza a gotear pus (que cerdo ctm). Puede localizarse lejos del ano

Dg: examen anal

Tto: Quirúrgico. Drenaje + remover trayecto de fístula

Abseso pelvirectal

Clínica: Absceso perianal + fiebre (sepsis) + signos de irritación vesical + mucho dolor al defecar (todo está inflamado). Dg diferencial de prostatitis aguda!

Dg: TAC o RMN de pelvis. Primero confirmar el absceso, tamaño y localización.

Tto: Quirúrgico, drenaje en pabellón + ATB de amplio espectro (ceftriaxona + metro)

10. Patología pilonidal

Se ha preguntado en el último tiempo

Quiste pilonidal

Clínica: aumento de volumen en zona sacrococcígea. Solevantado o hoyuelo con salida de secreción o con pelos. Asintomático de muchos años (congénito).

Dg: Clínico

Complicaciones: Fístula y absceso pilonidal

Tto: Asintomático → observar. Complicado o con clínica → cirugía (drenaje de absceso).

Si recurre hay que hacerle una extirpación. Si está infectado agregar ATB

Absceso pilonidal

Fosita pilonidal y seno (pediatria)

Fosita: hoyito en zona sacrococcígea (no es signo de espina bífida y shits)

Seno pilonidal: aumento de volumen en zona sacrococcígea. Dg clínico. CON RIESGO DE DISRAFIA! Hacer eco y estudiar.

11. Tumores de partes blandas

Quiste sebáceo (epidérmico)

Clínica: Aumento de volumen en alguna zona de la piel (neo benigna). Móvil. Puede venir con poro central que da salida a material sebáceo.

Complicaciones: Absceso

Dg: Clínico

Tto: Observación. Si es muy grande resección qx. Si se formó absceso → ATB (cloxa) + qx y drenaje

Quiste dermoides

Clínica: aumento de volumen MÓVIL. Sospecha según ubicación característica:

- Cola de las cejas
- Piso de la boca

Dg: clínico

Tto: Observación a menos que sea muy grande o complicado (infección) → resección. Se opera más que el epidérmico.

Lipoma

Clínica: Aumento de volumen de consistencia blanda. Más duro que la grasa en general. Adherido a planos profundos. La piel que está sobre él es muy móvil. Tumor benigno.

Generalmente <5 cm

Dg: Clínico. Si tengo duda hago una eco de partes blandas

Tto: Observación. Si mide >5cm o crece muy rápido → hacer biopsia excisional por sospecha de sarcoma de partes blandas.

Sarcoma de partes blandas

Clínica: aumento de volumen rápido grande (10-20 cm). Consistencia similar al músculo (+ duro pero no pétreo) Adherido a planos profundos + adherido a la piel.

Dg: RMN de elección (ecografía si no) + Biopsia histológica por punción. Hay que resear todo lo que tocó la aguja pq los sarcomas se siembran.

Tto: qx + quimioterapia + radioterapia. Ver si hacer resección (conservadora) vs amputación del miembro donde está el sarcoma (agresivo). Si es un TU muy grande, empezar con quimio + radio para achicar el TU y salvar la extremidad.

Pronóstico: grado de diferenciación histológica.

12. Trauma cervical y raquimedular / maxilofacial/ heridas cara y cuero cabelludo

Trauma raquimedular

Riesgos: sección medular (tetraplético si es cervical alto, paraplejia si es baja) y shock medular.

Causas: Accidente tránsito + caídas

Manejo: ABC. A: no solo vía aérea sino que tb collar cervical. Para la movilización de los pacientes hay que usar una tabla espinal (si se mueve la columna puede desencadenar que se haga una sección medular). Si viene con compresión → cirugía. Si viene con shock medular es shock vasodilatador así que el tto es SF + drogas vasoactivas (BIC nordrenalina o norepi)

Estudio: TAC de columna, obligatorio ante sospecha. Si el paciente está bien, al momento de sacarlo de la tabla examinar la columna palpando vértebras, buscando signo de fractura.

Esguince cervical

Clínica: Dolor cervical sin déficit neurológico.

Causa: accidente de tránsito

Manejo: ABC + collar cervical. Pedir mínimo rx. Lateral de cuello. Como alternativa si se sospecha alguna lesión pedir TAC.

Con rx normal: analgesia + collar cervical blando (sólo evita movimiento).

Traumatismo maxilofacial

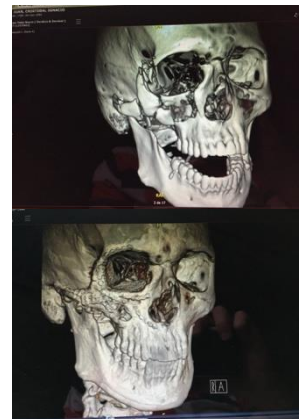
Riesgo: estético + vía aérea (fx ambas ramas mandibulares) + daño cerebral.

Manejo: ABC + tac de cara. Rx es examen mínimo.

Con rx normal: AINES

Con lesión grave: cirugía (no es urgencia, se difiere al día 7-14 para esperar a que baje edema). Lo mismo para fx nasal, órbita y cara.

Fx mandibular bilateral: TOT (intubar pq pierde vía aérea)



Creggers y su Le Fort I, II y III
Ocupen cinturón

Heridas de cara

Generalidades

Riesgo: estético. Buena irrigación por lo que no se infecta, Buena cicatrización (rápida)

Sutura: Cuando son muy grande, muy profundas, deformantes. Sutura intradérmica idealmente (con seda o nylon, o reabsorbible ideal)

Laceración labios, oreja nariz (afectación muscular) → Sutura por plano por especialista.

Los planos profundos se usa reabsorbible y los superficiales no absorbible

Herida cuero cabelludo

Manejo: buena irrigación, no ATB.

No Se usa sutura, se usan grapas o corchetes (más fácil) No es obligatorio afeitar la zona.

13. Estenosis carotídea/disección/disección vértebra

Estenosis carotídea

Clínica: Asintomático, a lo más soplo cervical. Síntomas: TIA o ACV

Causa: FRCV. Etiología ateromatosa, displasia fibromuscular, Takayasu (mujer joven)

Dg: Ecodoppler de cuello o carótida. Hay estenosis cuando es >50%, si es menor, se considera como presencia de placa de ateroma

Tto: Observar y tratar FRCV si es de etiología ateromatosa. Qx cuando >70% y cuando >50% + síntomas(TIA o ACV). Cx con endarterectomía

Disección carotídea y vertebrobasilar

Clínica: Antecedente de ejercicio o elongación cervical + dolor cervical + cefalea (en trueno o thunderclap, se inicio súbito).

Clínica de AVE: depende si es disección de carótida o de sistema vertebrobasilar.

Carotídea: clínica de ACM o ACA

Vertebral: clínica de isquemia de ACP o troncoencéfalo.

Dg: AngioRMN o AngioTAC (se usa +)

Tto: Anticoagulación con heparina, es raro, PERO HAY QUE EVITAR QUE SE FORME UN TROMBO. Si está obstruyendo mucho hay que operar y asegurar irrigación cerebral.

14. Cirugía pediátrica

Pregunta segura

Enterocolitis necrotizante

Clínica: RN día 2-7, con triada: vómitos + distensión abdominal + hematoquecia.

Causas: prematuro , asfixia o sepsis neonatal

Dg: Rx simple de abdomen. Se ve: dilatación de asa, neumatosis intestinal, neumoperitoneo (signo de perforación)

Tto: régimen O + SF + ALPAR + ATB por traslocación bacteriana.

Tto quirúrgico cuando hay:

- Perforación
- Estenosis
- Fístula
- Muy grave, complicación anatómica

Intususcepción Intestinal

Clínica: Lactante entre 6m – 1 año. Dolor abdominal intenso (crisis de llanto), puede ceder. Característico → hiperflexión de caderas. Hematoquezia (mermelada de grosella, frutilla). Masa palpable en cuadrante inferior derecho.

Causas: idiopático (intestino se “arremanga”), divertículo de Meckel, pólipo

Dg: Ecografía abdominal. Se ve signo de la dona o en target o tiro al blanco, signo de la herradura (corte longitudinal/oblicuo)

Tto: descompresión neumática, si no funciona hidrostática y si no se puede va a cirugía.

Divertículo de Meckel

Clínica: Niño de cualquier edad, asintomático, se complica con HDB grave. Otra complicación es una diverticulitis (similar a apendicitis)

Causa: congénito. Persistencia del conducto onfalomesentérico (no es completo, si lo fuera sería una fístula)

Dg: con sospecha de hemorragia → Cintigrafía con tecnecio. En esa zona hay mucosa gástrica

Tto: resección quirúrgica

Pólipo juvenil

Clínica: Escolares o preescolares. HDB leve y recurrente (historia clásica de recurrencia intermitente de rectorragia). Resto del examen físico normal

Causa: hamartoma vascular (desde que nace)

Dg: colonoscopia

Tto: resección colonoscópica.

Hematemesis en el lactante

Causa: sangre deglutida del pezón., otras causas como UGD, gastritis, ECN.

Manejo: test de apt-downey. Si cambia a color amarillo → es sangre adulta → observar. Si queda de color rojo → sangre fetal → SF + EDA.

Hernia diafragmática congénita

Clínica: RN. Dificultad respiratoria grave → hipoplasia pulmonar. Se auscultan RHA en tórax, abdomen excavado

Dg: RxTx. Ve imágenes circulares (asas intestinales) en tórax.

Tto: intubar + soporte ventilatorio (ventilación de alta frecuencia). Luego, reparación quirúrgica diferida.

Atresia esofágica

Clínica: RN. Sialorrea + dificultad respiratoria (por aspirar su propia saliva y/o asociación a malformación via aerea)

Causa: Malformación congénita. Fístula traqueoesofágica el 80%.

Dg: SNG + Rx tx

Tto: cirugía (restaurar tránsito)

Atresia duodenal

Clínica: RN desde día 1 con vómitos postprandiales. Signos de deshidratación.

Elimina meconio blanco

Causa: malformación congénita.

Dg: Rx de abdomen → doble burbuja

Tto: quirúrgico.



Estenosis hipertrófica pilórica

Clínica: RN entre semana 2-6, vómitos postprandiales + signos deshidratación (avidez por lactancia, poca orina, icterico) Antecedente de uso de eritromicina en el embarazo.

Causa: Idiopática

Dg: Ecografía: oliva pilórica engrosada (píloro engrosado) se puede palpar el píloro (se supone).

Dg. Diferencial: Hiperplasia suprarrenal congénita (esto viene con hipokalemia + alcalosis, la insuficiencia suprarrenal es hiperK y acidosis).

Tto: cirugía → pilorotomía de Ramstedt.

Enfermedad de Hirschsprüng

Clínica: RN con retraso de eliminación de meconio (se espera hasta 48 hrs, después de eso es patológico). Clínica de obstrucción intestinal incompleta.

Causa: ausencia de neuronas de plexos mientéricos/submucoso. "aganglioneosis"

Dg: rx. Baritada o manometría del colon (se ve hipertonía de la muscular). Confirmación: biopsia por succión

Tto: quirúrgico, resección de segmento comprometido + anastomosis término terminal

Ano imperforado

Clínica: RN que no elimina meconio + signos obstrucción intestinal + examen físico sin ano

Causa: malformación congénita (asociado a sd. Down)

Tto: cirugía

15. Úlcera perforada, perforación esofágica, e ingesta de soda caustica

Se pregunta con cierta frecuencia

Úlcera perforada

Clínica: Atcd de sd. Ulceroso (aumenta con ayuno, disminuye con ingesta alimentos), Dolor epigástrico muy intenso (en puñalada) + signos peritoneales +++++. Con abolición RHA y abdomen en tabla.

Dg: RxTórax de pie, si no sale de **tórax**, marcar Rx **abdomen** de pie (buscar neumoperitoneo, por la salida de gas de vísceras huecas)

Tto: Cirugía urgente + sutura úlcera (con parche de omento o epiplón). Luego erradicar *helicobacter*. Además, SF ev + omeprazol ev + ATB ev

Perforación esofágica

Clínica: disfagia + dolor torácico o cervical (depende de donde). Puede venir con vómito por irritación. Enfisema subcutáneo (aire en la piel), se palpa como aumento de volumen crepitante.

Causas: secundarias a EDA, por cuerpo extraño, sd. Boerhaave (perforación por vomitar mucho)

Dg: RxTx. Se busca neumomediastino. 2ª línea: TAC (por complicación de mediastinitis). NO HACER ENDOSCOPIA.

Tto: cirugía urgente !!. Además, régimen 0 + ATB. Si fuera mínima puede no operarse (conservador)

Ingesta soda cáustica

Clínica: dolor boca hasta abdomen y/o HDA. Signos peritoneales si hubo perforación de vísceras.

Manejo: EDA precoz!!! Según lo que muestre:

- Normal: observación + ingesta de líquidos
- Inflamación: régimen 0 + nutrición parenteral + EDA control
- Inflamación severa, necrosis, perforación: quirúrgico + nutrición parenteral.

No dar carbón activado (contraindicado). Tampoco sirve el lavado gástrico

16. Hernia hiatal, hernia diafragmática y tumor mediastínico

En general se preguntan poco, pero aparecen dentro de los distractores

Hernia diafragmática

Causa: trauma abdominal o torácico (da igual si es abierto o cerrado)

Clínica: según fase

- Fase aguda: dolor, pero mayoría asintomático porque los síntomas del trauma (de alta intensidad generalmente) ocultan los síntomas de la rotura diafragmática.
- Fase crónica: asintomática vs complicada (obstrucción, incarceration, etc)

Dg: Rxtx, se ven asas intestinales en el tórax

Tto: qx urgencia en agudo, en la fase crónica como en todas las hernias es electivo, cuando llega complicada es qx de urgencia

Hernia hiatal

Clasificación:

- Tipo 1: >95% de los casos. Hernia por deslizamiento. Estómago atraviesa el diafragma por hiato. Es asintomática, pero si se complica puede tener reflujo. Tto: observar, tto RGE
- Tipo 2: <5%, hernia paraesofágica (hernia real). Se complica con estrangulación, etc. Tto: cirugía electiva, o si esta complicada es de urgencia

TU mediastino

Causas: depende de que parte está

- Mediastino posterior (más frecuentes): origen nervioso, neurinomas, schwannomas
- Mediastino medio: de origen pericárdico y bronquial
- Mediastino anterior: las 4 T. Timoma, teratoma tiroides y el terrible linfoma.

Dg: TAC de tórax ante hallazgo de masa o mediastino ensanchado en Rctx.

Tto: según causa (benignos, evolución normal)

Manejo de Timoma: Observar, no es grave. La excepción es MIASTENIA GRAVIS. En ese caso se indica cirugía para extirparlo.

17. Cáncer de mama

Pregunta segura

1° causa muerte por Ca en mujeres (luego Ca gástrico, luego pulmón)

Estudio mujer asintomática: screening, anual(incluso Bianual) desde los 40 años.

MINSAL desde los 50 años. Si se palpa un nódulo mamario, hay que empezar los estudios antes

BIRRADs:

- Birrads 0: no concluyente. Conducta → eco mamaria
 - Birrads 1: mama normal. Conducta → observar evolución normal, mantener control mamográfico
 - Birrads 2: alteración benigna (quiste). Conducta → Lesión benigna, mantener control
 - Birrads 3: probablemente benigno. Conducta → puede complementarse con eco, pero **mamografía cada 6 meses** (marcar eso en examen)
 - Birrads 4: Lesión sospechosa de Ca. Conducta → biopsia histológica
 - Birrads 5: Probable lesión cancerígena . Conducta → Biopsia quirúrgica

Clínica: nódulo mamario duro, adherido a piel y planos profundos, inversión de pezón o piel de naranja, secreción mamaria hemática, adenopatías axilares (metástasis más frecuente). El autoexamen sirve para detectar un nódulo mamario.

*Variante inflamatoria Ca de mama → Simula una celulitis, es de diagnóstico super malo, avanza muy rápido.

Metástasis a: axila, huesos, pulmones (en estos 2 casos ya pasa a estar fuera de alcance terapéutico)

Pronóstico: según tiene o no adenopatías (axilares)

Biopsia: técnica histológica. No sirve aguja fina, en general se hace con un mamótomo. Trucut o estereotáxica (guiada bajo eco).

Factores de riesgo: Oncogenes (antecedentes familiares) BRCA 1 y 2, y p53. Si alguien tiene esos genes, es indicación relativa de mastectomía radical preventiva. Otros factores de riesgo son todo lo que estimule los estrógenos, tal como ACO y TRH, menarquia precoz, menopausia tardía.

Tratamiento:

Qx:

- Mastectomía parcial, luego se hace también vaciamiento axilar o disección axilar, cuando hay adenopatías clínicas o cuando biopsia Linfonodo centinela es (+) (con medio de contraste)

- Mastectomía total: cuando sea multicéntrico (más de 1 foco), bilateral, presencia de oncogenes (BRCA1, BRCA 3 y p53), desproporción Tumor/Mama (tumor muy grande en relación a la mama)
- Luego reconstrucción mamaria inmediata o retardada.

RT: postquirúrgica, previene recidiva local. Se hace siempre excepto: <5cm de tu, histología favorable (bajo grado de diferenciación, sin invasión linfática y con receptores de E y P).

QT: en Ca avanzado (metástasis).

Hormonoterapia: En Ca avanzados, se hace con tamoxifeno, inhibidor de receptor de estrógeno y progesterona. Solo se indica cuando están presentes esos receptores (es mejor que estén presentes)

Inmunoterapia: solo indicado cuando hay sobreexpresión de los genes HER2 o ERB2, se usa anticuerpo monoclonal trastuzumab.

18. Patología benigna de mama

Se pregunta siempre (Gine y Cx)

Fibroadenoma

Es lo que se pregunta más

Clínica: mujer joven. Nódulo mamario de consistencia gomosa, no pétreo. **Es muy móvil.**

Dg: ecografía mamaria. Se ve un Tu sólido, bien delimitado, capsulado. NO SE PIDE MAMOGRAFÍA

Conducta: ecografía mamaria cada 6 meses por 2 años, si está bueno seguir control normal.

Quiste simple mama

Clínica: nódulo mamario de bordes lisos, consistencia varía de blando a tenso (según cantidad de líquido). Puede doler.

Dg: PAF o **ecografía (elección)**. Con PAF, si sale sangre o era sólido, es sospechoso de Ca. Si la Eco ve un quiste se hace el diagnóstico y no es necesario PAF.

Conducta: mamografía anual, solo observación. PAF si tuviera dolor. Qx si fuera gigante o molesto (mucho riesgo de recidiva)

Mastopatía fibroquística (más frecuente)

Clínica: Aumenta la frecuencia a medida que aumenta edad, termina con la menopausia.

Síntoma principal es mastalgia. Mamas se palpan fibroquísticas y multinodulares

Dg: ecografía mamaria. Se van a ver múltiples quistes y/o fibrosis.

Conducta: mamografía sí, educar sobre que no es cáncer ni se va a transformar en Ca. Se le puede dar AINES como el ácido mefenámico. Indicar control mamográfico anual.

Mastalgia

Causas: premenstrual y mastopatía fibroquística

Conducta: anamnesis y examen físico. Educar y AINES (ácido mefenámico). Educar y control mamográfico anual

19. Anestesia

Probablemente no se pregunte

Evaluación preanestésica

Objetivos: evaluar y minimizar el riesgo, evaluar vía aérea, elegir tipo de fármacos.

Completa anamnesis y examen físico, anamnesis remota, revisar exámenes y medicamentos actuales (suspender TACO y AAS, generalmente 5 días antes. También suspender AINES 2 días antes)

Riesgo anestésico

Clasificación ASA

- I: Sano
- II: Enfermedad crónica, pero compensada
- III: enfermedad crónica descompensada, con daño a órganos
- IV: riesgo vital (ICC con EPA)
- V: paciente moribundo (muy probable que se muera)
- VI: es controvertido, es el paciente en muerte cerebral que le vas a dar fármacos para mantener órganos vivos para transplante

Riesgo anestésico

Se evalúa en base a cada uno de los sistemas. Cardiovascular y respiratorio son los de mayor riesgo

Riesgo cardiovascular: ICC severa, **IAM <6 meses (electivas no te dejan operarlo)**, estenosis aórtica, fumador y etc.

Riesgo respiratorio: lo que tiene más riesgo es el EPOC (espirometría alterada), en 2º lugar la qx abdominal (duele, por lo cual, puede hipoventilar y hacer atelectasias) y en 3er lugar qx torácica, todo lo demás.

Riesgo de vómitos: mujer, uso de opioides (previo o durante la cx), no fumar, náuseas,

Riesgo anestesia general o raquídea? Igual de riesgosas ambas.

Riesgo laparo vs abierta? Laparo es mejor, menor morbilidad

Tipos de anestesia

General:

- Gases anestésicos
- Endovenosa: Se necesita primero un inductor + relajante muscular + analgésicos

Regional: anestésicos locales. Peridural y raquídea/espinal. Incluye también los bloqueos de plexos y nervioso (no duermo al paciente pero intervengo una zona distal)

Local: Directo en tejidos y terminales nerviosos

Manejo vía aérea

Más frecuente en morbilidad. Si preguntan algo va a ser esto

Intubación difícil: factor de riesgo ppal es desproporción partes blandas y óseas. Índice cormack/ Mallampati III-IV (laringe y faringe respectivamente según índice). También es riesgoso el cuello rígido o alteración anatómica evidente

Ventilación difícil: Dificultad de mantener satO₂ adecuada. Factor de riesgo es antecedente de irradiación del cuello (linfoma por ejemplo), falta de dientes (cierran más l boca) y obesidad

Vía aérea difícil: considera los 2 anteriores, es decir, un intubación y/o ventilación difícil.

Manejo vía aérea difícil → Preoxigenar siempre. Alternativas:

- Máscara laríngea: es muy fácil, pero desventaja es que no protege de vómitos.
- Fastrach: es máscara laríngea + moderna (es lo que mas se ocupa hoy para pacientes difíciles, pero es caro)
- Intubación con guía
- Intubación por imagen
- Intubación vigil por la nariz
- No dormir al paciente y hacer anestesia regional

Situaciones especiales:

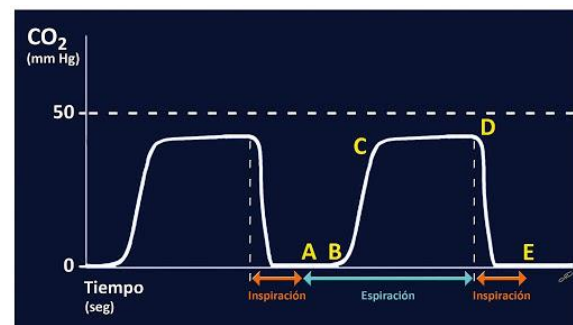
- Trauma facial: riesgo tec abierto → no intubar por la nariz!
- Trauma cervical: riesgo lesión medular (no se puede hiperextender cuello)
- Estómago lleno (lo que + se pregunta): riesgo de aspiración. Todas las cirugías de urgencia se consideran estómago lleno o si es <8 hrs. Se manejan distinto, se hace intubación en “secuencia rápida”. Hay que:

Preoxigenar, no ventilar, inducción y relajación con succinilcolina rápidamente, y se hace la maniobra se Sellick (colapsa el esófago para que no se devuelva contenido gástrico). Por último, se instala TOT.

Otras opciones: intubación vigil y videolaringoscopia

Evaluación de éxito de intubación

Capnografía: goldstandard. Curva que espira/inspira.



Tórax leñoso

Clínica: atc de uso de fentanilo.órax se pone rígido (transitoriamente) y dificulta la ventilación

Dg: clínico

Tto: suspender fentanilo. Si es mucho se da succinilcolina. Si es muy grave se da antídoto naloxona

Hipertermia maligna

Clínica: atc de uso de succinilcolina o gases halogenados. Triada: hipertermia (inmediata) + aumento tono muscular + compromiso de conciencia. Signo precoz es aumento del CO₂ en capnografía. Además, taquicardia e HTA

Dg: clínico. También aumento ck, CO₂ y ácido base

Tto: dantroleno (antídoto) + suspender los fármacos + soporte general (medidas físicas, manejo resto de las shifts)

Cefalea post punción

Causa: escape LCR post punción. Es complicación de la anestesia raquídea, y se puede ver en la peridural que se les pasó la mano y rompió duramadre.

Clínica: Puede venir con otros síntomas neurológicos, aumenta poniéndose de pie y disminuye con el decúbito. No es inmediato, pasa 1 o 2 días después

Dg: clínico (no requiere imagen)

Tto: analgésicos. AINES, opiáceos. Si falla dp de 48 hrs, se puede dar parche hemático o parche de sangre, es medio controvertido.

Intoxicación con anestésicos locales

Clínica: Arritmias y alteración hemodinamia, y/o convulsiones

Causas: haberlo administrado en un vaso sanguíneo → siempre aspirar. Otra causa es exceso de dosis → dosis máxima es 300-500 mg. Si se da con o sin adrenalina modifica la dosis, va a ser más baja la absorción.

Dx: clínico

Tto: ABC clásico + lípidos ev (antídoto de lidocaína porque la adsorben (tal cual, con D), wow) + anticonvulsivantes (sólo si convulsionó).

Fármacos en anestesia

Inductores: Propofol y tiopental. Riesgo: depresión cardiorrespiratoria. Como alternativa está etomidato, ketamina y midazolam (no se usa mucho). Tienen mejor estabilidad cardiorrespiratoria.

También está fentanilo que se puede usar como inductor en dosis más altas. NO ES INDUCTOR EN SÍ

Relajantes musculares: succinilcolina (más rápida, depolarizante), curonios (rocuronio, ve/pan) (más lentos, no depolarizante), curios (no aprender)

Analgésicos: AINEs, opiáceos, corticoides

Anestésicos locales: lidocaína (local), bupivacaina (regional) ropivacaína (regional, - RAM). Propacaina dimecaina (tópicos, aftas etc)

Gases anestésicos: N₂O, gases halogenados (halotano, isofluorano, sevofluorano, desfluorano) (están de mas viejo a más nuevo). Se adinistran y eliminan por vía inhalatoria.

20. TVP, TEP, anticoagulación y várices

Entran en varias especialidades (cirugía, respiratorio y cardio). Se preguntan siempre

- TVP

Edema unilateral con fovea (+) y eritema de la piel. Se presenta con dolor y suele tener signos de insuficiencia venosa (telangectasias, trayectos venosos tortuosos).

Signo de Homans → Dolor en gastrocnemios al dorsiflectar el pie.

Empastamiento → Se palpan duros los gastrocnemios

Antecedentes que orientan a TVP

- Triada de Virchow (Hipercoagulabilidad, ectasia venosa y daño endotelial)
- Trombofilia
- Postquirúrgico
- Puerperio
- Cáncer
- Síndrome nefrótico
- SAF (o patologías asociadas a este como el LES)

Se estudian con eco-doppler de EEII y se manejan con **anticoagulación por 3 meses habitualmente**. Si no tengo eco, anticoagulo a ciegas porque el riesgo de TEP es grande.

- TEP

Clínica → Dolor torácico + disnea de inicio súbito que aumenta con la inspiración (pleurítico). Se asocia a taquipnea, taquicardia (lo más común), hemoptisis, pueden hacer fiebre, desaturaciones y lo mas importantes es que puede venir precedido por TVP o factores de riesgo para TVP/TEP.

MANEJO

El examen de elección es el angioTAC. Se debe **anticoagular por mínimo 6 meses**. Como examen alternativo está el Dímero D. Esto se pide en paciente con baja sospecha de TEP.

Si sale negativo descarta el TEP (Alto VPN) si sale positivo debo ir a descartar con AngioTAC.

- TEP masivo

Misma clínica de TEP + hemodinamia inestable (hipotenso + ingurgitación yugular). El manejo es distinto.

El examen que se toma es el ecocardiograma. Este muestra hipertensión pulmonar

Tratamiento → trombolisis Ev

- Anticoagulación

Heparina

- Fraccionada (HBPM) → No requiere control
- No fraccionada → Se controla con TTPA. La idea es llevarlo a 1,5 veces el basal. Debe ser controlado cada 4 horas. Se administra hospitalizado por BIC

TACO (cumarínicos)

Warfarina y acenocumarol → Se controla con INR, dejándolo ente 2-3

Várices

Al diagnóstico es clínico (Aumento de volumen de venas, edema de extremidades, úlceras varicosas y signos de insuficiencia venosa)

Manejo → Vendaje compresivo y ejercicio. En casos graves se puede operar con safenectomía.

No hay fármacos muy útiles para su manejo. Si sangran (generalmente por trauma) el manejo es con compresión y por último suturar (se preguntó 1 vez).

21. Patología arterial de extremidades inferiores

Claudicación Intermitente

Causa → ateromatosis arterial

Clínica → Dolor en EEII (especialmente en pantorrillas) que aparece con el ejercicio y cede con el reposo.

Diagnóstico → Clínico

Tratamiento → Médico, manejo de los FRCV + programa de ejercicios y suspender tabaquismo.

Isquemia crítica EEII

Causa → Ateromatosis arterial con los mismo FRCV

Clínica → Igual a una claudicación intermitente +

- dolor de reposo
- úlcera arterial (maléolo externo, dolorosa, irregular y de fondo pálido)
- Índice tobillo brazo (ITB) menor a 0,5. (presión arterial tomada en el tobillo / PA brazo). Su VN es >1.

Esto debe estudiarse y tratarse de forma distinta.

Se estudia con PVR y después angiografía para determinar el sitio de obstrucción.

El tratamiento es quirúrgico haciendo un bypass.

Manejo úlcera arterial → Se hacen curaciones, posición de fowler (extremidades colgando) y ATB si se infecta.

Isquemia aguda de EEII

Causa → Embolia arterial (antecedente de FA o arritmia cardíaca). Suele venir con historia de un adulto mayor que estuvo mucho rato en cuclillas y al pararse inicio con dolor

Clínica → 6P

- Pain

- Palidez
- Paresia
- Parestesia
- Pulso ausente/disminuido
- Poiquilothermia (frialidad)

Manejo

4. Anticoagular con heparina
5. Angiografía
6. Embolectomía

Resumen

Patología	Clínica	Examen	Tto
Claud. Interm.	Dolor ejercicio	Solo clínica	Médico Ejercicios
Isquemia Crítica	Dolor reposo	PVR	Bypass
Isquemia Aguda	6P	Angio-grafía	Heparina Embolec.
TVP	Dolor Edema	Eco doppler	Heparina

22. Disección aórtica/Aneurisma aórtico abdominal

Se pregunta bastante

Disección aórtica

Causa → Degeneración de las arterias (**HTA principalmente**, Ehler-danlos, Marfán, etc.) y causas traumáticas

Clínica → Dolor torácico súbito, intenso, irradiado al dorso, de característica transfixiante.

Suele asociarse a crisis HTA, asimetría de pulsos, disfonía por compresión del laríngeo recurrente y soplo diastólico aórtico.

Diagnostico → Angio TAC de tórax o Ecocardio TE. ECG suele estar normal. Rx de tórax muestra ensanchamiento del mediastino.

Se clasifica en tipo A o B. A es sobre la subclavia o B bajo la subclavia. La tipo A se opera, mientras que, la disección tipo B se maneja médicamente para control de la crisis HTA (Labetalol y nitroprusiato generalmente)

**NUNCA JAMAS DAR:
ASPRIINA**

HEPARINA

TROMBOLISIS

ANEURISMA AÓRTICO ABDOMINAL

Causa → Enfermedad ateromatosa, es decir, es una situación de máximo riesgo coronario (es un equivalente coronario).

Clínica

No complicado → Asintomático, a lo más se palpa masa pulsátil en abdomen

Complicado → Roto, viene con una triada compuesta por **shock hipovolémico, dolor y masa pulsátil**. Si un adulto mayor viene con sospecha de cólico renal, este es un aneurisma aórtico abdominal hasta que se demuestre lo contrario (Se preguntó una vez).

Diagnóstico → Eco abdominal (Aorta >3cm)

Tratamiento → Depende del diámetro

<5cm → Conservador. Se sigue con eco abdominal y se manejan los factores de riesgo cardiovascular

> 5cm → Cirugía electiva (Stent endovascular o prótesis)

>8cm → Cirugía en el corto plazo

Roto → Cirugía de urgencia + manejo del shock (suelen morir)



Aneurisma micótico → Aneurisma de causa bacteriana (no hongos), generalmente secundario a embolia séptica de una endocarditis.

23. Paro cardíaco

No se pregunta tanto

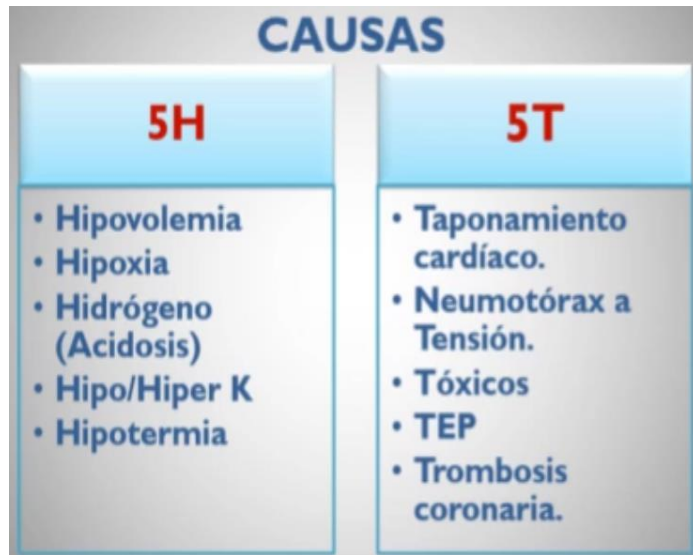
La mortalidad es alta

Paciente que no se mueve, no respira y no tiene pulso

Manejo → RCP básico (30 compresiones y 2 ventilaciones) Se reevalúa cada 5 ciclos (2 min)

Se aplica el CAB, porque acá **lo más importante son las compresiones**

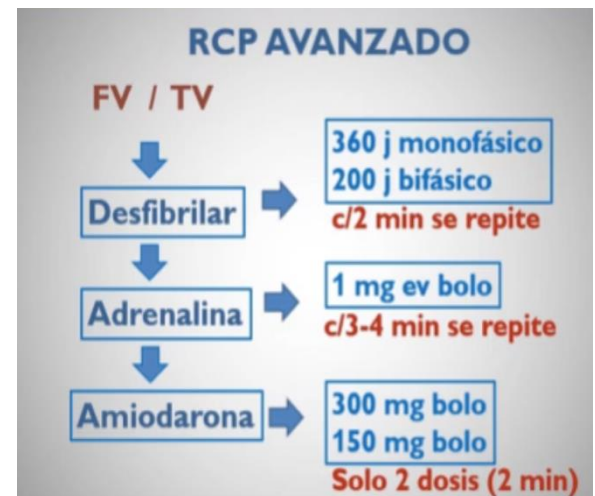
Causas
- 5H y 5T



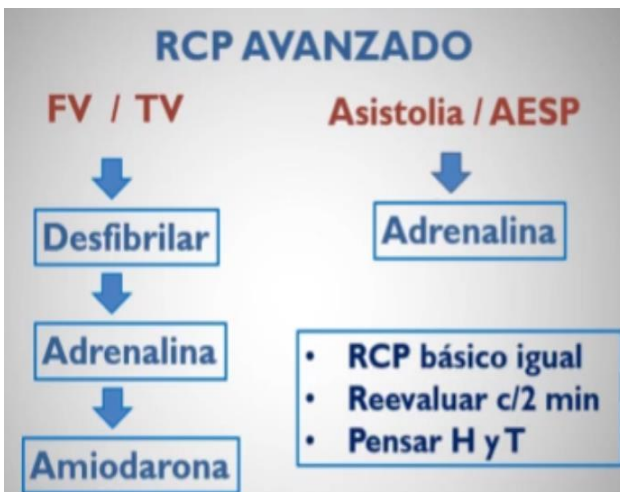
RCP avanzado → Es el que se realiza en el contexto hospitalario

1ª pregunta → ¿El ritmo es desfibrilable? → TV sin pulso y FV

Ritmos no desfibrilables → Asistolia y actividad eléctrica sin pulso (cualquier trazado sin pulso, salvo TV y FV)



Manejo general



¿Cuando suspendo RCP? → Cuando sale de paro (tiene pulso) o cuando se declara la muerte (tras 20-30 minutos de RCP)

En caso de que el paro se presencie en el hospital, se debe iniciar con la desfibrilación

24. Shock

Se pregunta bastante y difícil

Shock → Falla circulatoria con hipoperfusión e hipoxia de los tejidos en general. Viene con hipotensión, diaforesis, palidez, livedo reticularis, FC alta o baja y compromiso de conciencia

Hay de 3 tipos

- Hipovolémico → Por deshidratación o pérdidas de sangre
- Cardiogénico → Por insuficiencia cardíaca o taponamiento cardíaco
- Vasodilatador (el mas preguntado) → Incluye al shock séptico, anafiláctico y medular

Manejo

Hipovolémico → Suero fisiológico Ev. Si no responde se administran coloides

Cardiogénico → Manejo de la causa (angioplastia, cardioversión eléctrica, drogas vasoactivas etc.). **NO SE PUEDE DAR SUERO FISIOLÓGICO POR RIESGO DE EPA.**

Vasodilatador → Suero fisiológico + drogas vasoactivas.

SHOCK			
	PVC	PCP	RVP
Hipovolémico	↓	↓	↑
Cardiogénico	↑	↑	↑
Vasodilatador	↓	↓	↓

PVC: Presión venosa central PCP: Presión capilar pulmonar RVP: resistencia vascular periférica

Manejo general

- Hospitalizar UCI
- Régimen O
- Procalcitonina (elevado en shock séptico), lactato más mil pruebas más
- **Cristaloides (Para PVC sobre 8) , oxígeno (sobre 93%) y DVA (para PAM sobre 65)**

25. Neumotórax, Trauma de tórax, Hemotórax y Mediastinitis

NEMOTÓRAX

Aire en la cavidad pleural

Espontáneo→ Por rotura de bulas apicales generalmente

- Dolor pleurítico
- Disnea

Disminución del MP e hipersonoridad de la percusión.

El diagnóstico es con Rx en espiración máxima.

Tratamiento→Depende del tamaño

<15%--> AINEs + RX de control a las 4-6 horas. (tubo en caso de avance)

>15%--> Tubo pleural

A tensión→Se debe puncionar inmediatamente en el 2º EIC en línea media clavicular

Diagnóstico clínico

- Hipotensión
- Yugulares ingurgitadas
- Asimetría torácica
- Tráquea desviada

Tras la punción se debe realizar manejo usual de neumotórax.

SOLO PUNCIONAR LOS NEUMOTÓRAX A TENSIÓN, NO CUALQUIERA

Abierto→ Se debe tratar inmediatamente con parche en 3 puntas, luego cirugía

Secundario→ Por patologías pulmonares, como EPOC.

1er episodio suele no operarse, pero del 2º episodio en adelante se operan aunque sea pequeño, se hace pleurodesis.

TRAUMA DE TORAX

Se pregunta poco

Ante un trauma se debe pedir Rx y actuar según los hallazgos.

Tórax volante→ 2 o mas Fx de costillas en 2 o más zonas. Se maneja con analgesia + VMI. No es el tórax volante en si el que genera daño, es la contusión pulmonar.

Fx costal→ Manejo con analgesia

HEMOTÓRAX

Trauma de tórax + derrame

Manejo → Tubo

Masivo → Mas de 1.500cc o mas de 200cc por hora. Requiere cirugía

MEDIASTINITIS AGUDA

Causas

- Perforación esofágica (iatrogénica por EDA)
- Comida (hueso de pollo)
- Síndrome de boerhaave)
- Infecciones del cuello (absceso periamigdalino, parao retrofaringeo)

Clínica → Dolor torácico + sepsis

Diagnostico → TAC de tórax

Tratamiento → ATB de amplio espectro + cirugía

26. Ictericia

VN de la bilirrubina es < 1,1, pero genera ictericia sobre 2-2,5mg/dl

Diagnóstico diferencial → Carotenosis (Coloración amarillo-naranja de cara, palmas y plantas. Por consumo de carotenos (zapallo, zanahoria)

Causas

- Hiperbilirrubinemia indirecta
 - o Síndrome de Gilbert (con pruebas hepáticas normales, es genético y se observa)
 - o Hemolisis → Anemia con esquiztositos y LDH elevada. El Tto es según el tipo de anemia.
- Hiperbilirrubinemia directa (Cuando más del 30% de la bili es conjugada)
 - o Hepatitis → Elevación de las transaminasa
 - o Colestasia → Elevación de FA y GGT
 - Cirrosis biliar primaria
 - Coledocolitiasis/colangitis (Colestasias dolorosa)
 - Cáncer (colestasia sin dolor)

Ictérica por cáncer

Es una ictericia indolora o dolor leve (sordo) con baja de peso.

Sus causas son cánceres de páncreas o de vía biliar. Las pruebas hepáticas nos van a mostrar un patrón colestásico. **Se pide Eco (Siempre como 1ª aproximación diagnóstica)** y después RNM en caso de ver la masa. La excepción es el cáncer de páncreas, donde se pide TAC y no RNM.

27. Patología Biliar

COLELITIASIS

Presencia de cálculos en la vesícula.

Formas de presentación

1. Asintomático → Por hallazgo en ecografía, se debe operar laparoscópicamente de forma electiva.
2. Cólico Biliar → Dolor en epigastrio e HD de tipo sordo o cólico que dura **20-30 minutos** asociado a vómitos. El diagnóstico es clínico, pero se debe pedir Eco para descartar Colecistitis. Se maneja de forma sintomática con AINEs y antiespasmódicos. Tras la resolución del cuadro se debe planificar una colecistectomía laparoscópica.

COLECISTITIS AGUDA

Es similar, pero:

- Dolor dura más de 30 minutos
- Presencia de fiebre
- Elevación de PCR y leucocitos
- Signo de Murphy positivo

La ecografía muestra **barro biliar, pared vesical engrosada (>4mm) y vesícula distendida (>10cm).**

Manejo → Cirugía de urgencia.

COLEDOCOLITIASIS

Se presenta como dolor + ictericia

Pruebas hepáticas muestran colestasia

Ecografía → 1er examen a pedir, muestra vía biliar dilatada (>7mm). En algunos casos sirve para ver los cálculos

Colangio RNM → De elección porque muestra los cálculos

ERCP → Diagnóstica y terapéutica (después de hacer la RNM). Tras este procedimiento se debe realizar una cole laparoscópica de forma electiva.

COLANGITIS

Intenso dolor + ictericia marcada + fiebre (triada de Charcot). Si se agrega compromiso de conciencia + hipotensión se conforma la llamada Pentada de Reynolds

El diagnóstico es clínico

Manejo → SF + ERCP + ATB amplio espectro (ceftriaxona + metronidazol)

¿A quién hacer ERCP?

- Clínica de colangitis
- Observación de cálculos en colédoco en la eco

- Cuando la colangio RNM muestra cálculos

COLECISTITIS CRÓNICA

Suelen ser asintomáticas y se diagnostican por la Eco abdominal. Hay 2 tipos

3. Vesícula en porcelana
4. Vesícula escleroatrófica

Ambas tienen riesgo de progresar a CA de vesícula, por lo cual, el manejo es con Cirugía electiva

28. Cáncer de esófago, estómago, colon y recto

Clínica→ Todos pueden producir baja de peso, hemorragia digestiva, anemia y síntomas de alarma del ABCDE...

El diagnóstico es con EDA o EDB + biopsia según sea la sospecha. Se etapifican con TAC TAP

Pronóstico→ **Depende de la invasión transmural**

EL tratamiento curativo es la cirugía + QT y/o RT según corresponda

- Cáncer de esófago

Clínica→ Disfagia lórica

Antecedentes de importancia→ RGE y tabaquismo

Etapificación--> Acá nos sirve la endosonografía también.

- Cáncer gástrico

Clínica

- Sd pilórico (vómitos postprandiales que van en aumento)
- Masa epigástrica
- Dolor urente
- Adenopatías supraclaviculares

Suele dar síntomas tardíos, cuando ya da síntomas suele ser muy tarde.

Es la 1ª causa por muerte de cáncer en hombres y la 2ª en mujeres.

Fuertemente asociado a la presencia de E. pylori.

- Cáncer de colon

Síntomas mas frecuentes→ Constipación y se suele complicar con obstrucción intestinal (1ª causa de obstrucción intestinal en colon).

En caso de que tenga muchísimos pólipos en la colonoscopia, el tratamiento es colectomía total, dado que, probablemente se trate de polipomatosis adenomatosa familiar (PAF) y esta evoluciona en un 100% de los casos a cáncer.

Marcador de CA de colon → CEA. **Sirve para el seguimiento de la enfermedad**

QT → Suele tener muy buenos resultados y por eso mismo es un cáncer de mejor pronóstico.

Se opera SIEMPRE (hemicolecotomía), incluso aunque este muy avanzado, para evitar que se obstruya

Pólipos en la colonoscopia

Si hacemos colonoscopia y nos encontramos con una pólipos **debemos sacarlo si o si para bx.**

En caso de que sea de tipo hiperplásico (el mas frecuente) simplemente se observa.

Pero si es adenoamatoso, tiene riesgo de evolucionar a cáncer, entonces se debe hacer seguimiento colonoscópico seriado.

- Cáncer de recto

Se asocia a infección por VIH, VPH y colitis ulcerosa

Clínica → Afecta la defecación, produciendo dolor o cambiando su forma.

Da harta metástasis a pulmón, por lo cual, el TAC de tórax va si o si. Además se debe pedir RNM de pelvis y endosonografía. Es decir, se deben pedir muchas imágenes para estadiar este cáncer.

29. Abdomen agudo

Lo más importante es conocer la clínica

Abdomen agudo: Dolor abdominal potencialmente grave (muchas causas)

El diagnóstico es clínico

Las imágenes son útiles, pero no reemplazan a la clínica

No todos son quirúrgicos, no todos reciben ATB y no todos tienen signos peritoneales

- Apendicitis aguda

Dolor epigástrico/periumbilical que migra para ubicarse en la fosa iliaca derecha.

El diagnóstico es clínico.

En una mujer joven con esta clínica se le debe hacer un test de embarazo y evaluación ginecológica.

- Plastrón apendicular

Clínica de apendicitis que lleva varios días. Tiene una masa en la FID. Suele venir con antecedente de automedicación con ATB.

El diagnóstico no es solo clínico, se necesita un TAC.

Manejo → ATB Ev (Ceftriaxona + Metronidazol). En 2ª instancia podría relajarse una laparoscopia (a los 6 meses), esto es discutible.

- Diverticulitis aguda

Afecta a adultos sobre los 50 años generalmente. Su clínica es similar a una apendicitis, pero en FII

El diagnóstico es clínico, pero se pide un TAC para determinar el pronóstico y manejo.
CONTRAINDICADA LA COLONOSCOPIA

Se clasifica según la escala de Hinchey para saber el manejo

Hinchey I → Absceso pericólico menor a 5 cm. **Se trata con ATB (Cipro + MTZ o cfx + mtz) mas régimen líquido.**

Hinchey II → Absceso de mas de 5 cm o que esté distante (no pericólico). Se trata con drenaje con punción guiada por eco o TAC + ATB Ev (CFT + MTZ)

Hinchey III → Peritonitis difusa → Cirugía de Hartmann

Hinchey IV → Peritonitis esterocorácea → Cirugía de Hartmann

En caso de tener 2 o más casos de diverticulitis grado I o II se debe hacer una colectomía electiva.

- Enfermedad Diverticular

Se clasifica en complicado o no complicado

- No complicado → Tto → Dieta rica en fibra

- Asintomática
- Clínica inespecífica (SII)

- Complicada

- Diverticulitis → Se trata con cirugía electiva
 - Perforación
 - Obstrucción
 - Fistulas
- Hemorragia digestiva baja → Colonoscopia

30. Abdomen agudo de origen vascular

Se preguntan con cierta frecuencia. Lo importante es saber la clínica

- Embolia Mesentérica

Antecedente de FA generalmente

Clínica

- Dolor súbito muy intenso sin signos peritoneales (Aparecen al final cuando se necrosa)
- Puede haber vómitos y diarrea
- Hematoquezia

- RHA aumentados en un inicio, pero se van apagando a medida que se necrosa el intestino

Manejo

- AngioTAC
- Anticoagulación con heparina + Embolectomía o Trombolisis
- Suero fisiológico + ATB
- Cirugía en caso de necrosis/perforación

- Trombosis venosa mesentérica

Clínica

- Clínica similar, pero mas larvada
- Sí presenta signos peritoneales

Manejo

- Estudio con TAC c/c
- Anticoagular con heparina.
- Suero fisiológico + ATB
- Cirugía en caso de necrosis/perforación

- Colitis Isquémica

Clínica

- Dolor en HI (ángulo izq. del colon tiene irrigación terminal)
- Pueden tener hematoquezia
- Puede tener Signos peritoneales

Manejo

- TAC que mostrará inflamación en el ángulo izquierdo
- Suero fisiológico + ATB
- Cirugía en caso de necrosis/perforación

31. Pancreatitis

Pregunta segura

Pancreatitis aguda

Causas

- Litiasis
- OH
- Hipertrigliceridemia (sobre 500)
- Viral

- Traumática
- Autoinmune
- Otras

Clínica

- Dolor epigástrico irradiado en faja hacia los flancos
- Vómitos profusos
- Signos de Cullen (hemorragia periumbilical), Grey Turner (hemorragia zona lumbar) y Mayo-Robson (dolor en la unión costovertebral)
- CEG, fiebre, distress

Diagnostico

Clínica + amilasa y Lipasa sobre 3 veces su máximo. La Lipasa es más específica, pero la amilasa también sirve, El pronósticos se ve con el TAC a través de la clasificación de Baltazar. Los criterios de APACHE y Ranson (obsoletos) sirven para pronóstico también.

Criterios de Ranson			
↳ Obsoletos, pero útiles.			
L	LDH	V	Volumen (edema)
L	Leucocitosis	A	Anemia
E	Edad >55 años	N	BUN ↑
G	Glicemia ↑	C	Calcio ↓
O	GOT ↑	H	H+ (Acidosis)
		O	Oxígeno ↓

Tratamiento

- Régimen 0
- Hidratación EV
- Alimentación con sonda nasoyeyunal o Nutrición parenteral.
- AINEs
- ATB solo ante
 - Infección
 - Abscesos y necrosis infectados

Cirugía→Pancreatitis infectada o pseudoquiste 666 (mas de 6cm, ms de 6 semana y 6tomas(síntomas))

PANCREATITIS CRONICA

La causa es alcohol

Dolor postprandial o post consumo de alcohol.

Se suele complicar con diabetes insulinorequiriente y síndrome de malabsorción

Diagnóstico→ TAC

Tratamiento

- Suspender consumo de OH
- AINEs para tratar el dolor

- Insulina si se complica con DM
- Enzimas Vo si se complica con sd de malabsorción
- Cirugía→ Solo cuando no responde a AINEs

Angina mesentérica

Dolor abdominal post-prandial, baja de peso y diarrea. Si tiene antecedentes de factores de riesgo cardiovascular nos orienta a este diagnóstico. Se trata con manejo de los factores de riesgo cardiovascular y stent mesentérico.

32. Hemorragia digestiva

Pregunta segura

Masiva→ Compromiso hemodinámico. Primero se produce taquicardia, luego ortostatismo y finalmente caída de P/A.

Ambas se tratan igual, Fluidos Ev + EDA o colonoscopia

La gravedad va a estar determinada por la HEMODINAMIA Y NO POR EL HEMTOCRITO, dado que, este se altera después.

- HDA

Sobre el ángulo de Treitz

Viene con melena y/o hematemesis

Causas

- Várices esofágicas→ Suelen ser masivas, con hematemesis. Viene con antecedente de DHC generalmente (sospecharlo si tiene protrombina baja).
- Úlcera gastroduodenal→ Suele venir con antecedente de síndrome ulceroso (dolor urente epigástrico que aumenta en ayuno). Más que hematemesis presentan MELENA.
- Síndrome de Mallory-Weiss→ Vómitos alimentarios profusos que son seguidos por hematemesis. Suele resolver espontáneamente.

Manejo→ Siempre se da SF y se debe hacer una EDA.

Varices→ SF + EDA+ Terlipresina + ATB (profilaxis PBE) + Vit B1 en caso de ser alcohólico (profilaxis Encefalopatía de Wernicke)

Úlcera→ SF + EDA + Omeprazol Ev

Mallory-Weiss→ Podría ahorrarme la EDA si el paciente esta en BEG y la clínica es evidente.

- HDB

Bajo el ángulo Treitz

Viene con hematoquezia y/o rectorragia

Causas:

- Enfermedad Diverticular → Hemorragia Diverticular. Suele ser un sangrado grave
- Angiodisplasia
- Cáncer de colon
- Divertículo de Meckel en niños

Manejo

Suero fisiológico

Enfermedad divertículo → Colonoscopia en 24 horas tras preparación de colon en caso de no ser masiva. Si es masiva no esperamos y se hace urgente tras meterle volumen. Es probable que no vea nada por la presencia de deposiciones. Si no veo nada tengo que hacer EDA, porque un 10% de las HDB pueden ser de origen alto. Como tercera línea tenemos la Angiografía mesentérica y como último recurso la hemicolectomía (derecha generalmente)

En caso de no ser masiva no encontrarse el origen mediante la colonoscopia, se puede hacer una enteroclisia por TAC para buscar el origen en intestino delgado.

33. Disfagia

Principales causas

- Cáncer de esófago
- Acalasia

Disfagia → dificultad para tragar

Lógica → Progresiva de sólido y líquidos. Cáncer suele ser la causa

Ilógica → Fluctuante, afecta desde un principio a los líquidos. De cuenta de un trastorno motor (esclerodermia y Acalasia)

CÁNCER DE ESÓFAGO

Factores de riesgo

- Cigarrillo
- RGE

Clínica → Disfagia lógica + baja de peso

Diagnóstico → EDA+ biopsia

Etapificación → TAC TAP

Tratamiento → Cirugía es lo único curativo QT y RT.

Cáncer de cardias → Igual al cáncer de esófago, pero no se pregunta

ACALASIA

Disfagia ilógica baja fluctuante.

Se asocia a NAC aspirativas y RGE no ácido, pues viene del esófago, no del estómago.

Diagnóstico → Manometría (disminución de la peristalsis mas aumento de tono el esfínter esofágico inferior. En este tipo de trastornos suele iniciarse estudio con EDA, pero si se sospecha fuertemente de acalasia, se hace la manometría como primer examen y así tenemos el diagnóstico

Tratamiento → Cirugía → Esfinterotomía.

La inyección de bótox es otro tratamiento, pero la cirugía es la de elección

Esclerodermia

Disfagia de tipo ilógica + pirosis + CREST

Divertículo esofágico

También son causa de disfagia que no debemos confundir con acalasia

El más típico es el divertículo de Zencker. Es una disfagia alta de tipo fluctuante, dado que, a veces el divertículo se llena de comida. Viene con halitosis por la acumulación de comida en el divertículo. Hacen NAC aspirativas también.

Se estudia con Rx con bario

El tratamiento es quirúrgico

Divertículo del cuerpo esofágico → Se observan

Divertículo del esfínter esofágico inferior → Igual al divertículo de Zencker, solo que la disfagia es baja. Se maneja igual que Zencker (Rx con bario y Cx)

34. Nódulo tiroideo, Ca de tiroides y masa cervical

Nódulo tiroideo

Causas

- Benignas
 - Quiste Coloideo
 - Adenoma
- Malignas
 - Cáncer

Clínica → Presencia de nódulo tiroideo, el cual, debe ser estudiado con Eco y TSH. En caso de ser mayor a 1 cm se debe hacer PAAF (Punción aspiración con aguja fina)

Si la TSH esta baja (hipertiroidismo), se debe pedir una cintigrafía de yodo radioactivo para determinar si este nódulo es la causa del hipertiroidismo. Podemos tener dos resultados:

- Nódulo caliente (hipercaptante)→Se hace el diagnostico de adenoma toxico y se trata como tal (drogas antiroides y Yodo)
- Nódulo Frio→ Se hace la PAAF porque queda la duda de lo que puede ser

Cáncer de tiroides

El diagnostico se hace con la PAAF, es una biopsia **citológica**.

Puede ser un cáncer papilar (el mas común, 85%), folicular (10%), medular o anaplásico.

Cánceres papilar y folicular

Se tratan con tiroidectomía total y yodo radioactivo. El seguimiento es con tiroglobulina.

Tienen buen pronóstico porque responden a Yodo radioactivo

Cáncer medular→ Antes de empezar a tratarlo hay que descartar un Feocromocitoma.

Se trata con tiroidectomía + linfadenectomía seguido por quimio y radioterapia.

El seguimiento es con calcitonina

Cáncer anaplásico→ De muy mal pronóstico, el tratamiento es solo paliativo (Besito en la frente y amor)

Adenoma folicular→ Es benigno, pero totalmente indistinguible del cáncer en la PAAF, por lo tanto, también se va de tiroidectomía total.

Masa cervical

Lo importantes es el manejo

El examen inicial siempre es la eco de cuello

Causas que se preguntan

- Quiste del conducto tirogloso→ alteración congénita, se ve en los niños. Es una masa en la línea media. Si bien está desde el nacimiento, no siempre es evidente en esta etapa y puede hacerse el diagnostico en la adolescencia. Peor si es una masa que se moviliza con la deglución uno está seguro que es esto. Se operan
- Quistes Branquiales→ También de los niños, pero por la cara lateral, en relación al Esternocleidomastoideo
- Linfoma→ Masa, adenopatías + síntomas B. El estudio es con ex generales, Rx tórax y biopsia excisional
- Metástasis de cáncer de cabeza y cuello→ Primero se debe buscar el primario y si no lo encontramos se hace la PAAF.

35. Politraumatismo y fractura de pelvis

Se pregunta con cierta frecuencia

Politraumatismo

Trauma de al menos 3 sistemas

Causa → Accidentes de tránsito y caídas de altura son las más prevalentes.

Diagnóstico → Clínico

Radiografías mínimas → Lateral de cuello, AP de tórax y AP de pelvis.

Tratamiento → ABC + manejo de complicaciones

ABC

A → Mantener vía aérea permeable + instalación de collar cervical

B → Hay que asegurar de que el paciente ventile

C → Instalar 2 vías venosas gruesas y administrar cristaloides + compresión de las heridas

D → Déficit neurológico. Se debe hacer un examen neurológico completo para asegurarnos de que no hay compromiso neurológico

E → Exposición, desvestir al paciente para asegurarnos de que no haya lesiones bajo la ropa.

Fractura de pelvis

Causa → Accidentes de tránsito y caídas de altura son las más prevalentes. Se maneja igual que un politraumatizado.

Siempre hacer TR y tacto vaginal por riesgo de fractura expuesta hacia estas cavidades sépticas

Diagnostico → Rx AP de pelvis

Manejo → ABC + manejo de complicaciones

Complicaciones

1. Shock hipovolémico → Por lesiones de las **venas** pélvicas. Se maneja con ABC + estabilización externa de la pelvis. Se puede hacer con férula neumática, tutor externo, hamaca pélvica o con sábanas apretadas como último recurso.
2. Sección uretral → Lo importante es NO INSTALAR SONDA FOLEY, se realiza cistotomía. El diagnostico se hace mediante uretrocistografía y se trata quirúrgicamente.



Nuestro amigo creggers (sí, yo) después de ser chocado y quedar más mal que bien

36. Cuerpo extraño

Se pregunta mucho

Nasal

Suele ser en niños. Se presenta cuando hay rinorrea purulenta y fétida unilateral

Conducta → Derivar a ORL para que lo retire

Auditivo

Se presenta como sensación de oído tapado, dolor, otorrea en caso de llevar mucho tiempo

Ante la sospecha se debe hacer otoscopia y derivar a ORL en caso de ver el cuerpo extraño

En caso de haber un insecto, se mata con vaselina líquida o aceite vegetal y se deriva, NUNCA TRATARLO CON AGUA.

Laríngeo

Es una urgencia

Se manifiesta como la imposibilidad de hablar y respirar

Se debe tratar con la maniobra de Heimlich

<1 año → Golpes interescapulares

Muy obeso → Se hace con el paciente acostado

Si no es obstructivo → Se deriva a SU para Rx y extracción mediante laringoscopia.



Bronquial

Se presenta como tos intensa de inicio súbita.

Tras esto disminuye la tos y aparece expectoración que puede ser mucopurulenta. Se puede producir una atelectasia (crépitos localizados) o hiperinsuflación (sibilancias localizadas)

Generalmente se va hacia el bronquio derecho

Se pide una Rx de tórax en la Rx se puede ver la atelectasia, hiperinsuflación o el mismo cuerpo extraño.

Tras esto se retira mediante broncoscopio

Esofágico

Se pide Rx de tórax y abdomen

Se presenta como sialorrea porque no puede tragar, asociado a dolor torácico

Se retira mediante una EDA

Estomago/intestino

Se observa, sin necesidad de control radiológico

Excepciones → Pilas y 2 imanes. Estas deben ser retiradas mediante EDA

RESUMEN G-O GUEVARA

Son 29 preguntas, la mitad es obstetricia y la otra es de gine. No son preguntas fáciles, pero con pocas horas de estudio no es difícil tenerlas buenas.

OBSTETRICIA

1. CONTROL ANTENATAL EMBARAZO FISIOLÓGICO

Controles c/4 semanas hasta las 28 – c/2 semanas hasta 36 – semanal hasta el parto.

Controles:

- 1er control: anamnesis completa, determinación EG, muchos exámenes
 - H. Clínica, FR psicosocial. EF general y obstétrico.
 - EF general: PA (buscar si HTA cr), IMC (ver cuanto se recomienda de aumento de peso).
 - Examen obstétrico: AU y LCF.
 - Laboratorio: Hemograma, Grupo y Rh (si negativa, control con coombs ind.), VDRL/RPR, Chagas, VIH, (IgG CMV e IgG Toxoplasma) Glicemia, SO y UC, PAP (no cepillo endocervical). Si palpo nódulo eco mamaria.
 - Ecografía: viabilidad, pronóstico, nº embriones, **EG**
- 11-14 sem:
 - Ecografía:
 - Riesgo de **aneuploidias** (con translucencia nuchal)
 - Screening PE (arterias uterinas) → si alterado AAS.
 - Cervicometría si antecedente Incompetencia cervical (≥ 2 abortos tardíos, ≥ 2 PP previos extremos (<28 sem)).
- 20-24 sem:
 - Ecografía:
 - **Morfológico**
 - Doppler arterias uterinas.
 - **Cervicometría**, si <25 mm Progesterona VV y se suma cerclaje si antecedente.
 - VDRL
- 26-28 sem
 - PTGO, si alterado = DMGestacional.
 - Coombs ind si era Rh negativa.
 - Administración Rhogam si no sensibilizada
 - Ecografía: **morfológico** (por excelencia)
- 32-38 sem
 - Ecografía: **crecimiento fetal** (EPF)
 - Hemograma
 - VDRL
 - *35-37 sem: cultivo vaginoperianal para SGB

Nutrición:

- IMC normal embarazo → 20-24.9
 - Incremento de peso:
- (** mentira según Dr Lagos)

Bajo peso	12-18 Kg
Normal	10-13 Kg
Sobrepeso	7-10 Kg
Obesa	6-7 Kg

- Recomendaciones:
 - Calorías: 1er trimestre = normal. 2do T + 350 kcal/día. 3er T + 450 kcal/día
 - Proteínas: 0.8 g/kg/día
 - Carbohidratos: 175 gr/día.
 - * Pescados: si pueden comer 2v/semana, cocidos. NO: albacora, atún, pez espada ni blanquillo por los niveles de mercurio.
 - Suplementos:
 - Ac. Fólico: 0.4 mg/día a todas previo al embarazo ojalá – 4 mg/día si DMGestacional (o pregestacional), defectos tubo neural o gemelar.
 - Fierro: desde semana 16 → 30 mg Fe elemental. Sulfato ferroso 200 mg/día (divido en 5 da Fe elemental)
 - Calcio: 1 gr al día (4-5 lácteos al día). Si adolescente 1.3 gr.
 - Vitaminas: NO
 - Vitamina D solo a veganas, sin exposición solar o raza negra.

Lactancia: recomendaciones:

- Calorías: + 300-500 kcal/día
- Líquidos: + 0.5 – 1 L/día
- Calcio 1 gr/día.
- ** También vitamina D y Fe (no sale en video).

2. DETERMINACIÓN EDAD GESTACIONAL

Clínica:

- FUR segura y confiable: recordada (o anotada), ciclos regulares, sin lactancia, sin ACO últimos 3 meses.
 - FPP (regla Neagele): FUR + 7 días – 3 meses.
- Altura uterina: bajo costo, fácil, diferencias interobservador.
 - $AU \times 8/7$.
 - $EG = AU + 4$
- Movimientos fetales:
 - 20-22 semanas PG
 - 18-20 semanas MP
- Auscultación LCF: 20 sem pinard, 18 sem electrónico.

Ecografía:

- 1er trimestre:

- Saco Gestacional ± 7 días
- LCN 6-12 semanas. ± 7 días.
 - LCN + 6.5 = EG.
-
- 2do trimestre:
 - DBP 12-17 sem. ± 7 días
 - DBP 18-24 sem. ± 11 días
 - DBP 24-28 sem. ± 14 días.
- 3er trimestre: >29 sem DBP y LF. ± 21 días.
- Otros elementos que se pueden medir para ayudar a determinar EG.

FUR v/s Ecografía: si FUR segura esta acorde (dentro del rango de error) manda la FUR, si no mandaría la eco.

La mejor forma de determinar la EG $\rightarrow$ Ecografía lo más temprano posible. Si la eco no se hizo, es mejor la FUR segura y confiable, si no me quedo con la eco sabiendo que hay gran rango de error.

3. ANEMIA Y EMBARAZO

Causas:

- Fisiológica: dilucional por aumento 50% plasma y 25% masa eritrocitaria
- No fisiológica: Hb <11 . O Hb <10.5 en 2T.
 - Ferropénica
 - Deficiencia folato (antecedente o hemograma con VCM elevado)
 - Hemolítica inducida por embarazo (esquistocitos, LDH alta, BB elevada)

Anemia ferropénica:

- Causa:
 - Aumento requerimientos de Fe, feto extrae mas
- Diagnostico: Hemograma con micro-hipo. Ferritina $<10-15$, Sat transferrina $<16\%$. (No obligatorio pedir perfil de Fe).
- Profilaxis: desde semana 18.
 - 200 mg / dia Sulfato ferroso (30 mg Fe elemental)
- Tratamiento:
 - 200 mg c/8 hr Sulfato ferroso.
 - Si Hb <6 o sintomática $\rightarrow$ Transfusión.
- Riesgos:
 - Anemia postparto – Inercia uterina
 - RCIU, PP.

4. ABORTO ESPONTÁNEO

Motivo consulta: METRORRAGIA

Nomenclatura:

- Amenaza de aborto: dolor hipogástrico
- Síntomas de aborto: dolor + metrorragia
- Aborto inevitable: dolor + metrorragia + criterios de inevitabilidad.

- Criterios: dilatación cervical, huevo roto, huevo infectado, desprendimiento ovular.
- Aborto en evolución: + modificaciones cervicales
- Aborto completo: según tamaño endometrio, <15 mm
- Aborto incompleto: LE >15 mm.

Manejo:

- Especuloscopia: confirmar sangrado de origen uterino.
- Eco TV: otras causas (EE y mola) y pronóstico.
- Amenaza y Síntomas (hasta metrorragia sin modificaciones) → Ambulatorio + Abstinencia sexual + Reposo relativo.
 - Riesgo 50%, por lo general secundarios a alteraciones genéticas
- Inevitable o en Evolución → Hospitalizar + Conducción aborto.
- Incompleto: AMEU (aspiración manual endouterina) o Legrado
- Completo: Observar
 - DU dolorosa, metrorragia, eliminación abundante de restos ovulares, buen estado general.
 - Ecografía: útero tamaño normal, LE <15 mm, cuello cerrado o dilatado poco.
 - ¿Si hipotensión + liquido libre? → ECTOPICO ROTO.
- TODOS si Rh (-) → Rhogam.

5. ABORTO SÉPTICO

Causa más frecuente es aborto clandestino.

Incidencia ha disminuido desde uso de misoprostol.

Definición: clínica de aborto + fiebre >38° (tomada en 2 oportunidades en 6 hrs)

- Puede presentar
 - DU
 - Flujo purulento
 - Abdomen agudo
 - Antecedente de DIU (embarazo con DIU tiene 50% riesgo de aborto).
- Si < 8 semanas: solo fiebre >24 hrs + compromiso miometrial/anexial/peritoneal + flujo purulento x OCE (**similar a PIP pero con beta +**).

Manejo:

- Especuloscopia
- EcoTV
- Hospitalización, Hemograma + PCR
 - Bajo riesgo → ATB x 3-5 días EV (Ceftx + MTZ) + CSV horario
 - Alto riesgo → + P. hepáticas y coagulación (para descartar shock tóxico x c. perfringens que viene con falla renal y hepatitis importante)
 - Se cambian los ATB por Clindamicina + Gentamicina x 5-7 días.
 - + AMEU o Legrado → no de inmediato, solo si requiere, luego de 48 hrs con ATB o 24 hrs afebril

- Si shock séptico o tóxico → sumarle volumen + DVA
- Histerectomía: (para desfocar)
 - Shock refractario o mantenido
 - Miometritis y/o peritonitis
 - Abdomen agudo.
 - Metrorragia masiva

6. EMBARAZO GEMELAR

Se pregunta con alguna frecuencia

Incidencia 1%

FR:

- Edad materna >
- **Fertilización asistida**
- Raza negra
- Antecedentes familiares

Pronóstico y manejo: según corionicidad (Signo lambda → bicorial / Signo T → monocorial), determinar antes de las 15 semanas

- Siempre derivar a ARO

Clasificación:

- Bicorial-biamniótico: puede ser monocigoto o bicigoto, suman el 80% de todos (70% bicigotos y 10% monocigotos).
- Monocorial-biamniótico: solo pueden ser monocigotos. 20%
- Monocorial-monoamniótico: solo monocigotos. Son los mas peligrosos. 1%.
- Siameses.
- Múltiple: ≥ 3 fetos.

Complicaciones:

- Maternas:
 - Anemia
 - Hiperemesis
 - EPA
 - Hígado graso agudo
 - **SHE**: si es gemelar se puede hacer diagnostico antes de las 20 semanas
 - **Inercia uterina** y por lo mismo de Hemorragia Post Parto.
- Fetales (las más importantes a saber):
 - **Parto prematuro** en promedio nacen a las 36 semanas y 33 semanas en caso de ser triple.
 - **RCIU**
 - **Gemelos discordantes**: ninguno es chico, es decir, ambos >p10, pero uno es mucho mas grande que el otro (p80 y otro p12 por ejemplo).
 - Muerte de gemelo in-utero
 - Malformaciones.

Monocoriales: complicaciones específicas por comunicación corial entre fetos.

- **STFF** (Síndrome transfusión feto fetal): un feto le dona sangre al otro
 - Donante tiene OHA, Receptor PHA. Dg es con Eco. Letalidad cercana al 100%
 - Tratamiento: Amnioscopía + Coagulación laser de vasos comunicantes.
- **Sd. Anemia/Policitemia:**
 - Donante viene con anemia Hb <11. ACM >1.5, mientras que el receptor tiene policitemia Hb >20, es grave.
 - Tratamiento: Amnioscopía + Coagulación laser de vasos comunicantes.
- **Secuencia TRAP:**
 - Uno de los gemelos es acárdico, por lo cual, el otro gemelo es bomba para mantener a ambos vivos.
 - Tratamiento: Coagulación laser (guiado por US o amnioscopia) de vasos umbilicales de gemelo acardio (se mata al acárdico).

Manejo e interrupción:

- En ARO.
- Interrupción:
 - Bi-bi: 37 semanas
 - Mono-bi: 36 semanas con madurez pulmonar (c/2 sem). Antes si otra patología.
 - Mono-mono: 32-34 sem con madurez pulmonar. 1% de todos los gemelares. 10-20% letalidad por entrecruzamiento cordones.
- Vía de parto:
 - Cesárea:
 - Absoluta:
 - Monoamniótico
 - Gemelo 1 no cefálica
 - >2
 - Relativa: GI cefálica + GII no cefálica
 - Excepción si biamniótico cefálica los dos.

En resumen, cesárea para todos, salvo los bi-bi que vienen ambos en cefálica.

7. ABORTO RETENIDO

Es común confundirlo con el embarazo ectópico, a pesar de ser diferentes.

Al momento de realizar el 1er control del embarazo con Eco TV:

- Huevo anembrionado: saco gestacional > 25 mm sin embrión (si mide menos que eso es normal que no se vea el embrión)
- Embrión sin LCF: saco con embrión, LCN > 7 mm, LCF (-)
- Si la LCF es menor a 7mm : se repite eco en 7-14 días.
- Si es mayor: Diagnóstico de aborto retenido

Manejo:

- Huevo anembrionado, o aborto retenido de <12 semanas → Observar evolución y esperar que inicie de forma espontánea el aborto por 2 hasta un máximo de 8 semanas (Si espero más que eso tengo el riesgo de CID).
 - o Si no funciona → hospitalizar + conducción del aborto (mifepristona + misoprostol)
- > 12 sem → Hospitalización + conducción (riesgo alto de CID).
- Incompleto o con metrorragia → AMEU o Legrado
- Completo: observar.
- Rhogam si Rh (-) no sensibilizada.

8. EMBARAZO ECTÓPICO

Se pregunta siempre

Definición: implantación fuera de la cavidad uterina, 98% trompa.

Eco (-) con HCG >1500

Normalmente la beta se duplica o como mínimo aumenta >66% cada 48 hrs.

FR:

- EE previo
- Qx tubaria
- PIP.
- DIU
- Ligadura
- Promiscuidad (se asocia a PIP)

Clínica:

- No roto:
 - o Asintomático generalmente
 - o Metrorragia escasa 1T
 - o TU anexial (¿cuerpo luteo fisiológico del embarazo?)
- Roto:
 - o Dolor hipogástrico
 - o Shock hipovolémico
 - o EcoTV: líquido libre >100 cc
 - o Signos irritación peritoneal (sangre irrita el peritoneo).

EE no complicado:

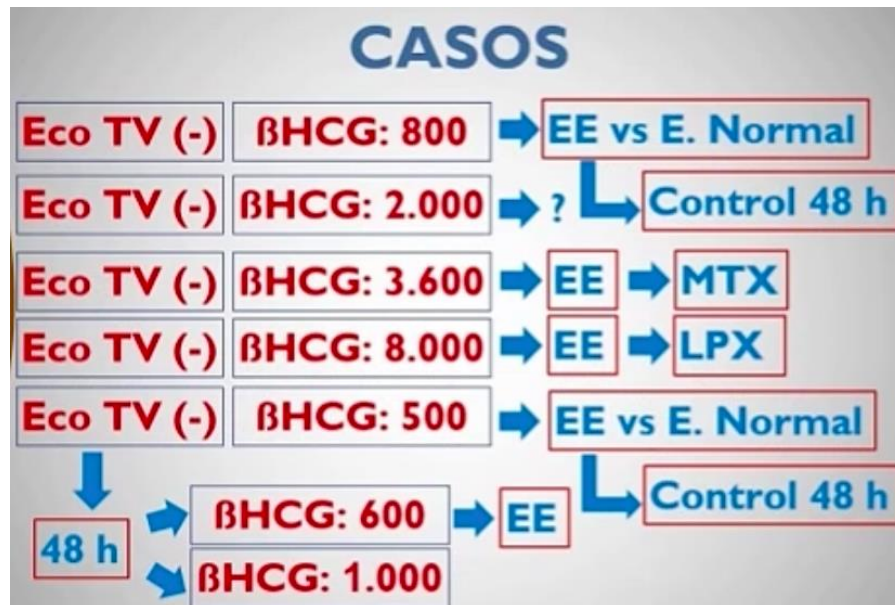
- EcoTV: sin embarazo intrauterino.
 - o Tengo 2 opciones: O es de menor EG y no se ve, o es ectópico.
- BHCG: >3500 (ACOG 2018), o >1500 (Minsal 2015).
 - o Clase: >2800.
 - o Si < a esto → repetir en 48 hrs.
- Biopsia: diagnostico definitivo, luego de cx.

EE roto:

- Clínica (shock, dolor y metrorragia) + BHCG positiva.

Manejo:

- EE roto:
 - Laparotomía (si HDNI)
 - LPC si HDNE
- EE no roto
 - MTX: evita daño trompa. <5 cm y <5000 IU BHCG
 - LPC:
 - Falla tto médico: Beta no baja >15% en los 2 días siguientes
 - BHCG > 5000
 - TU $\geq$ 5 cm
 - LCF + (criterio de carácter religioso)
 - Expectante * (NO): estable, asintomática, Beta <1000 y descendiendo.
- Rhogam si Rh (-) NS.



9. ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL

- **Mola hidatidiforme**
 - Tipos:
 - Completa 2n (2 del papá):
 - Aumento muy elevado BHCG
 - + AU > a la esperada.
 - + Hiperemesis gravídica
 - + Toxemia o PE.
 - + Quistes tecaluteínicos (TU anexial bilateral)
 - + Hipertiroidismo (x similitud de B con TSH)
 - Parcial 3n (2 papá 1 mamá), puede venir con feto malformado:

- Similar a aborto, solo metrorragia 72%.
- Diagnóstico: EcoTV.
 - Panal de abeja/Tormenta de nieve
 - Quistes tecaluteínicos.
 - Biopsia diagnostico definitivo después de sacarlo. Descartar coriocarcinoma
- Tratamiento: sacarlo.
 - Evacuación uterina AMEU o
 - Dilatación y Lgrado
 - NO oxitocina o PE1: riesgo de embolias TU.
 - Histerectomía:
 - Tamaño mayor
 - Paridad cumplida
 - Hemorragia severa.
 - Rhogam si Rh (-) NS
- Seguimiento:
 - Biopsia
 - BHCG: semanal hasta que negativice. Luego mensual por 6-12 meses (si completa 1 año).
 - + ACO (MAC) (no quiero que se embarazo para que no me confunda durante el seguimiento con la BHCG)
 - Si HCG persiste elevada → Es una Neoplasia Trofoblástica Gestacional (cáncer).

- **Neoplasia Trofoblástica Gestacional:**

Vine con antecedentes de aborto o mola. Es de buen pronóstico, responden bien a QT

- Tipos:
 - Mola invasora
 - Coriocarcinoma
 - TU sitio inserción placentaria
- Clínica: antecedente de mola (completa) / aborto / parto / + metrorragia.
- Diagnóstico: BHCG que se eleva después de haber sacado una mola.
 - Se hace EcoTV que muestra imagen típica y se confirma con Biopsia.
 - Mola invasora o Coriocarcinoma: mayoría de NTG
 - Mucha elevación BHCG
 - Buena respuesta a QMT.
 - TU sitio inserción placentaria o TU trofoblastico epitelial:
 - Leve elevación y lenta BHCG
 - Mala respuesta a QMT
- Manejo: HT + QMT.

Buen pronóstico, buena respuesta a QMT.

10. HIPEREMESIS GRAVÍDICA

Se ha preguntado mucho en los últimos años

Causa: elevación BHCG + estrógenos.

FR: gemelares y ETG (x mayor elevación BHCG).

Clínica:

- Vómitos persistentes y graves + baja de peso >5% y deshidratación (alteraciones ELP, limitación AVD)
- Diagnóstico de exclusión (descartar gastroenteritis, etc.)

Tratamiento:

- **Doxilamina** 10 mg + Piridoxina (B6).
- Metoclopramida
- Hidratación EV + Tiamina (B1)
- Ondansetron.

11. DISTOCIAS DE POSICIÓN

Se pregunta siempre

Puntos de reparo:

- Vértice NORMAL: occipucio (lambda) fontanela posterior.
- Cefálicas deflectadas
 - o Bregma (bregma) fontanela anterior
 - o Frente (nariz) NO PTV
 - La más distócica, diámetro de 13 cm.
 - o Cara (mentón) NO PTV (excepción mentopúbica-mentoanterior que esté todo súper bien).
 - Se describe como “Golpe de hacha” entre cabeza y espalda.
- Podálica (sacro) NO PTV
 - o Riesgo de retención de cabeza.
- Situación transversa (acromion) NO PTV.
 - o Pelvis vacía, nunca baja.

** Opción de PTV: vértice / bregma (ya que después se puede flectar) / excepción cara mentoanterior (mentopúbica).

Presentación podálica

- Tipos:
 - o Completa: ambas rodillas flectadas
 - o Incompleta: una rodilla flectada
 - o Nalgas pura: rodillas estiradas.
- Maniobras:
 - o Descenso brazos:
 - Pajot
 - Rojas
 - o Desprendimiento de cabeza:
 - Bracht: tracción de los pies hacia arriba para estirar cabeza

- Mariceau: se meten manos y se agarra boca de la guagua pa flectarla.
- Praga
- Fórceps.

12.CIE e HGAE

Se han preguntado

Colestasia intrahepática del embarazo:

- Importancia: riesgo fetal, sin riesgo materno (molesta)
- Diagnóstico: clínico.
 - Estudio con doppler umbilical.
 - Clínica: 2-3 trimestre.
 - Prurito palmoplantar bilateral, puede ser generalizado, > nocturno.
 - Ictericia puede o no tenerla, si tiene es severa.
 - Pruebas hepáticas: aumento ácidos biliares, aumento **leve** Bilirrubina, aumento leve GOT y GPT.
- Tratamiento:
 - Interrupción 38 semanas no icterica
 - Interrupción 36 semanas si icterica u otro criterio de severidad
 - Ácido ursodeoxicólico (mejora los síntomas).
 - Administración de corticoides como prevención en caso de tener que interrumpir antes.

Hígado graso agudo del embarazo

- Importancia: alta mortalidad materna y fetal (letalidad)
- Clínica: inespecífica, anorexia-astenia, CEG.
 - Puede tener dolor, náuseas, vómitos
 - Evolución a insuficiencia hepática fulminante → encefalopatía, coagulopatía.
 - AKI, pancreatitis como complicaciones de Falla Multiorgánica.
 - Sufrimiento fetal agudo
- Diagnóstico:
 - Elevación GOT/GPT <1000 (sobre 1000 es hepatitis)
 - Hipoglicemia marcada
 - Aumento TP o caída protrombinemia.
 - Biopsia hepática es el dg de certeza, pero técnicamente no se hace, es autopsia... Para confirmar que eso fue.
 - **Sospecha: Embarazo 3er trimestre + Falla hepática aguda.**
 - Diferencia con HELLP → viene con SHE, proteinuria, sin tanta astenia ni hipoglicemia, síntoma más importante del HELLP es la epigastralgia. La sigla: hemólisis, trombocitopenia. Tratamiento el mismo.

- Tratamiento: interrupción inmediata del embarazo → Cesárea de urgencia ante la mínima sospecha

13.METRORRAGIA PRIMERA MITAD EMBARAZO

Se pregunta siempre

Causa más frecuente de metrorragia → Ginecológica

- Especuloscopia:
 - Lesión cervical
 - Desgarro vaginal
 - Obstétrica (desde OCE) → EcoTV
 - Aborto: embarazo intrauterino
 - EE: utero vacío
 - ETG: copos de nieve, quistes
- Aborto: más frecuente causa de metrorragia obstétrica.
 - Puede tener dolor y modificaciones cervicales.
 - Amenaza/síntomas (sin mods cervicales) → Observar + reposo/abstinencia
 - Evolución/Inevitable (con modificaciones)
 - >15 mm endometrio → AMEU
 - <15 mm → Observar
- EE: si esta roto, con shock hipovolémico. HCG > 1500.
 - Eco: se puede ver TU anexial, diferenciar de cuerpo luteo (si tiene LCF).
 - Manejo: ABC + Cx urgencias → LPT exploradora + salpingectomía de urgencias.
- Mola: puede tener + hiperémesis/utero más grande/hipertiroidismo/SHE/quistes TU bilaterales.
 - Mola completa 2n (con todos los síntomas), parcial 3n (solo metrorragia) → Desde AMEU-Legrado a HT.
 - Seguimiento con HCG semanas hasta 2 negativas luego mensual 6-12 meses, si completa 1 año.
 - Antecedente de aborto + síntomas de mola → NTG → HT + QMT.

14.METRORRAGIA SEGUNDA MITAD EMBARAZO

Se pregunta siempre

Descartar causas ginecológicas, muy frecuentes. Especuloscopia.

Si obstétrica (desde OCE) → EcoTV

- DPPNI (se puede ver hematoma retroplacentario en eco, diagnostico es clínico). 1%
 - Clínica: metrorragia rojo oscuro, doloroso (90%), inicio brusco, tono uterino aumentado, SFA (sufrimiento fetal agudo) (hematoma >500 ml).
 - Realizar TV → interrupción vía más expedita.
 - Si todo bien se puede esperar.
- Placenta previa 0.5%. CONTRAINDICADO TV.

- Asintomática: diagnostico ecográfico con placenta sobre OCI. → seguimiento y cesárea a las 37 semanas + corticoides.
- Sintomática: metrorragia rojo brillante, indolora, inicio insidioso, tono uterino conservado, sin SFA.
 - Indicación de cesárea urgencia.
 - Si mamá y feto bien se puede observar.
- Tipos: parcial (opción PTV) u oclusiva total (cesárea 37 semanas).
- Riesgo de acretismo placentario (mas invasión pared uterina)
- Rotura uterina
- Rotura vasa previa

Si tengo metrorragia → ECO

Si metrorragia + clínica DPPNI → TV.

15.METRRORRAGIA DEL PARTO

- Rotura uterina:
 - Causas: cesárea previa (2CCA, 1CCA corporal, 1CCA con necesidad de inducción → contraindicado PTV)
 - Clínica: metrorragia inespecífica + CUD que desaparecen.
 - Puede quedar luego con dolor constante (escaso)
 - + SFA
 - + Pérdida presentación
 - + Palpación fácil partes fetales.
 - Manejo: cesárea de urgencia + reparación vs HT.
- Rotura vasa previa:
 - Causa: inserción velamentosa cordón (inserción en amnios, sin gelatina de Wharton, más exposición + vasa previa, bajo la cabeza)
 - Clínica: metrorragia inespecífica + RAM/REM + SFA. Madre OK
 - Manejo: cesárea de urgencia.
- DPPNI intraparto:
 - Clínica: metrorragia + RAM/REM + SFA + CUD + Hipertonía uterina.
 - Manejo: interrupción vía mas expedita (hacer TV), cesarea de urgencia.
 - Comunmente post RM, desprendimiento exvacuo.
- Acretismo placentario
 - Causa: cesárea previa, placenta previa
 - Clínica: metrorragia en alumbramiento, placenta imposible de extraer.
 - Manejo: histerectomía.
 - Clasificación:
 - Acreta: hasta endometrio
 - Increta: hasta miometrio
 - Percreta: sobrepasa miometrio, órganos vecinos.
- *Procidencia de cordón (no metrorragia): sale antes de la cabeza fetal

- Clínica: luego de RAM/REM + SFA.
- Manejo: tacto vaginal diagnóstica y descomprime. Luego cesárea de urgencia.
- *Inserción velamentosa del cordón asintomática: en parto rotura de vasa previa.
 - Manejo: si fue diagnosticado previamente
 - Seguimiento ecográfico. Muchos casos resuelven espontáneo, deja de ser “previa” y hay opción de PTV.
 - Si no resuelve → cesárea electiva a término.

16.METRORRAGIAS PUERPERALES

Hemorragia >500 ml PTV o >1000 ml cesárea.

Clasificación:

- Precoz, ocurren dentro de las primeras 24 hrs y sus causas se resumen en las 4T
 - **Tono:** atonía / inercia uterina (más frecuente 70%)
 - **Trauma:** lesiones del canal o hematomas
 - **Tejidos:** restos ovulares
 - **Trastornos coagulación** – hemostasia
- Tardía 24 hrs – 6 sem (término puerperio)
 - Restos ovulares → Lo más frecuentes, pero se dejan ATB Ev igual en caso de que sea una endometritis
 - Endometritis → Sospechamos esto más fuertemente si han pasado ya varios días desde el parto

Manejo:

- < 24 hrs:
 - SF EV (ABC)
 - Útero retraído → Sospecha de laceración → Revisión instrumental o manual de canal.
 - Útero distendido → Manejo inercia
 - Masajes + Uterotónicos (se da 1 uterotónico y luego ir a revisar en paralelo a poner otros)
 - Oxitocina
 - Carbetocina
 - Metilergonovina
 - Misoprostol
 - Revisión canal
 - Ligaduras
 - B-Lynch
 - Art. Uterinas
 - Art. Hipogástricas
 - HT
- > 24 hrs: sospecha restos ovulares o endometritis puerperal.
 - Antibióticos EV
 - + Legrado para remover si quedaran restos (bajo la cobertura ATB)

- Endometritis: si + fiebre, dolor, leucorrea, mal olor, muchos días postparto.

17. PARTO

Indicaciones de cesárea:

1. Cesárea previa: 2CCA, 1 corporal, 1 segmentaria <12 meses, 1 con necesidad misoprostol
2. Distocias de presentación: podálica, transversa, frente y cara (excepción mentoanterior-mentopública)
3. Desproporción cefalopélvica: TTC fracasada
4. Placenta Previa Oclusiva (PPO) total.
5. Macrosomía: > 4,5 kg (DM $\geq$ 4,3 kg).
6. Herpes genital activo
7. TU previo grande: condiloma gigante, Cáncer de cuello uterino por riesgo diseminación
8. <28 semanas o <1kg (relativo)
9. Necesidad interrupción rápida: no de cesárea en sí, pero la cesárea es lo más rápido x lo general.
 - a. SFA $\rightarrow$ TV para ver lo más rápido.
 - b. DPPNI
 - c. Corioanmionitis
 - d. PE severa/HELLP y similares.
10. **** NO: circular cordón, OHA, postérmino.

Fases del parto:

- Dilatación:
 - Latente: con cambios cervicales hasta los 3 cm.
 - Multípara: <14 hrs
 - Primigesta: <20 hrs
 - CONDUCTA: domicilio y consultar SOS o unas horas después.
 - Activa: $\geq$ 4 cm hasta dilatación completa.
 - MP: >1.5 cm/hr
 - PG: >1 cm/hr
 - CONDUCTA: hospitalizar en preparto
- Expulsivo: dilatación 10 cm hasta nacimiento (alargamiento hasta 1 hr mas si con anestesia)
 - MP: 60 min
 - PG: 120 min
 - CONDUCTA: hospitalizar en preparto.
- Alumbramiento: post nacimiento hasta expulsión total placenta.
 - MP <30 min
 - PG <45 min.
- Si avanza bien se observa, si es muy lento se hace prueba de parto.

Prueba de parto:

- Indicación: sospecha DCP, cuando parto no avanza
- Resultado:
 - Positiva: si se produce parto
 - Negativa: parto no avanza por DCP → cesárea.
- Esta prueba se hace a través de los elementos de conducción del T. de parto (3)
 - Oxitocina en goteo: para 3-5 CU / 10 min.
 - RAM
 - Anestesia: si dolor (dilatada 4-5 cm) – fase activa.
 - *Decubito lateral izquierdo

Caso 1	➡	RAM
Cefálica, CU: 4 en 10 min; E+2, Dilat: 5cm membranas íntegras, 2 horas: sin cambios		
Caso 2	➡	Oxitocina
Cefálica, CU: 2 en 10 min; E+0, Dilat: 7cm membranas rotas, 2 horas: sin cambios		
Caso 3	➡	Cesárea
Cefálica, CU: 4 en 10 min; E-2, dil: 10 cm membranas rotas, 2 horas: sin cambios		
Caso 4	➡	Hospitalizar
Cefálica, CU: 2 en 10 min; E-2 Dilat: 5cm membranas íntegras, Acaba de llegar		
Caso 5	➡	Enviar a domicilio
Cefálica, CU: 3 en 10 min; E-4 Dilat: 2cm membranas íntegras, Acaba de llegar		

18.PARTO PREMATURO

Se pregunta siempre y con detalle

Definición TPP: DU + Modificaciones Cervicales entre 22-37 semanas (antes es trabajo de aborto).

Incidencia 7-10%.

FR:

- **PP previo (más importante)**
- Útero grande (gemelar, GEG, PHA)
- Infecciones (PNA, vaginosis, IIA)
- **Cuello corto:**
 - <15 mm R50% parto en 7 días
 - >30 mm R1% en 7 días

Screening:

- Cervicometría a todas 20-24 sem x EcoTV.

- Si antecedente de incompetencia cervical: 11-14 semanas.
- Corte 25 mm
- Prevención:
 - Progesterona endovaginal: desde semana 16.
 - PP previo (16-36 sem)
 - Cervicometría <25 mm
 - Historia IC (abortos o PP muy prematuros), sem 16.
 - Cerclaje electivo: cuello corto +
 - Historia de Incompetencia Cervical: ≥ 2 abortos tardíos, ≥ 2 PP previos extremos (<28 sem).
 - Cerclaje de urgencia antes.

Manejo en agudo: paciente <37 sem con TPP.

- Definiciones:
 - Síntomas de PP o Amenaza de PP: DU regular 6 contracciones en 1 hr, 1 c/10 min. SIN modificaciones cervicales.
 - Trabajo de PP: DU regular 6 contracciones en 1 hr + Modificaciones cervicales.
- Síntomas de PP →
 - Bajo riesgo → se observa
 - Cuello > 30 mm → Observar x 1 hr.
 - Si cede DU o disminuye → domicilio.
 - Si empeora o modificaciones cervicales = TPP (amenaza de alto riesgo)
 - Alto riesgo → cervicometría alterada (cuello <30 mm) o mala evolución. Se maneja como Trabajo de PP.
 - < 15 mm → directo AMCT.
- TPP
 - > 34 semanas: evolución espontánea (ya tiene menor riesgo de complicaciones graves EMH, ECN)
 - < 34 semanas:
 - Tocolisis: objetivo frenar para dar CTC.
 - 1ra línea:
 - Nifedipino (>32 sem)
 - Indometacina (24-31 sem)
 - 2da línea:
 - Atosibán
 - Fenoterol
 - CONTRAINDICACIONES:
 - Absolutas:
 - >6 cm dilatación
 - Corioamnionitis
 - Malformación incompatible con la vida
 - Óbito

- Metrorragia severa
- Patología materna grave
- Deterioro grave UFP.
- Relativas:
 - 3-6 cm (desde fase activa no)
 - >34 sem
 - Madurez pulmonar (en AMCT)
 - Metrorragia moderada
 - RCIU
 - RPM
 - SHE.
- Corticoides: 24-34 sem. Se indica solo con el riesgo de PP.
 - Betametasona 12 mg/día IM x 2 días
 - Dexametasona 6 mg c/12 hrs x 4 veces (x 2 días)
 - Utilidad: disminuyen mortalidad neonatal, disminuyen EMH, HIC, ECN.
- Si no frena → AMCT para descartar infección → si tiene infección suspender Tocolisis y ATB.
 - Si descarto infección Tocolisis de 2da línea + Sulfato Mg.
- Sulfato de mg: carga 4 g en bolo, luego 2 gr/hr hasta parto
 - Disminuye parálisis cerebral.
 - Indicaciones: si falla tocolisis, y CI tocolisis.
- AMCT:
 - Cuello <15 mm
 - Falla respuesta tocolíticos
- Antibióticos: NO
 - Solo si IIA o RPM
 - Si prevención SGB:
 - Ampicilina 2 gr carga luego 1 gr/4 hr hasta parto.
 - PNC G 5 MM + 2.5 MM / 4 hr hasta parto.

19. ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS

Se abrevia RPM, se pregunta siempre, con bastante detalle

Rotura antes del Trabajo de Parto .

FR: PP previo, RPM previa, cuello corto, utero distendido, infecciones (= PP), otros: metrorragia 2do T, TBQ, AMC, cerclaje.

Complicaciones:

- Maternas: IIA/corioamnionitis, endometritis, sepsis, DPPNI
- Fetales: prematuridad, infección/sepsis fetal, otros: deformaciones esqueléticas, hipoplasia pulmonar, procidencia cordón.

Diagnóstico:

- Clínica: pérdida líquido claro con olor a cloro.
- EF: especuloscopia.
 - Líquido por OCE.

- NO TV: disminuye periodo latencia (aumento PP), aumento infecciones.
 - Solo TV si con DU, ver si partió con TPP.
- Si dudas:
 - Test cristalización: muestra desde el fdo de saco posterior en un porta objeto, mirar al microscopio → “hojas de helecho” confirma. FP: semen y mucus.
 - T. nitrazina: pH > 6 color azul confirmaría. FP orina, semen, sangre, mucus (no tan bueno)
 - Amniosure: glicoproteína PAMG-1 (alta S y E). Mejor rendimiento que el resto.
 - Eco: orienta si OHA, no es concluyente, requiere otra clínica o EF para complementar.

Diferencial:

- Leucorrea
- Tapón mucoso: 48 hrs anticipación parto. Secreción filante con tinte hemático.
- IOE
- Quiste vaginal o naboth
- Hidrorrea decidual.

Manejo:

- General:
 - Hospitalizar
 - Comprobar EG
 - Exámenes infecciosos: Hemograma + PCR, cultivos vaginales
 - Evaluación UFP doppler
 - NO tocolisis.
- >34 sem → ATB profilaxis SGB (ampicilina) + interrupción. Vía vaginal (misoprostol u oxitocina según Bishop) o cesárea.
- 24- 34 sem → hospitalizar
 - Exámenes (UFP, Hemograma PCR y cultivos vaginales)
 - ATB: ampi + eritro EV x 48 hrs, luego amoxi + eritro VO.
 - CTC
 - Amniocentesis: descartar IIA y ver madurez pulmonar... Indicaciones: Edad gestacional dudosa (posibilidad de que tenga madurez pulmonar) o clínica de infección sin criterios de corioamnionitis.
 - Interrupción a las 34 semanas o en caso de corioamnionitis clínica
- < 24 sem → ATB + expectante ambulatorio.
 - Similar a anterior, sin corticoides y ambulatorio hasta las 24 semanas. Mal pronóstico
- Corioamnionitis → ATB + interrupción inmediata (vía rápida, no siempre Cesárea, pero casi siempre a menos que venga con TDP avanzado)
- *** Con 1 CCA se contraindica PTV, porque no se puede dar misoprostol.

Caso 1	➡ RPO 30 sem
Corticoides + ATB + expectante	
Caso 2	➡ RPO sin EG; ECO: 30 sem
EG: 27 a 33 sem	
Corticoides + ATB + expectante	
Caso 3	➡ RPO sin EG; ECO: 32 sem
EG: 29 a 35 sem	
AMCT para determinar edad gestacional	

20. INFECCIONES OBSTÉTRICAS.

CORIOAMNIONITIS CLÍNICA

- Criterios de Gibbs: fiebre >37.8 - $38 + 2$ siguientes (hay que saberlos, se pregunta)
 - Taquicardia materna >100 lpm
 - Taquicardia fetal >160 lpm
 - Flujo vaginal purulento o mal olor
 - Dolor fondo uterino
 - Leucocitosis >15.000 .
- Diagnóstico es clínico
- Tratamiento: interrupción inmediata con ATB (clinda + genta)
 - Parto vaginal si esta avanzado
 - Cesárea si no.

INFECCIÓN INTRAMNIÓTICA

- Diagnóstico con AMCT: cualquiera de sgtes
 - Leucocitos >50 x mm³
 - Glucosa <15 mg/dl
 - LDH >400 U/L
 - Gram, cultivo o PCR (+).
- Tratamiento:
 - ATB: clinda + genta + eritro (micoplasma, ureaplasma)
 - Interrupción 32-34 semanas según clínica y parámetros inflamatorios.
 - Si <34 semanas corticoides.
 - NO tocolisis.

PROFILAXIS SGB (s.agalactiae)

- Indicaciones:
 - Sepsis neonatal previa
 - Bacteriuria por SGB
 - PP <37 semanas (FR de sepsis)
 - Cultivo positivo 35-37 semanas.
 - **Sin cultivo** pero con fiebre o RPM >18 hrs
- Esquema: durante el trabajo de parto fase activa.
 - Ampicilina 2 g EV

- Luego 1 gr c/4 hr
- Penicilina G 5 mill EV
 - Luego 2.5 mill c/4 hr

21. SÍNDROME HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO

Se pregunta siempre

- Clasificación:
 - PE: la mas frecuente y grave.
 - PE
 - Eclampsia
 - HELLP
 - HTA crónica
 - HTA crónica + PE sobreagregada
 - HTA gestacional (transitoria)
- Diagnóstico:
 - Screening: medición de PA a toda embarazada.
 - $\geq 140/90$
 - Confirmación con hospitalización por 6 hrs. Si persiste se diagnostica.
 - $\geq 160/110$: crisis HTA, diagnostico inmediato.
- Causas: según EG u proteinuria 24 hrs
 - <20 semanas → HTA crónica
 - >20 semanas
 - Proteinuria 24 hrs
 - Normal → HTA gestacional
 - Elevada (≥ 300 mg/24 hrs, o IPC ≥ 0.3) → PE
- Manejo: se hospitaliza la PE y se piden exámenes de severidad. A todas se controlan con niveles de proteinuria 24 hrs.
 - ** Gemelar o Mola se puede diagnosticar PE <20 semanas.

HTA CRONICA:

- Diagnostico: previo al embarazo, durante embarazo <20 semanas, persiste >12 sem post parto
- Manejo:
 - AAS 100 mg/dia como profilaxis: 12-36 semanas
 - Cambio de antiHTA por: alfametildopa, hidralazina (2ª línea)
 - Ecografía seriada (asociada a RCIU).
- Interrupción:
 - 40 semanas si no necesita fármacos
 - 38 semanas si requiere fármacos

HTA CR + PREECLAMPSIA

- Diagnostico: HTA cr + aparición de proteinuria >20 semanas.
- Manejo: = a PE.

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL

- Diagnóstico: SHE >20 semanas y antes del parto, sin proteinuria
- Importancia: riesgo de HTA a futuro, confusión con PE.
- Tratamiento:
 - o Parto (40 sem)
 - o Si PA >150/100 → manejo con alfametildopa
 - o Seguimiento con proteinuria semanal.

Caso 1 ➡ HTA crónica	Caso 4 ➡ HT gestacional
SHE, 34 años, embarazo 13 semanas Proteinuria negativa	SHE, 44 años, embarazo 33 semanas Proteinuria negativa
Caso 2 ➡ HTA crónica	Caso 5 ➡ Preclamsia
SHE, 44 años, embarazo 17 semanas Proteinuria 1 g/d	SHE, 28 años, embarazo gemelar 18 semanas; Proteinuria 1 g/d
Caso 3 ➡ PE	Caso 6 ➡ HTA crónica + PE
SHE, 22 años, embarazo 32 semanas Proteinuria 1 g/d	SHE, embarazo 12 sem. proteinuria 0,5 g/d; a las 32 semanas sube a 2 g/d

PREECLAMPSIA

- FR: **nuliparidad**, antecedente de PE, HTA crónica, nefropatía, microangiopatía, **emb multiple, mola**
- Predictor:
 - o Doppler arterias uterinas 22-24 semanas, S85%. (no es el screening)
- Prevención:
 - o Manejo FR
 - o AAS 100 mg/día
 - o Calcio si deficiencia.
 - o Doppler arterias uterinas 11-14 sem (screening)
- Criterios de severidad:
 - o PA $\geq$ 160/110
 - o Neurológico: eclampsia, excitabilidad neurológica (exaltación ROT)
 - o Renal: proteinuria >3 gr/día, creatinina >1 (falla renal)
 - o Hematológico: anemia, plaquetopenia (<100.000)
 - o CV: EPA, ICC.
 - o Hepático: aumento TA.
- Manejo:
 - o “Moderada” sin criterios de severidad:
 - General: hospitalizar, régimen normosódico, peso y diuresis diaria.
 - Evaluación UFP
 - Doppler semanal
 - Maduración pulmonar si 24-34 semanas.
 - Exámenes severidad: semanales.
 - AntiHTA: alfametildopa y eventualmente hidralazina si >150/100.

- Interrupción 37 semanas.
 - Severa:
 - General: hospitalizar, régimen 0
 - UFP diario o c/2 días con doppler semanal.
 - Maduración pulmonar si 24-34 sem
 - Exámenes severidad seriado
 - AntiHTA
 - Si crisis HTA: bomba labetalol EV (20 mg – 40 – 80 – 80)
 - Prevención eclampsia:
 - Sulfato de magnesio: 4 gr bolo, luego 1-2 gr/hr x 48 hrs mínimo.
 - Sonda Foley para medición de diuresis
 - ROT y frecuencia respiratoria. (hiporreflexia-bradipnea-arritmias)
 - Si PE moderada se administra solo en parto.
 - Interrupción: 34 semanas. Antes si compromiso fetal.
- SÍNDROME DE HELLP
- Criterios:
 - Hemolisis: anemia hemolítica, esquistocitos, LDH >600
 - Elevación enzimas hepáticas: GOT y GPT >70
 - Trombocitopenia: <100.000.
 - Diferencial:
 - Eclampsia
 - HGAE
 - PTT
 - SHU
 - LES
 - Complicaciones: CID, DPPNI, IRA, EPA, hematoma hepático (dolor epigástrico). Muerte fetal, RCIU, trombocitopenia neonatal, SDR. Rotura hepática.
 - Sospecha clínica: SHE + dolor HD + shock
 - Epigastralgia
 - Náuseas y vómitos
 - Cefalea severa o status mental alterado
 - Con o sin PA elevada.
 - Tratamiento: interrupción post estabilización materna, vía más rápida.
 - Previa administración SMg
- ECLAMPSIA: convulsiones o coma en paciente con PE.
- Síntomas predictores:
 - Tinnitus, fotopsias
 - ROT aumentados
 - Cefalea persistente
 - Visión borrosa
 - Fotofobia
 - Epigastralgia
 - Status mental alterado.

- Manejo:
 - Sulfato de magnesio (anticonvulsivante y evita recurrencias)
 - Interrupción inmediata luego de estabilizar x vía mas rápida.

22.RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO

RCIU vs PEG:

- RCIU: x insuficiencia placentaria
 - <p10, bajo su potencial genético
 - Riesgo de morbimortalidad
- PEG: genético/constitucional.
 - <p10 pero en su potencial genético.
 - Mismo riesgo que embarazo normal.
 - Es PEG si:
 - Doppler fetal normal
 - Todo normal
 - $\geq p3$

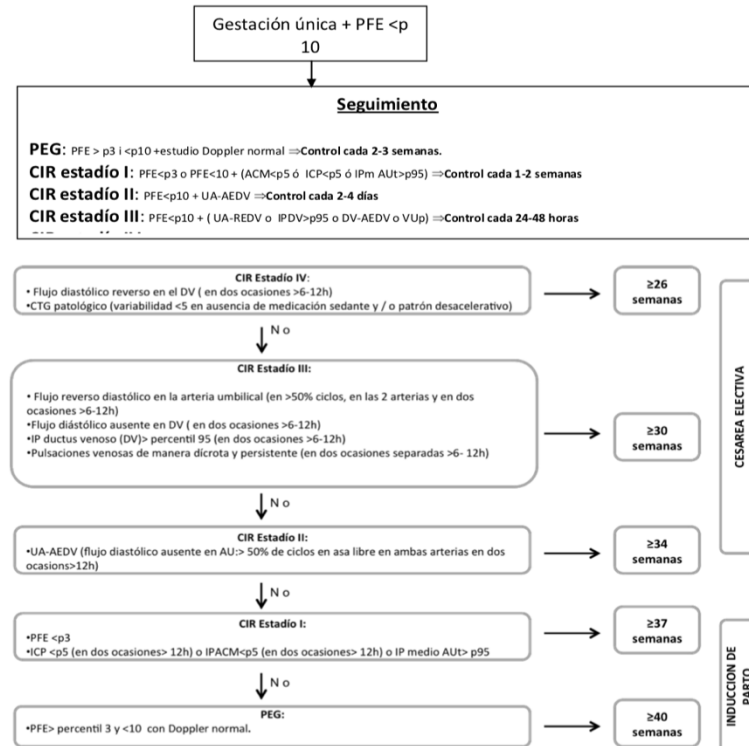
Clasificación:

- Proporción:
 - Simétrico:
 - Constitucional – PEG
 - Genopatías (severo)
 - TORCH (severo)
 - Asimétrico: x insuficiencia placentaria
- Temporalidad:
 - Precoz:
 - <32-34 sem
 - Toleran hipoxia
 - Tardío:
 - >34 sem
 - Menos tolerancia a la hipoxia
- Severidad:
 - Severo p0-p2
 - No severo >p2

Manejo:

- Doppler semanal.
 - Hemodinamia fetal (doppler art umbilical)
 - A. Umbilical: Flujo normal / Flujo ausente en diástole / Flujo reverso en diástole.
 - ACM
 - ICP
 - Ductus venoso: alteración → máximo riesgo de muerte fetal.
 - Arterias uterinas: definir si causa es por enfermedad placentaria.
- EG confiable: confirmar FUR y eco precoz.
- Ecografía c/2 semanas para evaluar crecimiento fetal
- Según sospecha: severo y simétrico:

- Cariograma o cariotipo
- Estudio TORCH
- Manejo general: reposo en decúbito lateral izquierdo e interrupción a diferentes EG.
- Interrupción
 - PEG → 40 sem, x PTV
 - Tipo I → 37 sem con opción de PTV (alguno de los sgtes) – doppler bueno.
 - > p3
 - ICP < p5 (2 ocasiones > 12 hrs)
 - IP ACM < p5 (2 ocasiones > 12 hrs)
 - IP medio AUt > p95
 - Tipo II → 34 sem, cesárea. (< p10 + alguno de los sgtes) – ya hay insuficiencia placentaria.
 - FDA en >50% ciclos en ambas arterias (2 ocasiones > 12 hrs)
 - P2.
 - Tipo III → 30 sem, cesárea (< p10 + alguno de los sgtes)
 - FDR en >50% ciclos en ambas arterias (2 ocasiones > 6-12 hrs)
 - IP ductus venoso > p95 o FDA DV (2 ocasiones > 6-12 hrs)
 - Tipo IV → 26 sem, cesárea (< p10 + alguno de los sgtes)
 - MEF patológico: variabilidad <5 en ausencia de sedante y/o patrón desaceleratorio
 - DV reverso (2 ocasiones > 6-12 hrs).



23. Psiquiatría obstétrica

Depresión en el embarazo

Es algo frecuente, siempre evaluar animo durante los controles.

Clínica y Dg es igual que en una no embarazada.

Tratamiento → Se intenta evitar los fármacos. En una depresión leve se trata solo con psicoterapia.

De agregar fármacos, se deben agregar ISRS. Los tricíclicos están totalmente contraindicados.

La sertralina es el ISRS de primera línea.

Si es muy severa y la paciente está psicótica, se puede ocupar la TEC

TAB en el embarazo

El embarazo es un descompensante del TAB. Los estabilizadores del ánimo tienen un riesgo muy alto, pues son potencialmente teratogénicos.

Diagnóstico es el mismo que en no embarazadas.

En las que estaban diagnosticadas de antes se ajusta el tratamiento, se deben suspender los fármacos y asegurar una buena red de apoyo.

En caso de que esté grave se deben mantener los fármacos, porque el riesgo de mantenerla sin fármacos es muy grave.

Si esta muy psicótica, se puede ocupar TEC

Depresión post parto o puerperal

TODO es igual que en la depresión del embarazo. La sertralina es el antidepresivo que menos pasa a la leche materna

Psicosis postparto

Alucinaciones, delirios y alteraciones importantes del comportamiento que ocurren en el puerperio. Habitualmente tiene varios días con inquietud, problemas para dormir y luego evoluciona con una psicosis.

Es de buen pronóstico a futuro, pero debes ser manejada adecuadamente durante esos días.

Se trata con antipsicóticos y se debe buscar la causa (TAB, EQZ, meningitis, etc.)

24. Atención del RN/ asfixia neonatal

1. Apgar: estado general del RN
 - Dirige la animación neonatal
2. Aseo
3. Apego
4. Profilaxis:
 - Colirio de gentamicina en ojos (evita conjuntivitis neonatal)
 - Vitamina K: coagulopatía RN
 - Vacuna BCG: > 2 kg
5. Antropometría: peso (3,5kg), talla (50 cm), CC (35 cm)
6. Examen físico: buscar malformaciones
7. Screening (a las 48 hrs): TSH y PKU (fenilcetonuria).

APGAR			
	0	1	2
FC	0	<100	>100
Resp.	No	Débil	Vigorosa
Tono	No	Hipotónico	Movimiento
Color	Cianosis general	Cianosis Extrem.	Rosado
Reflejo Catéter	No	Mueca	Tos, llanto

Asfixia neonatal:

- causa: hipoxia intraparto (habitualmente por accidente placenta y cordón)
- criterios:

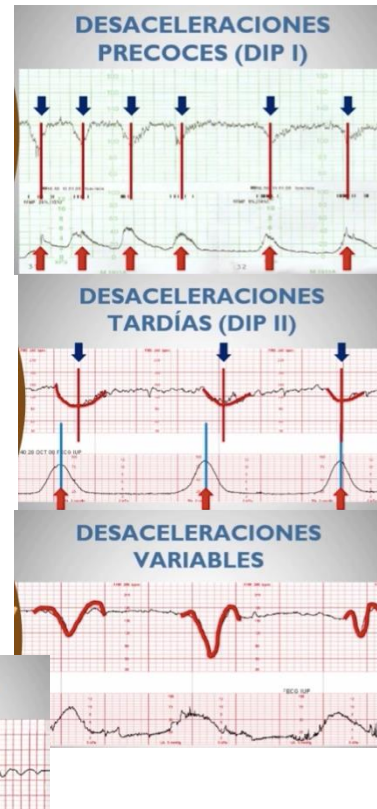
- > Apgar entre 0-3 a los 5 min
- > $ph < 7$
- > Encefalopatía hipoxisquémica (CC, convulsiones, hipotonía)
- > afectación otros sistemas (renal, hemato, GI, etc)
- Manejo: reanimación neonatal + soporte.
 - > Reanimación:
 1. evaluar cada 30 seg cm el apgar.
 2. Estimular + oxígeno
 3. VPP (con ambu) se mantiene mientras $FC < 100$ y en apnea.
 4. Masaje cardíaco: siempre y cuando su $FC < 60$ o paro (desde inicio junto a VPP)
 5. Adrenalina (0.01 mg/kg ev y si no hay vía venosa: 0.1 mg/kg TOT)

25.Detección de hipoxia fetal:

Tema difícil, se pregunta a veces

Hipoxia intraparto:

1. MEFI: Evalúa 5 elementos
 - FCF basal: 110-160
 - Variabilidad: 5-25 lpm (moderada)
 - Ausente—sin variabilidad
 - Mínima→ Oscilación mínima, menor a 5
 - Moderada→ entre 5 y 25, normal
 - Aumentada→ Variación mayor a 25
 - Aceleraciones (son normales)
 - Desaceleraciones:
 - > Precoces (DIP I): normales (reacción vagal x compresión cabeza)
 - > Tardías (DIP II): hipoxia fetal. Décalage de más de 15-20 seg
 - > Variables: compresión cordón umbilical. Joroba de camello (con aceleración post)
- Patrón sinusoidal: malo, de tipo pre mortem.



- MEFI I: tranquilizador (FCF normal, variabilidad normal, aceleraciones, puede tener DIP I).
Conducta: Expectante, TV para evaluar parto.

- MEFI II: Sopechoso, no es I ni III.
Conducta: Igual que MEFI III

- MEFI III: anormal/ominoso (patrón sinusoidal, variabilidad mínima +: DIP II, desaceleraciones variables o bradicardia)

Conducta MEFI II y III: reanimación intrauterina (oxígeno a la madre, lateraliza decúbito izq, suspender el goteo oxitocico) si no mejora en 30 min > interrumpir por la vía más expedita.

- Bradicardia sostenida con FC < 100 en > 10 min: interrupción más expedita.
- Interrumpir por vía más expedita:
 - > indicación: hipoxia intrauterina. En este caso, para determinar la vía más expedita se debe hacer TV: está en condiciones para hacer un forceps? (Cefalica, expulsivo es decir 10 cm dilatación, tercer plano o E + 2).



Si no está en condiciones de PV x forceps se hace cesárea de urgencia.

2. ph cuero cabelludo



Hipoxia anteparto:

1. RBNE:

- indicación: 1ª línea frente a hipoxia anteparto.
- interpretación: ≥ 2 aceleraciones en 20 min. Si: reactivo. No: no reactivo (se alarga x 20 min, si no reactivo pido otro examen)

2. PBF: ecografía (8 pts) + RBNE (2pts) (total 10/10)

- evalúa la vitalidad (similar apgar)
- mov fetales: 2
- mov respiratorios: 2
- tono fetal: 2
- LA: 2
- interpretación:
 - $\geq 8/10$: tranquilizador, se observa
 - 6/10: indeterminado, se decide con el LA: si 2/2 (observar) 0/2 (OHA, interrumpe) con el TV para ver vía.
 - $\leq 4/10$: ominoso, interrumpir vía más expedita xq hay sufrimiento fetal

3. TTC (test de tolerancia las contracciones): goteo oxitocico siempre y cuando tenga > 36 sem, es el más sensible. (Pb: antes de eso puede desencadenar un TP prematuro)

- mido el registro FCF en relación a las contracciones.
- normal: no hay desaceleraciones
- positivo: más del 50% de las CU con desaceleraciones tardías.
- Interpretación: igual al MEFI.

26. PUERPERIO

PUERPERIO NORMAL

- Definición: periodo desde el parto – 6 semanas después.
- Normal:
 - o Dolor
 - o Loquios
 - o Lactancia: calostro (amarillo) – leche.
- Manejo: educación, técnica lactancia materna, evaluación posibles patologías.

FIEBRE PUERPERAL

- Causas:
 - Mastitis
 - Endometritis
 - Tromboflebitis séptica
 - TVP/TEP
 - Otras
- Manejo: buscar y tratar la causa.
- **ENDOMETRITIS PUERPERAL**
 - Agentes: polimicrobiano.
 - Clínica: fiebre
 - Mayor dolor a lo esperado
 - Loquios de mal olor o purulentos
 - Metrorragia
 - Diagnóstico clínico
 - Tratamiento:
 - Clindamicina + Gentamicina
 - Si grave o refractario → histerectomía.
- **TROMBOFLEBITIS SÉPTICA:**
 - Evolución de endometritis a TVP de venas pélvicas.
 - Clínica: = endometritis
 - Sugerente: mejora con los ATB, pero persiste febril.
 - Diagnóstico: TAC de pelvis.
 - Tratamiento: ATB + Heparina/luego TACO
- **TVP/TEP:**
 - Causa: embarazo y puerperio aumentan riesgo (además trombofilias, etc).
 - Clínica: dolor y aumento de volumen, empastamiento. Si TEP dolor, desaturación súbita.
 - Si clínica lo sugiere es una TVP/TEP hasta demostrar lo contrario.
 - Diagnostico:
 - TVP: doppler EEII
 - TEP: angioTAC Tx.
 - **Dimero D NO sirve** (aumenta con puerperio y además ya hay alto riesgo)
 - Tratamiento: heparina/TACO

PATOLOGÍA MAMARIA: ninguna contraindica la lactancia, en todas hay que mejorar la técnica de lactancia materna.

- **CONGESTIÓN MAMARIA**
 - Causa: mala técnica de lactancia
 - Clínica: dolor y congestión, SIN fiebre ni eritema. (puede tener sensación febril)

- Tratamiento: técnica LM, si mucho dolor PCT.
- **MASTITIS**
 - Causa: mala técnica + sobreinfección (s.aureus / s.pyogenes)
 - Clínica: dolor y congestión + fiebre y eritema
 - Tratamiento: cloxacilina 500 c/8 hr EV u ambulatorio con amoxi/clavulánico. X 10 días.
 - Alergia: clindamicina 600 c/8
 - Mejorar técnica.
- **ABSCESO MAMARIO**
 - Causa: mala técnica + s.aureus.
 - Clínica: dolor, eritema y fiebre + masa palpable, no responde a antibióticos.
 - Si duda diagnóstica se puede hacer ecografía
 - Tratamiento: ATB + drenaje y aseo quirúrgico.
 - + Mejorar LM
- **GRIETAS DEL PEZON**
 - Causa: mala técnica
 - Clínica: dolor y grietas, puede haber sangrado y deglución sangre x RN (hematemesis)
 - Tratamiento: mejorar técnica
 - Pomadas de lanolina o leche, no sirven.
- **PUNTO BLANCO**
 - Causa: obstrucción conducto galactóforo, por trauma que hace el RN o infeccioso (si viene con clínica de mastitis)
 - Clínica: dolor + punto blanco en pezón
 - Tratamiento: calor local, si falla punción. Siempre mejorar técnica.
- **GLANDULA MAMARIA ACCESORIA**
 - Causa congénita
 - Clínica: aumento de volumen en la axila, consistencia tensa (lleno de leche). Con dolor y puede tener eritema.
 - Tratamiento: educación. Tienden a involucionar. Puede quedar con analgesia (PCT/AINES)
- **PEZONES PLANOS E INVERTIDOS.**
 - Causa: normal (variación, pezón no se diferencia de areola o están invertidos, desde siempre, si no pensar en CA)
 - Tratamiento: mejorar técnica de lactancia, no importa forma de pezón si no de areola entero.

GINECOLOGÍA

1. AMENORREA

AMENORREA PRIMARIA:

- Definición: ausencia de menarquia
 - o 13 años sin desarrollo puberal (retraso de pubertad)
 - o 15 años con desarrollo puberal
- Causas:
 - o Genéticas/Hormonales (sin desarrollo puberal) → hormonas varias, cariograma (descartar XO, hipersensibilidad andrógenos)
 - o Anovulación (con desarrollo puberal) → prueba de progesterona si a los 15 años amenorrea con desarrollo puberal.
 - o Malformaciones: de conductos de Müller (himen imperforado, ausencia útero, etc.) → Eco TR.

AMENORREA SECUNDARIA:

- Definición: ausencia menstruación por >90 días o >3 ciclos.
- Causas:
 - o Fisiológicas:
 - Embarazo
 - Lactancia
 - Menopausia
 - o Patológicas:
 - Hormonales
 - Anatómicas.
- Enfrentamiento clásico (obsoleto pero útil):
 - o 1º → Test embarazo: BHCG.
 - o 2º → TSH y PRL: descartar hipotiroidismo e hiperprolactinemia.
 - o 3º → prueba de progesterona
 - Positiva (menstrua): Anovulación (SOP)
 - Negativa: continuar estudio
 - o 4º → estrógeno + progesterona
 - Positiva: Hipogonadismo.
 - 5º → FSH y LH.
 - o Hipergonadotrópico → ovárica (menopausia o falla ovárica prematura 40 años)
 - o Hipogonadotrópico → hipotalámico/hipofisiario → RNM silla turca.
 - Negativa: causas uterinas (anatómico) → Eco TV.
- Actualmente se pide todo junto y se interpreta en conjunto.



Estradiol	↓	CASO 1 35 años, sin antecedentes ↓ Menopausia precoz	Estradiol	N	CASO 2 40 años, antec. Legrado post-aborto ↓ Sd. Asherman (sinequias uterinas)
Progesterona	↓		Progesterona	N	
FSH	↑		FSH	N	
LH	↑		LH	N	
PRL	N		PRL	N	
TSH	N		TSH	N	
HCG	(-)		HCG	(-)	
Anti-Mülleriana	↓		Anti-Mülleriana	N	
Estradiol	↓	CASO 3 30 años, ant. hemorragia puerperal y luego agalactia ↓ Sd. Sheehan	Estradiol	↑	CASO 4 22 años, acné ↓ Anovulación SOP
Progesterona	↓		Progesterona	↓	
FSH	↓		FSH	N	
LH	↓		LH	↑	
PRL	↓		PRL	N	
TSH	↓		TSH	N	
HCG	(-)		HCG	(-)	
Anti-Mülleriana	N		Anti-Mülleriana	↑	

Amenorrea primaria

Ausencia de menarquia a los 15 años con desarrollo puberal o a los 13 los sin desarrollo puberal (retraso de pubertad).

Causas

- Anovulación → Viene con desarrollo puberal. Se pide prueba de progesterona
- Genéticas / hormonales → Sin desarrollo puberal. Se piden todos los exámenes y cariotipo para descartar un síndrome de Turner
- Malformaciones → Generalmente uterinas. Se pide con ecografía transrectal

2. OLIGOMENORREA Y SOP

OLIGOMENORREA: ciclos largos de >35 días.

- Causas: similar a amenorrea, lo más frecuente es el SOP.

SOP:

- Diagnóstico: 2/3 criterios
 - Menstrual: amenorrea u oligomenorrea
 - Hiperandrogenismo
 - Clínico: acné, hirsutismo (vello en zonas androgénicas)
 - Laboratorio: IAL > 4.5 (testosterona/SHBG)
 - Ecográfico: EcoTV
 - >12 folículos o >10 cc por ovario.

- Tratamiento:
 - Causa: por RI y genético.
 - Dieta + Ejercicio + Metformina
 - Hiperandrogenismo: ACO antiandrogenico
 - Dienogest, Clormadinona, Drospirenona, Ciproterona (más antiandrogenico pero RCV).
 - Depilación
 - Manejo acné
 - Infertilidad:
 - Inductores ovulación: citrato clomifeno (inhibidor receptor de estrógenos, evita feedback e induce peak de LH), HCG (simula peak de LH), análogos GNRH.

Otras causas de hirsutismo/hiperandrogenismo

- Aumento DHEAS:
 - Enfermedad de Cushing
 - Hiperplasia suprarrenal congénita: con insuficiencia suprarrenal asociada, tendencia hipotensión, hiperpigmentación.
 - TU virilizante adrenal.
- Aumento testosterona:
 - TU virilizante ovárico.
- ACO proandrogénicos:
 - Levonorgestrel, Norgestrel.

3. SANGRADO UTERINO ANORMAL

Nomenclatura antigua

- Polimenorrea: ciclo <21 días.
- Oligomenorrea: ciclo >35 días
- Hipomenorrea: escasa, <2 días o <20 cc
- Hipermenorrea: abundante, >7 días u 80 cc
- Metrorragia: sangrado fuera del ciclo.
 - Funcional: > edad fértil
 - Atrofia: > menopausia
 - HPE y CA endometrial.

Nomenclatura nueva: SUA (causas → PALM – COEIN)

- P: pólipos
- A: adenomiosis
- L: leiomiomas
- M: HPE y CA

- C: coagulopatía – hemostasia primaria
- O: ovarios disfuncionales – SOP
- E: atrofia endometrial (postmenop)
- I: iatrogenia
- N: no clasificado.

Metrorragia:

- Manejo:
 - EDAD FERTIL:
 - 1º Test embarazo
 - 2º EcoTV
 - Miomas:
 - Hipermenorrea → tratamiento miomas
 - Metrorragia → biopsiar, porque miomas poco causan metrorragia.
 - 3º Biopsia endometrial, si Eco no demuestra causa o hay engrosamiento endometrial.
 - Pipelle
 - Randall
 - Lgrado.
 - Estudio EvW si clínica general o es desde menarquia.
 - MENOPAUSIA
 - 1º Eco TV
 - LE:
 - < 4 mm sin TRH o < 8 mm con TRH → Atrofia endometrial (> frecuente)
 - > de esto → biopsia
 - HPE
 - CA
 - Si asintomática, pero LE aumentado, si > 11 mm se biopsia igual.

4. PATOLOGÍA UTERINA

BENIGNA

- Miomatosis: neoplasia benigna, dependiente de estrógenos
 - Clínica: mayoría asintomáticos, pueden tener hipermenorrea, abortos y PP, TU pélvico.
 - Clasificación:
 - Intramurales (> frecuentes)
 - Submucosos: más sintomáticos
 - Subserosos (TU pélvico)
 - Diagnóstico: EcoTV, TU sólido hipo o hiperecogénico, homogéneo.
 - Tratamiento:
 - Asintomático: observar.
 - Sintomático: cirugía
 - Miomectomía o Resectoscopia.
 - Histerectomía (paridad cumplida)
 - Riesgo Qx muy alto: se puede tratar de achicar con agonistas GnRH (se pierde pulso y bloquea eje).

- Perimenopausia: se podría observar, ya que se irá achicando.
- Adenomiosis: idiopático, endometrio invade miometrio.
 - Clínica: dismenorrea + hipermenorrea + aumento de tamaño uterino liso.
 - Diagnostico: EcoTV: miometrio heterogéneo.
 - Tratamiento: según paridad cumplida se hace histerectomía y luego biopsia. Si quiere paridad observar y agonistas GnRh.
- Polipos endometriales: neoplasia benigna del endometrio
 - Clínica: hipermenorrea
 - Diagnostico: EcoTV – histerosonografía
 - Tratamiento: HCP con polipectomía-resectoscopia.

MALIGNA

- Hiperplasia endometrial/ Cáncer de endometrio
 - Causa: estrógeno >> progesterona.
 - FR: HONDA
 - HTA
 - Obesidad
 - Nuliparidad
 - DM2
 - Anovulación
 - Clínica: metrorragia (SUA). Útero agrandado.
 - Diagnóstico:
 - EcoTV: endometrio grueso e irregular
 - Biopsia de endometrio.
 - Tratamiento:
 - HE simple: progestágenos VO o DIU medicado.
 - HE atípica y/o compleja: histerectomía.
 - Se podría intentar ciclar y legrado.
 - Cáncer: histerectomía + QMT + RDT.

5. LEUCORREAS

Se preguntan siempre

- Vaginosis bacteriana: gardenella vaginalis (desequilibrio bacteriano)
 - Clínica: leucorrea blanca-gris, mal olor a pescado podrido, sin inflamación.
 - Diagnóstico: clínico.
 - KOH o test de aminas (+)
 - pH > 4,5.
 - MO: clue cells
 - Tratamiento: metronidazol 500 mg c/12 hr x 7 dias.
 - Tambien se puede usar monodosis de 2 gr.
 - Clindamicina ovulos también puede usarse.

- Candidiasis: candida albicans
 - Clínica: leucorrea blanca grumosa, prurito e inflamación.
 - Diagnóstico clínico, pH <4, MO levaduras (hifas)
 - Tratamiento: fluconazol 150 mg x 1 vez
 - Se pueden usar ovulos de clotrimazol VV
-
- Tricomoniasis: trichomona vaginalis (ETS)
 - Clínica: leucorrea grisácea-verde-amarilla, espumosa, mal olor (podrido), mucha inflamación (cuello en fresa), disuria, prurito.
 - Diagnóstico: clínico, pH >4, MO protozoo flagelado.
 - + pedir el screening de ETS.
 - Tratamiento: metronidazol 2 gr VO x 1 vez + tratar pareja.
 - Tinidazol
 - Ovulos MTZ.

Otras causas:

- Cervicitis:
 - Solo cuello afectado, vagina normal. ETS
 - Causas: gonorrea y clamidia
- PIP: fiebre + dolor + leucorrea desde OCE. ETS
- Cuerpo extraño: más en niñas x papel higienico, fétido, metrorragia.
- Cáncer.

	Vaginosis	Cándida	Trichomona
Síntoma	Olor a pescado	Prurito vaginal	Ardor, disuria, prurito
Leucorrea	Blanco grisácea	Blanca grumosa (leche cortada)	Amarilla verdosa y espumosa
Olor	pescado	No	Podrido
Inflamac.	-	++	++++ (Cuello en fresa)
Durante la menstruación	aumenta la leucorrea y mal olor	igual	aumenta leucorrea
pH	>4.5	<4	>4
Microscop.	Clue cells (Células clave)	Cándida (levadura hifada)	Trichomonas (Protozoo flagelado)
KOH P. de aminas	+ (aumenta el olor a pescado)	-	-

6. QUISTE BARTHOLINO Y FURÚNCULO GENITAL

No se ha preguntado nunca, pero está en el temario

QUISTE DE BARTHOLINO:

- Causa: obstrucción glándula.
- Clínica: aumento de volumen **dentro de labio menor**.
- Diagnostico clínico
- Tratamiento: observar. Qx si es muy grande → solo drenaje o marsupialización.

ABSCESO BARTHOLINO:

- Causa: gonorrea y clamidia, también x otras bacterias
- Clínica: aumento volumen, dolor, eritema, misma ubicación.
- Diagnostico clínico
- Tratamiento: drenaje Qx, ATB amplio espectro (azitro+ceftriaxona, o ceftriaxona+doxi+clinda)

FURÚNCULO PERIGENITAL

- Causa: infección folículo x s.aureus
- Clínica: aumento volumen, dolor, eritema, en zona **lateral a labios mayores**.
- Diagnostico clínico
- Tratamiento: observar, drenaje si absceso, se puede dejar antibiótico que cubra s.aureus, como cloxa, flucloxa, amoxi-clav, clinda, etc.

7. PATOLOGIA CERVICAL

Se pregunta SIEMPRE

PREVENCIÓN CCU

- Vacunación: prevención primaria
 - o Serotipos:
 - 6 y 11 condiloma
 - 16 y 18 CCU
 - o Quienes: niñas y niños 4-5 básico.
- PAP: **prevención secundaria**, no evita desarrollo si no que detecta estadios iniciales.
 - o Cuando:
 - GES: 25-64 años c/3 años
 - Ideal (Soc GO): desde inicio AS anualmente. Si 3 negativos, se puede espaciar c/3 años si mantiene una pareja sexual estable.
 - o Resultados:
 - Normal: control en 1-3 años
 - Muestra satisfactoria, sin atipias ni alteraciones citologicas.
 - Atípico: derivar para colposcopia y biopsia (a patología cervical)
 - ASC-H: atipias escamosas de alto grado.
 - o Colposcopia y biopsia:
 - Normal y PAP bajo grado → PAP en 1 año
 - Normal y PAP alto grado → Cono frío (Por disociación colpo-citológica)
 - Insatisfactoria (no ve zona de transición) → curetaje endocervical (CEC)
 - ASCUS: atipias escamosas de significado incierto
 - o PAP en 6 meses
 - o Tipificación VPH
 - Alto grado → Colpo

- Bajo grado → PAP en 6 meses
 - Colpo y biopsia. → si N → PAP en 1 año.
- AG: atipias glandulares
 - Colpo y biopsia + CEC (curetaje endocervical).
 - Normal → Bx endometrio (x disociación)
- AGUS: atipias glandulares de significado incierto.
 - = AG.
- Si en especuloscopia veo lesión: derivar a colposcopia y biopsia.
- Otros resultados:
 - Inflamatorio inespecífico (normal) → PAP en 1 año
 - Inflamatorio específico → Manejo según causa (gonorrea – ceftriaxona, trichomona-metronidazol)
 - Cándida solo tto si sintomático
 - Actinomyces: observar, es normal, solo se trata si PIP.
 - Muestra insatisfactoria → repetir de inmediato
 - Atrofia → estrógeno tópico + repetir PAP en 4-6 meses.
 - Células endometriales:
 - Fértil → observar
 - Menopausia → Se estudia como SUA en menopausia, con eco/bx endometrio.

PATOLOGÍA MALIGNA

- NIE:
 - Causas: VPH 16 y 18
 - Clínica: asintomática, hallazgo PAP y colpo.
 - Colpo: lesión acetoblanca – punteado rojo – reticulado – vasos sanguíneos, ulceraciones, etc. (ya es más cáncer)
 - Diagnóstico: biopsia
 - Clasificación: según grado de atipias en las células.
 - NIE 1
 - NIE 2
 - NIE 3
 - CIS (CA que no invade MB)
- CÁNCER CERVICOUTERINO:
 - Causa: VPH 16 y 18 (alto grado, 31, 33, 45, etc.)
 - Clínica: genitorragia, sinusorragia, asintomático (hallazgo PAP + colpo c/bx)
 - Diagnóstico: colpo c/bx
 - Lesión ulcerada, irregular
- Tratamiento de todos:
 - NIE 1:
 - Seguimiento con PAP y colposcopia c/6 meses.
 - Crioterapia: quemar con nitrógeno líquido
 - Tipificación de VPH
 - NIE 2, NIE 3, CIS:
 - Conización terapéutica: Cono LEEP (con electro, cono caliente)

- Riesgo de incompetencia cervical en próximos embarazos
 - CCU:
 - < 4 cm: histerectomía radical (TODO utero + anexos + tercio superior vagina).
 - Seguimiento PAP de cúpula vaginal
 - Buen pronostico
 - > 4 cm: QMT + RDT.
 - Si mucha MTT paliativo.
- ** Cáncer de vagina:
 - Causa, Diagnostico, Tratamiento y Clínica similar a CCU.
 - + Prurito vaginal + Adenopatías inguinales.
- Lo que mas determina el pronostico es la INVASIÓN DE PARAMETRIOS.

8. TUMOR OVÁRICO

General:

- Riesgos:
 - Cáncer
 - Torsión ovárica.
- Manejo:
 - TU palpable o hallazgo → Eco TV
 - Observar: si benigno
 - < 5 cm
 - Observar + ACO + control con EcoTV. (más frecuente tipo funcional que desaparecen con ACO)
 - Quirúrgico con Bx intraoperatoria
 - Malignidad:
 - Sólido o solido-quístico
 - Increscencias
 - Tabiques
 - Excrescencias
 - Ascitis, líquido libre.
 - También si:
 - > 10 cm
 - > 5 cm que no responde con ACO x 3 meses
 - Eco maligno
 - CA 125 elevado (>35 si postmenopausica/>200 e. fertil)
 - Biopsia rápida intraoperatoria:
 - Si confirma CA, seguir operando, sacar todo, tomar más muestras (cirugía radical)
 - Si no, cerrar.
 - Tipo de cirugía:
 - LPC generalmente.

- Joven: tumorectomía.
- Menopausia: anexectomía (trompa, ovario, anexos)

CÁNCER DE OVARIO:

- FR: antecedentes familiares (BRCA1), nuliparidad.
 - ACO NO SON FR, son PROTECTORES (menor estimulación ovárica)
- Clínica: dolor abdominal inespecífico, ascitis.
- Diagnóstico: ecoTV – Qx – Bx rápida intraoperatoria
- Tratamiento: cirugía + QMT (x lo general quimiosensibles, la idea de la cirugía es citorreducción).
 - Si MTT, quimioterapia paliativa

TU FUNCIONALES:

Quiste folicular

- Muy frecuentes, son hallazgos normales.
- Estudio con EcoTV: simple, benigno
- Tratamiento observar, se pueden dar ACO si esta duda.

Cuerpo lúteo:

- En fase lútea y en embarazo es normal.
- Estudio con EcoTV: TU solido-quístico (en edad fértil o embarazo)
- Tratamiento: observar evolución, igualmente se puede dar ACO si esta la duda.

TERATOMA

- EcoTV: lesión solida heterogénea en mujer joven. Puede tener dientes, pelos, etc.
- Tratamiento: cirugía, por riesgo de torsión.

SD DE MEIGS

- Diagnostico: EcoTV
 - Fibroma + Ascitis + Derrame pleural.
- Tratamiento: cirugía.

ENDOMETRIOMA:

- Causado por endometriosis
- Clínica: dismenorrea importante, que aumenta con el tiempo. Puede aumentar el CA 125.
- Diagnostico: EcoTV
 - Lesión quística con contenido de “vidrio esmerilado”
- Tratamiento cirugía.

9. Algia pélvica aguda

Se pregunta con alguna frecuencia

- Causas:
 - Digestivas: apendicitis, diverticulitis etc.
 - Ginecologías:
 - Ovulación dolorosa: en el día de la ovulación (ciclo-14), buen estado general, puede tener blumberg (confunde con apendicitis),

Eco TV (folículo roto, líquido libre escaso que es lo que irrita), tto: AINES

- Cuerpo luteo hemorrágico: en fase lutea (después día 14 o ovulación), buen estado general, puede tener un blumberg. Eco TV (cuerpo luteo grande y heterogéneo), Tto: AINES.
- Degeneración roja miomatosa: antecedente mioma, se infarta, clásico en embarazo. Dg: Eco TV (mioma aspecto heterogéneo), Tto: AINES.
 - Miomas y embarazo: 1/3 aumenta de tamaño, 1/3 se achica, 1/3 queda igual. Complicaciones: degeneración roja es frecuente, aborto, parto prematuro. Tto: observación.
- Torsión ovárica: antc de tumor ovárico (> 5 cm que persiste), dolor intenso, síntomas neurovegetativos (sudoración, vómitos). Dg: eco TV con doppler (aumento de tamaño y sin flujo), basta la sospecha clínica para el dg. Tto: distorsión por vía quirúrgica x LPC.
- PIP: Triada (fiebre+ leucorrea+ dolor), Dg clínico pero se pide Eco TV para mostrar ATO, Tto: Atb y si ATO cirugía por LPC.
 - Obstétricas: aborto, embarazo ectópico, corioamnionitis.
- Enfrentamiento:
 - Buscar la causa y tratarla
 - Anamnesis y EF completo
 - Test embarazo (edad fértil)
 - Evaluación por ginecología
 - Elección: eco TV
 - Manejo según causa específica
- Clínicas específicas de algunas de estas causas

10.PIP

- Causa: endometritis o salpingitis (gonococo y chlamydia), pero cuando evoluciona a ATO significa infección por anaerobios y gram negativos.
- FR: promiscuidad, DIU (reciente instalación)
- Clínica: fiebre + leucorrea+ dolor (palpación uterina, palpación anexial, movilización cervical)
- Dg: clínica (exs de apoyo dg: aumento PCR y VHS, aumento de blancos)
- Eco TV: puede mostrar ATO
- Tto: ATB (amplio espectro que cubra ETS), si esta bien VO si no EV
 - Ej. Ceftiaxona (cubre gonococo y gram (-)) + doxi (chlamydia) + clinda (cubre anaerobios y gram +)
 - Si ATO: cirugía x LPC (importante el drenaje para el pronóstico de la fertilidad)
- Si viene con toda la clínica de apendicitis?? Dg clínico por ende tiene que ir a apendicectomía, pero como es mujer edad fértil hacer antes test embarazo y evaluación x ginecólogo.

11. Algia pélvica crónica

- Causas:
 - Digestivas: Sd. Intestino irritable (la más común) y otras que no importan.
 - Ginecológicas:
 - Dismenorrea primaria
 - Dismenorrea secundaria: endometriosis, adenomiosis, malformaciones uterinas
- Enfrentamiento: anamnesis y examen físico y **ver si es o no cíclica**
 - Cíclica: Dismenorrea (causa ginecológica) → Eco TV → Manejo según causa
 - Excepción: endometriosis, puede venir con Eco TV normal, habría que hacer una LPC.
 - No cíclica: causa digestiva.
- Dismenorrea primaria:
 - Dolor cíclico, desde la 1ª menstruación, dolor leve a moderado, examen físico normal.
 - Dg: clínico
 - Tto: AINES (ácido mefenámico)
- Dismenorrea secundaria:
 - Clínica: dolor cíclico, después de la 1ª menstruación, progresivo, muy intenso en ocasiones.
 - Manejo: eco TV
 - Tto: según causa, AINES (ácido mefenámico).

Adenomiosis

Clínica → Dismenorrea, hipermenorrea. El útero se palpa grande y liso.

Endometriosis:

Clínica → Dismenorrea que aumenta con el tiempo, disquexia (dolor al defecar), dispareunia (profunda- dolor durante las relaciones sexuales), infertilidad. No hay alteraciones menstruales.

- Clínicas específicas de algunas causas

Endometriosis:

- Causa: muchas teorías (La más aceptada: flujo reverso asociado a obstrucción del tracto de salida menstrual)
- Clínica: **dolor** dado por dismenorrea secundaria, disquexia (dolor al defecar), dispareunia e **infertilidad**. NO afecta flujo rojo ni flujo blanco.
- Dg: Laparoscopia de elección, **antes eco TV** (buscando otras causas. Se ve normal o endometrioma en algunos casos)
- Tto: Muchas opciones
 - De elección es la cirugía por LPC donde se fulguran los focos de endometriosis.
 - Agonistas de GnRH (atrofian endometrio), se hace antes de la cirugía si es muy grave, para achicar los focos endometriósicos. .

- ACO (atrofian endometrio) , disminuye el dolor pero aumenta infertilidad. Es **solamente sintomático**
- AINES: acido mefenamico
- Menopausia es la cura

Caso 1 ➡ PIP	Caso 3 ➡ Endometriosis
Mujer 32 años, dolor a las relaciones sexuales en aumento, desde hace 7 días. Al examen dolor a la palpación anexial y movilización del cuello.	Mujer 28 años, usuaria de DIU, consulta por dismenorrea y disporeunia profunda de 8 meses de evolución, que ha ido en aumento
Caso 2 ➡ Endometriosis	Caso 4 ➡ Cáncer cuello uterino
Mujer 33 años, dismenorrea intensa, de varios meses. No ha quedado embarazada, a pesar de 2 años sin MAC. Dolor y dificultad para mover el cuello	Mujer 42 años, dolor a las relaciones sexuales y sinusorragia, en aumento, desde hace 2 meses.

12. Infertilidad

Imposibilidad de lograr embarazo a pesar de estar 1 año intentándolo sin MAC. Es un Dg de pareja

- Clasificación:
 - Primaria: Pareja nunca han logrado embarazo juntos. Aunque él o ella tenga hijos con otra pareja, si llevan un año intentándolo es infertilidad 1ª igual, es un dg de pareja.
 - Secundaria: 1 o mas embarazos previos (con o sin abortos)
- Causas:
 - Masculina: 40% (Azoospermia, oligospermia, teratospermia)
 - Anovulacion 25% (SOP, obesidad)
 - Tubo-peritoneales 20% (PIP)
 - Endometriosis 10%
 - Otras: insuficiencia lútea, patología cervical, malformaciones del utero
- Estudio: Sigue un orden
 - Primera línea
 - Masculino: Espermiograma
 - Anovulacion: seguimiento folicular (Eco TV seriadas), tb ve SOP
 - Factor cervical: test postcoital (Se toma una muestra del semen en fondo de saco post coito durante ovulación, si están bien el moco esta bueno, si están todos muertos se dice que el moco tiene alguna alteración)
 - Segunda línea:
 - Tubo-peritoneal: Histerosalpingografía
 - Tercera línea:
 - Endometriosis: LPC
- Tratamiento: depende de la causa
 - Masculina: fertilización artificial o fertilización in vitro o donante

- Anovulacion: inductores (estimulan el peak LH): citrato de clomifeno o HCG
- Falla ovárica: donante
- Tubo-peritoneal: cirugía
- Endometriosis: cirugía
- Vientre de alquiler.
- Adopcion.
- Riesgos:
 - Embarazo gemelar/multiple > que se puede producir en la inducción, in vitro
 - Sd hiperestimulacion ovárica > se genera en relación a la inducción (dolor abdominal, ascitis, aumento de Hcto con hemoconcentración, SIRS que se puede complicar con EPA, hepatitis, muerte.
 - Tto: soporte. En pacientes graves se puede dar cabergolina (agonista adrenergico)

13.Métodos anticonceptivos

Se ha preguntado poco

Clasificacion:

- Naturales:
 - Beneficios: aceptado por el cristianismo, sin RAM
 - Riesgos: embarazo
 - Coitus interruptus
 - Ducha vaginal
 - Metodo de la Tª (después ovulación aumenta Tª)
 - Método de Billings: único un poco mejor con índice de Pearl 2% (similar al del condon). Moco cervical cada vez mas filante durante fase folicular, luego después de ovulación se seca el moco.
 - Requisitos: conocer el ciclo menstrual
 - Ventana fértil: 5 días antes hasta del dia mismo de ovulación.
- De barrera
 - Beneficios: único previene ETS
 - Riesgos: embarazo, Pearl 2%
 - CI: alergia a latex
 - Preservativo: elección en sexo casual y promiscuidad
 - Condon femenino: incomodo
 - Diafragma: no protege ETS
- DIU
 - Beneficios: dura 5-10 años
 - Riesgos: aumenta la dismenorrea, hipermenorrea, PIP (al ponerlo y sacarlo)
 - Si embarazo: riesgo de Emb ectópico y aborto
 - CI: promiscuidad sexual, dismenorrea, hipermenorrea, nulípara.

- SI asociado a PIP: ATB, sacarlo solo si no responde a tto atb a los 3 días.
- DIU medicado: Levonogestrel
 - Casi 100% efectividad, Pearl 0,2% (mas eficaz)
 - R: PIP
 - CI: mirena
- Hormonales
 - Beneficios: efectivo (si los toma)
 - RAM: nauseas, aumentar RCV, mas riesgo de cáncer de mama.
 - Disminuye riesgo cáncer endometrio y ovario (bloqueo del eje y baja de gonadotropinas)
 - CI:
 - Hepatopatias: agudas o crónicas
 - Jacqueca (relativa): solo si producida o agravada por estos
 - LES (relativa)
 - Alto riesgo CV
 - Fumadora > 35 años
 - TVP/TEP
 - Ca mama (personal)
 - Ca endometrio
 - Metrorragia de causa desconocida
 - Melanoma
 - Vias administración:
 - Oral (simple): paso hepático, eso hace que aumente la dislipidemia y mayor RCV
 - Transdermica y Anillo vaginal: **sin paso hepático, elección en riesgo CV y dislipidemia.**
 - Inyectables e implantes SC: solo levonogestrel (practicos cada mucho tiempo), malo es que se asocian a spotting y subida de peso.
 - ACO:
 - Estrogenos: etinilestradiol (dosis)
 - Microdosis 15 a 20 ug: menos RAM, **mas spotting**
 - Dosis estandar (30 ug): mas RAM, menos spotting (en caso de dar microdosis y que haya spotting)
 - Progestageno: varía según generaciones
 - Proandrogénicos: levonogestrel, norgestrel
 - No androgenicos: desogestrel, gestodeno, norgestinamato
 - Antiandrogénicos: clormadinona, drospirenona, dienogest, ciproterona (x algunos meses si SOP, hirsutismo y acne x mas RCV)
 - LACTANCIA: progestagenos solos sin estrogenos (disminuye la leche). Puedo no darle nada si: LME, < 6 meses, amenorrea.

- Quirúrgicos
 - B: permanente
 - R: permanente
 - CI. Posibilidad de arrepentimiento
 - Ligadura tubaria: se aprovecha la cesarea
 - Emb ectópico? Si es que llega a haber emb
 - Vasectomía: ligadura de conducto deferente, riesgo quirúrgico mas bajo que la ligadura de trompa.
- La elección depende de beneficios, RAM y CI

14. CLIMATERIO, MENOPAUSIA Y TRH

Se pregunta bastante

- Conceptos:
 - Climaterio: periodo previo y después de menopausia, producido por caída de hormonas sexuales.
 - Menopausia: última regla de la vida
 - Diagnóstico retrospectivo después de 1 año.
 - Promedio 50 años.
 - Normal: > 40 años.
 - Precoz: < 40 años (riesgo de complicaciones asociadas)
- Ventajas: Se termina la dismenorrea, endometriosis, miomas, adenomiosis, mastalgia, embarazo y sd. premenstrual.
- Desventajas: clínica
 - Bochornos
 - Aumento riesgos:
 - Osteoporosis
 - IOE
 - Atrofia genital
 - Prolapso genital.
 - RCV
 - Depresión
- TRH: vía de administración, CI y RAM = ACO
 - Indicación: disminuir síntomas vasomotores (bochornos)
 - Además utilidad para osteoporosis (pero tto de esto es Ca + VitD + BF + ejercicio)
 - Regla general:
 - Estrógeno (baja potencia, E. conjugados) + Progesterona (=ACO, antiandrogénico).
 - Histerectomía: SOLO estrógenos.
 - Si sólo síntomas genitales: tratamiento con lubricante genital, si todavía mal, estrógenos vía tópica.
 - *Tibolona: menor R CA mama (=)
 - *Raloxifeno: disminuye el CA mama, pariente de Tamoxifeno. Disminuye además RCV. Pero aumenta los bochornos, no se usa por lo tanto como TRH. Se usa como tratamiento de osteoporosis.

- * no se usan de rutina.
- Si CI → AD IRS/Duales si bochornos.

Climaterio:

- Climaterio: periodo antes y despues de la menopausia: caída de hormonas sexuales.
- Menopausia: ultima regla de la vida. Dg retroactivo (1 año)
 - Habitual: 45-55 años (promedio 50 años)
 - Normal: desde los 40 años en adelante
 - Precoz: antes de los 40 años (mas riesgo osteoporosis, atrofia genital etc)
- Ventajas:
 - Se acaban: dismenorreas, endometriosis, miomas, adenomiomas, mastalgias, embarazo (MAC), sd premenstrual
- Problemas:
 - Bochornos (calor en cara), aumenta riesgos (osteoporosis, incontinencia urinaria, atrofia genital, prolapso genital, CV, depresión)
- TRH
 - Vias administración, CI, RAM > igual a ACO
 - Indicación: disminuye los síntomas vasomotores (bochornos)
 - Además útil: para la osteoporosis (no es su tratamiento)
 - Tto: calcio + vit D + bifosfonatos
 - Regla general: estrógenos + progestágeno
 - Dejan estrógenos de baja potencia: conjugados o estriol
 - Progestageno: igual ACO (antiandrogenico como drospirenona)
 - Histerectomia: solo estrógeno
 - Solo síntomas genitales: lubricantes genital
 - Si no anda bien solo estrógenos tópicos
 - ¿? Agonistas selectivos del R estrógeno (Tibolona y Raloxifeno)
 - Tibolona: menor riesgo de CA de mama
 - Raloxifeno: disminuye el CA de mama, disminuye el RCV, lo malo es que aumenta los bochornos (se usa por ende en tto de osteoporosis)

15. Prolapso genital

Patología frecuente, se pregunta

- Causa: multiparidad (PV> cesarea)
- Clínica: sensación de peso y humedad genital, tumoración genital, aumenta al toser y valsava.
- Dg: clínica (punto de reparo es el introito- plano de himen) para ver la severidad
- Clasificación:
 - Anterior: cistocele y uretrocele > se trata con colporrafia o vaginoplastía anterior.

- Medio: histeroceles > Se trata con histerectomía + fijación de cúpula
- Posterior: rectocele, enterocele > Se trata con colporrafia posterior o vaginoplastia posterior.
- Tto: cirugía
 - Si riesgo qx es muy alto se puede indicar un pesario o colpoclis (cierra la vagina > fin a la vida sexual)

16. Ginecología infantil

Se pregunta seguro (gine y/o pediatría)

- Metrorragia prepuberal
 - Causa: traumatismo (mas fr), cuerpo extraño vaginal, otras (vulvovaginitis, violación)
 - Manejo y dg: exploración, vaginoplastia, eco TR
 - NO TV, no especuloscopia, no eco TV.
 - Tto: según causa
- Leucorrea prepuberal
 - Causa: vulvovaginitis inespecífica (75% de los casos), Cuerpo extraño vaginal, vulvovaginitis específicas (candida etc)
 - Manejo y dg: = igual que la metrorragia (exploración y vaginoscopia) + gram y cultivo
 - Flujo normal: en RN y pubertad (mucoso transparente)
 - Prepuberal? Siempre patológico
- Vulvovaginitis inespecífica
 - Causa: 70% de las leucorreas prepuberal
 - Debido a alteración de la flora vaginal, estrepto A, neumococo, Haemophilus, virus, shigella, klebsiella, enterococo.
 - Clínica: inespecífica (leucorrea amarillenta, eritema)
 - Dg: clínico, se complementa con gram y cultivo
 - Tto: aseo + atb
- Cuerpo extraño vaginal
 - Causa: papel higiénico, otros
 - Clínica: leucorrea purulenta, mal olor, metrorragia
 - Dg: clínico
 - Tto: sacarlo
- Sinequias vulvares
 - Causa: mala higiene/inflamación, Dermatitis del pañal, Idiopática
 - Clínica: adherencias entre labios menores
 - Dg. Clínico
 - Tto: masajes con vaselina líquida + aseo
 - Si falla se puede remover con cirugía.
- Hallazgos normales en niñas

- RN: normal metrorragia, flujo mucoso, botón mamario. (x estrógenos maternos)
- Lactantes: botón mamario (hasta el año tanto en hombres como mujeres)
- Adolescentes postmenarquia → 2 años ciclos irregulares

Resumen Guevara by creggers

Pediatría

Si señores, ha llegado el momento de esta mierda



Video representativo de mis emociones al respecto:

https://www.youtube.com/watch?v=31g0YE61PLQ&ab_channel=ragnorak7

1. Ictericia neonatal

Se pregunta SIEMPRE (2 preguntas)

Puede ser fisiológico o patológico. El riesgo va a estar dado por la encefalopatía hiperbilirrubinémica (Kernicterus, genera una parálisis cerebral, ES PREVENIBLE)

Puede ser Fisiológica o patológica y precoz o tardía

Precoz, es siempre patológica (antes de las 24 horas, son de predominio indirecto)

- Hemólisis ABO
- Hemólisis Rh
- Sepsis
- Crigler Najjar

Tardía (después del 6º día)

Prolongada (duran más de 10 días). Lo importante en este tipo de ictericia es dividirlas en si son de predominio directo (Atresia biliar primaria o hepatitis neonatal) o indirecto (por lactancia materna o Hipotiroidismo)

Ictericia fisiológica

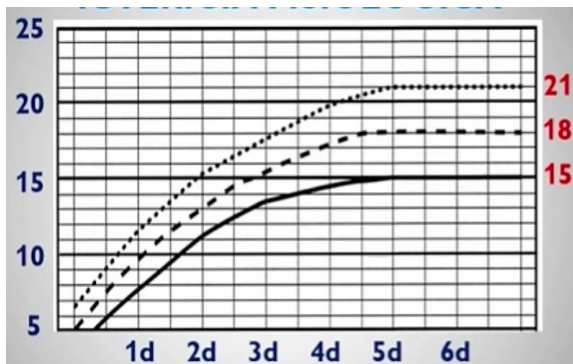
La producción de bilirrubina producida en los primeros días de vida es mayor a la capacidad del clearance de esta. Se asocia a parto prematuro y cefalohematomas.

Inicia después del 2º día y antes del 5º día y no suele durar mas de 7 días (nunca debería durar más allá del día 10)

Es de predominio indirecto, llega hasta los muslos y no da más síntomas.

El diagnóstico es clínico, pero hay que pedir niveles de bilirrubina para determinar la severidad.

Tratamiento→ Observación, pero si está por sobre cierto nivel se debe realizar fototerapia (exsanguineotransfusión es otra terapia en caso de que esté muy grave, pero se ocupa muy poco)



Las 3 líneas son los límites para las guaguas de bajo, intermedio o alto riesgo en base a la cantidad de días y los niveles de Bb en sangre.

RN de bajo riesgo → Sin patologías que nació después de las 38 semanas

RN de riesgo intermedio → Nacido entre las 35-37 semanas **o** con factores de riesgo (asfixia, alteraciones enzimáticas, etc.)

RN de alto riesgo → nacido entre las 35-37 semanas **y** con factores de riesgo (asfixia, alteraciones enzimáticas, etc.)

Aquellos nacidos antes de las 34 semana tiene su propio nomograma para determinar riesgo de Kernicterus

Van a presentar mayor riesgo de Kernicterus:

- A menor edad gestacional
- Mayor nivel de bilirrubinemia
- Menor edad gestacional
- Con factores de riesgo.

Ictericia precoz (aparece durante las primeras 24 horas de vida)

- Se pide hemograma, grupo y Rh, Coombs directo para buscar hemolisis y hemocultivo para buscar sepsis.

El tratamiento es la observación cuando es leve, fototerapia si la requiere y puede llegar hasta la exanguineotransfusión. Estas hiperbilirrubinemia son las mas graves y riesgosas.

Ictericias hemolíticas

Por incompatibilidad por grupo ABO. Este tipo de incompatibilidad se da desde el 1er embarazo. La incompatibilidad Rh se da a partir del segundo embarazo, pues necesita sensibilización (la madre tiene que ser negativa y el papa positivo).

El diagnóstico se hace con un Coombs **directo** DE LA GUAGUA, que va a estar positivo, lo cual, nos demuestra que hay anticuerpos atacando a los glóbulos rojos del niño. (Además tienen anemia con htco bajo 45 y esquiztositos).

Dg.

- Coombs Directo (+)
- Hgma: anemia (Hcto < 45)
- Frotis: esquiztositos

Prevención de isoinmunización Rh

La isoinmunización Rh se da para evitar la sensibilización de las mujeres Rh (-) durante el primer embarazo (suelen sensibilizarse durante el parto, momento donde hay mas intercambio de sangre entre RN y madre).

En este se debe pedir un Coombs **indirecto** para determinar si está sensibilizada. Si da negativo significa que no está sensibilizada y se puede aplicar el rhogam (para evitar la sensibilización).

En caso de que sea positivo (la madre está sensibilizada) no se puede hacer nada, se debe seguir estrictamente con doppler fetal de la ACM para determinar el grado de anemia de la guagua.

Administración de Rhogam: se da a las 28 semanas y durante las primeras 72 horas postparto en las madres Rh negativas (este es la dosis más importante). También se puede dar ante cualquier situación en que haya habido intercambio de sangre entre madre y feto (Aborto, embarazo ectópico, mola, amniocentesis, metrorragias o amniocentesis)

	Madre	RN	Desde
Incompat. ABO	O →	A o B	1er emb.
Incompat. Rh	(-) →	(+)	Desde 2do emb.

Ictericia tardía y prolongada

Tardía → Desde el día 6 o 7 en adelante

Prolongada → Mas de 10 días

Se debe pedir la bilirrubina total y directa.

Predominio indirecto:

Si es de predominio indirecto se sospecha de Hipotiroidismo (se pide TSH), pero si la TSH es normal es por lactancia materna.

Predominio directo:

En caso de que sea de predominio directo se debe pedir una eco abdominal para descartar atresia biliar primaria.

Ictericia por lactancia materna

Inicia al 4-7 día llegando a su máximo el día 14-20 (es prolongada) y puede durar hasta 3 meses.

Siempre está en niveles bajo 20mg/dl.

Es un diagnostico de descarte. El tratamiento es simplemente la observación, se mantiene la lactancia materna, pero en el caso de que se eleve mucho la bili se puede dar fototerapia.

NUNCA suspender la lactancia materna, podría aumentar el número de tomas diarias, pero nunca suspender.

Atresia biliar primaria

Es una obstrucción idiopática de la vía biliar. Es una ictericia tardía (14-21 días) de predominio DIRECTO, por lo que, puede venir con coluria y acolia.

El diagnostico es con la eco abdominal y el tratamiento es quirúrgico (Cx de Kasai), idealmente antes de las 8 semanas. Después de esto el niño probablemente va necesitar de un trasplante hepático.

Caso 1	➡ AB1ria
RN 20 días, ictericia y coluria.	
Caso 2	➡ Fisiológica
RN 5 días, ictericia hasta muslos que inició hace 2 días. Madre O-Rh(+). Niño A-Rh(-)	
Caso 3	➡ Leche materna
RN 18 días, ictericia hasta muslos. BiliT: 15; BiliD: 2; TSH: normal.	

Caso 4	➡ Hemólisis ABO
RN 2 días, ictericia marcada que inició a las 12 horas de vida. Madre primípara O-Rh(-). Niño A-Rh(+)	
Caso 5	➡ Hemólisis Rh
RN 10 horas, ictericia hasta muslos. Madre múltipara A-Rh(-). Niño B-Rh(+)	

2. Síndrome de distress Respiratorio

Se pregunta siempre

Es una clínica inespecífica dada por taquipnea, aleteo nasal, quejido, cianosis, uso de musculatura accesorio y desaturación. El diagnóstico es clínico y la radiografía me ayuda a determinar la causa. Las causas son múltiples y el tratamiento es siempre con soporte.

Taquipnea transitoria (TT)

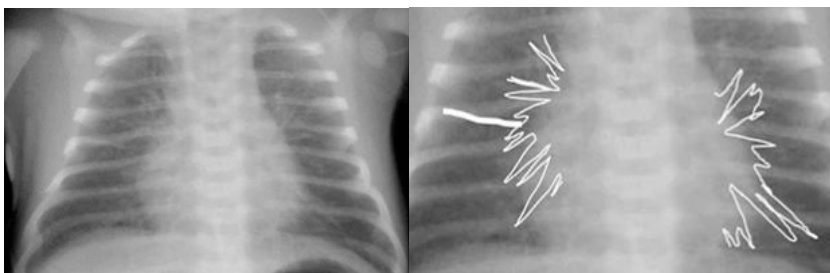
Es una demora en la reabsorción del líquido pulmonar.

FR:

- Prematurez (de las 37 semanas hacia abajo).
- Cesárea (no está sometido al stress del parto que ayuda en la reabsorción del líquido)

Clínica: Distress leve que responde bien a oxígeno en baja concentración.

Rx: Suele ser normal o mostrar un pulmón húmedo (hilos marcados con leve derrame o cisuritis, como una ICC en un adulto).



Se observan un cisuritis e hilos prominentes

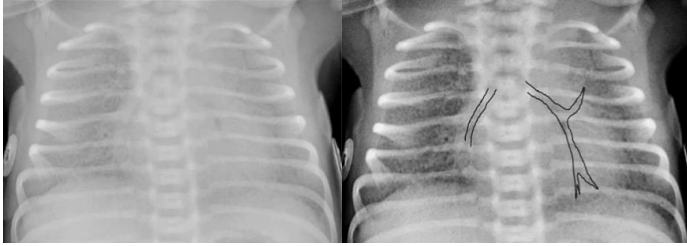
Tratamiento: Simplemente dar oxígeno en baja dosis.

Enfermedad por membrana Hialina (EMH)

Es de los más graves. Su causa es la falta de surfactante pulmonar, siendo su principal factor de riesgo la prematurez menor a 34 semanas (hijo de madre diabética también es factor de riesgo, hasta las 35 semanas en este caso).

Clínica: SDR severo

Rx: Se ve una condensación bilateral con broncograma aéreo y vidrio esmerilado.



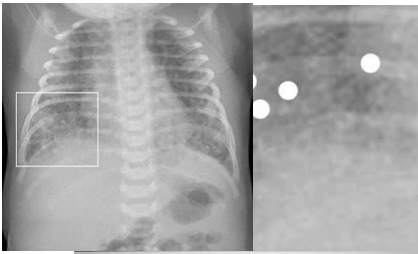
Tratamiento: Oxígeno y surfactante pulmonar sintético. Generalmente se dan ATB, porque las neumonías se ven iguales, una vez descartada se sacan estos.

Síndrome de aspiración meconial (SAM)

El principal factor de riesgo es la asfixia neonatal, porque en este momento se libera el meconio. EL RN post termino también tiene este riesgo por insuficiencia placentaria (riesgo de asfixia más alto) y porque ha juntado meconio por mas semanas.

Clínica: SDR severo (como en EMH) + clínica obstructiva con sibilancias, tiene riesgo de progresar a neumotórax. Suele venir con antecedente de meconio en LA.

Rx: se ven infiltrados bilaterales multifocales.



Tratamiento: Soporte

Hipertensión pulmonar persistente (HPP)

Al haber hipoxia hay vasoconstricción de los pulmones que me genera más hipoxia y se produce un circulo vicioso.

FR: Asfixia neonatal y otras causas de SDR porque todas generan hipoxia.

Clínica: SDR severo con cianosis que **no responde a oxígeno**

En un niño cianótico y que además tiene un soplo, por lo cual, hay que sospechar una cardiopatía, si no hay soplo probablemente es HPP. En caso de que haya duda diagnóstica se administra prostaglandina E1 que mantiene el ductus abierto

Rx: suele ser normal o presentar las características de la patología que está causando la hipoxia.

Tratamiento: Reanimación neonatal buscando romper el circulo vicioso, el oxígeno es el vasodilatador más importante de los vasos pulmonares, pueden terminar en VM.



3. Tipos de Recién nacidos

Recién nacido de pretérmino

Aquel que nace antes de las 37 semanas

Riesgos: Primera causa de muerte en niños es la prematurez y problemas asociados (EMH, ECN, HPV, Hipoglicemia, hipocalcemia, sepsis, ictericia, etc.), especialmente aquellos que nacen antes de las 34 semanas. Se complican con EMH, enterocolitis necrotizante y hemorragia periventricular, las cuales pueden ser prevenidas con la administración de corticoides prenatales. La hipoglicemia es la complicación más frecuente (+ hipocalcemia, hipotermia, sepsis, anemia e ictericia)

Recién nacido post termino

Aquel que nace después de las 42 semanas. Su principal riesgo es la insuficiencia placentaria, de esto salen el resto de los problemas como la hipoglicemia, asfixia, poliglobulia y aspiración de meconio.

El embarazo se interrumpe a las 41 semanas con misoprostol si se esta prolongando o con cesárea si está indicada

Recién nacido pequeño para la edad gestacional (PEG)

Peso menor al percentil 10 para la edad gestacional.

Sus riesgos vienen dados de la insuficiencia placentaria (hipoglicemia, poliglobulia, asfixia e hipotermia, porque vienen muy flacos).

El manejo es igual que el RCIU en base al doppler

Recién nacido Grande para la Edad Gestacional (GEG)

Peso mayor al percentil 90 para la edad gestacional

Esta muy relacionado con la diabetes gestacional aunque también los hay fisiológicos.

Riesgo de hipoglicemia y poliglobulia.

Se debe pedir HGT a las 2 horas en caso de que no sea hijo de madre diabética.

Recién nacido hijo de madre diabética (HMD)

Recién nacido de madre diabética o con diabetes gestacional.

La macrosomía es la principal complicación y las complicaciones obstétricas derivadas de esto (indicación de cesárea sobre 4.2Kg). Hacen hipoglicemia y poliglobulia también. A todo hijo de madre diabética se le debe pedir un HGT a las 2 horas, porque la hipoglicemia es la complicación más frecuente.

En caso de ser hijo de madre con diabetes pregestacional, se agregan los riesgos de malformaciones, PE y RCIU.

4. Patología neonatal

Hipoglicemia

Tiene múltiples factores de riesgo (PEG, EMD, GEG, Pre o postérmino). La clínica es muy similar a la del adulto (generalmente un RN tembloroso que llora). Se manifiesta con mayor frecuencia a las 2-4 horas.

Como screening se puede HGT a las 2 horas (si esta limite bajo se repite en 2 horas más)

EL diagnostico es con **HGT menor a 45 mg/dl**, la cual, debe ser confirmada con glicemia venosa. Manejo: Suero glucosado vía oral si la glicemia está sobre 30 y el niño está bien Si con síntomas o HGT bajo 30 se debe dar Suero glucosado EV.

Hipocalcemia

Trastorno hidroelectrolítico mas frecuente en el RN, sus FR son ser HMD y prematuro. La clínica viene dada por alteraciones del SNC + hipotonía, convulsiones + tetania (espasmos musculares), pueden haber arritmias como torsión de puntas. El dg es con el calcio total (menos a 7) o iónico (Menos de 3.5). Si es leve simplemente se observa evolución. Si es severa (síntomas o 1 punto bajo limite inferior), se debe dar gluconato de calcio EV

Poliglobulia neonatal

FR (GEG, PEG, MHD, postérmino, PE, RCIU y demora en cortar el cordón umbilical). El niño suele verse de color más rojo, pueden hacer convulsiones y se suele asociar a hipoglicemia. El dg es con hematocrito sobre 65%.

Manejo→Sobre 70% se hace una eritroféresis (sueroclisis), en la cual, se saca sangre y se mete suero, para diluir el exceso de GR. Si es menor a 70% y está asintomático se puede observar.

Encefalopatía hipóxico-isquémica

Es debido a asfixia neonatal y cualquier causa que genere hipoxia intrauterina. La clínica va a estar dada por una encefalopatía (letargia, hipotonía, convulsiones, etc.). El diagnostico es de exclusión descartando otras causas (hipocalcemia, hipoglicemia, poliglobulia) y aparte se le pide una eco cerebral.

El tratamiento es solo soporte y rehabilitación si queda con alguna secuela.

Convulsiones neonatales

Se tratan con fenobarbital. Se debe tratar la causa descompensante y solucionarla.

Sepsis neonatal

El agente suele ser el Strepto agalactiae (Grupo B) y en segundo lugar la E. coli. El principal, FR es ser RN prematuro, por eso a todos los prematuros se le hace profilaxis para Strepto grupo B. Rotura prematura de membranas e infección intramniótica también son FR, pero el principal es la prematurez.

Clínica→Fiebre (mas de 38), hipotermia, letargia, convulsiones, hipotonía, rechazo alimentario, ictericia, hepatoesplenomegalia (no teniéndola al momento del nacimiento).

Un niño que se me hecha a perder desde el día 2 en adelante tiene una sepsis hasta que se demuestre lo contrario. Se piden muchísimo exámenes, siendo hemograma, PCR y cultivos los más importante (PL, orina, Rx Tx, hemocultivo).

Ante la sospecha se inician ATB (Ampicilina + cefotaxima o gentamicina).

5. Microcefalia, macrocefalia y cefalea

Microcefalia→Perímetro craneano bajo -2 DE (ajustado por sexo y edad). Las causas son múltiples siendo la principal el TORCH, genético o por noxas intrauterina que hayan afectado el

desarrollo fetal (sd alcohólico fetal). A las microcefalias se asocia discapacidad cognitiva en un 85% de los casos. El diagnóstico es totalmente clínico, el cual, debe ser complementado con una neuroimagen para evaluar si hay causas manejables.

Macrocefalia → Perímetro craneano sobre +2 DE (Ajustado por sexo y edad). Suele ser genético (constitucional) y en segundo lugar la hidrocefalia. El 90% son genéticas y si los papas son cabezones no hay que asustarse, pero hay signos de alarma ante los cuales pedir neuroimagen

Signos de alarma:

- Examen neurológico alterado (Hipotonía, espasticidad, convulsiones)
- Avance de la macrocefalia
- Signo de la puesta de sol (teniendo el niño los ojos abiertos, se puede ver la esclera sobre el iris, es un signo de hidrocefalia). El dg suele ser antenatal por la eco obstétrica.

Solo se pide neuroimagen si hay signos de alarma, porque suele ser constitucional.

Tratamiento → Depende de la causa

Cefalea

El enfrentamiento es igual los adultos, es decir, una buena anamnesis y examen físico y si no hay signos de alarma se da analgesia y fin. De haber signos de alarma (Signos meníngeos, alteración del examen neurológico o del FO), se debe pedir una neuroimagen o PL si se sospecha meningitis.

6. Neurología pediátrica

Parálisis cerebral

La clínica viene con retraso del DSM + que el niño **no pierde** los hitos del DSM que ya ha ganado, **no retroceden** en esto. 70% viene con espasticidad (el otro 30% con hipotonía). 80% de los casos tiene un CI normal, las alteraciones son motoras.

Causas → TORCH, asfixia neonatal, meningitis Bacteriana, Kernicterus

El diagnóstico es absolutamente clínico. El tratamiento es multidisciplinario

Síndrome hipertónico e hipotónico

El tono normal de los RN es flexor con reflejos arcaicos simétricos. Si viene muy duro es hipertónico si viene muy flácido es hipotónico.

Pueden ser de causa central (lo más común, 80%) dentro de esto, lo más común, es la encefalopatía hipoxico-isquémica (por asfixia neonatal). Otras causas son la genopatías como el síndrome de Down.

Dentro de las causas de tipo periférica (menos comunes) tenemos la hipomagnesemia (las mas común) algunas neuro y miopatías.

El tratamiento de el hipo e hipertónico es tratar la causa. Lo que importa es poder diferenciar si es central o si es periférico

Central → Convulsiones, compromiso de conciencia o con signos focales (espasticidad o hipotonía en un solo hemisferio). **Su estudio es con una neuroimagen.**

Periférica→ Arreflexia, hipoventilación, alteración ELP y CK elevada. **El estudio es con electromiografía.**

Reflejos arcaicos→ Normales al nacer y duran un par de meses. (no se han preguntado nunca)

Succión, búsqueda, marcha automática, prensión palmar duran 3 meses

Reflejo de moro→ 3-6 meses

Prensión plantar→ 9-10 meses

Reflejos de protección→ Aparecen después, de los 6 meses en adelante (paracaídas anterior, lateral y posterior) y presentes hasta la adultez.

Hitos del DSM

Se evalúan en conjunto, solo uno alterado no significa tanto.

Hay que saberse los hitos del desarrollo psicomotor a los 2, 4, 6, 9, 12 y 24 meses, no preguntan más.

El primer año se desarrolla mas lo motor.

Control de cabeza 2 meses

Control de tronco 4 meses

Sentarse 6 meses, sin apoyo a los 8 meses

Caminar 12 meses (**red flag a los 18 meses**)

El 2º año de vida es cuando se empieza a desarrollar más el lenguaje.

2 meses sonrisa social

4 meses se ríe a carcajadas

Palabras a los 10-18 meses (si no se comunica de forma verbal quizás es sordo, pero si no se comunica de ninguna forma hay que pensar en enfermedades del espectro autista)

Motor 1er año	1) Cabeza (2 m) 2) Tronco (4 m) 3) Sentarse (6-8 m) 4) Caminar (12-18 m)
Lenguaje 2do año	1) Sonrisa (2 m) 2) Risa (4 m) 3) Alguna palabra (10-18m) 4) Frases (2 años) 5) Se les olvida hablar bien (adolescentes)

7. Síndrome de Down

Se ha preguntado 1 vez

Clínica

- Hipotonía
- Fascie característica
- Discapacidad cognitiva

La intensidad de los síntomas puede ser muy variable de un niño a otro. El principal FR es la edad materna (a los 30 años el riesgo es de 0,1% a los 40 es de un 1% y a los 50 años es 10%)

El diagnostico es clínico, pero se confirma con cariotipo.

El diagnostico se puede hacer de forma antenatal en la ecografía de las 11-14 semanas

NO ES CAUSAL DE ABORTO (trisomía 13 y 18 sí, porque son incompatibles con la vida)

Tratamiento

Multidisciplinario para estimular al niño las mas posible.

Fenotipo:

Epicantos

Separación mas grande entre los ojos

Puente nasal deprimido

Inserción baja de las orejas

Macroglosia

Leve microcefalia

Mano simial



Enfermedades asociadas

- Cardiopatías congénitas (Canal auriculoventricular las más común)
- Malformaciones gastrointestinales (Atresia esofágica, duodenal y ano imperforado)
- Hipotiroidismo
- otras

El crecimiento y DSM se mide con tablas especiales

8. Inmunodeficiencias

Generalidades

Se define como la presencia de infecciones recurrentes en el niño

Las causas suelen ser secundarias (VIH, desnutrición, cáncer), además de las primarias

Estudio mínimo de paciente con infecciones recurrentes:

- Hemograma con recuento de subpoblaciones, clases de inmunoglobulinas, Elisa VIH y subclases de IgG.

El tratamiento va a depender según la causa.

Pueden ser humorales (anticuerpos (linfocitos B) o el complemento) o celulares (afectan a los linfocitos T, neutrófilos o macrófagos)

Inmunodeficiencias humorales

Se generan infecciones por bacterias capsuladas como Haemophilus, pneumo y meningococo. El tratamiento va desde la vacunación hasta la IgG que se da 1 vez al mes (como en la agamaglobulinemia, la ID mas grave y que se presenta después de los 6 meses)

Inmunodeficiencia común variable → Parte tarde en niños normales que en la etapa escolar, adolescencia hacen hartas con neumonías sinusitis, otitis y meningitis. El déficit de IgA es la mas común

Inmunodeficiencias celulares

El VIH es la más clásica por falla de los Linfocitos T

Inmunodeficiencia combinada severa → Es la inmunodeficiencia mas severa, parte con síntomas desde que nace. Son los clásicos niños burbujas que tienen que vivir confinados a la casa porque sino se muere. El único tratamiento es un trasplante de médula.

VIH → Es mas severa que en los adultos, la clave es prevenir la transmisión vertical. Al niño se deja siempre la triterapia hasta que se haga el diagnostico.

Habla hartas pijas más, pero dice que no lo preguntan mucho y es pura shit. Si hacen una pregunta de esto ... te invito a unas buenas piscolas para compensar. Si no tienes mi número de teléfono, busca en tu corazón



9. Fiebre

Tema que se pregunta SIEMPRE

Fiebre → Temperatura mayor o igual a 38 grados, ¿por cual vía es mejor? por cualquier vía, idealmente rectal.

Las causas son infinitas, las más importantes son las Virales y en 2º lugar las bacterianas que son más graves (ITU, NAC, meningitis y sepsis es lo que HAY que ir a buscar)



El estudio y anamnesis varia según la edad y síntomas.

Tratamiento sintomático

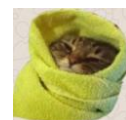
Paracetamol 10-15 mg/kg/dosis con un máximo de 4 dosis al día. AINEs se pueden dejar, pero en lactantes están contraindicados (por Ulcera y daño renal)

Fiebre sin foco

- <6 semanas → Se deben pedir todos los exámenes (incluso PL) + ATB (**ampicilina + cefotaxima o Gentamicina**) SI O SI. Hay que ser exagerado (como las pediatras)
- <3 meses → Se piden los mismos exámenes sin la PL y sin ATB, se espera resultado de exámenes para decidir tratamiento ATB
- 3-12 meses → Se deja paracetamol y se observa si es que no hay foco. Se controla en 24-48 horas. Se asume que es viral si el niño no se ve mal. Si la fiebre es sobre 39 se debe descartar el foco urinario (OC – UC)
- > 12 meses → Paracetamol y observación. Control en 1-2 días.
- Niño de aspecto tóxico mayor de 6 semanas → Se maneja igual que el niño menor de 6 semanas, solo que el manejo ATB es distinto (cefotaxima + **vancomicina**) y esperar resultado de cultivos.

Hipotermia → Temperatura menos a 35 vía rectal. Es por exposición al frio, iatrogenia y en RN por sepsis, prematurez o PEG.

El manejo es con manejo de la causa + abrigar y dar calor (abrazar, ponerlo cerca de fuente de calor o si es mas grave se dan líquidos calientes VO o EV)



10. Muerte súbita y ALTE

Se ha preguntado un par de veces.

Prevalencia de 1 en 1000

Muerte súbita→ Muerte de un lactante durante el sueño sin una causa aparente (Autopsia normal). Sucede entre los 2-6 meses.

FR: **Prematurez** (aumenta riesgo en 30 veces), Tabaquismo, alcoholismo y drogadicción maternas, dormir en cama de los padres, dormir en prono, antecedentes familiares de muerte súbita, estar sin lactancia materna y el sexo masculino (60%M v/s 40%F).

Prevención: Lactancia Materna, Dormir en supino, dormir en cuna propia, no con los padres (pero sí en la misma habitación)

ALTE (Apparent life Threatning Event)

Clínica→ evento agudo que aparentemente amenaza la vida del lactante.

La guagua de la nada se pone morada, se ahoga, no respira, queda inconsciente, etc. Lo mas importante es la apnea, cambio de color e hipotonía.

Hay ALTE de alto y bajo riesgo

Bajo riesgo→ Mayor de 6 meses, niño sano y asociado a apneas emotivas (niños que hacen apneas cuando lloran mucho)

EL manejo en este caso es tranquilizar y educar a los padres.

Alto riesgo→ FR: Menos de 6 meses, prematuros o que necesite de estimulación vigorosa para despertarlo.

Se maneja con hospitalización mas muchísimos exámenes para estudiarlo completo. Se deja monitor para la casa y se enseña RCP a los papás

11. Diarrea

Se pregunta siempre

Diarrea aguda→ La causa mas frecuente es de tipo viral y luego bacteriano. De los virus, el rotavirus es el más común, puede dar fiebre alta. De las bacterias E. coli es la más común, suelen ser cuadros autolimitados y no necesitar ATB.

Es mas común en el verano

Manejo→ Hidratación

DH leve (<5% peso)→ **Plan A** que implica SRO 100-200cc después de cada deposición diarreica.

DH moderada (5-10%, hay signos de DH) → **Plan B**, se dan SRO, 50-100cc/kg en 4-6 horas. En caso de que tenga vómitos igual se intenta VO, fraccionando las tomas a menos que sean muchos los vómitos, ahí se da EV.

DH Severa (>10%), shock hipovolémico, compromiso de conciencia, Insuficiencia renal) → **Plan C**, SF EV 20 cc/kg u osteoclisis (se insatalla en la Tibia) si no se puede encontrar vía

Trastornos hidroelectrolíticos → Solo se arreglan cuando ya se corrigió la volemia

Antiemético, antipiréticos y antiespasmódicos también se pueden dejar.

Los ATB solo se dejan en niños con mal estado general o con Disentería, Fiebre alta, dolor intenso o confirmación en coprocultivo de Shigella o E coli enteroinvasora.

El ATB a dejar es el ciprofloxacino o cefotaxima.

NO SE DEJAN ANTIDIARREICOS

Diarreas crónicas → El manejo es el mismo, la hidratación + el tratamiento de la causa

Diarrea crónica inespecífica

Causa mas frecuente de diarrea crónica en pediatría. Se debe a la ingesta de jugos hiperosmolares que generan diarrea osmótica. Es una diarrea crónica intermitente con buen incremento de peso y examen físico normal. El diagnóstico es totalmente clínico y el tratamiento es la suspensión de jugos hiperosmolares

Giardiasis

Parásito unicelular Giardia Lamblia. Suele darse en escolares y preescolares en zonas rurales con higiene deficiente. Genera una diarrea crónica, flatulencia y dolor abdominal cólico. El examen físico suele ser normal. Puede asociarse con un síndrome de mala absorción (en una enfermedad celiaca se debe descartar giardiasis). Si en la familia hay gente con síntomas similares es sugerente.

El diagnóstico es con el EPSD y el tratamiento es con tinidazol o metronidazol

Enfermedad celiaca

Reacción inmune al gluten (Se encuentra en trigo, cebada y centeno). La clínica suele iniciarse al año de edad, pero puede ocurrir en cualquier edad.

La clínica es un síndrome de malabsorción con mal incremento ponderal o baja de peso, esteatorrea y lentería junto a síntomas carenciales como la anemia ferropénica, piel seca, uñas feas.

El diagnóstico es con la EDA donde se toma una biopsia del duodeno y anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomio (+). Estos marcadores sirven tanto para diagnóstico como para seguimiento pues bajan si el paciente sigue la dieta sin gluten.

El tratamiento es la dieta estricta sin gluten.

Fibrosis quística

Enfermedad genética recesiva que tiene una clínica dada por malabsorción intestinal y síntomas respiratorios (SBO recurrente + NAC por pseudomonas o S. aureus).

Se pregunta como: 1) diarrea + Neumonía o como 2) NAC por pseudomonas o S. aureus

El diagnóstico es con el test del sudor (cloro elevado en sudor)

El tratamiento es multidisciplinario con soporte, y finalmente el trasplante de pulmón es el único tratamiento que los puede hacer llegar hasta la vida adulta.

Alergia a la proteína de leche de vaca (APLV)

Es una reacción alérgica con una clínica muy variada. Afecta 4% de los lactantes. Generalmente síntomas gastrointestinales (Diarrea, reflujo), puede venir con hemorragia digestiva, lesiones en el ano + lesiones cutáneas y asma (

Es, en resumen, un niño que está **tomando formula láctea** con síntomas gastrointestinales intensos y síntomas alérgicos en general (exantema, rinitis, asma)

Si está con lactancia materna exclusiva y presenta estos síntomas igual podría llegar a ser APLV por traspaso de los antígenos a través de la leche (poco frecuente)

El diagnostico es difícil porque la clínica es inespecífica. Se hace con prueba terapéutica de 4 semanas (Se saca el relleno o que la mama deje de tomar leche de vaca. Si desaparece y reaparece al reintroducirlo se hace el diagnostico)

Tratamiento→ Formula altamente hidrolizada y si está con lactancia materna se le prohíben los lácteos a la madre

12. Reflujo y Dolor Abdominal

Reflujo de los lactantes

Hay que diferenciar el fisiológico del patológico. El reflujo fisiológico se ve un niño feliz que regurgita. Tiene un peak a los 2-6 meses y suele desaparecer después del año de edad, máximo 18 meses.

El reflujo patológico es secundario a una enfermedad.

Reflujo patológico

Se ve como un niño con mal incremento ponderal, puede tener hemorragia digestiva, síntomas respiratorios (SBO, asma), ALTE, etc. Se diagnostica con la clínica, pero puede hacerse una pHmetría para objetivarlo (suele bastar con la clínica). El tratamiento es con omeprazol (IBP). Son mas eficaces y seguro que los antieméticos. De segunda línea se pueden dar proquinéticos. La ultima línea de tratamiento es la cirugía (funduplicatura de nissen). No confundir con la estenosis hipertrófica del píloro.

Dolor abdominal Crónico

Se estudia igual que en adultos buscando signos de alarma a la anamnesis y examen físico (baja de peso, vómitos, hemorragia digestiva) se deberá estudiar con imágenes (Eco de forma inicial, TAC) en caso de estar estos presentes.

En caso de que no presente signos ni síntomas de alarma lo mas probable es que sea de tipo psicógeno (lo mas frecuente en niños). El tratamiento va a depender de la causa.

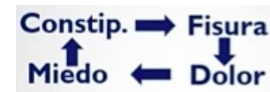
Orienta a esto al aumentar con el stress (colegio, pruebas y que disminuya con las vacaciones) y de ubicación periumbilical (porque ahí asocian los niños el dolor abdominal).

El tratamiento es el manejo del stress.

Constipación y fecaloma

La causa en general son los malos hábitos alimenticios (poca fibra y poca agua) y malos hábitos de defecación (este debe ser formado en los niños).

Esto puede formar una fisura anal → Dolor → Miedo. Este es un círculo vicioso que hay que ir a romper.



Su clínica es que tenga 2 o menos deposiciones a la semana, siendo estas duras, caprinas o muy grandes (que tapen el baño), asociado al dolor en las defecaciones. Si tiene un fecaloma es diagnóstico de constipación.

El fecaloma se diagnostica con tacto rectal.

- ≤ 2 evacuaciones / semana
- Deposiciones duras, caprinas o grandes
- Dolor en evacuaciones
- Fecaloma (TR o Ex. abd.)

Fecaloma → Masa abdominal y masa rectal es lo típico, pero además puede venir con dolor abdominal inespecífico, pseudo incontinencia fecal (incontinencia por rebalse), encopresis (se hace caca mientras duerme) y que manche los calzoncillos.

El manejo tiene 2 etapas,

1. la **desimpactación** del fecaloma con PEG vía oral idealmente, como alternativa tenemos el enema evacuante (igual de bueno que el PEG). La proctoclisia es la última opción.
2. La segunda fase es la de **mantenimiento**, evitando que esto se reproduzca manteniendo los laxantes por un mínimo de 4 semanas y formar los hábitos de alimentación y defecación (por lo menos durante 5 minutos después de cada comida).

13. Infecciones respiratorias

SE PREGUNTA SI O SI

Resfriado Común

Causado por virus respiratorios, el más común el rinovirus.

Caracterizado por rinorrea, tos, disfonía, odinofagia y obstrucción nasal. Suele tener fiebre baja. Tiene un examen pulmonar totalmente normal, porque es una infección alta. El diagnóstico es clínico con tratamiento sintomático (**SF intranasal y paracetamol**). Los antitusivos no están indicados, porque pueden aumentar las complicaciones infecciosas. Los descongestionantes podrían utilizarse.

Influenza

Producido por el virus influenza. Da fiebre alta (sobre 40 en algunos casos) además de tos, mialgia y gran CEG. El examen pulmonar también está normal, es IRA alta. El diagnóstico es clínico, pero se puede confirmar con PCR. El tratamiento es sintomático con paracetamol, **NO SE DEJA OSELTAMIVIR** (Solo en adultos de alto riesgo)

Neumonía

La causa depende de la edad. En el RN suele ser producida por estreptococo grupo B (agalactiae). En menores de 1 año suelen ser de causa viral (sincial generalmente), mayores de 1 año suele ser por neumococo. En escolares suele ser por neumococo y mycoplasma. La clínica es tos, expectoración y fiebre con un examen pulmonar con crépitos, broncofonía, respiración soplate, etc.

Diagnóstico→ es clínico, pero suele pedirse una Rx de tórax para confirmar el diagnóstico.

Tratamiento→ es con ATB

- Ambulatorio
 - o Amoxicilina
- Hospitalizado
 - o Penicilina
- RN
 - o Ampicilina + cefotaxima o gentamicina

Neumonía atípica

Causado por mycoplasma pneumoniae, chlamydia pneumoniae o neumophila, pero por lejos el más común es el mycoplasma. En RN puede ser por Chlamydia (precedido por conjuntivitis) El cuadro clínico es larvado, suele iniciarse como una infección viral (1-3 semanas) que avanza a NAC. El examen pulmonar tiene signos obstructivos (sibilancias y crépitos) y suele ser bilateral.

Diagnóstico→ también es clínico, pero se complementa con radiografía (patrón alveolo-intersticial).

Tratamiento→ Los Betalactámicos no cubren al mycoplasma. **Se dejan Macrólidos** como la azitromicina **por 5 días** o quinolonas respiratorias como levo o moxifloxacino (se evitan en niños)

Coqueluche o tos convulsiva

Causado por Bordetella pertussis. Empieza con un examen pulmonar inespecífico, lo más importante es la historia clínica que tiene 2 fases.

La primera (**catarral**) es muy similar a un resfrío común y luego viene la fase de ataques de tos paroxística (**fase paroxística**) donde el niño tiene tos que viene en accesos (ataques) con gallito inspiratorio. Dado el exceso de tos puede tener petequias en la cara, vómitos y apneas.

Guagua de 3 meses con tos y apneas→ Coqueluche.

Diagnóstico: Es con PCR o con inmunofluorescencia directa para Bordetella.

Hay bacterias y virus que puede simular la clínica del coqueluche (mycoplasma, VRS, parainfluenza y adenovirus) por lo cual, debe ser confirmado con PCR.

Rx Tx suele ser normal o con alteraciones inespecíficas. Lo más importante es la historia clínica y la PCR (examen físico y Rx Tx no aportan mucho).

Tratamiento→Azitromicina, esta sirve principalmente para evitar que siga contagiando, su utilidad es máxima cuando se da en la primera fase.

Manejo de contactos→ Se deja en 2 casos, los sintomáticos y los grupos de riesgo.

En los pacientes contacto de coqueluche y están con síntomas (tos) su efectividad es en la fase inicial, no después.

Aquellos que son contactos de alto riesgo son:

- Menores de 1 año
- Menores de 2 años que no han sido vacunado
- Adultos mayores
- Hospitalizados
- Embarazada en 3er trimestre

Vacuna→ Completar esquema si está incompleto

Se debe dar azitromicina por 5 días.

14. Púrpura y Anemia

Purpura→ Lesiones cutáneas que no se blanquean a la compresión.

Lo mas importante es pedir un hemograma con recuento de plaquetas. Si están bajas, será purpura trombocitopenica. Dentro de estas, la importante es la PTI (purpura trombocitopénica idiopática o inmune). Otras causas menos frecuentes son la leucemia, SHU y CID.

Cuando no es trombocitopénico, la mas frecuente es la púrpura de Schönlein-Henoch. Causa menos frecuentes son purpuras por AINEs, enfermedad de Von Willebrand y otras raras.

Por lo tanto, el enfrentamiento es ver si es o no trombocitopénico. De ser trombocitopénico pensamos en PTI, pero de no ser trombocitopénico pensamos en Schönlein- Henoch.

¿Y si tiene fiebre?--> Meningococcemia o leucemia

Púrpura de Schönlein Henoch

Enfermedad Post infecciosa (estreptocócica generalmente) por deposito de IgA

La purpura es palpable que suele afectar a EEII, glomerulonefritis aguda (mala pronóstico), artralgias/artritis, dolor abdominal difusa, hemorragia digestiva baja y/o diarrea.

Entonces es un purpura con compromiso renal, gastrointestinal y de articulaciones.

El Diagnóstico es clínico (se puede hacer biopsia que muestra deposito de IgA)

El daño renal es el que muestra el riesgo.

Tratamiento→ Observación, aunque pueden indicarse corticoides orales en caso de artritis, glomerulonefritis y compromiso gastrointestinal, aunque la evidencia no demuestra que sean útiles.

Purpura trombocitopénica inmune

Es una enfermedad sin causa aparente, aunque muchas veces puede ser postinfecciosa

Clínica→ Alteración de la hemostasia primaria: Petequias/equimosis + sangramiento de origen mucoso (epistaxis, gingivorragia)

El diagnostico se hace con el hemograma donde se observan plaquetas bajas con las otras líneas celulares normales. Si queda la duda se debe ir a confirmar con una biopsia de medula ósea para descartar leucemia.

Fiebre, adenopatías y esplenomegalia NO DEBEN ESTAR, porque eso nos orienta a leucemia.

El tratamiento va a depender del numero de plaquetas. **Sobre 20.000** y paciente bien, solamente se **observa**.

En caso de que las plaquetas estén **bajo 20.000** se deben dar **corticoides**.

En caso de **hemorragia grave** se debe dar **IgG endovenosa** en alta dosis, este es el tto de rescate que apaga la respuesta inmune

Anemia

Se define con hemoglobina menor al p10 para la edad (RN <15, 3 meses <9, 12meses <12)

Estudio y manejo → Muy similar al de los adultos

Anemia fisiológica → **entre los 2 y 6 meses (no después)**, que es cuando la hemoglobina está más baja, pero SIEMPRE SOBRE 9

Anemia ferropriva → Se produce después de los 6 meses, habitualmente un niño que está con lactancia materna exclusiva. Por eso a los niños se les da fierro de los 4 a los 12 meses, porque la leche materna es lo mejor, pero le falta fierro. **En un niño prematuro el fierro se inicia a los 2 meses o cuando duplica su peso. (esto fue pregunta una vez)**

15. Diagnóstico nutricional y talla baja

Estos 2 temas se preguntan SIEMPRE.

Diagnóstico nutricional

P/E, P/T e IMC → Dg nutricional

T/E → Para talla baja

< 1 año: Se ocupa P/E para hacer diagnostico de desnutrición y P/T para el diagnostico de sobrepeso y obesidad

1 – 5.9 años → Se ocupa el P/T

>6 años → Se ocupa el IMC, pero se interpreta según la edad

2DE → Obesidad

>+1DE → Sobrepeso

-1 – +1DE → Eutrófico

-1 – -2 DE → Riesgo de desnutrición

<-2DE → desnutrido

>+2	Ob.
>+1	SP
0	Eutr.
≤-1	Riesgo D.
≤-2	Desn.

Talla Baja

Índice T/E menor a **-2DE** (p3) (lo normal es entre -2 y +2)

Manejo

1. Observar su curva de crecimiento, esta nos permite diferenciar causas graves de las mas normales. Es fundamental pues nos permite diferenciar las tallas bajas fisiológicas de las patológicas.

En las patológicas el niño tiene un cambio de carril en su curva, mientras que en la fisiológica siempre mantiene el carril. Ante una talla baja fisiológica debemos pensar en talla baja familiar y retraso constitucional del crecimiento que se diferencian entre ellas por la edad ósea.

2. Rx de carpo para determinar la edad ósea, además nos sirve para determinar el pronóstico de la talla final.

Talla baja familiar (TBF) → Padres chicos, el niño tendrá una talla baja y tiene una edad ósea acorde con su edad cronológica

Retraso constitucional del crecimiento (RCC) → Los papás no son chicos, el niño probablemente tendrá la talla que se esperaba y en la Rx de carpo tendrá una edad ósea menor a la cronológica (diferencia de por lo menos 2 años).

TBF	RCC
• Padres bajos • Talla final baja • Edad ósea acorde	• Padres altos • Talla final normal • Edad ósea menor

Otras causas de talla baja

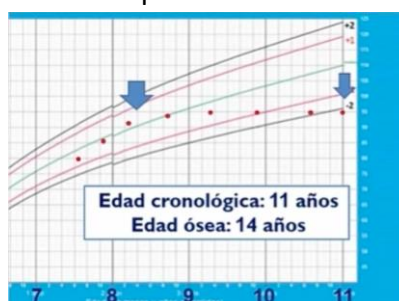
Enfermedad celiaca → Talla baja patológica (con cambio de carril) asociado a diarrea (Sd malabsorción)

Síndrome de Turner → Niñas con cariotipo 45XO, petirigium coli (Cuello alado) y tórax ancho con separación de los pezones.

RCC



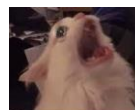
Pubertad precoz



16. Nefrología en Pediatría

SHU (Se ha preguntado en casi todos lo últimos EUNACOM)

GN secundaria a la toxina Shiga (producida por E. coli enterohemorrágica principalmente, también por Shigella). Suele venir con antecedente de diarrea de tipo disintérica, **Insuficiencia**



renal aguda grave (causa de muerte), anemia hemolítica y baja en las plaquetas. Puede afectar el SNC (Convulsiones). El tratamiento es el soporte, se suele requerir hemodiálisis por la fuerte falla renal. Su letalidad es de 5%.

Se presenta **SIEMPRE CON HTA, EDEMA Y ANEMIA**

SHU	IRA prerrenal
Edema HTA Anemia	Deshidratación Shock Hemoconcentr.

Síndrome nefrítico y GN post estreptocócica (GNAPE)

Las Glomerulonefritis agudas se definen como hematuria dismórfica (acantocitos).

El sd nefrítico posee una triada **caracterizada por EDEMA, HTA Y HEMATURIA**, asociado a IRA generalmente.

GNAPE → Suele tener el antecedente de amigdalitis 1-2 semanas antes junto a un síndrome nefrítico clásico. En el laboratorio encontraremos Hipocomplementemia y ASO (+). El manejo es soporte. (furosemida para manejo del edema y IECA par manejo de HTA). Diálisis en caso de ser necesario. Es un cuadro autolimitado que dura un par de semanas y después se mejora.

Síndrome nefrótico y nefrosis lipoidea

El sd nefrótico se caracteriza por un aumento marcado de la proteinuria sobre $40\text{mg}/\text{m}^2/\text{h}$, además de edema, hipoalbuminemia y dislipidemia.

Puede ser puro o impuro (se agrega hematuria, HTA o IRA). En caso de que sea impuro se debe biopsiar. EN caso de que sea puro entre 5 -10 años no se biopsia porque se asume que es enfermedad por cambios mínimos (nefrosis lipoidea).

Nefrosis lipoidea

Es un síndrome nefrótico puro en niño éntre los 5 y 10 años. EL manejo es con corticoides (por 3 meses generalmente) y podrían agregarse IECA (para la proteinuria) y furosemida (para el edema)

HTA en niños

Solo un 10% es esencial, 90% es secundaria.

- HTA renovascular (La más frcuente) → Por displasia de los vasos renales que genera obstrucción de las arterias renales.
- Coartación aortica → Malformación congénita
- Nefropatías médicas (IRC) → La 2ª más frecuente.
- Feocromocitoma, Cushing
- Otras

El diagnostico es con las presiones (diastólica y/o sistólica) sobre el percentil 95 para talla, edad y sexo.

Una vez hecho el diagnostico se debe ir a estudiar (90% son por causa secundaria) con Ecodoppler de las arterias renales (para descartar renovascular) y fx renal (Para descartar insuficiencia renal).

El tratamiento es de la causa. Como antihipertensivos tenemos los IECA y otros anti-HTA (IECA son los más usados)

17. Síndrome Bronquial obstructivo SBO

La pregunta va si o si

SBO

Sinónimo de bronquitis obstructiva

Causa → VRS en el 80% de los casos, suele verse en invierno (metapneumovirus, adenovirus y parainfluenza son las otras causas).

Clínica → Igual a una infección respiratoria alta viral (mocos, estornudo) que progresa a dificultad respiratoria. Tiene in examen pulmonar alterado con sibilancias. Se observa taquipnea, uso de musculatura accesoria y puede tener cianosis.

Diagnóstico → es totalmente clínico

Bronquiolitis → Primera crisis obstructiva en un lactante

SCORE DE TAL: La severidad se mide con el Score de Tal que mide 4 variables (frecuencia respiratoria, sibilancias, uso de musculatura accesoria y cianosis).

0-5: leve

6-8: moderado

9-12: Severo

Escala de valoración

Tabla 1. Score de Tal modificado (usar en menores de 3 años).

Puntaje	Frecuencia respiratoria		Sibilancias	Cianosis	Retracción
	< 6 meses	≥ 6 meses			
0	≤ 40	≤ 30	NO	NO	NO
1	41 - 55	31 - 45	Fin de espiración c/ fonendoscopio	Peri-oral al llorar	Subcostal (+)
2	56 - 70	46 - 60	Inspir. y espir. c/fonendoscopio	Peri-oral en reposo	Intercostal (++)
3	> 70	> 60	Audibles a distancia	Generalizada en reposo	Supraclavicular (+++)

Manejo: La evidencia solo dice que sirve darle O2 si desatura.

Leve: 2 puff SBT y pa la casa

Moderado: SBT 2 puff cada 10 minutos x 5 veces y reevaluación.

Severo: Lo mismo + O₂



Los corticoides sistémicos se indican cuando no responde tras 1 hora, si es SBOR y cuando se decide la hospitalización.



Criterios de hospitalización

- Score de tal 11-12
- Score 9-10 que persiste después de tratamiento
- Scores de 6-8 que no responden después de 2 horas.

SBOR

Hiperreactividad bronquial secundario a infección por VRS.

Son 3 o mas crisis obstructivas en 1 año. El dg es clínico.

El manejo es igual al asma (SBT SOS + corticoides inhalados c/12 hrs. Si esto falla se da Montelukast)

SBOR secundario

- Cardiopatía congénita → sospechar ante soplos o cardiomegalia
- Fibrosis quística → tiene bronquiectasias a la Rx, hace NAC por pseudomonas o S. aureus y además tiene un sd de malabsorción (diarrea)
- Enfermedad de cilio inmóvil → Mutación en la cual los cilios no se mueven. Hay bronquiectasias y tiene dextrocardia.
- Displasia broncopulmonar → Secuela de la enfermedad por membrana hialina

18. Vacunas y alimentación

En general hay 2 preguntas de vacunas

- Reacciones adversas
- Indicaciones y contraindicaciones
- Vacunas PNI
- Vacunas extra PNI
- Motivos para indicar las vacunas (PNI y extra PNI)

También suelen haber 2 preguntas de alimentación

- Contraindicaciones de lactancia materna
- Formulas de leche purita
- Razones de las distintas concentraciones de las leches
- Tipos de leche del plan de alimentación complementaria (PNAC)
- Alimentos por edad
- Prevención de obesidad (hábitos estilos de vida saludable)

TODO ESTO CAMBIA SIEMPRE, ASIQUE HAY QUE LEERSE LA GUIA MINSAL ACTUALIZADA ANTES DEL EUNACOM.

19. Atención del RN/Asfixia neonatal

1. Apgar: estado general del RN en lo ventilatorio y circulatorio
 - Dirige la animación neonatal en caso de APGAR bajo
2. Aseo y secado para evitar que se enfrie
3. Apego
4. Profilaxis:
 - Colirio de gentamicina en ojos (evita conjuntivitis neonatal)
 - Vitamina K: coagulopatía RN
 - Vacuna BCG: > 2 kg

5. Antropometría: peso (3,5kg), talla (50 cm), CC (35 cm)
6. Examen físico: buscar malformaciones (cara, caderas, ano perforado, neurológico)
7. Screening (a las 48 hrs): TSH y PKU (fenilcetonuria).

	0	1	2
FC	0	<100	>100
Resp.	No	Débil	Vigorosa
Tono	No	Hipotónico	Movimiento
Color	Cianosis general	Cianosis Extrem.	Rosado
Reflejo Catéter	No	Mueca	Tos, llanto

Asfixia neonatal:

- causa: hipoxia intraparto (habitualmente por accidente placenta y cordón)
 - criterios de asfixia (hay que saberlos, debe tener por lo menos 4):
 - > Apgar entre 0-3 a los 5 min
 - > pH cordón < 7
 - > Encefalopatía hipoxisquemica (Compromiso conciencia, convulsiones, hipotonía)
 - > afectación otros sistemas (renal, hemato, GI, etc.)
 - Manejó: reanimación neonatal + soporte.
- Reanimación:
1. evaluar cada 30 seg. con el apgar
 2. Estimular + oxígeno
 3. VPP (ventilación a presión positiva con ambu) se mantiene mientras FC < 100 y en apnea, es la medida mas importante.
 4. Masaje cardiaco: siempre y cuando su FC < 60 o paro (desde inicio junto a VPP)
 5. Adrenalina (0.01 mg/kg ev y si no hay vía venosa: 0.1 mg/kg TOT). Cuando el masaje no ha funcionado.

20. Exantemas

Lo importante de ellos es saber la clínica porque su diagnóstico es clínico. Suelen ser 2 preguntas de este tema

Para su diagnóstico es vital conocer

- Edad
- Ubicación
- Síntomas acompañantes

SARAMPIÓN

Causado por virus del sarampión

Enfermedad de notificación inmediata

Edad→ En Chile está erradicado. Sería por tanto un extranjero o un niño menor de 1 año con contacto con extranjero.

Ubicación→ Exantema rojo intenso (morbiliforme) maculopapular que inicia en la cabeza y luego se desplaza hacia caudal

Síntomas→ fiebre alta precedido por conjuntivitis o tos. Viene con un enantema, las llamadas manchas de Koplick en la mucosa oral, son patognomónicas. Suelen aparecer un par de días antes del exantema.

Diagnostico→ Clínico, pero requiere confirmación con IgM

Tratamiento→ Sintomático

Riesgo→ Neumonía y encefalitis



RUBEOLA

Causado por Virus Rubeola

Enfermedad de notificación obligatoria.

Edad→ Extranjeros o menores de 1 año contactos de extranjeros

Ubicación→ Exantema rosado maculopapular, mas tenue que sarampión

Síntomas→ Fiebre baja, adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores además de artralgias y/o artritis

Diagnostico→ Clínico pero requiere confirmación con IgM

Riesgo→ TORCH, artritis viral



ERITEMA INFECCIOSO o QUINTA ENFERMEDAD

Producido por Parvovirus B19

Es el que más se pregunta

Edad→ Escolares y preescolares

Ubicación→ Inicia con eritema malar (signo de la cachetada) y luego aparece exantema en encaje (reticular) que afecta tronco y extremidades

Clínica→ Fiebre baja, artralgias

Diagnostico→ Clínico, no requiere confirmación

Tratamiento→ Sintomático

Riesgo→ Aborto



EXANTEMA SÚBITO, ROSÉOLA O SEXTA ENFERMEDAD

Se pregunta con frecuencia

Producido por virus herpes 6 y 7

Edad → Lactantes entre 6 y 18 meses.

Clínica → Fiebre alta (causa de convulsiones febriles) que cede y tras esto aparece el exantema maculopapular eritematoso inespecífico

Diagnóstico → Clínico

Tratamiento → Sintomático



SÍNDROME PIE MANO BOCA

Producido por Coxsackie A-16

Edad → Preescolares y escolares

Ubicación → Exantema **papulo-vesicular** que afecta manos, pies y enantema en paladar. Afecta manos, palmas y dorso (vesículas dolorosas). También puede estar en resto del cuerpo.

Síntomas → Fiebre baja

Diagnóstico → Clínico

Tratamiento → Sintomático



Si esta clínica se presenta en adulto → Pienso en sífilis

Si esta clínica se presenta en lactante → Pienso en sarna

ESCARLATINA

Se ha preguntado un par de veces

Producida por estreptococo grupo A productor de toxina eritrogénica.

Edad → Escolares principalmente. Puede afectar a preescolares también, **pero siempre >3 años**.

Ubicación → Exantema en piel de gallina (papular) que respeta el triángulo de Fialtov (entre los surcos nasogenianos) y viene con enantema, lengua aframbuesada

Líneas de Pastia → Petequias de distribución líneal en fosas cubitales.

Síntomas → Amigdalitis purulenta

Diagnóstico → Clínico

Tratamiento → Penicilina benzatina o amoxicilina



Líneas de Pastia

Meningococcemia

Se ha preguntado un par de veces
Causado por meningococo

Edad→ A todos

Clínica→ Purpura petequeial que luego se vuelve equimótico + Fiebre alta. Antes puede venir con exantema rosado.

Además puede venir con meningitis y hacer síndrome de waterhouse friedrichsen (insuficiencia suprarrenal grave). Además puede hacer CID y shock séptico

Es el exantema mas grave, se debe sospechar desde un inicio



Diagnostico→ es clínico, pero se objetiva con hemocultivos y PL, las cuales, no deben retrasar el inicio de ATB.

Tratamiento→ Penicilina G en dosis altas o cefalosporinas de 3ª G.

Fiebre alta→ Sarampion, meningococcemia y exantema súbito

Purpuras febriles→ Siempre urgencia, porque es meningococcemia, CID o Leucemia aguda

CASO

Niño 5 años, fiebre, 38.5°C hace 2 días, más eritema en mejillas, desaparece la fiebre y aparece exantema en tronco y extremidades.

Caso real del EUNACOM, es un eritema infeccioso a pesar de que podríamos pensar en exantema súbito. Tiene fiebre baja y la edad en la cual se produce la 5ª enfermedad (exantema súbito es de lactantes)

21. Varicela/ Herpes Zoster

Varicela

Causado por Varicela zoster

Ubicación→ Siempre afecta la cabeza, luego tronco y finalmente extremidades, distribución cefalo-caudal. Es un exantema polimorfo **pruriginoso** (pápulas que se convierten en vesículas, luego pústulas, úlcera y finalmente costra).

Clínica→Pródromo de Fiebre, malestar general y cefalea.

La varicela contagia, hasta que todas las heridas son costras.

Diagnóstico→ Clínico

Tratamiento→ Sintomático. No dar AINEs ni AAS, por riesgo de sd de reye (encefalitis y edema cerebral + hepatitis muy grave, causa de muerte)

La administración de antivirales tiene ciertas indicaciones

- > 13 años
- 2º caso familiar (por riesgo de varicela mas grave, pues la carga infecciosa fue más grande)
- Varicela grave (con vesículas hemorrágicas , >100 lesiones o inmunodeprimido)

Dosis (doble de la dosis que VHS)

Aciclovir→ 800mg/4 horas (10-20mg/kg/día) x 7 días

Valaciclovir→ 1g /8 horas x 7 días (10-20mg/kg/día)x 7 días

Complicaciones

- Sobreinfección bacteriana→clásica de los niños. Suele infectarse con gram+, se trata con cefalosporinas de 1ª generación o cloxacilina
- Neumonía→ Aciclovir Ev
- Encefalitis→ Aciclovir Ev
- Hepatitis→ Aciclovir Ev

HERPES ZÓSTER

Reurrencia del VVZ

Clásico del adulto mayor, inmunodeprimido y gatillado por stress

En quien hace 2 herpes zóster se debe sospechar inmunosupresión

Síntomas→ Eritema y luego vesículas en un dermatomo, asociado a dolor neuropático (que puede aparecer antes). No sobrepasa la línea media

Diagnostico→ Clínico

Tratamiento→ Aciclovir o valaciclovir (800mg 5 veces al día o 1g cada 8 horas por 7 días)



Este tratamiento es para disminuir el riesgo de neuritis post herpética, dolor que puede persistir incluso por años.

Embarazo → Tiene riesgos

- **Neumonía o neumonitis** → Tienen mayor riesgo durante el embarazo, por lo tanto, toda embarazada con varicela deben recibir aciclovir si o si, **pero de forma Ev en caso de hacer neumonía.**
- **TORCH** → Cuando hay **primoinfección** antes de las 24 semanas. Si nunca ha tenido varicela, se le pide IgG para certificar que nunca la ha tenido y en caso de ser negativa la IgG, se da IgG anti VVZ. En caso de haber tenido varicela antes (IgG + o antecedente) no se hace nada.
- **Varicela neonatal** → Es una varicela grave en el RN, la madre le pasa el virus pero no los Anticuerpos. Se da aciclovir Ev + IgG. Es un cuadro grave.
Vamos a dar aciclovir si la mamá presenta varicela 5 días preparto hasta 2 días post-parto, aunque el niño no tenga síntomas.

22. Meningitis

Tema muy preguntado

Clínica

- Cefalea
- Nauseas
- Vómitos
- Fiebre
- Signos meníngeos (rigidez de nuca, Kernig y Brudzinski)

Se debe pedir TAC de cerebro para descartar HTEC y una vez descartada esta se hace una PL
La PL me hace el diagnostico y diferencia entre las distintas etiologías.

Ante la duda, se trata como si fuera bacteriana (en caso de que no haya TAC, si existe HTEC o tenemos una PL con líquido intermedio)

	Bacteriana	Viral	TBC	Normal
Glucosa	↓	N	↓	>40mg/dl
Tipo de células	PMN	MN	MN	-
No células	>1000	>10	>100	<10/mm³
Proteína	>100	>40	>100	<40mg/dl

Tratamiento MBA

- Antibióticos → empíricos, van a depender de la edad de paciente
 - o RN
 - Cefotaxima + ampicilina
 - o Niños
 - Ceftriaxona + Vancomicina (para neumococo resistente)
 - o Adultos
 - Ceftriaxona + *Vancomicina* (opcional)
 - o Adulto mayor y embarazada
 - Ceftriaxona + ampicilina (para cubrir listeria)
- Corticoides → Útiles en infecciones pediátricas producidas por neumococo y Hib, pero se da para todos.

La ceftriaxona cubre: Neumococo (el mas frecuente), Meningococo (2º mas frecuente), Hib y E. coli

Neumococo → Diplococo gram (+) en cadena corta. Responde a ceftriaxona

Meningococo → Diplococo gram (-). Responde a ceftriaxona o penicilina

Hib → Cocobacilo gram (-). Responde a ceftriaxona

E. coli → Bacilo gram (-), se trata con ceftriaxona

Listeria → Bacilo gram (+), se trata con ampicilina

ESTO SE PREGUNTA CON HARTA FRECUENCIA



Manejo de contactos

Hib → Rifampicina por 4 días (20mg/kg/día)

Meningococo → Rifampicina (20mg/kg/día), ciprofloxacino o ceftriaxona o 500mg dosis única

Encefalitis viral

Clínica muy similar a la MBA

Causado por enterovirus generalmente

Tratamiento → Paracetamol



El problema es en caso de ser por VHS 1 o 2 es que puede producir una encefalitis herpética.

Se trata con aciclovir Ev, ante la mera sospecha se debe iniciar tratamiento

Se confirma con PCR de LCR

¿Que me hace sospechar encefalitis por VHS?

- Clínica grave (desorientación, convulsión, compromiso de conciencia)

- Afecta más adultos jóvenes y adolescentes
- Lesiones temporales en el TAC
- LCR de tipo viral con sangre (xantocromía o GR cromados)

23. Estridor laríngeo, laringitis aguda, croup espasmódico y epiglotitis

Estridor Congénito

Suele ser por laringomalacia (90%), pero puede ser también por hemangioma o membrana laríngea. Los hemangiomas crecen y pueden obstruir la vía aérea, por eso es importante descartar con NFC, examen que nos mostrará la causa.

Laringomalacia

La laringomalacia se presenta por estridor inspiratorio de tonalidad alta, sin afectación respiratoria. Puede aparecer varios días después de haber nacido, no está siempre desde un inicio

El diagnóstico es con NFC. El tratamiento es la observación

Laringitis aguda y croup espasmódico

Se pregunta con frecuencia

La laringitis es producida por virus parainfluenza

Clínica

- Tos
- Disfonía
- Fiebre
- Examen pulmonar normal

Diagnóstico es clínico y tratamiento es sintomático

Laringitis obstructiva→ Es el mismo cuadro pero que viene con cierto grado de obstrucción. En este caso hay estridor inspiratorio con disnea, uso de musculatura accesoria y cianosis. El uso de musculatura accesoria avanza de arriba hacia abajo en gravedad, la retracción subcostal es lo peor, **al revés que la bronquiolitis y el SBO.**

Diagnóstico es clínico

Tratamiento→ Depende del grado

Grado I→ Sin obstrucción. Se trata de forma sintomática

Grado II→ Con obstrucción. Es la que más se pregunta. Se trata con adrenalina racémica para desobstruirlo (0,05ml/kg) + dexametasona para bajar la inflamación y prevenir recurrencia (0,15-0,6 mg/kg). Si se desobstruye solo (con el frío al salir, por ejemplo) no sirve dar adrenalina. **NO confundirlo con SBO**

Grado III→ Agitado. El niño debe ser hospitalizado. Se le da oxígeno como medida inicial

Grado IV→ Pérdida de vía aérea→ Intubación

Croup espasmódico

Aparece con frecuencia en las alternativas, no se ha preguntado aún

Causa→ Viral, reacción alérgica o por comida que se le va a la laringe

No confundirlo con croup laríngeo, que es lo mismo que la laringitis obstructiva

Clínica

- **Sin clínica de IRA previa**
- Inicio agudo (la laringitis es mas lenta)
- El resto de la clínica es igual a la laringitis

El diagnostico es clínico, hay que diferenciarlo de la laringitis

Tratamiento→ De la causa (reacciones alérgicas generalmente, viral o por comida que cae en la laringe que genera espasmo de las cuerdas). Se observa porque se suele destapar rápidamente (minutos) y si no responde se maneja igual a una laringitis obstructiva

Epiglottitis

Producida por Hib. La clínica es similar a una laringitis aguda, pero el niño tiene aspecto séptico, **con fiebre alta.**

El niño viene en posición de trípode (echado hacia atrás para poder respirar mejor)

Diagnostico→ Clínico + Rx lateral de cuello que muestra imagen en punta de lápiz

Tratamiento→ Ceftriaxona+ adrenalina racémica y corticoides

Enfermedad de notificación INMEDIATA

24. Pubertad Precoz, hipotiroidismo congénito e hiperplasia suprarrenal congénita

Pubertad Precoz

Pubertad→ Aparición de caracteres sexuales secundarios.

Primer signo de desarrollo puberal→ Aumento de volumen de testículos en niños (orquidarquia) y aparición del botón mamario en niñas (telarquia), esto es Tanner 2

Pubertad normal→ 9-14 años en niños y 8-13 años en niñas.

Si empieza antes se habla de pubertad precoz. Si parte después se llama retraso puberal.

Ambas se estudian con gran cantidad de exámenes (LH, FSH, testosterona, estrógeno, progesterona, 17-hidroxiprogesterona y edad ósea)

Riesgo de PP→ Se quedan chicos, talla baja.

Causas

- Central (la más frecuente). Es por una activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Hay aumento de LH y FSH, por lo cual, las gónadas aumentan de tamaño

- Periférica → Hay varias causas (generalmente tumores productores de hormonas sexuales), la FSH y LH están bajas, por lo cual, **las gónadas son pequeñas**. (poco probable que se pregunte)

NO confundirlo con adrenarquia precoz, que es la activación precoz de las glándulas suprarrenales que producen algunas hormonas sexuales (tendrán olor axilar y pubarquia escasa). **Se observa, no se piden exámenes a menos que haya desarrollo sexual**

Hipotiroidismo congénito

Es una causa congénita por disgenesia tiroidea.

A todo RN se le pide TSH al nacer por esto mismo.

Clínica

- Ictericia tardía de predominio indirecto
- Hipotermia
- Hipotonía
- Retraso en caída del cordón (7-14 días es lo normal)
- Voz Ronca (llanto ronco)
- Sialorrea

Al nacer son normales, pero a largo plazo puede presentar retraso mental irreversible (cretinismo). Erradicado en Chile.

El tratamiento es con Levotiroxina 1,6ug/kilo y bien tratado va a ser un niño totalmente normal.

Hiperplasia suprarrenal congénita (HSRC)

Es de causa congénita por déficit enzimático, por lo cual, no se produce cortisol. Esto genera hiperproducción de ACTH que aumenta el tamaño de las suprarrenales.

Diagnostico → Por aumento de la 17- hidroxiprogesterona. Clínicamente se presenta como una insuficiencia suprarrenal, incluso con hiperpigmentación por aumento de la ACTH.

Aumenta la DHEA que puede producir hiperandrogenismo

Clínica → Hiperandrogenismo, insuficiencia suprarrenal e hiperpigmentación. La presentación es similar a una estenosis hipertrófica del píloro (salvo que esta viene con hipoK y la HSRC con hiperkalemia)

El tratamiento es con cortisol. Se agrega fludrocortisona si es perdedor de sal.

25. Sd mononucleósico, sd retroviral agudo y TORCH

Se pregunta con cierta frecuencia

Síndrome mononucleósico

Tiene una triada clásica compuesta por **Odinofagia, Fiebre y Adenopatías cervicales**

Muy inespecífico porque muchos virus (VEB, VIH, CMV, VHS, ADV) algunas bacterias (SGA, bartonella), parásitos (toxoplasma), cáncer y fármacos pueden producirlo en su infección aguda

A la mononucleosis en particular además de esta triada se agregan otros síntomas

- Esplenomegalia
- Hepatomegalia
- Ictericia
- Hepatitis
- Rash morbiliforme → Presente en un 30% de los casos que aumenta a 90% en caso de usar aminopenicilinas (amoxicilina, penicilina o ampicilina)

Hemograma → muestra linfocitosis (como en cualquier infección viral), pero estos linfocitos son extraños al frotis, es una linfocitosis atípica.

Anticuerpos heterófilos → Hace pensar mucho en Mononucleosis, pero se piden poco, están obsoletos

Diagnóstico → IgM VCA o VEB

El virus Epstein Bar es por lejos el virus mas frecuente en producir Mononucleosis. Es muy frecuente en niños.

Su tratamiento es totalmente sintomático.

Si la IgM es negativa se debe pensar en otras causas de Mononucleosis como CMV, VIH, etc.

Síndrome retroviral Agudo

Síndrome asociado a la primera infección por VIH. Esta suele ser asintomática, pero de no serlo puede dar un síndrome mononucleósico + un Rash rosado.

Para sospecharlos se debe tener un antecedente de riesgo (promiscuidad sexual, contacto sexual de riesgo o accidente cortopunzante)

Promiscuidad sexual → mas de 2 parejas sexuales al año

El diagnóstico es con PCR VIH o Antígeno p24. El ELISA no sirve a estas alturas, porque mide anticuerpos y estos demoran días en positivizarse.

Tratamiento síndrome retroviral agudo → TAR

TORCH

T oxoplasma

O otros (sífilis, Chagas, varicela y Zika)

R ubéola

C itomegalovirus

H erpes simplex

Se produce cuando hay una **primoinfección** al inicio del embarazo, salvo en infecciones crónicas como sífilis o Chagas.

Riesgo

Malformaciones (cerebrales, cardíacas, GI)

Microcefalia con retraso mental

CMV→ Es la causa más frecuente, da un RCIU, microcefalia, hepatoesplenomegalia y Calcificaciones cerebrales. (es el que más se ha preguntado)

Toxoplasmosis→ Es igual a CMV + Hidrocefalia (CMV igual, pero menos)

Rubéola→ Cataratas congénitas, microcefalia, cardiopatía congénita (erradicada en Chile)

Se hace un screening IgG de toxoplasma y CMV antes del embarazo. Como son IgG, si están positivas nos habla de que no tiene riesgo de TORCH por estos bichos

La IgM no se pide, a menos que este con un Sd mononucleósico durante el embarazo y se debe tratar.

26. Traumatología infantil

Se pregunta en pediatría y TMT, es pregunta segura

Displasia de caderas

Clínica→ Asintomática. Al examen físico tenemos el signo de Ortholani (podemos reposicionar la cadera basalmente luxada) y barlow (la cadera está encajada y yo puedo luxarla)

Riesgo→ Artrosis, dolor, claudicación, por lo cual, debe ser manejada tempranamente

Factores de riesgo

- Sexo femenino
- Posición podálica
- Oligohidroamnios
- Antecedentes familiares
- Alteraciones neurológicas

Screening→ Rx de cadera a los 3 meses

Ecografía→ Al mes, en caso de guagua con factores de riesgo

Tratamiento→ A menor edad, mayor éxito

- Correas de Pavlik→ método de elección, el mas sencillo y con mas éxito
- Yeso con yugo→ Solo sin fallan las correas
- Quirúrgico→ En caso de displasias severas o a mayores de 1,5 años

< Edad
> Éxito



Podemos evaluarlo con la ubicación de los núcleos de osificación usando las líneas de perkins (línea vertical que pasa por el borde del acetábulo), los núcleos de osificación debiesen estar en el cuadrante inferointerno), mediante el arco de shenton o mediante el ángulo acetabular >36



Escoliosis

Desviación de la espalda

Diagnostico es clínico mediante la prueba de Adams (se pide al niño que se agache). Nos sirve para diferenciarlo de la pseudoescoliosis o giba costal.

Tratamiento → Depende del grado de desviación y de la edad.

Menor a 30 grados se trata solo con ejercicios, mayor a 30 grados se trata con corsé y mayor a 50 grados se trata con cirugía

Pie Plano

No hay arco plantar

Diagnostico → Clínico

Puede ser rígido o flexible (fisiológico y más común)

Pie plano flexible → el arco se forma al hiperextender el primer orjejo, levantar el pie o al extender todos los orjejos.

Tratamiento

Flexible → Se observa (Plantillas solo en caso de dolor)

Rígido → Derivar a TMT infantil

Pie Bot o zambo

Pie desviado en varo, equino (hacia abajo), cavo y aducto (se gira hacia dentro)

Diagnóstico → Clínico

Tratamiento → Ortopédico con yesos de ponseti

A menor edad, mayor éxito. En los adultos se trata con cirugía

< Edad
> Éxito



Sinovitis transitoria

Hay que saber diferenciarla de la artritis séptica, perthes y epifisiolisis.

Se da en niños de 2-4 años con dolor en la cadera (más frecuente) y rodilla (2ª en frecuencia)

Viene con claudicación de al marcha y niño con buen estado general.

Suele tener antecedente de una infección respiratoria alta previa

Diagnostico → Clínico, las Rx están normales

Tratamiento → Sintomático con paracetamol

Enfermedad de Perthes

Necrosis avascular de la cabeza femoral de un niño.

Se da en niños entre 5 y 10 años con dolor en la cadera y claudicación de la marcha

Puede venir con antecedente de talla baja y mucha actividad física

Diagnóstico → Radiografía AP de Pelvis (cabeza femoral plana y densa).

Tratamiento → Desde el reposo absoluto hasta la cirugía (en caso de gran necrosis en la cual requiere una prótesis).

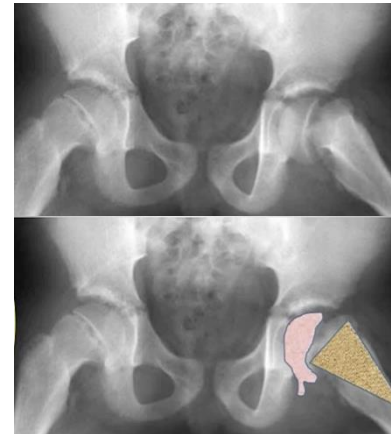


Epifisiolisis de la cabeza femoral

Se da en adolescentes de 12 a 15 años con dolor en cadera y claudicación de la marcha y puede venir con antecedente de obesidad

Diagnóstico → Radiografía AP de pelvis donde se ve la epífisis separada, signo del “helado caído”

Tratamiento → Cirugía



27. Oftalmología pediátrica

Suele ser 1 pregunta, aparece casi siempre

Ambliopía

Clínica → Disminución de la agudeza visual de un ojo que no mejora inmediatamente al corregirla

Se debe a una falta de estimulación de un ojo que lleva a falta de desarrollo nervioso de este.

Diagnóstico → Clínico

Tratamiento → Tratar la causa lo más precozmente posible

Lo más importante es la prevención

• Niño 6 años, con dificultades para leer. Tiene miopía -6 OD y -2 OI. Se corrige con lentes, pero sigue viendo mal por OD

Estrabismo

Desviación de la mirada de uno de los ojos

Puede causar diplopía

Su compilación mas frecuente es la ambliopía (Es la principal causa de ambliopía)

Diagnostico→ Clínico mediante a prueba de Hirschberg

Al iluminarle los ojos al niño, el reflejo de la luz debería estar en la mitad de la pupila de ambos

Tratamiento→ <6 meses y fluctuante→ Observar

>6 meses o fijo→ Derivar a oftalmólogo



Hirschberg alterado



Hirschberg normal, simplemente tiene epicantos. Es un pseudeoestrabismo

Obstrucción de la vía lagrimal (atresia lagrimal)

Clínica→ Epifora y suele complicarse con infecciones (conjuntivitis y dacriocistitis)

El Diagnostico es clínico. Es importante descartar el glaucoma

Tratamiento→ Sigue un orden (se pregunta)

1. Masajes del saco lagrimal
2. Cateterismo de la vía lagrimal
3. Dacricistorinostomia

Glaucoma congénito

Clínica

- Epifora
- Buftalmo y megalocornea (ojos muy grandes)
- Opacidad corneal
- Estrías de Haab

Diagnostico→ Clínico, ante la sospecha se debe derivar a oftalmólogo

Tratamiento→ Quirúrgico



Buftalmo y Megalocórnea



Buftalmo, megalocornea y opacidad corneal

Retinoblastoma

Clínica

- Leucocoria
- Proptosis
- Estrabismo

Diagnóstico→Clínico, ante la sospecha se debe derivar. Buen pronóstico si se diagnostica tempranamente

Tratamiento→ QT/RT/ Qx

Puede recurrir o asociarse a otros tipos de cáncer dado el carácter hereditario

Leucocoria

Pupila blanca

Causa

- Catarata congénita
- Retinoblastoma
- Persistencia del vítreo primario hiperplásico
- Retinopatía del prematuro

Diagnostico→ Clínico, se debe derivar

Tratamiento→ Según causa

Si está al nacer→ Catarata congénita

Si aparece a los 6 meses→ Retinoblastoma

Retinopatía del prematuro

Se debe hacer FO a todo prematuro menor de 32 semanas o peso menor a 1.500g.

Muestra una retina con una zona avascular.

Mientras mas central es la lesión, es peor.

Tiene riesgo de desprendimiento de retina que avanza a hacia la ceguera

Tratamiento→ Observar hasta una completa vascularización de la retina. Se realiza fotocoagulación y vitrectomía en los casos mas graves.

28. Dermatología pediátrica

Hemangiomas y Malformaciones vasculares

Hemangiomas→ Ausentes al nacer, pero crecen rápidamente y luego involucionan.

Se ubican en la cara y en el sacro (marcador de alto riesgo de espina bífida, SE DEBE PEDIR UNA ECOGRAFÍA)

Tratamiento→ Propanolol Oral (evitan su evolución y hemorragias)



Malformaciones vasculares

Las malformaciones vasculares están presentes desde el nacimiento y crecen junto con el niño

Pueden estar ubicada en cualquier parte y verse igual que un hemangioma, pero su evolución es distinta

Tratamiento → Observar a menos que se compliquen o estéticamente sean muy feas.



Hemangionas	Malformaciones
- Ausentes al nacer - Crecen rápido - Luego involucionan	- Presentes al nacer - Crecen a la misma velocidad del niño
Localización: cara, sacro (EBO)	Localización: cualquiera
Propanolol vo	Observación
Si falla: Qx	Si falla: Láser / Qx

Nevus flameus y mancha salmón

Nevus flameus

Es una macula roja (mancha vino tinto o mancha de oporto)

Ubicada en la mitad del cuerpo, no pasa la línea media

No desaparece, es una malformación vascular

Tratamiento → Observar. Se puede tratar con laser o con fines estéticos



Mancha salmón

Macula roja, mas rosada que el nevus

Ubicada en la línea media y la traspasa

Desaparece con el tiempo (generalmente al año)

Tratamiento → Observar



Nevus flammeus	Mancha salmón
- Mácula roja (vino tinto u oporto) - No pasa la línea media - No desaparece	- Mácula roja - En línea media (frente / occipital) - Desaparece con el tiempo
Láser / observación	Observación

Manifestaciones cutáneas normales en el RN

Se observan y no se hace nada

Milium sebáceo

Pequeñas pápulas puntiformes amarillo

pálido en dorso y alas nasales



Perlas de Ebstein
Pápulas blancas en la cara anterior de las encías
Desaparecen en pocos días



Miliaria cristalina
El sudor queda atrapado en pequeñas vesículas.



Acné neonatal
Se llena de pústulas en cara y pecho



Eritema tóxico
Aparece al 2-5 día de vida generalmente
Pústulas o vesículas de base eritematosa
Respeta palmas y plantas



Melanosis pustular
Pústulas generalmente en EEII, palmas y plantas



Mancha mongólica
Macula azulosa en zona glútea y sacra que suele desaparecer con el tiempo



Nevo de Ito
Mancha azul en el hombro (el nevo de Ito es una mancha azul en el hombrito)
No desaparece



Nevo de ota
Mancha azul en la cabeza (el nevo de ota es una mancha azul en la cabezota)
No desaparece



Manchas café con leche
Si son menos de 6, es normal. Si son mas sospechar neurofibromatosis



Nevo de spilus
Irregular, grande, color heterogéneo con maculitas
mas oscuras dentro

29. ITU en pediatría, malformaciones urológicas y reflujo vesicoureteral

Se preguntan siempre

ITU

Su diagnostico es igual que en los adultos (clínica + UC).

UC (+):

- >100.000 UFC por segundo chorro o recolector
- >10.000 UFC por sondeo, de elección en lactantes
- > 1 UFC por punción

Las ITU en pediatría se estudian con:

Eco renal → Para ver malformaciones obstructivas y reflujo vesicoureteral (RVU) grado III en adelante. Se pide SIEMPRE, es el estudio mínimo ante ITU en pediatría

Uretrocistografía → En caso de que la Eco esté alterada o en menores de 1 año con PNA.

GS para el RVU,

Cintigrafía DMSA → En agudo me orienta a PNA. De manera diferida (6-12 meses posterior a PNA) me muestra si hay o no una cicatriz. Se pide ante eco alterada o ante PNA en menor de 1 año.

Tratamiento

ITU baja → Nitrofurantoina o cefadroxilo x 7 días.

ITU alta → Cefadroxilo. En menores de 3 meses o niño grave se debe hospitalizar y usar cefalosporinas Ev (cefazolina, cefotaximo o ceftriaxona)

Los menores de 3 meses con ITU febril se hospitalizan si o si, los mayores de 3 meses se manejan ambulatorio a menos que venga grave o con complicaciones.

Profilaxis antibiótica → se hace con nitrofurantoina o cefadroxilo en una toma diaria y a la mitad de al dosis:

- Mientras esté el estudio pendiente
- Pendiente la resolución de la causa (reflujo, malformación, etc.)
- ITU recurrente (3 o mas ITU)

Malformaciones urológicas

Son muy frecuente en pediatría, tipo de malformaciones más frecuentes en general

Clínica

- Dificultad para orinar
- Incontinencia
- Infecciones urinarias
- ERC post renal
- HTA 2ª

Se estudian con Ecografía (examen más importante)

Tratamiento → Cirugía

Valvas uretrales → Dilatan de la vejiga hacia arriba, la obstrucción está en al uretra.

Estenosis ureterovesical → Se dilata **solo un uréter** desde la región distal hacia arriba (está estenótica la unión con la vejiga)

Estenosis pieloureteral → Se dilata desde la pelvis renal hacia arriba, la obstrucción esta en la unión entre la pelvis y el uréter.

Reflujo vesicoureteral

Se presenta como PNA y desarrollo de ERC.

El diagnóstico es con la UCG, la eco solo mostrará la dilatación del uréter, pelvis y riñón, pero esto se ve solo desde el grado III en adelante.

La UCG ve desde el grado I en adelante.

Tratamiento

- Leve (grado I y II) → Observar y ATB profiláctico en caso de ITU recurrente
- Grado III en adelante (con dilatación del uréter) → Cirugía (reimplante del uréter en la vejiga)

30. Ginecología Infantil

Se pregunta seguro (gine y/o pediatría)

- Metrorragia prepuberal
Causa: traumatismo (mas frecuente), cuerpo extraño vaginal (2ª + fr), otras (vulvovaginitis, violación) Manejo y dg: exploración, vaginoscopía, ecografía via TR, NO TV, no especuloscopia, no eco TV (se hace TR).
Tto: según causa
- Leucorrea prepuberal
Causa: vulvovaginitis inespecífica (75% de los casos), Cuerpo extraño vaginal, vulvovaginitis específicas (candida etc)

Manejo y dg: igual que la metrorragia (exploracion y vaginoscopía) + gram y cultivo
RN y pubertad→ Su flujo normal es mucoso transparente
Prepuberal→ Siempre patológico

- Vulvovaginitis inespecífica
Causa: 70% de las leucorreas prepuberal debido a alteracion de la flora vaginal por patógenos respiratros (+ ferc) o gastrointestinales como strepto A, neumococo, Haemophilus, virus, shigella, klebsiella, enterococo.
Clinica: inespecífica (leucorrea amarillenta, eritema y signos infalamtorios)
Dg: clínico, se complementa con gram y cultivo
Tto: aseo + atb
- Cuerpo extraño vaginal
Causa: papel higiénico es lo más frecuente.
Clínica: leucorrea purulenta, mal olor, metrorragia
Dg: clínico
Tto: sacarlo
- Sinequias vulvares
Causa: mala higiene/inflamación, Dermatitis del pañal, Idiopática
Clinica: adherencias entre labios menores
Dg. Clínico
Tto: masajes con vaselina liquida + aseo
Si falla se puede remover con cirugía.

Hallazgos normales en niñas

- RN: flujo mucoso, metrorragia y botón mamario (estrógenos maternos)
- Lactantes: botón mamario (hasta el año tanto en hombres como mujeres)
- Adolescentes postmenarquia→ 2 años ciclos irregulares

31. Psiquiatría infantil

Se pregunta SIEMPRE

El tratamiento en general es la psicoterapia con enfoque familiar



Depresión

Es lo que se ha preguntado con más frecuencia

Causa→ Disfunción familiar

Clínica

- Tristeza
- Anhedonia
- Insomnio
- Baja de peso/detención del crecimiento
- Cambio en el comportamiento (baja las notas en el colegio, niño se vuelve insolente)

Tratamiento→ Psicoterapia con enfoque sistémico. Se deben evitar los fármacos a menos que sea muy severa y refractaria.

Trastorno bipolar→ Suele manifestarse en la adultez, es raro que se vea en los niños.

Distimia→ También debido a disfunción familiar. La clínica es igual que en los adultos, pero el tiempo para hacer el diagnóstico es menor, pues aquí la tristeza que debe durar más de 1 año (no 2 años como en adultos)

Se trata con psicoterapia con enfoque familiar

Trastornos ansiosos

El más frecuente es el trastorno de ansiedad de separación.

Hay un apego inseguro, por lo cual, tanto los padres como el niño se ponen muy ansiosos con la separación

Afecta a preescolares al momento que empiezan a ir al jardín infantil generalmente.

Hay una ansiedad importante al separarse de los padres junto al miedo de que le pase algo a ellos. Existen pesadillas de separación y finalmente conductas evitativas de separación

Tratamiento→ Educación y psicoterapia enfocada en lograr un apego seguro

En los lactantes esto es normal desde los 10 meses.

TEPT y trastorno por stress agudo: Muy similar a adultos

• **TEPT y TEAg: el evento traumático puede ser distinto (ej. película de miedo, hospitalización, castigo, etc.)**

Trastorno por déficit atencional

Es de causa genética

Se caracteriza por mal rendimiento escolar. Cambia frecuentemente el foco de atención y no puede concentrarse en una sola cosa. Puede ser hiperactivo (típico niño hiperquinético chato) o Hipoactivo (el único síntoma suelen ser las malas notas, no es evidente, pasa piola)

Tratamiento

Lo más importante son las técnicas de estudio y trabajar en la autoestima.

Como 2ª línea se dejan psicoestimulantes (metilfenidato), Anfetaminas o modafilino.

En adultos también existe, la causa es la misma. Son niños con déficit atencional que se vuelven adultos. Son impulsivos, desordenados, verborreicos.

Viene SIN síntomas del ánimo (en ese caso es manía)

El tratamiento es el mismo, los fármacos no son lo mas importante.

- Trastornos del espectro autista

Son de causa desconocida

Clínica→ Niños con dificultad/imposibilidad con la comunicación, socialización e interacción con las otras personas.

Ya no se diferencian en autismo, asperger, etc. Son todas TEA, pero separarlas sirve para entender su clínica.

Asperger→ Grado más leve. Piensan de forma distinta y tiene áreas de interés distintas. Personas muy concretas, no entienden las indirectas. No son empáticos. Son niños que sufren de Bullying



Autismo→ Gran retraso del lenguaje. Si al año y medio no habla y no tiene problemas auditivos hay que pensar en autismo. Vienen con manierismos (movimientos estereotipados), no les gusta que los toquen.

El diagnóstico es clínico, se hace después de los 2 años

El tratamiento es multidisciplinario

Discapacidad intelectual

Causas múltiples (genético, asfixia neonatal, TORCH, etc.), pero generalmente desconocida. Se define como un CI menor a 70 y dificultad para las habilidades cognitivas en general (esto es lo más importante).

Parálisis cerebral→ Hasta un 80% tiene CI normal, lo que tienen si o si es afectación motora

- Oposicionismo normal

Proceso de individuación normal. A medida que el niño forma su identidad, puede haber casos de reticencia a obedecer.

Clínica→ niños de 2-3 años con rabietas y obstinación

Tratamiento→ Educar a los padres, esto es normal. Se debe desarrollar la tolerancia a la frustración en los niños

CASO 1: Niño de 2 años hace rabietas y grita cuando no se hace lo que quiere. Se tira al suelo y pateo.

- Trastorno oposicionista desafiante

Causa→ Temperamento difícil + mala disciplina. Se vuelve un niño de mierda insoportable

Niños de 6,7 años insolente, terco y agresivo. Tiene una mala relación con la autoridad, sin embargo, con sus pares se lleva bien.

Muy poca tolerancia a la frustración y es oposicionista, hace lo contrario a lo que se le pide.

Tratamiento→ Educación y disciplina

CASO 2: Niña de 5 años es muy insolente y desobediente. Hace lo contrario de lo que se le pide, golpea a los padres y los insulta.

- Trastorno de conducta disocial

Niños en ambientes vulnerables (abandono, maltrato, drogas, etc.)

Escolares de 10-12 años o adolescente que mas que insoportable es un niño malo. Miente, roba, es irrespetuoso, se saca malas notas, **maltrata a personas y animales**, destruye cosas ajenas y puede empezar a delinquir, narcotráfico, etc.

Tratamiento→ Intervención inmediata en la red de apoyo, es difícil y generalmente no se logra corregirlo, pero más fácil que hacer cambiar a un adulto. Suele avanzar hacia un TP antisocial.

CASO 4: Niño de 13 años, le ha robado a su madre. Raya las paredes del colegio, copia y miente. Le lanza piedras a los perros y ha reprobado muchas asignaturas.

CASO 3: Niño de 12 años, sin mayores antecedentes. Hace un mes bajó sus calificaciones, anda irritable e insolente. Se encierra en su pieza, con un portazo y le ha gritado a la mamá.



Era un niño normal y agudamente se fue a la B, hay que pensar en una depresión



- Maltrato infantil y violencia intrafamiliar

Hay que saber como sospecharlo y tratarlo médicamente

Hay que reconocer tanto la violencia física como psicológica

Es a causa de falta de herramientas de los padres para criar a los niños. Puede estar asociado a TP de los padres.

Clínica de sospecha

- Fracturas o equimosis con distintos grados de avance
- Fracturas costales posteriores y de escápula
- Hemorragias en el fondo de ojo
- Quemaduras por cigarrillo

Exámenes a pedir

- Radiografías de todo el cuerpo
- Fondo de ojo

Tratamiento→ Protección de la víctima con activación de protocolo jurídico y se debe denunciar de forma obligatoria.

El victimario debe ser derivado a psicoterapia

32. Cirugía pediátrica

Pregunta segura

Enterocolitis necrotizante

Clínica: RN día 2-7, con triada: vómitos + distensión abdominal + hematoquecia.

Causas: prematuro, asfixia o sepsis neonatal

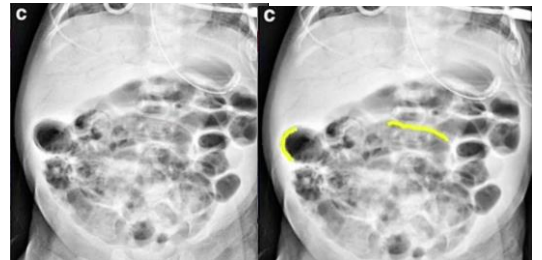
Dg: Rx simple de abdomen. Se ve: dilatación de asa, **neumatosis intestinal**, neumoperitoneo (signo de perforación)

Neumatosis Intestinal

Tto: régimen O + SF + ALPAR + ATB por traslocación bacteriana.

Tto quirúrgico cuando hay:

- Perforación
- Estenosis
- Fístula
- Muy grave, complicación anatómica



Intususcepción Intestinal

Clínica: Lactante entre 6m – 1 año. Dolor abdominal intenso (crisis de llanto), puede ceder.

Característico → hiperflexión de caderas. Hematoquezia (mermelada de grosella, frutilla). Masa palpable en cuadrante inferior derecho.

Causas: idiopático (intestino se “arremanga”), divertículo de Meckel, pólipo

Dg: Ecografía abdominal. Se ve signo de la dona o en target o tiro al blanco, signo de la herradura (corte longitudinal/oblicuo)

Tto: descompresión neumática, si no funciona hidrográfica y si no se puede va a cirugía.

Divertículo de Meckel

Clínica: Niño de cualquier edad, asintomático, se complica con **HDB grave**. Otra complicación es una diverticulitis (similar a apendicitis)

Causa: congénito. Persistencia del conducto onfalomésentérico (no es completo, si lo fuera sería una fístula)

Dg: Ante sospecha de hemorragia → Cintigrafía con tecnecio. En esa zona hay mucosa gástrica.

Tto: resección quirúrgica

Pólipo juvenil

Clínica: Escolares o preescolares. **HDB leve** y recurrente (historia clásica de recurrencia intermitente de rectorragia). Resto del examen físico normal

Causa: hamartoma vascular (desde que nace)

Dg: colonoscopia

Tto: resección colonoscópica.

Hematemesis en el lactante

Causa: sangre deglutida del pezón., otras causas como UGD, gastritis, ECN.

Manejo: test de apt-downey. Si cambia a color amarillo → es sangre adulta → observar. Si queda de color rojo → sangre fetal → SF + EDA.

Hernia diafragmática congénita

Clínica: RN. Dificultad respiratoria grave → hipoplasia pulmonar. Se auscultan RHA en tórax, abdomen excavado

Dg: RxTx. Ve imágenes circulares (asas intestinales) en tórax.

Tto: intubar + soporte ventilatorio (ventilación de alta frecuencia). Luego, reparación quirúrgica diferida.

Atresia esofágica

Clínica: RN. Sialorrea + dificultad respiratoria (por aspirar su propia saliva y/o asociación a malformación via aerea)

Causa: Malformación congénita. Fístula traqueoesofágica el 80%.

Dg: SNG + rxtx

Tto: cirugía (restaurar tránsito)

Atresia duodenal

Clínica: RN desde día 1 con vómitos postprandiales. Signos de deshidratación. Elimina meconio blanco (1 vez)

Causa: malformación congénita.

Dg: Rx. De abdomen → doble burbuja

Tto: quirúrgico.



Estenosis hipertrófica pilórica

Clínica: RN entre semana 2-6, vómitos postprandiales + signos deshidratación (avidez por lactancia, poca orina, icterico).

Causa: Idiopática, aunque puede venir con antecedentes familiares o de uso de eritromicina en el embarazo que podría tener algun asociación.

Dg: Ecografía: oliva pilórica engrosada (píloro engrosado) se puede palpar el píloro (se supone).

Dg. Diferencial: Hiperplasiasuprarrenal congénita (esto viene con hipokalemia + alcalosis, la insuficiencia suprarrenal es hiperK y acidosis).

Tto: cirugía → pilorotomía de Ramstedt.

Enfermedad de Hirschsprüng

Clínica: RN con retraso de eliminación de meconio (se espera hasta 48 hrs, después de eso es patológico). Clínica de obstrucción intestinal incompleta.

Causa: ausencia de neuronas de plexos mientéricos/submucoso. "aganglionosis"

Dg: rx. Baritada o manometría del colon (se ve hipertonia de la muscular). Confirmación: biopsia por succión

Tto: quirúrgico, resección de segmento comprometido + anastomosis término terminal

Ano imperforado

Clínica: RN que no elimina meconio + signos obstrucción intestinal + examen físico sin ano

Causa: malformación congénita (asociado a sd. Down)

Tto: cirugía

33. Cardiopatía congénita y soplo cardíaco

Cardiopatía se pregunta en pediatría también

Se dividen en 2, cianóticas (shunt de derecha a izquierda) y acianóticas (shunt de izquierda a derecha, las mas frecuentes)

Acianóticas

Presentan hiperflujo pulmonar que genera congestión pulmonar, mal incremento ponderal e intolerancia al ejercicio (se cansan con la succión) e infecciones respiratorias a repetición.

Pueden hacer cianosis y mejoran con el uso de Oxígeno.

Tipos

- **CIV (las más frecuente)→** Soplo holosistólico, dilatación de cavidades **izquierdas**
- CIA→ La 2ª más frecuente. Tiene un soplo sistólico eyectivo (mesosistólico) más un desdoblamiento del segundo sonido. Dilata las cavidades **derechas**
- Ductus arterioso persistente (DAP)→ Soplo continuo sistodiastólico. Dilata el lado **izquierdo**.
- Coartación aórtica→ Cardiopatía obstructiva izquierda que tiene soplo eyectivo (mesosistólico) con disminución de los pulsos de las EEII. Puede venir con HTA de las EEII.
- Canal auriculoventricular (se ha preguntado 1 vez)→ CIA + CIV, característico del Sd de down

Cianóticas

Se presentan con cianosis que no mejora con oxígeno (así mismo lo preguntan)

- Tetralogía de fallot→ **Es las más frecuente de las cianóticas**. Viene con una obstrucción derecha, por eso tiene este shunt de derecha a izquierda.
- Ventrículo único
- Trasposición de grandes vasos→ La aorta y la arteria pulmonar están cambiadas (aorta sale del lado derecho y pulmonar del izquierdo). No tiene soplos y no hay mezcla de las sangres. Hay un circuito de sangre que nunca se oxigena y otro sistema que nunca pasa a nivel sistémico. Si se cierra el ductus el paciente se muere rápidamente, es **ducto dependiente**
- Tronco arterioso→ Al aorta y la arteria pulmonar salen como una única arteria, se mezclan las sangres.

Todas tiene la misma clínica→ cianosis que no mejora con oxígeno, esto es lo importante

Diagnostico de ambas → Se hace con ecocardiograma

Tratamiento

TODAS se operan. El DAP puede intentar cerrarse antes con AINEs (indometacina o ibuprofeno)

Cianótica→ Como pueden ser ductus dependiente, se debe mantener el Ductus abierto con prostaglandinas (antes de hacer el diagnostico con eco, ante cianosis que no mejora a oxígeno).

TODO NIÑO QUE TIENE SOPLO Y CIANOSIS QUE NO MEJORA CON OXIGENO, DEBE RECIBIR PROSTAGLANDINAS.

Soplo Cardíaco→ Lo importante es diferenciar si es un soplo funcional o patológico. La clínica da la diferencia en general

Soplo funcional→ SIEMPRE es sistólico eyectivo sin frémito, tienen tonalidad musical con intensidad III/VI

Soplo patológico→ Puede ser sistólico o diastólico, puede tener frémito (intensidad IV/VI) y tiene síntomas de insuficiencia cardíaca

Los soplos funcionales se observan, los patológicos deben ser estudiados con ecocardiograma.

34. Criptorquidea, testículo retráctil y testículo en ascensor

Criptorquidea

Testículo no palpable en escroto (podría palparse en el conducto inguinal)

Tiene riesgo de cáncer e infertilidad

Estudio

1. Ecografía inguinoescrotal (encuentra el 70%)
2. Laparoscopia exploratoria en caso de que la Eco no localice el coquito

Tratamiento

Lactante menor→ Se observa hasta el año de vida por la posibilidad de que descienda.

Después de esto, quirúrgicamente se baja el testículo y se hace una orquidopexia. **No elimina el riesgo de cáncer**, pero si elimina la infertilidad.

En el adolescente el testículo se saca, porque ya quedo infértil ese coco y el riesgo de cáncer es alto.

Testículo retráctil y Testículo en ascensor

Testículo no palpable en escroto, pero si en el conducto inguinal con la capacidad de bajarlo al escroto.

En caso de que al bajarlo se devuelva al conducto inguinal es un testículo retráctil

En caso de que se queda en el escroto es un testículo en ascensor

Causa→ Reflejo cremasteriano exacerbado

Diagnóstico→ Clínico

Tratamiento→ Observación, no tiene ningún riesgo

35. Crisis convulsivas, epilepsia, convulsiones ebriles y status convulsivo

Crisis convulsiva

Se dividen en tipo focal y generalizada. Las focales, a su vez, pueden ser motoras, sensitivas o psicomotoras.

Estas además se dividen en parcial simple (no pierde conexión con el medio) o parcial compleja (en algún minuto se compromete de conciencia)

Generalizadas

- Tónico-clónica
- Mioclonica
- Tónica
- Atónica
- Ausencia

Si la convulsión inicia focal y se convierte a generalizada, se considera como focal.

Manejo de una crisis focal → Se asume que es por una lesión focal (tumor, ACV, etc.). Se pide una neuroimagen y luego de haber encontrado la causa se debe tratar la causa y se dejan anticonvulsivantes (carbamazepina y fenitoina).

Manejo de una crisis generalizada → Las causas más comunes son las epilepsia y alteraciones toxico-metabólicas, por lo tanto, se piden exámenes generales buscándolas (hiponatremia, hipoglicemia) + EEG.

Los anticonvulsivantes que se dejan en este caso con el ácido valproico, lamotrigina y fenitoina

¿Como diferenciamos una crisis convulsiva atónica de un síncope?

La crisis tónica tiene compromiso de esfínter

Epilepsia primaria: Generalmente de causa genética.

Diagnostico → Clínico con 2 crisis estereotipadas sin gatillante específico o con una sola crisis con EEG característico.

En el caso de que solo haya tenido una convulsión se diagnostica primoconvulsión. Si esta no tiene una causa que lo explique se asume que es una epilepsia y se trata como tal (anticonvulsivantes, idealmente como monoterapia y ajustado a niveles plasmáticos).

Convulsiones febriles

Convulsiones benigna → Son las mas comunes. Si esta en BEG y tiene entre 5 meses y 6 años. Simplemente se debe educar y tranquilizar. Re consultar SOS

En caso de que el niño este muy séptico y se sospeche de una meningitis bacteriana se debe hacer una PL (post TAC descartando HTE)



Manejo → Educar + antipiréticos para evitar fiebre.

Si es recurrente se deja Diazepam para cuando este con fiebre. En caso de que este convulsionando, se da lorazepam 0,1mg por kilo (hay que saber esta dosis).

Convulsión febril compleja: Que sea focal o que dure más de 15 minutos o bien más de 2 crisis en 24 horas. **En este caso se debe pedir RNM buscando tumores**

Estatus convulsivo

Convulsiones de 30 o más minutos sin recuperación ad integrum entre crisis

El manejo se inicia antes de cumplir los 30 minutos, no más allá de 5 min idealmente.

Se debe dar lorazepam Ev 4mg Ev (adultos) o 0,1mg/kg en niños, más una carga de fenitoina para evitar que vuelva a caer en otra convulsión.

Si esto no funciona se dan barbitúricos. Como ultima línea se dan anestésicos generales.

En resumen, existen 5 tipos de manejo de las crisis convulsivas

Septico → Estudiar MBA

Todo bien → PCT

Recurrente → PCT + diazepam

Convulsionando ahora → Lorazepam

Si es compleja → RNM

36. Malabsorción intestinal, enfermedad celiaca, intolerancia a la lactosa y galactosemia

Síndrome de malabsorción

Clínica

- Diarrea
- Baja de peso
- Esteatorrea
- Lientería
- Signos carenciales (anemia ferropénica, piel seca, queratitis angular, caída de pelo, etc.)

El diagnóstico es relativamente clínico, pero se necesitan exámenes para ir a confirmarlo (Test de Sudán y D-Xilosa)

Test de Sudán → Utiliza una muestra de deposiciones para determinar la presencia de grasa en ellas. Es un test para confirmar la esteatorrea y con esto la malabsorción

Test de D-xilosa → La D-xilosa es un monosacárido que se absorbe, pero no se metaboliza, por lo cual, se orina en su totalidad (orino todo lo que absorbo). Si la cantidad de d-xilosa orinada es menor a la cantidad ingerida, nos habla de un problema parietal, un problema de absorción intestinal (enf celiaca, Crohn, intestino corto, etc.). Si esta normal (Orinó la misma cantidad consumida) asumimos que es un problema enzimático como la fibrosis quística, pancreatitis crónica.

Se pide un EPSD para descartar una giardiasis

Enfermedad Celiaca

Respuesta inmune al gluten (antígeno en cereales) que genera inflamación y atrofia de la pared intestinal.

Clínica

- Síndrome de malabsorción
- Dolor abdominal
- Disminución del apetito
- Gases

Suele venir con anemia ferropénica e hipocalcemia, dado que, estos 2 electrolitos (Fe y Ca) se absorben en el duodeno (la parte mas afectada por la enfermedad celiaca)

Se puede confundir con un trastorno funcional fácilmente.

Diagnostico:

- Anticuerpos
 - Antitransglutaminasa
 - Anti endomisio
- EDA
 - Biopsia de duodeno
 - Disminución de la altura de las vellosidades
 - Alargamiento de las criptas
 - Infiltrado linfoplasmocitario en la lamina propia

Se pide también IgA total, dado que, suele estar baja y como los anticuerpos anti endomisio y anti TG también son IgA, entonces si esta muy bajo podría ser un falso negativo.

Tratamiento→ Dieta sin gluten ni avena

Control→ Clínica + niveles de anticuerpos (deberían ir bajando hasta llegar a ser negativos al año si ha seguido bien la dieta)

La falta de respuesta a tratamiento es por falta de apego a la dieta. En caso de que los anticuerpos si estén negativos (es decir, si hay apego a la dieta), se debe sospechar en un linfoma de MALT, el cual, se trata con antibióticos.

Intolerancia a la lactosa

Hay una disminución de la producción de lactasa

- Diarrea
- Dolor abdominal
- Distensión abdominal

Puede simular un sd de malabsorción.

Dg→ Prueba de tolerancia a la lactosa (Se toma lactosa y se miden los niveles de lactosa en sangre, los cuales, van a ser 0 porque no la absorbe)

Tratamiento→ No tomar lactosa

Galactosemia

Enfermedad genética recesiva rara, en la cual, faltan enzimas que degradan la galactosa, por lo cual, se acumula esta.

La clínica es inespecífica, da ictericia, IRC, daño del SNC y cataratas

Tratamiento → Dieta sin lactancia materna ni ningún otro tipo de leche animal, se debe dar "leches" de origen vegetal

37. Intoxicaciones

Se pregunta en pediatría y psiquiatría

Manejo general de las intoxicaciones

1. ABC
2. Lavado gástrico (solo dentro de la 1ª hora de la intoxicación, después no sirve)
3. Carbón activado → Para casi todas las intoxicaciones, salvo en las A's. **Ácidos, Álcalis, Alkoholes, Algunos metales (mercurio, plomo) y Alifáticos (hidrocarburos)**
4. Antídoto (de existir uno)
 - a. Órganos fosforados (insecticidas) → Atropina
 - b. Paracetamol → N-acetil-cisteína
 - c. BDZ → Flumazenil
 - d. Metanol → Etanol
 - e. Morfina → Naloxona

Intoxicación por benzodiacepinas (sd narcótico)

Síntomas → Compromiso de conciencia, depresión respiratoria. **Pupilas normales**

Lo importante es dar soporte respiratorio

El antídoto es el flumazenil. Mas que terapéutico es diagnóstico porque su efecto es muy breve

Intoxicación por opioides (sd opiáceo)

Clínica → Compromiso de conciencia y depresión respiratoria con **miosis puntiforme**

Tratamiento → General + Naloxona. Ventilar es lo más importante.

Intoxicación por anfetaminas, cocaína (sd adrenérgico)

Síntomas → HTA, taquicardia, sudoración, **midriasis** e hipertermia

Tratamiento → General + Diazepam. Betabloqueo TOTALMENTE CONTRAINDICADO

Intoxicación por antidepresivos tricíclicos y antipsicóticos (sd anticolinérgico)

Clínica → Compromiso de conciencia, taquicardia, midriasis, íleo paralítico, retención urinaria, sensación de boca seca y agitación

Manejo→General + bicarbonato en caso de ser por tricíclicos. Siempre tomar un ECG por riesgo de arritmias ventriculares.

El lavado gástrico podría hacerse hasta 2-4 horas tras su consumo

Intoxicación por ISRS, IMAO o ADTC (sd serotoninergico)

Generalmente al mezclarlos, no por si solos.

Clínica→agitación, rigidez, hipertermia, HTA, **temblor**, compromiso de conciencia y taquicardia

Tratamiento→ Manejo general

Intoxicación por antipsicóticos (sd neuroléptico maligno)

Clínica→ Compromiso de conciencia, hipertonia e HTA

Manejo→ General + BDZ y dantroleno (antídoto)

Intoxicación por insecticidas, órganos fosforados e inhibidores de acetilcolinesterasa (sd colinérgico)

Clínica→ Temblor, sialorrea y espasmos musculares. Suelen venir con vómitos y tener miosis.

Manejo→ General + atropina. Es importante lavar al paciente y su ropa en caso de ser trabajadores agrícolas.

Miosis→ Colinérgico y opiáceo

Midriasis→ Adrenérgico y anticolinérgico



14 preguntas que no son difíciles

1. Generalidades

Tipos de trastornos

- Anímicos
 - Depresión → Patología psiquiátrica más frecuente
 - Trastorno afectivo bipolar
 - Distimia
 - Trastorno adaptativo
- Psicóticos
 - Esquizofrenia
 - Trastorno delirante
 - Trastorno esquizoafectivo
 - Psicosis aguda
- Trastornos ansiosos
 - Trastorno de pánico (el que más se pregunta)
 - T. De Ansiedad generalizada
 - TOC
 - Fobia simple
 - Fobia social
 - T. Stress agudo
 - T stress post-traumático
- Somatomorfos
 - T. Somatización
 - T. Hipocondría
 - T. Por Dolor
 - T. Facticio
 - T. Conversivo
- Alimentación
 - Anorexia nerviosa
 - Bulimia nerviosa
- T. Disociativos
 - Amnesia disociativa
 - Fuga disociativa
 - Estupor disociativo
 - Sd de ganser
 - Personalidad doble
- T. por abuso de sustancias
 - Alcoholismo
 - Bebedor problema
 - Tabaquismo
 - Adicción a drogas
- Trastornos de personalidad
 - Cluster A
 - Esquizoide
 - Paranoide
 - Cluster B
 - Limítrofe
 - Narcisista
 - Histriónico
 - Antisocial
 - Cluster C
 - Evitativo
 - TOC
 - Dependiente

DSM→ Manual diagnóstico y estadístico y CIE 10→ Consenso nacional de estadística

Establecen criterios diagnósticos para las distintas enfermedades psiquiátricas, aunque realmente no importa, hay que aprenderse las clínicas clásicas, las preguntas EUANCOM no suelen cumplir criterios, pero si vienen con las clínicas clásicas

Neurosis v/s psicosis

Neurosis→ Sin pérdida de juicio de realidad, se ve en la gran mayoría de los trastornos psiquiátricos. Los pacientes entienden que pueden estar equivocados

Psicosis→ Pierde juicio de realidad, se ve en trastornos psicóticos. Presentan síntomas psicóticos, delirios y alucinaciones. Es apodíptico, los pacientes no son capaces de reconocer que están equivocados

Descompensante→ Stress es lo que descompensa todos los trastornos psiquiátricos

Complicaciones→ Todo trastorno psiquiátrico se complica con otros trastornos psiquiátricos. **Generalmente depresión**, pero también puede ser ansiedad o psicosis

PSICOTERAPIA

Trabajo del psicólogo, psiquiatra o médico general con el paciente

Todos los trastornos psiquiátricos deberían recibirla, además de fármacos en algunos casos

Cognitivo conductual→ “conozca y actúe”. Se le educa sobre su enfermedad y por tanto como manejarla. Esta es la terapia que más se usa, tiene efectos rápidos. No actúa sobre el problema de base, pero es efectiva para ayudar en el desenvolvimiento del paciente.

Psicoanalítica→ Se basa en la relación con otros. Busca un cambio más profundo. Es cara y lenta.

Psicoterapia sistémica→ Intervención en el paciente y su red de apoyo. Es la ideal en los niños

2. Trastornos del ánimo

Depresión

Es sinónimo de depresión mayor o episodio depresivo mayor

Existen varios tipos de depresión.

La depresión melancólica es la típica (baja de peso e insomnio).

Atípica→ en mujeres jóvenes. Sube de peso y duerme mucho. Tienen Craving por cosas dulces, intolerancia al rechazo). Se trata con IMAO (SE PREGUNTA)

Psicótica→ Se agregan delirios. Ruina, culpa (por mi culpa se murió mi hijo de cáncer, por culpa la sociedad es un desastre, etc.) y enfermedad (tengo cáncer porque lo sé, sin importar los exámenes) son los delirios más típicos.

Reactiva→ Tiene un gatillante. Clásico del 1er episodio

Recurrente→ Mas de 1 episodio, las cuales después vienen sin gatillante. Se dan antidepresivos a permanencia

Doble→ Distimia+ depresión. Se trata igual que una depresión

Su diagnóstico es clínico

Clínica→ Dura **por lo menos 14 días con Tristeza**

- Tristeza y/o Anhedonia
- Cambios en el peso (subir o bajar)
- Alteraciones del sueño
- Alteración de la concentración
- Ideas de muerte o suicidio

Suele venir con llanto, aislamiento y desesperanza

Antes de hacer el diagnósticos se debe pedir: **TSH** (hipotiroidismo puede simularlo), hemograma (anemia puede generar astenia y adinamia) y glicemia (para descartar diabetes)

El más importante es la TSH

Tratamiento

- Psicoterapia
- Antidepresivos
 - ISRS→ Son los que tienen menos efectos adversos, esto los hace el tratamiento de elección. RAM: Náuseas, impotencia o disminución de la libido. Se debe partir con dosis pequeñas para no genera síntomas ansiosos en un inicio. **Demoran 2-4 semanas en empezar a hacer efecto** y meses hasta erradicar los síntomas. Una vez erradicados los síntomas se deben dejar 6 meses más e ir bajándolos de a poco
 - Fluoxetina
 - Paroxetina (NO EN ADULTO MAYOR)
 - Sertralina
 - Citalopram y escitalopram
 - Duales→ Actúan sobre 2 neurotransmisores. Indicados en depresión refractaria a ISRS. Son de 2ª línea
 - Venlafaxina
 - Duloxetina
 - Mirtazapina→ Generalmente no se usa
 - Bupropión→ Sirve para el cese tabáquico
 - IMAO→ Inhibidores de la MAO, tienen varias RAM (**HTA, taquicardia**, hipotensión ortostática, diarrea, constipación y boca seca). Sirven para las depresiones atípica (Sube de peso y duerme mucho)
 - Seleginina y moclobemida→ Se han preguntado

- Tricíclicos→ Tienen muchas RAM. Las mas graves son las arritmias ventriculares, sedación y efectos anticolinérgicos (**contraindicado en glaucoma**). **Generalmente no se usan en depresión**, Pueden usarse en el manejo del dolor.
 - **Amitriptilina**
 - **Imipramina**

Casos especiales

Depresión en el adulto mayor→ Los ISRS son de elección, NUNCA dar tricíclicos

Embarazo→ De elección es la Fluoxetina, tiene un buen perfil de seguridad

Lactancia→ Sertralina, NO pasa a la leche materna

Niños→ No se ocupan fármacos, se hace psicoterapia familiar

Bipolares→ Contraindicados los antidepresivos, se deben dar estabilizadores del animo

Trastorno adaptativo

Es tanto un trastorno ansioso como del ánimo

Clínica

- **Evento gatillante**
- Síntomas depresivos
- Síntomas ansiosos
- Conductas desadaptativas (tomar OH, irresponsabilidades, etc.)

Puede ser depresivo, ansioso o mixto. Lo importante es que **no cumple criterios de nada**.

Puede venir con síntomas depresivos pero no le da para ser depresión

Puede evolucionar hacia una depresión

Tratamiento→ Psicoterapia SOLA, sin antidepresivos. Se enfoca la terapia en que supere la crisis que lo gatilló

Los gatillantes son crisis que pueden ser normativas (un gran porcentaje de la gente se ve expuesta a estas) o no normativas (más inusual). Ambas pueden producir un síndrome adaptativo o descompensar algún tipo de trastorno psiquiátrico

NORMATIVOS (salir del colegio, empezar a trabajar, nacimiento del primogénito, salida de los hijos de la casa, muerte de los padres)

NO NORMATIVOS (enfermedades, muerte de hijo, ser despedido, termino de una relación)

Duelo normal→ Hay tristeza, llanto, añoranza, etc., pero dura menos de 1 año y **NO HAY** criterios de enfermedades psiquiátricas (sin baja de peso, psicosis, conductas desadaptativas, etc.)

CASO 1: Paciente 50 años, su hijo se va a vivir al extranjero. Presenta llanto frecuente y se siente vacía.
Peso igual / baja de peso de 6 Kg / hace 7d

Trastorno adaptativo/ Depresión / Trastorno adaptativo

CASO 2: Paciente 30 años, despedida de su trabajo. Está triste y angustiada. Tiene la esperanza de encontrar uno nuevo.

Trastorno adaptativo

CASO 3: Paciente 70 años, muere su hijo de cáncer. Lloro todo el día y ya no sale de su casa. Se cree culpable de la muerte.

Depresión con síntomas psicóticos

Si nos dan un caso en que tenemos la duda entre adaptativo v/s depresión (tiene insomnio, pero no baja de peso por ejemplo). **Si es que hay un gatillante específico** marquen TRASTORNO ADAPTATIVO

Distimia

Es sinónimo de depresión menor

Clínica→ más de 2 años (1 año en adolescentes) con ánimo bajo, pero no cumple criterios de depresión.

Exámenes y tratamiento es igual a la depresión

Trastorno bipolar

Clínica

- Manía/hipomanías
- Depresión (mas frecuente que manías/hipomanías)

Suele debutar de forma temprana, alrededor de los 20 años

Diagnóstico→al menos 1 episodios maniaco/hipomaniaco o mixto

Causa→ Genético, viene con antecedentes familiares

Es importante diagnosticarlo, porque **CONTRAINDICA EL USO DE ANTIDEPRESIVOS**

Episodio maniaco→ Dura mínimo 4 días

- Animo expansivo, muy alto
- Irritabilidad
- Verborrea
- Fuga de ideas
- Hiperactividad (mental, motriz)
- Disminución de necesidades de sueño
- Actividades riesgosas → Esto es lo grave de las manías
 - o Sexo (le pone el gorro a su pareja generalmente)
 - o Compras (se gasta todo y se endeuda)
 - o Deportes

Episodio hipomaniaco → Es parecido pero menos intenso

Mixto → Mezcla de depresión y manía (triste, Anhedonia pero duerme poco, verborreico, ideofugal, etc.)

El diagnostico es siempre trastorno bipolar al encontrarnos alguna de estas 3 cosas

Tratamiento

Estabilizadores del ánimo a permanencia, **NUNCA DAR ANTIDEPRESIVOS**

El más usado es el Litio, de elección

Ac valproico, lamotrigina y carbamazepina se ocupan también.

En caso de agitación psicomotora se manda haldolazo 5mg im y a mimir



El litio es efectivo, pero muy tóxico, por lo cual, está contraindicado en pacientes con ERC y en pacientes embarazadas porque es teratogénico.

Intoxicación por litio

- Nauseas
- Vomito
- Dolor abdominal
- Ataxia
- Poliuria

Diagnostico → Litemia >1,2

Tratamiento → Suero fisiológico para forzar diuresis. Hemodiálisis en caso de estar muy mal

3 casos de TAB

CASO 1: Paciente 18 años. Agresivo y descontrolado. Habla mucho, dejando ideas inconclusas. Dormía 4 horas diarias.

CASO 2: Paciente 40 años, personalidad difícil. Está muy molesto con familiares, porque no entienden sus negocios que serán muy exitosos. Se va enojando con ud.

CASO 3: Paciente 25 años, está deprimido. Refiere muchas deudas, porque hace 6 meses gastó todos sus ahorros: compró auto, viajó y tenía 2 novias

3. Intoxicaciones

Se pregunta en pediatría y psiquiatría

Manejo general de las intoxicaciones

1. ABC
2. Lavado gástrico (solo dentro de la 1ª hora de la intoxicación, después no sirve)
3. Carbón activado → Para casi todas las intoxicaciones, salvo en las A's.
Ácidos, Álcalis, Alcoholes, Algunos metales (mercurio, plomo) y Alifáticos (hidrocarburos)
4. Antídoto (de existir uno)
 - a. Órganos fosforados (insecticidas) → Atropina
 - b. Paracetamol → N-acetil-cisteína
 - c. BDZ → Flumazenil
 - d. Metanol → Etanol
 - e. Morfina → Naloxona
 - f. Antipsicóticos → Dantroleno

Intoxicación por benzodiacepinas (sd narcótico)

Síntomas → Compromiso de conciencia, depresión respiratoria. **Pupilas normales**

Lo importante es dar soporte respiratorio

El antídoto es el flumazenil. Mas que terapéutico es diagnóstico porque su efecto es muy breve

Intoxicación por opioides (sd opiáceo)

Clínica→ Compromiso de conciencia y depresión respiratoria con **miosis puntiforme**

Tratamiento→ General + Naloxona. Ventilar es lo más importante.

Intoxicación por anfetaminas, cocaína (sd adrenérgico)

Síntomas→ HTA, taquicardia, sudoración, **midriasis** e hipertermia

Tratamiento→ General + Diazepam. **Betabloqueo TOTALMENTE CONTRAINDICADO**

Intoxicación por antidepresivos tricíclicos y antipsicóticos (sd anticolinérgico)

Clínica→ Compromiso de conciencia, taquicardia, midriasis, íleo paralítico, retención urinaria, sensación de boca seca y agitación

Manejo→ General + bicarbonato en caso de ser por tricíclicos. Siempre tomar un ECG por riesgo de arritmias ventriculares.

El lavado gástrico podría hacerse hasta 2-4 horas tras su consumo

Intoxicación por ISRS, IMAO o ADTC (sd serotoninérgico)

Generalmente al mezclarlos, no por si solos.

Clínica→ agitación, rigidez, hipertermia, HTA, **temblor**, compromiso de conciencia y taquicardia

Tratamiento→ Manejo general

Intoxicación por antipsicóticos (sd neuroléptico maligno)

Clínica→ Compromiso de conciencia, hipertonía e HTA

Manejo→ General + BDZ y dantroleno (antídoto)

Intoxicación por insecticidas, órganos fosforados e inhibidores de acetilcolinesterasa (sd colinérgico)

Clínica→ Temblor, sialorrea y espasmos musculares. Suelen venir con vómitos y tener miosis.

Manejo→ General + atropina. Es importante lavar al paciente y su ropa en caso de ser trabajadores agrícolas.

Miosis→ Colinérgico y opiáceo

Midriasis→ Adrenérgico y anticolinérgico

5. Trastornos psicóticos

Psicosis→ Pérdida del juicio de realidad

Su diagnóstico es clínico y tratamiento es con antipsicóticos

Antipsicóticos típicos→ Muy potente pero con muchas RAM.

Uso→ En psicosis agudas y pacientes agitados

RAM→ Síndrome extrapiramidal

Fármacos→ Haloperidol, clorpromazina y tioridazina

Atípicos→ con menos RAM, son de elección para los trastornos crónicos

Uso→ EN psicosis crónicas. ACTÚAN SOBRE LOS SINTOMAS NEGATIVOS de la EQZ

RAM→ Los mismo que los típicos, pero menos frecuente

Fármacos→ Risperidona, Quetiapina, olanzapina y clozapina (esta es excelente, pero baja los neutrófilos, por lo cual se debe controlar con hemograma)

ESQUIZOFRENIA

Es una enfermedad genética autosómica dominante con penetrancia de 75%

Clínica

Primarios o negativos

- Aplanamiento afectivo
- Apatía
- Abulia

Secundarios o positivos

- Alucinaciones
 - Auditivas y personificadas principalmente
- Delirios

Se manifiesta en pacientes jóvenes al igual que el TAB, alrededor de los 18 años

EQZ paranoide→ EQZ clásica. Tiene tanto síntomas positivos como negativos

EQZ simple→ Solo síntomas negativos

Residual→ Solo síntomas negativos, pero por el tratamiento

Catatónica→ Muchos síntomas motores, Rigidez cética y estupor catatónico

Hebefrénica→ Pensamiento muy desorganizado y raro de entender

Tratamiento

Antipsicóticos atípicos orales

En caso de haber mala adherencia se ocupan antipsicóticos de depósito como el modecate.

Generalmente los EQZ que viven en la calle ocupan estos fármacos

Agitación→ Antipsicótico típico IM (Haldolazo)

Factores pronósticos de la EQZ

Buen pronóstico	Mal pronóstico
• Paciente adaptado previamente • Casado • Profesional • Inicio súbito de los síntomas	• Muchos síntomas negativos / primarios • EQZ catatónica y desorganizada • Inicio larvado / insidioso de los síntomas • Demora en el tratamiento

Trastornos delirante

Clínica → Delirio sistematizado (bien explicado) de mínimo 4 semanas de duración (antes de esto es una **psicosis aguda**). NO afecta al resto de los aspectos de su vida
Viene SIN ALUCINACIONES NI SÍNTOMAS NEGATIVOS, en ese caso es EQZ

Si le da a un adolescente o tiene antecedentes familiares de EQZ, pensar que es EQZ también

Tipos de trastornos delirantes

DELIRIO	→ Apodíptico
Paranoide	Me espían / Complot
Celos	Mi pareja me es infiel
Erotomanía	Está enamorado de mí
Daño	Me odia y quiere dañar
Megaloman.	Superpoder / Importan.
Enfermedad	Tengo una enfermedad

→ Se ha preguntado

→ Se ha preguntado

Trastorno esquizoafectivo

Clínica → Síntomas anímicos (como una depresión o un TAB) + síntomas psicóticos que **inician de forma simultánea**.

Hay de tipo depresivo y de tipo bipolar

Tratamiento

Depresivo → Antidepresivo + antipsicóticos

Tipo TAB → Estabilizadores del ánimo + antipsicóticos

Psicosis reactiva

Clínica → Cuadro psicótico (Alucinaciones, delirios) tras un gatillante. Dura más de 1 día y menos de 1 mes.

Se recupera por completo posteriormente, es de buen pronóstico y no suele recurrir.

Se trata con antipsicóticos + tratar la causa. Es fundamental tratar la causa (drogas, infecciones, intoxicaciones, etc.) Se debe pedir neuroimagen

Psicosis postparto

Ocurre en el puerperio. Generalmente viene con problemas para dormir, inquietud y después aparecen las alucinaciones y los delirios.

Tratamiento→ Antipsicóticos y buscar la causa

Es de buen pronóstico también.

6. Trastornos Ansiosos

Trastorno de pánico

En general sienten angustia/ansiedad y algunos hacen crisis de pánico

Suelen venir con evitación. Evitan aquello que les genera angustia

El diagnóstico de todos ellos es clínico

Se tratan, de modo general, con antidepresivos (ISRS) a dosis bajas que se suben lentamente.

Las BDZ son el tratamiento sintomático de elección para la crisis de angustia. Deberían usarse por poco tiempo

Crisis de pánico→ Es un síntoma , no una enfermedad

Clínica

- Inicio súbito
- Alcanza su intensidad máxima en menos de 10 minutos
- Miedo/ansiedad
- Muchos síntomas
 - Palpitaciones
 - Disnea
 - Opresión torácica
 - Vértigo
 - Sudoración
 - Despersonalización

La crisis se trata con BDZ SL o Ev (lorazepam 2mg SL es el típico)

Trastorno de angustia, ansiedad o pánico

Es lo mismo que el trastorno de angustia y trastorno de pánico

Clínica

- Crisis de pánico recidivantes
- Sin causa explicada
- Miedo a la crisis con ansiedad anticipatoria

Puede venir con o sin agorafobia (miedo a no recibir ayuda)

Exámenes→ ECG (podría ser una arritmia paroxística), TSH (hipertiroidismo) y glicemia (hipoglicemia)

Tratamiento→ BDZ para las crisis e ISRS para el trastorno de ansiedad

Trastorno de ansiedad o angustia generalizada

No es lo mismo que el trastorno de angustia o ansiedad

Clínica

- expectación ansiosa (esperando que pase algo malo)
- Evitación - "algo malo va a pasar". Tienen miedo a todo

No hacen crisis de pánico, porque evitan todo

Tratamiento→ ISRS para el trastorno en si y BDZ para los síntomas

Agorafobia

Miedo a no recibir ayuda. También tienen conductas evitativas

Suele ser a situaciones en particular (muchedumbre, espacios abiertos o cerrados, puentes, metro)

Tratamiento→ BDZ e ISRS (El mismo de siempre)

Fobia social

Ansiedad ante el juicio o escrutinio público. Miedo a hacer el ridículo.

Se da ante presentaciones/exámenes orales o hacer cualquier cosa en público

Suelen tener amigos/pareja, pero en estas situaciones en particular no puede comportarse normal.

El tratamiento es psicoterapia y si es grave se da el tratamiento clásico.

TOC

Clínica→ Obsesiones (idea recurrente que genera ansiedad) + compulsiones (conducta que me disipa la ansiedad)

El paciente sabe que sus ideas son obsesivas, no es psicótico.

La compulsión le permite descargar su ansiedad y no hacer crisis de pánico.

La mas frecuente es la obsesion de contamiacion y compulsión de limpieza. Es frecuente también la obsesion de duda y compusion de corroboración, por ejemplo, al bajarse del auto cerrarlo mas de una vez (pero francamente, el que aprieta el botón para cerrar el auto solo una sola vez al bajarse es un psicópata)

Tratamiento→ BDZ e ISRS

TEPT y T. Stress agudo

Evento gatillante que compromete la vida de la persona o alguien más. Tiene fenómenos de reexperimentación, recuerda el momento o tiene pesadillas.

Están en estado de hiperalerta y tienen medidas evitativas

Si lleva menos de 4 semanas **desde el evento gatillante** es un T. stress agudo y si lleva mas de 4 semanas es un TEPT

Ej:

CASO 5: Paciente es asaltada y se acuerda constantemente de lo que le pasó y ya no quiere salir de la casa, por miedo.

Tratamiento

Stress agudo → Psicoterapia (contención emocional) + BDZ para la abgustia

TEPT → ISRS + BDZ

Fobia simple

Miedo irracional a algo específico

Suelen hacer crisis de pánico al exponerse a lo que le da miedo y presentar medidas evitativas frente a este.

Lo mas frecuente es la fobia a los animales, a la sangre, aviones, oscuridad, espacios cerrados

Tratamiento → Psicoterapia de exposición progresiva

Fobia v/s TEPT → El TEPT viene con reexperimentación

7. Trastornos somatomorfos

Se preguntan siempre

Síntomas muy variados sin una causa orgánica que la explique. Asociados al stress

El diagnóstico es absolutamente clínico

NO ESTÁN PSICÓTICOS

Solo se deben pedir exámenes para descartar causa orgánica. El tratamiento es la educación, no sirven los fármacos

Trastorno de somatización

Es el más frecuente y que se pregunta más

Clínica

- Síntomas de todo tipo, habitualmente dolor. Se piden 4 tipos de dolor para un diagnóstico más certero
 - o Dispareunia, disminución de la libido
 - o Disestesia, alodinia,
- Vida muy afectada por estos síntomas

Se complica con depresión

Trastorno por dolor

Clínica → solo Dolor

Podría venir relacionado con una patología que lo explique, pero es un dolor que persiste más allá de lo normal

Trastorno por hipocondría

Clínica → Sin síntomas o muy piola e inespecíficos, pero tiene **miedo a tener una enfermedad progresiva y grave** (cáncer)

Suele desconfiar del médico y exige exámenes

Trastorno dismórfico corporal

Clínica → “Una parte de mi cuerpo es horrible”. Esto hace que se avergüence y la oculte. Suele buscar cirugía estética, pero queda disconforme. La solución es la psicoterapia, no la cirugía

Trastorno facticio

Finge o se autoinduce los síntomas.

Tiene un **fin ganancial** (afectiva, emotiva, cuidado, atención)

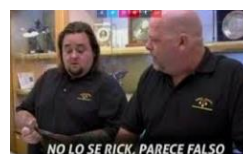
Trastorno por simulación

Es muy similar, finge o se autoinduce los síntomas, pero en este caso busca una ganancia monetaria, pensión, evitar cárcel, etc.

CASO 1: Paciente 50 años, sufre accidente laboral, con fractura de pierna. A los 6 meses, sigue con mucho dolor, que no se condice con el grado de consolidación.

CASO 2: Paciente 32 años quiere frenillos, porque sus dientes están muy chuecos. Al examen, sus dientes son normales.

CASO 3: Paciente 24 años ha tenido muchos vómitos. La madre encontraron un jarabe de ipeca en su velador.



8. Trastornos de personalidad

No se puede hablar de trastorno de personalidad antes de los 18 años, pues ahí aún no está formada la personalidad

La característica más importante son las malas relaciones con los demás

Son egosintónicos

Se clasifican en 3 clusters

Cluster A → Personalidades “psicóticas”

TP esquizoide

TP limítrofe

Cluster B → TP “anímico”

TP limítrofe

TP histriónico

TP Narcisista

TP antisocial

TP Evitativo

Cluster C → Ansiosos

TP Evitativo

TP dependiente

TP TOC

El diagnóstico es clínico y el tratamiento es con psicoterapia

Son de mal pronóstico el esquizoide, paranoide y antisocial

Cluster A

Esquizoide → Persona muy indiferente, fría, plana afectivamente. Habitualmente no tiene amigos ni pareja y no le importa.

No desea ni disfruta de las relaciones interpersonales

Paranoide → Persona desconfiada. Percibe significados ocultos en todo lo que se le habla.

Siempre cree que va a ser traicionado

Esquizotípico → Persona excéntrica, rara. Lo caracteriza las ideas de referencia (todas las cosas que pasan a su alrededor son señales para él). Cerca de la psicosis

Tiene creencias, comportamiento y lenguaje raro.

No tiene muchos amigos

NO está psicótico, pero se considera dentro de los tipos de EQZ

Cluster B

Antisocial → Una persona mala, cruel, suelen ser delincuentes. Son deshonestos, agresivos, mentirosos e incumplen la ley. No tienen empatía ni remordimientos

Narcisista→ Arrogante y envidioso. Tiene fantasías de éxito y son explotadores, se aprovechan de los demás. Se siente especial y único. Son envidiosos y además sienten que los envidian

Límite→ Agresivos, impulsivos e inestables. Pasan muy rápido de la felicidad a la rabia máxima. Tienen relaciones interpersonales muy inestables. Luchan contra el abandono de la gente, es un chato ql.
Son los que más se suicidan

Histriónico→ Quiere ser el centro de atención. Tiene emociones exageradas y cambiantes. Superficial, teatral y muy influenciado por los demás.

Cluster C

Evitativo→ Se siente inferior, es muy retraído con baja autoestima. Es el contrario al narcisista. Siente ansiedad ante el rechazo, se sienten poca cosa y creen que los van a rechazar. Quiere tener amigos y pareja. Evita situaciones en las cuales se expone al rechazo de los demás. NO va a lugares donde tenga que interactuar mucho. Sus amigos son sus familiares

Dependiente→ Necesita el apoyo en todo, delega sus decisiones a otros y no expresan desacuerdo. Aceptan el abuso del resto. Complace a los demás para sentirse querido, apoyado. Apenas termina una relación empieza otra.

TOC→ Muy ordenada y detallista. Si les desarmas su orden sufren. Muy dedicadas al trabajo y estudio. Obstinado, terco, avaro e inflexibles. Es egosintónico



9. Trastornos conversivos y disociativos

Trastorno conversivo

Síntomas súbitos de tipo **neurológico** sin causa orgánica. (síncopes, pérdida de conciencia, hemiplejía, parálisis facial, convulsión, etc.)

Es común que el paciente no se vea tan preocupado y a pesar de haber tenido síncope/convulsión, no se golpea fuertemente, pues si bien es involuntario, igual es controlado

El diagnóstico es clínico

El tratamiento se basa en educar y psicoterapia para tratar la causa (generalmente stress).
Recorre con poca frecuencia.

Ej:

CASO 1: Paciente de 23 años sufre síncope durante discusión. Exámenes normales. Parece indiferente y no se golpeó.

CASO 8: Paciente se queda ciega después de enterarse que su novio le era infiel.

Trastornos disociativos

Son varios

Viene con síntomas de tipo psicológicos sin causa orgánica. Se asocian a stress también.

El diagnóstico es clínico y su tratamiento es educar y psicoterapia.

- Amnesia discociativa

Ante un trauma pierde la memoria e incluso puede olvidar mas cosas e inventa la historia

Ej:

CASO 4: Paciente es asaltada, pero ella no lo recuerda. Sabe que algo pasó, pero no se acuerda ni del asaltante ni del asalto mismo.

- Fuga discociativa

Escape repentino, se escapa de los problemas. Puede venir asociado a amnesia discociativa

Ej:

CASO 3: Médico. El día del Eunacom es encontrado vagando por la ribera del Río Mapocho. Dice que vive ahí.

- Estupor discociativo

Ante un trauma se queda inmóvil



- Trastorno de identidad disociativa (doble personalidad o múltiple)

2 o más personalidades, existiendo amnesia de lo que hizo "la otra" personalidad



- Despersonalización

Sensación de que el cuerpo no es realmente su cuerpo

Puede ser parcial (una parte del cuerpo nomas "este pie no es mio)

NO HAY PSICOSIS, sabe que la mano, pie, etc. si es suyo, pero siente que no

Ej:

CASO 10: Mujer siente que su mano derecha no es de ella y que se siente rara y se "mueve distinto". Está asustada.

- Desrealización

Sensación de que el mundo no es real

La realidad es percibida como una extrañeza

Entiende que si es real, pero no lo siente así

Ej:

CASO 9: Hombre 33, muy estresado por su trabajo. Refiere que tiene la sensación de que el mundo está raro, sin color, sin vida, como que fuera plástico. Sabe que no es normal

- Sd de Ganser

Clásico de los reos.

Respuestas erróneas (pararespuestas) más otros síntomas disociativos y alucinaciones

10. Trastornos de alimentación

De vez en cuando se preguntan

Su diagnóstico es clínico y se trata de forma multidisciplinaria (nutrición, psicoterapia y fármacos eventualmente)

- Anorexia nervosa

Clínica

- Baja de peso
- Preocupación excesiva por el peso
- Alteración de la percepción corporal
- Amenorrea (puede darse un Hipogonadismo hipotalámico, no siempre)

Se asocia al TP TOC

Complicaciones

- Osteoporosis
- DHC
- Desnutrición

Se debe pedir densitometría ósea y pruebas hepáticas

- Bulimia Nervosa

Clínica

- **Atracones** (perdida del control sobre la comida)
- **Purgas** (se siente culpable y toma acciones para evitar subir de peso como vómitos, ejercicio excesivo, laxantes, dietas mu estrictas)
- Suelen tener normopeso, sobrepeso e incluso obesidad, pero no desnutrición

Asociado a TP límitrofe

Complicaciones

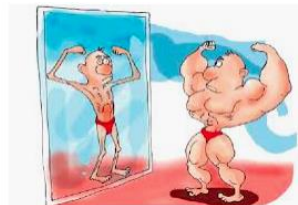
- Parotidomegalia (por vomitar tanto)
- Síndrome de mallory weiss y Boerhaave

Sirven los antipsicóticos atípicos y betabloqueo no selectivo porque ayuda un poco en el control de los impulsos.

- 17 años.
- **Peso: 40 Kg; Talla: 1,7m**
- **Se siente muy gorda.**
- **Come muy poco.**
- **Vomita después.**

→ Anorexia con purga (anorexia restrictivo-prugativa). Lo que manda es el peso. En caso de hacer purga sería bulimia

La Vigorexia es un trastorno dismórfico corporal, no es un trastorno de la alimentación



11. Trastorno por consumo de sustancias

Dependencia → Necesitar una droga para poder vivir. Se pierde mucho tiempo consiguiendo, consumiendo y recuperándose de la sustancia. Genera tolerancia y abstinencia además de múltiples intentos fallidos por dejarla.

Abstinencia → Sensación de malestar al no consumir la droga.

Tolerancia → Dosis mas alta para lograr el mismo efecto con una droga

Abuso → Consumo de una droga que genera efecto negativo (físico, médico, laboral, familiar, etc.)

Intoxicación → Síndrome transitorio por el consumo de una sustancia (borrachera por ejemplo)

Craving → Deseo incontrolable de consumir una droga

Marihuana

Consumo muy difundido en Chile y hay una falsa creencia de que no es perjudicial Su daño más grande es la desmotivación. Esto lleva a deserción académica (Se ha preguntado).

Sirve para el dolor refractario, para subir de peso y anticonvulsivante.

No produce EQZ, pero si puede hacer que se manifieste un brote en el paciente (se preguntó)

Cocaína

Proadrenérgico.

Su riesgo más grande es la sobredosis llevando a infartos, ACV y arritmias.

Las BDZ son el tratamiento. NUNCA dar betabloqueo

Pasta Base de cocaína

Cocaína menos láis, viene con dosis más erráticas de cocaína. Asociado a vulnerabilidad

Diagnóstico → Clínico

Tratamiento → Entrevista motivacional (como en todo abuso de sustancias), psicoterapia cognitivo-conductual (base del tratamiento) y si ya no hay nada que hacer, se maneja con minimización de daños. Esto es asumir que va a seguir consumiendo y logara que lo haga menos y controlado

12. Trastorno por consumo de alcohol

Riesgos del alcohol

DHC

Daño cerebral

Accidentes de tránsito

Problemas familiares

Cantidad máxima de alcohol

Mujeres → 1 trago al día

Hombres → 2 tragos al día (2 cervezas o 1 destilado)

Alcoholismo → Dependencia del alcohol

Bebedor problema → Consumo perjudicial de alcohol

El objetivo en estas personas es lograr la abstinencia completa

SÍNDROME DE ABSTINENCIA

Abstinencia al alcohol

Produce ansiedad, insomnio, temblor y malestar en casos leves.

En casos graves de abstinencia puede llegar a convulsiones y delirium tremens, el cual se manifiesta como temblor, microzoopsias (alucinaciones visuales de animales pequeños que lo atacan) y agitación.

Tratamiento → BDZ

Abstinencia a BDZ

Igual al alcohol, pero sin delirium tremens

Tratamiento → BDZ

Síndrome de discontinuación de SIRS

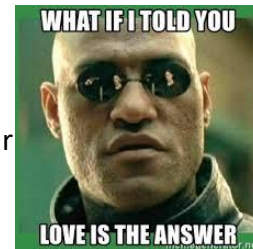
Viene con 2 conjuntos síntomas.

Síntomas ansiosos (ansiedad, malestar, temblor, insomnio) y gripales

Tratamiento→ Educación y quizás un poco de BDZ. Suele ser de duración breve, 2-4 días se pasa

13. Psiquiatría infantil

Se pregunta SIEMPRE



El tratamiento en general es la psicoterapia con enfoque familiar

- Depresión

Es lo que se ha preguntado con más frecuencia

Causa→ Disfunción familiar

Clinica

- Tristeza
- Anhedonia
- Insomnio
- Baja de peso/detención del crecimiento
- Cambio en el comportamiento (baja las notas en el colegio, niño se vuelve insolente)

Tratamiento→ Psicoterapia con enfoque sistémico. Se deben evitar los fármacos a menos que sea muy severa y refractaria

Trastorno bipolar→ Suele manifestarse en la adultez, es raro que se vea en los niños.

Distimia→ También debido a disfunción familiar. La clínica es igual que en los adultos, pero el tiempo para hacer el diagnóstico es menor, pues aquí la tristeza que debe durar más de 1 año (no 2 años como en adultos)

Se trata con psicoterapia con enfoque familiar

- Trastornos ansiosos

El más frecuente es el trastorno de ansiedad de separación.

Hay un apego inseguro, por lo cual, tanto los padres como el niño se ponen muy ansiosos con la separación

Afecta a preescolares al momento que empiezan a ir al jardín infantil generalmente

Hay una ansiedad importante al separarse de los padres junto al miedo de que le pase algo a ellos. Existen pesadillas de separación y finalmente conductas evitativas de separación

Tratamiento→ Psicoterapia enfocada en lograr un apego seguro

En los lactantes esto es normal

- Trastorno por déficit atencional

Es de causa genética

Se caracteriza por mal rendimiento escolar. Cambia frecuentemente el foco de atención y concentrarse en una sola cosa. Puede ser hiperactivo (típico niño hiperquinético chato) o Hipoactivo (el único síntoma suelen ser las malas notas)

Tratamiento

Lo más importante son las técnicas de estudio y trabajar en la autoestima
Psicoestimulantes (metilfenidato), Anfetaminas o modafilino

En adultos también existe, la causa es la misma. Son niños con déficit atencional que se vuelven adultos. Son impulsivos, desordenados, verborreicos.
Viene SIN síntomas del ánimo (en ese caso es manía)
El tratamiento es el mismo, los fármacos no son lo mas importante

- Trastornos del espectro autista

Son de causa desconocida

Clínica→ Niños con dificultad/imposibilidad con la comunicación, socialización e interacción con las otras personas.

Ya no se diferencian en autismo, asperger, etc. Son todas TEA, pero separarlas sirve para entender su clínica

Asperger→ Grado más leve. Piensan de forma distinta y tiene áreas de interés distintas. Personas muy concretas, no entienden las indirectas. No son empáticos. Son niños que sufren de Bullying

Autismo→ Gran retraso del lenguaje. Si al año y medio no habla y no tiene problemas auditivos hay que pensar en autismo. Vienen con manierismos (movimientos estereotipados), no les gusta que los toquen
El diagnóstico es clínico, se hace después de los 2 años
El tratamiento es multidisciplinario



- Discapacidad intelectual

Causas múltiples (genético, asfixia neonatal, TORCH, etc.), pero generalmente desconocida
Se define como un CI menor a 70 y dificultad para las habilidades cognitivas en general (esto es lo mas importante)

Parálisis cerebral→ Hasta un 80% tiene CI normal, lo que tienen si o si es afectación motora

- Oposicionismo normal

Proceso de individuación normal. A medida que el niño forma su identidad, pueden haber casos de reticencia a obedecer.

Clínica→ niños de 2-3 años con rabietas y obstinación

Tratamiento→ Educar a los padres, esto es normal. Se debe desarrollar la tolerancia a la frustración en los niños

CASO 1: Niño de 2 años hace rabietas y grita cuando no se hace lo que quiere. Se tira al suelo y pateo.

- Trastorno oposicionista desafiante

Causa→ Temperamento difícil + mala disciplina. Se vuelve un niño de mierda insoportable

Niños de 6-7 años insolente, terco y agresivo. Tiene una mala relación con la autoridad, sin embargo, con sus pares se lleva bien.

Muy poca tolerancia a la frustración y es oposicionista, hace lo contrario a lo que se le pide.

Tratamiento→ Educación y disciplina

CASO 2: Niña de 5 años es muy insolente y desobediente. Hace lo contrario de lo que se le pide, golpea a los padres y los insulta.

- Trastorno de conducta disocial

Niños en ambientes vulnerables (abandono, maltrato, drogas, etc.)

Escolares de 10-12 años o adolescente que más que insoportable es un niño malo.

Miente, roba, es irrespetuoso, se saca malas notas, maltrata a personas y animales, destruye cosas ajenas y puede empezar a delinquir, narcotráfico, etc.

Tratamiento→ Intervención inmediata en la red de apoyo, pero es difícil y generalmente queda en nada. Suele avanzar hacia un TP antisocial



CASO 4: Niño de 13 años, le ha robado a su madre. Raya las paredes del colegio, copia y miente. Le lanza piedras a los perros y ha reprobado muchas asignaturas.

CASO 3: Niño de 12 años, sin mayores antecedentes. Hace un mes bajó sus calificaciones, anda irritable e insolente. Se encierra en su pieza, con un portazo y le ha gritado a la mamá.

Era un niño normal y agudamente se fue a la B, hay que pensar en una depresión

- Maltrato infantil y violencia intrafamiliar

Hay que saber como sospecharlo y tratarlo médicamente

Hay que reconocer tanto la violencia física como psicológica

Es a causa de falta de herramientas de los padres para criar a los niños. Puede estar asociado a TP de los padres.

Clínica de sospecha

- Fracturas o equimosis con distintos grados de avance
- Fracturas costales posteriores y de escápula
- Hemorragias en el fondo de ojo

- Quemaduras por cigarrillo

Exámenes a pedir

- Radiografías de todo el cuerpo
- Fondo de ojo

Tratamiento→ Protección de la víctima con activación de protocolo jurídico y se debe denunciar de forma obligatoria.

El victimario debe ser derivado a psicoterapia

14. Demencia y Delirium

DEMENCIA

Alteración de la memoria asociado a alteración del resto de las funciones cognitivas (apraxias y agnosias) de instalación crónica.

Suele ser por causas degenerativas

El diagnóstico es totalmente clínico (MMSE ayuda cuando es menor a 24 junto al test del reloj (que dibuje un reloj y ponga una hora solicitada correctamente))

Manejo: Buscar la causa y tratarla

Exámenes mínimos antes de diagnosticar demencia: TSH, VDRL, VIH, B12 (o hemograma), TAC de cerebro junto a exámenes generales para determinar si hay causa tratable

Tratamiento:

Multidisciplinario : Geriatra, TO, Kine. Se debe evitar el stress del cuidador (repartiendo el cuidado entre varias personas para evitar stress y depresión)

Donepezilo o rivastigmina (inhibidor de la acetilcolinesterasa)

Memantina algo puede ayudar también.

Causa más común: Alzheimer

Su estudio y tratamiento es ambulatorio

- 1- Alzheimer: Alteración de la memoria asociado a apraxias y agnosias
- 2- Demencia Vascular→ Demencia causada por accidentes vasculares (1 o muchos), es la segunda demencia más frecuente.
- 3- Demencia frontotemporal→ Pacientes jóvenes (55-60años) con **desinhibición**, de avance rápido (6 meses). En el TAC puede haber atrofia frontotemporal (Apoya, pero el diagnóstico es clínico)
- 4- Hidrocefalia normotensiva→ caracterizado por triada de instalación rápida (6 meses). **Demencia (Problemas de memoria), caídas frecuentes + incontinencia urinaria (triada de HNT)**. En algunos casos se suma torpeza motora. El tratamiento en este caso es con válvula de derivación Ventrículo-peritoneal. (TIBU-TIP: Demencia de instalación rápida en gente joven→ Siempre sospechar demencia por VIH)
- 5- Demencia por cuerpos de Lewy: Problemas de memoria asociado a alucinaciones visuales y auditivas asociado a temblor en reposo y rigidez. **EMPEORA CON ANTIPSICOTICOS.**

Delirium

Alteración de la atención asociado a compromiso de conciencia (cualitativo y/o cuantitativo) de instalación aguda. Suele ser por alteraciones toxico metabólicas, aunque realmente hay 10.000 causas que pueden causar delirium.

El diagnóstico es totalmente clínico. Se utiliza el CAM que consta de 4 elementos (los 2 primeros deben estar si o si):

1. **Disminución de la atención (SIEMPRE)**
2. **Inicio agudo (SIEMPRE)**
3. Curso fluctuante y/o
4. compromiso de conciencia.

Evaluación de la atención: inversión de series

Estudio de causa: Hemograma, Orina Completa, Rx Tx, ECG, ELP, función hepática, renal, etc. para buscar el elemento desencadenante

Tto:

- Medidas generales (orientar al paciente, ejercicio diurno, uso de lentes y audífonos)
- Antipsicóticos como Haldol (0,5-1 mg IM) o risperidona.
- Tratar la causa desencadenante

Estudio y tto es hospitalizado

15. Tabaquismo

Se pregunta con bastante detalle

Riesgos del consumo de cigarrillos

- Cardiovascular
 - AVE, IAM, Claudicación, AAA, etc.
- Cáncer
 - Pulmón, boca, vejiga, etc.
- EPOC
- Bronquitis crónica

IPA: Cigarrillos al día/20 x años de tabaquismo

Criterios de tabaquismo

- Fumar mas de 25 cigarros al día
- Fumar más durante la mañana
- Fumar en lugares prohibidos
- Fumar a pesar de estar resfriado/EPOC

Tratamiento

- Psicoterapia cognitivo/conductual es la base del tratamiento
- Apoyo nicotínico (parches o chicles nicotínicos) para síndrome de abstinencia
- Fármacos (disminuyen el deseo de fumar)
 - Bupropion
 - Vareniclina (Champix)

Cigarrillo electrónico → Se recomienda **NO** usarlo, pues mantiene el hábito, aunque es un mal menor.

Medidas para dejar el
Decirle DEJE DE FUMAR → 5%
Tener un ACV → 75%



tabaquismo

Contaminación ambiental → Tiene riesgos similares al tabaquismo, pero en menor intensidad
Aumenta las infecciones respiratorias de tipo viral
Aumenta riesgo de NAC
Aumenta riesgo de CA pulmón
Aumenta riesgo cardiovascular

Medidas de protección primarias para esto → Restricción vehicular y calefacción a leña

16. Trastornos del sueño

1. Insomnio → Dificultad para conciliar el sueño o bien para mantener el sueño.

Tratamiento: Higiene del sueño, terapia cognitivo conductual (básico de la higiene del sueño).

Fármacos solo están indicados en casos graves, refractarios y no reemplaza la higiene del sueño (lo complementan). Deben ser usados por un periodo breve de tiempo.

- BDZ (alprazolam, clonazepam, Diazepam) tienen muchos efectos adversos y generan dependencia, por lo cual, deben ser usados por un periodo breve.
- Hipnóticos Z (zopiclona, zolpidem y eszopiclona) → Tienen muchos menos efectos adversos y no generan dependencia.
- Melatonina → Hormona secretada por la glándula pineal. Casi no tiene efectos adversos, pero es menos eficaz

2. Hipersomnia → Necesidad de dormir mas de 11 horas al día (8 y 6 horas es el promedio en adultos y adultos mayores respectivamente). Puede ser secundaria o primaria (se trata con metilfenidato). Lo mas común es secundaria a SAHOS y el tratamiento es etiológico.

3. SAHOS (se habla de esta patología en otro video 😊)

4. Síndrome de piernas inquietas → Disestesia (siento incomodas las piernas) y hay movimientos de las piernas al dormir que despiertan al paciente. El Dg es clínico. El tratamiento es con hierro + prodopaminérgicos (fármacos raros, esto no se pregunta)

4. Pesadillas→ Mal dormir por miedo. Ocurre durante el sueño REM. El paciente se despierta asustado y se acuerdan a día siguiente. Es un proceso normal que aumenta con el stress. El manejo es educación a los padres
5. Terrores nocturnos→ Ocurre durante el sueño no REM, variante del sonambulismo. El niño se despierta asustado, pero no se acuerda, se despierta feliz de la vida al día siguiente. Es un proceso normal que aumenta con el stress. El manejo es educación a los padres.
6. Narcolepsia→ Es una tétrada dada por:
 - a. Hipersomnolencia diurna→ Es irresistible, es el síntoma mas clásico, incluso puede ser el síntoma único. Son ataques de sueño
 - b. Cataplejía→ Se pierde el tono muscular durante la vigilia (la atonía del REM se inserta en la vigilia)
 - c. Parálisis del sueño→ Se despierta y solo puede abrir y mover los ojos. Puede tener alucinaciones durante este periodo
 - d. Alucinaciones Hipnagógicas e hipnopompicas→ Aparecen al quedarse dormido y las otras al despertarse.

Resumen Guevara by creggers

Otorrinolaringología

Son 4 preguntas, habitualmente fáciles

1. Amigdalitis aguda

Pueden ser virales (90%) o bacteriana (10%)

Bacteriana → Producida por Strepto Pyogenes (streptococo betahemolítico grupo A)

Clínica

- Odinofagia intensa de inicio agudo
- Adenopatías cervicales
- Fiebre alta
- Exudado grisáceo en surcos amigdalinos
- Eritema faríngeo, petequias en paladar blando
- **Sin síntomas catarrales (tos, disfonía, conjuntivitis ni rinorrea)**

Exudado en surcos amigdalinos



Diagnostico → Cultivo faríngeo es el Gold estándar. Las prueba rápidas de detección Strepto son útiles. Lo que manda es la clínica.

Si tiene la clínica, se dejan los antibióticos.

En caso de que quede con la duda de si es bacteriano o viral (con síntomas catarrales y menos intenso) ahí debemos pedir el cultivo o test pack

En caso de que tenga clínica viral se trata de forma sintomática

Tratamiento → Penicilina Benzatina 1.2 millones UI x una vez o se puede dar amoxicilina VO por 10 días. A los alérgicos se les da azitromicina o clindamicina por 5 días. Cefadroxilo es otra buena opción.

Complicaciones

- Glomerulonefritis aguda post estreptocócica (GNAPE)
- Fiebre reumática → El tratamiento ATB la ha hecho desaparecer
- Abscesos → Se debe tomar un TAC, dar ATB de amplio espectro y drenaje quirúrgico.
 - o Absceso periamigdalino → Trismus + pilar abombado. Es el más frecuente
 - o Absceso parafaríngeo → Duele a la movilización lateral del cuello
 - o Absceso retrofaríngeo → Dolor a la movilización anteroposterior del cuello. Este es el más grave.

Hay que saber diferenciarlos porque se preguntan

Si avanzan pueden llegar a producir una Mediastinitis aguda y ahí se nos va a la B el cabre.

Amigdalitis virales

- Odinofagia
- Síntomas catarrales
 - o Tos
 - o Rinorrea
 - o Disfonía
 - o Conjuntivitis (pensar en adenovirus)
 - o Si hay exudado es blanco, grande y adherente (VEB)
- NO ES
 - o Súbito
 - o Petequias en paladar

Clásica amigdalitis por VEB



El tratamiento es sintomático

El hemograma mostrará una leucocitosis de predominio linfocitario

Si tiene un exantema escarlatiniforme se piensa que es bacteriano

Si tiene un exantema morbiliforme se piensa en Mononucleosis

Complicaciones de la amigdalitis pultácea

- Piógenas
 - o Abscesos → Se toma TAC de cuello para determinar su extensión y como abordarlo quirúrgicamente, su resolución ES QUIRÚRGICA
 - Periamigdalino → El mas frecuente, viene con odinofagia intensa, localizado unilateralmente. Viene con Trismus y abombamiento del pilar amigdalino anterior.
 - Parafaríngeo → Viene con dolor a los movimientos LATERALES del cuello
 - Retrofaríngeo → Es el mas grave, viene con dolor a los movimientos ANTEROLATERALES del cuello.
 - Mediastinitis aguda → Los abscesos pueden complicarse con esto. Se presenta como dolor torácico con cuadro séptico. Se estudia con TAC de tórax y se resuelve de forma quirúrgica
- Inmunes
 - o GNAPE
 - o Enfermedad reumática

Indicaciones de amigdalectomía

- Amigdalitis crónicas → Amigdalitis recurrentes. Mas de 7 amigdalitis pultáceas en un año, 5 al año en 2 años o 3 al año por 3 años
- Absceso periamigdalino → Cuando se producen 2 o más
- Hipertrofia sintomática de amígdalas → cuando producen SAHOS, respiración bucal o cuando son amígdalas grado 4 (se topan en la línea media)
- Asimétricas → Se sospecha de cáncer y la mínima biopsia de amígdalas posible es la amígdala completa.

2. Hipertrofia de adenoides

Se ha preguntado en el último tiempo

Clínica → Asintomática

Complicaciones

- Respiración bucal
- Disfunción tubárica → Obstrucción de la trompa de Eustaquio que puede producir otitis media aguda, recurrente, con efusión o crónica
- Adenoiditis a repetición (Amigdalitis de las adenoides)

El diagnóstico es clínico + radiografía de cavum

Tratamiento → Adenoidectomía en caso de ser sintomática

Se clasifican en grado I -III

I → Obstruye 0-33% de obstrucción

II → Obstruye 33-66% de obstrucción

III → Obstruye 67-100% de obstrucción



Indicaciones de adenoidectomía

- Grado II o III + síntomas
 - o Síntomas
 - OMA recurrente, con efusión o crónica
 - SAHOS
 - Respiración bucal
 - Infecciones recurrentes (Adenoiditis, otitis o sinusitis)

Respiración bucal

Causas

Obstrutivo → Porque tiene la nariz tapada. La causa más común es la rinitis alérgica (la más común), hipertrofia de adenoides o tumores

NO obstructivo → respira por la boca por weta nomas.

Tratamiento → Según la causa

En caso de ser congénito, se debe pensar en atresia de coanas

3. Cáncer de cabeza y cuello

El factor de riesgo más importante es el cigarrillo. Suelen ser carcinomas epidermoides (=espinocelular = escamoso = pavimentoso)

Su pronóstico está dado por las adenopatías (se ha preguntado)

Se estudia con buen examen físico, si no se encuentra se pide Nasofibroscopía (NFC) o EDA. En 3er lugar se pide TAC de cuello para etapificarlo
Tratamiento→Cirugía es el único tratamiento curativo

CÁNCER NASOSINUSAL

Clínica

- Obstrucción nasal unilateral (donde está el cáncer)
- Epistaxis
- Invasión de la órbita, produciendo estrabismo

Estudio

TAC de senos paranasales→ NFC para biopsia

Tratamiento→ Cirugía + QT o RT

CÁNCER DE BOCA

Clínica

- Lesión heterogénea que se ulcera y sangra
- Crecimiento lento

Factor de riesgo→ Tabaquismo o VIH(+)

LA ubicación mas frecuente es la lengua

Estudio→ Biopsia

Tratamiento→ Cirugía + QT/RT

LEUCOPLAQUIA Y ERITROPLAQUIA

Corresponden a lesiones precancerosas

Son placas blancas o rojas en una mucosa de crecimiento lento

FR→ Tabaco/VIH

Son premalignas, por lo cual, deben biopsiarse

Se trata con crioterapia o cirugía

CÁNCER DE FARINGE

Su clínica depende de la ubicación

Rinofaringe

- Otitis media con efusión u OMA→ Toda otitis media con efusión en un adulto es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Se debe estudiar con NFC

- Obstrucción nasal

Orofaringe

- Odinofagia
- Disfagia

Hipofaringe

- Odinofagia
- Disfagia
- Cambios en la voz

Su estudio es con NFC y luego TAC de cuello para etapificarlo

Tratamiento→ Cirugía +RT/QT. Salvo el de rinofaringe que se trata solo con RT o QT

CÁNCER DE LARINGE

El que más se pregunta

Su clínica depende de la ubicación

Supraglótico→ Se presenta como prurito laríngeo y luego aparece disnea, disfonía y estridor inspiratorio

Glótico→ Produce disfonía precoz. Su pronóstico es mejor porque el paciente consulta antes, las cuerdas no tienen drenaje linfático

Infraglótico→ Es el de peor pronóstico por su diagnóstico tardío. Suele presentarse como disnea, disfonía mas tardía y hemoptisis. Se estudia con NFC y TAC de cuello también.

La biopsia puede hacer en la nasolaringoscopia o mediante laringoscopia directa

Tratamiento→ Laringectomía total, quedando con Traqueostomía, por lo cual, queda sin voz

4. Patología de glándulas salivales

Se pregunta 1 vez cada 2 años, son muy simples

- Parotiditis

Es poco frecuente por la vacuna contra el virus de las paperas

Clínica→ Aumento de volumen y dolor bilateral de las parótidas. Se complica con orquitis u ooforitis, este es el motivo por el cual se vacuna (riesgo de infertilidad).

El diagnóstico es clínico y se debe notificar de forma obligatoria

Tratamiento→ AINES

Bacteriana→ Es la misma clínica, pero aparece pus. Producido por Gram + (SBHA o aureus)

TRATAMIENTO→ Cloxacilina, cefadroxilo o Amoxi/clav. Si hay abscesos se opera

SIALOLITIASIS

Enfermedad mas frecuente de la glándula salival

Suele ubicarse en las glándulas submaxilares. Un cálculo obstruye el conducto de salida de la glándula salival.

Se produce dolor y aumento de volumen de **inicio súbito**

Diagnostico→ Clínico si se ve el calculo o ecográfico si no se ve a simple vista.

Tratamiento→ Sintomático y cirugía en caso de que el cálculo no salga o sea recurrente

Tumores de glándula salival

Se preguntan más

Mientras mas chica la glándula, mas probable que sea cáncer

Benignos→ Móviles de consistencia lisa sin afectación del nervio facial

Malignos→ Fijos, adheridos a planos profundos, duros, irregulares y generalmente se asocian a parálisis facial

Ambos se estudian con biopsia y se tratan con cirugía, seguido de QT o RT en caso de ser maligno

5. Cuerpo extraño

Se pregunta mucho

Nasal

Suele ser en niños. Se presenta cuando hay rinorrea purulenta y fétida unilateral

Conducta→ Derivar a ORL para que lo retire

Auditivo

Se presenta como sensación de oído tapado, dolor, otorrea en caso de llevar mucho tiempo

Ante la sospecha se debe hacer otoscopia y derivar a ORL en caso de ver el cuerpo extraño

En caso de haber un insecto, se mata con vaselina liquida o aceite vegetal y se deriva, **NUNCA** TRATARLO CON AGUA

Laríngeo

Es una urgencia

Se manifiesta como la imposibilidad de hablar y respirar

Se debe tratar con la maniobra de Heimlich

<1 año→ Golpes interescapulares

Muy obeso→ Se hace con el paciente acostado

Si no es obstructivo→ Se deriva a SU para Rx y extracción mediante laringoscopia

Bronquial



Se presenta como tos intensa, súbita. Tras esto disminuye la tos y aparece expectoración que puede ser mucopurulenta. Se puede producir una atelectasia (crépitos localizados) o hiperinsuflación (sibilancias localizadas)
Generalmente se va hacia el bronquio derecho
En la Rx se puede ver la atelectasia, hiperinsuflación o el mismo cuerpo extraño.

Tras esto se retira mediante broncoscopio

Esofágico

Se pide Rx de tórax y abdomen

Se presenta como sialorrea porque no puede tragar, asociado a dolor torácico
Se retira mediante una EDA

Estomago/intestino

Se observa, sin necesidad de control radiológico

Excepciones → Pilas y 2 imanes. Estas deben ser retiradas mediante EDA

6. Traumatismos ORL

Fractura nasal

Clínica → Antecedente de trauma

- Dolor y deformación
- Equimosis infraocular

Diagnostico → Rx

Tratamiento → AINEs y cirugía diferida (7-14 días) en caso de deformación o alteración funcional

Hematoma del tabique nasal

Antecedente de traumatismo y al examinarlo hay aumento de volumen nasal

Diagnostico es clínico

Tratamiento → Es de urgencia, no como la fractura nasal. Se debe realizar una cirugía con escisión amplia por el riesgo de necrosis avascular del cartílago
Tras la cirugía queda con Amoxicilina y taponamiento (merocel)



Hematoma de pabellón auricular

Antecedente de trauma en la oreja con aumento de volumen de al oreja

Diagnostico es clínico y tratamiento es de urgencia, en el cual, se debe drenar el hematoma por el riesgo de necrosis avascular

Se deja con ATB (cloxacilina o Amoxi/clav) + vendaje compresivo

Perforación timpánica traumática

Antecedente de trauma con cotonito, palo o golpe con palma abierta

Evoluciona con dolor, hipoacusia y Otorragia

La otoscopia muestra la perforación

Tratamiento→ Observar, el tímpano cicatriza rápido. NO PUEDE MOJARSE LOS OIDOS. Debe ponerse tapón para ducharse

Barotrauma timpánico

Clínica

- Exposición a cambio de presión atmosférica importante (andar en avión, Paracaídas, buceo)
- Dolor
- Hipoacusia

En la otoscopia se ve un hemotímpano

Tratamiento→ Observar, suele ser transitorio. AINEs en caso de dolor

7. Otitis

Se pregunta seguro

Todas son clínicamente distintas y se tratan diferente

Otitis Externa (otitis del nadador)

Causas

- Pseudomonas
- S. aureus
- Aspergillus (menos frecuente)

Clínica

- Otalgia intensa
- Aumenta al traccionar el pabellón auricular

- Otorrea
- Antecedente de baño en piscina

Otoscopía
CAE eritematoso con tímpano normal

Tratamiento → Antibióticos tópicos (ciprofloxacino o neomicina).

Prevención → Evitar hisopos y lavarse el CAE con ácido bórico a los nadadores con este cuadro a repetición

Otitis Externa Maligna

Se ha preguntado harto

Causada por *Pseudomonas*, es grave

Clínica

- otalgia
- Otorrea
- **Eritema y edema de oreja y cara**

Suele venir con antecedente de diabetes o neutropenia



Diagnóstico → Clínico

Tratamiento → Antibióticos Ev con doble cobertura antipseudomónica (ceftazidima, Cefoperazona, cefepime, carbapenémicos o aminoglicósidos como tobra o amikacina)

Otitis Media aguda

Se pregunta con mucha frecuencia

Causada por
Neumococo o *Haemophilus*

Clínica

- otalgia
- Fiebre (en lactantes)
- Otorrea en caso de perforación (disminuye el dolor al perforarse)

Suele venir con antecedente de cuadro respiratorio alto

Diagnóstico → Otoscopia (tímpano rojo y abombado)



Tratamiento → Amoxicilina x 10 días (macrólidos en caso de alergia). Si tras 3 días no responde se agrega ácido clavulánico (porque probablemente es por *Moraxella* que produce betalactamasas)

En casos de que se complique se trata con ATB Ev

Otitis Media aguda recurrente

Se produce por los mismos agentes, pero acá hay una disfunción tubárica que produce las infecciones recurrentes.

Clínica→ 3 o mas OMA's en un año

Tratamiento→ Exactamente el mismo que una OMA

Se debe derivar ORL para decidir cirugía

Otitis media crónica

Producida por los mismos agentes (Neumococo o Haemophilus) y se agrega el S. aureus

Clínica

- Otorrea que aumenta al mojarse el oído
- Hipoacusia de conducción (poco severa)

Diagnóstico→ Otoscopía que demuestra perforación timpánica (perforación timpánica que no es traumática es una OMC si o si)

Si perforación es atical→ Colesteatoma



Tratamiento→ ATB tópicos (Ciprofloxacino, NO SE PUEDE DEJAR AMINOGLICOSIDOS por ototoxicidad. (dado que el tímpano está perforado).

Si no responde se dejan ATB por vía oral (Amoxi/clav, moxi o ciprofloxacino)

Como tercera línea se opta por la cirugía

Si viene con colesteatoma se opera SI O SI para evitar complicaciones, solo para evitar (meningitis, absceso, etc.)

De hecho, la hipoacusia suele empeorar

Complicaciones de OMA y OMC

- Meningitis
- Absceso cerebral→ Clínica de HTEC, fiebre y signos focales. Se hace neuroimagen y luego se trata con ATB Ev y drenaje por punción
- Mastoiditis (Se pregunta)→ Eritema y edema retroauricular. Diagnóstico es clínico y se maneja con ceftriaxona Ev. Si no responde se trata con cirugía
- Laberintitis (Se pregunta)→ lo mismo más vértigo, parálisis facial y fiebre. Diagnóstico es clínico y se maneja con ceftriaxona Ev. Si no responde se trata con cirugía



Mastoiditis

Otitis Media con efusión

Causa→ Disfunción tubárica, afecta principalmente a los niños (si es un adulto, es cáncer hasta que se demuestre lo contrario)

Clínica→ Hipoacusia

Otoscopía→ Suele ser normal. Si hay burbujas es patognomónico de OME
Para hacer el diagnóstico se utiliza la impedanciometría con curva B o Cs

Tratamiento→ Observar, se mejora sola. Si no mejora (3-6meses), hay retraso del lenguaje o ante TEA/Sd Down va a cirugía
Los ATB no sirven

8. Hipoacusia

Clínica

- hipoacusia
- Tinnitus (también llamado acufeno)
- Sensación de oído tapado

Estudio→ Audiometría, confirma el diagnóstico cuando requiere intensidades mayores a 20db, además me da la severidad y me diferencia los distintos tipos de hipoacusias

Tratamiento→ Depende de la causa, si no es tratable se dan audífonos

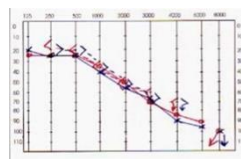
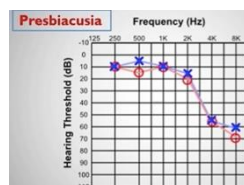
AUDIOMETRÍA

Evalúa la audición por vía ósea y aérea

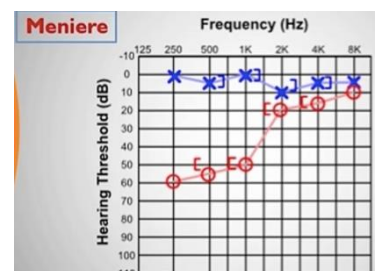
Alteración de la vía aérea→ Hipoacusia de transmisión o conducción

Alteración de ambas vías→ Hipoacusia de tipo sensorineural

Presbiacusia→ Hipoacusia de conducción con mayor compromiso de las tonalidades altas



Azul: Oído izquierdo
Rojo: Oído derecho



Ménière→ Hipoacusia unilateral de tipo sensorineural

Diapasones

Esta la prueba de Rinne y Weber

Rinne→ Se golpea el diapasón y se acerca a la oreja, luego se da vuelta y se apoya en la mastoides. Lo normal es que escuche mejor por la vía aérea (Rinne positivo)

Weber→ Se golpea y se pone el diapasón en la línea media y se le pregunta a que lado escucha mejor. En la hipoacusia de conducción va a lateralizar hacia el lado enfermo, mientras que en la sensorineural lateraliza al lado sano.

	RINNE	WEBER
Normal	(+)	No lateraliza
HC	(-)	Lateraliza al lado enfermo
HSN	(+)	Lateraliza al lado sano

IHC: Hipoacusia conducción
HSN: Hipoacusia sensorio neural

Impedanciometría

Sirve para diferenciar la **hipoacusias de conducción**
Está siempre normal en las HSN

Curva A: Es lo normal. Tiene la parte más alta (vértice) en el 0 (donde la presión de la impedanciometría es igual a la atmosférica. Viene con una altura entre 0,5 y 1,5 (impedancia en ml). Esta se ve en las HSN.

Curva Ad: Muy alta, que se va más arriba del 1,5. Es por rotura de la cadena de huesecillos del oído medio por lo cual el tímpano queda muy suelto

Curva As: Es una curva baja, clásica de la otosclerosis (se ha preguntado varias veces). Se fibrosa la cadena de huesecillos y cuesta que se mueva la membrana.

Curva C: Es igual a la A, pero desplazada hacia las presiones negativas. El vértice está en el -300 aprox. Se debe a una disfunción tubárica, podría no producir síntomas

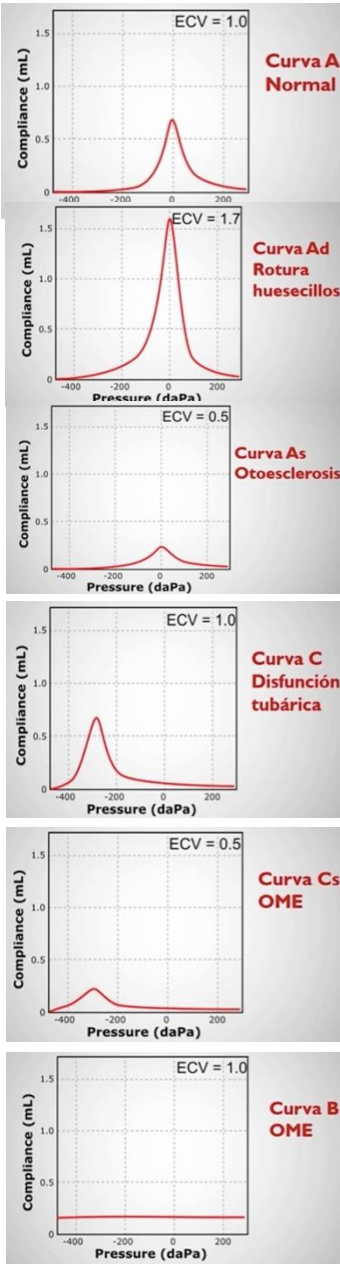
Curva Cs: Con el vértice desplazada hacia el lado negativo, pero muy baja, es clásica de la OME.

Curva B: clásica de la OME también, plana

Hipoacusias de conducción

Se evalúan con impedanciometría

- Tapón de cerumen



El diagnóstico es muy fácil, porque es llegar y verlo en la otoscopia
El tratamiento es la irrigación con agua tibia mediante una jeringa grande

- Otitis media crónica

En la otoscopia se ve una perforación timpánica

Otosclerosis

Viene con Otoscopía normal. De las pocas HC que viene con Otoscopía normal. Puede volverse mixta porque se termina esclerosando el oído interno, pero es de conducción. El diagnóstico será con la impedanciometría donde veremos una curva As
Suele venir con antecedentes familiares, se ve en gente joven, incluso en niños

Otitis media con efusión

La otoscopia puede ser normal o inespecífica, pero las burbujas son patognomónicas
Tiene una curva B o Cs a la impedanciometría

Hipoacusias senosrioneurales

Se evalúan con audiometría

- Presbiacusia

Es un adulto mayor que va disminuyendo de forma progresiva su audición.
Su audiometría muestra una curva de tipo descendente, afecta mas las tonalidades agudas

- Trauma acústico

Tiene antecedente de exposición laboral al ruido
La audiometría muestra cueva en V con compromiso de las frecuencias medias
Suele ser una enfermedad laboral

- Ménière

Viene con una triada: Tinnitus, vértigo e hipoacusia. Clínicamente es fluctuante (Algunos días es mas intenso que otros). Es a causa de un hidrops de la endolinfa

- Ototoxicidad

Viene con el antecedente de exposición a ototóxicos (aminoglicósidos, diuréticos de asa y Quimioterapia). Su audiometría es muy inespecífica

- Sordera súbita

HSN de inicio súbito. El diagnostico es clínico y se trata con corticoides. No hay que saber más.
No se sabe la causa, pero se sabe que sirven los corticoides

Hipoacusia congénita

A los RN se les debería hacer un screening de hipoacusia con potenciales evocados (BERA).
Las emisiones otacústicas es otro test de screening mas barato. Si esta normal nos quedamos tranquilos, pero si sale fallado se corrobora con potenciales evocados

FR Prematurez, ototóxicos, genopatías y TORCH

Tratamiento→ Según la causa y darle audífonos o implante coclear como última línea

9. Disfonías crónicas

Se preguntan con cierta frecuencia

Clínica→ Disfonía que dura mas de 4 semanas o 2 semanas sin mejoría

Estudio→ Nasofibrolaringoscopia para descartar cáncer

Causas

- **Disfonía musculotensional**→ Patología laríngea funcional. Su clínica viene con antecedente de abuso vocal (profesores, cantantes, gritones). Se caracteriza por ser una disfonía que empeora con el uso, pero mejora con el descanso. El diagnostico es con la NFC, la cual, es normal. El tratamiento es con fonoaudiología
- **Nódulos vocales**→ Patología laríngea funcional. Es la evolución de la disfonía musculotensional generalmente. Empeora con el uso de la voz pero se diferencia en que la disfonía nunca mejora, el reposo no le sirve.
En la NFC se ven los nódulos BILATERALES y se hace el diagnostico. El tratamiento es la fonoaudiología también.
- **Pólipos vocales**→ Patología laríngea funcional. Antecedente de uso vocal de manera intensa y aguda (en un concierto por ejemplo, esto se preguntó así). Inicia de manera aguda, pero luego se mantiene por un periodo largo, pues es 2º a una hemorragia laríngea. El diagnostico también es con NFC donde se ve un pólipo UNILATERAL. Se trata con cirugía
- **Edema de Reinke**→ Antecedente de tabaquismo, hipotiroidismo, abuso vocal o RGE. En algunos casos puede ser funcional, pero suele ser 2º a otras causas. Es una disfonía que dura mas de 2 semanas sin mejora. Se hace la NFC donde se ve edema de las cuerdas vocales. El tratamiento es el reposo vocal más tratamiento de la causa
- **Parálisis de nervio laríngeo recurrente**→ Se ha preguntado un par de veces. Viene con el antecedente de cirugía de tiroides, disección aórtica o cx de tórax. Se presenta como una voz bitonal. La NFC observa una cuerda en reposo (aducción). Se trata con fonoaudiología. Se recupera según la intensidad del daño
- **Cáncer de laringe**→ Viene con antecedente de tabaquismo y se caracteriza por voz rasposa. El diagnostico es con NFC que va a laringoscopia directa después para sacar biopsia. Luego se hace TAC para estudiar diseminación

10. Estridor congénito/laringitis aguda/croup espasmódico/epiglotitis

Estridor Congénito

Suele ser por laringomalacia (90%), pero puede ser también por hemangioma o membrana laríngea. Los hemangiomas crecen y pueden obstruir la vía aérea, por eso es importante descartar con NFC, examen que nos mostrará la causa.

La laringomalacia se presenta por estridor inspiratorio de tonalidad alta, sin afectación respiratoria. Puede aparecer días después de haber nacido, no está siempre desde un inicio. El diagnóstico es con NFC. El tratamiento es la observación.

Laringitis aguda y croup espasmódico

La laringitis es producida por virus parainfluenza.

Clínica

- Tos
- Disfonía
- Fiebre
- Examen pulmonar normal

Diagnóstico es clínico y tratamiento es sintomático.

Laringitis obstructiva → Es el mismo cuadro pero que viene con cierto grado de obstrucción. En este caso hay estridor inspiratorio con disnea, uso de musculatura accesoria y cianosis. El uso de musculatura accesoria avanza de arriba hacia abajo en gravedad, al retracción subcostal es lo peor, al revés que la bronquiolitis y el SBO.

Diagnóstico es clínico.

Tratamiento → Depende del grado.

Grado I → Sin obstrucción. Se trata de forma sintomática.

Grado II → Con obstrucción. Es la que más se pregunta. Se trata con adrenalina racémica para desobstruirlo (0,05 mg/kg) + dexametasona para bajar la inflamación y prevenir recurrencia (0,15-0,6 mg/kg). NO confundirlo con SBO.

Grado III → Agitado. El niño debe ser hospitalizado. Se le da oxígeno como medida inicial.

Grado IV → Pérdida de vía aérea → Se va de tubo.

Croup espasmódico

Aparece con frecuencia en las alternativas, no se ha preguntado aún.

Causa → Viral, reacción alérgica o por comida que se le va a la laringe.

Clínica

- Sin clínica de IRA previa.

- Inicio agudo (la laringitis es mas lenta)
- El resto de la clínica es igual a la laringitis

El diagnostico es clínico, hay que diferenciarlo de la laringitis

Tratamiento→ De la causa. Se observa porque se suele destapar rápidamente y si no responde se maneja igual a una laringitis obstructiva

- Epiglottitis

Producida por Hib. La clínica es similar a una laringitis aguda, pero el niño esta de aspecto séptico, con fiebre alta.

El niño viene en posición de trípode (echado hacia atrás para poder respirar mejor)

Diagnostico→ Clínico + Rx lateral de cuello que muestra imagen en punta de lápiz

Tratamiento→ Ceftriaxona+ adrenalina racémica y corticoides

11. Rinitis

Se ha preguntado siempre. Hay que saber en detalle cada una y el manejo

Clínica

- Rinorrea
- Estornudos
- Obstrucción nasal (la causa más frecuente)

Complicaciones

- Roncopatía
- Epistaxis
- infecciones

Causas

- **Rinitis alérgica**→ Clínica de rinitis + antecedente de alergia, mucosa nasal pálida y prurito nasal. El diagnóstico es totalmente clínico. El prick test se hace para determinar el alérgeno al cual esta sensibilizado y evitarlo.
Tratamiento→ Antihistamínicos H1 (2ª generación) y corticoides tópicos si no responde (fluticasona, mometasona, budesonida)
En caso de que venga con mucha obstrucción nasal se eligen los Corticoides tópicos como 1ª línea
- **Rinitis vasomotora**→ Viene con un desencadenante que suele ser el ejercicio, cambios de temperatura, condimentos. EL diagnostico es clínico y tratamiento es evitar los gatillantes. Se puede dejar pseudoefedrina como 1ª línea y como 2ª línea antiH1 o corticoides

- **Rinitis hormonal**→ Asociada al embarazo. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es el parto.

- **Rinitis ocena**→ NO confundirla con Ozuna.

Viene con antecedente de cirugía nasal, tiene fosas nasales amplias y costras de mal olor por sobreinfección bacteriana por falta de mucus.

El diagnóstico es clínico y el tratamiento son los lavados con SF para mantener hidratada la mucosa y remover las costras de mal olor. Los ATB tópicos podrían servir. Si no responde podría considerarse la cirugía para disminuir el tamaño de las fosas nasales



Vestibulitis Nasal

Infección del vestíbulo nasal

Eritema y costras del vestíbulo nasal producidas por infección por S. aureus.

Se trata con ATB tópicos como mupirocina

Prick Test→ Test para determinar la sensibilización a alérgenos, para determinar a que soy alérgico. Es un test de apoyo diagnóstico

12. Pólipo nasal/tumores nasales/epistaxis

Clínica→ asociado a alergia (rinitis alérgica o asma)

- Obstrucción nasal
- Sinusitis recurrente

Diagnóstico→ Con la clínica y la especuloscopia o NFC si está más atrás. Es de causa inflamatoria, no neoplásica. Son tumoraciones amarillas brillantes

Tratamiento→ Corticoides vía oral en un inicio y al achicarse se mantienen vía tópica

Rinofibroangioma o angiofibroma nasal

Clínica→ Adolescente

- Epistaxis unilateral
- Obstrucción nasal

Diagnóstico→ TAC de CPN o NFC

Tratamiento→ Cirugía

Cáncer nasosinusal

Clínica→ Paciente fumador

- Obstrucción
- Rinorrea hemopurulenta o serohemática
- Invasión de órbita (exoftalmo)

Diagnóstico→ TAC de CPN y luego NFC para ir a biopsiar

Tratamiento→ Cirugía + QT/RT

Manejo de la epistaxis

1. Compresión nasal → 10-20 minutos, lo comprimes tu o el paciente
2. Taponamiento anterior → Con merocel (en un lugar lais) o con gasas hasta llenar la nariz y dejarlo taponeado. Cada vez que se hace taponamiento hay que dejar antibióticos
3. Taponamiento posterior → Se le pasa una sonda Foley por la nariz hasta llegar a la faringe, se infla y se fracciona. Así queda tapando la Coana por atrás

13. Trastornos de la deglución/trastornos del habla

A lo más 1 pregunta

Trastornos de la deglución

Clínica

- Tos al comer
- Neumonías aspirativas a repetición
- Disfagia

Causa

- ACV (la principal causa)
- ELA
- Tumores cerebrales

Todo paciente con ACV se asume que tiene trastorno de la deglución, se debe estudiar antes de permitir alimentación normal.

Diagnóstico → NFC de deglución

Tratamiento → Régimen 0 por boca, terapia de la deglución y elegir vía de alimentación en base a la presencia/ausencia de vómitos y si el cuadro es crónico o agudo.

	Transitorio	Permanente
Sin vómitos	SNG	Gastrostomía
Con vómitos	SNE	Yeyunostomía

Trastornos del habla

Afasia → Alteración del lenguaje. La afasia puede ser de Broca o Wernicke.

En la afasia motora o de Broca. No puede hablar ni escribir, pero sí comprende el lenguaje.

La afasia sensitiva o de Wernicke o de comprensión sí puede hablar y escribir, pero no entiende ni lee.

Broca → Lóbulo frontal

Wernicke → Lóbulo parietal

Afasia de conducción → Por daño de las fibras que comunican la área de Broca y Wernicke entre ellas. La diferencia es que el paciente puede repetir. Esto la diferencia de la afasia de Broca

Mixta→ Sensitiva (Wernicke) + motora (Broca)
Disartria→ Mala articulación, como ebrio
Dislexia→ Dificultad del aprendizaje de la lectura del lenguaje
Disgrafía→ Dificultad en el aprendizaje de la escritura
Dislalia→ Error en la pronunciación
Disemia→ Tartamudez

El tratamiento de todas estas alteraciones es la fonoaudiología.

14. Vértigo/parálisis facial

VERTIGO

Sensación de que las cosas giran a mi alrededor (objetivo) o que yo giro (subjetivo). Este es un tipo de clasificación, pero que no es muy útil, dado que, lo importante es diferenciar entre vértigo central y vértigo periférico.

Vértigo periférico

- Nistagmo horizontal que se escapa de la lesión (la fase rápida se escapa del lado afectado)
- Lateropulsiones hacia el lado afectado
- Síntomas auditivos (hipoacusia o tinitus)

Causas

- Vértigo postural paroxístico benigno→ De inicio súbito asociado a cambios de posición de la cabeza, dura menos de 1 minuto. Puede tener antecedente de TEC. El tratamiento es mediante de técnicas de reposición de los otolitos.
- Enfermedad de Ménière→ Triada **de vértigo, hipoacusia y tinitus**. Se caracteriza por ser fluctuante y que los síntomas no aparecen juntos. El Dg es clínico, se trata con antivertiginosos (difenidol, cinnarizina, betahistina). Todo ménière es un neurinoma hasta que se demuestre lo contrario. (por tanto, a todo ménière se le debe pedir una RNM)
- Neurinoma del acústico (Tumor benigno del VIII par)→ Clínica progresiva (por crecimiento del tumor). Su clínica es similar al ménière y podría afectar al 5º y 7º par (parálisis facial con hipostesia facial). El tto es con Radioterapia y si no responde a esto se hace cirugía.
- Neuritis (neuritis) vestibular→ Clínica de inicio súbito, es un vértigo persistente que dura días, incluso semanas. El dg es clínico y el tratamiento es con corticoides orales y antivertiginosos como tto sintomático.

Vértigo central

- Nistagmo vertical o multidireccional
- Lateropulsiones multidireccionales (se caen para todos lados)
- Signos cerebelosos (porque la primera causa de vértigo central son lesiones cerebelosas)
- Signos focales (podría haber hemiparesia por ejemplo)

Manejo

Se pide examen del VIII par. El examen del VIII par está compuesto por audiometría, prueba calórica (Debe haber nistagmo, si no hay nistagmo es una prueba alterada) y pruebas de provocación.

Causas

- Infarto del cerebelo
- Lesión del tronco encefálico
- ACV
- Esclerosis múltiple, tumores

Como son lesiones focales lo importante es pedir una neuroimagen (RNM o TAC)

PARÁLISIS FACIAL

Imposibilidad de mover la cara. Puede ser central o periférica.

La periférica afecta toda la cara. Puede generar disgeusia (imposibilidad de sentir sabores) y disminución de la sensibilidad del trago (pabellón auricular). Además puede generar hiperacusia por afección del nervio cuerda del tímpano

Central

Respeto los músculos de la frente.

Puede tener signos focales y afectación de otros pares craneales.

MANEJO DE LAS PARÁLISIS FACIALES

Periférico

Corticoides + protección ocular (Para evitar una queratitis)

Central

Se debe realizar Neuroimagen (RNM o TAC)

TIBU-TIP

Síndrome de Ramsay-Hunt → Es un herpes Zoster del VII par. Da una parálisis facial con vesículas en el trago. En este caso además debe dejarse aciclovir

15. Apnea del sueño/CE respiratorio/intoxicación por CO/asfixia por inmersión

SAHOS

Roncopatía + somnolencia + complicaciones

Somnolencia

- Hipersomnolencia diurna
- Sueño no reparador
- Desconcentración
- Accidentes de tránsito frecuentes

Complicaciones

- HTA
- Poliglobulia

Diagnostico → Polisomnografía (5 o mas apneas/hipopneas por hora)

Tratamiento→ Bajar de peso (se asocia a obesidad o sobrepeso), evitar OH y BDZ antes de dormir, CPAP y cirugía solo en caso de qe haya alteraciones anatómicas groseras

Indicaciones de CPAP

Que sea severa (mas de 30 apneas/hipopneas por hora)

Que siga con síntomas pese a tratamiento inicial

Cuerpo extraño respiratorio



Nasal→ Rinorrea purulenta fétida unilateral. Se debe derivar a otorrino

Laríngeo→ Es una urgencia por imposibilidad de respirar. Realizar maniobra de Heimlich. En menores de 1 año se realizan 5 golpes interescapulares seguidos de 5 compresiones torácicas. En caso de no ser obstructivo se debe derivar a servicio de urgencia para Rx y extracción.

Bronquial→ Tos súbita, intensa y persistente. Puede generar atelectasias, hiperinsuflación o sibilancias localizadas en la zona de obstrucción. El lugar mas frecuente es el LID. Se toma Rx y se extraer por broncoscopía

Intoxicación por monóxido de carbono

La fuente de CO más frecuente es un brasero, calefón en baño, estufa a leña en la pieza o automóvil viejo

Clínica

- Hipoxia
- Compromiso de conciencia
- **SIN CIANOSIS**

Diagnóstico→ Carboxihemoglobina. PaO2 y SatO2 estarán normales.

Tratamiento→ Oxígeno al 100%. Cámara hiperbárica es el ideal,

ASFIXIA POR INMERSIÓN

Su prevención es lo mas importante. Rejas altas y barrotes no escalables en piscinas

Tratamiento

RCP + soporte ventilatorio y medidas de neuroprotección

16. Amigdalitis/difteria/angina infecciosa

Amigdalitis

Pueden ser virales (90%) o bacteriana (10%)

Bacteriana → Producida por Strepto Pyogenes (streptococo betahemolítico grupo A)

Clínica

- Odinofagia intensa de inicio agudo
- Adenopatías cervicales
- Fiebre alta
- Exudado grisáceo en surcos amigdalinos
- Eritema faríngeo, petequias en paladar blando
- **Sin síntomas catarrales (tos, disfonía, conjuntivitis ni rinorrea)**

Exudado en surcos amigdalinos



Diagnostico → Cultivo faríngeo es el Gold estándar. Las prueba rápidas de detección Strepto son útiles. Lo que manda es la clínica.

Si tiene la clínica, se dejan los antibióticos.

En caso de que quede con la duda de si es bacteriano o viral (con síntomas catarrales y menos intenso (ahí debemos pedir el cultivo o test pack

En caso de que tenga clínica viral se trata de forma sintomática

Tratamiento → Penicilina Benzatina 1.2 millones UI x una vez o se puede dar amoxicilina VO por 10 días. A los alérgicos se les da azitromicina o clindamicina por 5 días. Cefadroxilo es otra buena opción.

Complicaciones

- Glomerulonefritis aguda post estreptocócica (GNAPE)
- Fiebre reumática → EL tratamiento ATB le ha hecho desaparecer
- Abscesos → Se debe tomar un TAC, dar ATB de amplio espectro y drenaje quirúrgico.
 - o Absceso periamigdalino → Trismus + pilar abombado. Es el más frecuente
 - o Absceso parafaríngeo → Duele a la movilización lateral del cuello
 - o Absceso retrofaríngeo → Dolor a la movilización anteroposterior del cuello. Este es el más grave.

Hay que saber diferenciarlos porque se preguntan

Si avanzan pueden llegar a producir una Mediastinitis aguda y ahí se nos va a la B el cable.

Amigdalitis virales

- Odinofagia
- Síntomas catarrales
 - o Tos
 - o Rinorrea
 - o Disfonía
 - o Conjuntivitis (pensar en adenovirus)
 - o Si hay exudado es blanco, grande y adherente (VEB)
- NO ES
 - o Súbito

Clásica amigdalitis por VEB



- Petequias en paladar

El tratamiento es sintomático

El hemograma mostrará una leucocitosis de predominio linfocitario

Si tiene un exantema escarlatiniforme se piensa que es bacteriano

Si tiene un exantema morbiliforme se piensa en Mononucleosis

Difteria

Enfermedad erradicada gracias a la vacunación. Muy grave

Clínica

- Amigdalitis + faringitis
- Pseudomembranas en faringe y amígalas
- Odinofagia
- Edema cervical (cuello de toro)



Complicaciones

- Miocarditis
- NTA

Diagnostico es clínico con las Pseudomembranas y el gram

Tratamiento → Penicilina o Macrólidos

Anginas infecciosas

La única que hay que saber es la angina de Vincent.

Infección faríngea por anaerobios

Clínica

- Amigdalitis
- Gingivitis severa
- Halitosis
- Ulceras y necrosis de paladar blando y/o amigadlas

El diagnostico es clínico. Se pide gram y cultivo para descartar difteria. El tratamiento es con enjuagues de agua oxigenada + ATB para anaerobios (metronidazol o clindamicina)

Resumen Guevara by Creggers

Dermatología

Son 4 preguntas fáciles, se han preguntado con imágenes en los últimos EUNACOM
El diagnóstico es casi siempre clínico, fundamental saber la clínica, tipo de lesiones y ubicación de ellas.

1. Lesiones eritemato-descamativas

Lesiones rojas y vienen con "caspa"

Psoriasis Vulgar

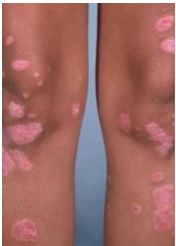
Clínica→ Placas eritemato-descamativas en zonas extensoras. Si se ubica en la cabeza suele sobrepasar la línea del pelo.

Puede afectar a las uñas, produciendo pits ungueales (piquetes de pájaro en las uñas)

Causa→ Enfermedad autoinmune

Tratamiento→ Sigue un orden

1. Humectación
2. Corticoides tópicos (corticoides orales TOTALMENTE contraindicados)
3. Inmunomoduladores tópicos (tacrolimus)
4. PUVA terapia con luz UV



Psoriasis Guttata

Clínica→ Placas eritemato-descamativas generalizadas. Respetan palmas y plantas
Lesiones del tamaño de gotas (por eso el nombre)

Causa→ Post infecciosa (estreptocócica)

Tratamiento→ Observación, es autolimitado.

En caso de cronificarse se trata como una psoriasis vulgar



Pitiriasis Rosada o Pitiriasis de Gilbert

Clínica→ Placas eritematodescamativas en tronco (no en cara ni extremidades).

Muy característico es que viene con mancha heráldica, lesión que aparece un par de días antes

Causa→ Virus herpes 6 y 7

Tratamiento→ Observación (antihistamínicos si pica)



Sífilis 2ª

Clínica→ Placas eritemato-descamativas generalizadas que afecta palmas y plantas

Causa→ ETS causada por treponema palidum

Tratamiento→ Penicilina benzatina 2.4 millones por 2 veces separada por 1 semana



Psoriasis en tronco → Pitiriasis rosada

Psoriasis generalizada sin compromiso de palmas y plantas → Psoriasis Guttata

Psoriasis generalizadas con compromiso de palmas y plantas → Sífilis 2ª

Liquen plano

Clínica → Pápulas pruriginosas eritematodescamativas ubicadas en muñecas y tobillos brillantes. 50% de los casos tiene afectación de las mucosas.

Su clínica se resume en las 6P

6P	• Pápulas • Pequeñas • Púrpuras	• Poligonales • Pruriginosas • Prillantes
-----------	---	---



Causa → Autoinmune

Tratamiento → El mismo de la Psoriasis vulgar

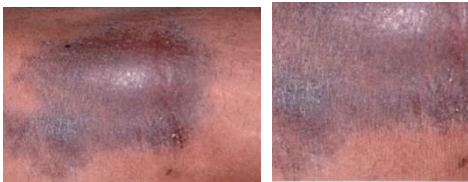
Liquen simple crónico

Clínica → Placa pruriginosa liquenificada (aumento del dibujo cutáneo) ubicada en cuello, tobillos y brazos principalmente.

Causa → Rasquido



Tratamiento → Romper el círculo vicioso del rasquido. Dar corticoides para la inflamación y antihistamínicos para el prurito



Acá de base puede haber tenido una dermatitis atópica, se rascó mucho y se formó está pápula con aumento del dibujo cutáneo

Liquen escleroso

Clínica → Placa de color blanquecino que puede o no ser pruriginosa. Se puede ubicar perivulvar, perianal y en prepucio. No afecta las mucosas.

Causa → Autoinmune

Tratamiento → El mismo de la psoriasis



2. Acné y rosácea

Se pregunta con cierta frecuencia, hay que saber bien el manejo

Acné

Clínica→ Comedones ubicados en cara, pecho y espalda usualmente.

Acné inflamatorio→ pápulas y pústulas

Acné nódulo-quístico→ a nódulos/absceso

Acné conglobata → Se generaliza, uniéndose los nódulos entre ellos

Acné fulminans→ Etapa final con aspecto séptico, fiebre, artralgias y CEG



Causa

1. Hormonal→ Mas frecuente en adolescencia y pacientes SOP
2. Propionibacterium Acnes→ Bacteria presente en piel
3. Genético→ queratinización anormal de la piel, obstruyendo la glándula sebácea

Tratamiento→ Depende de la etapa

Comedoniano→ Queratolíticos (peróxido de benzoilo)

Inflamatorio→ Se agrega clindamicina tópica y luego doxiciclina vía oral. La isotretinoína es la última opción. Totalmente contraindicada en el embarazo y deben evitar exposición solar quienes la ocupen

Nódulo-quístico y Conglobata→ Se inicia ATB VO e isotretinoína de una

Fulminans→ Se maneja además con ATB endovenosos

Rosácea

Enfermedad que afecta la cara.

SIN COMEDONES

Etapa I→ En la etapa inicial viene con eritema y telangectasias

Etapa II y III→ Luego aparecen pápulas y pústulas

Etapa IV→ Rinofima

Desencadenantes

- Alcohol
- Condimentos
- Cambios de temperatura

Rosácea ocular→ Puede generar blefaritis (inflamación y eritema de los párpados) con chalaziones y puede llegar a producir queratitis y uveítis

Causa→ Idiopática. Puede estar asociada a la presencia de un ácaro, el *Demodex*

Tratamiento→ Sigue un orden

1. Evitar desencadenantes
2. Bloqueador solar (la más importante, evita su progresión)
3. Metronidazol tópico

En caso de ser fimatosa, el único tratamiento es la cirugía

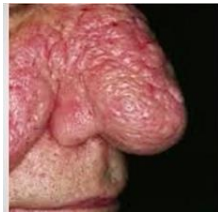
Requiere control oftalmológico por frecuente afectación ocular



Rosácea inflamatoria



Rosácea con rinofima inicial



Rinofima

3. Alopecia y lesiones hipopigmentadas

Alopecia Androgénica

Caída de cabello + cabello más delgado.

Es mas frecuente en los hombres.

Causa→ genético, pero influyen las hormonas (mas en hombres y mujeres en postmenopausia. Puede responder al bloqueo androgénico)

Tratamiento→ Observar, es normal. Por motivo estéticos se puede tratar con finasteride (bloqueador de alfa -5- reductasa y ACO antiandrogénicos en caso de mujeres.)

Alopecia areata

Caída de cabello en un área en particular

SIN SIGNOS INFLAMATORIOS (la diferencia de la tiña capitis)

Causa→ Autoinmune, muy relacionado con stress (aumenta en periodos de stress)

Tratamiento→ Observación, se mejora espontáneamente + manejo del stress. Se pueden dar corticoides tópicos para acelerar la recuperación y frenar la cada

Si afecta mas del 50% del cuero cabelludo tiene mal pronóstico, tiene una probabilidad no baja de que no le vuelva a salir el pelo.

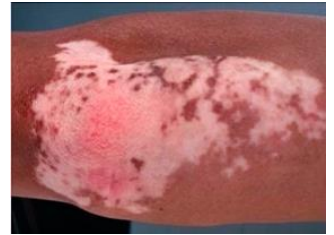


Vitíligo

Maculas acrómicas en cara (periorificial), manos, pies, genitales y axilas, pero puede estar en cualquier parte

Causa→ Enfermedad autoinmune relacionada al stress.

Tratamiento→ Corticoides tópicos como el Clobetasol (se ha preguntado) y manejo del stress. El bloqueador solar es FUNDAMENTAL



Pitiriasis Alba

Maculas hipopigmentadas con borde difuso y descamación, Ubicado frecuentemente en cara, espalda y hombros.

Causa→ Se relaciona con la atopía. Mas frecuente en niños

Manejo→ Bloqueador solar + humectación y manejo de la dermatitis atópica

Pitiriasis versicolor

Maculas hipopigmentadas en espalda, pecho. Son zonas donde hay mucho sudor. Suelen descamar.

Causado por hongos que proliferan con humedad (Malassezia)

Tratamiento→ Shampoo de ketoconazol o fluconazol oral + evitar el sudor

4. Enfermedades autoinmunes

Pénfigo

Clínica→ Ampollas generalizadas recurrentes y flácidas.

Causas→ Autoinmune

Tratamiento→ Corticoides orales y eventualmente inmunomoduladores



Penfigoide

Clínica→ Ampollas generalizadas, pero son tensas, difíciles de romper.

Causa→ Autoinmune

Tratamiento→ Corticoides + inmunomoduladores (hay que diferenciarlo de epidermólisis bulosa que es una enfermedad genética que se ve en los niños)



Prurigo

Clínica→ Vesículas pruriginosas, más frecuente en niños (escolares). Suele afectarse el tronco y extremidades.

Causa→ Reacción alérgica a la picadura de insectos (lo más común) o plantas

Tratamiento→ Observación. En casos graves se ocupan corticoides orales



Eritema nodoso

Nódulos eritematosos y dolorosos en la cara anterior de las piernas

Causa→ Autoinmune, suele ser 2º (infecciones, TBC, EII o EAA)

Tratamiento→ Corticoides orales + tratar la causa

Eritema indurado

Nódulos o placas eritematosas en la cara posterior de las piernas- Tienden a ulcerarse.

Causa→ 2º a TBC

Tratamiento→ Tratar la TBC

Lupus disoide

Lo mismo que lupus cutáneo subagudo

Placas eritematosas descamativas que dejan cicatriz (importante). Si afecta el cuero cabelludo genera alopecia

Afecta zonas fotoexpuestas.

Causa→ Autoinmune (se asocia a anti-Ro y La)

Tratamiento→ Corticoides tópicos si es pequeño y VO si es grande. Hay que ir a descartar un LES, por lo cual, se deben pedir muchísimos exámenes



Lupus eritematoso sistémico

Clínica→ Fiebre, malestar general, pero para dermatología lo importante es el Rash malar. Ese rash respeta el surco nasogeniano. Viene con úlceras orales indoloras y fotosensibilidad.

Causa→ Autoinmune

Tratamiento→ Corticoides + inmunomoduladores



Dermatomiositis

Clínica→ Mialgias, debilidad de predominio proximal + aumento de CK y 3 tipos de Rash:



Rash heliotropo → Color violáceo en los párpados superiores
Pápulas de gotrón → Afecta nudillos (metacarpofalángicas o IFP e IFD)
Rash en manto → En la espalda alta, como si se hubiese puesto un manto

Causa → Autoinmune, se asocia a anticuerpos Anti-JO1.
Se asocia a síndrome paraneoplásico, hay que ir a buscar el cáncer (Se ha preguntado)

Tratamiento → Corticoides + inmunomoduladores



5. Dermatitis

Dermatitis = eccema

Dermatitis atópica

Se ha preguntado muchas veces

Clínica → Pápulas, placas y excoriaciones en zonas clásicas + signos de atopia. La zona va a depender de la edad

Lactantes → Zonas extensoras, mejillas y cuero cabelludo

Escolares → Zona flexoras, son las zonas donde hay sudor

Signos de atopia

Piel seca, el más frecuente y más importante

Queratitis pilar (como piel de gallina)

Lengua depapilada o geográfica

Pitiriasis alba (maculas hipopigmentadas en cara)

Pliegue de Dennie-Morgan



Tratamiento → Humectación de la piel (lo más importante) + corticoides tópicos

Dermatitis seborreica

Clínica → Escamas amarillentas (costra láctea), eritema que afecta cuero cabelludo y no sobrepasa la zona de implantación del pelo, alrededor de la nariz y entre las cejas.

Causa → Hongo (pitirosporum ovale)

Tratamiento → En el lactante se observa, a menos que sea muy marcado, caso en el cual le ponemos vaselina líquida.

En adultos se deja ketoconazol y corticoides tópicos como 2ª medida

Dermatitis de contacto



Clínica

Aguda→ Eritema, bulas, rehumectación (líquido que sale) y vesículas (igual que una quemadura)

Subaguda→ Eritema

Crónica→ Liquenificación (aumento del dibujo cutáneo) más hipo/hiperpigmentación

Suele presentarse en orejas y ombligo (Reacción a los aretes, cinturón o botón del pantalón)



Puede ser de causa alérgica (Afecta a sensibilizados y no es dosis dependiente) o irritativa (no requiere sensibilización y es dosis dependiente)

Tratamiento→ Evitar aquello que me dio la reacción. Corticoides tópicos para disminuir la reacción

Eritema Pérmico (Sabañones, Frostbite)

Clínica→ Eritema, dolor, descamación e inflamación en zonas expuestas al frío.

Causa→ Exposición al frío, es una quemadura por frío.

Tratamiento→ Evitar el frío + humectación.

Fotodermatitis (reacción fotoalérgica)

Clínica→ Placas + eritema y dolor que sigue una disposición lineal (línea de exposición con la planta)

Causa→ Litre (en los cerros de la zona central) + exposición solar

Tratamiento→ Saludar al litre y no tocarlo



Fotodermatitis

Eritema, pápulas y vesículas en zonas fotoexpuestas

Causa→ Exposición solar

Tetraciclina e isotretinoína son fototóxicos, ojo al ocuparlos

Tratamiento→ Bloqueador solar y humectación



Urticaria

Clínica→ Ronchas que al comprimirlo se aplanan (es por edema). Cuando son muy grandes se llaman habones. Viene con mucho prurito

Causa

Aguda→ Alimentos, infecciones virales, fármacos, etc.

Crónica→ Idiopática, cambios de temperatura o exposición a alérgenos

Tratamiento→ Antihistamínicos

Riesgo→ Anafilaxia y angioedema. En estos casos se da adrenalina IM

Angioedema de Quincke

Clínica→ Edema de aparición brusca que afecta la cara (párpados, labios) y puede afectar el tubo digestivo (vómitos) y vía respiratoria (muy peligroso, puede morir ahogado)

Causa→ Reacción alérgica

Tratamiento

Grave→ Adrenalina IM

Leve→ Corticoides y antihistamínicos

6. Tumores premalignos y malignos de piel

En el último tiempo han aparecido siempre con fotos

LESIONES PREMALIGNAS

Queratosis actínica

Enfermedad premaligna, avanza a Ca espinocelular

Placa eritematosa descamativa y ásperas

Es a causa de exposición solar, las encontramos en zonas fotoexpuestas

Tratamiento→ Crioterapia



Enfermedad de Bowen

CARCINOMA IN SITU con riesgo de progresar a un Ca espinocelular

Placa hiperqueratósica con eritema. Es áspera. Se encuentra en zonas fotoexpuestas, esta es su causa

Tratamiento→ Crioterapia o imiquimod

LESIONES TUMORALES BENIGNAS

Queratosis seborreica

Placa solevantada hiperpigmentada. Rugoso al aspecto pero suave al tacto

Causa→ Exposición solar

Tratamiento→ Observación



Léntigo Solar

Máculas hiperpigmentada homogénea en zonas fotoexpuestas

Causa→ Exposición solar

Manejo→ Observación



Quiste epidérmico o epidermoide (llamado quiste sebáceo)

Nódulo con poro central que al comprimirlo da salida a material sebáceo

Causa→ Idiopático

Manejo→ Observación, se puede operar si es muy grande o se infecta



Quiste Dermoides

Nódulo de bordes lisos, móvil, ubicado en la cola de las cejas o en zona ciliar en general

Causa→ Congénito, pero va aumentando el tamaño con el tiempo y puede recién verse en adolescencia o adultez

Tratamiento→ Observación, pero puede sacarse si es muy grande o se complica



Lago venoso

Tumor vascular benigno

Nódulo violáceo habitualmente en los labios (labio inferior)

Causa→ Exposición solar

Manejo→ Observación a menos que sea muy grande



Punto Rubí

Nódulo o pápula de color rojo intenso y pequeño tamaño en zonas fotoexpuestas (pecho y espalda)

Causa→ Exposición solar

Tratamiento→ Se observa



Granuloma Piógeno o telangectásico

Se ha preguntado harto últimamente
Nódulo rojo de aspecto húmedo y que sangra muy fácilmente.
Se ubica frecuentemente en la boca, manos, dedos, tórax o en cualquier parte

Es mas frecuente que aparezca en los niños

Causa→ Inflamación 2ª a heridas

Tratamiento→ Extirpación quirúrgica



Nevo sebáceo

Placa amarilla en la cabeza, congénita pero que puede aumentar de tamaño en la adolescencia

Manejo→ Extirpación por riesgo de evolución a neoplasia



7. Cáncer de piel

El diagnostico requiere de biopsia

Cáncer basocelualr

Nódulo con ulceración central y borde perlado(brillante). Suele venir con telangectasia adyacente

NO da metástasis a pesar de invadir localmente

Causa→ Exposición solar

Tratamiento→ Resección quirúrgica. NO requiere QT ni RT por no dar metástasis



Cáncer espinocelular o escamoso o pavimentoso

Nódulo hiperqueratósico con tendencia a ulcerarse y sangrar.
Ubicado en zonas fotoexpuestas (cara, orejas)

Tratamiento→ Cirugía + RT y/o QT

Dan metástasis por vía linfática

La hiperqueratosis me lo diferencia del basocelular



Melanoma Maligno

Desde una simple macula hasta una placa hiperpigmentada irregular con coloración heterogénea, de mas de 6 mm

Si no tiene nada del ABC, probablemente es un nevo atípico

A	➡	Asimetría
B	➡	Borde irregular
C	➡	Color irregular
D	➡	Diámetro > 6mm
E	➡	Exposición solar
F	➡	Familiar antecedente

Manejo→ Biopsia excisional

Se saca bajo el diagnostico de nevo atípico pero una vez que tengo al biopsia que me confirma un melanoma, debo ir a ampliar los bordes de la resección

El Score de Breslow (nivel de invasión) es el que me da el pronostico

Si invade mas de 1 mm, es de mal pronóstico

Tiene un elevado riesgo de metástasis



Léntigo maligno

Melanoma de buen pronóstico. Suele ser de adultos mayores, ubicado en la cara que crece lento.

Micosis fungoide

NO tiene ninguna relación con hongos, es un linfoma de piel

Clínica

1. Fase macular→ Máculas en extremidades y tronco. Se confunde con otras lesiones, por lo cual, se dan corticoides y responde, pero vuelve a salir después
2. Fase de placas→ Se empiezan a solevantar las placas
3. Fase tumoral→ Se ponen gruesas como tumor y se ven feas.



Etapa de

Causa→ Linfoma T

Diagnostico→ Biopsia

Manejo→ PUVA terapia

En estadio iniciales tiene buena respuesta y pronóstico, pero en estadios avanzados es de mal pronóstico



Etapa tumoral

Síndrome de sézary

Iguala a la micosis fungoide, pero generalizado a toda la piel.

Es un linfoma que avanza más rápido y pruriginoso

Tratamiento→ PUVA terapia, pero generalmente es paliativo con sobrevida de 5-10 años

8. Reacciones adversas a medicamentos

Se pregunta siempre, el tratamiento siempre incluye suspender el fármaco

Eritema multiforme menor

Lesiones en Target (tiro al blanco), es lo más característico, clave para su diagnóstico

Vine sin signo de Nikolsky (La epidermis se desprende de forma espontanea o bien al traccionarla con un dedo)

No afecta mucosas

Afecta menos del 10% de la piel

Es causado principalmente por el VHS y en segundo lugar como RAM (pero esta se pregunta siempre)



Tratamiento → Suspender el fármaco

Síndrome de Steven Johnson

Es grave, afecta mucosas, particularmente la boca y ojos

Tiene además muchas bulas y vesículas

NO tiene signo de Nikolsky y afecta entre 10-30% de la piel.



Causa → RAM (ATB, lamotrigina, AINEs principalmente pero cualquier fármaco en verdad), aunque también puede ser por HS (peor menos frecuente)

Tratamiento → Suspender el fármaco + Corticoides Ev

Afectación de mucosas y bulas son clave para su diagnóstico

Necrosis epidermolítica tóxica (NET)

Afectación generalizada de piel y mucosas o (más de 30% de la piel) que viene con dolor, vesículas y bulas que pueden ser hemorrágicas.

Tiene signo de Nikolsky → Es clave para el diagnóstico

Este signo aparece en 3 enfermedades: NET, pénfigo y síndrome de piel escaldada



Causa → RAM muy grave

Se maneja en UCI con corticoides e IgG en dosis altas

Eritema Fijo

Manifestación rara, pero no grave

Placa redonda u ovalada en cualquier parte del cuerpo que es roja o violácea que al tomar el fármaco por 2ª vez la lesión vuelve a aparecer en el mismo lugar, esto es lo característico

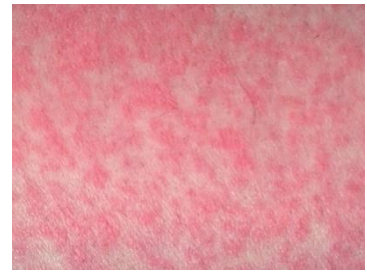
Causa → RAM

Tratamiento → Suspender el fármaco

Exantema eritematoso inespecífico

Rash inespecífico generalizado, nada mas
Causado por RAM (RAM mas frecuente), virus
(cualquiera) o enfermedades autoinmunes

Manejo → Suspender el fármaco



Síndrome de Dress (drug reaction with eosinophilia and Symptoms)

Es grave

Suele producirse 1-2 semanas posterior al uso de los farmacos

Reaccion cutanea de cualquier tipo + eosinofilia + compromiso sistémico

- hepatitis generalmente
- nefritis intersticial
- fiebre
- adenopatias
- artralgias

Causa → RAM muy grave (letalidad 10%)

Manejo → Suspender fármaco + corticoides + soporte de IR, hepatitis. Puede evolucionar hacia una enfermedad autoinmune

OTRAS

Las RAM pueden presentarse de cualquier forma (psoriasiformes, vitíligo, alopecia, acneiformes, urticaria, etc.)

9. Dermatología pediátrica

Hemangiomas y Malformaciones vasculares

Hemangiomas → Ausentes al nacer, pero crecen rápidamente y luego involucionan

Se ubican en la cara y en el sacro (marcador de alto riesgo de espina bífida, SE DEBE PEDIR UNA ECOGRAFÍA)

Tratamiento → Propanolol Oral (evitan su evolución y hemorragias)



Malformaciones vasculares

Las malformaciones vasculares están presentes desde el nacimiento y crecen junto con el niño

Pueden estar ubicada en cualquier parte y verse igual que un hemangioma, pero su evolución es distinta

Tratamiento → Observar a menos que se compliquen o estéticamente sean muy feas.



Nevus flameus y mancha salmón

Nevus flameus

Es una macula roja vino tinto (mancha de oporto)

Ubicada en la mitad del cuerpo, no pasa la línea media

NO desaparece, es una malformación vascular

Tratamiento → Observar. Se puede tratar con laser o con fines estéticos



Mancha salmón

Macula roja, mas rosada que el nevus

Ubicada en la línea media y la traspasa

Desaparece con el tiempo (generalmente al año)

Tratamiento → Observar



Manifestaciones cutáneas normales en el RN

Se observan y no se hace nada

Milium sebáceo

Pequeñas pápulas puntiformes amarillo

pálido en dorso y alas nasales



Perlas de Ebstein

Pápulas blancas en la cara anterior de las encías

Desaparecen en pocos días



Miliaria cristalina

El sudor queda atrapado en pequeñas vesículas.



Acné neonatal

Se llena de pústulas en cara y pecho



Eritema tóxico

Aparece al 2-5 día de vida generalmente

Pústulas o vesículas de base eritematosa

Respetar palmas y plantas



Melanosia pustular

Pústulas generalmente en EEII, palmas y plantas



Mancha mongólica

Macula azulosa en zona glútea y sacra que suele desaparecer con el tiempo



Nevo de Ito

Mancha azul en el hombro (el nevo de Ito es una mancha azul en el hombrito)

No desaparece



Nevo de ota

Mancha azul en la cabeza

No desaparece

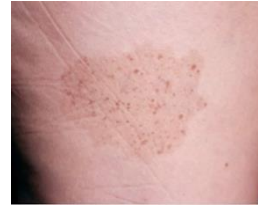


Manchas café con leche

Si son menos de 6, es normal



Nevo de spilus
Irregular, grande, color heterogéneo con maculitas
mas oscuras dentro



10. Pediculosis, loxocelismo, Sarna, verrugas, molusco contagioso y Herpes

Pediculosis

Clínica→ Prurito de la cabeza con visualización de liendres y/o piojos.
Ver liendres o piojos nos hace el diagnóstico

Tratamiento→ Permetrina 1% en Shampoo en esquema 1-6-1. Además, se deben remover las liendres.

Se debe tratar a toda la familia, es una enfermedad muy contagiosa

Ladillas

Prurito púbico con presencia de pthirus pubis y sus huevos en la región púbica.
Puede incluso aparecer en cejas, tronco, pelos de las piernas.
Tratamiento→ Permetrina 1-6-1 y estudio de ETS

Sarna o escabiosis

Producido por Sarcoptes scabiei



Nuestra mascota sarcoptes,
JIM Temuco 2015

Clínica
Prurito generalizado, generalmente mayor en manos (entre los dedos), abdomen y genitales
Hay 2 lesiones patognomónicas. Las lesiones perladas y el surco acarino

Diagnostico→ Acaro test

Tratamiento→ Existen varias opciones
Permetrina 5% en esquema 3-4-3

En mujeres embarazadas, lactancia o menores de 3 meses se debe tratar con vaselina azufrada
Tratar a toda la familia también y tratar los fómites (lavar y planchar sabanas, colchones y ropa)

Loxocelismo

Mordedura por la araña de rincón. Es la araña que mas pica en Chile
Existen 2 tipos, loxocelismo cutáneo y loxocelismo visceral

Cutáneo→ Placa livedoide (con centro necrótico) que puede evolucionar a una escara

Visceral→ Hemólisis, IRA y CID. Pasa cuando el veneno se va por la sangre, por mala cuea



Lo mas importante es la prevención (aseo de a casa) y educar a la gente. Lo mas importante es poner hielo precozmente para evitar su paso a vasos sanguíneos

Tratamiento→ De ser cutáneo solo se observa si es pequeño, pero podemos llegar hasta la escarectomía si se necrosa mucho

El visceral debemos dar SF a chorro para evitar la IRA + soporte

Verrugas

Lesión hiperqueratósica que borra el dibujo cutáneo. Pueden tener puntitos negros que son vasos sanguíneos trombosados

Pueden picar o doler un poco, principalmente las plantares

Agente→ VPH

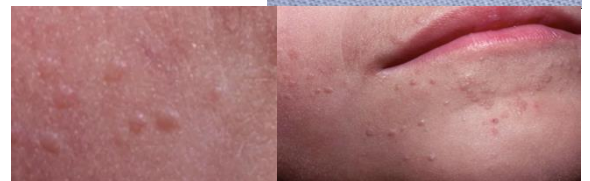
Tratamiento→ Crioterapia



Verrugas planas

Lesiones papulares lisas que borran el dibujo cutáneo
Adquieren una disposición siguiendo las línea de grataje.

Se ubican en cara, manos y brazos.



Agente→ VPH

Tratamiento→ Crioterapia

Molusco contagioso

Lesiones nodulares o papulares de aspecto brillante con una umbilicación central

Agente→ Virus Pox

Se ubican en cara y manos

Más frecuente en niños e Inmunodeprimidos



Tratamiento→ Curetaje, crioterapia, observación

Herpes

Clínica

Primoinfección → Múltiples úlceras y vesículas en toda la boca con fiebre, adenopatía y dolor de garganta
Reurrencias → Aparición de vesículas en alguna parte de la cara, generalmente en los labios.

Agente → VHS1

Tratamiento → Aciclovir 400mg/4-6 hora por 5- 7 días a o valaciclovir 1g/8 horas por 5-7 días



11. Infecciones por hongos

Su diagnóstico es clínico

El tratamiento es con antimicóticos tópicos y oral

Tiña capitis

Causado por *C. canis*

Se ve como una placa alopécica **con signos inflamatorios** (alopecia areata viene sin signos inflamatorios)

Se trata con griseofulvina **oral**



Tiña corporis

Causado por *T. rubrum*

Placa eritematosa descamativa con bordes festoneados o asciformes. Viene con inflamación de la dermis.

Tiene tendencia a la curación central

Se trata con terbinafina tópica



Tiña pedis

Causado por *T. rubrum*

Llamada pie de atleta, viene con descamación, mala olor, eritema, se encuentra principalmente entre los dedos de los pies.

Se trata con terbinafina tópica + buen manejo del calzado



Tiña cruris

Causado por *T. rubrum*

Es un tipo de intertrigo

Se trata con terbinafina tópica



Oncicomicosis

Causado por *T. rubrum*

Viene con onicogрифosis (uña gruesas), deformación de las uñas, color mas oscuro, quebradizas y onicolisis (uña se va despegando)

Se trata con terbinafina **oral**

No se deben pedir pruebas hepáticas antes del tratamiento, pero si después de haberlo iniciado. En caso de haber factores de riesgo de daño hepático se piden antes de iniciar terapia.



Intértrigo→ Hongos en los pliegues, se trata de forma tópica mas el manejo del sudor en esa zona.

Dermatitis del pañal vs candidiasis del pañal

Ambas son muy frecuentes y hay que saber manejarlo

LA dermatitis respeta los pliegues solo afecta la zona de contacto con el pañal y suele venir sin lesiones satélite

Tratamiento→ Cambio de pañal frecuente mas pomadas de óxido de zinc



Dermatitis del pañal, respeta los pliegues

La candidiasis si afecta los pliegues, viene con lesiones satélite (puede llegar hasta los muslos o abdomen) y puede venir con secreción blanquecina característica de candida

Tratamiento→ Cambio de pañal con oxido de zinc + antimicóticos tópicos (cotrimazol/nistatina)



Candidiasis clásica



Candidiasis en la Z

Resumen Guevara by creggers

Oftalmología

Son 4 preguntas fáciles. Es importante su manejo clínico, es decir, reconocer la enfermedad y saber diferenciarlas

1. Ojo Rojo superficial

Es lo mismo que ojo rojo periférico

Conjuntivitis bacteriana

Clínica

- Ojo rojo superficial (causa mas frecuente)
- Ardor/arenilla ocular (mas intenso que la viral)

Puede ser bacteriana, viral o alérgica

	Bacteriana	Viral	Alérgica
Secr.	Purulenta	Serosa	Mucosa
Reac.	Ninguna	Folicular	Papilar
Otros	- Ojos pegados - Legañas	- Adenopatía - Faringitis Unilat ➔ Bilat	- Prurito - Atopía

Secr. → Secreción
Reac → Reacción tarsal o palpebral

Viral:

Reacción folicular → Se describe como un empedrado

Adenopatía pre o retroauricular

Alérgica → Reac. papilar (empedrado más chico)

Diagnostico → Clínico

Tratamiento

Bacteriana → ATB tópicos (gotas de cloranfenicol o tobramicina por 5-7 días)

Viral → Sintomático

Alérgica → Antihistamínicos VO o corticoides tópicos como 2ª línea

Conjuntivitis bacteriana crónica

Clínica → La misma que la aguda pero menos intensos y fluctuantes

Causa → Mal aseo, usuario de lentes de contacto con mal manejo, blefaritis

Diagnóstico → Clínico

Tratamiento → ATB tópicos y tratar la causa

Blefaritis

Inflamación del párpado

Clínica

- Eritema de párpados
- Descamación (se acumula una “caspa” en las pestañas)

Causa→

- Rosácea (las mas frecuente)
- Sequedad ocular
- Dermatitis de contacto

Diagnóstico→ Clínico

Tratamiento→ Buen aseo ocular + tratamiento de la causa

Orzuelo y Chalazión

Causa

Orzuelo→ Funiculitis de una pestaña (la lesión se ve en la línea de las pestañas)

Chalazión→ Obstrucción de glándula de meibomio

Clínica

- Aumento de volumen palpebral
- Eritema y dolor
- Puede absedearse

Diagnóstico→ Clínico

Tratamiento

Masaje con calor húmedo

Dacriocistitis

Causa→ Infección por *S. aureus*

Clínica

- Aumento de volumen en la zona medial del ojo
- Eritema
- Dolor
- Epifora



Diagnóstico→ Clínico

Tratamiento→ ATB orales (amoxic/clav, cefadroxilo, cloxa, etc.)

Si es recurrente se debe sospechar de la obstrucción del conducto nasolagrima

2. Ojo Rojo profundo

Pregunta segura

Es lo mismo que ojo rojo central o periquerático.

Los vasos sanguíneos llegan hasta el borde esclerocorneal

Es importante ver las pupilas

Queratitis

Clínica

- Ojo rojo profundo
- Ardor
- Fotofobia
- Blefaroespanto
- Epifora

Pupila → Normal

Causas

- Infecciosa → Viene con el antecedente de infección
- Herpética → Viene con una úlcera de tipo dendrítico a la tinción con fluoresceína
- Ojo seco (queratitis punctata o Sika) → Úlceras puntiformes
- Actínica → Tras la exposición a radiación (soldadores)



Úlcera dendrítica (queratitis herpética) a la fluoresceína

Diagnóstico → Clínico, es importante hacer la tinción con fluoresceína para descartar úlcera o que sea herpética

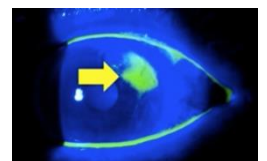
Tratamiento → Ungüento ATB (se suelen sobreinfectar) y tratar la causa.

Erosión corneal

Clínica → Igual a queratitis con antecedente que haya generado esta erosión (trauma, cuerpo extraño)

Diagnóstico → Clínica + tinción con fluoresceína

Tratamiento → de la causa + ungüento antibiótico y parche ocular

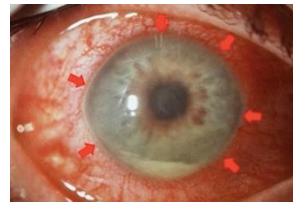


Uveítis

Clínica

- Ojo rojo profundo
- Dolor

- Hipopión (pus en cámara anterior)
- Disminución de agudeza visual
- Enoftalmo



Hipopion

Pupila → Miosis

Lo importante es que es un ojo rojo con miosis

Causas

- Infecciosa (precedida por conjuntivitis)
- Autoinune (las más frecuentes, estas se han preguntado)
 - o Espondilitis anquilosante
 - o Enfermedad inflamatoria intestinal
 - o Otras pelviespondilopatías

Tratamiento → Según la causa. Cuando es autoinmune se trata con corticoides tópicos

Glaucoma Agudo

Es lo mismo que glaucoma de ángulo estrecho

Clínica

- Ojo Rojo profundo
- Dolor intenso
- Vómitos en algunos casos
- Disminución de agudeza visual
- Hipertonía ocular (ojo duro)

Pupila → Midriasis arrefléctica

Reflejo fotomotor ausente

Causas

- Cierre del ángulo iridocorneal

Tratamiento → Bajar la presión ocular (manitol, acetazolamida, timolol y pilocarpina).

DERIVAR

Se opera como profilaxis para evitar recurrencia

Endoftalmitis

Infección grave del ojo

Clínica

- Ojo rojo profundo
- Hipopion masivo
- DOLOR
- Disminución de la agudeza visual
- Quemosis (edema de la conjuntiva bulbar)

Diagnóstico → Clínico

Causa→ Postqx, infección que avanza

Tratamiento→ ATB Intraoculares. DERIVAR

Escleritis

Vasos dilatados en la esclera, pero de localización periférica. Puede producir un adelgazamiento de la esclera que podría producir una herniación vítrea

Causas→ Artritis reumatoide

Tratamiento→ Corticoides sistémicos+ inmunomoduladores

Celulitis orbitaria y periorbitaria

Clínica

- Aumento de volumen de párpado
- Edema de párpado
- Eritema de párpado

¿Que me hace pensar que es orbitaria o no preorbitaria?

- Proptosis
- Disminución de la agudeza visual
- Alteración del reflejo fotomotor
- Oftalmoparesia

Causas

- 2ª a sinusitis (complicación mas frecuente de sinusitis)
- Infecciones externas (conjuntivitis, chalazión)

Manejo

Pre-orbitaria→ Ambulatorio con ATB VO (cefuroximo o amoxi/clav)

Orbitaria→ Se debe pedir TAC de órbita y se trata con ATB Ev (ceftriaxona + cloxacilina)



→ Celulitis Preorbitaria



Celulitis orbitaria (proptosis)

3. Pérdida lenta de visión

Cataratas

Clínica

- Adulto mayor
- Disminución lenta de la visión
- Encandilamiento (ven mejor en la oscuridad)
- Disminución/alteración del rojo pupilar
- Leucocoria en algunos casos

Causa

- Catarata senil es lo más común
- Diabetes
- 2ª uso de corticoides

Diagnóstico → Clínico

Tratamiento → Quirúrgico, de elección con Dr. Andreggers



Degeneración macular relacionada con la edad (DMRE)

Clínica

- Adulto mayor
- Disminución lenta de la agudeza visual
- Metamorfopsias (las formas están alteradas, no las distingue bien)

No tiene leucocoria, encandilamiento ni alteración del rojo pupilar

Causa → Patología degenerativa

Diagnóstico → Fondo de ojo

Tratamiento → No existe



Glaucoma crónico

Clínica

- Agudeza visual normal en un inicio, pero al final se afecta
- Pérdida del campo visual progresiva (inicia con escotomas periféricos que evoluciona hacia visión tubular)
- Aumento de la excavación papilar

Es asintomática hasta que el paciente se da cuenta que está viendo poco y ahí ya es muy tarde.

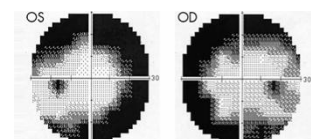
Puede ser muy asimétrica su evolución entre ambos ojos y dentro del mismo ojo también

Causa → Mayor producción que reabsorción de humor acuoso

Screening → Tonometría ocular (mide la Presión Intraocular, PIO)

Diagnóstico → Campimetría (Con o sin tonometría alterada)

Tratamiento → Gotas antiglaucomatosas (timolo, pindolol, pilocarpina)



Contraindicados → Anticolinérgicos (Antidepresivos tricíclicos) Se ha preguntado

4. Pérdida súbita de la visión

Se pierde la visión súbitamente de 1 ojo, si pasa en los 2 ojos es un síndrome conversivo

Clínica de todas → Amaurosis súbita

Manejo inicial de todas → Fondo de ojo

Desprendimiento de retina

Clínica

- Su clínica es menos súbita, puede durar días
- Fotopsias (luces)/entopsias (moscas) localizadas (contralateral al lado afectado)
- Caída del telón o alzamiento de un muro
- Reflejo pupilar aferente relativo

Causas

- Retinopatías (lo más frecuente)
- Miopía
- Trauma

Diagnóstico → Fondo de ojo

Tratamiento → Quirúrgico

Trombosis de la vena central de la retina

Clínica

- Ceguera súbita (segundos a minutos), pero puede contar dedos, ve sombras

Causas

- Retinopatía hipertensiva
- Trombofilias

Diagnóstico → Fondo de ojo

Tratamiento → Fotocoagulación

Oclusión de la arteria central de la retina (OAC)

Clínica

- Amaurosis súbita, ni siquiera cuenta dedos, no ve ni un harto
- Defecto pupilar aferente

Causas

- Embolia arterio-arterial (embolo de la carótida, por ejemplo)

Diagnóstico → Fondo de ojo

Tratamiento → Manejo del ACV con estudio de fuente embolígena

Hemorragia vítrea

Clínica

- Amaurosis súbita (segundos a minutos)
- Pérdida del rojo pupilar

- Puede conservar algunas partes del campo visual

Causas

- 2ª a retinopatía proliferativa (diabética es la más frecuente donde hay vasos de neoformación)

Diagnostico → Fondo de ojo

Tratamiento → Depende de la severidad que va desde expectante hasta cirugía (vitrectomía)

Neuropatía óptica isquémica

Clínica → Igual a OAC

Causa → La misma, pero en vez de llegar el embolo a la arteria central, llega a la arteria del nervio óptico.

Diagnóstico → RNM

Fondo de ojo → NORMAL

Manejo → Igual a OAC

Neuritis óptica

Clínica

- Amaurosis de horas a días (suele ser de causa autoinmune)
- Defecto pupilar aferente
- Edema de papila unilateral

Causas

- Autoinmune (Esclerosis múltiple es lo más común)
- Arteritis de la temporal

Diagnostico → RNM

Tratamiento → Corticoides

5. Vicios de refracción

Todos mejoran su agudeza visual al mirar por un agujero estenopeico

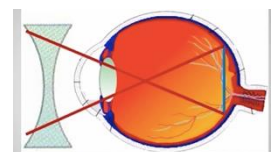
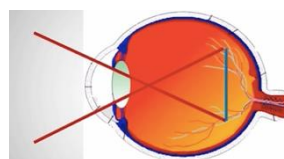
Diagnostico → Con optometría (refractometría)

Tratamiento → Lentes

Miopía

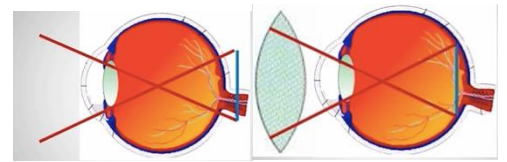
Ven mal de lejos

Ojo muy largo, la imagen se forma delante de la retina, se corrige con lente biconcavo



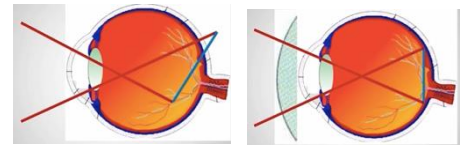
Hipermetropía

Ven mal de cerca
Ojo muy chico, la imagen se forma tras la retina, se corrige con lente biconvexo



Astigmatismo

Ven mal de lejos y cerca
Es lo mas frecuente
Ojo de longitud normal, las curvaturas de los lentes del ojo están alterados. Se arregla con lentes cilíndricos



Presbicia

Ven mal de cerca
Se da en adultos mayores, aunque suele iniciar a los 40 años
Ven bien de lejos, pero no de cerca

Es por envejecimiento del cristalino, que pierde su elasticidad y le cuesta enfocar. Se corrige con lentes biconvexas para leer

	Visión	Causa	Lente
Miopía	Ve mal de lejos	Ojo grande	Bicóncavo
Hipermetropía	Ve mal de cerca	Ojo chico	Biconvexo
Astigmatismo	Ve mal siempre	Curvatura distinta	Cilíndrico
Presbicia	Ve mal de cerca	Cristalino rígido	Biconvexo

6. Lesiones traumáticas oculares

Hay que saber lo básico de ellas

Trauma ocular

Hay que buscar signos de severidad
Si no los tiene, es un trauma simple, paracetamol y pa la casa
Si tiene signos de alarma se debe derivar de forma urgente

Signos de severidad

- Hipotonía (ojo blando, es lo mas grave)
- Discora (pupila deforme)
- Disminución de la Agudeza visual
- Hifema (sangre en cámara anterior)
- Laceración/penetrante

Hemorragia subconjuntival

Puede ser traumática o espontánea

El diagnóstico es clínico

Tratamiento→ Observación, se mejora fácil. NO ES SIGNO DE ALARMA

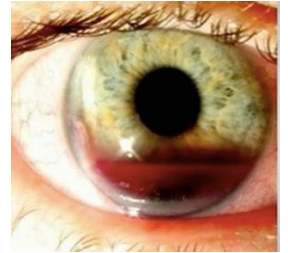
Se asocia a HTA

Hifema

Sangre en la cámara anterior

Causa→ Trauma

En este caso, si es signo de alarma y debe ser derivado urgentemente semisentado, para que la sangre no se vaya hacia adelante ni atrás.



Penetrante ocular

Penetrante→ Se entierra algo en el ojo

Estallido→ Un golpe rompe el ojo

Clínico→ Hipotonía, discoria, disminución de la AV y laceración evidente.

Conducta→ Derivar de forma urgente. NO DEBO TOCAR EL OJO. Se dan ATB de amplio espectro y analgésicos antes del traslado

Causticación ocular

Le salta un químico al ojo

Clínica→ Ardor, epifora dolor, ojo rojo, etc.

No se hace anamnesis, se hace abundante lavado con SF al tiro, por 20-30 minutos para asegurarnos de remover los químicos que entraron al ojo.

Después del lavado se aplica ungüento ATB

NO CUBRIR EL OJO

Heridas de párpado

Si no tiene signos de severidad se maneja de forma general como cualquier herida

Si tiene signos de alarma se deriva (lesión transfixiante, lesión que llegue hasta el borde libre de las pestañas o lesión de la vía lagrimal)

Cuerpo extraño ocular

Depende de la ubicación

Palpebral→ Sacarlo mediante eversión del párpado. Se tiñe con fluoresceína para buscar erosiones 2ª al cuerpo extraño

Corneal→ Puedo intentar removerlo con hisopo. De no poder, se deriva

Intraocular→ Derivar inmediatamente

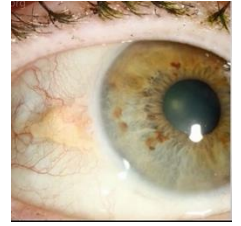
7. Misceláneos

Síndrome de ojo seco

Clínica→ Sensación de arenilla ocular. Puede complicarse con úlceras corneales y conjuntivitis crónica

Causa→ Sd de Sjögren es lo mas común

Diagnóstico→ Test de Schirmer
Tratamiento→ lágrimas artificiales

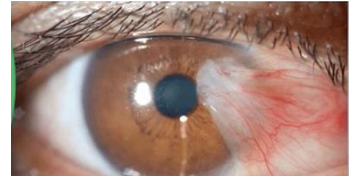


Pingüecula

Carnosidad en la cara medial de la esclera habitualmente
Clínica→ aumento de volumen indoloro en la conjuntiva bulbar. Puede complicarse con la pingüieclitis (dolor, aumento de volumen)
Se desconoce la causa, probablemente por exposición al sol
Dg→ Clínico
Tratamiento→ Protección solar (lentes de sol) y lubricación ocular

Pterigion

Carnosidad que se mete hacia la córnea. Parecido a la pingüecula, pero invade la córnea
Causa, Dg y tratamiento→ Igual a la pingüecula.



Leucocoria

Pupila blanca
Adulto mayor→ Probablemente catarata
Niños→ Catarata congénita, retinoblastoma, persistencia del vítreo 1º y retinopatía del prematuro
Dg→ Clínico
Tratamiento→ Depende de la causa

Leucoma

Opacidad focal de la córnea, generalmente después de una úlcera corneal o queratitis.
Diagnostico→ Clínico
Tratamiento

- Agudo→ Tratamiento de la causa, podría ser curativo
- Establecido→ Cirugía, trasplante de córnea

Xantelasmas

Aumento de volumen de color amarillento alrededor de los ojos
Causa→ Dislipidemia y cirrosis biliar primaria
Diagnostico→ Clínico
Manejo→ Perfil lipídico
Tratamiento→ De la causa



Órbitopatía Distiroidea

Exoftalmo, diplopía y sequedad ocular

Causa→ Enfermedad de Basedow graves es la más frecuente
No tiene correlación con el grado del Hipertiroidismo
Diagnostico→ Clínico



Tratamiento→ Observación + lubricante en casos leves. Corticoides, inmunomoduladores o radioterapia en caso de estar avanzado. Cirugía cuando ya está en la B

Pseudotumor orbitario

Clínica→ Exoftalmo con pruebas tiroideas normales

Es idiopático

Diagnóstico→ Clínico, se debe descartar enfermedad de Graves

Tratamiento→ Igual a la orbitopatía distiroidea

Tumores oculares

Órbita→ Exoftalmo unilateral, se debe pedir un TAC de órbita y manejo según causa

Globo ocular→ Leucocoria, el clásico es la retinoblastoma. Se pide TAC para evaluarlo

Conjuntiva y párpado→ Igual que los Ca de piel, su manejo es el mismo

Retinopatías

Clínica→ asintomática. Reflejan el daño de órgano de la patología

Diagnóstico→ Fondo de ojo (exudados céreos, microaneurismas, microinfartos, microhemorragias, etc.)

Manejo→ De la causa, en caso de venir con vasos de neofromación se hace fotocoagulación

Diabética→ Fondo de ojo con exudados céreos, microaneurismas, microinfartos, microhemorragias, etc. Al final aparecen los vasos de neoformación. Al aparecer estas lesiones se pasa a llamar retinopatía proliferativa y requiere de fotocoagulación láser.

Hipertensiva

Específico de esta patología es la disminución de cruces arteriovenosos, disminución de diámetro de las arterias con aumento de su brillo y hemorragias en llama.

Además, puede venir con microaneurismas, microhemorragias y exudados

8. Neurooftalmología

Hay que conocer la semiología de las patologías

Lesiones de la vía visual

La parte medial del nervio óptico (retina medial) se decusa en el quiasma, mientras que la parte lateral (retina lateral) no se decusa.

La retina viene invertida en cuanto al campo visual

Lesión del nervio óptico→ Amaurosis

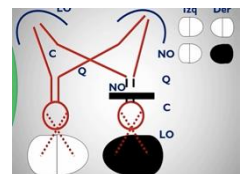


Figure 1 consists of three parts, (a), (b), and (c), each showing a schematic of an experiment with two paths, LO (Left) and Q (Right), and a series of circular detectors. Each detector is divided into two halves, black and white, representing different states. To the right of each path, there is a table of results for 'Izq' and 'Der' columns.

(a) Experiment 1: The LO path has a vertical barrier in the center. The Q path has a vertical barrier in the center. The results table shows:

	Izq	Der
NO	White	Black
Q	White	Black
C	White	Black
LO	White	Black

(b) Experiment 2: The LO path has a vertical barrier in the center. The Q path has a vertical barrier in the center. The results table shows:

	Izq	Der
NO	White	Black
Q	White	Black
C	White	Black
LO	White	Black

(c) Experiment 3: The LO path has a vertical barrier in the center. The Q path has a vertical barrier in the center. The results table shows:

	Izq	Der
NO	White	Black
Q	White	Black
C	White	Black
LO	White	Black

Lóbulo occipital→ Se afectan las retinas del mismo lado, hemianopsia homonimia contralateral a la lesión

Neuritis óptica

Reflejo pupilar aferente relativo → Si ilumino el ojo malo, se contraen ambas pupilas, pero poco

Defecto pupilar eferente → Por afectación del oculomotor. Ilumino el ojo malo, y el ojo bueno se contrae igual. Acá lo malo es la eferencia

Hay asimetría entre ambos ojos

Es algo normal que no traer ninguna consecuencia

III→ Clínica

- Ptosis
- Midriasis
- Estrabismo divergente (Se va a hacia afuera el ojo)
- Imposibilidad de mirar hacia arriba, abajo y medial.

- Estrabismo divergente (hacia lateral y arriba)
- Imposibilidad de mirar hacia inferomedial

- Estrabismo convergente
- Imposibilidad de mirar hacia lateral

Participa en la mirada conjugada. Une el VI par de un ojo con el III del otro para poder mirar en la misma dirección de forma conjugada.

Si se lesiona, al mirar hacia medial no lo logra por afección del tercer par.

Síndrome de Horner

Clínica

- Ptosis
- Miosis
- Anhidrosis de hemicara

Es por una lesión de la vía simpática

El antecedente mas frecuente es una neoplasia de pulmón que genera una metástasis al ganglio estrellado donde están las vías simpáticas.

Conducta→ Pedir Rx de tórax en búsqueda del ca

Pupila de Argyll Robertson

Perdida del reflejo fotomotor, pero mantiene el de acomodación. (se dilatan al mirar cerca y se contraen al mirar de cerca)

Se debe sospechar en una neurosífilis, por lo cual, se debe hacer una PL y pedir VDRL del LCR.

9. Oftalmología pediátrica

Suele ser 1 pregunta, aparece casi siempre

Ambliopía

Clínica→ Disminución de la agudeza visual de un ojo que no mejora inmediatamente al corregirla

Se debe a una falta de estimulación de u ojo, que lleva a falta de desarrollo nervioso de ese ojo.

Diagnostico→ Clínico

Tratamiento→ Tratar la causa lo más precoz posible

Lo más importante es la prevención

Estrabismo

Desviación de la mirada de uno de los ojos

Puede causar diplopía

Su complicación mas frecuente es la ambliopía

Diagnostico→ Clínico mediante a prueba de Hirschberg

Al iluminarle los ojos al niño, el reflejo de la luz debería estar en la mitad de la pupila de ambos

Tratamiento→ <6 meses y fluctuante→ Observar

>6 meses o fijo→ Derivar a oftalmólogo



Hirschberg alterado



Hirschberg normal, simplemente tiene epicantos. Es un pseudeoestrabismo

Obstrucción de la vía lagrimal (atresia lagrimal)

Clínica→ Epifora y suele complicarse con infecciones (conjuntivitis y dacriocistitis)

El Diagnostico es clínico. Es importante descartar el glaucoma

Tratamiento→ Sigue un orden

4. Masajes del saco lagrimal
5. Cateterismo de la vía lagrimal
6. Dacricistorinostomia

Glaucoma congénito

Clínica

- Epifora
- Buftalmo y megalocornea (ojos muy grandes)
- Opacidad corneal
- Estrías de Haab

Diagnostico→ Clínico, ante la sospecha se debe

derivar a oftalmólogo

Tratamiento→ quirúrgico



Buftalmo y megalocórnea



Buftalmo, megalocornea y opacidad corneal

Retinoblastoma

Clínica

- Leucocoria
- Proptosis
- Estrabismo

Diagnóstico→Clínico, ante la sospecha se debe derivar. Buen pronóstico si se diagnostica tempranamente
Tratamiento→ QT/RT/ Qx
Puede recurrir o asociarse a otros tipos de cáncer dado el carácter hereditario

Leucocoria
Pupila blanca

Causa

- Catarata congénita
- Retinoblastoma
- Persistencia del vítreo primario hiperplásico
- Retinopatía del prematuro

Diagnostico→ Clínico, se debe derivar
Tratamiento→ Según causa

Si esta al nacer→ Catarata congénita
Si aparece a los 6 meses→ Retinoblastoma

Retinopatía del prematuro

Se debe hacer FO a todo prematuro menor de 32 semanas o peso menor a 1.500g.
Muestra una retina con una zona avascular.
Mientras mas central es la lesión, es peor.

Tiene riesgo de desprendimiento de retina que avanza a hacia la ceguera
Tratamiento→ Observar hasta una completa vascularización de la retina y se realiza fotocoagulación en los casos mas graves.

Resumen Guevara by creggers

Geriatría

Hay 4 preguntas de geriatría que suelen ser fáciles.

Hay una de demencia, una de delirium y de algún otro tema

1. Adulto Mayor normal, VGI, polifarmacia y síndrome de fragilidad

Adulto mayor normal → Tienen presbicia, mayor cantidad de grasa, menor cantidad de masa muscular, disminuye la cantidad de sueño (6 horas), y disminuye el clearance de creatinina (de los 40 en adelante disminuye 1ml/min al año). Esto último implica que hay una mayor reacción adversa a medicamentos.

Evaluación geriátrica integral → Enfoque multidisciplinario biopsicosocial. Movilidad, caídas, dependencia, caídas y visión/audición es fundamental (funcional), además de su red de apoyo, soledad, pobreza y abusos (social). Obviamente se deben preguntar por fármacos, enfermedades, etc. (Biológico Y Psicológico)

Polifarmacia → Esto sumado además de la disminución del clearance de creatinina, los viejos tienen enfermedades y toman muchos fármacos, por lo cual, tiene riesgo de interacciones entre ellos.

Síndrome de Fragilidad → Disminución de las reservas fisiológica en el adulto mayor, lo cual, hace que su respuesta ante estresantes sea peor. "cualquier cosa puede matar a un viejito, ese es el resumen. Todo puede descompensarlo y matarlo, por lo mismo, hay que preocuparse de todos estos ámbitos (se suele tomar la postura contraria, no hagamos nada porque esta muy viejito y eso está mal)

Patologías en el adulto mayor

Infecciones → Pueden venir sin fiebre

Abdomen agudo → Puede venir sin signos peritoneales

IAM → Puede venir sin dolor

Deshidratación → Puede venir sin signos de deshidratación, la oliguria es el signo más confiable de deshidratación en el adulto mayor

TODOS estos cuadros pueden presentarse simplemente como confusión, por lo cual, a un adulto mayor que estaba bien ya ahora confuso, hay que ir a descartar todas estas opciones recién vistas.

2. Atrofia muscular, inmovilidad y caídas, depresión y vacunas

Atrofia muscular

Se llama sarcopenia.

El adulto mayor suele ser sedentario, esto sumado al envejecimiento normal nos genera sarcopenia. Esto tiene varios riesgos, uno de estos la **inmovilidad** (que puede llevar a la **postración** y la postración aumenta la mortalidad) y también **caídas** (genera inmovilidad y postración además de riesgo de Fx de cadera).

Por lo tanto, la sarcopenia conlleva riesgo de muerte en el adulto mayor

La evaluación se hace con el examen físico. El test mas común es el Test up and go, que nos sirve para ver la fuerza de las EEII y con la prueba de prensión palmar para medir la fuerza de las EESS.

Lo fundamental para evitar y/o revertir esto es el ejercicio. Reduce la inmovilidad y mejora al sarcopenia

Caídas

Es un problema muy frecuente y grave en el adulto mayor, principalmente por su asociación con fractura de cadera que se asocia a una elevada mortalidad al año

Sd postcaída→ Miedo a caerse de nuevo, . Esto hace que finalmente el viejo se quede inmóvil→ postración→ muerte

Manejo→ **Ejercicio** (lo más importante), **buscar y tratar las causas** y una órtesis como tercera opción (bastón, andador)

Causas de caídas

- 1- Debilidad (se maneja con ejercicios)
- 2- Arritmias (ECG y en caso de que hayan bradiarritmias (las mas comunes) se deben tratar con marcapaso)
- 3- Hipotensión ortostática→ LA forma de tratarlo es con medias elasticadas
- 4- Fármacos→ AntiHTA y todos los que afectan al SNC(antidepresivos, BDZ)
- 5- Enfermedades degenerativas como el parkinson
- 6- **Se debe evaluar el domicilio, para que esté adaptado para el adulto mayor (que viva en 1er piso, sin alfombra, piso resbaloso), que ocupe sus lentes.**

Depresión en el adulto mayor (Se ha preguntado con cierta frecuencia)

Causas

- **Soledad (principal causa)**
- Enfermedades
- Pobreza
- Dependencia

El diagnostico es simplemente clínico, al igual que en el paciente joven. El test de Yessavage (de 30 o 15 preguntas) es útil que es en base a preguntas (con 10/30 o 5/15 se hace el diagnóstico).

Tratamiento

Se ocupan los ISRS, la sertralina es el mas ocupado. Los tricíclicos están TOTALMENTE CONTRAINDICADOS.

Abuso en el adulto Mayor

Es un problema frecuente (físico, psicológico, sexual y/o económico)

Vacunas en el adulto mayor

Por regla general el AM recibe 2 vacunas:

1. Influenza de forma anual (desde los 65 en adelante)
2. Neumococo cada 5 años (desde los 65 en adelante)

3. Incontinencia Urinaria

Pregunta segura del EUNACOM, 2 generalmente (Uro, Gine, Geriatria)

Definición: Escape de orina que afecta la vida.

El diagnostico es totalmente clínico.

Incontinencia urinaria de esfuerzo→ Se caracteriza por afectar a las mujeres multíparas, es la causa mas frecuente en las mujeres. Se caracteriza por pequeños escapes de orina relacionado con esfuerzos (tos, risa saltar, levantar peso). El Diagnostico se apoya con perfil uretral (mide la presión intraluminal de la uretra, que concluye que hay debilidad del piso pélvico).

Incontinencia urinaria de urgencia→ Mas frecuente en mujeres jóvenes. Caracterizado por grandes escapes de orina asociado a necesidad imperiosa del ir al baño.

Incontinencia urinaria por rebalse→ asociado a uropatías urinarias bajas, de los hombres. Se asocia a la incontinencia de urgencia (por la hipertrofia del detrusor que genera una vejiga de lucha). El diagnostico se puede apoyar con la cistomanometria (mide la presión hidrostática dentro de la vejiga) que pesquisa contracciones no inhibidas del detrusor.

Fistula vesicovaginal→ Escape de orina **continuo (goteo)**. Puede ser congénita o iatrogénico (histerectomía, cesárea).

Tratamiento

IOE→ El tratamiento tiene un orden que debe ser respetado. 1. Descartar ITU 2. KNT pélvica (Kegel) 3. Cirugía (TOT o TVT)

IOU→ El tratamiento también sigue un orden: 1. Descartar ITU 2. Terapia conductual (que orine frecuentemente, que no tome agua si va a lugar sin baño, etc.) 3. Fármacos anticolinérgicos (Oxibutinina o **tolterodina**)

Neurología

1. Demencia y Delirium

DEMENCIA

Alteración de la memoria asociado a alteración del resto de las funciones cognitivas (apraxias y agnosias) de instalación crónica.

Suele ser por causas degenerativas

El diagnóstico es totalmente clínico (MMSE ayuda cuando es menor a 24 junto al test del reloj (que dibuje un reloj y ponga una hora solicitada correctamente))

Manejo: Buscar la causa y tratarla

Exámenes mínimos antes de diagnosticar demencia: TSH, VDRL, VIH, B12 (o hemograma), TAC de cerebro junto a exámenes generales para determinar si hay causa tratable

Tratamiento:

Multidisciplinario : Geriatra, TO, Kine. Se debe evitar el stress del cuidador (repartiendo el cuidado entre varias personas para evitar stress y depresión)

Donepezilo o rivastigmina (inhibidor de la acetilcolinesterasa)

Memantina algo puede ayudar también.

Causa más común: Alzheimer

Su estudio y tratamiento es ambulatorio

- 1- Alzheimer: Alteración de la memoria asociado a apraxias y agnosias
- 2- Demencia Vascular → Demencia causada por accidentes vasculares (1 o muchos), es la segunda demencia más frecuente.
- 3- Demencia frontotemporal → Pacientes jóvenes (55-60 años) con **desinhibición**, de avance rápido (6 meses). En el TAC puede haber atrofia frontotemporal (Apoya, pero el diagnóstico es clínico)
- 4- Hidrocefalia normotensiva → caracterizado por triada de instalación rápida (6 meses). **Demencia (Problemas de memoria), caídas frecuentes + incontinencia urinaria (triada de HNT)**. En algunos casos se suma torpeza motora. El tratamiento en este caso es con válvula de derivación Ventrículo-peritoneal. (TIBU-TIP: Demencia de instalación rápida en gente joven → Siempre sospechar demencia por VIH)
- 5- Demencia por cuerpos de Lewy: Problemas de memoria asociado a alucinaciones visuales y auditivas asociado a temblor en reposo y rigidez. **EMPEORA CON ANTIPSICOTICOS.**

Delirium

Alteración de la atención asociado a compromiso de conciencia (cualitativo y/o cuantitativo) de instalación aguda. Suele ser por alteraciones tóxico metabólicas, aunque realmente hay 10.000 causas que pueden causar delirium.

El diagnóstico es totalmente clínico. Se utiliza el CAM que consta de 4 elementos (los 2 primeros deben estar si o si):

5. Disminución de la atención (SIEMPRE)
6. Inicio agudo (SIEMPRE)
7. Curso fluctuante y/o compromiso de conciencia.

Evaluación de la atención: inversión de series

Estudio de causa: Hemograma, Orina Completa, Rx Tx, ECG, ELP, función hepática, renal, etc. para buscar el elemento desencadenante

Tto:

- Medidas generales (orientar al paciente, ejercicio diurno, uso de lentes y audífonos)
- Antipsicóticos como Haldol (0,5-1 mg IM) o risperidona.
- Tratar la causa desencadenante

Estudio y tto es hospitalizado

2. TEC

Se dividen en TEC simple (sin signos de alarma) y TEC severo (con signos de alarma).

Signos de alarma:

- Compromiso de conciencia
- Convulsiones
- Dolor muy intenso (Nos hace sospechar Fractura o hematoma)
- Náuseas y vómitos explosivos profusos
- Focalidades al examen neurológico
- Otorragia → Sangre por el odio es signo de fractura de cráneo
- Edad
- **Menor de 2 o mayor de 65 (se manejan como TEC severo)**
- Signos de TEC abierto (Otorraquea, Rinorraquea)
- Signos de fractura de cráneo
 - o Signo de Battle → Equimosis retroauricular
 - o Signo del mapache → Equimosis periorcular

No son signos de alarma:

Compromiso de conciencia, amnesia o convulsiones **inmediatamente después del TEC.**

Manejo:

TEC Simple → TAC cerebro con ventana ósea + medidas de neuroprotección inespecífica (evitar HTA, mantener normoglicemia, normotemperatura (se dice así?), anticonvulsivantes SOS), para la casa con paracetamol y control SOS ante signos de alarma.

TEC severo → Hospitalizar

Complicaciones:

- Hematoma subdural y epidural → Se manejan con drenaje. El HSD (de viejos) se debe a sangramiento venoso en el cual el intervalo de lucidez es largo (horas-días), mientras que en el HED (de jóvenes) el sangramiento es arterial y eso hace que el intervalo lúcido sea breve (minutos).
- Contusión cerebral → En la zona frontal o occipital por golpes del cerebro (lesión hiperdensa al TAC). Acá las medidas de neuroprotección son mas importantes
- Daño axonal Difuso → Paciente en coma que no responde a estímulos dolorosos + TAC normal (sin lesiones focales). El pronóstico es muy malo, suelen fallecer o quedar en estado vegetal o con secuelas graves.

- **Concusión o conmoción cerebral**→ Compromiso de conciencia, amnesia y/o convulsiones **inmediatas** , son de buen pronóstico porque es un TEC simple. Si dura mas de 15 minutos es un signo de alarma

Hematoma Subdural→ Imagen de semiluna

Hematoma epidural o extradural→ Imagen biconvexa

Hemorragias subaracnoidea→ Se ve la sangre entre las cisuras del cerebro

3. Trastornos del Sueño

1. **Insomnio**→ Dificultad para conciliar el sueño o bien para mantener el sueño.
Tratamiento: Higiene del sueño, terapia cognitivo conductual (básico de la higiene del sueño).
Fármacos solo están indicados en casos graves, refractarios y no reemplaza la higiene del sueño (lo complementan). Deben ser usados por un periodo breve de tiempo.
Fármacos
 - **BDZ** (alprazolam, clonazepam, Diazepam) tienen muchos efectos adversos y generan dependencia, por lo cual, deben ser usados por un periodo breve.
 - **Hipnóticos Z** (zopiclona, zolpidem y eszopiclona)→ Tienen muchos menos efectos adversos y no generan dependencia.
 - **Melatonina**→ Hormona secretada por la glándula pineal. Casi no tiene efectos adversos, pero es menos eficaz

2. **Hipersomnia**→ Necesidad de dormir mas de 11 horas al día (8 y 6 horas es el promedio en adultos y adultos mayores respectivamente). Puede ser secundaria o primaria (se trata con metilfendiatto).

Lo mas común es secundaria a SAHOS y el tratamiento es etiológico.

3. **SAHOS** (se habla de esta patología en otro video 😊)
4. **Síndrome de piernas inquietas**→ Disestesia (siento incomodas las piernas) y hay movimientos de las piernas al dormir que despiertan al paciente. El Dg es clínico. El tratamiento es con hierro + prodopaminergicos (fármacos raros, esto no se pregunta)
4. **Pesadillas**→ Mal dormir por miedo. Ocurre durante el sueño REM. El paciente se despierta asustado y se acuerdan a día siguiente. Es un proceso normal que aumenta con el stress. El manejo es educación a los padres
5. **Terrores nocturnos**→ Ocurre durante el sueño no REM, variante del sonambulismo. El paciente se despierta asustado, es clásico de los niños. El niño no se acuerda, se despierta feliz de la vida al día siguiente. Es un proceso normal que aumenta con el stress. El manejo es educación a los padres.
6. **Narcolepsia**→ Es una tétrada dada por:
 - a. **Hipersomnolencia diurna**→ Es irresistible, es el síntomas mas clásico, incluso puede ser el síntoma único. Son ataques de sueño

- b. Cataplejía → Se pierde el tono muscular durante la vigilia (la atonía del REM se inserta en la vigilia)
- c. Parálisis del sueño → Se despierta y solo puede abrir y mover los ojos. Puede tener alucinaciones durante este periodo
- d. Alucinaciones Hipnagógicas e hipnopompicas → Aparecen al quedarse dormido y las otras al despertarse.

7. Vértigo, parálisis facial

VERTIGO

Sensación de que las cosas giran a mi alrededor (objetivo) o que yo giro (subjetivo). Este es un tipo de clasificación, pero que no es muy útil, dado que, lo importante es diferenciar entre vértigo central y vértigo periférico.

Vértigo periférico

- Nistagmo horizontal que se escapa de la lesión (la fase rápida se escapa del lado afectado)
- Lateropulsiones hacia el lado afectado
- Síntomas auditivos (hipoacusia o tinitus)

Causas

- **Vértigo postural paroxístico benigno** → De inicio súbito asociado a cambios de posición de la cabeza, dura menos de 1 minuto. Puede tener antecedente de TEC. El tratamiento es mediante de técnicas de reposición de los otolitos.
- **Enfermedad de Ménière** → Triada de **vértigo, hipoacusia y tinitus**. Se caracteriza por ser fluctuante y que los síntomas no aparecen juntos. El Dg es clínico, se trata con antivertiginosos (difenidol, cinarizina, betahistina). Todo ménière es un neurinoma del qcústico hasta que se demuestre lo contrario. (por tanto, **a todo ménière se le debe pedir una RNM**)
- **Neurinoma del acústico** (Tumor benigno del VIII par) → Clínica progresiva (por crecimiento del tumor). Su clínica es similar al ménière y podría afectar al 5º y 7º par (parálisis facial con hipostesia facial). El tto es con Radioterapia y si no responde a esto se hace cirugía.
- **Neuritis (neuronitis) vestibular** → Clínica de inicio súbito, es un vértigo persistente que dura días, incluso semanas. El dg es clínico y el tratamiento es con corticoides orales y antivertiginosos como tto sintomático.

Vértigo central

- Nistagmo vertical o multidireccional
- Lateropulsiones multidireccionales (se caen para todos lados)
- Signos cerebelosos (porque la primera causa de vértigo central son lesiones cerebelosas)
- Signos focales (podría haber hemiparesia por ejemplo)

Manejo

Se pide examen del VIII par. El examen del VIII par está compuesto por audiometría, prueba calórica (Debe haber nistagmo, si no hay nistagmo es una prueba alterada) y pruebas de provocación.

Causas

- Infarto del cerebelo
- Lesión del tronco encefálico

- ACV
- Esclerosis múltiple, tumores

Como son lesiones focales lo importante es pedir una neuroimagen (RNM o TAC)

PARÁLISIS FACIAL

Imposibilidad de mover la cara. Puede ser central o periférica.

La periférica afecta toda la cara. Puede generar disgeusia (imposibilidad de sentir sabores) y disminución de la sensibilidad del trago (pabellón auricular). Además puede generar hiperacusia por afección del nervio cuerda del tímpano

Central

Respeto los músculos de la frente.

Puede tener signos focales y afectación de otros pares craneales.

MANEJO DE LAS PARÁLISIS FACIALES

Periférico

Corticoides + protección ocular (Para evitar una queratitis)

Central

Se debe realizar Neuroimagen (RNM o TAC)

TIBU-TIP

Síndrome de Ramsay-Hunt → Es un herpes Zoster del VII par. Da una parálisis facial con vesículas en el trago. En este caso además debe dejarse aciclovir

8. Compromiso de conciencia

Tiene muchísimas causas, la mayoría graves, por lo tanto, el enfrentamiento es el ABC (por definición es una urgencia).

Se deben tomar muchos exámenes, **el primero es el HGT** y habitualmente una neuroimagen.

Después pedir exámenes generales.

La escala de Glasgow es para cuantificar el estado de conciencia. Recordar que menos de 8 se debe intubar para proteger la vía aérea.

El compromiso de conciencia puede ser cualitativo (desorientación, inatención) o cuantitativo (sopor superficial – Sopor profundo – Coma).

Apraxia y Agnosia

Apraxia → Quiere hacer algo pero no puede

Agnosia → Percibe pero no entienden. No procesa aquello que está sintiendo.

Las apraxias y agnosias tienen múltiples causas (demencias, ACV y cualquier lesión cerebral)

Manejo: Son solo un síntoma, por lo cual, hay que buscar y tratar la causa

Afasia: Alteración del lenguaje

- Broca: Motora o de expresión No puede hablar ni escribir, pero entiende y lee sin problemas

- Wernicke: Sensitiva o de comprensión. No puede entender lo que escucha, no puede leer, pero si puede hablar y escribir.
- Conducción: Mezcla de ambas, pero las personas pueden repetir
- Mixta: Mezcla de sensitiva y motora pero no puede repetir

La sensitiva y motora son alteraciones del corteza cerebral, mientras que la de conducción y mixta son de las fibras que unen ambas cortezas (Broca y Wernicke)

Disartria: Articula mal (como ebrio)

Dislexia: Dificultad del aprendizaje (confunde las letras)

Disgrafía: Trastorno del aprendizaje para escribir

Dislalia: Pronuncia mal

Disfemia: Tartamudez

9. Accidente vascular encefálico

Causas:

Isquémico → Por embolias (generalmente por FA) o trombóticos (los más comunes son los lacunares asociados a HTA).

Hemorrágico → El mas común es asociado a HTA (por aneurisma de las arterias perforantes).

Diagnostico de los ACV es solo con clínica → Signos focales de inicio súbito. De todas formas se pide un TAC sin contraste, pero esto es para poder diferenciar un ACV isquémico (se observa un área hipodensa, pero podría incluso estar normal) de uno hemorrágico.

Manejo ACV isquémico:

1. Medidas de neuroprotección
 - a. O₂ (Para saturar >94%)
 - b. Anticonvulsivantes SOS
 - c. Mantener temperatura normal
 - d. Mantener normoglicemia (bajo 200)
 - e. Presión arterial debe estar bajo 220/120 (Captopril SL o Labetalol Ev SOS)
2. Aspirina 325mg (sirve poco)
3. Heparina (pero nunca dentro de las primeras 48 hrs por riesgo de conversión de ACV hemorrágico)
4. Trombolisis, es la medida más importante. Se debe hacer con rTPA 10UI EV (no dar estreptoquinasa, esta sirve para el IAM, no para ACV). La trombolisis se debe realizar dentro de la ventana de trombolisis, es decir, dentro de las primeras 4,5 horas de iniciado los síntomas.
5. Quirúrgico: solo si hay enclavamiento

Manejo ACV hemorrágico

1. Medida de neuroprotección → Iguales a las del ACV isquémico, salvo que mis limites de PA son más bajos (180/110).
2. Qx solo si enclavamiento

Clínicas específicas:

- **ACA (Arteria cerebral Anterior)→** Lo fundamental es que viene con hemiparesia y puede venir también con hemihipoestesia, ambos de predominio crural y contralateral. Además se acompaña de desorientación y mutismo aquinético. Estas cosas nos indican afectación del lóbulo frontal.
- **ACP (arteria cerebral posterior)→** Lo fundamental es que viene con hemihipoestesia y puede venir también con hemiparesia, ambos de predominio crural y contralateral (al revés que ACA). Presentan también defectos en el campo visual debido a la afectación del lóbulo occipital.
- **ACM (Arteria cerebral media)→** Es la más comúnmente afectada y la más grave. Viene con hemiparesia que suele ser mas fuerte que la hemihipoestesia. En este caso es de predominio fasciobraquial. Es contralateral igual que en las otras.
- **AVB (Arteria Vertebrobasilar)→** Irriga al cerebelo y TE, su clínica es afectación de estos órganos (Cefalea, vértigo, ataxia, debilidad, estrabismo y Disfagia) de inicio agudo.
- **Síndrome alterno→** Es debido a un AVE del tronco encefálico. Se afecta un par craneano ipsilateral + hemiparesia o hemihipoestesia contralateral
- **Disección carotidea→** El síntoma mas importante es el dolor cervical asociado a cefalea súbita en trueno además de clínica de ACV de ACM y ACA. Suele estar asociado al antecedente de un ejercicio de elongación cervical
- **Disección Vertebrobasilar→** Es igual (Dolor cervical + cefalea), pero la clínica de ACV en este caso es de ACP o tronco encefálico. Suele estar asociado al antecedente de un ejercicio de elongación cervical

TIA→ Tiene clínica de un ACV, pero se resuelve antes de 24 hrs (generalmente dentro de la primera hora). El manejo es igual al ACV isquémico, solo que sin trombolisis. Es fundamental hacer el estudio de la fuente embolica, el cual, se hace con:

1. Ecodoppler de carótidas
2. ECG (buscar infarto antiguo)
3. Holter de arritmias (pensando en FA).

Este estudio de fuente embolica también se debe hacer ante cualquier ACV isquémico

10. Cefalea

Tiene múltiples causas, la clínica es fundamental para determinar las causas de la cefalea. Es importante buscar signos de alarma para descartar enfermedades graves

Si no hay signos de alarma simplemente se debe dar tratamiento sintomático y etiológico si es que lo hay.

1. Cefaleas agudas

- Hemorragia subaracnoidea (HSA)

Cefalea de inicio súbito (como golpe en la cabeza) que alcanza la intensidad máxima (10/10) dentro del primer minuto. Puede tener signos de HTE. Podrían haber signos meníngeos y convulsiones a medida que pasa el tiempo. La primera causa es traumática, puede ser también por aneurismas. El dg es con TAC s/c. cuando han pasado muchas horas el TCA pierde sensibilidad. Por lo tanto, si el TAC

esta normal pero la clínica sugiere HSA, se debe hacer una PL (se buscan Glóbulos rojos crenados o xantocromía (color amarillento)). El Tto es igual al ACV hemorrágico

- **AVE hemorrágico**

Se sospecha por dolor súbito o rápido (menos rápido que la HSA) con signos de HTE asociado a signos focales (la HSA no focaliza).

- **Meningitis bacteriana aguda (MBA)**

Cefalea con fiebre, signos meníngeos, convulsiones (a veces)

- **Tumor cerebral**

Cefalea de inicio subagudo que tiene una triada caracterizada por HTE, signos focales y convulsiones focales. Conducta: neuroimagen (TAC c/c o RNM ojalá) y luego QT, RT o Qx (especialista). Se Puede dar nimodipino (si, existe) para evitar el vasoespamo.

- **Absceso cerebral**

Igual que el Tumor cerebral pero viene además con fiebre

- **Síndrome de hipertensión endocraneana (HTE)**

Triada clásica de cefalea holocránea mayor en las mañanas, náuseas/vómitos, y edema de papila en el fondo de ojo (clínicamente se presenta como disminución de la agudeza visual, pero generalmente solo podemos objetivarlo con el FO). Se debe pedir neuroimagen para buscar la causa.

2. Cefalea crónica

El diagnóstico es absolutamente clínico, no requieren de TAC a menos que hay signos de alarma (cambio en la clínica es uno de esos signos)

- **Jaqueca, migraña o cefalea vascular**

De tipo pulsátil u opresiva en la región frontoparietal retroocular con sonofobia o fotofobia. Puede tener aura (el clásico es el escotoma centellante) que puede aparecer antes de la cefalea (lo mas común) o durante la migraña.

- **Cefalea tensional**

De carácter opresivo occipital o en cintillo, suele irradiarse a los músculos del cuello.

- **Cefalea en racimo, Cluster o síndrome de Horton**

Se caracteriza por dolor muy intenso lacinante de ubicación periocular o en otro lado de la cabeza, pero siempre unilateral. Puede asociarse a miosis del ojo, ojo rojo superficial, Ptosis, epifora y rinorrea. (no confundirlo con glaucoma agudo)

- **Neuralgia del trigémino**

Dolor de tipo eléctrico que puede desencadenarse al tocar la cara. El trigémino tiene 3 ramas, por lo tanto, puede afectar una o mas rama (las tres incluso). Las neuralgias pueden ser primarias o secundarias. La diferencia la da el examen neurológico. Si está normal es primaria, pero si está anormal (hipoestesia, alteración del reflejo corneal o debilidad de la masticación) es secundaria.

- **Status migrañoso**

Jaqueca que no responde al tratamiento tradicional. Se debe evitar ruidos y luz. Los AINEs son los fármacos de elección y los serotoninérgicos como los triptanes y las ergotamínicos (ergotamina). Si tras esto no responde se puede escalar a metoclopramida y dexametasona. Si tras esta 3ª línea sigue sin responder, podemos aplicar sedación con opioides, BDZ o barbitúricos.

- **Cefalea por ergotamínicos**

Cuando se abusa de este fármaco se genera un efecto rebote por el mismo uso de este fármaco. Se debe dar tto sintomático con otros analgésicos y evitar ergotamina

Tratamiento:

Existe tratamiento para la crisis como profiláctico para nuevas crisis

Cefalea tensional

- Crisis: PCT y AINES.
- Profiláctico (mas de 2 a las semana): Ac valproico, flunarizina o antidepresivos tricíclicos

Migraña:

- Crisis: Triptanes y ergotamínicos (no es de 1ª línea por su efecto rebote, máximo 2 veces ala semana por esto mismo)
- Profiláctico(mas de 2 al mes, es muy invalidante): Ac valproico, flunarizina o antidepresivos tricíclicos + propranolol)

Cluster

Crisis: Oxígeno al 100% y triptanes por vía subcutánea.

Profiláctico: Corticoides (no más de 3 semanas) y verapamilo cuando es mas allá de 3 semanas. Se debe abstener del consumo de alcohol porque este puede ser un gatillante

Neuralgia: carbamazepina u otro anticonvulsivante. Si no funciona o es alérgico se puede dar pregabalina o gabapentina.

11. ELA y Esclerosis múltiple

Ambas son enfermedades degenerativas

ELA

Se degenera el asta anterior de la médula donde sinapta la 1ª con la 2ª motoneurona, por lo cual, la enfermedad será un mix de ambos síndromes (totalmente motor, sin síntomas sensitivos). El pronóstico es pésimo (90% vive 3-5 años, casos excepcionales viven más como Stephen Hawking) El diagnostico es totalmente clínico, pero se hacen exámenes para descartar otras enfermedades, dado el pésimo pronóstico que tiene esta enfermedad. NO EXISTE TRATAMIENTO, solo soporte.

Síndrome de 1ª motoneurona (síndrome piramidal)

- Aumento del tono
- Aumento de los ROT
- Clonus
- Babinsky (+)

Síndrome de 2ª motoneurona(Síndrome de denervación)

- Hipotonía
- Hiporreflexia
- Fasciculaciones
- Atrofia (más marcada que en la 1ª motoneurona)

La ELA entonces es un mix de ambos síndromes (hipertonía, hiperreflexia atonía y fascinaciones es lo más clásico). Es solo motor y progresivo.

Esclerosis múltiple

Enfermedad autoinmune debido a una desmielinización del SNC y el nervio óptico. Siempre afecta la sustancia blanca, no la gris. La clínica va a estar dada por signos focales que aparecen de forma subaguda y aumentan progresivamente.

EL diagnostico es mediante RNM donde se observan focos de desmielinización. La PL muestra aumento oligoclonal de inmunoglobulinas, pero solo con RNM estamos para el diagnóstico.

Tratamiento

Crisis→ Corticoides EV

Inter crisis→ Interferón (cubierto por GES)

12. Epilepsia, , crisis convulsivas, convulsiones febriles y estatus convulsivo.

Crisis convulsiva

Se dividen en tipo focal y generalizada. Las focales, a su vez, pueden ser motoras, sensitivas o psicomotoras.

Estas además se dividen en parcial simple (no pierde conexión con el mundo) o parcial compleja (en algún minuto se compromete de conciencia) (desactualizado, según la ILAE desde el 2017 se llaman crisis FOCALES, no parciales y no se dividen en simples o complejas, solo en sin/con compromiso de conciencia, s)

Generalizada

- Tónico-clónica
- Mioclónica
- Tónica
- Atónica
- Ausencia

Si la convulsión inicia focal y se convierte a generalizada, se considera como focal.

Manejo de una crisis focal→ Se asume que es por una lesión focal (tumor, ACV, etc.). Se pide una neuroimagen y luego de haber encontrado la causa se debe tratar la causa y se dejan anticonvulsivante (carbamazepina y fenitoina).

Manejo de una crisis generalizada→ Las causas más comunes son las epilepsia y alteraciones toxico-metabólicas, por lo tanto, se piden exámenes generales buscándolas (hiponatremia, hipoglicemia) + EEG.

Los anticonvulsivantes que se dejan en este caso con el ácido valproico, lamotrigina y fenitoina

¿Como diferenciamos una crisis convulsiva atónica de un síncope?

La crisis tónica tiene compromiso de esfínter

Epilepsia primaria: Generalmente de causa genética. El diagnóstico es clínico con 2 crisis estereotipadas sin gatillante específico o con una sola crisis con EEG característico.

En el caso de que solo haya tenido una convulsión se diagnostica primoconvulsión. Si esta no tiene una causa que lo explique se asume que es una epilepsia y se trata como tal (anticonvulsivantes idealmente con monoterapia y ajustado a niveles plasmáticos).

Convulsiones febriles

Convulsiones benigna → Son las más comunes. Si esta en BEG y tiene entre 5 meses y 6 años, simplemente se debe educar y tranquilizar. Re consultar SOS

En caso de que el niño este muy séptico y se sospeche de una meningitis bacteriana se debe hacer una PL (post TAC descartando HTE)

Manejo → Educar + antipiréticos para evitar fiebre. Si es recurrente se deja Diazepam para cuando este con fiebre. En caso de que este convulsionando, se da lorazepam 0,1mg por kilo.

Status convulsivo

Convulsiones de 30 o más minutos sin recuperación ad integrum entre crisis (descartado, son más de 5 minutos)

El manejo se inicia antes de cumplir los 30 minutos (a los 5 minutos). Se debe dar lorazepam Ev 4mg Ev (adultos) o 0,1mg/kg en niños, más una carga de fenitoina para evitar que vuelva a caer en otra convulsión.

Si esto no funciona se dan barbitúricos. Como última línea se dan anestésicos generales.

13. Polineuropatías, neuroalgias y neuropatías por atrapamiento

Polineuropatías

Afectación de distintos nervios. La causa más común es la diabetes (por lejos), pero también hay otras causas como déficit de B12, autoinmune.

La clínica va a estar dada por disminución de la sensibilidad, aunque también puede afectar la parte motora. La sensibilidad más afectada es la termoalgia, vibratoria y la propioceptiva.

Habitualmente es de ubicación distal y suele ser en guante y calcetín. Puede haber debilidad distal. Se puede asociar también dolor de tipo neuropático (urente, alodinia e hiperalgesia)

Tratamiento

Lo más importante es tratar la causa y en segundo lugar cuidar los pies, dado que, va a sentir menos y puede hacerse lesiones graves en los pies.

Neuralgias

El diagnóstico es totalmente clínico dado por dolor agudo muy intenso en ramalazo (urente) que sigue la distribución del nervio.

Se dividen en primarias o idiopáticas y secundarias. La diferencia la da el examen neurológico. Si esta normal es primaria, pero si hay alteraciones (hipoestesia, alteración de reflejos) es secundaria.

Las primarias se tratan con antidepresivos tricíclicos, carbamazepina, pregabalina o gabapentina.

La secundaria se debe buscar la causa y se estudia con neuroimagen.

Ej: Neuralgia post herpética.

→ Neuralgia que es precedida por un herpes zoster. En las primeras 48 horas del herpes zoster se debe dar antivirales para evitar esta complicación (neuralgia). El tratamiento mismo de la neuralgia es con antidepresivos tricíclicos, carbamazepina, pregabalina o gabapentina

Neuropatía por atrapamiento

La clínica es lo más importante. Suelen haber parestesias y paresia mas alteraciones de los reflejos que siguen la distribución de un nervio.

El estudio es con electromiografía y se tratan generalmente con cirugía para liberación del atrapamiento nervioso

Síndrome de túnel carpiano → Afecta del dedo 1 al 4 (de este ultimo solo la mitad más cercana al pulgar) y hay debilidad para la flexión de los primeros 3 dedos. Se asocia a embarazo, hipotiroidismo, DM2 y Artritis reumatoide.

Atrapamiento cubital → Afecta al 4º y 5º dedo (el lado cubital del 4º dedo) y el resto de la clínica igual al túnel carpiano

Meralgia parestésica → Se afecta el femorcutáneo que inerva la cara lateral del muslo. Se asocia a obesidad

Neuropatías por compresión

Parálisis por borracho → Se duerme sobre el brazo y se afecta el nervio radial, se traducen no poder extender muñeca ni dedos además de afectación del reflejo tricipital.

Parálisis de la luna de miel → La pareja se duerme sobre el hombro del paciente y afecta el plexo braquial. Se despierta con toda la EESS “muerta” y con hipoestesia.

14. Síndromes Motores

Primero debemos diferenciar las alteraciones producidas por enfermedades de la 1ª v/s la 2ª motoneurona (hacen sinapsis en el asta anterior de la médula)

1ª motoneurona (síndrome piramidal)

Causas:

- AVE
- Esclerosis múltiple
- Lesión (sección) medular

Clínica

- Aumento del tono
 - Aumento de los ROT
 - Clonus
 - Babinsky (+)
- En agudo puede presentarse con hipotonía y arreflexia

2ª motoneurona (síndrome de denervación)

Causas

- Desmielinización (Guillain Barre)
- Polineuropatías
- Mononeuropatías múltiples (asociado a vasculitis de vaso pequeño)

Clínica

- Hipotonía
- Hiporreflexia
- Fasciculaciones
- Atrofia (más marcada que en la 1ª motoneurona)

Miopatías

Polimialgia reumática, polimiositis, distrofia muscular de Duchenne

Las miopatías tienen debilidad de tipo proximal y no hay atrofia

En las neuropatías son de predominio distal, presentan atrofia y presentan alteraciones sensitivas

Proximal/distal y atrofia o no son las principales características

Miastenia Gravis → Debilidad fluctuante con afectación de los ojos (músculos que más se ocupan).

Nunca afecta al sistema nervioso autónomo, solo afecta a los músculos voluntarios. Empeora con las repeticiones y se puede asociar a un timoma

Es una enfermedad autoinmune

Síndrome de Guillain Barré

Enfermedad desmielinizante que afecta al Nervio periférico. Enfermedad autoinmune de curso agudo y que suele mejorarse. Suelen venir precedida por infecciones, generalmente por diarrea por *Campylobacter jejuni*.

La clínica es motora (lo más importante) y sensitiva.

Hay debilidad progresiva, presenta arreflexia e hipotonía generalizada (**tetraparesia flácida arrefléctica**)

La clínica sensitiva puede venir con dolor o hipoestesia (asociado a los síntomas motores)

El diagnóstico es clínico, pero podemos apoyarnos en EEG y PL (disociación albumino citológica, es decir, hay hiperproteinorraquia pero no hay pleocitosis)

El tratamiento es con plasmaféresis o la inmunoglobulina G además del soporte

Mielitis Transversa

Es una enfermedad autoinmune. Tiene clínica de sección medular. Da paraplejia si es bajo T1 y tetraplejia si es sobre este nivel. Presenta nivel sensitivo, afecta los esfínteres (Guillain Barré usualmente no lo hace) y produce dolor dorsal (por la inflamación de las meninges en la médula).

El diagnóstico es con RNM que va a mostrar la inflamación de la médula en esa zona además de ver otras causas como tumor o infarto.

El tratamiento es con corticoides. Es un síndrome de 1ª motoneurona, pero recordemos que los síndromes piramidales pueden venir con hipotonía y arreflexia en un principio y así podríamos confundirlo con Guillain Barré.

15. Temblor y síndromes extrapiramidales

Temblor

Temblor esencial (el mas frecuente)

Es bilateral y aumenta al tomar objetos o adoptar posturas

El dg es clínico. El tratamiento de ser muy intenso el temblor es el propranolol

Enfermedad de Parkinson

Es un temblor de reposo habitualmente asimétrico

Disminuye al tomar objetos o adoptar posturas. Se caracteriza por bradicinesia (movimientos lentos) y rigidez en rueda dentada (**TEMBLOR, RIGIDEZ Y BRADICINESIA ES LA TRIADA CLÁSICA**). Aparecen movimientos involuntarios anormales y disminuyen los movimientos involuntarios normales, es decir, hay temblor y disminuye el pestañeo, braceo y hay hipomimia

El diagnóstico es clínico y el tratamiento es con agonistas dopaminérgicos como levodopa o carbidopa. Al final de la enfermedad puede aparecer demencia (distinto si parto con la demencia, ahí es enfermedad por cuerpos de Lewy)

Síndrome cerebeloso

Temblor de intención, hay adiadocinesia (no se puede hacer movimientos alternantes) y ataxia (dificultad para caminar). Las lesiones en el cerebelo dan alteraciones ipsilaterales.

Su diagnóstico también es clínico, pero hay que pedir neuroimagen para determinar la causa.

El tratamiento es en base a la causa.

Extrapiramidalismo

El sistema extrapiramidal coordina los movimientos. Las causa es por enfermedades degenerativas o por fármacos antidopaminérgicos (antipsicótico y antieméticos) principalmente.

Parkinsonismo → temblor de reposo + bradicinesia+ rigidez

Coreas → Movimientos involuntarios como un baile, generalmente los brazos

Distonias → Contractura muscular dolorosa. La clásica es la torticollis espasmódica clásica de los médicos (¿?) en que se les flexa la mano y no pueden escribir bien a mano. Es frecuente luego de iniciar o subir dosis de antipsicóticos. El tto es con BDZ y suspender fármaco causante además de escribir a computador.

Disquinesia Tardía → Movimientos reptantes de boca y lengua que aparecen varios años posterior a haber iniciado el tratamiento antipsicótico. Se deben suspender los antipsicóticos. El pronóstico es malo porque no se recupera. Los otros se recuperan tras suspender el fármaco.

Balismo → Movimientos súbitos en la zona proximal

Acatisia → Inquietud y disestesias en las extremidades. Son movimientos voluntarios. Es común luego de antipsicóticos aunque también puede presentarse después de antidepresivos. Se puede suspender el fármaco o dejar BDZ. Transitorio y de buen pronóstico

Síndrome neuroléptico maligno → Triada clásica de hipertensión, hipertermia y compromiso de conciencia. Frecuente luego de dar un antipsicótico. Las medidas físicas y BDZ sirven para tratarlo

además del dantroleno que es el antídoto. Obviamente se debe suspender el antipsicótico que produjo el problema.

16. Meningitis

Tema muy preguntado

Clínica

- cefalea
- Náuseas
- Vómitos
- Fiebre
- Signos meníngeos (rigidez de nuca, Kernig y Brudzinski)

Se debe pedir TAC de cerebro para descartar HTEC y una vez descartada esta se hace una PL
La PL me hace el diagnóstico y diferencia entre las distintas etiologías

Ante la duda, se trata como si fuera bacteriana (en caso de que no haya TAC, si existe HTEC o tenemos una PL con líquido intermedio)

	Bacteriana	Viral	TBC	Normal
Glucosa	↓	N	↓	>40mg/dl
Tipo de células	PMN	MN	MN	-
No células	>1000	>10	>100	<10/mm ³
Proteína	>100	>40	>100	<40mg/dl

Tratamiento MBA

- Antibióticos → empíricos, van a depender de la edad de paciente
 - RN
 - Cefotaxima + ampicilina
 - Niños
 - Ceftriaxona + Vancomicina (para neumococo resistente)
 - Adultos
 - Ceftriaxona + Vancomicina (opcional)
 - Adulto mayor y embarazada
 - Ceftriaxona + ampicilina (para cubrir listeria)

- Corticoides → Útiles en infecciones pediátricas producidas por neumococo y Hib, pero se da para todos

La ceftriaxona cubre: Neumococo (el mas frecuente), Meningococo (2º mas frecuente), Hib y E. coli

Neumococo → Diplococo gram (+) en cadena corta. Responde a ceftriaxona

Meningococo → Diplococo gram (-). Responde a ceftriaxona o penicilina

Hib → Cocobacilo gram (-). Responde a ceftriaxona

E. coli → Bacilo gram (-), se trata con ceftriaxona

Listeria → Bacilo gram (+), se trata con ampicilina

ESTO SE PREGUNTA



Manejo de contactos

Hib → Rifampicina por 4 días (20mg/kg/día)

Meningococo → Rifampicina (20mg/kg/día), ciprofloxacino o ceftriaxona o 500mg dosis única

Encefalitis viral

Clínica muy similar a la MBA

Causado por enterovirus generalmente

Tratamiento → Paracetamol



El problema es en caso de ser por VHS 1 o 2 se puede producir una encefalitis herpética.

Se trata con aciclovir Ev, ante la mera sospecha se debe iniciar tratamiento

Se confirma con PCR de LCR

Que me hace sospechar encefalitis por VHS?

- Clínica grave (desorientación, convulsión, compromiso de conciencia)
- Afecta más adultos jóvenes y adolescentes
- Lesiones temporales en el TAC
- LCR con sangre (xantocromía o GR cromados)

17. Lumbago, Cervicalgia, hombro doloroso, codo doloroso, tendinitis, bursitis y fibromialgia

Se preguntan en su clínica

Lumbago

Causas

- Mecánico es lo más frecuente. Se debe a una debilidad de la musculatura lumbar. Dg es clínico y se trata con AINEs, calor local y Kine para fortalecer CORE.

Signos de alarma → Si están presentes se debe solicitar una RNM. De no estar presentes se sigue el tto anteriormente mencionado

- **Fractura**
 - Osteoporosis
 - Corticoides
 - Adulto Mayor
 - Caída o trauma
- **Cáncer**
 - Antecedente de cáncer
 - Síntomas B
- **Clínica de enfermedad reumatológica**
 - Aumenta con reposo y disminuye con ejercicio
 - Entesitis
 - Uveítis
 - Rigidez matinal
- **Infección**
 - Fiebre
-
- **Afectación neurológica**
 - Disminución de fuerza
 - Disminución de sensibilidad
 - Alteración de los ROT (**irradiación del dolor no es Red Flag**)
- **Duración mayor a 6 semanas**

Lumbociática

Dolor lumbar irradiado EEII

El manejo es igual al lumbago mecánico (Analgesia, calor y Kine)

Se indica RNM en caso de compromiso neurológico o si no responde a tratamiento

Dorsalgia, Cervicalgia y cervicobraquialgia

Se manejan igual que un lumbago.

Hombro doloroso

Síndrome de manguito rotador es la causa clásica

- Dolor aumenta con movimiento repetitivos
- Aumenta en la noche

- Aumenta ante la abducción y extensión contra resistencia
Diagnóstico es clínico, pero se pide Ecografía para determinar la causa

Manejo

Reposo, AINEs y Kine motora

Solo se opera si el tendón está muy malo y no responde a tratamiento médico

Hombro congelado

Dolor impide la movilización tanto activa como pasiva, lo cual, lleva a la anquilosis (en esta etapa sin dolor)

Diagnóstico es clínico

Tratamiento→ Corticoides + KNT y en ultima instancia podría llegar a Cirugí

Codo Doloroso

Epicondilitis o Epicondilitis lateral o codo del tenista→ Duele la zona de inserción de los extensores del codo.

Tratamiento→ Reposo, AINEs y Kine + Epicondilera

Epitrocleitis o Epicondilitis medial codo del golfista → Duele la zona de inserción de los flexores del codo

Tratamiento→ Reposo, AINEs y Kine + Epicondilera

Tendinitis tricipital→ Duele inserción del tríceps

Tendinitis→ Dolor a la elongación y palpación de un tendón debido a movimientos repetitivos.

T. Pata de ganso→ Cara medial

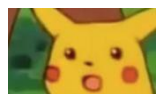
T. Rotuliana→ Cara anterior

T. Fascia lata o Sd de la banda iliotibial o tendinitis del trotador → Cara lateral

T. de Quervain→Cara lateral de muñeca

T tricipital→ Dolor sobre olecranon

Tratamiento→ Reposo relativo, AINEs+ KNT. Si se llega a pedir imagen se pide una Eco



Bursitis→ Inflamación de una bursa. Se presentan como dolor, **eritema y aumento de volumen** de la bursa.

La clásica es la bursitis olecraneana, peritrocantérica y rotuliana.

Tratamiento→ AINEs + Calor/frío local



- Fibromialgia

Diagnostico es clínico

Dolor a la compresión de puntos gatillo (masas musculares), astenia

Suele estar asociado a otros trastornos somatomorfos como SII.

Tratamiento→ Ejercicio + moduladores del dolor (pregabalina, gabapentina o Tricíclicos)

Si VHS aumentada pensamos en Polimialgia reumática
Si CK elevada pensamos en Polimiositis o Polimialgia reumática

Traumatología y carpintería humana

Son 5 preguntas fáciles

1. Generalidades de fracturas

Clínica

- Dolor
- Desviación de ejes
- Equimosis
- Aumento de volumen
- Crépitos óseos

Diagnostico → Radiografías

Tratamiento → Ortopédico o quirúrgico.

Indicaciones quirúrgicas generales de fracturas

- Fracturas expuestas (requiere buen aseo quirúrgico por riesgo de osteomielitis)
- Fracturas intraarticulares (por riesgo de evolución a artrosis)
- Fracturas muy desplazadas (por riesgo de no unión o pseudoartrosis)
- Fracturas conminutas (riesgo de no unión o mala unión)
- Segmentaria (Queda un segmento entremedio que es móvil, también tiene riesgo de no unión o mala unión)

2. Fracturas expuestas

Se pregunta siempre

Clínica → Fractura mas herida en la cual el hueso tiene contacto con el exterior

Diagnostico → Clínico + radiológico

Riesgo → Infección y progreso a osteomielitis

ES UNA URGENCIA NO DERIVABLE

Tratamiento → Para evitar la infección

1. ABC
2. Aseo con suero fisiológico (3-10 litros) a chorro.
3. ATB Ev. Depende del grado.
 - a. Grado I → Cefazolina
 - b. Grado II → Cefazolina + gentamicina
 - c. Grado IIIC → Cefazolina + gentamicina + Clindamicina
4. Analgesia
5. Vacunación antitetánica

6. Traslado para realizar Cirugía → Inmovilizar con valvas largas. NO SE DEBE SUTURAR, solo cubrir con apósitos estériles

Clasificación Gustilo y Anderson			
I	< 1 cm	Baja energía Mínima contaminación	
II	> 1 cm	Moderada energía	
III	> 10 cm Sucia Bala Catástrofe	A	Partes blandas OK
		B	Partes blandas mal
		C	Sección neurovascular

3. Complicaciones de las fracturas

Se pregunta siempre (2-3 preguntas)

Distrofia simpático Refleja (síndrome de dolor regional complejo o Sd de Südeck)

Clínica → Aparece semanas a meses después de la Fx

- **Dolor neuropático** muy intenso de tipo urente con alodinia e hiperalgesia
- Aumenta con movilidad distal (como el Sd compartimental)
- Edema
- Eritema
- **Cambios tróficos de piel y fanéreos** (uñas gruesas o delgadas, piel puede cambiar de color poner delgada o gruesa y puede aumentar o disminuir la cantidad de vello)
- **Osteoporosis moteada** (lesiones en sacabocado)

Causa → No se sabe. Se cree que hay interacción de las fibras del dolor con las del sistema nervioso simpático y esto podría causarlo



Diagnóstico → Clínico

Manejo → Mejorar analgesia + moduladores del dolor (pregabalina, gabapentina y Antidepresivos Tricíclicos)

Retracción isquémica de Volkman

Clínica → Aparece semanas a meses después

- Asociado a Fx de EESS (supracondilea de húmero generalmente)
- Retracción de la extremidad (mano en garra)



Diagnóstico → Clínico

Conducta → KNT para recuperar la movilidad. Si esto no funciona se hace cirugía.

Síndrome compartimental

Es el que se pregunta con mayor frecuencia

Clínica→ Minutos a horas posterior a la fractura

- Dolor punzante de gran intensidad
- Aumenta con la movilidad distal
- Edema
- Disminución de pulsos

Diagnóstico→ Clínico (se puede medir la presión dentro del compartimento si tengo la duda)

Manejo→ Retirar yeso, elevar extremidad y pasar a fasciotomía amplia

TVP

Clínica→ Días después de la Fx

- Dolor que aumenta al palpar las masas musculares
- Edema
- Signo de Hommans
- Eritema/cianosis

Diagnóstico→ Eco-doppler de EEII

Manejo→ Anticoagulación por mínimo 3 meses.

Ante contraindicación de anticoagulación, se instala filtro de vena cava

TEP

Clínica→ Días después, se produce debido a la TVP

- Disnea/dolor torácico de inicio súbito
- Desaturación
- Derrame pleural
- Fiebre
- Hemoptisis
- Síncopes

Diagnóstico→ Angio TAC de tórax. NO NOS SIRVE EL DÍMERO D (La misma fractura lo eleva)

Manejo→ Anticoagulación por 6 meses

Ante contraindicación de anticoagulación, se instala filtro de vena cava

El TEP masivo es aquel con compromiso hemodinámico. Se estudia con ecocardio y se maneja con trombolisis.

Embolia Grasa

Clínica→ Aparece a las horas de la fractura

- Distress respiratorio (EPA no cardiogénico)
- Compromiso de conciencia
- Rash petequial

Se asocia a fracturas de huesos largos

Diagnóstico→ Clínico

Manejo→ Soporte, ningún fármaco ha demostrado utilidad.

Complicación grave que evoluciona a muerte o daño cerebral.



Lesiones nerviosas

Clínica→ Inmediata

- Déficit neurológico
 - o Paresia o plejia
 - o Hipo o anestesia
- Arreflexia (en caso de participar en un reflejo)

Diagnóstico→ Clínico (se pregunta siempre)

Pronóstico→ Depende del tipo de lesión

Neuroapraxia→ Nervio quedó atontado, pero no se cortó. En cosa de horas/días se mejora el déficit.

Axonotmesis→ Se cortan los axones, pero aun queda la vaina de mielina. Demora semanas en recuperarse

Neurotmesis→ Se cortaron los axones y la vaina de mielina. El déficit queda de forma permanente, por lo cual, requiere de reparación quirúrgica si se quiere intentar resolver el déficit.

Tratamiento→ Desde la observación hasta la cirugía

Lesión del nervio radial

Se da en contexto de una fractura de la diáfisis humeral

Clínica→ Imposibilidad de extender dedos y muñeca con disminución de la sensibilidad de la cara posterior de la EESS

Lesión del nervio axilar/circunflejo

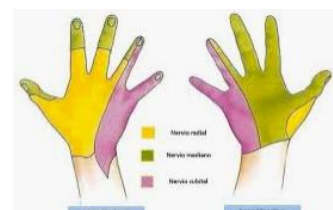
Asociado a luxación anterior de hombro

Clínica→ Imposibilidad de abducir el hombro (inerva el deltoides) y disminución de la sensibilidad de la región delotidea

Lesión del Nervio mediano

Asociado a fractura supracondilea de húmero

Clínica→ Imposibilidad de flexar dedos 1-3 con disminución de la sensibilidad de los dedos 1-4.



Lesión del nervio cubital

Asociado a fractura de codo

Clínica→ Imposibilidad de flexionar y disminución de la sensibilidad en el 4º y 5º dedo

Lesión del nervio ciático

Se asocia a luxación posterior de cadera

Clínica→ Imposibilidad de flexionar EEII asociado a disminución de la sensibilidad del pie, pierna y cara posterior del muslo. Se observa disminución del reflejo aquiliano (S1).

Parálisis del borracho

Se duerme sobre el brazo y se afecta el nervio radial, se traducen no poder extender muñeca ni dedos además de afectación del reflejo tricipital.

Parálisis de la luna de miel

La pareja se duerme sobre el hombro del paciente y afecta el plexo braquial. Se despierta con toda la EESS “muerta” y con hipoestesia.

Lesiones Vasculares

Clínica

- Oclusión → 6P
 - Palidez
 - Paresia
 - Parestesia
 - Pulso ausente
 - Poiquiloterapia
 - Pain

En caso de oclusión (6P) sin hemorragia, se debe realizar desobstrucción o reparación quirúrgica. La heparina se puede administrar en caso de que no esté sangrando.

- Hemorragia→ Pulsátil de ser arterial

Diagnóstico→ Clínico

Manejo

1. Compresión
2. Cirugía

Torniquete→ NUNCA (aumenta el daño isquémico). Se comprimen, nunca se hace torniquete.



Retraso de consolidación

Clínica→ Dolor persiste por más tiempo de lo normal

Causa→ Inadecuada inmovilización. AINEs pueden agravarla (por disminución del flujo sanguíneo)

Diagnóstico→ Clínico + Rx (muestra callo óseo en maduración)

Manejo→ Mejorar inmovilización y reemplazo de AINEs

Pseudoartrosis o no unión

Clínica→ Movilidad anormal en el foco de fractura. No duele o duele muy poco. Se interponen partes blandas entre ambos focos, esto ya no consolida.

Causas

- Hipertrófica→ Por mala inmovilización
- Atrófica→ Por mala irrigación

Diagnóstico → Clínico + Rx (se interponen partes blandas entre extremos del hueso, los cuales, se ven hipertróficos (pata de elefante) o atróficos.

Manejo→ Quirúrgico, se deben remover las partes blandas interpuestas. Además, se debe tratar la causa



Pseudoartrosis de tipo hipertrófica (pata de elefante)

Consolidación viciosa o mala unión

Clínica→ Consolidación con desviación. NO hay dolor

Causa

- Mala inmovilización
- Mala reducción

Diagnostico→ Rx



Manejo→ Cirugía, se debe refracturar para luego inmovilizar adecuadamente



	Clínica	Rx	Tto
Retardo Cons.	Dolor persiste	Callo óseo	Inmov. ¿\$ AINEs?
No unión	Movilidad Sin dolor	PB se interponen	Qx (PB remover)
Mala unión	Desviación Sin dolor	Consolidó desviado	Qx ReFx

4. Politraumatismo y fractura de pelvis

Se pregunta con cierta frecuencia

Politraumatismo

Trauma de al menos 3 sistemas

Causa → Accidentes de tránsito y caídas de altura son las más prevalentes.

Diagnóstico → Clínico

Radiografías mínimas → Lateral de cuello, AP de tórax y AP de pelvis.

Tratamiento → ABC + manejo de complicaciones

ABC

A → Mantener vía aérea permeable + instalación de collar cervical

B → Hay que asegurar de que el paciente ventile

C → Instalar 2 vías venosas gruesas y administrar cristaloides + compresión de las heridas

D → Déficit neurológico. Se debe hacer un examen neurológico completo para asegurarnos de que no hay compromiso neurológico

E → Exposición, desvestir al paciente para asegurarnos de que no haya lesiones bajo la ropa.

Fractura de pelvis

Causa → Accidentes de tránsito y caídas de altura son las más prevalentes. Se maneja igual que un politraumatizado.

Siempre hacer TR y tacto vaginal por riesgo de fractura expuesta hacia estas cavidades sépticas

Diagnostico → Rx AP de pelvis

Manejo → ABC + manejo de complicaciones

Complicaciones

1. Shock hipovolémico → Por lesiones de las **venas** pélvicas. Se maneja con ABC + estabilización externa de la pelvis. Se puede hacer con férula neumática, tutor externo, hamaca pélvica o con sábanas apretadas como último recurso.
2. Sección uretral → Lo importante es NO INSTALAR SONDA FOLEY, se realiza cistotomía. El diagnostico se hace mediante uretrocistografía y se trata quirúrgicamente.

3. Lesiones de hombro

Causa → Caída a nivel con golpe en el hombro

Clínica → Dolor e impotencia funcional

Diagnóstico → Rx AP y axial de hombro



Nuestro amigo creggers (sí, yo) después de ser chocado y quedar más mal que bien

Luxación anterior de hombro

Clínica específica → Hombro en charretera

Riesgo → Lesión del nervio axilar

Diagnostico → Radiografía

Tratamiento

Ortopédico: Reducción cerrada + inmovilizador de hombro

Cirugía → En caso de ser recurrente (2 o mas, se asume que hay rotura del labrum)

Luxación posterior → La clínica es muy parecida a la luxación anterior

Es clásico de los pacientes que se electrocutan o convulsionan

Diferencias

- 1 Examen físico menos alterado
- 2 mayor riesgo de recurrencia (daña mas el labrum)
- 3 se debe solicitar RNM de hombro por probable daño del labrum y partes blandas para determinar si requiere cirugía desde el 1er episodio.

El resto del manejo es igual



Disyunción acromioclavicular

Clínica específica → Signo de la tecla y dolor en la articulación A-C

Diagnostico → Radiografía AP bilateral COMPARATIVA de hombros.

Tratamiento

Inmovilización en grados 1 y 2

Cirugía en grados 3-6



Once again, nuestro amigo creggers sacándose la chucha

Fractura de clavícula

Clínica específica → Dolor y deformación de la clavícula. Podría tener el signo de la tecla

Diagnostico → Radiografías

Tratamiento → Suele ser ortopédico con inmovilizador de hombro. Ante fractura de los tercios medial o proximal o gran desplazamiento puede ser quirúrgico



4. Lesiones de extremidades Superiores

Su causa suele ser la caída nivel con el apoyo en extensión de la mano.

El diagnóstico es con radiografías

Fractura de escafoides

Clínica→ Dolor en la tabaquera anatómica. Es clásico de los jóvenes

Riesgo de necrosis avascular de este hueso, es una fractura potencialmente muy grave.

Diagnóstico→ TAC, la Rx no es buena, pero se pide igual.
Si la Rx esta normal, debo pedir un TAC. De no tenerla disponible debo inmovilizar hasta que se la haga.

Tratamiento

Ortopédico→ Inmovilizador de la mano en las no desplazadas ni complicadas

Quirúrgico→ Desplazadas o que se haya complicado con necrosis avascular



Fractura de muñeca

Clínica→ Deformación en dorso de tenedor (radializada o dorsalizada).

Diagnostico→ Radiografías

Tratamiento→ El típico



Fractura de antebrazo

Clínica y diagnostico→ Same shit

Tratamiento→ Cirugía

Luxofracturas→ Se preguntan harto

Monteggia	Galeazzi
Fx. diáfisis cúbito	Fx. diáfisis radio
Luxa cúpula radial	Luxa cúbito distal

Monteggia→ Tiene una O, como la forma de la cúpula radial que es la que se luxa.

Característico de esta es que duele en la pronosupinación



→ Monteggia



→ Galeazzi

Fractura supracondílea de humero



Clínica→ Equimosis en fosa cubital y deformación del codo. El traumatismo suele ser más intenso que las anteriores.

Riesgos

Lesión de la arteria braquial

Lesión del nervio mediano

Dg→ Radiografía

Tratamiento→ quirúrgico

Fractura de cúpula radial

Clínica→ Duele en la pronosupinación, sin gran compromiso de la flexoextensión (Similar a Monteggia)

Diagnóstico y tratamiento→ Rx, ortopédico o quirúrgico

Fractura subcapital de húmero

Clínica→ Es una fractura osteoporótica. Viene con equimosis en la cara interna del brazo.

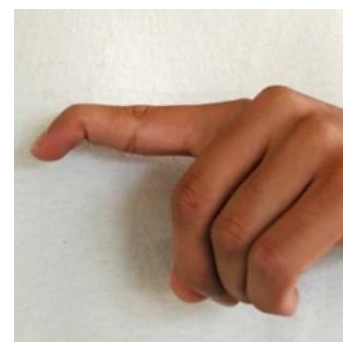
Diagnóstico y tratamiento→ Rx, ortopédico o quirúrgico

Dedo en martillo o Mallet finger

Trauma en dedo que queda con imposibilidad de extender la falange distal por rotura de la fascia extensora. Tiene el riesgo de quedar con el dedo malo.

Diagnóstico→ Rx para descartar fractura avulsiva (mallet fracture)

Tratamiento→ Ortopédico **urgente** con férula en extensión



Dedo en gatillo

Clínica→ Dificultad para extender uno o más dedos

Causa→ Atrapamiento del tendón del flexor profundo de los dedos en la polea.

Diagnóstico→ Clínico

Tratamiento→ Quirúrgico

5. Lesiones de extremidades inferiores

El tratamiento es quirúrgico salvo excepciones que no vale la pena conocer

Fractura de fémur

Habitualmente es una fractura cabalgada

Fractura de pierna

Se complica habitualmente con síndrome compartimental

Puede responder a tratamiento ortopédico, pero es muy lento y estar 3 meses sin apoyar se asocia a más complicaciones

Fractura de tobillo

Por mecanismo de inversión o eversión forzada.

Se produce dolor, impotencia, equimosis tanto en fractura como esguince, por lo tanto, para diferenciarlos y saber que es una fractura, debe venir con:

- Imposibilidad de apoyar peso
- Crepitación ósea
- Dolor a la compresión de las eminencias óseas (maléolos, base del 5º metatarsiano y cabeza del peroné)

Manejo→ Rx para descartar fractura. Si la Rx está normal, se diagnostica esguince de tobillo

Tratamiento fractura→ Cirugía

Tratamiento esguince→ RICE + Bota removible

6. Lesiones de rodilla

Viene con dolor e impotencia funcional

El diagnóstico es con RNM

Lesiones meniscales

Clínica→ Sensación de bloqueo articular, inestabilidad, dolor a la palpación de la interlínea y maniobra de Appleby (+)

Mecanismo→ Torsión de rodilla (giro brusco con apoyo de la rodilla)

Diagnóstico→ RNM

Tratamiento

- Conservador→ Reposo, ejercicio y AINEs
- Quirúrgico→ Artroscopia, cuando el conservador ha fallado o la RNM está muy fea

Lesiones de ligamentos cruzados

Clínica→ Inestabilidad de la rodilla. Signo del cajón anterior (LCA) o posterior (LCP) (+)

Se da por hiperextensión de la rodilla (LCA) o por hiperflexión (LCP)

Diagnóstico→ RNM

Tratamiento

LCA→ Cirugía

LCP→ Conservador a menos que esté muy inestable o que sea muy deportista

Lesiones de ligamentos colaterales (esguince de rodilla)

Mecanismo→ Varo forzado (LCL) o valgo forzado (LCM)

El bostezo es el signo más específico

La lesión del LCM se asocia a lesión del menisco interno

Diagnóstico→ RNM

Tratamiento→ Conservador con inmovilizador de rodilla

Disfunción patelofemoral

Dolor en la zona anterior de la rodilla, principalmente al subir y bajar escaleras, cerros, etc.

Puede venir con inestabilidad de la rótula.

Diagnóstico→ Clínico

Tratamiento→ Reposo, AINEs y Kine (fortalecimiento de cuádriceps)

7. Fractura de cadera

Se pregunta en TMT y geriatría, por lo cual, aparece con frecuencia

Clínica

- Antecedente de osteoporosis
- Adulto Mayor
- Imposibilidad de caminar
- Imposibilidad de levantar el talón
- Abducción, rotación externa y acortamiento de la extremidad (Posición impúdica).

Mecanismo→ Caída a nivel en el adulto mayor con golpe en la cadera. Impacto de alta energía en gente joven.

Diagnostico→ Radiografía AP y axial de cadera + AP de pelvis

Tratamiento → Quirúrgico. Primero se debe estabilizar

Tipos de cirugía

- Ante riesgo de necrosis avascular que se da en Fx de cuello en >65años o que esté desplazada → **Prótesis**
- Intertrocantéricas→ **DHS**
- Cuello→ **Tornillo canulado**



Un paciente postrado con Fx de cadera se debe operar igual para que no tenga dolor a futuro retirando la cabeza femoral.

Luxación posterior de cadera

Clínica

- Caída a nivel o accidente de tránsito como copiloto
- Imposibilidad de caminar
- Posición púdica

Diagnostico → Radiografía

Tratamiento → Reducción cerrada en pabellón



8. Lesiones de partes blandas

Contusión

Traumatismo de partes blandas que evoluciona con dolor y equimosis.

Rx descarta fractura, el diagnóstico es clínico

Tratamiento → Frio local + AINEs

Desgarros musculares

Antecedente de ejercicio intenso o de estiramiento del musculo con dolor y hematoma o equimosis.

Diagnostico es clínico y se puede confirmar con una eco.

Tratamiento → Frio y luego calor local, con AINEs

Hematomas

Antecedente de traumatismo o desgarro muscular que evoluciona con aumento de volumen y dolor.

Diagnostico es clínico, si queda la duda puede verse con la ecografía

Tratamiento → Los mismo de siempre + cirugía en caso de que sea muy grande o se infecte

Esguinces

Antecedente de traumatismo o estiramiento de un tendón o ligamento que evoluciona con dolor y aumento de volumen, equimosis (grado 2 y 3)

Grado 1	Sin rotura	Dolor
Grado 2	Rotura parcial	+ Equimosis
Grado 3	Rotura total	+ Inestabilidad

Diagnostico → Clínico, se puede pedir Ecografía para ver el ligamento roto o Rx par descartar la fractura

Tratamiento→ RICE, AINEs e inmovilización en grado 2 y 3.

Quiste de Baker o Poplíteo

Aumento de volumen en la fosa poplíteo

Si se rompe presenta dolor en la fosa poplíteo con aumento de volumen y edema, es diagnóstico diferencial de la TVP.

Tratamiento→ Observación. En caso de ser gigante se punciona, pero muy rara vez se opera



Rotura del tendón de Aquiles

Clínica→ Dolor súbito e intenso en la región supra calcáneo con sensación de haber recibido pedrazo en el talón

Es de causa degenerativa, por lo cual, es de viejos.

Examen físico: Thomson (+) (al apretar el gastrocnemio no se mueve el pie)

Diagnóstico→ Clínico, se puede complementar con RNM o eco

Tratamiento→ Quirúrgico

9. Tumores óseos

Se pregunta poco

Se caracterizan por ser generalmente asintomáticos o venir con dolor óseo o fracturas patológicas.

Se diagnostican con la radiografía.

Benignos→ Respetan la cortical, no invaden partes blandas, homogéneo, bien delimitado y sin reacción perióstica.

Malignos→ disrupción de la cortical, invaden partes blandas, heterogéneo, mal delimitado y con reacción perióstica compleja.

Es importante saber 3 cosas de los distintos tumores

1. Maligno o benigno
2. Edad de presentación
3. Lugar de localización

Osteocondroma

Lesión benigna que se da en pacientes jóvenes generalmente.

Rx→ Lesión ósea polipoidea

Tratamiento → observación, porque es benigno



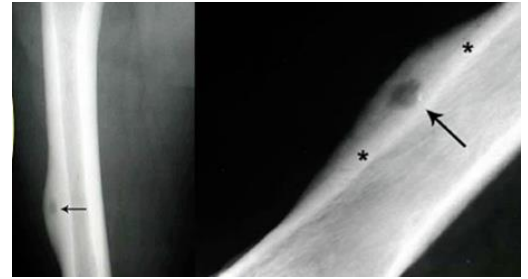
Osteoma osteode

Tumor benigno que afecta a jóvenes. Puede venir con dolor nocturno que responde a AINEs, aunque suele ser asintomático

Rx→ Aspecto benigno radiolúcido con un halo radiopaco.

Localización→ En la cortical

Tratamiento→ Observación. En caso de ser sintomático va desde AINEs a cirugía



Enfermad de Paget

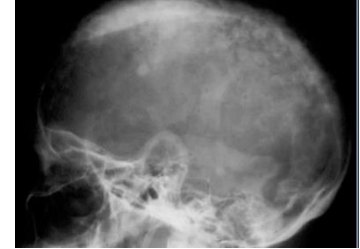
Suele ser asintomático, pero puede venir con Fx o dolor.

Es una patología genética pseudotumoral.

Se presenta con FA elevadas

Rx→ Lesiones en sal y pimienta (mezcla de zonas radiopacas con zonas radiolúcidas).

Tratamiento→ Observación (asintomático) o bifosfonatos (sintomático)



Osteosarcoma

Se da en adolescente y en adultos mayores

Rx→ aspecto maligno, de localización metafisiaria

Tratamiento→ Cirugía y eventual QT o RT



Tumor de células gigantes

Suele darse en hombres entre 40 y 50 años.

Es un tumor localmente agresivo (se ve maligno a la Rx), pero no da metástasis

Es benigno, pero de aspecto maligno.

Suele ubicarse en huesos alrededor de la rodilla

Tratamiento→ Cirugía



Sarcoma de Ewing

Afecta a niños y adolescentes

Rx→ Aspecto maligno

Localizado en diáfisis

Tratamiento→ Quimioterapia y luego cirugía



Al final del video hay 3 casos clínicos por si los quieren sapear

10. Traumatología infantil

Se pregunta en pediatría y TMT, es pregunta segura

Displasia de caderas

Clínica→ Asintomática. Al examen físico tenemos el signo de Ortholani (podemos reposicionar la cadera basalmente luxada) y barlow (la cadera está encajada y yo puedo luxarla)

Riesgo→ Artrosis, dolor, claudicación, por lo cual, debe ser manejada tempranamente

Factores de riesgo

- Sexo femenino
- Posición podálica
- Oligohidroamnios
- Antecedentes familiares
- Alteraciones neurológicas

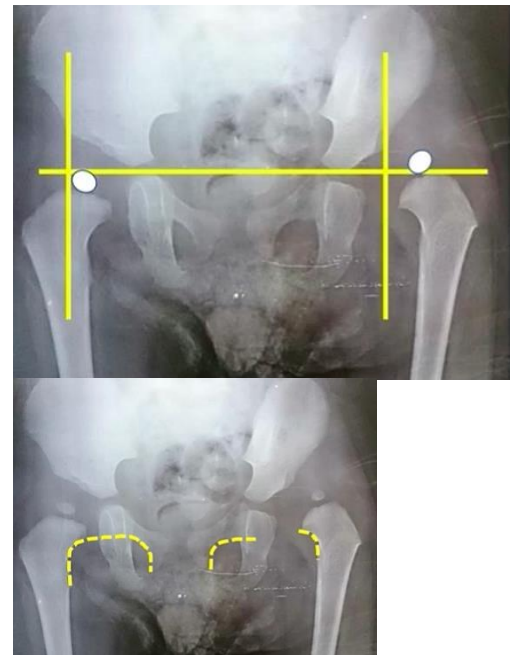
Screening→ Rx de cadera a los 3 meses

Ecografía→ Al mes, en caso de niño con factores de riesgo

Tratamiento→ A menor edad, mayor éxito

- Correas de Pavlik→ método de elección, el mas sencillo y con mas éxito
- Yeso con yugo→ Solo sin fallan las correas
- Quirúrgico→ En caso de displasias severas o a mayores de 1,5 años

Podemos evaluarlo con la ubicación de los núcleos de osificación (usando las líneas de perkins), mediante el arco de shenton o mediante el ángulo acetabular >35



Escoliosis

Desviación de la espalda

Diagnostico es clínico mediante la prueba de Adams (se pide al niño que se agache). Nos sirve para diferenciarlo de la pseudoescoliosis o giba costal.

Tratamiento→ Depende del grado de desviación y de la edad.

Menor a 30 grados se trata solo con ejercicios, mayor a 30 grados se trata con corsé y mayor a 50 grados se trata con cirugía

Pie Plano

No hay arco plantar

Diagnostico→ Clínico

Puede ser rígido o flexible (fisiológico y más común)

Pie plano flexible→ el arco se forma al hiperextender el primerortejo, levantar el pie o al extender todos los ortejos.

Tratamiento

Flexible→ Se observa (Plantillas solo en caso de dolor)

Rígido→ Derivar a TMT infantil

Pie Bot o zambo

Pie desviado en varo, equino (hacia abajo), cavo y aducto (se gira hacia dentro)

Diagnóstico→ Clínico

Tratamiento→ Ortopédico con yesos de ponseti

A menor edad, mayor éxito. En los adultos se trata con cirugía



Sinovitis transitoria

Hay que saber diferenciarla de la artritis séptica, perthes y epifisiolisis.

Se da en niños de 2-4 años con dolor en la cadera (más frecuente) y rodilla (2ª en frecuencia)

Viene con claudicación de la marcha y niño con buen estado general.

Suele tener antecedente de una infección respiratoria alta previa

Diagnostico→ Clínico, las Rx están normales

Tratamiento→ Sintomático con paracetamol

Enfermedad de Perthes

Necrosis avascular de la cabeza femoral de un niño.

Se da en niños entre 5 y 10 años con dolor en la cadera y claudicación de la marcha

Puede venir con antecedente de talla baja y mucha actividad física

Diagnostico→ Radiografía AP de pelvis (cabeza femoral plana y densa).

Tratamiento→ Desde el reposo absoluto hasta la cirugía (en caso de gran necrosis en la cual requiere una prótesis).



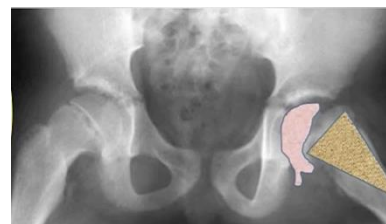
Epifisiolisis de la cabeza femoral

Se da en adolescentes de 12 a 15 años con dolor en cadera y claudicación de la marcha y puede venir con antecedente de obesidad



Diagnostico→ Radiografía AP de pelvis donde se ve la epífisis separada, signo del “helado caído”

Tratamiento→ Cirugía



11. Infección de piel y partes blandas

Entra en pediatría, TMT, dermatología e infecto, asique es pregunta segura, pero fácil
 Son producidas por bacterias Gram + (Staphylo aureus y Strepto grupo A)
 Su diagnóstico es clínico y se trata con ATB por 10 días generalmente, que varia dependiendo de si es leve o grave y del MO obviamente

S. aureus (SA)
S. Pyogenes (SP)

	Leve VO	Grave EV	Alérgico	Resistente
SP	Amoxi Ampi	Peni G Ampi	Macrólidos Clinda	No hay resistencia
SA	Cloxa Flucloxa Cefadroxilo	Cloxa Cefazolina	Clinda	Vanco

Si es muy grave, se agrega clindamicina al esquema
 TODOS los ATB que cubren al S. aureus también van a cubrir al Strepto pyogenes

Erisipela

Producida por S. Pyogenes, es grave, por lo cual, se trata Ev
 Placa eritematosa con BORDES NÍTIDOS, fiebre y compromiso linfático. Suele venir con harta fiebre. Si viene con demasiado dolor y/o bulas hemorrágicas hay que sospechar que es una fascitis necrotizante. Si lo sospecho debo ir a confirmarlo con imágenes (RNM o Eco)
 Si me queda la duda entre si es erisipela o fascitis, debo confirmarlo con imágenes (Eco o RNM)



Celulitis

Producida por *S. aureus* o *S. pyogenes*.

Se presenta como una placa eritematosa de bordes difusos, dolor y fiebre

Tratamiento → Es Ev con Cloxa o cefazolina para cubrir *S. aureus*.



Fasceitis necrotizante

Producida por *Streptococcus pyogenes*

Es una placa dolorosa, violácea/negra (necrosis) con bulas hemorrágicas y mucho DOLOR

Tratamiento → Penicilina Ev + Clindamicina + DEBRIDACIÓN QUIRÚRGICA



SHOCK TÓXICO

Por *S. aureus* o *S. pyogenes*

Ambos productores de exotoxina que activa el sistema inmune

Clínica → Hipotensión, taquicardia, mala perfusión. Es un shock vasodilatador (no responde a volumen).

Es un cuadro grave, tiene una letalidad alta

Tratamiento → Cloxacilina o Penicilina Ev + clindamicina Ev + SF + Drogas vasoactivas

Si viene con eritrodermia, me orienta a Shock toxico por strepto pyogenes



Síndrome de piel escaldada

Producido por *S. aureus* productor de epidermtoxina

Clínica → Inicia como eritema periorcular, luego en los pliegues, luego vesículas y pápulas sobre las zonas eritematosas, que rompen y se cae la epidermis.

Viene con signo de nikolski (Se desprende la epidermis al presionarla con el dedo). Pénfigo y NET también tienen este signo.



Tratamiento: Cuadro grave, se trata con cloxacilina + clindamicina EV

Impétigo

Producido por ambas bacterias (aureus y pyogenes)

Produce costras mielicéricas generalmente alrededor de la boca o nariz (costra amarillenta fácil de remover).

Es una infección leve, se trata con flucloxacilina o cefadroxilo Vo o mupirocina tópica, ambos por 10 días.



Impétigo bulloso

Por S. aureus productor de toxina exfoliativa, como en piel escaldada, pero en este caso la infección está solo en la zona del impétigo.

Clínica → Impétigo + bulas flácidas

Tratamiento → El mismo del impétigo



Foliculitis

Producido por S. Aureus

Clínica → Pústulas en relación al folículo piloso, frecuentemente después de afeitarse o depilarse

Tratamiento → Coxa, flucloxa o cefadroxilo o bien no se hace nada porque es un cuadro de mierda que pasa solo.



Si se ha bañado en sauna o aguas estancadas se sospecha de infección por pseudomonas y se trata con ciprofloxacino.

Furúnculo

Producido por S aureus

Igual a una Foliculitis, pero mas grande que podría absedarse

Tratamiento → Nada o ATB orales o drenaje si es muy grande



Ántrax

Producido por S aureus

Masa inflamatorio donde varios furúnculos se unen en una sola masa

Tratamiento → Cloxacilina o cefazolina **Ev** + drenaje quirúrgico



12. Artrosis y Monoartritis

Artrosis

Enfermedad degenerativa que destruye el cartílago articular

Causas

Primaria

- Genética/Degenerativa (1ª causa)

Secundaria

- Luxación crónica
- Fx intraarticular
- Artritis séptica/reumatoide

Clínica → DOLOR (puede evolucionar a anquilosis) y puede haber derrame. Si hay una Rx alterada pero no hay dolor, no se diagnostica artrosis, el diagnóstico exige que haya dolor.

Características radiológicas

- **Disminución del espacio articular**
- Osteofitos
- Esclerosis subcondral (radio opacidad)
- Geodas (quistes) subcondrales



Tratamiento (sigue un orden)

1. Paracetamol (1g/8hrs) + ejercicio de fortalecimiento
2. AINEs si lo anterior no sirve (**no se usan si tiene ERC o ulcera gastroduodenal y paso directo a opiáceos**)
3. Tramadol si el dolor persiste
4. Corticoides intraarticulares si aun persiste con dolor
5. Cirugía como última opción. Generalmente prótesis (artrodesis en caso de las IFP)

MONOARTRITIS AGUDA

Dolor, aumento de volumen, eritema y derrame en 1 articulación

Conducta → Punción para determinar la causa

Líquido no inflamatorio → Artrosis

- Menos de 1.000 células
- Filante, transparente

Líquido Inflamatorio → Artritis por cristales o Artritis séptica

- Más de 1.000 células (50.000 en AR y 100.000 en AS generalmente)
- Turbio
- Filancia disminuida

Artritis por Cristales

- Birrefringencia (Elongación) positiva → Condrocálcinosis (cristales de pirofosfato de calcio)
- Birrefringencia (Elongación) negativa → Gota

Séptica

Gram (+) → *S. aureus*. Se trata con cloxacilina o cefazolina Ev + drenaje Qx

Gram (-) → *Gonococo*, se trata con ceftriaxona Ev + drenaje Qx

GOTA

Monoartritis aguda recidivante, clásicamente la metatarsofalángica (podagra). La podagra es la única monoartritis que no se punciona, cuando la clínica no orienta a artritis séptica.

CONDROCALCINOSIS

Monoartritis aguda que afecta generalmente la rodilla

Tratamiento

AINEs Ev (colchicina como 2ª opción)

No se debe cambiar la dosis ni iniciar alopurinol durante la crisis de gota. Si estaba tomando alopurinol de antes, no puedo suspender ni aumentar su dosis.

Prevención

Condrocálcinosis → Nada que hacer

Gota → Dieta (baja consumo de OH y comer poco marisco y carnes) + baja de peso.

Como tratamiento farmacológico se puede dar Alopurinol (**solo si tiene 2 o más crisis al año, sino no sirve**).

Se debe mantener el Ac úrico bajo 6 en mujeres y bajo 7 en hombres

6. Lumbago, cervicalgia, hombro doloroso, codo doloroso, bursitis, tendinitis y fibromialgia

Lumbago

Causas

- Mecánico es lo más frecuente. Se debe a una debilidad de la musculatura lumbar. Su diagnóstico es clínico y se trata con AINEs, calor local y Kine para fortalecer CORE (una vez pasado el dolor). Es una enfermedad recidivante

Signos de alarma → Si están presentes se debe solicitar una RNM. De no estar presentes se sigue el tto anteriormente mencionado

- **Fractura**
 - Osteoporosis
 - Corticoides
 - Adulto Mayor
 - Caída o trauma
- **Cáncer**
 - Antecedente de cáncer
 - Síntomas B
- **Clínica de enfermedad reumatológica**
 - Aumenta con reposo y disminuye con ejercicio
 - Entesitis
 - Uveítis
 - Rigidez matinal
- **Infección**
 - Fiebre
- **Afectación neurológica**
 - Disminución de fuerza
 - Disminución de sensibilidad
 - Alteración de los ROT (**irradiación del dolor no es Red Flag**)
- **Duración mayor a 6 semanas (o que tras 2 semanas empeora)**

Lumbociática

Dolor lumbar irradiado EEII

El manejo es igual al lumbago mecánico (Analgesia, calor y Kine)

Se indica RNM en caso de compromiso neurológico o si no responde a tratamiento

Dorsalgia, Cervicalgia y cervicobraquialgia se manejan igual que un lumbago.

Hombro doloroso

Síndrome de manguito rotador es la causa clásica

- Dolor aumenta con movimiento repetitivos
- Aumenta en la noche
- Aumenta ante la abducción y extensión contra resistencia

Diagnóstico es clínico, pero se pide Ecografía para determinar la causa

Manejo

Reposo, AINEs y Kine motora

Solo se opera si el tendón está muy malo y no responde a tratamiento médico

Capsulitis adhesiva (Hombro congelado)

Dolor impide la movilización tanto activa como pasiva, lo cual, lleva a la anquilosis (en esta etapa sin dolor)

Diagnóstico → Clínico

Tratamiento → Corticoides + KNT y en ultima instancia podría llegar a Cirugía

Codo Doloroso

Epicondilitis o Epicondilitis lateral o codo del tenista → Duele la zona de inserción de los extensores del codo.

Tratamiento → Reposo, AINEs y Kine + Epicondilera

Epitrocleitis o Epicondilitis medial o codo del golfista → Duele la zona de inserción de los flexores del codo

Tratamiento → Reposo, AINEs y Kine + Epicondilera

Tendinitis tricipital → Duele inserción del tríceps

Tendinitis → Dolor a la elongación y palpación de un tendón debido a movimientos repetitivos. Puede afectar cualquier tendón.

Tendinitis clásicas:

T. Pata de ganso → Cara medial de la rodilla (asociado a trekking)

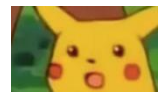
T. Rotuliana → Cara anterior de la rodilla

T. Fascia lata o Sd de la banda iliotibial o tendinitis del trotador → Cara lateral de la rodilla (clásica del trotador)

T. de Quervain → Cara lateral de muñeca

T tricipital → Dolor sobre olecranon

Tratamiento → Reposo relativo, AINEs+ KNT. Si se llega a pedir imagen se pide una Eco



Bursitis → Inflamación de una bursa. Se presentan como **dolor, eritema y aumento de volumen** de la bursa.

La clásica es la bursitis olecraneana, peritrocanterica y rotuliana. El aumento de volumen y eritema me permiten diferenciarlo de una tendinitis.

Tratamiento → AINEs + Calor/frío local



Fibromialgia

Diagnostico es clínico

Cínica → Dolor a la compresión de puntos gatillo (masas musculares), astenia

Suele venir con astenia y estar asociado a otros trastornos somatomorfos como SII.

Tratamiento → Ejercicio + moduladores del dolor (pregabalina, gabapentina o Tricíclicos)

Si VHS aumentada pensamos en Polimialgia reumática

Si CK elevada pensamos en Polimiositis o Polimialgia reumática

Resumen Guevara by creggers

Urología



1. Problemas sexuales

Se pregunta con alguna frecuencia en psiquiatría o Uro

Dispareunia

Dolor al tener al sexo. Se produce en las mujeres.

Superficial (vaginismo) → Contracción tónica de los músculos de la vagina. De causa psicológica

Profunda → Duele a la penetración profunda, suele ser 2ª a otra enfermedad. De causa orgánica (PIP, endometriosis cáncer, etc.)

Diagnostico → Clínico

Tratamiento → Tratar la causa

Impotencia sexual

Imposibilidad de lograr o mantener la erección

NUNCA es normal.

Causas:

- Psicológicas → Asociado a stress. Sí tiene erecciones en otros momentos (erecciones matinales o masturbación)
- Orgánicas → Asociado a enfermedades vasculares (HTA, DM) o hipogonadismo

Tratamiento → Tratar la causa + Sildenafil (solo sintomático)

Disminución de la libido

Causa → Psicológica (stress, depresión) o hipogonadismo

Eyacuación precoz

Se debe bajar la ansiedad, es totalmente psicológico. ISRS bajan la ansiedad y el deseo sexual. Se puede usar preservativo también que disminuye la sensibilidad.

Priapismo

Se ha preguntado un par de veces

Erección dolorosa por más de 4 horas

Afecta solo los cuerpos cavernosos, el glande está blando

Causa → Drogas vasodilatadoras, vascular /anemia de células falciformes)

Diagnostico → clínico

Tratamiento → Fenilefrina intracavernosa + tratamiento de la causa

Infertilidad masculina

Imposibilidad de lograr embarazo intentándolo 1 año sin MAC
Causas→ Sd de Klinefelter (XXY), hipogonadismo,
Diagnóstico→ Espermiograma
Tratamiento→ Depende de la causa

2. Testículo agudo/orquiepididimitis/dolor testicular crónico

Se pregunta harto

Testículo agudo

Clínica

- Dolor
- Inicio agudo
- Aumento de volumen
- Ascenso del testículo (en caso de torsión)

Causas→ Torsión de hidátide (en niños) o torsión testicular (adolescentes y adultos)

Clínicamente son casi indistinguibles, por lo cual hay que asegurarse de que no sea una torsión, lo cual, se hace quirúrgicamente (destorsión + orquidopexia).

Podríamos intentar destorcer manualmente, girando hacia afuera en caso de no haya acceso a una atención profesional rápida, con éxito de 60%

Doppler→ No sirve si la clínica es de testículo agudo, se debe ir directo a la exploración quirúrgica

En caso de ser de **inicio subagudo** si sirve el doppler.

Orquiepididimitis

Clínica

- Dolor
- Aumento de volumen
- Eritema
- Fiebre

Causa

- ETS
 - chlamydia y Gonococo
 - Hombre joven con actividad sexual sin protección
 - E. Coli o Gram (-)
 - Mayores de 60 años con pareja estable

Diagnóstico→ Clínico

Tratamiento→ ATB (ceftriaxona + doxicilina)

Orquitis Urleana

Producida por Virus Paperas. Genera infertilidad e hipogonadismo

Se vacuna para esto en la trivírica (para hombres y mujeres, pues afecta a ambos)

Dolor testicular crónico

Varicocele, epididimitis crónica, tumores, quistes, espermatocele o orquialgia crónica benigna

Orquialgia crónica benigna

Es la más común

Este es el diagnóstico en caso de tener un examen físico normal

Se maneja con PCT/AINEs

3. Tumor testicular / Quistes del epidídimo / Hidrocele / Varicocele

Tumores testiculares

Clínica→ Suelen ser un hallazgo, se encuentran como hallazgo (ante un trauma generalmente).

Examen físico→ Me permite diferenciar entre un tumor testicular v/s un aumento de volumen testicular. Tras esto se pasa a la ecografía

Lesión quística→ quiste del epidídimo, conductos seminíferos, etc. Son todos benignos y se observan. Solo si hay mucho dolor se resecan

Sólido→ Se asume que es cáncer se debe biopsiar. La biopsia mínima de un testículo es el testículo completo mediante orquiectomía radical (Se saca conducto espermático completo). Se hace biopsia que me va a demostrar el tipo de masa (benigno, seminoma o no seminoma)

Marcadores tumorales→ No cambian conducta, la eco determina la conducta

HCG→ Marcador de todos los tumores

AFP→ Marcador de los no seminomas

LDH→ Sugiere metástasis en casos de estar muy alta, MUY INESPECÍFICO

Tratamiento del cáncer de testículo→ Depende del tipo de cáncer (Seminoma o No seminoma) y de si está localizado o hay metástasis

	Localizado	Metástasis
Seminoma	RT	QT
No seminoma	LALA	QT

El seminoma es un Ca con buen pronóstico

LALA→ Linfadenectomía lumboaórtica

Excepciones

Teratoma→ Solo cirugía

Coriocarcinoma→ QT, siempre hay metástasis

Seminoma con AFP (+)→ Se maneja como un NO seminoma

Etapificación→ TAC TAP, las metástasis suelen ser a ganglios retroperitoneales y pulmón en 2º lugar.

Quistes del epidídimo→ Se manejan igual que los tumores testiculares

Hidrocele

Clínica

- Aumento de volumen escrotal (no testicular)
- Prueba de transiluminación positiva

Conducta→ Observar, suele resolver de forma espontánea

En caso de ser gigante, dolor, muy molesto o genera problemas psicológicos se trata con cirugía.

En niños es por persistencia del conducto peritoneovaginal y en los adultos es idiopático

Varicocele

Se ha preguntado un par de veces

Clínica→ Aumento de volumen en escroto como “bolsa de gusanos” con prueba de transiluminación negativa

Diagnóstico→ Clínico

Suele ser asintomático, pero puede complicarse con infertilidad, atrofia testicular e hipogonadismo

Manejo

Asintomático→ Observar

Dolor, muy grande, infertilidad, atrofia o hipogonadismo→ Ligadura del plexo pampiniforme

4. Trauma renal / Trauma uretral / Trauma vesical / Trauma testicular / Fractura de pene

Aparecen con cierta frecuencia

Trauma Renal

Clínica

- **Asociado a trauma en zona lumbar**
- **Hematuria**
- Shock hipovolémico
- Equimosis lumbar (por hematoma retroperitoneal)

Estudio→ TAC con contraste

Tratamiento→ Depende del grado de daño

Sin shock y con TAC normal → Observar

Shock, lesiones de vía urinaria, laceración renal, hematoma → Cirugía (conservadora v/s nefrectomía)

Trauma uretral

Se pregunta con harta frecuencia

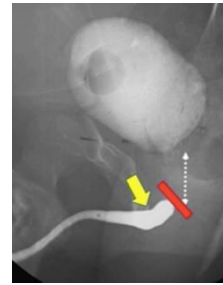
Asociado a fractura de pelvis

Clínica

- Uretrorragia
- Próstata ascendida al TR
- Globo vesical

Examen de elección → Uretrocistografía (UCG)

Tratamiento → Cirugía



Uretrocistografía de sección uretral

NO SE DEBE SONDEAR AL PACIENTE, se debe realizar cistotomía

Tratamiento → Cirugía

Trauma Vesical

Clínica → Asociado a trauma de abdomen o pelvis con vejiga llena.

Se presenta como estallido vesical (anuria sin globo vesical) y como Insuficiencia renal aguda por reabsorción de orina al torrente sanguíneo

Contusión vesical → Hematuria

Estudio → UCG y TAC probablemente

Tratamiento

- Estallido → Cx
- Contusión → Observar

Trauma testicular

Trauma en escroto + dolor y hematocele (aumento de volumen con equimosis en escroto)

Se debe realizar ecografía testicular

Tratamiento → Frio local + AINEs. Cirugía en caso de daño testicular (Reparación o resección en caso de laceración o estallido respectivamente)

Fractura de pene



Clínica→ Durante relación sexual muy intensa se escucha chasquido que evoluciona con dolor y hematoma gigante

Diagnostico→ Clínico

Tratamiento→ Quirúrgico



5. Cáncer de próstata

Se pregunta con mucha frecuencia

Screenng→ APE + TR anual desde los 50 hasta los 70 años. Iniciar a los 40 años en personas con antecedentes familiares. Ante screening alterado se debe realizar biopsia transrectal

Screening alterado

- TR alterado
- APE sobre 4
- Velocidad de elevación del APE mayor a 0,75

Clínica

- Uropatía obstructiva baja
 - o Disminución del calibre miccional
 - o Latencia
 - o Intermitencia
 - o Disuria de esfuerzo
 - o Polaquiuria
 - o Nicturia
 - o Incontinencia
 - o Nicturia
- Baja se peso
- Dolor lumbar
- Dolores óseos (por MTT)

Pronóstico→ **Niveles de APE** + extensión palpable de la lesión al TR + score de gleason

Etapificación→ APE, RNM de pelvis + cintigrafía (ante APE mayor a 20 o dolores óseos)

Tratamiento

Localizado → Prostatectomía radical (menores de 70) u observar en mayores de 70 años. Como tercera opción tenemos la braquiterapia (radioterapia)

Avanzado (MTT) → Hormonoterapia con agonistas GnRH (Se pregunta)

6. Hematuria, cáncer de vejiga y cáncer de uréter

Hematuria

Inicial → Lesión de la uretra

Terminal → Vejiga

Continua → Uréteres o renal

Estudio → Tiene un orden

1. Sedimento de orina + UC

2. Imágenes (Eco renal y vesical o UroTAC)

3. Cistoscopia, para determinar si hay alteraciones en la vejiga

En caso de ser hematuria dismórfica se manda IC a nefrología (glomerulonefritis)

Eco y UroTAC me sirve para ver litiasis y Cáncer

Cistoscopia es el examen de elección para ver el cáncer de vejiga, cistitis intersticial, hemorrágica, etc.

Cáncer de vejiga

Su clínica suele ser solo hematuria. Viene con antecedente de tabaquismo o exposición a anilinas (enfermedad laboral).

Es la 1ª causa de hematuria sin síntomas agregados

(ITU es la principal causa de hematuria, pero viene con mas síntomas)

Tratamiento → Depende de si compromete o no al detrusor

No invade → RTU + BCG

Invasión del detrusor → Cistectomía radical + RT o QT

Cáncer de uréter

Clínica → Hematuria continua

Diagnostico con el estudio de hematuria clásico.

Tratamiento → Ureterectomía + “pastilla vesical” (Se reseca un pedazo de vejiga)

7. Tumor Renal y cáncer renal

Se pregunta con bastante frecuencia

Cáncer renal

Clínica→ Asintomático, suele ser hallazgo en imágenes. De venir con síntomas, presenta la triada clásica de Hematuria, fiebre y masa renal.

Se caracteriza por desarrollar muchos síndromes paraneoplásicos (se pregunta)

- Hepatitis
- TVP/TEP
- Hipercalcemia

Si un niño presenta esta clínica probablemente es un tumor de Wilms

Estudio:

- Eco renal
 - o Quístico→ Quiste renal simple, se observa sin importar el tamaño
 - o Sólido→ Ca renal probablemente, debemos continuar estudio con TAC y se debe operar, es su único tratamiento curativo

Tratamiento

Sin metástasis→ si tiene menos de 7 cm se hace cirugía parcial, pero si mide mas de 7 o está en el hilio renal, se debe sacar el riñón completo

Metástasis→ Paliatibu. No sirve la RT ni QT

Tumor de pelvis renal→ es de origen urotelial, se debe hacer una nefroureterectomía por riesgo de siembra transurinaria.

Ca renal→ Nefrectomía

Ca pelvis renal→ Nefroureterctomía

8. Fimosis, parafimosis, balanitis y adherencia balanoprepuciales

Fimosis

Dificultad para retraer el prepucio por formación de un anillo fibrótico

Diagnostico→ Clínico

Su riesgo es que se puede complicar con parafimosis, infecciones recurrentes, ERC

Tratamiento

- **Observar**→ en menores de 4 años, ni siquiera se hace el diagnóstico porque es normal
- Corticoides tópicos→ En mayores de 4 años, por 2 semanas con tasa de éxito de 80-90% de éxito.
- Cirugía→ Ante complicaciones, en adultos y si los corticoides fallan.

Parafimosis

Atascamiento del anillo fibrótico por detrás del anillo balanoprepucial con incapacidad de reposicionarlo. Se produce dolor y edema

Es un tratamiento de urgencia en el cual

1. Se intenta reposición manual
2. Incisión por la región dorsal
3. Posteriormente se hace la circuncisión

Balanitis

Causa

Niños→ Por bacterias Gram (+) como *S. aureus*

Adolescentes→ Por hongos (*C. albicans*)

Adultos→ Por *C. albicans* también. Se debe ir a descartar que haya diabetes de base (se ha preguntado varias veces)

Clínica→ Eritema, prurito, edema y secreción

Diagnóstico→ Clínico

Tratamiento

Adultos→ Fluconazol 150mg x 1 vez

Niños→ Cloxacilina o cefadroxilo

Adherencia balanoprepuciales y quistes de smegma

Clínica→ Adherencias que unen el glande con el prepucio

Diagnóstico→ Clínico

Tratamiento→ Observar en niños (desaparecen en la adolescencia), a menos que se compliquen con infecciones o que sea en adultos.



Quistes de smegma

También son normales, es retención de smegma en prepucio o glande

Tratamiento→ Observa a menos que se infecte o se presente en un adulto



9. Criptorquídea, testículo retráctil y testículo en ascensor

Criptorquídea

Testículo no palpable en escroto (podría palpase en el conducto inguinal)

Tiene riesgo de cáncer y de infertilidad

Estudio

3. Ecografía inguinoescrotal

4. Laparoscopia exploratoria en caso de que la Eco no localice el coquito

Tratamiento

Lactante menor → Se observa hasta el año de vida por la posibilidad de que descienda.

Después de esto, quirúrgicamente se baja el testículo y se hace una orquidopexia.

No elimina el riesgo de cáncer, pero si elimina la infertilidad.

En el adolescente el testículo se saca, porque ya quedo infértil ese coco y el riesgo de cáncer es alto.

Testículo retráctil y Testículo en ascensor

Testículo no palpable en escroto, pero si en el conducto inguinal con la capacidad de bajarlo al escroto

En caso de que al bajarlo se devuelva al conducto inguinal es un testículo retráctil

En caso de que se queda en el escroto es un testículo en ascensor

Causa → Reflejo cremasteriano exacerbado

Diagnóstico → Clínico

Tratamiento → Observación, no tiene ningún riesgo

10. ITU en pediatría, malformaciones urológicas y reflujo vesicoureteral

Se pregunta siempre

ITU

Su diagnóstico es igual que en los adultos.

UC +

>100.000 UFC por segundo chorro o recolector

>10.000 UFC por sondeo, de elección en lactantes

> 1 UFC por punción

Las ITU en pediatría se estudian con:

Eco renal → Para ver malformaciones obstructivas y reflujo vesicoureteral (RVU) grado III en adelante. Se pide **SIEMPRE**, es el estudio mínimo ante ITU en pediatría

Uretrocistografía → Para el RVU, en caso de que la Eco esté alterada o en menores de 1 año con PNA.

Cintigrafía DMSA → En agudo me orienta a PNA, de manera diferida (6-12 posterior a PNA) me muestra si hay o no una cicatriz renal.

Tratamiento

ITU baja → Nitrofurantoina o cefadroxilo

ITU alta → Cefadroxilo. En menores de 3 meses o niño grave se debe hospitalizar y usar cefalosporinas Ev (cefazolina, cefotaximo o ceftriaxona)

Los menores de 3 meses con ITU febril se hospitalizan si o si, los mayores de 3 meses se manejan ambulatorio a menos que venga grave o con complicaciones.

Profilaxis antibiótica → se hace con nitrofurantoina o cefadroxilo en una toma diaria y a la mitad de la dosis:

- Mientras esté el estudio pendiente
- Pendiente la resolución de la causa (reflujo, malformación, etc.)
- ITU recurrente (3 o más ITU)

Malformaciones urológicas

Son muy frecuente en pediatría, las más frecuentes en general

Clínica

- Dificultad para orinar
- Incontinencia
- Infecciones urinarias
- ERC post renal
- HTA 2ª

Se estudian con Ecografía (examen más importante)

Tratamiento → Cirugía

Valvas uretrales → Dilatan de la vejiga hacia arriba, la obstrucción está en al uretra.

Estenosis ureterovesical → Se dilata solo un uréter desde la región distal hacia arriba (está estenótica la unión con la vejiga)

Estenosis pieloureteral → Se dilata desde la pelvis renal hacia arriba, la obstrucción esta en la unión entre la pelvis y el uréter.

Reflujo vesicoureteral

Se presenta como PNA y desarrollo de ERC.

El diagnóstico es con la UCG, la eco solo mostrará la dilatación del uréter, pelvis y riñón, pero esto se ve solo desde el grado III en adelante.

La UCG ve desde el grado I en adelante.

Tratamiento

- Leve (grado I y II) → Observar y ATB profiláctico en caso de ITU recurrente

- Grado III en adelante (con dilatación del uréter)→Cirugía (reimplante del uréter en la vejiga)

11. Enfermedades de Transmisión sexual

Lo fundamental es la prevención.

La educación sexual y evitar promiscuidad (>2 parejas al año) son la clave.

Solo existe vacuna contra VPH (6,11,16 y 18) y hepatitis B



El condón es el único anticonceptivo que protege contra ETS

Tener una enfermedad de transmisión sexual es el máximo riesgo para tener mas ETS, por lo tanto, ante una ETS debemos ir a descartar las otras

Uretritis

El diagnostico es clínico. Se caracteriza por disuria, secreción uretral y puede venir con adenopatías inguinales. Las mujeres suelen ser asintomáticas

Cuando hay uretritis se debe diferenciar la etiología.

Esto va a variar si es en un hombre o mujer

Hombre→ Por lo general se utiliza tinción de gram

Mujeres→ Hay que hacer una PCR o cultivo de Thayer Martin

Si es gonococo (coco gram -) se debe tratar con ceftriaxona 250mg IM x 1 vez (o ciprofloxacino 500mg o azitromicina 2g VO x 1 vez).

Como se dijo anteriormente, si se tiene una ETS el riesgo de tener otra es alto, por lo cual, además de gonococo debo ir a cubrir chlamydia, lo cual, se hace con doxiciclina 100mg/12horas o azitromicina **1g** x 1 vez.

Si no es gonocócica puede ser por mycoplasma, ureaplasma y chlamydia. En este caso se deja cobertura con doxiciclina 100mg/12 horas por 10 días. La alternativa es azitromicina **1g** x 1 vez.

Cuando es gonocócica se deja cobertura para gonococo y chlamydia y si es no gonocócica se deja cobertura solo para no gonocócica

En las mujeres suele ser asintomático. Se puede complicar con PIP, embarazo ectópico y cervicitis.

Herpes Genital

Producido generalmente por VHS 2, aunque puede ser producido por el 1 también (este suele ser oral)

Diagnostico es clínico, pero se puede apoyar en la PCR

Se observan vesículas múltiples que se rompen y forman ulceras, fiebre, adenopatías y disuria.

Tratamiento→ Aciclovir o valaciclovir (hay que saber las dosis)
Aciclovir 400mg cada 6 horas por 7 días
Valaciclovir 500mg cada 8 horas por 7 días

El herpes **activo** durante el parto, contraindicada el parto vaginal por riesgo de herpes neoantal que es muy grave. (se pregunta)



Condiloma acuminado

Producido por VPH serotipos 6 y 11

Genera lesiones polipoideas solevantadas indoloras que crecen lentamente

En los hombres generalmente en el surco balanoprepucial, meato urinario o perianal en caso de sexo anal.

En las mujeres generalmente en labios mayores, menores o perianal en caso de sexo anal.

El diagnóstico es clínico, pero si encontramos VPH debemos DESCARTAR OTRAS ETS, como en toda ETS.

Tratamiento→ Crioterapia, resección cx, acido tricloroacético, imiquimod, etc.

Condiloma si tiene opción de parto vaginal a menos que sea gigante. En caso de Ca cervical sí lo contraindica.

Chancroide

Causado por Haemophilus ducrei

Es una ulcera igual que el chancro, pero duele

Usualmente viene con una adenopatía dolorosa que puede absedarse y fistularse

Diagnostico→ Clínico

Tratamiento→ Ceftriaxona o azitromicina

Sífilis

Es lo que más se pregunta tanto en clínica como exámenes

Producido por treponema palidum

Tiene clínicas muy variables

Sífilis primaria

- Chancro
 - Ulcera única indolora
 - Aspecto limpio (no como chancroide)
 - Indolora

Sífilis secundaria

- Fiebre
- Exantema

- Placas eritematosas generalizadas que **afecta palmas y plantas** (basta 1 sola lesión e palma o planta)

Sífilis terciaria

- Gomas sífilíticas → Aumentos de volumen
- Tabes dorsal → Alteración neurológica donde se pierde la sensibilidad de extremidades inferiores (afectación de cordones posteriores)
- Aneurisma aórtico
- Neurosífilis

Sífilis latente

Totalmente asintomática, se diagnostica solo por exámenes

Diagnostico se hace mediante pruebas no treponémicas y se confirma con pruebas treponémicas

No treponémicas → RPR y VDRL. Negativizan con tratamiento

Treponémicas → Fta ABS y MHA-TP. Permanecen positivas tras tratamiento

La excepción es la sífilis 1ª (chancro), porque el diagnóstico es clínico. Puede apoyarse en microscopia de campo oscuro que observa el treponema.

VDRL	FTA-ABS	Dg
+	-	Falso +
-	+	Tuvo y mejoró
+	+	Sífilis

Tratamiento

Penicilina benzatina 2,4 millones UI IM 1 a 2 dosis para la 1ª y 2ª, pero para sífilis 3ª se requiere de 3 dosis. Cada una separada por 1 semana

Neurosífilis se trata con penicilina G Ev

Ante alérgicos se trata con macrólidos, doxiciclina o ceftriaxona

Cuando se trata?

- VDRL y FTA ABS positivo
- Sífilis primaria
- VDRL (+) más:
 - Embarazo (Pido FTA ABS, pero no espero el FTA ABS, trato de una a pesar de que pueda ser falso +)
 - Clínica de sífilis 2ª (igual pido el FTA ABS, pero no espero su resultado)
 - Si ya tuvo sífilis antes, porque el FTA ABS va a estar + de seguro

Ladillas

Ptyrus pubis. Lo importante de encontrarlo es ir a descartar otras ETS. Se trata con permetrina al 1% en esquema 1-6-1

12. Infección del Tracto Urinario

Causas → E. coli (70-80%) + mas otras enterobacterias. Pseudomonas y acinetobacter son importantes agentes en ITU por sondas e IAAS.

Diagnostico → Clínica + UC

UC positivo

- >100.000 UFC por 2º chorro
- >10.000 UFC por sondeo
- >1 UFC por punción vesical

ITU baja

Clínica

- Disuria
- Polaquiria
- Pujo y tenesmo
- Nicturia
- Orinas turbias
- Mal olor

Tratamiento → Ciprofloxacino o cefalosporina de 1ª generación por 3 días en mujeres sanas y por 7 en hombres.

Nitrofurantoina se da por 7 días

Pielonefritis aguda

Clínica

- ITU baja
- +
 - Fiebre
 - Puño percusión

Hospitalización

- Grave
- Embarazo

Tratamiento

Ciprofloxacino o cefalosporinas de 1ª o 2ª generación por 7-10 días Vo

Cefalosporinas de 1ª o 3ª generación por vía Ev. Aminoglicósidos (amikacina) se dan por 10-12 días.

Bacteriuria asintomática

Solo UC positivo, sin clínica

Si tenemos la clínica y el sedimento +, pero UC negativo, hay que ir a descartar TBC (junto a Lupus y Kawasaki son causas de piuria aséptica)

NO se tratan, a menos que la paciente esté embarazada.

Caso:**Mujer 80 años, Alzheimer.****Usa sonda Foley.****Cuidadores notan orinas turbias por lo que se pide UCT, que muestra **E. Coli > 100.000 UFC**, sensible solo a **Imipenen**, **Tobramicina** y **Nitrofurantoína**.**

No se trata por ser bacteriuria asintomática.

ITU y Sonda

Tener una sonda aumenta el riesgo de ITU (y por bichos mas malos como pseudomonas o acinetobacter)

Se previene mediante la instalación de sonda Foley mediante técnica estéril

No se debe cambiar de forma periódica, no se dan ATB profilácticos ni irrigaciones con suero fisiológico a través de la sonda

Tratamiento → Cambio de sonda + ATB

ITU en pediatría

Lo importante es que LAS ITU EN PEDIATRÍA SE ESTUDIAN

Exámenes para estudio de ITU

- Eco renal → Se pide siempre
- Uretrocistografía → En caso de eco alterada o que sea PNA
- Cintigrafía DMSA → En caso de eco alterada o que sea PNA

ITU en embarazo

En este caso se tratan las bacteriurias asintomáticas como una ITU baja por 7 días.

Se pide UC al inicio del embarazo y a las 28 semanas

Las PNA se hospitalizan con cefalosporinas de 1ª o 3ª generación Ev. Contraindicado el ciprofloxacino y se recomienda evitar la nitrofurantoína

Profilaxis

- Si tiene 2 o más bacteriurias asintomáticas o ITU's (sintomática o asintomáticas) durante el embarazo

13. Incontinencia urinaria

Pregunta segura del EUNACOM, 2 generalmente (Uro, Gine, Geriatria)

Definición: Escape de orina que afecta la vida. El diagnostico es totalmente clínico.

Incontinencia urinaria de esfuerzo→ Se caracteriza por afectar a las mujeres multíparas, es la causa mas frecuente en las mujeres. Se caracteriza por pequeños escapes de orina relacionado con esfuerzos (tos, risa saltar, levantar peso). El diagnostico se apoya con perfil uretral (mide la presión intraluminal de la uretra, que concluye que hay debilidad del piso pélvico)

Incontinencia urinaria de urgencia→ Mas frecuente en mujeres jóvenes. Caracterizado por grandes escapes de orina asociado a necesidad imperiosa del ir al baño.

Incontinencia urinaria por rebalse→ asociado a uropatías urinarias bajas, de los hombres. Se asocia a la incontinencia de urgencia (por la hipertrofia del detrusor que genera una vejiga de lucha). El diagnostico se puede apoyar con la cistomanometria (mide la presión hidrostática dentro de la vejiga) que pesquiza contracciones no inhibidas del detrusor.

Fistula vesicovaginal→ Escape de orina continuo (**goteo**). Puede ser congénita o iatrogénico (histerectomía, cesárea).

Tratamiento

IOE→ El tratamiento tiene un orden que debe ser respetado. 1. Descartar ITU 2. KNT pélvica (Kegel) 3. Cirugía (TOT o TVT)

IOU→ El tratamiento también sigue un orden: 1. Descartar ITU 2. Terapia conductual (que orine frecuentemente, que no tome agua si va a lugar sin baño, etc.) 3. Fármacos anticolinérgicos (Oxibutinina o **tolterodina**)

14. Litiasis Urológica

Las preguntas suelen ser fáciles

Cólico Renal

Clínica

- Dolor lumbar tipo cólico
- Irradiación hacia genitales
- Nauseas/vómitos
- Agitación psicomotora

El diagnóstico es clínico

Tratamiento

Sintomático con antieméticos, AINEs y de segunda línea opioides.

Hay que recordar que clínicamente un Aneurisma abdominal roto se puede presentar igual, pero presentará hipotensión

Una vez que se maneja el cuadro agudo, debo ver que hago con el cálculo. El cálculo voy a ir a verlo con un PielotAC para determinar sus dimensiones y ubicación.

<1cm → Se observa, se debería eliminar solo

>1cm → LEC de elección, a menos que esté en la pelvis. En este caso se hace una ureteroscopia.

Cálculos coraliformes → Nefrolitotomía extracorpórea

Prevención de recidivas

Es una enfermedad crónica recidivante.

La medida más importante es tomar mucha agua.

Además, se hace un análisis químico del cálculo para saber de qué está hecho, pues podría beneficiarse de ciertos tratamientos.

Hipercalciuria (lo más común) → Se trata con hidroclorotiazida

Hiperoxaliuria (la 2ª más común) → Dieta baja en carne y frutos secos

Asociado a ITU (estruvita) → Se dejan ATB para tratar la ITU

15. Uropatía obstructiva baja, retención urinaria y Sondas urinarias

Uropatía obstructiva Baja

Causas

- Hiperplasia protática benigna
- Cáncer de próstata
- Estenosis uretral, solo en caso de que tenga los siguientes antecedentes
 - Uretritis
 - Trauma perineal
 - RTU

Clínica

- Síntomas obstructivos
 - Disuria de esfuerzo
 - Latencia
 - Intermittencia
 - Disminución del calibre miccional
 - Goteo terminal
- Síntomas irritativos
 - Nicturia
 - Polaquiritia
 - Incontinencia de urgencia o por rebalse

Diagnostico→ Clínico

Pero de todas formas se debe estudiar la causa, por lo cual, se pide:

- APE (screening de Ca próstata)
- Eco vesico-prostática (Para ver la obstrucción y el tamaño de la próstata)
- Uretrocistografía (en caso de sospechar estenosis uretral)

Complicaciones

- Hematuria recurrente
- ITU recurrente
- ERC post-renal
- Hidroureteronefrosis
- Urolitiasis
- Retención urinaria aguda

Tratamiento

- Médico (1ª línea)
 - Tamsulosina (antagonista Alfa 1)
- Quirúrgico→ Cuando no responde a tratamiento médico o que tenga complicaciones
 - RTU (<60cc)
 - Prostatectomía (>60cc)

Estenosis uretral→ Se estudia con UCG y se trata con RTU

Retención urinaria aguda

Complicaciones de la UOB

Clínica

- Dolor abdominal bajo
- Retención urinaria
- Globo vesical

Manejo

Instalar sonda Foley hasta que se haya operado el paciente

Si la sonda no pasa o hay sospecha de sección uretral se debe hacer una cistotomía

Sondas Urinarias

Sonda Nelaton→ Se usa de forma intermitente con técnica limpia (no estéril). Es de elección en vejiga neurogénica

Sonda Foley→ Útil para el sondeo permanente, se debe instalar con técnica estéril, por lo cual, es de elección en la retención urinaria aguda y pacientes que quedan sondeados a permanencia.

CASO

Paciente 75 años, antecedente de diabetes mal controlada, presenta incontinencia urinaria e ITU recidivantes.

Ecografía: Vejiga dilatada de paredes muy finas

Manometría: Sin contracciones del detrusor

Vejiga neurogénica → **Autocateterismo limpio con sonda Nelaton**

Tema 5: Salud Pública:

Clases:

1. Historia Natural de la Enfermedad
2. Determinantes del Nivel de Salud
3. Prevención en Salud
4. Nociones de Estadística
5. Epidemiología Descriptiva
6. Epidemiología Analítica
7. Medidas de Asociación e Impacto
8. Test Diagnósticos
9. Tipos de Estudios Epidemiológicos
10. Estructura del Sistema de Salud Chileno
11. Instituciones del Sistema de Salud Chileno
12. Administración en Salud
13. Plan AUGE
14. Licencias Médicas
15. Ética Médica
16. Responsabilidad Médica y Mala Praxis

Tema 5: Salud Pública
Clase 1: Historia Natural de la Enfermedad

Temario:

- Historia Natural en Enfermedades Infecciosas
- Ejemplos
- Historia Natural en Enfermedades No Transmisibles
- Ejemplos

I. Historia Natural en Enfermedades Infecciosas:

1. Periodos:

a) Incubación o Latencia:

- Paciente ya está contagiado, enfermo, pero que aún no ha desarrollado ningún síntoma
- Portador asintomático

b) Pródromo:

- Aparecen síntomas pero son inespecíficos que no se pueden diferenciar de otra enfermedad
- Ej: malestar general, fiebre, pero no se puede descubrir en primera instancia de qué infección se trata

c) Periodo de Estado o Clínico:

- Aparecen síntomas característicos de la enfermedad

d) Periodo de Resolución o Desenlace:

- Se sana
- Secuelas – crónica
- Se muere
 - **¿Cuándo contagia?:** en el periodo de transmisibilidad, y esta varía según la infección de la que se trate

2. Ejemplos:

Caso 1. Paciente se hace screening de ELISA VIH y resulta (+):

- Periodo de latencia: no hay ningún síntoma

Caso 2. Paciente de 19 años con ictericia y coluria. IgM – VHA (+):

- Periodo de estado o clínico: ya presenta la clínica

Caso 3. Niño con fiebre y malestar general. En su colegio hay un brote de meningitis meningocócica.

- Periodo de pródromo: está sólo con síntomas inespecíficos
 - Podría estar con meningitis o con cualquier otra infección por los síntomas iniciales

3. Vacunación:

- **¿Cuándo vacuno?**
 - Antes de contagiarse: debo evitarlo, cuando el paciente está totalmente sano
- **¿Cuándo aislo a un paciente con una infección?**
 - Durante el periodo de transmisibilidad
- **¿Cuándo trato?**
 - Depende de la enfermedad
- **¿Qué contactos estudio?**
 - A los que estuvieron en contacto con el paciente durante el periodo de transmisibilidad (que varía según cada enfermedad)

II. Historia Natural en Enfermedades No Transmisibles:

1. Periodos:

a) Periodo Prepatogénico:

- Presenta factores de riesgo (+)

b) Cambios Bioquímicos:

- Exámenes alterados, sin síntomas
- Se puede diagnosticar algunas enfermedades

c) Cambios Tisulares:

- Daño en distintos órganos, pese a que no hayan síntomas
 - Ej: que presente ya una nefropatía, retinopatía en el caso de la diabetes

d) Período Clínico:

- Aparecen síntomas de la enfermedad: ya sean los característicos o sus complicaciones

e) Periodo de Desenlace:

- Evoluciona a:
 - Daño crónico
 - Paciente fallece
- Lo importante es actuar lo antes posible para evitar que avance esta enfermedad crónica

2. Preguntas:

- **¿Cuándo se hace screening?**
 - Ideal: durante los cambios bioquímicos
 - No se puede hacer en todas las enfermedades. Ej: en la HTA, no hay cambios bioquímicos, sino que se hace el diagnóstico cuando se hace el examen físico. Sí se puede en la diabetes o dislipidemia por ejemplo.
- **¿Cuándo es más eficaz la intervención?**
 - Periodo prepatogénico: mientras antes se actúe es más costo efectivo y más eficaz

3. Ejemplos:

Caso 1: Paciente con pie diabético:

- Periodo de desenlace: ya está al final de la enfermedad

Caso 2: Paciente con TTGO 250 mg/dL a las 2 horas y HbA1c: 9.5%:

- Ya tiene el diagnóstico de una diabetes, y mal controlada → requerirá de insulina
- Periodo de cambios bioquímico: en caso de que no presente ningún síntoma:
 - Habría que estudiarlo con fondo de ojo, función renal y otros exámenes para evaluar si ya hay daño de otros órganos y que ya se encuentre en el periodo de cambios tisulares

Caso 3: Paciente con microalbuminuria en diabético:

- Microalbuminuria: alteración bioquímica, pero refleja el daño renal inicial:
- Periodo de cambios tisulares: ya tendría el diagnóstico de nefropatía diabética inicial

Caso 4: Paciente diabético con polidipsia + poliuria:

- Periodo clínico

Caso 5: Paciente hipertenso con ECG: HTVI:

- Periodo de cambios tisulares: no tiene ningún síntoma, pero ya tiene hipertrofia cardíaca → cambio estructural

Tema 5: Salud Pública

Clase 2: Determinantes del Nivel de Salud

Temas:

- Determinantes Sociológicos
- Determinantes Demográficos
- Pirámides Poblacionales
- Indicadores Materno – Infantiles
- Diagnóstico de Situación de Salud

I. Determinantes Sociológicos:

1. Generalidades:

a) Basta Tener Una Idea:

- **Económicos:** pobreza, desigualdad
- **Ambientales:** contaminación, clima
- **Sociales:** violencia, educación
- **Laborales:** estabilidad, legislación, seguridad en el trabajo
- **El sistema de salud:** instituciones, profesionales, recursos, organización → uno de los más importantes

II. Determinantes Demográficos:

1. Generalidades:

- **Natalidad:** nacidos vivos / población general del país
- **Mortalidad:** muertes / población general del país
- **Crecimiento Vegetativo:** natalidad – mortalidad
 - Chile: 14 x 1000 habs – 6 x 1000 habs → 8 x 1000 habs
 - Cuánto aumenta la población con el sólo hecho de que nazca o se muera la gente
- **Crecimiento Poblacional:** (natalidad – mortalidad) + (inmigración – emigración)
 - Hay que agregarle la inmigración y la emigración

III. Piramidales Poblacionales:

1. Tipo de Pirámides:

a) Joven:

- Característico de países de África
- Base ancha: mucha gente joven, niños
- Alta natalidad
- Alta mortalidad infantil
- Baja expectativa de vida: fallecen muy rápido pese a que nace mucha gente
- Problemas de salud más importantes:
 - Infecciones
 - Desnutrición: tanto infantil como de la población en general
- Focos de intervención de salud pública:
 - Enfoque en materno infantil



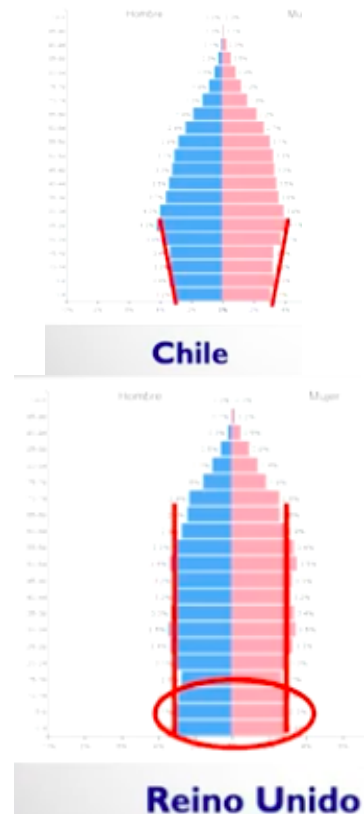
b) Transición:

- Se caracteriza en una caída en la natalidad en los últimos años
- Baja la mortalidad infantil
- Enfermedades más importantes:
 - Enfermedades crónicas no transmisibles
 - Enfermedades degenerativas
 - Cáncer
- Foco de intervención de la salud pública:
 - En el adulto mayor, pero aún hay que preocuparse de los niños y mujeres embarazadas → enfoque dual

c) Envejecida:

- “Forma de misil”:
 - Base muy angosta: natalidad muy baja
 - No se muere nadie
- Característico de los países desarrollados
- **Enfermedades más importantes:**
 - Enfermedades crónicas no transmisibles
 - Enfermedades degenerativas
 - Cáncer
- Foco de intervención de la salud pública:
 - En el adulto mayor
- **Pregunta EUNACOM:** la mortalidad infantil es un indicador del desarrollo de un país: sí lo es → entre más baja sea, mejor. Es sólo un indicador, no define el desarrollo de un país

** También es el caso de Chile, pese a que presente una pirámide de transición



IV. Indicadores Materno Infantiles:

Todas las tasas se calculan por los nacidos vivos (dividido)

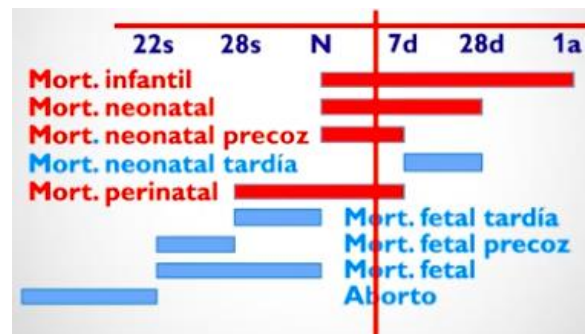
1. Mortalidad Infantil:

- **Mortalidad Infantil:** desde que nace hasta que cumple 1 año
- **Mortalidad Neonatal:** desde que nace hasta que cumple los 28 días de vida
 - **Mortalidad neonatal precoz:** desde que nace hasta los 7 días de vida
 - **Mortalidad neonatal tardía:** desde que cumple los 7 días hasta los 28 días de vida
- **Mortalidad Perinatal:**
 - Incluye además las muertes intrauterinas desde 28 semanas hasta las extrauterinas antes de los 7 días de vida
 - Sería la suma de la mortalidad perinatal tardía + mortalidad neonatal precoz
- **Mortalidad Fetal Tardía:**
 - Muertes intrauterinas desde las 28 semanas hasta el nacimiento
- **Mortalidad Fetal Precoz:**
 - Desde las 22 hasta las 28 semanas de gestación
- **Mortalidad Fetal:**
 - Durante todo el embarazo: desde las 22 semanas de gestación hasta el nacimiento → muertes intrauterinas
- **Aborto:**
 - Muertes intrauterinas antes de las 22 semanas de gestación



2. Ejemplos:

Caso 1. Si un recién nacido muere a los 6 días de vida:



3. Mortalidad Materna:

- **Causada** por embarazo, parto o puerperio
- **Ejemplos:**
 - Muerte por síndrome de HELLP → sí
 - Muerte por caída de altura durante el embarazo → no
 - Muerte por TEP en puérpera → sí
 - Embarazada con cardiopatía congénita se descompensa y muere → sí

V. Diagnóstico de Situación de Salud:

1. Etapas:

- **Diagnóstico:**
 - Se miden todos los determinantes, prevalencia, incidencia en una población
 - Así se tiene una idea de la situación de salud actual de dicha población
- **Planificación:**
 - Se diseña una política pública de salud a aplicarse y se fijan objetivos
 - Idealmente dejar establecidos los indicadores con los que se medirán estos objetivos, para evaluar si mi intervención tiene éxito o no
 - Diferencia con la programación: es lo mismo que la planificación pero en el corto plazo. En general, se considera más como parte de la fase de ejecución, ya que en la planificación se ve más a largo plazo, se ve la estrategia general, mientras que en la programación veo cómo voy ejecutándolo a corto plazo
- **Ejecución:**
 - Se ejecuta todo lo anterior, se lleva a acabo lo planificado anteriormente
- **Evaluación y Control:**
 - Se evalúa con los indicadores establecidos en etapas anteriores si es que mi intervención tuvo éxito o no

Tema 5: Salud Pública
Clase 3: Prevención en Salud

I. Medidas de Prevención en Salud:

1. Tipos:

a) Prevención Primaria:

- Trata de evitar la aparición de la enfermedad
- Actuar antes de que la enfermedad exista
- Manejo de los factores de riesgo
- **Intervenciones:**
 - Promoción de la salud: enseñarle a la población en general de que tenga hábitos de vida saludable
 - Promoción de protección: intervenir el ambiente: tener un sistema de alcantarillado bueno, que se recoja la basura, agua potable, calles seguras, señaléticas
 - Prevención específica: relacionadas con una enfermedad en específico. Ej: vacunas, fluorar el agua para evitar caries

b) Prevención Secundaria:

- En relación con las pruebas de screening: busca tener un diagnóstico precoz para tener un tratamiento oportuno antes de que la enfermedad sea incurable

c) Prevención Terciaria:

- Cuando la enfermedad ya está establecida. Busca curar la enfermedad, evitar recurrencias complicaciones y secuelas. Incluye también la rehabilitación de las secuelas

**** Mientras antes actúe, mejor y más barato**

	Enfermedad	Síntomas
Primaria	(-)	(-)
Secundaria	(+)	(-)
Terciaria	(+)	(+)
Cuaternaria	(-)	(+)

d) Prevención cuaternaria: sería como un trastorno somatomorfo, donde se busca evitarlos, pero que en verdad también son medidas de prevención primaria, en el sentido de que se evita el desarrollo de una enfermedad mental

2. Ejemplos:

- **Ley de uso de silla de auto en niños:**
 - Prevención primaria
- **TSH y PKU neonatal:**
 - Prevención secundaria
- **Vitamina K neonatal:**
 - Prevención primaria
- **PCR a contactos COVID 19:**
 - Prevención secundaria
- **Corticoides en COVID 19:**
 - Prevención terciaria
- **Mascarilla en COVID 19:**
 - Prevención primaria
- **Cuarentena en COVID 19:**
 - Prevención primaria
- **Enseñar hábitos saludables:**
 - Prevención primaria
- **Clases de educación física:**

- Prevención primaria
- **Restricción vehicular:**
 - Prevención primaria
- **APE y tacto rectal:**
 - Prevención secundaria
- **Microalbuminuria y IECA en DM2:**
 - Prevención secundaria → microalbuminuria (nefropatía)
 - Prevención terciaria → si se piensa en la diabetes
 - Sería más que nada secundaria, ya que no tiene síntomas
- **Salas ERA y salas IRA:**
 - Prevención terciaria
- **PNAC y PNI:**
 - Prevención primaria

3. ¿Cómo Afectan Estas Medidas En La Incidencia y Prevalencia?:

	Incidencia	Prevalencia
Primaria	↓: Disminuir los casos nuevos	↓
Secundaria	= Hago un diagnóstico de una enfermedad que ya existe: se mantiene incidencia	¿↓? Depende de la enfermedad
Terciaria	=	¿ ↓ ?

Ej: Sífilis: si la trato, disminuiré su prevalencia

Ej: VIH: enfermedad incurable: voy a aumentar su prevalencia, ya que nadie se muere de VIH, por lo que los casos totales, que son medidos en la prevalencia, irá aumentando con el tiempo

Prevalencia:

- Si es una enfermedad que se puede curar → disminuye
- Si es una enfermedad incurable → va a aumentar, ya que no dejará que los pacientes se mueran

Tema 5: Salud Pública

Clase 4: Nociones de Estadística

Temas:

- Tipos de Variables
- Medidas de Tendencia Central
- Medidas de Dispersión
- Percentil

I. Estadística Básica:

1. Variable:

Es algo que puede adoptar distintos valores

a) Tipos de Variables:

- **Cuantitativas:** expresan una cantidad
 - Continua: puede adquirir distintos valores dentro de los números reales. Ej: peso

- Discretas: pueden adquirir algunos de estos valores y no todos. Ej: tener 5 o 4 dedos, pero no puedo tener 3.5 dedos
- Características de variables cuantitativas:
 - Se pueden sumar, promediar, sacar desviación estándar
- **Cualitativas**: expresan una cualidad o calidad
 - Dicotómicas: simplemente 2 valores. Ej: hombre o mujer, enfermo o sano
 - Politómicas: pueden adquirir varios valores. Ej: puede tener el tratamiento A, B y C
 - Ordinales: son con algún orden, pero que sigue expresando una calidad. Ej: “poco, muy poco, regular, mucho”
 - Características de variables cualitativas:
 - La única forma de expresarla es qué tanto se repiten, su frecuencia, su porcentaje. Ej: “el 80% está enferma”

b) Características:

- La misma información se puede ocupar con distintos tipos de variables
 - **Ej 1: valores de PA de una persona:**
 - Cuantitativa: 145/99 mmHg
 - Dicotómica: normal o alterada
 - Ordinal: normal, PA alta, HTA etapa I, HTA etapa II
 - **Ej 2: peso de una persona:**
 - Cuantitativa: pesa 75 kg
 - Cualitativa: normal o anormal
 - Ordinal: bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad

c) Ejemplos:

No confundirlo con la frecuencia o promedio.

- **Ej 1: el 90% de los pacientes con antibiótico se curan vs el 70% de los pacientes con placebo:**
 - 90 % y 70 % NO son las variables
 - Variable es el distinto valor que puede adquirir en 1 persona.
 - No puede una persona “curarse en un 70%”
 - Las variables son 2: el tratamiento que se está dando (aquí adquiere 2 valores: es dicotómica → antibiótico versus placebo) y la otra variable es si se mejora sí o no → son 2 variables cualitativa dicotómica.
- **Ej 2: los hombres tienen Hb de 15 mg/dL y las mujeres de 15 mg/dL en promedio:**
 - Las variables no son los 15 mg/dL en promedio, sino que es el sexo por un lado (hombre versus mujer → cualitativa dicotómica), y la segunda variable sería el nivel de Hb (variable de tipo cuantitativa)
- **Ej 3: se siguen a pacientes COVID 19 con obesidad y con normopeso y se calcula el porcentaje de casos graves:**
 - Las variables serían: normopeso versus obesidad (peso: expresado de manera cualitativa), y la segunda variable sería si se agrava o no (cualitativa dicotómica)

II. Medidas de Tendencia Central:

Sólo se pueden calcular en las variables cuantitativas

1. Tipos:

- Promedio o media
- Mediana o p50
- Moda: número que más se repite

2. Ejemplos:

Caso 1: Glicemias: 67 – 70 – 70 – 72 – 88 – 150 – 180 – 620

- Media: suma total y dividido por el total → 164, 6 mg/dL
- Mediana: ver los 2 números que están en el centro, el que está al medio → 80: si hay 2 valores como mediana, se deben promediar
- Moda: número que más se repite → 70

- ¿Qué sucede si elimino el 620 mg/dL? Ya que es un valor extremo:
 - Media: 99.6 mg/dL
 - Mediana: 72 mg/dL
 - Moda: 70 mg/dL
 - Afecta a la media principalmente

III. Medidas de Dispersión:

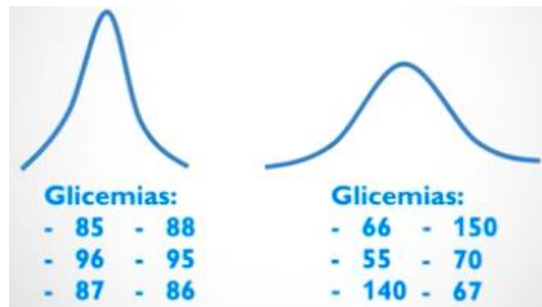
Sólo se pueden calcular en las variables cuantitativas

1. Tipos:

- Desviación estándar: es promedio en el que los distintos valores se alejan del promedio
- Varianza
- Rango
- Error estándar

2. Ejemplos:

- Curva 1: hay menos dispersión:
 - Todos los valores se concentran cerca del promedio
- Curva 2: hay más dispersión



IV. Percentil:

1. Generalidades:

- “Está por sobre ese % de la población en ese determinado valor
- Ej: p99 versus p75 en altura de un paciente:
 - p99: su altura es mayor a la del 99% de la población general
- Otro ejemplo: feto en p75 de peso → su peso es mayor que el 75% de los fetos de esa misma edad gestacional

2. Equivalencia aproximada de los percentiles respecto a la DS:

Esto aplica sólo en una curva de distribución normal

- **Promedio = p50** → suele estar en el p50
 - p50 es lo mismo que la mediana pero no es lo mismo que el promedio, pero aquí es lo contrario, dado que es una curva con distribución normal → el promedio sí será equivalente a la mediana
- **± 1 DS:**
 - + 1 DS: suele calzar con p84
 - -1 DS: suele calzar con p16
- **± 2 DS:**
 - +2 DS: suele calzar con p98
 - -2 DS: suele calzar con p2
- **± 3 DS:**
 - +3 DS: suele calzar con p100
 - -3 DS: suele calzar con p0

Tema 5: Salud Pública
Clase 5: Epidemiología Descriptiva

Temas:

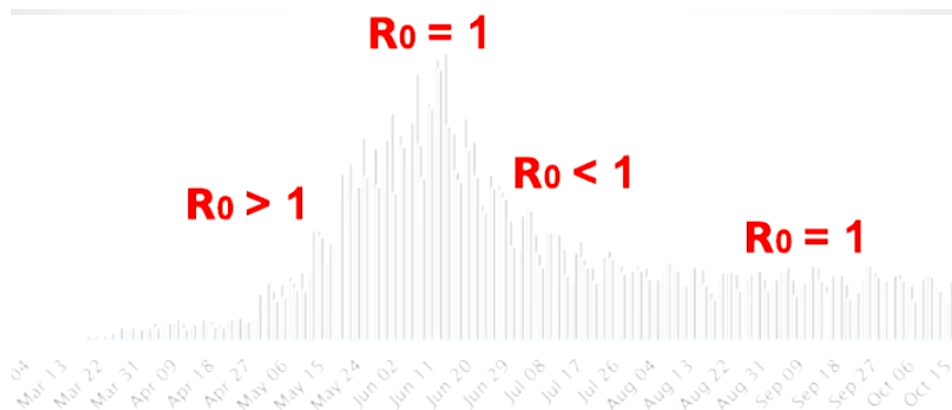
- Incidencia
- Prevalencia
- Letalidad
- Mortalidad
- Vigilancia Epidemiológica
- Conceptos Epidemiológicos

** La epidemiología descriptiva busca generar información y no busca generar causalidad (causa – efecto)

I. Tasa de Morbilidad:

1. Tipos:

- **Prevalencia:**
 - **Casos actuales / población total**
 - Es la probabilidad de estar enfermo. Como son los casos actuales, son los casos que están enfermos en ese momento
 - Cálculo: se obtiene mediante estudios transversales o de prevalencia
- **Incidencia:**
 - **Casos nuevos en X lapso de tiempo / población que tiene el riesgo de desarrollar la enfermedad**
 - Es la probabilidad de enfermarme hacia el futuro. Lo mide dentro de 1 año.
 - Ej: si la tasa de incidencia es de 5 x 100.000 → el riesgo de que me enferme durante ese año va a ser de 5 en 100.000
 - Cálculo: se obtiene mediante estudios de cohorte → tomo a un grupo de personas y los voy siguiendo en el tiempo y calculo la incidencia acumulada durante ese periodo de tiempo
- **Tasa de ataque:**
 - Variante de la incidencia.
 - Mide la incidencia en corto plazo (brotes y epidemias)
 - Se calcula el índice “R0”: muestra la velocidad con la que se están contagiando las personas actualmente:
 - **$R_0 > 1$** → enfermedad en expansión: cada vez hay más casos
 - **$R_0 = 1$** → enfermedad se mantiene: los casos nuevos son igual a los casos que se están mejorando o falleciendo (saliendo)
 - **$R_0 < 1$** → enfermedad en reducción



2. ¿Incidencia o Prevalencia?

- Ambas muestran la morbilidad, pero tienen distintos objetivos.
- **Impacto de enfermedad infecciosa** → tasa de incidencia
 - Y para todas las enfermedades agudas de una enfermedad, ya que interesan los casos nuevos
- **Impacto en enfermedad crónica (DM2, ERC, DHC, VIH, VHC)** → tasa de prevalencia
 - Se incluye VIH y VHC, ya que también son enfermedades crónicas
- **Impacto de enfermedad de corta duración (IAM, TEP)** → tasa de incidencia
 - Porque es una enfermedad aguda que puede mejorar o morir en pocos días
 - Prevalencia no sirve mucho ya que deja de ser un caso actual
- **Impacto de cáncer de pulmón** → tasa de incidencia
 - Enfermedad de alta letalidad
- **Impacto de obesidad** → tasa de prevalencia
- **Impacto de FRCV** → tasa de prevalencia
- **Determinar éxito de campaña de prevención de VIH** → tasa de incidencia
 - Quiero ver si la campaña tuvo éxito o no, ver que realmente haya caído la tasa de incidencia de la enfermedad para decir que la campaña fue exitosa
- **Calcular costos del tratamiento del VIH en el país** → tasa de prevalencia
 - Para saber el número de TARV que necesito para pacientes VIH, debo conocer el número de pacientes que actualmente están enfermos
- **Determinar éxito de tamizaje de cáncer** → tasa de mortalidad del cáncer
 - EUNACOM: en el caso de que no aparezca la tasa de mortalidad, se usa la tasa de prevalencia
- **Determinar éxito de vacunación** → tasa de incidencia

II. Tasa de Mortalidad y Letalidad:

1. Definiciones:

a) Tasa de Mortalidad:

- **Muertes / población total**
 - Ve al total de la población
 - Es la probabilidad de morir de determinada enfermedad
 - Se obtiene el valor con estudios de cohortes: de la población completa

b) Tasa de Letalidad:

- **Muertes / casos de esa enfermedad**
 - Mira sólo a las personas que enfermaron de eso
 - Probabilidad de morir de determinada enfermedad si es que yo me enfermo de esa enfermedad
 - Ej: paciente contrae Hanta → se quiere saber cuál es la probabilidad de morir por Hanta
 - Se obtiene el valor con estudios de cohortes: de los enfermos solamente

2. Ejemplos:

- **Determinar la gravedad de la enfermedad** → tasa de letalidad
- **Impacto de la pandemia COVID 19** → tasa de mortalidad
- **Éxito de un tratamiento nuevo** → viendo la reducción de la letalidad
- **Éxito de una campaña de screening** → tasa de mortalidad (su reducción)
 - Objetivo a largo plazo: reducir la tasa de mortalidad por esa enfermedad que se está buscando tempranamente

III. Vigilancia Epidemiológica:

Es como se vigilan las distintas enfermedades infecciosas que hay, para evitar que se expanda, contagie...

1. Tipos de Vigilancia Epidemiológica:

a) Vigilancia Activa:

- Notificación obligatoria (ej: COVID 19)
 - Inmediata: ante la mera sospecha, se debe notificar de manera inmediata
 - Diaria: se hace durante el mismo día o al día siguiente
 - Depende de la virulencia: qué tan grave y contagiosa es la enfermedad. También si es una enfermedad muy rara para el país (ej: Enfermedad de Lyme)
- Ante sospecha de la enfermedad se debe notificar a la **Seremi de Salud (representa al MINSAL en las regiones)**
- **Enfermedades a notificar:** botulismo, brucelosis, ántrax (por *Bacillus anthracis*), cólera, difteria, *Haemophilus influenzae* invasivo, meningococo, transmitidas por mosquitos (dengue, fiebre amarilla, fiebre del Nilo, malaria, Chikungunya, Zika), leptospirosis, peste, poliomielitis, rabia humana, sarampión, SARS, hantavirus, y triquinosis.
 - Brotes (intoxicación alimentaria)
 - Muerte no explicada en persona sana
 - Algunas ETS (VIH, sífilis, gonorrea)

b) Vigilancia Centinela:

- Se hace a través de centros centinelas: algunos hospitales, consultorios, clínicas
- Son los obligados que estudian la etiología y la notifican. Ej: enfermedades respiratorias virales → deben ver qué virus.
- Son los únicos encargados de notificar
- Infecciones frecuentes: diarreas e infecciones virales respiratorias
- **Enfermedades a notificar:** coqueluche, Chagas, fiebre tifoidea y paratifoidea, hepatitis virales (A-E), hidatidosis, parotiditis, rubéola, psitacosis, gonorrea, sífilis, VIH, tétanos, tuberculosis, lepra y tifus exantemático.
 - Enfermedades respiratorias altas
 - Diarreas
 - Varicela
 - Resto de ETS

c) Vigilancia Pasiva:

- Control estadístico anual
- Se aplica a la gran mayoría de las enfermedades
- Se entrega la información a la Seremi de distintas regiones y MINSAL, haciendo un informe final
- **Enfermedades a notificar:**
 - Infecciones no transmisibles (ej: ITU, celulitis) o leves

IV. Conceptos Epidemiológicos:

1. Definiciones:

a) Endemia:

- Casos ± estables (variación estacional) → ej: Hanta en Chile es endémico, pero en el verano hay más casos porque hay más ratones que la transmiten

b) Brote:

- Cuando hay ≥2 casos relacionados, fuera de lo habitual
- Deben estar relacionados de alguna u otra forma.

c) Epidemia:

- Cuando el brote ya se hace más grande. Hay muchos casos, algo fuera de lo habitual
- En el momento en que empieza a perderse la trazabilidad, se considera epidemia (cuando aún se puede trazar, es un brote)

d) Pandemia:

- Cuando ya se extiende a nivel mundial.

2. Ejercicios:

- **Varios casos de coqueluche en un colegio** → brote
- **Hay 50 casos aproximados de Hanta al año** → endemia
- **El año 2019 hubo más casos de Hanta que lo habitual** → endemia
 - Pero si están relacionados entre sí en una determinada ciudad → brote
- **VIH** → pandemia
- **Ébola en Sierra Leona y Siberia** → brote
 - Aunque fueron casi 10.000 casos → epidemia localizada en esos países
- **Chagas en Chile** → endemia
 - Hay casos todos los años
- **Dengue en Isla de Pascua** → brote

Tema 5: Salud Pública

Clase 6: Epidemiología Analítica

Temas:

- Criterios De Causalidad: Hills
- Test De Hipótesis (Concepto)
- Error Aleatorio
- Error Sistemático O Sesgo
- Ejemplos
- Validez, Fiabilidad Y Relevancia Clínica

**** Busca relaciones de causa – efecto (test de hipótesis)**

I. Criterios de Causalidad:

1. Criterios de Causalidad de Bradford Hill:

No tiene porque estar todos

- **Asociación o de fuerza de asociación:**
 - Al aumentar la frecuencia de la causa, aumenta la frecuencia del efecto
 - Se mide con RR (riesgo relativo) y OR (odds ratio) → medidas de asociación
 - **Caso EUNACOM:** hay 4 estudios que muestran que hay un RR entre 3 y 4 para para X factor de riesgo en relación a una determinada enfermedad // están dando que el RR es entre 3 y 4, por lo que uno dice que hay fuerza de asociación, pero también había congruencia, ya que los ensayos clínicos mostraban un resultado similar.
- **Congruencia:**
 - Se refiere a que varios estudios buscan la misma relación causa – efecto, tengan resultados similares
- **Reproductibilidad:**
 - Que el estudio pueda ser replicable
 - Relación con algunos eventos que ocurren 1 vez → Ej: pandemia de COVID y uno queda con la duda de cuál fue su origen (no hay algo que se pueda replicar)
- **Dosis – efecto:**
 - Si a mayor dosis tengo un mayor efecto, lo más probable es que lo que yo esté administrando sea la causa de ese efecto
- **Plausibilidad biológica:**
 - Que presente una explicación científica racional
 - **Caso EUNACOM:** se ha entendido que la úlcera gástrica se genera por la inflamación gatillada por H. pylori // en este caso, habría una explicación científica racional
- **Secuencia temporal:**
 - Causa ocurre antes que el efecto

- Es el que debe estar siempre
- **Especificidad:**
 - Causa con efecto único
- **Analogía:**
 - Causa similar con efecto similar
- **Evidencia experimental:**
 - Ensayos clínicos lo confirman
- **Cesación de la exposición:**
 - Cesa la causa y cesa el efecto
 - **Caso EUNACOM:** se ha visto que el tratar el H. pylori disminuye la recurrencia de las úlceras // hay cesación de la exposición: cesa la causa, por lo que deja de estar el H. pylori y esto disminuye la recurrencia de la úlcera (que sería el efecto)

II. Test de Hipótesis:

1. Tipos de Hipótesis:

- **H0 o hipótesis nula:**
 - No hay diferencias → ambas cosas son iguales // la característica que estoy buscando no está presente
- **H1 o hipótesis alternativa:**
 - Sí hay diferencias entre lo que se busca // la característica que estoy buscando sí está presente

III. Error Aleatorio:

1. Introducción:

- Al tener el test de hipótesis, se hace un trabajo estadístico y se puede determinar el error aleatorio
- Es el error causado por el azar
- La forma de disminuir el error aleatorio es aumentando el tamaño muestral ("n") → si el tamaño de la muestra es pequeño, es más alta la probabilidad de que haya un error aleatorio

2. Tipos de Error Aleatorio:

- **Tipo 1 o α :**
 - Sí hay diferencias ... pero en verdad, al final no hay (hay un error, me equivoqué)
 - Este es el más grave: decir que X fármaco sí sirve o que Y cosa era la causa de alguna enfermedad, pero que al final no lo es, es lo más grave
- **Tipo 2 o β :**
 - No hay ninguna diferencia... pero en verdad, al final sí las hay

3. Definiciones:

- **Número "p":**
 - Es la probabilidad de cometer un error aleatorio tipo 1
 - Si el riesgo es < 0.05 o 5% → gana H1:
 - "Sí hay diferencia y el "p" es de 3%: sí, efectivamente hay diferencia y es estadísticamente significativa"
 - Si el riesgo es ≥ 0.05 o 5% → gana H0:
 - "Sí hay diferencia, pero no puedo descartar H0 ya que son diferencias que no son estadísticamente significativas porque el riesgo de estar cometiendo un error tipo 1 es muy alto"

IV. Error Sistemático o Sesgo:

1. Tipos de Sesgo:

a) Sesgo de Selección:

- Voy y selecciono una muestra que **no es representativa** de la población
- Para evitarlo → aleatorizar

- Ej: si comparo 2 fármacos, mando uno a un lado y el otro a otro lado, todo al azar, y de manera al azar, voy asignando un medicamento o el otro
- Tipos:
 - Exclusión: excluye a un grupo relevante. Ej: investigo acerca del COVID pero dejo fuera a todos los pacientes con FRCV (cuando en verdad se sabe que esto se asocia a mayor riesgo)

b) Sesgo de Información o Medida:

- Se mide mal, obteniendo una información inadecuada
 - Instrumento: no calibrado o no validado
 - Del evaluador (*)
 - Del evaluado: no da la información correcta (*)
 - (*): Se utiliza el doble ciego, con el fin de tener una información correcta. Ej: ni el evaluador ni el evaluado sabe con qué medicamento está, por lo que de esta forma no se induce que diga más o menos información
 - Memoria: se les olvida. Característico de los estudios retrospectivos. Ej: pregunto si ha consumido alcohol y dice que no, pero se le olvidó que antes tomaba hasta morir todos los fines de semana cuando estudiaba
 - Pérdidas: característico de los estudios que duran mucho tiempo y que son de tipo prospectivos, en el sentido de que debo ir siguiendo a los pacientes pero éstos nunca vuelven a control, por lo que nunca sé qué es lo que pasó con ellos

c) Sesgo de Variable Confundente:

- Son aquellas que están asociadas a la variable dependiente y a la variable independiente también
- Ej: se hizo un estudio en el que comparaba el consumo de OH y el desarrollo de cáncer de esófago, y se vio que sí había una asociación que era importante, pero luego se vio que el consumo de OH se asociaba al consumo de cigarrillo y que el cáncer de esófago también se asociaba al consumo de cigarrillo, por lo que la variable confundente era el consumo de cigarrillo que estaba relacionada con ambas variables
- Al hacer un análisis estratificado, un análisis estratificado, se soluciona.
 - Del ejemplo anterior: se hizo un análisis estratificado y se separó entre pacientes que fumaban y no fumaban, comparándose entre ellos y se descubrió que los pacientes que no fumaban no tenían ninguna relación entre el consumo de OH y el desarrollo de cáncer de esófago. Mientras que en el grupo de los que sí fumaban, sí tenían relación, por lo que se interpretó de que el OH no era la causa del cáncer de esófago, pero sí era un coadyuvante del efecto del cigarrillo para generar el cáncer de esófago. Con esto, aparece una nueva variable confundente, que es el número de cigarrillos fumados (los que consumen OH fuman en mayor cantidad).

d) Sesgo de Notificación:

- No se comunica información relevante porque no estaba antes incluida en el diseño del estudio
- Ej: veo que con la vacuna para el COVID, los pacientes tienen caída del cabello, pero como no estaba inicialmente en la lista de efectos adversos, simplemente no lo comunico

e) Sesgo de Publicación:

- No es del estudio, sino que es del sistema de publicación en general
- Se publica menos lo no interesante. Ej: H0 gana.

V. Ejemplos:

Caso 1: Un estudio de casos y controles estudia la relación entre el hábito de consumir OH y el cáncer de vejiga, encontrando asociación. No se evaluó el hábito tabáquico.

- Sesgo por variable confundente.

Caso 2: un estudio de cohortes muestra que el grupo de obesos desarrolló diabetes con más frecuencia que el grupo de normopeso, sin embargo, se realizó el doble de glicemias en los obesos.

- Sesgo de medición → de frecuencia de la medición: entre más veces yo evalúo, más riesgo tengo de encontrar esa alteración

Caso 3: se les pide a los sujetos de un estudio, que compara 2 antiHTA, que se controlen la PA en sus casas, sin embargo, no se los capacita en la toma de presión.

- Sesgo de medición

Caso 4: una vacuna experimental presenta 4 suicidios entre las 200 personas que la recibieron, lo que no se informa, por no estar en los outcomes a evaluar.

- Sesgo de notificación

Caso 5: se observa que las mujeres que consumen ACO tienen más incidencia de CaCU.

- Sesgo de variable confundente
 - Hay una variable confundente: actividad sexual → se relaciona con los ACO porque se usan para no embarazarse y también se relacionan con el CaCU, ya que su causa es el VPH, que se transmite por vía sexual

Caso 6: Se tratan con anticuerpos monoclonales a los pacientes COVID-19 más graves y se compara con pacientes con cuadro moderado, tratados con corticoides.

- Sesgo de selección
 - Yo seleccioné a los pacientes de manera no aleatorizada, sino que arbitraria, lo que induce a un error

VI. Otros Conceptos:

1. Fiabilidad:

- Se relaciona con el error aleatorio → sin error aleatorio, con " p " < 0.05

2. Validez:

- Sin sesgos, sin error sistemático
- Validez externa: es la capacidad de extrapolar los resultados de un estudio bien hecho, a una población que es distinta. Ej: si hice un estudio en gente joven, no puedo extrapolarlo a las mujeres embarazadas

3. Relevancia Clínica:

- Útil desde el punto de vista clínico
- El estudio está bien hecho, pero los resultados que dan, no me son útiles desde el punto de vista clínico
- Está lleno de estudios muy bien hechos, con " p " < 0.05, pero al ver los resultados, no tiene ninguna importancia

4. Ejemplos:

Caso 1: la Hidroxicloroquina demostró disminuir la replicación viral in vitro.

- No hay relevancia clínica, ya que lo que importa es que si disminuye o no la mortalidad o letalidad de la enfermedad

Caso 2. Los anticuerpos monoclonales redujeron la letalidad en un 20%, $p = 0.2$

- No hay fiabilidad, hay un error aleatorio muy grande (porque " p " es ≥ 0.05) → no hay diferencias significativas
- Caso 3: el estudio no incluyó a los adultos mayores

- Sesgo de selección. Habría un sesgo de exclusión.

Tema 5: Salud Pública

Clase 7: Medidas de Asociación e Impacto

Temas:

- Medidas de asociación:
 - Riesgo relativo
 - Odds ratio
- Intervalos de confianza
- Medidas de impacto:
 - Riesgo atribuible
 - NNT y NNH
- Consejo

** Es parte de la epidemiología analítica

I. Medidas de Asociación:

1. Riesgo Relativo (RR):

- Indica el número de veces que aumenta el riesgo de algo
 - Ej: el RR es 5 → aumenta 5 veces el riesgo
- Si fuese un $RR < 1$ → disminuye el riesgo
 - Ej: si el RR es 0.5 → disminuye el riesgo a la mitad
- **Forma de cálculo:** división de las incidencias → incidencia de los expuestos (un factor de riesgo, un medicamento) dividido en la incidencia de los no expuestos
 - $RR = I_e / I_o$
- Como requiere de incidencias, sólo se puede calcular en los ensayos que se ven hacia el futuro, en estudios prospectivos: ensayos clínicos (en donde se suelen ver RR bajos, < 1) o en los ensayos de cohorte (el clásico para los factores de riesgos) → no se puede usar en los casos y controles ni en los estudios transversales, ya que aquí no hay una incidencia
 - Sólo en estudios prospectivos: ensayos clínicos y de cohorte
- **Forma de interpretación:**
 - $RR > 1$: ↑ el riesgo
 - $RR = 1$: sin asociación (no aumenta ni disminuye el riesgo)
 - $RR < 1$: ↓ el riesgo de lo que estoy evaluando

2. Odds Ratio (OR):

- Es un estimador del riesgo relativo
- Cuando no tengo incidencia y no puedo calcular el RR, se está obligado a estimarlo mediante el odds ratio: sería el de elección en:
 - Estudios transversales (o de prevalencia)
 - Estudios retrospectivos, como casos - control
- **Forma de cálculo:**

	Enfermos	Sanos
--	----------	-------

Expuestos a un Factor de Riesgo	A	B
No Expuestos a un Factor de Riesgo	C	D

- **A:** personas que estaban expuestas al factor de riesgo pero que se enferman
- **B:** los que estaban expuestos al factor de riesgo pero que se mantuvieron sanos
- **C:** personas que no estaban expuestas al factor de riesgo pero que aún así se enfermaron
- **D:** los que no estaban expuestos al factor de riesgo y que se mantuvieron sanos

3. Fórmulas:

- **Riesgo relativo (RR):** $\{A / (A + B)\} / \{C / (C + D)\}$
 - $RR = I_e / I_o \rightarrow$ incidencia de los expuestos dividido en la incidencia de los no expuestos
 - Incidencia de los expuestos = $\{A / (A + B)\}$:
 - Personas expuestas a un factor de riesgo que se enfermaron dividido en el total de los expuestos
 - Incidencia de los no expuestos = $\{C / (C + D)\}$
 - Personas que se enferman dentro de los no expuestos al factor de riesgo dividido en el total de los no expuestos
- **Odds ratio (OD):** $A \times D / C \times B$
 - Habría que multiplicar de manera cruzada
- **Tips:**
 - Fijarse de que el cuadro esté bien formulado: que los expuestos estén arriba y los no expuestos abajo, y que los enfermos estén a la izquierda y los sanos a la derecha

II. Intervalo de Confianza (IC):

1. Generalidades:

- IC 95 % sería el equivalente al “p” < 0.05 (P < 5% es algo significativo)
 - Si pasa por el 1: no significativo
 - Si no pasa por el 1: sí es significativo
- ¿Qué significa que el IC no pase por el 1?:
 - Significa lo mismo de que el “p” sea < 0.05 $\rightarrow$ sí hay diferencia significativa

2. Ejemplos:

Caso 1. RR = 2.4. IC 95% [2,0 – 2,8]

- $RR = 2,4 \rightarrow$ aumenta el riesgo $\rightarrow$ sería un factor de riesgo que lo aumenta 2,4 veces
- IC va desde 2,0 (que es mayor a 1) hasta 2,8 (que también es mayor a 1) $\rightarrow$ no pasa por el 1 $\rightarrow$ sí es estadísticamente significativo
- Es un IC estadísticamente significativo, por lo que aumenta el riesgo de manera estadísticamente significativa

Caso 2. OR = 1,2. IC 95% [0,7 – 2,0]

- $OR = 1,2 \rightarrow$ OR es > 1 $\rightarrow$ aumenta el riesgo, sí es un factor de riesgo
- IC va desde 0,7 (que es < 1) hasta 2,0 (que es > 1) $\rightarrow$ aquí sí pasa por el 1 $\rightarrow$ esto NO es significativo
- Con el OR de 1,2, = va a aumentar el riesgo en un 20%. Sin embargo, con un IC de 95%, es decir, con un 95% de confianza puedo decir que disminuye el riesgo en un 30% (que es lo que le falta al 0,7 del IC para llevar a 1 = 0,3 = 30%) o me lo aumenta al doble. Entonces: ¿aumenta o disminuye el riesgo?
 - No es significativo (dado que el IC para por el 1)

Caso 3. RR = 14. IC 95% [2 – 32]

- $RR = 14 \rightarrow$ aumenta 14 veces el riesgo $\rightarrow$ es un factor de riesgo muy importante
- IC 95% [2 – 32] $\rightarrow$ es muy amplio: 2 $\rightarrow$ aumenta el riesgo 1 vez, hasta 32 $\rightarrow$ aumenta el riesgo hasta 32 veces.

- En este caso, pese a un IC muy amplio, no pasa por el 1:
 - Sí es estadísticamente significativo (no sé cuánto aumenta el riesgo, ya que el IC es muy grande, pero sí estoy segura de que sí aumenta el riesgo, ya que no pasa por el 1)

Caso 4. RR = 0,85. IC 95% [0,75 – 0,95]

- RR = 0,85 → disminuye el riesgo
- Con un 95% de confianza, disminuye el riesgo en un 25% hasta un 5% → ambos son números < 1:
 - Sí es estadísticamente significativo.
 - En este caso, no sería un factor de riesgo, ya que el RR es < 1, por lo que sería un factor de protección

Caso 5. OR = 0,2. IC 95% [0,01 – 0,4]

- OR = 0,2 → disminuye el riesgo en un 80% (lo disminuye porque es < 1)
- IC muy amplio, pero aún así son todos < 1 → no pasa por el 1
 - Sí es estadísticamente significativo → es un factor que disminuye el riesgo (es un factor de protección real estadísticamente significativo)

Caso 6. RR = 0,76. IC 95% [0,35 – 1,02]

- RR = 0,76 → disminuye el riesgo en 24%
- Con un 95% de confianza, puedo asegurar de que disminuye el riesgo en un 65% o que en verdad lo puede aumentar en un 2% → IC pasa por el 1
 - No hay diferencias estadísticamente significativas (ya que puede aumentar o disminuir el riesgo)

3. Preguntas EUNACOM:

Caso 1. Vendedor dice “doctor: este medicamento reduce a la mitad las muertes por IAM”

- RR = 0,5 → efectivamente disminuye el riesgo a la mitad
- IC 95% [0,3 – 0,7] → ambos son números < 1, por lo que sí son estadísticamente significativos
 - En este caso, sí es estadísticamente significativo
- IC 95% [0,07 – 1,22] → sí pasa por el 1
 - No habrían diferencias estadísticamente significativas

Caso 2. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante?

- a) RR = 0,5. IC 95% [0,4 – 0,6]
 - RR es < 1: no es un factor de riesgo (es un factor protector). IC: estadísticamente significativo.
 - Respuesta incorrecta
- b) RR = 2,5. IC 95% [2,0 – 3,0]
 - RR es > 1: sí es un factor de riesgo. IC entre 2 y 3 (no pasa por el 1): sí es estadísticamente significativo.
- c) RR = 4,5. IC 95% [3,0 – 6,0]
 - RR es > 1: sí es un factor de riesgo. IC entre 3 y 6 (no pasa por el 1): sí es estadísticamente significativo.
- d) RR = 7,3. IC 95% [0,9 – 15,3]
 - RR es > 1: sí es un factor de riesgo. IC 0,9 es < 1 hasta 15,3 → sí pasa por el 1. Queda descartado por pasar por el 1 (no sé si que realmente disminuye o aumenta el riesgo).
 - Respuesta incorrecta
- e) RR = 2,6. IC 95% [0,7 – 5,2]
 - RR es > 1: sí es un factor de riesgo. IC 0,7 es < 1 hasta 5,2 → sí pasa por el 1. Queda descartado por pasar por el 1 (no sé si que realmente disminuye o aumenta el riesgo).
 - Respuesta incorrecta
- ** Respuesta: puede ser la alternativa B o C, ya que ambas son un factor de riesgo y son estadísticamente significativas, por lo que debo fijarme en el riesgo relativo más grande, que sería la alternativa C, ya que aumenta el riesgo 4,5 veces versus la alternativa B, que aumenta el riesgo 2,5 veces.
 - Respuesta correcta: alternativa C

III. Medidas de Impacto:

1. Riesgo Atribuible:

- Es el aumento de riesgo en términos absolutos = es el exceso de riesgo que una persona tiene por estar expuesta a un factor de riesgo → es el exceso de riesgo en pacientes expuestos
- **Forma de cálculo:**
 - $RA = I_e - I_o$
 - Incidencia de los expuestos menos la incidencia de los no expuestos → aquí es la diferencia de las incidencias, mientras que en el riesgo relativo era la división de las incidencias.
- **Forma de interpretación:**
 - $RA > 0$: ↑ el riesgo
 - $RA = 0$: sin impacto (o no hay ninguna asociación)
 - $RA < 0$: ↓ el riesgo
- **Permite calcular el NNT y NNH:**
 - **NNT**: number needed to treat (número necesario para tratar)
 - Es el número de pacientes al que yo debo darle un tratamiento, un medicamento, para que 1 se mejore debido al medicamento (que 1 se beneficie debido a esa intervención)
 - Son las personas que se iban a morir sin un tratamiento, pero que yo al dárselo, se va a mejorar gracias a éste
 - Lo óptimo es que tenga un valor de 1
 - $NNT = 1 / (-RA) \rightarrow 1$ dividido en la reducción de riesgo atribuible
 - **NNH**: number needed to harm (número necesario para herir)
 - Es el número de pacientes al que yo debo darle un tratamiento, un medicamento, para que 1 tenga efectos adversos debido al medicamento
 - Lo óptimo es que sea infinito (que no tenga eventos adversos, o que uno tenga infinitos pacientes para que 1 tenga un evento adverso)
 - $NNH = 1 / RA \rightarrow 1$ dividido en el riesgo atribuible de efectos adversos
 - NNT y NNH son una forma de expresar el riesgo atribuible que hay que saber interpretar

2. Ejemplos:

	NNT	NNH
Fármaco A	4	200
Fármaco B	40	60
Fármaco C	4	60
Fármaco D	40	200

- **¿Cuál de los 4 fármacos es el mejor?**
 - **NNT**: es el número de pacientes que se va a beneficiar de un tratamiento. Lo mejor es que sea lo menor posible:
 - $NNT = 4 \rightarrow$ con darle el tratamiento a 4 personas, 1 se beneficia
 - $NNT = 40 \rightarrow$ con darle el tratamiento a 40 personas, 1 se beneficia → es mucho mayor el número de pacientes a tratar para lograr obtener un beneficio
 - **NNH**: es lo contrario que el NNT: entre más pacientes le de el medicamento para que 1 tenga un evento adverso, es mejor:
 - $NNH = 60 \rightarrow$ de 60 personas que les de el tratamiento, 1 va a tener un evento adverso
 - $NNH = 200 \rightarrow$ de 200 personas a las que les de el tratamiento, 1 va a tener un evento adverso → en este caso, lo ideal es que sea el número mayor (es mejor que de 1 evento adverso en un grupo de 200 personas que en uno de 60 personas)
 - Respuesta: fármaco A:
 - NNT más bajo
 - NNH más alto

3. Riesgo Atribuible Poblacional (RAP):

- Es el exceso de riesgo en la población donde algunos están expuestos (en esta población hay personas que sí están expuestas al factor de riesgo, como también hay personas que no están expuestas)
- **Fórmula de cálculo:**
 - $RAP = I_p - I_o$
 - I_p : incidencia en la población
 - I_o : incidencia en los no expuestos

4. Riesgo Atribuible Porcentual (RA%):

- Es el porcentaje de casos causados por el factor de riesgo en los pacientes expuestos → qué porcentaje de los casos es causado por un factor de riesgo en los pacientes expuestos
- **Fórmula de cálculo:**
 - $RA\% = (I_e - I_o) / I_e$

5. Riesgo Atribuible Poblacional Porcentual (RAP%):

- Es el porcentaje de casos causados por el factor de riesgo en la población (donde hay personas tanto expuestas al factor de riesgo como no expuestas)
- **Fórmula de cálculo:**
 - $RAP\% = (I_p - I_o) / I_p$

6. Resumen:

- Riesgos porcentuales: habla del porcentaje de casos causados por un factor de riesgo
- Riesgos poblacionales: habla de la población
- Riesgos no poblacionales: habla de los pacientes expuestos al factor de riesgo

7. Ejemplos:

Caso 1. El 90% de los cánceres de pulmón son causados directamente por el cigarrillo

- Habla del RAP% (habla del porcentaje de casos causados por un factor de riesgo en una población, donde unas personas fuman y otras no fuman). El factor de riesgo sería el cigarrillo

Caso 2. Si no existiera la obesidad y los FRCV, se habrían evitado el 50% de las muertes por COVID.

- Habla del RAP% → ¿Qué porcentaje de muertes se habrían evitado si se elimina el factor de riesgo? Un 50%, ya que dice que el 50% de las muertes por COVID fueron causadas por estos factores de riesgo (obesidad y FRCV)

Caso 3. En los diabéticos, el 80% de las ERC se deben a la diabetes.

- No habla de la población completa, sino que habla sólo de los diabéticos: son los expuestos al factor de riesgo (que es la diabetes)
- Habla del RA% → habla del porcentaje de casos de una enfermedad causada por un factor de riesgo en el grupo de pacientes expuestos

Caso 4. Una vacuna presentaba efectos adversos, pero el placebo también. Se calculó que, de cada 8 pacientes vacunados, uno tenía efectos adversos atribuibles a la vacuna.

- Habla del NNH (sería un NNH = 8, ya que 1 de cada 8 pacientes que recibieron la vacuna, presentó efectos adversos de la vacuna)

Tema 5: Salud Pública
Clase 8: Test Diagnósticos

Temas:

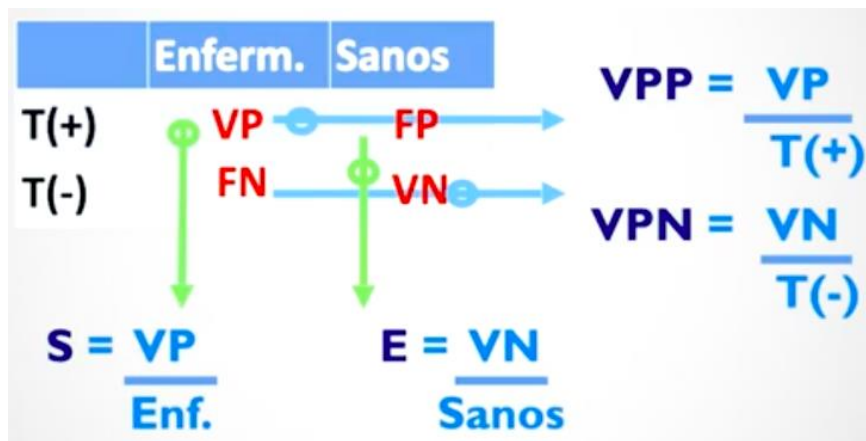
- Cálculo de:
 - Sensibilidad
 - Especificidad
 - Valor Predictivo Positivo (VPP)
 - Valor Predictivo Negativo (VPN)
- Ejemplos y Preguntas

I. Test Diagnóstico:

1. Generalidades:

	Enfermos	Sanos
Test (+)	Verdadero positivo	Falso positivo
Test (-)	Falso negativo	Verdadero negativo

- **Sensibilidad:**
 - Se calcula hacia abajo
 - $S = VP / \text{total de enfermos (VP + FN)}$
 - Habla del total de enfermos, de un paciente del cual estoy segura de que está enfermo, se habla de sensibilidad
- **Especificidad:**
 - Se calcula hacia abajo
 - $E = VN / \text{total de sanos}$
 - Habla del total de los pacientes sanos, de un paciente del cual estoy completamente segura de que está sano, se habla de especificidad
- **Valor predictivo positivo:**
 - Se calcula hacia el lado
 - $VPP = VP / \text{test (+)}$
 - Habla de los tests que están positivos (tanto de una persona como del total de exámenes positivos)
- **Valor predictivo negativo:**
 - Se calcula hacia el lado
 - $VPN = VN / \text{test (-)}$
 - Habla de los tests que están negativos (tanto de una persona como del total de exámenes negativos)



II. Ejemplos:

Caso 1. Un paciente tiene su APE elevado. ¿Tiene cáncer?:

- APE elevado = test positivo → el paciente tiene cáncer con una probabilidad de un VPP de su APE elevado

Caso 2. ¿Qué porcentaje de los cáncer de mama se diagnostican con la mamografía?:

- Habla del total de los cáncer de mama → sensibilidad

Caso 3. El 5% de las personas sanas tiene ANA (+):

- Es la especificidad: porque habla de que el total de personas sanas, un 5% de los exámenes están alterados (están falsamente positivos), en cambio, el 95% estaría negativo
 - Especificidad del 95%

Caso 4. La probabilidad de detectar a un enfermo:

- Sensibilidad: se define como la probabilidad de un test de detectar a un enfermo (de resultar un examen positivo en un paciente que de seguro está enfermo)

Caso 5. “A mi mamá le salió normal la colonoscopia”:

- Se sabe que ya tiene un resultado que está negativo → ve el VPN

Caso 6. Para descartar una enfermedad se requiere de un examen con alta:

- Sensibilidad:
 - Los exámenes muy sensibles resultan alterados o positivos en los pacientes enfermos, por lo tanto, si está negativo, quiere decir que no está enfermo, por lo tanto, descarto. ¿Porqué lo descarto?: porque si hubiese estado enfermo, porque es muy sensible, le habría salido un examen alterado.
 - Un examen muy sensible va a detectar a todos los enfermos, por lo tanto, si dice que está negativo, es porque no está enfermo, por lo que descarto.

Caso 7. Para confirmar una enfermedad se requiere un examen con alta:

- Especificidad:
 - Porque los exámenes muy específicos resultan negativos en los pacientes sanos, por lo tanto, si este paciente hubiese estado sano, le habría salido negativo. Por lo tanto, si está positivo, es porque no está sano y está enfermo.

III. Test de Screening:

1. Características:

- No se usa en cualquier enfermedad: se usa en una enfermedad potencialmente grave
- Etapa inicial tratable
- Test barato
- Test con alta sensibilidad: porque se necesita que descarte
- Especificidad: al menos que sea moderada a alta
- ¿Y la prueba confirmatoria?
 - Debe tener alta sensibilidad y especificidad

Tema 5: Salud Pública

Clase 9: Tipos de Estudios Epidemiológicos

Temas:

- Tipos de Estudios
- Estudios Ecológicos
- Estudios Transversales o de Prevalencia
- Estudios de Casos y Controles
- Estudios de Cohortes
- Ensayos Clínicos
- Otros Estudios Experimentales

I. Tipos de Estudios:

1. Estudios Observacionales:

a) Observacionales:

- **Ecológicos:**
 - Sujetos de estudio son poblaciones (un país o una ciudad; no son personas, no son individuos)
 - No usa las variables individuales de cada una de las personas (ya que no estudia a las personas, sino que una población), sino que utiliza variables agregadas (o secundarias)
 - Ej: la tasa de mortalidad de una enfermedad en un país // el promedio de consumo de OH o cigarrillo en una población.
 - Son estudios baratos: exploratorios → simplemente sirve para generar una idea general de si hay relación entre una cosa o no
 - NO olvidar: siempre hay que hacer un ajuste de tasas (al menos, por edad)
 - Comparo poblaciones entre Nigeria y Rusia en relación al cáncer de próstata, pero me queda la duda si es que realmente hay una diferencia entre ambos países o está dado por la diferencia por las edades de la población (ya que la población de Rusia tiene una edad promedio mayor respecto a la de Nigeria, hay más adultos mayores y más gente) → se hace un ajuste de tasas por edad, y cuando se realiza, se puede hacer una comparación fidedigna
 - Ejemplo: se revisa en internet el consumo de cigarrillos per cápita en 50 países y se contrasta con las tasas de mortalidad de distintos cánceres (intentando buscar una relación entre el tabaquismo y el cáncer)

- Aquí, simplemente se buscó en internet el consumo per cápita y también la tasa de mortalidad de los distintos cánceres
- **Transversales o de Prevalencia:**
 - Cada individuo se evalúa sólo una vez (pero el estudio puede durar mucho) → mido las variables en un sujeto sólo en 1 instante; la prevalencia son los casos actuales, los que ocurren en un determinado momento.
 - Se mide la prevalencia de distintas enfermedades y también de los factores de riesgo → puedo buscar una asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad
 - Concluye asociación, pero no causalidad → como se mide en un solo instante, no tengo la relación de la temporalidad (no tengo una causa que ocurra antes del efecto): puedo ver asociación, pero no puedo inferir que haya causalidad → es una diferencia de los estudios transversales, comparado con los estudios longitudinales (que son estudios que se extienden a lo largo del tiempo)
 - Se calcula el odds ratio (OR)
 - Ejemplo: se mide la HbA1c en 100 pacientes obesos y en 200 pacientes normopeso y se comparan los resultados.
 - Se midió sólo en una oportunidad
 - Si se controlara nuevamente, se transformaría en un estudio de cohorte: es el estudio que hace un seguimiento hacia el futuro
- **Caso – control:**
 - Tiene sesgo de memoria: se le pregunta hacia el pasado si es que estuvo expuesto a un factor de riesgo
 - Se seleccionan enfermos de determinada enfermedad (casos) y sanos (controles) y se ve si estuvieron expuestos a distintos factores de riesgo.
 - Es un estudio retrospectivo (se extiende hacia el pasado), pero longitudinal (se extiende en el tiempo)
 - Es de bajo costo. Es el óptimo en enfermedades raras o que demoran mucho en aparecer (en estos casos, sería mejor que el estudio de cohortes.
 - Ej: quiero buscar acerca de la Histiocitosis X, por lo que lo mejor es buscar ya a los pacientes que sí la tengan y los comparo con los controles y pregunto hacia el pasado acerca de distintos factores de riesgo
 - Ej: intento buscar la relación entre la enfermedad de Alzheimer y la lactancia materna, debo buscar a lactantes que estén con lactancia materna exclusiva y los sigo en el tiempo para ver si les da Alzheimer o no (igual es un mal ejemplo, ya que primero se morirá el investigador antes de que les de Alzheimer)
 - Ejemplo real: se comparan 100 pacientes con cáncer de pulmón (casos) y 100 pacientes sanos (control) y se les pregunta por su hábito de fumar.
 - En los casos y controles se calcula el odds ratio
- **Cohortes:**
 - Se calcula el riesgo relativo: porque se calculan las incidencias hacia el futuro
 - Tiene el sesgo por pérdidas: dado que demora bastantes años y uno tiene que asegurarse que los pacientes lleguen al control en el futuro → las pérdidas van alterando la calidad del estudio
 - Se seleccionan pacientes expuestos y pacientes no expuestos a un factor de riesgo y se siguen en el futuro, determinando la aparición de enfermedades
 - Diferencia con casos y controles: en este, se empezaba con los enfermos y sanos, mientras que en cohorte se empieza con gente sana, donde los divido en expuestos y no expuestos a un factor de riesgo y luego voy a ver a futuro si se enferman o no
 - Mide la incidencia y es prospectivo (va hacia el futuro; también es longitudinal: porque se extiende en el tiempo)
 - Es de mayor costo, pero de mejor calidad
 - ¿Ensayo clínico?:
 - El ensayo clínico es experimental, se hace una intervención

- Es el óptimo si quiero buscar una medida o un tratamiento que ayuda a evitar una enfermedad
- En cambio, si es para un factor de riesgo, tengo la limitante de la ética, ya que no puedo llegar y decir “quiero buscar si el arsénico produce alguna enfermedad, así que a un grupo le daré placebo y al otro le doy arsénico”, mientras que en el estudio de cohortes ya puedo ver a personas que estaban expuestas al arsénico por alguna razón, y los sigo a futuro, viendo realmente si la exposición a este metal genera alguna enfermedad
- Ejemplo 1:
 - Se seleccionan fumadores y no fumadores y se siguen por 10 años, evaluando la aparición de cáncer y patología cardiovascular
- Ejemplo más importante: Framingham → busca los FRCV. Si bien, demora mucho tiempo en aparecer, es un estudio de buena calidad.

2. Estudios Experimentales:

** Estudios experimentales: se controla una variable en que se realiza una intervención

- **Ensayo clínico:**
 - Distintos grupos son expuestos a distintas intervenciones, donde se puede incluir el placebo y la mezcla de las distintas intervenciones
 - Ej: a distintos grupos los expongo a un fármaco A, a otro a un fármaco B, a otro a cirugía, a otro al fármaco A + cirugía
 - Se miden los distintos resultados:
 - Veo si se mejoran, si mueren, si tienen efectos adversos, complicaciones
 - Mide incidencia y es prospectivo (porque va hacia el futuro)
 - ¿Aleatorizados?
 - Es para evitar el sesgo de selección
 - ¿Doble ciego?
 - Se busca evitar el sesgo de información o de medición, donde el paciente y el observador no saben la intervención a la que será expuesto
 - Ej:
 - Se tratan con Hidroxicloroquina versus placebo los pacientes COVID 19 graves
 - Placebo: se usa para evitar el “efecto placebo”
 - Limitación ética placebo:
 - Puedo dar un placebo cuando no existe un tratamiento que sea bueno
 - Ej: a un grupo con PNA le doy un nuevo antibiótico mientras que al otro grupo le doy un placebo
 - Tiene distintas etapas: laboratorio, animales, voluntarios sanos, voluntarios enfermos
- **Ensayo de campo:**
 - Intervención: medida preventiva → no cura, sino que previene
 - Ej: vacunas
 - Los participantes son sanos → quiero evitar que se enfermen en el futuro
 - Requieren un “n” (tamaño muestral) más grandes → elevan el costo del estudio
 - Ej: estudios de vacunas COVID – 19
- **Intervención comunitaria:**
 - Es un estudio experimental en donde se interviene a la población, no en el sujeto
 - No sé realmente si le llegará a toda la población, y en qué intensidad le llegará la intervención
 - Ejemplos:
 - Campañas educativas (educación sexual, prevención del cólera, VIH, drogas) → no sé quienes verán los afiches y la información que aporte
 - Yodar la sal, fluorar el agua, folatos en la harina
- **Metanálisis:**
 - Es un estudio que resume muchos ensayos clínicos similares

- Tienen la mejor evidencia científica → ya que estudia varios de los ensayos clínicos que ya existen, “agarrando” los datos que están en estos y los une e interpreta de una manera agregada

**** IMPORTANTE:** No confundir los estudios experimentales y observacionales, con estudios descriptivos con estudios analíticos:

- Estudios descriptivos: buscaban encontrar una determinada información (ej: incidencia o la historia natural de una enfermedad)
- Estudios analíticos: buscaban una relación causa – efecto mediante test de hipótesis (ej: estudios de casos y controles o los de cohortes habitualmente son analíticos, en el sentido en que buscan si un factor de riesgo es la causa de una enfermedad o no)

3. Estudios Cuasiexperimentales:

- Sin grupo de control
- Siguen siendo experimentales, ya que hay una intervención, en donde se controla una variable, pero presenta limitaciones:
 - No se sabe si los resultados obtenidos tienen efecto placebo o no (porque no tienen un grupo control)
 - No se sabe si hay otros sesgos que no se estén midiendo correctamente

Tema 5: Salud Pública

Clase 10: Estructura del Sistema de Salud Chileno

Temas:

- Estructura General (Seguros y Prestadores)
- Fonasa
- Isapres
- Prestadores de Salud
- Sistema de Salud Laboral

I. Estructura General del Sistema de Salud Chileno:

1. Seguros:

- Sistema de cotización obligatoria en que todos los trabajadores deben entregar un porcentaje de su remuneración a las aseguradoras de salud
- Libertad de optar si contratan en:
 - **Fonasa:** es un seguro de salud público (fondo nacional de salud):
 - “Estado \$ \$ \$ “: Financiamiento estatal: el estado sobra impuestos a la población, y con estos hace la ley de presupuesto del estado y con eso, le asigna una cantidad de recursos a la salud
 - “7% \$ \$ “: 7% del. Aporte de la remuneración de los trabajadores
 - “Copago \$ “: Pacientes Fonasa, habitualmente pueden tener una cobertura que no es completa, y pueden dar un copago: al momento de atenderse en algunos lugares, ellos pagan con su dinero la diferencia que no les cubre Fonasa

- **Isapres:** seguros de salud privados (sistema de salud previsional):
 - “7% - \$ \$ \$ \$ “: Financiamiento aportado por el trabajador.
 - “Estado \$”: al ser privadas, el rol del estado es mínimo: aporta con las garantías de salud (GES) o con Ley Ricarte Soto → estado sí les da parte del presupuesto a las Isapres, con el fin de asegurar la cobertura de sus afiliados también
- Si bien, tienen la libertad de escoger cualquiera, tienen la obligación de escoger uno de los dos

2. Prestadores:

Son las personas que entregan los servicios de salud: médicos, hospitales, clínicas. Se divide en prestadores del:

- **Sistema público:**
 - **Prestadores del sistema público:**
 - Hospitales públicos
 - Consultorios
 - SAPU, SAR, Cefsam, Cosam → son de atención primaria, pero como “subespecializados”
 - Lo habitual, es que la gente Fonasa se atienda en el sistema público
- **Sistema privado:**
 - **Prestadores institucionales:**
 - Clínicas
 - Centros médicos
 - **Prestadores individuales:** prestan sus servicios de manera particular. Por ejemplo, con algún convenio con Isapres. Son los profesionales de salud propiamente tal:
 - Médicos
 - Enfermeras
 - Kinesiólogos
 - Dentistas
 - Lo habitual, es que la gente de Isapres se atienda en el sistema privado
- No es excluyente: la gente de Fonasa puede escoger atenderse en el sistema privado, y la forma más frecuente es mediante la modalidad de libre elección. Por lo contrario, muchas veces, las Isapres sí tienen una buena cobertura en el sistema público: hay que ver bien el plan de salud y averiguar dónde es que le cubre mejor, si en el sistema público o en el sistema privado



3. Generalidades:

- Quien fiscaliza todo el sistema de salud chileno es el SIS (superintendencia de salud). Fiscaliza a:
 - Todos los seguros (Fonasa e isapres): que cumplan con su cobertura y calidad
 - Prestadores: que cuenten con los permisos necesarios por la seremi, que cuenten con la acreditación de las personas que trabajan en el lugar, etc...

II. FONASA:

1. Generalidades:

- Malo: un único plan de salud → cuando se opta por Fonasa, uno opta por la cobertura que presta y no se puede escoger algo que se ajuste a los requerimientos de salud del paciente
- En general, se paga el 7% de la remuneración del trabajador
 - Actualmente, personas a honorarios también se les resta un porcentaje de sus honorarios para que tengan cobertura de salud también
 - El 7% lo retiene el empleador: se le descuenta al trabajador, por lo que quien hace el aporte es el trabajador, pero quien lo entrega a la institución (Fonasa) es el empleador
 - En el caso de personas que trabajan a honorarios, quien retiene el 7% es el cliente a quien le emito la boleta de honorarios, y esto se entrega al SII (servicio de impuestos internos), donde después de haber pagado todos los impuestos que se tengan que pagar, la diferencia se manda a Fonasa o a la Isapre, y por otra parte, la otra diferencia se manda a la AFP
- Fonasa se clasifica en 4 grupos según los ingresos de las personas que están afiliadas a este plan de salud:

FONASA	Ingresos	Copago	MLE
A	Sin ingresos	0 %	No (**)
B	\$	0 %	Sí
C	\$ \$	10 % (*)	Sí
D	\$ \$ \$ (ganan > \$600.000 aprox)	20 % (*)	Sí

- Fonasa C y D pagan un copago en las urgencias y por atenciones en hospitalizaciones
- (*): no pagan en atención primaria: porque la atención primaria es más eficiente y es más que nada, un incentivo para que la gente consulte más tempranamente en la atención primaria que ir a un lugar mucho más costoso, que sería la atención secundaria y terciaria
- MLE = modalidad de libre elección
 - Fonasa B, C y D sí tienen MLE: Fonasa cubre un % en el caso de atenderse en el sistema privado
 - Esto se hace mediante la compra de un bono para el sector privado ("bono Fonasa"), en donde el prestador privado tiene un convenio con Fonasa, aceptando atender por Fonasa y el paciente compra este bono pagando una parte de la atención (por ejemplo: paga 8.000 pesos por una consulta con oftalmólogo, que es lo que Fonasa no le cubre). Al comprar el bono, podrá atenderse con el médico que escogió, donde Fonasa le pagará la otra parte al especialista.
 - Aquellos médicos que trabajan con esta modalidad, quienes hacen un convenio con Fonasa, se les obliga a atender a los pacientes que consultan por Fonasa en el lugar donde atiendan. No se les puede negar la atención, discriminar ni limitar la cantidad de pacientes a atender por Fonasa. También se comprometen a cobrar sólo 1 bono: no se les puede cobrar más de 1 bono ni cobrar alguna diferencia.
- (**): Se dice que la gente de Fonasa no tiene derecho a MLE, por lo que se atienden en el servicio público y nada más, no pueden ir al sistema privado.
 - Una excepción a esto, son los adultos mayores de Fonasa A, donde ellos sí tienen derecho a atenderse en la modalidad de libre elección

III. Isapres:

1. Generalidades:

- Tienen distintos planes de coberturas: cubren más en unas clínicas que otras, o cubren más ciertas prestaciones que otras. Por ello, tienen distintos precios. Hay una variedad de planes a los que se puede optar.
- Forma de pago: 7% de las remuneraciones + diferencia
- Problemas:
 - Alza unilateral de los planes: ilegal
 - Pre existencias: dejaban fuera a estos pacientes → ilegal
 - Discriminación por edad: cobran más a los adultos mayores → ilegal

IV. Prestadores de Salud:

1. Sistema de Salud Público:

- **Hospitales:**
 - Otorgan atención secundaria y terciaria
 - Son administrados de los servicios de salud
 - Descentralizados
 - Financiamiento: aporte estatal
- **Consultorios:**
 - Otorgan atención primaria
 - Dependen de la municipalidad: dependen de la administración de cada comuna
 - Por lo anterior, es que son aún más descentralizados
 - Financiamiento:
 - Aporte per cápita (\$ \$ \$)
 - Aporte municipal voluntario (\$ \$)
 - ** Es la municipalidad quien otorgará esta plata, pero la ley de presupuestos del estado tiene una asignación que es el “aporte per cápita”: a cada consultorio se les aporta cierta cantidad de plata según el número de pacientes inscritos → una comuna con un mayor número de pacientes inscritos recibirá un aporte mayor

2. Sistema de Salud Privado:

- **Prestadores institucionales:** clínicas y centros privados
- **Prestadores individuales:** médicos, dentistas...
 - Ambos prestadores:
 - Pueden presentar convenios tanto con isapres como por Fonasa
 - Requieren de la certificación, acreditación por SIS (superintendencia de salud)
 - Requieren de la autorización de la seremi de salud para poder funcionar

V. Sistema de Salud Laboral:

1. Generalidades:

- **Encargado de cubrir:**
 - Accidentes del trabajo y del trayecto (desde el trabajo hacia la casa y viceversa)
 - Enfermedades profesionales: aquellas enfermedades ocasionadas por el mismo trabajo: no cubre si es que a un trabajador le da COVID19 en el trabajo (salvo a los profesionales de salud) o que le de un IAM mientras trabaja
- **Forma de seguro:**
 - Mutuales
 - Financiado por el empleador: 0.85% de la remuneración del trabajador
- **Prestadores:**
 - Mismas mutuales
- Hay una igualdad entre los seguros y el prestador: es más eficiente, pero hay un sesgo en cubrir, ya que es la mutual quien administra la plata y es la misma mutual quien ocupa esa plata en entregar la cobertura de salud al paciente
- El sistema de salud laboral es fiscalizado por la superintendencia de seguridad social (“Suseso”): es quien determina si una enfermedad es laboral o no → no se relaciona con el MINSAL, sino que con el ministerio del trabajo)

Tema 5: Salud Pública

Clase 11: Instituciones del Sistema de Salud Chileno

I. Mapa de Instituciones del Sistema de Salud Chileno:

1. Introducción:

- MINSAL tiene 2 subsecretarías:
 - Subsecretaría de redes asistenciales: se relaciona con:
 - Servicios de salud: Hospitales → recordar que los servicios de salud son autónomos, por lo que es más una relación de coordinación, supervisión y fiscalización, más que una relación totalmente directa
 - Municipalidad: Consultorios
 - Prestadores del sector privado
 - Subsecretaría de salud pública: es la que se encarga de las políticas públicas relacionadas con salud
- MINSAL, a su vez, se relaciona con las Seremis de salud (secretarías regionales ministeriales de salud), que son las que están en las distintas regiones (16 regiones = 16 seremis)
 - Seremis no sólo representan al MINSAL, sino que también a las subsecretarías
- Hay otras instituciones adicionales:
 - Fonasa
 - Isapres
 - Mutuales
 - ISP (instituto de salud pública): encargado de la fiscalización de las farmacias, medicamentos, laboratorios (tanto de producción de fármacos como de toma de muestras), confirmar enfermedades de relevancia clínica (Ej: VIH, COVID19, etc). ** Importante recordar que fiscalizan a los laboratorios, porque el ISP tiene laboratorios
 - SIS (superintendencia de salud)
 - Cenabast (central nacional de abastecimiento): es la encargada de comprar insumos “al por mayor” (para tener medicamentos de menor costo) para luego entregarlos a los distintos servicios de salud o a quienes deseen comprarlos.
 - INE (instituto nacional de estadística): se relaciona con el ministerio de economía (*)
 - Suseso (superintendencia de seguridad social): se relaciona con el ministerio de trabajo (*)
 - (*): no se relacionan directamente con el MINSAL



II. ¿Qué Institución Lo Hace?:

1. Generalidades:

- Autorización sanitaria a restaurantes → Seremi
- Fiscaliza a isapres y Fonasa → **superintendencia de salud**
- Fiscaliza a las mutuales → **Superintendencia de seguridad social**
- Lleva estadísticas de salud y otros temas → INE

- Tiene la última palabra en las licencias médicas → **Suseso**
- Tiene la última palabra en la denegación de cobertura → **superintendencia de salud**
- Puedo alegar de que la mutual dice que mi enfermedad no es laboral → **Suseso**
- Puedo alegar porque la isapre terminó mi contrato → **Superintendencia de salud**
- Autoriza a que se pueda abrir una sala de procedimientos o un pabellón → **Seremi de salud**
- Autoriza a hacer una consulta médica → **No se requiere autorización** (siempre y cuando no se realicen procedimientos)
- Certifica la calidad de un prestador → **Superintendencia de salud**
 - En los prestadores institucionales, lo que se les exige es la autorización de la seremi
 - Luego se requiere de la certificación o autorización de calidad otorgada por la superintendencia de salud
- Lleva el registro de los prestadores individuales e institucionales → **Superintendencia de salud**
- Compra insumos al por mayor y más baratos y los distribuye en la red asistencias → **Cenabast**
 - Es bueno porque es más barata, pero no tiene una gran variedad de insumos
 - No se está obligado a comprarle a la Cenabast (se puede comprar de manera externa también)
- Lleva el programa PNI y PNAC → **MINSAL**
 - Viene asociada a la subsecretaría de salud pública, pero en trabajo conjunto con la subsecretaría de redes asistenciales, quien es que finalmente organiza a que la red asistencial administre las vacunas y entregue los alimentos complementarios
- Dan seguros de salud a los pacientes:
 - Público → **Fonasa**
 - Privado → **Isapres**
 - A esto hay que sumarle los seguros complementarios: seguro catastrófico, seguros específicos (Fonasa e isapres son seguros obligatorios)
- Dan seguros de mala práctica a los médicos → **Aseguradoras individuales**
- Gestiona la disponibilidad de camas UCI en pacientes COVID19 → **Subsecretaria de redes asistenciales:**
 - Es quien coordina con las distintas UCI del país, viendo dónde hay disponibilidad de camas para eventualmente trasladar pacientes
- Es la máxima autoridad sanitaria en Chile → **MINSAL** (ministro de salud)
- Sanciona a los médicos por negligencia médica → **Tribunales de justicia**
 - Sanción civil (multa)
 - Sanción penal (cárcel)
 - Sanción administrativa en el sistema de salud o en el consultorio en el que están

Tema 5: Salud Pública

Clase 12: Administración en Salud

Temas:

- Conceptos en Administración
- Ejemplos
- Indicadores de Gestión de Salud
- SS (Servicios de Salud) y Municipalidades

I. Conceptos en Administración:

1. Definiciones:

- **Eficacia:**
 - Es la capacidad de generar resultados favorables en un ensayo clínico, en condiciones controladas; la que genere algún beneficio bien estructurado y controlado
 - No me importa cuánto cueste, sino que importa que genere un beneficio
 -
- **Efectividad:**
 - Es la capacidad de generar resultados favorables en la vida real, en situaciones similares que ocurren en la actividad normal de las personas.
 - No me importa cuánto cueste, sino que importa que genere un beneficio
- **Eficiencia:**
 - Es la capacidad de generar resultados favorables a menor costo
 - Lo que interesa es que sea a un costo más bajo
- **No confundir con “costo – beneficio”:** es la diferencia de los costos y beneficios económicos medidos en dinero.
 - Ej: sé que al tratar una enfermedad con un fármaco de muy alto costo, aún así, me va a ahorrar muchas hospitalizaciones a largo plazo, versus a otros medicamentos que son de menor costo, pero que a largo plazo, sería de mayor costo
 - “Por muy caro que sea, me sale más barato que los otros costos asociados a futuro”

II. Ejemplos de Conceptos en Administración:

Caso 1. En COVID, los corticoides tienen menor mortalidad que la Hidroxicloroquina:

- No están hablando de los costos
- Si es en un ensayo clínico → eficacia
 - Esta es la respuesta más probable, que esté dentro de un ensayo clínico
- Si dicen que los corticoides tienen menor mortalidad que la Hidroxicloroquina después de haberlo observado y dado en el manejo en pacientes de X hospital → efectividad

Caso 2. Los ACO fallan porque no se los toman:

- Hay un problema con la efectividad: todos saben que los ACO son muy eficaces cuando uno se los toma, por lo que en la vida real, si no se los toma, son poco eficaces (en la vida real sería “difícil seguir con esta indicación”)

Caso 3. El tratamiento con Omeprazol es mucho más barato e igual de efectivo que con Esomeprazol:

- El Omeprazol es de menor costo que el Esomeprazol
- Como dicen que es igual de efectivo, se está hablando de la eficiencia → se están preocupando de los costos
 - Omeprazol sería más eficiente que el Esomeprazol

Caso 4. “Sólo si el screening está alterado, haremos la RNM”:

- Se habla de eficiencia: los screening son exámenes más baratos, por lo que en general, la utilidad de un screening, es justamente que es que sea más barato y eficiente que llegar y hacer una RNM a todos los pacientes
- Respuesta: Eficacia

III. Indicadores de Gestión de Salud:

1. Introducción:

- **Índice de ocupación de camas:**
 - Fórmula de cálculo: $\text{Días cama ocupados} / \text{días cama disponibles}$
 - Días cama ocupados: del total de camas que había, lo multiplico por el total de días del mes y veo en cada día cuántas eran las camas ocupadas. Ej: se calcula sumando el número de pacientes que hubo cada día. Importante su interpretación: “hubo un 93% de días cama ocupados”: estuvo muy lleno,

faltan camas. “Hubo un 20% de días cama ocupados”: las camas estuvieron mucho tiempo vacías, sobran camas. Tener un 70 – 80% de días cama ocupados refleja que hubo una buena utilización del recurso y, al mismo tiempo, hay posibilidad de recibir más pacientes según la demanda hospitalaria

- Días cama disponibles: total de capacidad de las camas durante ese mismo mes. Ej: en una UCI hay 10 camas, y el mes tuvo 30 días → 10 camas x 30 días → 300 días cama disponible
- **Índice de hospitalización promedio (*):**
 - Uso para evaluar la producción o eficiencia de un hospital
- **Días de licencia promedio (*):**
 - Uso para evaluar la producción o eficiencia de una mutual: aquí, el costo más caro son las licencias médicas: intentan dar licencias por el menor tiempo posible y mejorarlos en el menor tiempo posible
- **** (*)** Es el tiempo en que uno se demora en sanar a un paciente.
- **Pacientes atendidos por hora:**
 - Eficiencia de un profesional de la salud en general: al profesional se le paga por hora, por lo que la eficiencia del recinto en el que trabaje, va a depender del número de horas trabajadas

Tema 5: Salud Pública

Clase 13: Plan AUGE

Temas:

- Concepto GES
- Principios AUGE
- Ley Ricarte Soto

I. Concepto GES o AUGE:

1. Generalidades:

- **GES:** garantías explícitas de la salud
- **AUGE:** acceso universal a las garantías explícitas
- **¿Qué es una garantía?**
 - Es un derecho + mecanismo de exigibilidad → puedo exigir mi derecho a tratamiento de inmediato, “a la fuerza”
 - La constitución asegura el derecho a la integridad psíquica y física, pero no asegura el derecho a la salud en Chile
- **Ley AUGE:**
 - Garantiza prestaciones en una lista de patologías (algunos fármacos, tratamientos, atención por un determinado especialista) → se otorga el derecho a que se entregue de manera obligatoria, con un mecanismo de exigibilidad, estas distintas prestaciones de salud
 - Como es un derecho del paciente, el médico está obligado a informárselo al paciente y notificarlo. Si no lo hace, el médico es el responsable de todos los gastos del paciente que eventualmente puede incurrir en ello
 - La lista de patologías se hizo por un criterio de eficiencia: se garantiza la atención de las enfermedades en donde cada peso que se inyecta al sistema, se transforma en más salud

- Si no se cumplen los plazos de las distintas garantías que la ley establece:
 - Se puede notificar en la superintendencia de salud (SIS) y quejarme. Esta es la institución que se encarga de velar por el cumplimiento del AUGE
 - Si la SIS no resuelve el problema, se puede eventualmente ir a los tribunales de justicia y exigir mis derechos

II. Principios AUGE:

1. Generalidades:

- **Acceso universal:**
 - Tanto los pacientes Fonasa como isapre tienen el derecho de acceder a las distintas prestaciones
- **Oportunidad:**
 - Es que sea oportuno: que se cumpla en un determinado plazo: están establecidas dentro de la ley
- **Calidad:**
 - Asegurar la calidad de los prestadores AUGE acreditados (dado por el SIS)
- **Protección financiera:**
 - Subsidio estatal: el estado otorga parte del presupuesto público para financiar directamente las distintas patologías AUGE.
 - No es sólo para Fonasa, sino que también ayuda en parte a las isapres → aporte estatal + prima GES (plan de salud de isapre aumenta un poco su valor en base a la cobertura del GES)

III. Ley Ricarte Soto:

1. Generalidades:

- Ley de financiamiento:
 - Se asegura el financiamiento de ciertos exámenes y tratamientos que son de muy alto costo de enfermedades determinadas
- Hay una lista de las distintas enfermedades
- Se autoriza por un comité de expertos, quien determina si una persona cumple los requisitos para esta ley
- Hay plazos determinados a cumplir

Tema 5: Salud Pública

Clase 14: Licencias Médicas

I. Generalidades de Licencias Médicas:

- Matronas y dentistas también pueden otorgar licencias médicas (de acuerdo a su profesión)
- **Beneficios:**
 - Permiso de ausentarse en el trabajo
 - Subsidio: el dinero que debió haber ganado por haber trabajado se lo paga Fonasa o la isapre → tiene un tope: "renta tope": a sueldos más altos, es más difícil que se le devuelva la cantidad completa. El subsidio a obtener depende del número de días de licencia que uno tiene:
 - 1 – 3 días: no se pagan
 - 4 – 10 días: descuentan 3 días. Ej: si la licencia es de 10 días, sólo pagarán 7 días
 - > 11 días: se pagan todos los días. El riesgo de otorgar una licencia por muchos días, es que los días de licencia están estipulados por ley según cada patología, por lo que si otorgo una licencia por 15 días cuando realmente debería ser por sólo 7 días, le van a rechazar la licencia y no le pagarán nada. Sí se puede extender la licencia en caso de que el paciente persista en malas condiciones, quedando como una única licencia (ej: inicialmente se otorga

una licencia de 5 días, pero al 5º día persiste mal, por lo que extendiendo su licencia por 10 días más, siendo un total de 15 días, por lo que podrán pagarle el total de los días)

- Licencias laborales: se paga todo
- ¿Si rechazan la licencia? O ¿Si pagan menos?:
 - Se puede reclamar al Compín (comisión de medicina preventiva e invalidez → Fonasa) o a la isapre. Las isapres también pueden reclamar al Compín
 - Si Compín dice que no se pagará → se alega a la Suseso

II. Licencias Maternales:

1. Generalidades:

- Pre y post natal
- Las subsidia el estado
- Tiene el objetivo de proteger a la mujer embarazada o puerpera y a la familia
 - **Prenatal:** 6 semanas antes de la fecha probable de parto según las condiciones individuales de la mujer embarazada. No es a las 34 semanas; ej: si una mujer con un embarazo gemelar se tiene una estimación de interrupción del embarazo a las 36 semanas, el prenatal se indica a partir de las 30 semanas
 - **Postnatal:** desde el momento en que nace hasta 12 semanas después del parto
 - **Postnatal parental:** son 12 semanas más (por lactancia materna y cuidado del bebé)
 - Postnatal son 24 semanas en total
 - **Licencia para el cuidado del hijo enfermo < 1 año:** sólo para la madre. Si la mujer muere, se otorga este beneficio al padre
- **Objetivos:**
 - **Prenatal:** que la mujer embarazada se sienta bien
 - **Postnatal:** recuperación de la mujer que acaba de tener un parto
 - **Postnatal parental:** lactancia y cuidado del bebé. Si el bebé nace muerto, no se puede otorgar
- **Fuero maternal:**
 - No se puede despedir a la mujer durante todo el embarazo hasta que el hijo tenga 1 año y 12 semanas

Tema 5: Salud Pública

Clase 15: Ética Médica

I. Principios de la Ética Médica:

- **Beneficencia:**
 - Es hacer el bien, buscar el bien del paciente
- **No Maleficencia:**
 - No dañar
- **Autonomía:**
 - Consentimiento informado: que el paciente entregue su voluntad y que sea informado: que sea explicado y que haya entendido correctamente
- **Justicia:**
 - “Que cada uno reciba lo que le corresponde”
 - Sin discriminar de forma arbitraria
 - Actuar conforme a la ley

II. Ejemplos:

Caso 1. se incluye en un estudio a un niño de 15 años. Los padres consienten, al niño no se le pregunta:

- Hay falta de la autonomía, pese a que los padres sean los representantes legales

Caso 2. Se realiza un estudio que compara un nuevo medicamento versus un placebo: no se informa a participantes que pueden recibirlo:

- Como no se está dando la información, no hay un consentimiento informado, pese a que el paciente sabe que participará de un estudio y dio su consentimiento informado, pero no fue informado completamente (no se le dijo que podría recibir un placebo)

Caso 3. Se realiza un estudio que compara un nuevo medicamento versus un placebo: no se informa a participantes que pueden recibirlo. Además, existía un tratamiento bueno:

- Se les está dando un placebo cuando se les podría dar un tratamiento ideal desde antes
- Hay una falta en el principio de beneficencia: uno tiene la obligación de beneficiar al paciente.
- En este caso, está la obligación de no comparar el tratamiento con un placebo, sino que compararlo con un medicamento que ya sirviera

Caso 4. Un laboratorio da viajes a médicos que recetan mucho sus medicamentos:

- Se afecta el principio de justicia: el paciente está recibiendo algo que no se merece
- En el caso de que el fármaco realmente no lo beneficia según la patología que presenta, se vería afectado el principio de beneficencia y/o el principio de no maleficencia, en el caso de que le hiciera algún daño

Tema 5: Salud Pública

Clase 16: Responsabilidad Médica y Mala Praxis

Temas:

- Concepto Mala Praxis
- Riesgos (Civiles y Penales)
- Requisitos
- Casos
- Prevención
- Seguros de Responsabilidad Civil

I. Mala Praxis:

1. Introducción:

- Es una acción u omisión (hacer o no hacer) que sea en la actividad médica, ya sea en el diagnóstico o en el tratamiento médico
- Es realizada con culpa
- Genera un daño en el paciente
- Genera responsabilidad en el médico de reparar el daño causado
- Requiere de 4 requisitos:
 - Hecho (acción u omisión)
 - Culpa
 - Daño

- Relación causal (entre el hecho culposo y el daño causado)

2. Riesgos:

- **Sanción penal:**
 - En el código penal, se clasifica como “cuasidelito de homicidio / lesiones” en el caso de fallecer o quedar con alguna lesión permanente respectivamente
- **Sanción civil:**
 - Indemnizar el daño con dinero

3. Tipos de Culpa:

- **Negligencia:**
 - Es una omisión: el no hacer algo que debía hacerse
- **Imprudencia:**
 - Hacer algo que no debía hacerse
 - ** En ambos casos, sin el debido cuidado: actuar conforme a “Lex artis” (mejores prácticas médicas)
- **Impericia:**
 - El actuar sin los conocimientos o habilidades requeridas.
 - Ej: médico general opera una cirugía que no sabe realizar (es de especialista)
- **Infracción a los reglamentos:**
 - No sigue las normas
 - Ej: guías MINSAL tiene normas que obligan a actuar de una determinada manera

4. Ejemplos de Culpa:

Caso 1. Cirujano no controla al paciente post operado y se va de vacaciones:

- Hay una omisión culpable → negligencia

Caso 2. Médico deja al interno atender, sin supervisión y le da un medicamento contraindicado:

- Interno está actuando de manera anti ética e impericia (aún no es un médico y no tiene el conocimiento necesario para actuar bien)
- El médico es quien tiene la culpa (aunque siempre dicen que la tiene el interno, pero realmente no es así), ya que es él quien debía supervisar y no lo hizo: cometió una negligencia → no actuó de manera culposa, en el sentido de que él debió haber supervisado, porque esa era su obligación.

Caso 3. Opera una apendicitis y termina siendo un embarazo de 25 semanas:

- Hay una omisión culpable: omitió realizar el test de embarazo
- Es una negligencia

Caso 4. Llega un paciente con dolor torácico, inespecífico. No se le hace ECG. Antecedentes de HTA, DM2, de 65 años.

- Se deriva a domicilio → negligencia
 - Cualquier dolor torácico puede ser un IAM, por lo que mínimo se debe pedir un ECG
 - Aún más con los antecedentes personales → negligencia por no actuar
- Recordar que el ECG no descarta el IAM:
 - Éste diferencia un SCA CSDST y un SCA SSDST
 - Se debe hospitalizar ya que presenta clínica de un SCA y con su debido manejo, pese a que el ECG esté normal → los IAM es una de las causas que llegan con mayor frecuencia a tribunales
- Si no tiene clínica característica de SCA + ECG normal + sin antecedentes previos:
 - Recién se puede mandar a domicilio

II. Casos:

Caso 1. Mujer de 60 años con diagnóstico de diverticulitis aguda perforada. Un cirujano digestivo le realiza una cirugía de Hartmann. Evoluciona con dehiscencia de la anastomosis, por lo que requiere de una nueva cirugía. Se complica con una TVP que evoluciona a un TEP, quedándose hospitalizado en UCI por 20 días.

- Es un médico habilitado para poder realizar este tipo de procedimientos.
- Los requisitos para que sea una negligencia médica son:
 - Hecho
 - Culpa
 - Daño
 - Relación causal
- En este caso, no hay culpa. Todo lo que se hizo, se hizo bien. La obligación del médico es una obligación de medios: de actuar conforme a la lex artis, no de resultados, no de que no haya un daño, no de que haya ninguna complicación.
- Es por esto que es importante el consentimiento informado previo, donde se le explican los distintos riesgos asociados.

Caso 2. Un niño de 7 años cursa con neumonía. Tiene el antecedente de ser alérgico a la PNC, pero el médico no pregunta acerca de sus antecedentes. Le dejó Amoxicilina e hizo una reacción anafiláctica, por lo que respondió adecuadamente al suero y adrenalina.

- Hay un hecho: la administración del medicamento
- Fue con culpa: hubo una negligencia al no preguntar acerca de los antecedentes
- No hay daño: el paciente respondió adecuadamente al suero y adrenalina
 - Al no haber daño, no habrá una indemnización ni un daño penal.

Caso 3. Hombre de 46 años consulta por malestar general y estrés. Al examen físico presenta signos vitales normales, por lo que se decide que se solicitarán exámenes y controles ambulatorios, pero finalmente resulta que era una apendicitis perforada con sus complicaciones asociadas.

- El único registro que se tiene es que los signos vitales estaban normales, por ello queda la duda si hubo culpa o no:
 - No se sabe si se hizo un examen físico completo o no, si es que se evaluó el abdomen, por lo que se puede inferir de que no se hizo y por eso es que no lo registró.
 - El no hacer un examen físico es persé una negligencia → uno como médico tiene la obligación de hacer una anamnesis y un examen físico completo
- Puede que el médico haya hecho el examen físico completo, pero que no lo registró en la ficha clínica

III. Prevención Mala Praxis:

- **Anamnesis + examen físico:**
 - Completos → siempre registrarlos en la ficha clínica: es el medio de defensa más importante para el médico
- **Siempre escribir el control SOS:**
 - “Control si signos de alarma (se explican claramente al paciente)” → y obviamente hacerlo
- **Reconocer las limitaciones:**
 - Derivar, pedir exámenes
 - Limitaciones ya sean como médico como del recinto en donde se está trabajando también → suele ser frecuente que en consultorios no se disponga de todos los instrumentos para poder realizar un diagnóstico completo y certero, por lo que si presenta signos de alarma, se debe derivar a un recinto que sí los disponga
- **Mantenerse actualizado:**
 - No sólo del contenido académico, sino que también de las normativas médicas
- **Buena relación médico paciente:**

- Una mala relación médico paciente persé es causa de demanda, aunque no se haya cometido una negligencia
- **Consentimiento informado:**
 - Firmado
 - Bien redactado
 - Enumera riesgos de manera detallada
 - Que sea bien explicado
 - Dejar registro de que se lee el consentimiento informado con el paciente, entendiendo todos los riesgos asociados, y se le resuelven sus dudas también
- **Leer protocolos:**
 - Cuidado con las normas y reglas del mismo hospital
- **Pausas de seguridad:**
 - Principalmente en las cirugías
- **Evitar consulta de pasillo, por whatsapp y similares**

IV. Seguros de Mala Praxis:

1. Cobertura:

- Responsabilidad civil (indemnización)
- Defensa judicial (costos abogados, costo de un perito, etc)
- Cobertura tiene límites:
 - Generalmente entre 2.000 y 7.000 UF
- Leer la póliza:
 - Es el documento que informa la cobertura que va a recibir
 - Ej: muchas veces se encuentra escrito la obligación de avisar ante una posible demanda
 - Leer lista de exclusiones:
 - Estética / cosmética: suele excluir la cobertura de este tipo de procedimientos. Ej: otorrino que hace una cirugía de nariz, no va a quedar cubierto
 - Fertilidad e infertilidad
 - Atenciones a familiares y empleados
 - Especialistas sin Conacem



No les puede ir mal después
de leer todo esto cabr@s qls



Éxito en lo que viene,

Creggersoficial